

专科专病
名医临证经验丛书

呼吸病

吴艳华 郭桃美 · 主编



人民卫生出版社

专科专病名医临证经验丛书

呼 吸 病

主 编 吴艳华 郭桃美

副主编 肖达民 吴肇添

NAUFG/02

人 民 卫 生 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

呼吸病/吴艳华等主编. —北京: 人民卫生出版社,
2001

(专科专病名医临证经验丛书)

ISBN 7-117-04607-4

I. 呼... II. 吴... III. ①呼吸系统疾病-
中医学临床-经验-中国-现代②呼吸系统疾病-验方
IV. R259.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 084442 号

专科专病名医临证经验丛书

呼 吸 病

主 编: 吴艳华 郭桃美

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 67616688)

地 址: (100078) 北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼

网 址: [http://www. pmph. com](http://www.pmph.com)

E - mail: [pmph@pmph. com](mailto:pmph@pmph.com)

印 刷: 北京市通县永乐印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 850×1168 1/32 印张: 18.75

字 数: 412 千字

版 次: 2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

印 数: 00 001—3 000

标准书号: ISBN 7-117-04607-4/R·4608

定 价: 29.00 元

著作权所有, 请勿擅自用本书制作各类出版物, 违者必究

(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

出版者的话

为了进一步抢救、挖掘、继承和发扬名老中医、著名中西医结合医学术思想和宝贵经验，不断提高中医、中西医结合诊疗水平，满足广大中医、中西医结合工作者学习需要和加强中医专科专病建设的要求，我社特组织全国有关专家学者编写了《专科专病名医临证经验丛书》。本丛书是在广泛收集近现代国家级和部分省部级名医临床诊疗经验和学术成果的基础上，经过精选、整理研究、汇编而成的系列丛书。该丛书共 12 个分册，包括呼吸病、心脑血管病、脾胃病、肝胆病、肾脏病、糖尿病、风湿病、血液病、肿瘤、妇科病、儿科病、皮肤病等分册。每一分册均包括两个部分，即疾病篇与方剂篇。其中疾病篇所选医家诊疗经验以病为纲，以人为目；每一疾病均按概述、名医经验、按语三部分来阐述。方剂篇所选医家诊疗经验以病为纲，以证为目，下分列临证有效的专病专方。本丛书作者均为长期在临床第一线从事相关专科专病医疗的工作

者，对名医的诊疗经验和学术思想学习理解颇深，故所收名医经验突出名医在诊疗疾病方面的独到之处，而不是面面俱到、泛泛而谈；其中也选录了少量对某一疾病有独到认识和经验的专家体会，以提高本书的实用性。按语是作者结合个人临证体会加以阐述，对名医辨证思维、遣方用药心得进行挖掘、归纳、提炼，指出各名医诊疗疾病的特点所在，语言精练，客观公允，具有画龙点睛的作用，以便于读者理解和掌握。该丛书资料翔实，内容丰富，重点突出，切合临床实际，为各科临床医生提高诊疗水平提供借鉴。本丛书所收病种一律采用西医病名，所选病种为中医或中西医结合治疗疗效好，有优势、有特色者。本丛书对各级中医和中西医结合医师、中医药大专院校师生、中医药专业研究生学习提高参考价值颇大。

人民卫生出版社

2001年10月

内 容 提 要

本书分为疾病篇和方剂（药）篇。疾病篇中，参考了众多近代名老中医的医案及全国各类中医杂志中的名老中医论文，收集了名老中医对呼吸病的认识和选方用药的经验，加以分类整理，用与现代医学近似的病名进行归纳，每一类病种有概述、名医经验，最后附加编者按语对名老中医的临床诊治精华加以归纳分析。方剂（药）篇中，遴选名老中医诊治疾病的验方多首，每方列有组成、用法、功效、主治、方解、加减等项，简明扼要。两篇合观，能够系统、全面反映名老中医的学术思想、临床经验及验方特色。

编写说明

中国医药学历史悠久，源远流长，是有独特而完整的理论体系和丰富实践经验的一门学科，为炎黄子孙的繁衍昌盛发挥了巨大的作用。近代中医名流辈出，他们博览群书，既继承了前人的精华，又通过实践积累了丰富的临床经验。为振兴中医，继承和发扬名老中医经验，编者将一些凝集着现代名老中医毕生心血的临床诊治经验，经过收集、整理，编写了《专科专病名医临证经验丛书·呼吸病》一书，使名老中医的临床诊治经验得以更好地推广、继承和发扬，造福今人和子孙后代，丰富和发展中医学。全书共分疾病篇和方剂（药）篇两篇。疾病篇，参考了众多近代名老中医的医案书籍及全国各类中医杂志中的名老中医论文，收集了名老中医对呼吸病的认识和选方用药的临床经验，加以分类整理，用与现代医学近似的病名进行归纳，每一类病种有概述、名医经验，后附加编者按语对名老中医的临床诊治精华加以归纳分析，参考文献均标明出处。方剂（药）篇，遴选了名老中医诊治疾病的验方多首，每方列有组成、用法、功效、主治、方解、加减等项，简明扼要，为学习提供了有益的指南。本书收集面广，内容丰富，论述详尽，写法新颖，编写时力求能够较系统、全面地反映名老中医的学术思想、临床经验及验方特色。阅读

2 编写说明

本书，不仅使读者认识、了解名老中医诊治疾病的特色，还可深入学习现代中医的不同流派，从而能开阔思路，对继承当代名老中医学家的宝贵经验、充实祖国医学宝库、提高临床医师的实际工作能力均有重要意义。

由于时间仓促，加之编者学识有限，书中错误之处在所难免，敬请读者批评指正。

编者

2001年9月

目

录

疾 病 篇

慢性支气管炎	1
弥漫性泛细支气管炎	55
感冒	60
支气管哮喘	71
慢性阻塞性肺病	211
肺间质纤维化	221
慢性肺源性心脏病	228
咳嗽	270
肺结核	386
胸腔积液	410
结核性胸膜炎	412
渗出性胸膜炎	416
支气管扩张	419
肺炎	435
肺气肿	463
肺脓疡	470
脓胸	493

2 目 录

自发性气胸.....	499
矽肺	506
肺部囊状疾病	513
肺性脑病	516

方剂（药）篇

流行性感胃.....	519
咳嗽	522
支气管炎	531
咳喘	541
肺炎	544
哮喘	548
肺气肿	566
肺源性心脏病	568
肺结核	573
咯血	579
肺脓疡	582
矽肺	584

疾 病 篇

慢性支气管炎

【概述】

慢性支气管炎是气管、支气管壁的慢性炎症。其病理特点是支气管腺体增生、粘液增多，临床表现有连续2年以上，每年持续3个月以上的咳嗽、咳痰。病理进展缓慢。引起慢性支气管炎的原因尚未彻底明了，可能与相互关联的多方面因素有关，如物理化学刺激因素、感染因素、过敏因素、气候因素等。慢性支气管炎反复发作，迁延不愈可发展成为阻塞性肺气肿与慢性肺源性肺心病。中医学认为，慢性支气管炎的发生和发展与外邪的侵袭和肺脾肾三脏功能的失调有关，而且往往是外感和内伤同时影响发病。慢性支气管炎常见的临床证型有痰湿犯肺型、外寒内饮型、外寒内热型、肺脾两虚型及肺肾两虚型等，根据不同证型施以不同方药，可获较好疗效。

【名医经验】

1. 高辉远诊治经验

①新感引动伏痰，当先祛痰宣肺：肺位于胸中，为五脏之华盖，又为娇脏，性喜清肃，外合皮毛，最易感受外邪侵袭。《内经》病机十九条曰：“诸气膹郁，皆属于肺”。膹为气上逆而喘，郁为闭塞。高氏认为，慢性支气管炎有反复咳、痰、喘，尤以痰潜伏肺家是其发病基础。由于人体正气不足，卫外不固，气候稍变或寒冷，乘虚袭人之客邪，肺又首当其冲，新感引动伏痰，如此内外合邪，郁遏太阴，咳喘之痰因此诱发或转甚者屡见不鲜。故其主要表现为咳嗽、咯痰、痰多，气喘或有发热恶寒，临证必须根据痰之色、质、苔、脉等辨其寒热。寒痰宜温化，热痰宜清化。但治疗大法总不离乎祛痰宣肺，此时大忌敛肺止咳，以防闭门留寇。若是年老素体亏虚者，因其脏腑痿痹，故宣肺不可太过，以免损伤正气，临证投剂，当注意及此。

高氏认为，临证不论何种咳嗽咯痰，只要是恶寒发热，咳嗽清涕，痰白而稀，苔薄或白腻，脉浮或浮紧，便是寒痰阻肺的证候，宜鞠通杏苏散主之。方中苏叶发散风寒，前胡宣肺化痰，杏仁、桔梗、枳壳以理肺降气，法夏、陈皮、茯苓以化痰理气，甘草调和诸药，姜、枣以和营卫，使其表解痰化，肺畅气调，诸证可愈。若体素气虚，客伤风寒，内有痰饮，咳嗽痰多，头痛鼻塞，胸膈满闷，苔白，脉浮而虚者，可与参苏饮，以补气化痰。长期伏痰必从热化，症如咳嗽气急，咯痰黄稠，胸膈满闷，口苦口干，舌红，苔黄，脉滑数等。清热化痰之方以清气化痰丸与温胆汤化裁最为合拍。若胸满痰阻，咳嗽吐痰腥臭，可与千金

苇茎汤加桔梗、桑白皮、前胡，以取疏泄，导邪外出，病易解也。

②正虚邪恋缠绵，法宜标本兼施：慢性支气管炎，病情既不能缓解痊愈，又未表现急性发作状态，然始终纠缠不愈者，此为慢性迁延期属正虚邪恋之证。临床可见外邪客肺和痰浊壅肺的标实证，又有肺脾肾不足的本虚证。正如《内经》所云：“肺不伤不咳，脾不伤不久咳，肾不伤不喘”。因久咳伤肺，肺主气，气虚则藩篱不固，卫气不能抗御外邪，久之脾气亦虚，脾虚生湿，湿盛生痰，痰气上逆，致肺失宣降，则咳嗽痰多，故有“脾为生痰之源，肺为贮痰之器”之说。如此久咳不已，终必及肾，肾虚则气不受纳，气喘不接，或肾阴不足，内热灼津生痰，此乃慢性支气管炎发展变化的基本规律。

高氏认为，久罹慢性支气管炎，卫气虚弱，患者不任风寒，极易感邪，其证咳嗽有痰兼喘，咳声低弱，痰白清稀，自汗恶风，易于感冒，身倦懒言，舌淡，苔薄白，脉虚弱等，此多为肺虚痰恋之证，宜用玉屏风散合补肺汤化裁。方取生黄芪、太子参补肺益气固表，以白术、茯苓健脾利湿，补土以生肺金，法半夏辛温辛燥，功能燥湿化痰，橘红理气化痰，使气顺则痰降，气化则痰亦化，防风走表而祛风邪，五味子收敛耗伤之肺气，桑白皮、紫菀、杏仁顺降肺气，以复其清肃之权。

脾为后天之本，气血生化之源，气机升降之枢。肺气不足之因脾土亏虚者不为少见，故补益肺气而收效不显者，可从脾土求之。证如咳嗽痰多，痰白粘稠，倦怠乏力，食欲不振，腹胀便溏，舌淡苔白，脉沉滑，其病机为脾虚痰滞。高氏主张益气健脾，止咳化痰之法，宗六君子汤合二陈、三子养亲汤化裁。方取太子参、茯苓、白术、山药、

炙甘草健脾益气，以化痰湿；法半夏、苏子、陈皮、杏仁降气化痰止咳；炒莱菔子、神曲醒脾开胃，消食化痰。兼寒者加少量干姜，与官桂同用，既可温中散寒，又有“少火生气”之用。其量宜轻勿重，缓缓调治。

肾为水脏，主藏精，故滋水润金为肺阴不足常用之法，特别于慢性支气管炎者尤宜。其证为咳嗽气急，水泛为痰，动则转甚，腰酸腿软，潮热盗汗等症，高氏主张宜麦味地黄丸合太子参、天冬、沙参治之，甘寒滋阴，肺肾同治。俾金水相生，互滋互充，于证惬当。若肾气上逆而咳痰喘，上盛下虚，其症痰涎壅盛，胸膈噎塞，宜苏子降气汤。方中沉香、肉桂统纳肾气。肺气亏虚因肾阳失煦，徒温补肺气，补益中气不效者，当温肾纳气，其证多为咳发喘促，动则为甚，腰酸腿软，夜尿频多，头晕耳鸣，身寒肢冷，气短语怯，舌淡胖，苔白滑润，脉沉细。方宜右归丸化裁，方中以附子、肉桂温补肾阳，熟地、山药、山萸肉、枸杞子滋补肾阴，以阴引阳，杜仲强肾益精，五味子、胡桃肉补肾润肺，又能摄纳气。气虚喘盛加入人参、补骨脂补气助肾纳气。肾阳不足，温化无权，水湿上注为痰，咯痰量多而稀薄者，加法半夏、陈皮、苏子等，药出入其间，标本兼顾，效更显著。

③病缓标实已平，重在扶正固本：慢性支气管炎病人经过治疗或自然缓解，临床表现无明显症状，或有轻微咳嗽，咯痰，或稍有气喘，精神欠佳，面色少华，食纳欠馨，舌淡苔白，脉沉细无力等，均属临床缓解期阶段。高氏认为，此时病情暂趋于相对平稳状态，但机体抗病能力差，其病变尚未清除，容易复感外邪，而使病症复发或加重。因此，必须重视缓解期患者的治疗。正如朱丹溪所云：“久喘之症，未发宜扶正为主，已发以攻邪为主。”可见前贤早

就注意到了缓解期治疗的重要意义。慢性支气管炎缓解期以本虚为主，标证不突出，故治疗上主要针对其虚多实少的病机，缓则治其本，以扶正固本为要，以促进机体虚损脏器逐渐复原，提高自身抗病能力。高氏主张采用扶正固本，培补肺脾肾，改善此三脏功能为重点，临证多以保元汤、玉屏风散、六君子汤、人参胡桃汤等方剂为基础方化裁变通治之。方中以人参益气，黄芪固表，甘草和中，肉桂助阳，配合为用，相得益彰。其中参、芪得桂之引导，则益气之功更著，桂得草之和平，则温阳而调理气血。前人尝谓气虚久咳不愈，诸药不效者，惟有益脾补肾。此方用人参、芪、草补中益气，恢复脾胃之功，配以肉桂温下焦元阳，两顾脾肾，所以能治真元不足，阳气偏虚之喘证。另外合益气、固表、止汗之玉屏风散治肺气虚弱之喘哮，再合益气、补脾、化痰之六君子汤治脾气不足之咳嗽，更合补气、益肾、定喘之人参胡桃汤治肾不纳气之喘甚，均为温补元气之举，使气充体壮，而虚损自复，纵有外邪，也不致作喘。

根据中医学“冬病夏治”的理论，在临床观察到夏季伏天使用益气健脾温肾之剂可增强人体抗病能力，慢性支气管炎患者用此治疗，冬季发病明显减轻，而且容易控制。高氏对有些患者在缓解期及平时亦喜以中成药调治，气虚者可用六君子丸、补中益气丸，肾虚者可用金匱肾气丸，或用平补阴阳的河车大造丸以扶正固本，缓缓图功之意，加之服药量少，不碍脾胃，对机体康复极为有利，常可取效。

此外，本病患者平日应注意防止感冒，适寒温，调饮食，戒烟酒，忌食辛辣、肥甘厚腻之品，还应保持情绪稳定，坚持规律和合理的生活起居，参加适当体育活动，如

太极拳、八段锦、散步、慢跑以及气功等，以增强体质，这对于控制本病的复发和发展都有益处。^[1]

2. 林求诚诊治经验

①对慢支合并感染的学术见解：慢性支气管炎的特点就是病程长，经常合并感染，病情反复。根据中医学“病有标本，本为病之源，标为病之变”，“因外感者本于表，因内伤者本于里”的观点，林氏认为：慢支的发生、发展大致上有下列两种模式：一是先感外邪招致标证，由于标证的反复和发展导致正虚，正虚的结果导致标证更为加剧，即标→本→标模式；二是先有正虚，易感外邪，引起标证，由于标证的存在，更伤正气，即本→标→本的模式。正气愈虚，邪气愈盛，邪气愈盛正气愈虚，标实与本虚的交互作用，使病理变化恶性循环。由于久病入络，所以在慢支患者中存在不同程度的瘀血证。如指尖血管容积示波描记的波幅降低和流入容积减慢；甲皱微循环血管异率率增加及血流瘀滞（这些往往未引起人们的注意）；舌质常暗红或紫暗或见瘀斑、瘀点，舌下静脉充盈等。所以慢支合并感染是本虚标实的病证，其标实为痰湿化热壅肺兼有瘀血，其本虚常为肺脾两虚。

②治疗慢支合并感染遣方用药特点：慢支合并感染临床上常表现为咳嗽，痰多，痰黄不易咯出，胸闷气短，神疲乏力，或见发热、口干，舌质暗红或有瘀斑、瘀点，苔黄腻，脉细滑。中医辨证为痰热壅肺，气虚血瘀。林氏喜用自拟的清热化痰益气活血方。药用：瓜蒌 10g，薤白 10g，半夏 10g，黄芪 15g，党参 15g，丹参 15g，赤芍 15g，黄芩 10g，连翘 15g，蒲公英 24g，紫花地丁 24g，鱼腥草 24g，甘草 3g。方由瓜蒌薤白半夏汤发展而来，林氏取其

瓜蒌清肺化痰、利气宽胸，半夏燥湿化痰、消痞散结；妙在薤白的灵活运用，痰为阴邪，非温不化，薤白通阳散结、行气导滞，能加强瓜蒌、半夏化痰之力。脾为生痰之源，黄芪、党参健脾益气，脾健则痰无由生。黄芩、连翘、蒲公英、紫花地丁、鱼腥草清热燥湿，泻火解毒。赤芍、丹参活血祛瘀，甘草调和诸药。全方共奏清热化痰、益气活血之功。林氏认为，这种病证单用清热化痰的办法控制标证是不够的，还要采取健脾益气，培土生金，佐以活血的方法标本兼治以提高临床疗效。同时，针对痰热这一特点，选用清热解毒之品，药味要多，剂量要大，方能收效。对于合并肾虚患者，可加用仙灵脾、核桃肉、枸杞等补肾填精，纳气平喘。

如治吴某，男，64岁，1997年6月4日初诊。病人反复咳嗽18年，每次发作，症状缠绵难愈，历时4~6个月，经打针服用大量的抗生素方可控制症状。本次咳嗽又发7天，西药治疗疗效不佳，而求中医治疗。诊见：咳嗽，痰多而黄，不易咯出，胸闷而喘，发热，口干而苦，纳少，神疲乏力，动则气促加剧，舌质暗红，舌下静脉怒张，舌苔黄腻，脉细数无力。体检：T37.8℃，双肺布满痰鸣音，少许湿啰音。胸透示：双肺纹理增多、模糊，双下肺野可见散在的斑点状阴影。血常规检查：WBC $12 \times 10^9/L$ ，NO.83，L0.17。诊断为慢支合并感染；中医证属痰热壅肺，气虚血瘀。治以清热化痰，益气活血。方用清热化痰益气活血方加味：瓜蒌10g，薤白10g，半夏10g，川贝6g，黄芪15g，党参15g，丹参15g，赤芍15g，枳壳10g，厚朴10g，黄芩10g，连翘15g，蒲公英24g，紫花地丁24g，鱼腥草24g，甘草3g。4剂。二诊：药后咳嗽明显减轻，痰量减少，发热平，胸闷气促亦瘳。药已中病，但余

邪未清，按上方去厚朴、枳壳、川贝，加白术 10g，4 剂。服药后咳平痰消，纳增，舌苔转薄白，脉较前有力，但舌质仍稍暗红，乏力。复查血常规：WBC $6.8 \times 10^9/L$ ，N0.65，L0.34，M0.01。胸透示：双肺纹理稍增多。痰热已清，肺脾仍虚。予以玉屏风口服液、香砂六君子丸健脾益气固表，以巩固疗效。

本例初诊时痰热较重，肺气闭郁，故加厚朴、枳壳宽胸理气，川贝化痰。二诊时，痰热已去大半，加白术增强健脾之力。三诊时，痰热已清，故只用健脾益气之法，脾气得健，肺气得固，则可打破正气愈虚邪气愈盛、邪气愈盛、正气愈虚的恶性循环，有利于机体的康复。^[2]

3. 邵长荣诊治经验

①久咳木郁，疏肝润肺以达之：久咳是慢性支气管炎的主要临床特征。《内经》云：“五脏六腑皆令人咳，非独肺也”。在灵活的辨证中，重视从肝治咳是邵氏的一大特点。他认为，久咳常为表邪内郁，少阳枢机不利，以致肺失宣肃，气血、津液流通输布受阻，痰饮停聚。其状咳嗽胸闷、两胁胀疼、寒热往来、口苦咽干、面红头昏，舌边红、苔薄白、脉弦。与《医醇膳义》指出的“肝经之咳，痰少、胁痛、易怒、头眩”基本相一致。然邵氏特别强调，以上症候群临床须灵活掌握，久咳者但见一证便是，不必悉具。此证予投常规的宣肺止咳之品往往不能奏效。对此，邵氏则喜用柴胡配前胡，以柴胡疏散少阳郁热，转动少阳枢机；配前胡宣达肺气，润肺化痰，并可防柴胡燥烈伤津。临床根据不同症状，还可灵活化裁。如兼风邪可与荆芥、防风、羌活、独活配伍，取荆防败毒散之意；兼表虚证可与桂枝、白芍配伍，取柴胡桂枝汤之意；兼痰热内结者可

与黄芩、枳实配伍，取大柴胡汤之意；兼肝气郁结甚者可与枳壳、香附、青陈皮配伍，取柴胡疏肝散之意；兼有寒饮者可与细辛配伍；兼有肝肾不足者可与桑椹子、桑寄生配伍。凡此种种，不一一枚举。

如治黄某，男，70岁。1997年5月7日初诊。病史：10余年来每逢冬季咳嗽、咯白色泡沫痰，近2~3年呈全年发病，清晨咯白色泡沫痰，每天约50ml。曾做支气管镜检查为阴性，肺功能测定正常。胸片：两肺纹理增深。诊断为慢性支气管炎。经中西医多方治疗1年症状无改善。诊见：咳嗽，痰白如泡沫，易出汗，易感冒，头昏耳鸣，口苦咽痒，腰膝酸软，舌红而干、苔薄腻，脉小弦。咽充血，淋巴滤泡增生。两肺呼吸音正常。证属表邪内郁，少阳枢机不利，肺失宣肃，久病及肾。治拟疏肝益肾，佐宣肺化痰。方用赤芍18g，白芍18g，细辛4.5g，平地木30g，青皮9g，陈皮9g，柴胡9g，前胡9g，姜半夏9g，桑叶9g，桑白皮9g，杜仲9g，桑椹子9g，桑寄生12g，功劳叶12g，女贞子12g。7剂见效，21剂后，患者相告，咳嗽、咯痰已基本缓解。再以原方加黄芪15g，防风9g，苍术12g，白术12g，薏苡仁18g，白茅根30g，芦根30g。调治2月，病情霍然，随访半年未复发。

②喘责肺肾，宣肺纳肾以平之：明·张景岳《景岳全书》云：“肺为气之主，肾为气之根”，“肺主皮毛而居上焦，故邪气犯上则上焦气壅而为喘者，宜清宜破也。肾主精髓而在下焦，若真阴亏损，精不化气，则下不上交而而为促，宜填其精也。”慢性支气管炎病程日久，见喘促者众多。邵氏认为喘有虚实之分，但临证所见，常虚中有实，实中夹虚。治当攻补兼施，宣肺纳肾兼之。只是根据临床情况不同而有所偏重耳。

实喘宜宣肺开泄，驱邪为务。常选小青龙汤加减以宣肺散寒而用于寒喘；选定喘汤加减以宣肺清热而用于热喘。对于体虚易汗者邵氏常加用麻黄根以宣肺止汗；对于年老体弱而患有高血压、心脏病者，邵氏常用黄荆子易麻黄，盖黄荆子功同麻黄而无麻黄之加快心率、升高血压之弊。无论寒喘、热喘，邵氏还喜欢用射干和胡颓叶及川芎和石菖蒲两对药，以射干利咽降气，胡颓叶敛肺平喘，两药相配降气平喘效颇佳；用川芎活血化瘀，石菖蒲化痰开窍，二药相配化痰瘀之郁而使气调喘平。虚喘以补、填、纳肾为主。对肾阳不足者常选用补骨脂、仙灵脾，盖两药都具补肾壮阳、温肾纳气之功，是治虚喘之要药。现代药理证明：二药均可降低气道高反应，解除气管平滑肌痉挛。对阳虚畏寒偏甚者加用附子、肉桂以温阳平喘。对肾阴不足为主者，常选用桑椹子、桑寄生、杜仲、牛膝、女贞子等以填精，纳气平喘。现代医学证明：慢性肺气肿患者常有 α 抗胰蛋白酶减少或缺如现象，而邵氏80年代的一项临床实验表明，运用补肾药等可增加此酶，改善肺泡壁的弹性，降低肺气肿的程度，从而为“肾主纳气”理论提供了微观上的依据。

如治冯某，男，73岁，1997年6月24日初诊。病史：反复咳、痰、喘10余年，以冬季发作为多。发作时咳嗽，痰多，气喘明显。发作缓解时仍感气急，动则益甚。近2年气急尤为加重。平时感胸闷，心慌，腰酸。下肢无浮肿，纳可，二便调。诊见：痰多，咳嗽，气急甚，口干，舌质红，苔薄，脉细滑。证属痰热恋肺，肾气不足。治拟宣肺化痰，补肾纳气。方用：黄荆子9g，桑叶9g，桑白皮9g，青皮9g，陈皮9g，川芎9g，冬瓜仁9g，炙紫菀9g，桑椹子9g，女贞子9g，杜仲9g，姜半夏9g，嫩射干12g，胡颓

叶 12g, 桑寄生 12g, 石菖蒲 12g, 鹅管石 18g。服药 7 剂后, 咳嗽、咯痰、气喘均有缓解, 守法治疗 1 月, 咳嗽、咯痰基本消除, 气喘明显改善。再拟前方去宣肺化痰之品, 加补骨脂 9g, 狗脊 9g, 牛膝 9g, 调治 2 月, 已无明显气急现象。

③喘肿并作, 宣通三焦以利之: 慢性支气管炎患者, 病情发展到晚期, 可出现咳喘、胸闷、短气、不能平卧、痰量多、其形如肿等症状, 浮肿可见于面部或下肢, 中医称之为“喘肿”, 多见于现代医学中的慢性阻塞性肺气肿后期及肺心病阶段。邵氏认为“喘肿”的病理基础是久病五脏俱损, 三焦气化失利, 导致痰饮、水气等诸邪互结。形成正虚邪实的局面。治疗重在助三焦气化而使通利水道。通过宣肺、温肾、疏肝、健脾等诸法助三焦气化而使水道通利, 从而可以消水气, 化痰饮。最后随着浮肿的消退, 咳喘自平。待喘肿缓解后再徐调五脏虚损以图治本。

如治李某, 男, 63 岁。有慢性咳、痰、喘史近 20 年, 近来时有面浮肢肿, 咳喘、痰白, 动则气促, 背部怕冷, 出汗, 苔薄, 脉沉细。听诊: 两肺干啰音。证属肾阳不振, 三焦气化失权, 水饮内停。治拟温阳而助三焦气化, 通利水道, 化饮平喘。方用: 桂枝 6g, 细辛 4.5g, 嫩射干 12g, 车前草 12g, 仙灵脾 12g, 胡颓叶 12g, 青皮 9g, 陈皮 9g, 熟附子 9g, 姜半夏 9g, 石菖蒲 9g, 川芎 9g, 防己 9g, 姜竹茹 9g, 赤芍 18g, 白芍 18g, 猪苓 18g, 茯苓 18g, 鹅管石 30g, 陈葫芦 30g。服药 2 周后咳喘明显好转, 浮肿亦尽退。听诊: 两肺干啰音消失。再拟培补脾肾法以善其后。^[3]

④散寒化饮法: 在临床上除咳嗽、咳痰之症外, 往往有形寒怕冷, 口渴喜热饮等症, 患者常诉犹如冷水浇背的感觉, 虽多加衣被也往往无济于事, 脉象多见沉细无力,

苔白膩或薄白，质淡胖或带齿印。邵氏常用的处方为：熟附子 9g，桂枝 6g（或肉桂 3g），赤芍 18g，白芍 18g，姜苕 9g，炙甘草 4.5g，炙款冬花 9g，细辛 4.5g，冬瓜仁 9g。胸闷加全瓜蒌 12g，薤白头 9g 以宽胸利膈。喘促较著者加炙麻黄 9g，嫩射干 18g。喘而易汗者，炙麻黄改用麻黄根 12g。高血压及有心胆疾病者，则应以黄荆子代麻黄。黄荆子性辛苦带温，是马鞭草科黄荆的果实，祛风散寒，行气除痰，有麻黄的功效，而无其副作用。

⑤清肺散瘀法：本法适宜于久咳不愈，痰黄不畅，咽干唇色暗红，伴胸胁痞满或隐隐作痛，苔薄黄膩，舌质紫红少津，或伴瘀点，舌下静脉青紫明显。可用桑白皮 9g，黄芩 12g，连翘 12g，玄参 12g，瓜蒌皮 12g，天竺子 9g，白前胡 9g，桃仁 9g，川芎 9g，平地木 15g，海浮石 18g，海蛤壳 18g。若效果不著，可在一般清肺化痰的基础上加入软坚散结、活血化瘀之品，一般人习用前胡、杏仁，邵氏则以桃仁换杏仁。因桃仁有杏仁润肺止咳的功效，同时又是一味祛瘀生新的良药，辅以川芎行气止痛，平地木活血祛瘀。

⑥健脾化湿法：不少患者，临床表现为身重胸闷，四肢乏力，痰涎白沫，纳谷不香，口干不欲饮，舌苔白膩，尤以根部为显著，痰湿阻滞、脾虚湿困的见证，若用养阴润肺之剂有助湿之弊，所以邵氏喜用苍术 9g，陈皮 4.5g，姜半夏 9g 治疗，以取二陈合平胃之意。至于合并肺气肿的患者，其证类似中医“喘肿”，治疗时可加入陈葫芦 30g，车前草 18g，茯苓 12g，防己 9g，以利水除湿，效果很好。

⑦补肾培本法：慢性支气管炎在缓解期中，一般均采用培补方法，尤其在夏天病情稳定的时间给药，即所谓“冬病夏治”，用药一般以四君、四物或六味为基础方，并

随证加入补骨脂、杜仲、巴戟天、桑寄生等味。^[4]

4. 许公岩诊治经验

慢性支气管炎根据病因可分属外感咳嗽及内伤咳嗽。然而，不论何因造成的咳嗽，如出现痰多且粘稠，胸脘满闷，食纳欠佳，四肢乏力，腹胀便溏，口不渴，舌苔厚腻，脉象滑等证时，则属“痰湿型咳嗽”。其病机为脾虚湿盛。脾虚失其健运，以致痰湿内生，上渍于肺，阻碍气机，引起咳嗽。对其治疗，许氏不单单采用健脾燥湿、止咳化痰之法，而是主张用“推化痰湿”的方法来治疗，其目的在于消除体内所形成的痰湿水饮，使湿浊之邪有出路。常用药物有苍术、麻黄、胡黄连、莱菔子、甘草、桔梗、木通、当归、泽泻、半夏、干姜、薏苡仁、大黄等等，应用此法患者咳嗽明显减轻，咳痰明显减少。许氏应用此法治疗慢性支气管炎患者，绝大多数效果显著。

如治徐某，女，26岁，1989年5月5日初诊。患慢性支气管炎10余年，近2年症状加重，发作无季节性。现咳嗽夜重，胸闷发憋，咯痰不爽，喉间痰鸣，口干不欲饮，大便干，素嗜茶，舌暗胀，苔白厚腻满布，脉沉弦滑左滞。证属痰湿中阻，治以推化痰湿。药用：苍术12g，麻黄1g，桔梗12g，干姜30g，莱菔子30g。服7剂后咳嗽、胸闷发憋及喉间痰鸣等症明显减轻，咯痰畅、量多。余症同前，仍以推化痰湿为主。药用：泽泻30g，苍术12g，干姜15g，生大黄10g，当归10g。上方7剂服后，咳嗽减轻、咳痰量减少，口渴恶饮，食纳可，大便日一行，舌苔黄厚腻满布，脉滑。浊仍盛，脾虚故也，遂用调中四消丸，早晚各服9粒。服13天后，咳嗽少作，白痰量少，食纳增加，大便调，舌淡胀，腻苔变薄，脉由滑变缓，继服调中四消丸而

痊愈。水液代谢，有赖于脾之转枢，肺之治节，肾之温化。本例脾虚湿盛，湿困中焦，生痰化饮，痰饮上犯于肺，阻滞气机，致肺气上逆而胸闷喘憋，咳白粘痰，结于咽喉气道，为气息冲击，则见喉中痰鸣如水鸡声。治以宣肺降气，推化痰湿。方中麻黄、桔梗宣肺止咳，苍术健脾燥湿，重用莱菔子、干姜降气化痰，7剂药服后诸症减轻，唯痰量仍多，治疗仍需推化痰湿，重用泽泻及生大黄加强渗湿利水之功，使体内湿浊减少，咳痰减轻。该患者证属虚实夹杂，初以祛邪扶正，继以扶正祛邪，所以奏效。

“脾为生痰之源，肺为储痰之器”。对本病着重理脾化湿，是许氏多年来治疗肺系疾病的重要经验。许氏认为不能单纯治肺，见痰治痰、见咳止咳，而应从整体出发，侧重理脾、推化痰湿。推化痰湿的主方——苍术麻黄汤是根据张仲景《金匮要略》麻黄加术汤化裁而成。仲景以麻黄发汗驱表邪，白术健脾去湿，表里同治，也是湿家理脾之重要治疗法则。许氏认为，湿家理脾以苍术更为得力，故用麻黄与苍术相伍。苍术麻黄两药等量使用，临床常见有发大汗之作用，苍术两倍于麻黄则发小汗，苍术三倍于麻黄则有较强的利尿作用，苍术四倍五倍于麻黄虽无明显之汗、利作用，但能使湿邪自化，苍术得麻黄之助，能行表里之湿而利小便，这也是许氏以前人“湿家理脾为其重要”理论作指导，又经过多年临床实践加以提炼的精华。

再者，积食与积湿均可造成脾运不健、脾被湿困，而使痰浊之邪上犯于肺，而致咳嗽、咯痰等。因积食造成的脾运不健证见舌苔腻厚、大便不爽，便干或便溏。治以消食导滞，和胃宽中，药用莱菔子、半夏、枳壳、胡黄连及大黄等。而因积湿造成的脾运不健、脾被湿困，证见胸闷发憋，舌苔薄腻，大便如常，疲乏倦怠等，治当健脾渗湿，

药用泽泻、木通、薏苡仁、白芥子等通利二便，为推降痰湿之重要治疗手段，经过多年验证，疗效卓著。^[5]

5. 姚真敏诊治经验

姚氏从事老年病防治多年，对老年慢性支气管炎治疗，效果较好，经验丰富。

①治标祛邪为主，首辨寒热：姚氏认为，本病诊治必须分清轻重缓急，辨明外感内伤。冬春季节发作时，多为新感引动伏邪，主要为风寒、风热、痰湿之邪犯肺，肺失清肃，引动伏邪宿疾，发为咳嗽、喘证或痰饮。本着“急则治其标”的原则，外感引发时，以实证居多，治疗以祛邪平喘止咳为主。又因老年人具有五脏日虚的特点，故也应该佐以扶正，并通过辨证分清寒痰、热痰、湿痰，遣方用药。若痰热犯肺，证见咳痰黄稠，发热，喜冷饮，舌红、苔黄腻，脉滑数，姚氏擅用清金化痰汤加减清热化痰，宣肺止咳；外寒内饮证见咳痰清稀色白，形寒恶冷，喜热饮，天冷加重，舌淡苔白滑，脉沉弦，喜用小青龙汤化裁温化寒饮，宣肺化痰止咳；湿痰犯肺见咳痰白粘量多，恶心呕吐，痞满胸闷，纳差，舌淡，苔白腻，脉濡滑，多用苏子降气汤出入标本兼顾，行气化痰止咳。老年之人，五脏日虚，本病病程绵长，反复发作，耗损正气，且肺为娇脏，用药处方时须顾护正气，药味以清灵活泼为主，药量轻，少而精，佐以扶正之品，祛邪不伤正，扶正不碍邪。

如治俞某，女，73岁，退休工人，1992年10月22日初诊。反复咳嗽胸闷10年，加重1周，痰多色白质粘，咳嗽晨间加重，痰出咳平，伴纳减少，神疲乏力，腰膝酸软，舌淡，苔白腻，脉濡。诊为慢支（痰湿犯肺型），选用苏子降气汤加减降气平喘，祛痰止咳。药用紫苏子12g，半夏

10g, 前胡 6g, 当归 10g, 生甘草 5g, 杏仁 6g, 桔梗 6g, 紫菀 10g, 炙款冬花 10g, 5 剂。复诊: 咳嗽、胸闷缓解, 痰少, 精神好转。上方去紫菀、款冬花、杏仁, 加肉桂 3g, 炒白术 6g, 菟丝子 15g, 14 剂后症平。本病案患者年已古稀, 久病不愈, 正气亏损, 适新感外邪, 病情复杂, 本虚标实, 急则治标, 以紫苏子、半夏、前胡、杏仁、桔梗、紫菀、炙款冬花降气化痰, 平喘止咳, 佐以当归、甘草扶正补气血。复诊时标实之症大减, 加入炒白术、菟丝子、肉桂肺脾肾兼顾, 扶正固本而获效。

②治病求本, 从肺脾肾三脏辨治: 景岳曰: “若内伤咳嗽, 则病来有渐”, 又云: “则病必自上而下, 由肺由脾, 以极于肾”。姚氏认为, 本病重点在于缓解期治疗, “缓则治其本”。本病之本乃正气虚衰, 随病程延长, 病情发展, 逐渐由肺气虚, 肺阴虚而至脾气虚, 肾阴、阳虚, 阴阳两虚。临床证出多变, 常多脏器同病, 诊治棘手。治本之法应从肺入手, 兼顾脾肾, 应诊时多分四个证型证治。肺气虚弱则咳声低微, 痰多清稀, 自汗乏力, 脉弱无力, 舌淡, 苔白, 选用六君子汤补肺益气, 化痰止咳; 肺阴不足证见干咳少痰, 盗汗, 口干, 脉细, 舌红少苔, 姚氏擅用沙参麦冬汤养阴润肺, 清热止咳; 脾肾阳虚则见咳喘, 动则加重, 腰酸尿频, 痰多清稀, 畏寒纳差, 脉沉细无力, 舌淡胖, 苔薄白, 姚氏喜用金匱肾气丸加味温肾健脾, 纳气平喘; 肺肾两亏证见咳喘痰多味咸, 胸闷短气, 盗汗, 耳鸣, 腰酸足软, 脉虚无力, 舌淡, 少苔, 常用金水六君煎肺肾双补, 化痰平喘。临床上病程不长, 体质较好的慢支患者, 仅见肺虚之症; 病程绵长, 素体较弱的慢支病人, 多见肺脾肾多脏器亏损之象, 但遣方用药时, 因老年之人, 五脏日虚, 阴阳处于弱平衡状态, 故往往加入山药健脾益气,

菟丝子温肾壮阳，兼顾先后天之本，使气血生化有源。同时，根据病情发展规律，也符合“不治已病治未病”的原则，先安未伤之脏。

如治陈某，男，70岁，退休工人，1992年8月2日初诊。反复咳喘14年，咳痰量多味咸，伴胸闷短气，腰酸足软，潮热盗汗，舌红，苔白腻，脉细滑，诊为慢支（肺肾两亏型），选用金水六君煎加减肺肾双补，化痰平喘。药用当归12g，熟地20g，党参15g，黄芪15g，茯苓12g，生白术6g，法半夏10g，陈皮6g，菟丝子12g，五味子6g。7剂后诸症减，继服21剂，一冬未发。老年之人，阴气多亏，所谓年四十而阴气自半。本案以熟地滋肾；当归养血；以党参、黄芪、茯苓、白术补肺健脾，使气血得以生化；陈皮、法半夏理气化痰；佐以菟丝子补肾；五味子纳气平喘。标本兼顾，服用近月而收效。

③久病入络，痰瘀同治，佐以扶正：前贤云：“肺胀满，即痰与瘀血碍气，所以动则喘急”。慢支病程长，根据中医“久病入络”原则，在本病后期要注意瘀血之症，往往痰瘀互结，症见胸刺痛，咳喘，痰出不畅，唇绀，脉涩，舌紫暗有瘀点等，治疗时以活血化瘀、通络止痛为主，佐以祛痰止咳平喘。方用桃红四物汤、二陈汤合葶苈大枣泻汤三方出入。

如治顾某，女，75岁，退休工人，1992年10月21日初诊。反复咳喘20余年，咳痰不爽，胸闷刺痛，部位固定，腰酸痛，纳少神疲，脉细涩，舌红边有瘀点，苔少。诊为慢支（痰瘀交阻型），选用桃仁10g，红花6g，赤芍10g，当归10g，生地20g，陈皮6g，法半夏10g，茯苓10g，桔梗6g，葶苈子（包）12g，大枣15g，山药15g，菟丝子12g，7剂后症减痛止。改服金匱肾气丸，每

日2次，每次9g，1月症平。患者久病未愈，迁延入络，出现气滞血瘀之证，痰瘀互结，兼见肺脾肾三脏之虚象，病情复杂。先以桃红四物去川芎活血化瘀，通络止痛，二陈合葶苈大枣泻肺汤祛痰止咳平喘，佐以菟丝子、山药扶正固本而症减，后用金匱肾气丸补肾助阳，巩固疗效，防病复发。^[6]

6. 王有奎诊治经验

王氏以治疗呼吸道疾病见长，通过对大量慢性支气管炎患者的系统观察和治疗实践，积累了丰富的经验，对本病具有独到见解和治疗方法。对慢性支气管炎分以下五型治疗。

①阴虚肺燥型：口干咽燥，咽痒而咳，痰液粘稠，咳吐不利，或有轻度气短。宜养阴润燥，利痰止咳。以润肺汤主治，方药为桑白皮、苏子、天花粉、冬瓜子、百部、款冬花、党参、麦冬、五味子。若无痰可加川贝母、沙参，夜晚咳嗽加知母。

②脾虚痰湿型：痰多咳嗽，痰易咯出，多为痰凉背冷，胃脘胀满，食后加重，不欲饮食，倦怠无力，舌苔厚腻，脉缓。宜健脾和胃，祛痰止咳。以健脾祛痰汤主治。方药为党参、半夏、陈皮、茯苓、白术、紫菀、款冬花、苏子。背冷加干姜；痰凉加白芥子、干姜。

③痰气交阻型：咳嗽，胸憋，喘促，痰多不利，烦躁易怒，恼怒时病情加重，舌苔薄白，脉弦。宜理气化痰，止咳平喘。以苏子杏仁汤主治。方药为苏子、杏仁、麻黄、枳壳、厚朴、紫菀、款冬花、天花粉、冬瓜子、甘草。

④肺热型：咳嗽，痰多粘稠，色黄，胸闷，口苦，或兼发热，便秘尿黄，舌苔黄，脉数。宜清热化痰。以清金

化痰汤主治。方药为胆南星、瓜蒌、黄芩、枳壳、浙贝母、杏仁、葶苈子、桑白皮、鱼腥草、知母。

⑤肺肾两虚型：气短，活动加重，咳嗽，痰多不利，倦怠无力，舌苔腻，脉弦数。宜补肾纳气，化痰止咳。以复健汤加苏子、紫菀、款冬花主治。方药为熟地、山药、茯苓、五味子、黄芪、当归、补骨脂、胡桃肉、党参（或人参）。

慢性支气管炎虽是以咳嗽、咯痰为主症的疾患，但并非单纯消炎或化痰止咳就能取得满意疗效。而必须根据辨证分型进行针对性治疗才能提高疗效，进而达到治愈目的。王氏通过长期观察和治疗实践，认识到本病可分五个类型，根据每型特点可用燥、痰、郁、热、虚五个字来概括。阴虚肺燥型关键在于“燥”，口干咽燥、咽燥痒则咳、痰少不利；脾虚痰湿型关键在于“痰”，痰多而利，多兼脾胃虚弱之症；痰气交阻型关键在于“郁”，胸憋、气喘咳嗽、咯痰不利；肺肾两虚型关键在于“虚”，气短，活动加重，痰多不利。

慢性支气管炎属内伤咳嗽范畴，在治疗过程中可根据以上辨证，针对各型主症，采取扶正祛邪，标本兼治的方法才能取得满意疗效。对各型不但要采取不同的化痰止咳方法，而且要采取相应的扶正固本措施。

慢性支气管炎虽为内伤咳嗽，但很难不治自愈。患者体虚不甚时，病情发展不大，经数年甚至数十年，仍病情如初，往往不引起病人的重视而失于治疗。但患者年老体衰时往往会骤然加重，出现以气短、活动加重等主要症状，此时多合并不同程度的肺气肿，病情严重，治疗也较困难。因此，对于慢性支气管炎，应掌握其发展规律，进行早期治疗，以达到根治目的。^[7]

7. 洪广祥诊治经验

洪氏专注于肺系病的临床研究，尤其对慢性支气管炎的诊治独树一帜，临床疗效显著。

①师古而不泥古，独创“治肺不远温”的辨证思路：中医认为慢性支气管炎多属咳嗽、痰饮、喘证等范畴。以冬春两季发作为甚。洪氏通过对本病的深入研究，深刻体会到痰饮是其主要病理基础，外感风寒、饮食生冷常为本病的诱发因素。风寒之邪，外侵皮毛，内束肺气，肺失宣肃，津液内停，聚而成痰；或饮食生冷，损伤脾阳，脾失健运，水湿不化，痰浊内生；或肺、脾、肾三脏功能失调，水液代谢障碍，聚湿生痰。痰饮为阴邪，遇寒则聚，得温则行，故洪氏提出“治肺不远温”的治疗原则，不仅是对张仲景“病痰饮者当以温药和之”学说的深化和发展，而且明确了治疗慢性支气管炎的辨证思路。所以在临床上不论是久郁寒饮化热者、阳虚痰瘀化热者还是热证化寒者均以温化寒饮为本。基本方：生麻黄 10g，细辛 3g，法半夏 10g，生姜 3 片或干姜 6g，紫菀 10g，款冬花 10g，白前 10g，矮地茶 10g。如伴痰白量多者，加小皂荚 6g；伴干咳无痰或咯痰不爽者加浙贝母 10g，冬瓜仁 10g 或桃仁 10g，沙参 10g 以润化滋阴；伴痰黄粘稠，苔黄腻者加鱼腥草 30g，黄芩 9g，天葵 10g，野荞麦根 15g；伴气喘明显者加葶苈子 15g，青皮 10g，陈皮 10g；伴大便秘结者加生大黄 6g。

如治陈某，男，61 岁，1994 年 11 月 20 日初诊。主诉：咳嗽反复发作 1 年余，近因气候转冷，2 周来咳嗽明显加重。某医院诊断为慢性支气管炎（单纯型），经服抗生素、止咳药等对症处理，效果不显。就诊时闻咳声重浊，

咯痰不爽，偶见白粘痰，咯出为快。伴胸闷气喘，口干思饮，纳可，大便偏干，数日一行，舌质红暗，苔黄腻，脉弦滑。证属寒痰内伏，郁久化热。治宜温化寒痰，宣肺止咳兼清郁热。处方：生麻黄 10g，细辛 3g，法半夏 10g，干姜 6g，紫菀 10g，款冬花 10g，白前 10g，芦根 30g，鱼腥草 30g，葶苈子 15g，青皮 15g，陈皮 10g，生大黄 6g，5 剂，水煎服。二诊：服药后咳喘明显减轻，咯痰易出，大便通畅，胸闷改善。守原方出入 10 剂，诸症悉除。

②治病必求其本，重视益气护卫法在治疗本病中的作用：洪氏认为，慢性支气管炎反复发作，缠绵难愈的根本原因是患者久病体虚，自身免疫功能低下导致恶性循环引起的。故患者平素多畏风怕冷，极易感冒，尤以气候交变之时或早晚阴盛之时表现明显。属于中医的卫气不固，气阳两虚证。此因除与先天禀赋有关，还与寒痰伏肺，痰瘀交结伤及阳气或咳、痰、喘反复发作重伤阳气有关。所以在治标之时必须配合益气护卫法，多选生黄芪 15~30g、防风 10g、白术 10g、熟附子 10g 等，方可大大提高疗效，缩短疗程。

③不忽视鼻腔疾患的治疗是提高慢性支气管炎疗效的重要因素：鼻为肺之窍，是呼吸出入的门户，不仅对呼吸有调节作用，而且对下呼吸道也有保护作用，据洪氏长期的观察证明，慢性支气管炎患者中有 80% 伴有鼻腔疾患，如慢性鼻炎、过敏性鼻炎等，故患者多伴鼻塞，流稀涕，喷嚏多或鼻痒等症状，以晨起为甚。洪氏认为其病机重心是肺肾阳虚，所以在治疗慢性支气管炎的同时配合运用温阳宣窍利鼻法兼顾治疗鼻腔疾患，收效甚捷。临床多选生黄芪 15~30g、仙灵脾 10g、仙茅 10g、防风 10g、白术 10g、路路通 30g、卫矛 10g、辛夷花 10g、苍耳子 10g 等，

其中路路通、卫矛具有抗过敏的作用，对于过敏性鼻炎效果尤佳。辛夷花、苍耳子宣窍利鼻，引药上行。

④上下兼顾，温肺不忘利咽：慢性支气管炎长期迁延不愈易引起咽部炎症，临床上患者多伴有咽部不适，自觉有梗阻感，似有痰粘，但咯之不出，或咽痒难忍作咳，或咽痛等症状，咽部望诊可见局部充血，滤泡增生。所以对于慢性支气管炎合并咽炎的患者，洪氏多运用上下兼顾的方法，在温化寒痰之中加桔梗 6g、瓜蒌皮 15g、白僵蚕 10g、射干 9g、牛蒡子 15g、白鲜皮 15g、地肤子 15g、木蝴蝶 10g、丹皮 15g、赤芍 15g 等行气化痰利咽之品。其中丹皮、赤芍可改善咽部的微循环，促使局部血液运行。

如治黄某，女，42 岁，1995 年 1 月 10 日初诊。主诉：咽痒作咳 3 个月，遇风寒加剧，咽部如虫爬行，瘙痒难忍，咯痰不利，伴胸闷气短，鼻痒，晨起多喷嚏，流清涕，平素极易感冒，自觉畏风怕冷，纳可，二便正常，舌淡红，苔白腻，脉沉滑。证属气阳两虚，寒饮内伏。治宜益气护卫，温化寒饮为主，兼宣窍利咽。处方：生黄芪 15g，防风 10g，白术 10g，仙茅 10g，仙灵脾 10g，路路通 30g，卫矛 10g，生麻黄 10g，细辛 3g，干姜 6g，法半夏 10g，紫菀 10g，款冬花 10g，白鲜皮 15g，地肤子 15g。7 剂，水煎服。二诊：服药后咽痒明显改善，咳嗽减轻，苔白腻变薄，守原方出入，处方：生黄芪 30g，防风 10g，白术 10g，仙茅 10g，仙灵脾 10g，路路通 30g，卫矛 10g，地肤子 15g，白鲜皮 15g，桂枝 10g，赤芍 15g，白芍 15g，桔梗 6g，炙甘草 6g，生姜 3 片，大枣 6 枚。7 剂，水煎服。三诊：药后自觉咽部症状消失，咳嗽已愈，诸症均减，嘱其自服玉屏风散口服液以善后。^[8]

8. 葛琳仪诊治经验

葛氏临床经验丰富，早在 70 年代，即开始致力于对慢性支气管炎采用中医中药治疗的研究，积累了一套行之有效的经验。

①发作期以清为治：慢性支气管炎急性发作期患者，多由外感引动宿饮，表证较为明显，表现为发热、微恶寒、咽痛咽痒、咳嗽痰少等。葛氏擅长运用清法贯穿始终，治疗多采用清宣为主，重用金银花、连翘、牛蒡子、黄芩、蒲公英、桔梗、前胡、杏仁、浙贝母、板蓝根、青果、木蝴蝶等，使邪从表而解。经过治疗，表证渐去，对痰热（浊）壅肺，肺失肃降所致咳嗽、咯痰量多、气喘、动则尤甚、舌苔黄（白）腻为主要表现者，则以清化、清降为治，处方多投黄芩、蒲公英、重楼、野荞麦根、炒苏子、莱菔子、牛蒡子、姜半夏、厚朴花等。

盖本病的起因，或由于外感风热之邪，内合于肺，肺气壅塞，不能输布津液而聚成痰热；或由于饮食不当，恣食肥甘、生冷，脾运失健，痰湿内生，上壅于肺，日久郁而化热成痰热，故治疗当以清为主。间或个别患者感受外感风寒之邪，恶寒重，发热轻，亦多属“寒包火”证，治疗虽可辛温解表，但仍需清泄里热，否则风寒之邪很快入里化热，恐有助痰热、生痰火之虑。现代医学认为，慢性支气管炎急性发作期都存在细菌感染的问题。而现代药理研究则认为，金银花、连翘、黄芩、蒲公英、重楼、野荞麦根之类均有广谱抗菌作用，能抑制金黄色葡萄球菌、肺炎球菌（杆菌）、链球菌等生长。

②迁延期重在健脾补肾：慢性支气管炎迁延期的患者，主要表现为咳嗽咯痰、痰多色黄（白）、晨起明显、动则气

喘等痰热（浊）壅肺之症，“脾为生痰之源，肺为贮痰之器”，久病之体，因脾失健运，水谷不得化生津液，聚成痰湿，是肺之痰浊的主要病因。故在清肺化痰的基础上，加入白术、薏苡仁、茯苓、猪苓健脾助运，淡渗利湿，是葛氏常用的方法。《本草述·卷十六》曰：“薏苡仁，除湿不如二术助燥，清热而不如芩、连辈损阴，益气而不如参、术辈犹滋湿热，诚为益中气要药”。现代药理研究则认为：茯苓、猪苓有增强机体免疫功能的作用，可提高机体抵抗感染的能力。

在健脾利湿助运的同时，葛氏还十分重视补肾纳气以平喘。盖“肺为气之主，肾为气之根，肺主出气，肾主纳气，阴阳相交，呼吸乃和。”反复咳喘的患者，久病必虚，而肾虚不能纳气又是导致患者气喘、动则更甚的主要原因。因此治疗痰热渐化的患者，在继续清化的同时往往加入补骨脂、枸杞子平补肾之阴阳。现代药理研究证实，枸杞子可提高机体的免疫功能，而补骨脂不仅具有抗衰老作用，亦有明显的平喘作用，对由组织胺引起的气管收缩有明显的平喘功能。清热化痰与健脾、补肾，看似矛盾的两个对立面，但只要选择适宜的时机合理配伍，实乃“治病求本”的根本所在。

中医学认为久病必瘀。慢性支气管炎的患者，痰壅于肺，肺失宣肃，气不煦则血不濡，多发展成气血瘀滞之证，症见唇黯舌紫、面色晦黯、手足青黑等，可适时加入当归、丹参、莪术等药，以行血导滞。

③缓解期宜用冬病夏治：慢性支气管炎缓解期的病人，发病日久，肺、脾、肾三脏多有虚损。葛氏认为由于个体禀赋的不同、病程长短的不一、病邪寒热的偏盛，可出现津气、阴阳不同程度的耗损，故治疗当仔细明辨、灵活用

药，可分别采用清热生津、补益肺气、健脾助运、补肾纳气、温阳利水、滋阴清热等治法。药用南沙参、北沙参、麦冬、玄参、五味子、党参、炒白术、薏苡仁、茯苓、补骨脂、枸杞子、制玉竹、仙茅、淫羊藿、车前子、泽泻等。此类患者临床上往往是肺脾两虚或脾肾两虚，甚或肺、脾、肾三脏俱虚同时存在，故而需采用多种方法联合运用方能奏效。

葛氏经过几十年的临床，摸索出夏天“三伏”季节服用中药治疗慢性支气管炎的经验。因为慢性支气管炎的患者在冬春寒冷季节气候多变的情况下易感受外邪，引动宿饮，诱发咳、痰、喘。这说明此类患者的卫阳亏损、腠理空虚，故易致反复受邪，此期治疗多以驱邪为主。而夏季“三伏”，是一年中外界阳气最盛时期，卫阳固护，不易外感，故是培补虚损之体的大好时机。同时，中医学认为“春生、夏长、秋收、冬藏”，夏季是一年中机体生长更新的旺盛时期，此期投以补益之剂如清炙黄芪、炒白术、防风、党参、茯苓、薏苡仁、人参叶、补骨脂、枸杞子、制玉竹、当归、仙茅、淫羊藿等治疗虚损的脏器，往往能收到事半功倍之效。^[9]

9. 高复安诊治经验

高氏长期从事老年医学研究，学验俱丰，尤以擅治老年性慢性支气管炎而称著。

①补肺益肾治病求本：老年慢性支气管炎属中医“内伤咳嗽”、“痰饮”、“喘证”等范畴。老年人元气渐衰，肺、脾、肾不足，既易滋生痰饮，又易感受外邪，导致肺失宣肃而咳嗽不已。高氏认为，究其病之根本，还在于肺肾亏虚。《景岳全书》云：“凡内伤之嗽，必皆本于阴分，何为

阴分，五脏之精气是也，然五脏皆有精气，而惟肾为元精之本，肺为元气之主……肺肾俱病则他脏不免矣”。肺与肾乃金水之脏，肺为气之主，肾为气之根，病则可彼此影响，互为因果。久咳不愈伤肺，肺气日虚，母病及子，病则由肺传肾，导致肾也亏虚；肾虚水泛，为痰为饮，上阻于肺，又致咳嗽不已。最终必致肺肾俱虚，宣降摄纳失司，咳喘繁剧，缠绵难愈。这是老年慢性支气管炎的基本病机特点。高氏强调“治病必求其本”，故补肺益肾为其治疗该病的基本原则。他认为即使在急性发作期，也不能仅仅是见痰化痰，见喘平喘，而应标本兼顾，扶正祛邪。临床上常用的药物有人参、麦冬、五味子、熟地、山药、山茱萸、补骨脂、蛤蚧、冬虫夏草等。久咳久喘，耗气伤阴，治疗肺虚高氏常用生脉散，特别是五味子，在所必用。谓其“既主益气，又善敛阴，补肺滋肾，平喘止咳，不可或缺”。肾阴虚者用熟地、山药、山茱萸；肾阳虚者用制附子、肉桂、补骨脂等。兼风寒加荆芥、防风；兼风热加桑叶、菊花；有寒饮加细辛、干姜；有热痰加川贝母、鱼腥草；咳重加杏仁、款冬花；痰多加半夏、葶苈子；喘甚加黑锡丹；神疲肢软，纳呆便溏加党参、白术、炙甘草益气健脾。

如治某男，68岁，1996年12月25日初诊。患慢性支气管炎10余年，肺气肿3年。近半月来病情加重，反复咳嗽。痰黄稠不易咯出，咳甚则喘，伴腰酸肢软，五心烦热，咽干口燥，舌红，少苔，脉细数。辨证为肺肾阴虚，痰热壅肺，治以补肺滋肾，清热化痰。处方：熟地、太子参各15g，款冬花15g，山药30g，鱼腥草30g，山茱萸10g，麦冬10g，五味子10g，知母10g，黄柏10g，川贝母10g，百部10g，杏仁10g，甘草10g。每天1剂，水煎分早晚2次服。服7剂后，咳嗽减轻大半，痰色转白，咯出较畅，仍

五心烦热，纳食不香，原方加地骨皮 10g，谷芽 30g，麦芽 30g，继服 7 剂，咳嗽基本痊愈。后服固本咳喘胶囊，每次 5 粒，每日 3 次。连服 3 个月，随访 1 年，未见复发。

②治肺从脾培土生金：高氏对老年慢性支气管炎，虽重视肺肾二脏，但从未忽略脾虚这一重要因素。脾胃乃后天之本，气血生化之源，若脾失健运，水谷既不能化为精微上输以养肺气，也不能下输以滋肾元，反而聚为痰浊，上贮于肺，肺气壅塞则上逆为咳。由此可见脾虚对本病之邪实与正虚两个方面均有重要影响，尤其是后者。高氏认为是老年慢性支气管炎积年久咳，迁延难愈的一个重要因素。临床上老年慢性支气管炎患者常常见有少气懒言，倦怠乏力，脘闷纳呆，大便溏薄等脾胃虚弱的症状。高氏强调脾虚在老年人诸脏亏虚中的重要地位，常谓脾胃一虚，则四脏无所受益，机体防御功能减弱，百病易生。肺之与脾，子母相依，若脾虚不能散精归肺，则肺气先绝生化之源，此即肺最先受病。由于肺气的强弱在一定程度上取决于脾胃的盛衰，因此对一些久咳不愈的患者，采用治肺从脾，培土生金的方法，常可获得满意的疗效。临床上，高氏常用六君子汤、参苓白术散等方化裁。气虚明显者加炙黄芪，胸痞呕恶加代赭石、旋覆花，食欲不振加谷芽、麦芽，咳嗽甚加杏仁、百部，痰多加莱菔子、冬瓜仁，痰湿化热加黄芩、鱼腥草，伴有浮肿加猪苓、大腹皮，动则气喘加补骨脂、菟丝子。

如治某男，70 岁，1997 年 5 月 16 日初诊。患慢性支气管炎 20 余年，平素神疲乏力，嗜卧懒言，畏寒肢冷，极易感冒。1 月前再次因感冒而诱发咳嗽加重，痰白、为泡沫状、量多，纳食不香，便溏乏力，舌质淡，苔白腻，脉濡细。辨证为肺脾气虚，痰湿阻肺。治以健脾益肺，燥湿

化痰。方拟参苓白术散加减：党参 15g，薏苡仁 15g，白术 25g，茯苓 30g，山药 30g，谷芽 30g，麦芽 30g，炙甘草 10g，桔梗 10g，杏仁 10g，百部 10g，半夏 10g，陈皮 10g，砂仁 6g。每天 1 剂，水煎，分早、晚 2 次服。服药 5 剂，咳势已减。继进 5 剂，咳嗽、咳痰明显减少，纳差便溏好转，仍感四肢乏力。原方加羌活 10g，独活 10g。服至 20 余剂，痰消咳止，诸症皆愈。此后又在此方基础上调理巩固 2 月余，停药后随访半年，未见复发。

③化痰祛瘀标本兼顾：虽然老年慢性支气管炎患者久病为虚，但临床上单纯的虚证少见，而常为虚中夹实，出现痰、热、湿、瘀等见证。高氏强调补虚不忘邪实，不仅仅是对处于急性发作期或慢性迁延期的患者而言，即使是处于缓解期，在以扶正固本为主治疗的同时，还应化痰祛瘀，标本兼顾。他认为老年慢性支气管炎患者经过治疗虽然病情得以缓解，但毕竟是积年久咳，其肺络深部之痰一时难以尽除，痰浊郁久则化热，热伤肺络，导致瘀血内生。此外，痰浊不化，阻碍气机，也会使血行不利，产生瘀血。由此可见，痰热与瘀血是导致老年慢性支气管炎反复发作，并可能进一步发展为肺胀的两个重要的病理因素。鉴于老年慢性支气管炎的这些特点，结合自己长期的临床经验，高氏自制固本咳喘胶囊，主要用于慢性支气管炎缓解期以及肺气肿等病的治疗，药物组成为人参、蛤蚧、冬虫夏草、川贝母和三七。该方特点是肺、脾、肾俱补，痰与瘀同治。方中人参大补元气，补脾益肺，生津安神，是治疗肺脾两虚病证之要药，对老年人元气亏虚更为适宜。蛤蚧入肺肾二经，具有补肺益肾，定喘止嗽的功效。冬虫夏草，《本草从新》谓其“保肺益肾，止血化痰，止劳嗽”。三药合用，可谓固本而无虞。川贝母与三七，清肺化痰，活血祛瘀，

二药合用以治标。川贝母入肺经，性凉而甘，兼有润肺之功。三七善化瘀血，又能止血妄行，对热灼金伤者尤为适宜。经大量临床观察表明，该药疗效显著，能预防感冒，减少老年慢性支气管炎复发，减轻咳、痰、喘症状，明显延长缓解期。实验研究证明有增强机体免疫功能、提高动脉氧含量的作用。^[10]

10. 胡翹武诊治经验

胡氏精于医理，更善辨证，组方用药严谨活泼。平淡之中常能出奇制胜。治疗老年慢性支气管炎（以下简称“老慢支”）有独到经验。

①老慢支患者以气阴两虚为多，治节无权，宣肃失司，故滋益气阴，补肺固金为其重要一环。历代补益肺金之方甚多，胡氏认为唯生脉散最佳，以人参益肺气，麦冬养肺阴，五味子既可敛肺生津，又可收耗散之气。如阴虚甚者，加南沙参、北沙参、百合等；气虚甚者，加炙黄芪、炙甘草。

肾为水脏，主藏精，故滋水润金为肺阴不足常用之法，特别于老慢支患者尤宜。其症为咳喘气急，动则转甚，形体瘦削，面颊潮热，腰膝酸软，头昏目眩，耳鸣耳聋，舌红，少苔，脉细数等，方以六味地黄丸合生脉散化裁，宜去茯苓、泽泻，加玄参、天冬、南沙参、北沙参等，俾金水相生，互滋互充。若兼精血不足者，龟板胶、阿胶、冬虫夏草等肺肾兼补之血肉有情之品也可随症选入。

脾为后天之本，气血生化之源，五脏皆禀受于此。肺气不足之因脾土亏虚者不为少见，故补益肺气而收效不显者，可从脾土求之。症如纳少神疲，四肢倦怠，少气懒言，中脘不适，大便溏泄，咳喘经久，气不接续，稍劳则甚，

舌淡脉虚等一派脾土不足、中气亏虚者，非培补脾土无以使肺气旺盛，治以保元汤合补中益气汤化裁，兼寒者加少量干姜，与肉桂同用，既可温中散寒，又有“少火生气”之用。其量宜轻勿重，缓缓调治。若肺气亏虚因肾阳失煦，徒温补肺气，补益中气不奏效者，当温养肾督，以煦补肺气，其症多为形寒肢冷，腰膝酸痛，咳喘气不续接，动则更甚，痰涎清稀，口淡乏味，尿清且频，舌淡润、苔白薄，脉沉迟等，方宜右归丸加紫河车、紫石英、胡桃肉、五味子等，坚持服用，或蜜丸缓投，常可收效。如肺阴亏虚因脾阴不足所致者，症如喘咳气急，口干欲饮，纳差脘痞，面颊唇舌淡红，尿淡黄，大便或结或溏，脉虚濡且数等，非滋养脾阴无以建功，此与肾阴不足无以润肺者有别，六神散合生脉散加百合、北沙参、西洋参为佳，此也为培土生金之法。

②本病有有形之痰痹阻，故消除痰浊对畅通气道，恢复正常吐纳具有十分重要的作用。痹阻气道与壅遏肺金之痰大致有寒热之分，其中以热痰更为常见。症如咳痰不爽，或痰黄质稠，或稀薄之中夹有黄豆大小之坚韧老黄痰；胸膈灼热憋闷，口干或喜饮，舌红、苔黄腻，脉滑数等。清化热痰之方以雪羹汤、苇茎汤最为合拍，葶苈子、泽漆、贝母、海浮石等也可随症加入。葶苈子对久蕴肺金之痰热有“披坚执锐之才，以成捣穴犁庭之绩”，“且体质本轻，故能上行入肺，而味又甚淡，何至猛烈乃尔。”（《本草正义》）小剂 6g，重剂 30g，清化热痰之功诚非他药之所能及。泽漆功主利水消肿，杀虫解毒，然其消痰止咳也为其独擅。胡氏于老慢支为痰热蕴壅者，常以此二药辅佐苇茎、雪羹汤中。然葶苈子长于下气定喘，泽漆长于利水消肿，此又为同中有异，可视不同症情而择用之。至于寒痰之阻

遏，咳痰清稀，胸背憋冷，形寒肢凉，口淡多涎，面色青晦，舌淡润、苔白滑，脉沉弦紧等症，治以二陈汤加白芥子、细辛、皂荚、制南星等。其中白芥子、皂荚为治寒痰顽结之佳品。白芥子辛温入肺，功擅利气豁痰，温中散寒，凡寒痰凝痹肺络者非此不除。皂荚辛温有小毒，除痰力猛。白芥子尚能利气温中，皂荚还兼疏风开窍，此为不同之处，也应随症选用更佳。尚有控涎丹，本为《韩氏医通》主治高年咳嗽气逆痰痞之良方，对老慢支之属顽痰壅遏者甚为合拍，应视体质之强弱，而予不同剂量缓投。

久咳络瘀，方书论之不多，就临床以久病入络推理外，诸如唇舌紫黯、胸膈闷痛、甲床紫黯按不褪色，或痰中夹有紫色血块、口干不欲饮水、脉涩等症也足以说明之。致瘀之由除痰浊痹阻、气机郁遏等因素外，与经年久咳，由气及血，由肺累心，心主受损，血流不畅，脉络受阻之原因尤为有关。历代贤哲在制配治咳喘方剂时，也有佐辅活血逐瘀之品者，如苇茎汤中之桃仁，金沸草散中之赤芍，苏子降气汤中之当归等。胡氏常用活血逐瘀之品，药如丹参、当归、桃仁、赤芍、马鞭草、红花等随症选入、佐辅于相应方中，可起事半功倍之效。

老慢支患者由于正虚邪实，一遇季节变更，或气温突然由暖转冷，乘虚袭入之客邪，则肺又首当其冲，如此内外合邪，郁遏太阴，咳喘之疾因此诱发或转甚者屡见不鲜。如终日洒淅恶寒，四末不温，此与肺之阳气虚弱虽有相似之处，但彼得衣被可减，此则不然，或头身酸楚，咽喉不利；气虚湿痰虽也有此症，但彼多短气身困，此多咽痛且痒；再如咳声重浊，鼻塞不通，时流清涕，舌淡上浮白薄之苔，脉浮寸显等症。临床所见外邪客袭，冒风感寒者十居八九，暑热而致者不过一二，故辛散宣透为常用之法，

在众多疏风解表宣肺方中，胡氏则以止嗽散为首选方剂。此方单独用也可，配伍相应内治方中也可。若感寒甚者，三拗汤较宜；胃受暑热者，香薷饮合越婢汤化裁，务使客邪速去，咳喘之症辄愈大半，再针对正虚状况，稍事调理，临床诸症均可逐日缓解。^[11]

11. 陈树森诊治经验

慢性支气管炎是常见的多发病，属于中医的“咳嗽”、“痰饮”、“咳喘”范畴，本病常反复发作，经久不愈。陈氏的治疗经验是急则治标，缓则治本。在急性发作期须分寒热。寒证：咳嗽比平时加重，咳痰稀白量多，甚者喘息不能平卧，恶寒发热，舌苔白腻，脉弦紧。治以散寒化痰，宣肺降气，镇咳平喘，常以小青龙汤加减：炙麻黄 9g，桂枝 9g，白芍 10g，杏仁 10g，细辛 5g，制半夏 10g，甘草 6g，干姜 5g，五味子 6g，黄荆子 15g，橘红 9g。如咳喘剧烈，不能平卧者加射干、款冬花，甚者加天仙子粉 0.1g（冲服），每日 3 次。热证：咳嗽咯痰黄粘不爽，发热口干，舌红，苔黄，脉滑数者，治以清肺化痰，常以麻杏石甘汤加味：炙麻黄 9g，杏仁 10g，甘草 9g，生石膏 30g，鱼腥草 20g，野荞麦根 30g，炒黄芩 15g，知母 10g。咳甚加川贝粉（分冲）6g、枇杷叶、矮地茶。喘加炙马兜铃、地龙。痰粘咯不爽加桔梗、麦冬。慢性迁延期：当标本兼顾，如病久肺脾两虚，痰湿壅盛，咳嗽痰多而浊，色白或灰白，但易咳出，纳差腹胀，或大便时溏，神疲乏力，舌胖，苔薄或腻，脉缓弱或弦滑者，治以补气健脾，燥湿化痰，常用六君子汤合三子养亲汤加减：党参 15g，炒白术 10g，茯苓 10g，炙甘草 3g，制半夏 15g，橘红 10g，炙紫菀 10g，百部 15g，白芥子 10g，炒莱菔子 10g，炙苏子 10g（后三

味研细末，分3次冲服)。纳差加焦神曲、焦山楂、焦麦芽、山药，自汗容易感冒加黄芪。如久延肺肾两虚，降纳失司，咳嗽伴有喘息，气短，呼多吸少，动则尤甚，腰膝酸软，舌淡或紫暗、苔薄或无，脉弱或虚数，治以补肾纳气佐以活血化痰，常用麦味地黄汤合人参蛤蚧散加减：麦冬15g，五味子6g，生晒参9g，山茱萸9g，茯苓10g，丹皮9g，泽泻10g，蛤蚧粉4g（冲服），紫河车粉9g（冲服），杏仁10g，丹参15g。肾阴虚加知母，肾阳虚加补骨脂、仙灵脾。如病情稳定，临床缓解期，咳喘不明显，痰量很少，时易自汗气短，动则尤甚，此时治疗应予扶正固本为主，佐以化痰活血，方用人参、蛤蚧、虫草、三七、川贝母等分研细，水泛为丸或胶囊装，每次服2g，每日3次，久服有效。此外宜加强锻炼，如气功、太极拳等，以改善肺功能，预防感冒及气管炎的发作。^[12]

12. 曹鸣高诊治经验

外感咳嗽如迁延失治或年老体弱反复感邪，损伤肺气，肺失肃降，气不归根，终成反复发作之慢性支气管炎，此类病人见诸临床以属虚寒为多，患者常咳而短气，倚息不得卧，痰吐白膩，怯寒神倦，肢冷，苔白，脉细软。宜用“劳者温之，损者益之”之法。如归身、款冬花、狗脊、党参、丹参、远志、白术、桂枝、茯苓、陈皮、川贝等以温肺化痰，补益心脾。如咳呛阵作，咽燥口干，痰多黄脓或痰中夹血，肺阴本虚，炼液成痰，痰郁蒸热，肺失清肃下行之常。宜清肺泄热，顺气化痰，药用：桑白皮、地骨皮、黄芩、知母、射干、海蛤壳、生石膏、芦根、白前、瓜蒌皮、生甘草。如咳嗽痰鸣，气急，能俯不能仰，足跗浮肿，可用葶蒌大枣泻肺汤。如咳血色鲜，方中加入醋制大黄

3g、参三七粉 3g 调服。还有些病例如肺阴既虚，脾阳又亏，温燥则伤肺，清润又碍脾，此时需找出矛盾的主要方面，分清主次，如咳嗽痰稀火升，咽燥脉细数又兼纳呆、便溏、神倦怯寒，只要舌不红、苔不燥，宜治脾为先，佐以养肺。可用七分脾药，三分肺药，脾得健运，津液上输于肺，而肺得濡养。如咳吐浓痰，痰中带血，咽燥口干，舌质红、苔糙黄或有裂纹，自当以阴伤肺燥为主，虽便溏纳呆，重点宜先治肺而用七分肺药，三分脾药，但宜清润不宜柔腻。如咳嗽经久，三阴并亏，上则肺失肃降，中则脾失健运，下则肾失摄纳，升多降少，动则喘息，自汗肢冷，宜人参、蛤蚧尾、霍山石斛、煅牡蛎、煅龙骨、北五味、川贝、甘草等以扶正培元，平补三阴。慢性支气管炎急性发作的病人，在病情控制后可服下列丸方以作固本治疗：炒党参 45g，白术 45g，茯苓 45g，沙参 45g，炙黄芪 50g，桂枝 20g，白芍 30g，防风 30g，阿胶 45g，百部 30g，苏子 45g。上药共研细末，水泛为丸如绿豆大，每日服 2 次，每次 6g，开水送服。如腰酸下遗，动则喘息，可在丸方中酌加大熟地、山茱萸、枸杞子、淡干姜、北五味。^[12]

13. 姜春华诊治经验

慢性支气管炎以虚寒性为多，急性发作也可见到实热类型。急性发作以解表为主，兼治咳嗽。姜氏治慢性支气管炎早年也从辨证论治，摸到一点规律，即见咳休治咳，体虚者加以补益，肾虚补肾，肺虚补肺，脾虚健脾，因本病与此三脏有关。在治疗上宜选择重点，对于咳嗽，假如干咳痰稠，以滋润化痰为主，使其痰增加，容易咳出，就可减少咳嗽。假如痰多气壅，则常用刺激性祛痰药物，使其痰能排除，痰除则咳易止。干咳阵作以止咳为主，因为

这种咳与痰无关。痰粘成块，则以化痰为主，使痰变稀，则容易咯出，咳也易平。除上述环节，还拟了一张治咳主方，集中兵力打歼灭战，用于一般咳嗽，多获良效。其有不效者，则按辨证加减，方为：百部 9g，开金锁 15g，全瓜蒌 15g，马勃 3g，南天竹 6g，天浆壳 3 只，五味子 9g。开金锁即野荞麦根，能消菌消炎治咳。百部治咳有卓效，不拘新老寒热虚实皆可配伍应用。全瓜蒌有抗菌作用，能润肺、祛痰、止咳、平喘。马勃治咳嗽，见周吉人《集验方》，原系研粉滴冰糖含咽，现改入汤剂，恐疗效受一定影响。南天竹为观赏植物，广东药摊常与天浆壳合治百日咳，有镇咳平喘作用，但用量不可过大。天浆壳亦名萝藦，治咳嗽痰喘。五味子补肺滋肾，平喘止咳。上方寓温补清消、止咳化痰祛痰于一炉，可以不拘寒热虚实、新旧老小皆可服用。若遇痰多者常加川贝（或大贝）、半夏、桔梗，痰黄成块成丝加竹沥、竹茹、蛤粉、天竺黄；干咳无痰或痰少而粘，加麦冬、天冬、石斛、北沙参、木蝴蝶；遇有阳虚肢冷畏寒，脉微舌淡者，加附子、肉桂，或桂枝、干姜；如气虚气短懒言，四肢无力者，加黄芪、党参；如脾虚痰多咳唾不止，加入香砂六君丸、干姜。^[12]

14. 颜德馨诊治经验

慢性支气管炎急性发作之由于风燥痰热引致者，证见咳嗽，咽痒，痰粘难出，脉滑数，舌红，苔黄腻，一般宣肃之品皆无效果。颜氏常以麻杏石甘汤加葶苈子大剂宣风肃肺，直泻肺金之热，一鼓而下，往往立竿见影。用治咳嗽初起失宜，或用麻醉镇咳药太早者，久咳不已，亦验。颜氏临床体会，咽痒乃风热内寄的表现，葶苈子泻肺，釜底抽薪，风热不解即为肺实，亦治未病之意，颇具临床效

果。小儿支气管炎，常运用盛心如老师的经验，用天竺子、腊梅花、凤凰衣三味等量煎服，颇验。慢性支气管炎，始病于肺先不降，久之则波及脾肾，临床习以附子、桂枝之温化，麻黄、细辛之辛散，生半夏之逐痰，葶苈子之泻肺，随证加减配伍，以温、散、逐、泻四法合治，每多应手。凡证见咳喘胸闷，多白沫痰，形寒神怯，即以附、桂为君，温运肺肾之阳，立法重在“温”字。若咳喘气短，不得平卧，则加细辛、麻黄温散寒痰。次则重视“散”字，久咳痰粘难化，仅用温、散犹难中的，颜氏每加上生半夏9~15g，温化痰浊，往往可使大量之痰，一药而效，此“逐”痰之义不可偏废。邪满于中，冲激上逆，上迫于肺，喘逆难平，故常加葶苈子9~15g泻肺降气，以速其效。或以降香2.4g，降气亦所以泻肺，集温、散、逐、泻四法，辨证制方，适用于慢性支气管炎之偏于寒性者。南烛子本为涩带固遗之品，用治白带遗精等症。但此品有良好的镇咳作用，颜氏常于急慢性支气管炎中加本品与车前子合用，有较好的止咳作用。^[12]

15. 吴圣农诊治经验

吴氏对本病的治疗措施主要是：发时宣肺气、化痰浊；平时固表卫、温元阳；或滋肾水、养肺阴。发时的基本方是小青龙汤合射干麻黄汤之意加减。由于本病每以外感新邪为诱因，故以麻、桂宣肺温阳，细辛温肾纳气兼散寒邪，干姜温脾化湿以杜痰源，五味子或以为虽能敛肺以止咳，亦能敛邪而致咳，故有弃而不用者。吴氏认为酸敛配伍辛散，既有相反相成之功，亦有互生互制之妙。吴氏用五味子常与干姜同捣。喘满哮喘（水鸡声）为痰阻气道与喉头水肿所致。射干清热利咽可消肿以通气道。本病患者，痰

量较多，或稠粘如胶，橘、贝、夏、星之类，往往不能尽如人意。吴氏常用皂荚子 9~12g（捣），化橘红 9g，效果较好。痰黄者加生石膏 60g（先煎），即小青龙汤加石膏之意，如出现发热、剧咳、痰多、胸闷、气急“慢支继感”者，用自制的“七味清肺饮”：黄连 3g，黄芩 6g，冬瓜子 15g，黛蛤散 30g，鱼腥草 30g，生大黄 6g。《别录》谓大黄祛痰实有一定效果。平时可固表卫，温元阳。表卫不固，则外邪易入，元阳不足则内寒自生，形成了所谓“新感引动伏邪”的发病机理。所以固表卫、温元阳是“治未病”（防复发）的重要措施。而固表与温阳又是相互促进的。吴氏的基本方剂是六君子汤加黄芪、当归、黑附子、紫河车粉（吞服）。大便溏薄者加淡干姜、炒扁豆以温脾健运。其次滋肾水，养肺阴。年老久病，肺肾之阴必虚。阴虚必及阳，既易招外邪而气失宣肃，更能滋生内火而炼液成痰。为新感引动伏邪之又一机制，且肺肾本为相生之脏，故对本病之发生与复发影响极大。吴氏用自制的“滋肾养肺饮”：南沙参 12g，北沙参 12g，天冬 9g，麦冬 9g，玄参 12g，熟地 15g，当归 12g，黛蛤散（包）30g，百合 15g，生甘草 9g，鲜竹沥 60ml（另服）。有一定缓解症状、减少复发的效果。^[12]

16. 程门雪诊治经验

程氏认为，慢性支气管炎在临床上纯寒宜温的有，温而兼清的也有，纯热宜清的就很少。基于上述经验，凡本病初发，咳喘并见，程氏善用小青龙汤治之。以麻黄、桂枝等辛温解表，宣肺平喘。程氏认为，方中细辛、五味子配伍最妙。细辛温肺散寒，五味敛肺止咳，辛散之中，配以酸敛，颇为恰当。《素问·五运行大论》说：“辛生肺”，

“用辛泻之”，这个“泻”字，是驱散表邪之意，邪去则正安，起到助肺的作用，谓之“生肺”。《素问·脏气法时论》说：“肺欲收，急食酸以收之，用酸补之。”咳喘则肺气耗散，故用酸味以补其肺体，收其耗散之气。肺主呼吸，肺敛则呼出，肺张则吸入，是开阖的枢机。五味子酸以敛其肺体，细辛辛以助其肺用，一张一敛，开阖得宜，则咳喘可平。程氏还常用干姜和五味子同捣，温化痰饮，对慢性支气管炎可起帮助排痰作用。他对细辛、五味子、干姜的用量很轻，每味1~1.5g，他认为“上焦如羽，非轻不举。如用重剂，反而僨事”。程氏用小青龙汤时常与射干麻黄汤相配，用射干利咽喉，消痰涎，用紫菀、款冬花温肺化痰，并配以鹅管石温肾纳气。如咳喘不平，痰转稠黄，认为是“饮从热化”，则宜温清并用，程氏常投定喘汤。他认为本方是治疗本病“寒邪化热”的良方，方中桑白皮、黄芩相配，起到泻肺平喘清热的作用。程氏还有许多特殊的经验，他治疗老人体虚，喘甚而咳嗽轻微，汗多，用生脉散煎汤，化服《局方》牛黄丸1粒，颇有效验；治疗阳虚咳喘痰鸣，借鉴《外科全生集》阳和汤方意，用熟地、麻黄、鹿角霜、白芥子再加紫菀、款冬花、苏子、杏仁等药，亦获良效；治疗虚喘常随症选用紫衣胡桃、五味子、坎炁，可奏益肾纳气之功。^[12]

17. 黄文东诊治经验

黄氏治疗慢性支气管炎，在初发时首重祛邪，认为邪气不能外达，痰浊无以化，肺气壅遏不宜，则咳喘难平矣。他善用三拗汤加前胡、桔梗以治本病初发。但指出：治疗慢性支气管炎发作，与一般急性外感咳嗽不同，前者宜宣肃同用，可在三拗汤中加紫菀、款冬花之

类，后者以“宣”为主，不宜过早用润肃之品，否则，在邪气不清时，反有恋邪之弊。黄氏治疗本病，如肺气亏虚，汗出形寒，除舍麻黄而改用苏子、杏仁、旋覆花以降气平喘外，还配以黄芪、桂枝、白芍以益气固表，调和营卫。如肺有蕴热，痰稠苔黄，常用泻白散加黄芩清泻肺火，如肺热而兼阴虚，再加沙参、麦冬、玉竹、瓜蒌皮以养阴润肺。黄氏用肃肺药根据偏寒偏热之异，而讲究温肃清肃之别。温肃药常用紫菀、款冬花、旋覆花等，清肃药常用枇杷叶、马兜铃、桑白皮等。黄氏在咳喘平定之后，强调治本，以防止或减少复发。在补肾的同时，还要处处照顾脾胃。盖脾胃乃后天之本，气血生化之源，脾胃健运，则正气充沛，不致滋生痰湿，同时培土又有资助肾脏元气作用，故应培补脾肾并举。补脾常选用党参、黄芪、白术、茯苓、黄精等，益肾常选用紫河车、胡桃肉、补骨脂、蛤蚧等。^[12]

18. 李济仁诊治经验

慢性支气管炎患者，病情多于朝夕加甚，尤以晨起前后，暮寝之时，更见顿顿作咳，频频痰嗽，喘息气促，胸闷窒塞，直至大量痰液咯出，始见缓解。可见痰液阻塞气道为其病机。故患者每喜清晨热饮浓茶，以涤痰利气。鉴此，李氏认为豁痰利气，实属治之要法也。痰除则去其阻塞气道之弊，又消其刺激气道而致反复感染之因，临床常见痰液渐稀少或被祛除之际，即胸宽气畅病缓之时。除痰之法，大有用也。因此，李氏在治本病时紧扣“痰”，据痰辨治。李氏的经验是，①痰色白，量少质稀者，选用射干麻黄汤加减。药用射干、麻黄、细辛、紫菀、款冬花、法半夏、姜、枣之属。②痰量多、色黄、质偏稠者，以马兜

铃、海浮石、款冬花、桑白皮、杏仁、苏子、黄芩、炒葶苈子、清半夏等为主，因症化裁。③痰量中等或较多，色青灰、质稠厚者，则以炒苏子、旋覆花、紫菀、橘红、杏仁、法半夏、远志、制南星、炙甘草等为主，加减使用。由于本病患者多见老人，体质多虚，故除痰黄热显著者外，李氏常在治痰同时，加用桂附八味丸以平补肾中之阴阳，如此汤丸并进，攻补兼施，收效颇著。此外，李氏还注意择时服药。如以汤丸并进，则晨起一用附桂八味丸，为借自然与人体“平旦阳气升”之力，而助肾气发旺；二用汤药豁痰利气，清除隔夜之陈积。寝前一时许，再服汤剂，为求药效恰在喘嗽动作时得以发挥，临卧服丸剂，以补入夜阳气衰，而减夜间喘嗽之苦。李氏多年体会，临床若见服药疗效不显，未可全责方药之不灵，或因用药之法有未妥，良医者，病变而药亦变，方见回春之功。^[12]

19. 王宁诊治经验

王氏治疗慢性支气管炎常采用《金匱要略》中之射干麻黄汤取得满意疗效。射干麻黄汤主治咳喘不得平卧，喉间鸣响如水鸡声，痰多而稀，不渴饮，苔滑润，脉弦紧。本方有祛寒温肺、止咳化痰之功。适应于慢性支气管炎急性发作期，辨证属寒饮郁肺，肺气不宜者效果颇佳。但在寒饮郁而化热，或痰热郁肺，肺气不宜，痰多变稠，咳痰不爽者亦可加减使用。寒邪化热者原方中可去款冬花、细辛，加金银花、黄芩、桑白皮。痰热阻肺者可去款冬花、细辛而加瓜蒌皮、川贝、枇杷叶等。

如治一女性患者，患慢性喘息性支气管炎合并肺气肿10余年。近因感冒诱发，发热恶寒，胸闷气急，喘息不得平卧，喉中水鸡声，唇甲轻度紫绀，两肺散在性干、湿啰

音，苔微黄腻，脉细弦数，辨证为寒饮郁肺化热，予射干麻黄汤加減：射干 9g，麻黄 6g，半夏 9g，紫菀 9g，五味子 9g，黄芩 9g，金银花 15g，瓜蒌皮 9g。仅服 1 剂，患者咳嗽胸闷减轻，痰能咳出，已能平卧。

若本病迁延久治不愈，病久正气益虚，甚至合并慢性肺气肿。患者一般多无外感发热、恶寒、头痛等症状，而见咳喘久作，短气自汗，动则益甚，纳差便溏，苔白滑，脉沉细无力，辨证属肺脾两虚，则用六君子汤合生脉散，具体应用时，方中可加清热解毒药如鱼腥草、桔梗、败酱草、金银花 1~2 味。服后患者常见精神转佳，咳痰变爽，气短减轻。^[12]

20. 陈泽霖诊治经验

对慢性支气管炎的治疗，应掌握发时治标，缓时治本的原则。在急性发作时，陈氏先父陈耀堂老中医有一通用方：霜桑叶 9g，前胡 9g，牛蒡子 9g，生甘草 6g，桔梗 6g，凤凰衣 4.5g，玉蝴蝶 6g，鱼腥草 30g，野荞麦根 30g，佛耳草 15g。有发热的加黄芩、天竺黄；痰咯不爽加枳实、淡竹沥；痰液清稀加冬瓜子、白芥子；兼有气喘者加蜜炙麻黄、地龙；黄痰加蒌皮、大贝母。他认为凤凰衣治咳喘疗效甚好，此药主要来自民间单方，可能有抗过敏作用，且常与玉蝴蝶同用。在缓解期，根据中医理论“脾为生痰之源，肺为贮痰之器”及“肾虚则水泛为痰”，治本可用健脾化痰之香砂六君丸及补肾之金匱肾气丸合方常服，可使慢性支气管炎在秋冬之交减轻发作或不再发作。陈氏治本病除用以上基本方外，也采用冬病夏治法，对某些逢冬必发之老年慢性支气管炎患者，常在七八月间即予服用健脾补肾药，常用生地 15g，熟地 15g，山药 12g，山茱萸

4.5g, 巴戟天 6g, 仙灵脾 9g, 白术 9g, 党参 9g, 灵芝 9g。以上各药 10 倍量共研细末, 再用鱼腥草 30g, 佛耳草 15g, 野荞麦根 30g, 煎汤代水泛丸。每次服 6g, 每日 2~3 次, 服用 3 个月, 常可改善病人体质, 增强免疫功能, 当天气转冷, 寒潮来临时即有抗御能力, 能减轻发病或不发病。曾观察近 200 例, 有效率在 85% 左右。久病痰液壅盛, 痰量甚多, 每日超过 500ml 者, 可服控涎丹如芥子大丸 6~8 粒, 每日 3 次以泻其痰, 用苓桂术甘汤合二陈汤也有一定疗效, 可使痰液减少。咳痰日久可有少许伤阴者, 常见舌红少津, 此时应养肺阴为主, 可用生地、南沙参、北沙参、天冬、麦冬、百合、白及之类。对本病日久影响肺功能, 动则气喘, 呈肾不纳气者, 常用生晒参 30g, 蛤蚧 1 对, 共研细末, 每次服 3g, 每日 2 次, 服完为 1 疗程, 常可使肺功能有明显改善。

如治一患者, 原来上三楼一步一停, 要走一刻钟, 服参蛤散 2 个疗程后, 即能平步登楼。但此方对严重肺功能损害者效即不显, 故应早用, 迟用则少效。对于婴幼儿的咳嗽, 反复发作不易痊愈者, 为先天不足所致, 可用紫河车焙干研粉, 每次服 3g, 每日 2 次, 能使咳嗽减轻或不再发作。^[12]

21. 梁乃津诊治经验

梁氏认为老年慢性支气管炎因年老肾虚, 且久咳伤肺。若肺不主气, 肾不纳气, 则咳喘难愈。肺卫力弱, 易受外邪, 遇风寒热, 失于宣肃, 炼液成痰, 痰阻气道, 则咳喘加重。故病变多虚实互见, 寒热错杂, 以肺肾两虚为本虚, 风寒热犯、痰浊困肺为标实。心肺同居上焦, 肺气贯通心脉, 百脉朝会于肺, 肺气不足, 痰浊阻肺, 以致心脉不畅,

血脉瘀阻，出现胸闷心悸、唇甲紫绀。肾虚失主，气化不利，水道不通，以致水湿内停，泛滥肌肤，出现排尿量少，肢体浮肿。咳痰喘肿四症俱全，终致肺胀心衰。其辨证应着重辨肺肾气虚的本虚或气阴两虚；再辨风寒痰瘀或风热痰瘀的标实；再辨标本的缓急轻重。病变加重期多有风寒痰瘀或风热痰阻肺，治以祛邪治标为主。寒者行祛风散寒、化痰燥肺、止咳平喘之法，选用小青龙汤、麻黄附子细辛汤、苏子降气汤等加减；热者行疏风清热、化痰润肺、止咳平喘之法，选用清气化痰丸、贝母瓜蒌散、定喘汤等加减。病变缓解期，治以扶正固本为主。肺肾气虚则益肺补肾，兼止咳平喘，常用黄芪、党参、蛤蚧、胡桃肉、五味子、紫菀、款冬花、百部、苏子、杏仁、法半夏、橘红等；肺肾气阴两虚则益气养阴，兼止咳平喘，常用黄芪、生地黄、太子参、沙参、麦冬、五味子、山茱萸、冬虫夏草、山药、川贝母、紫菀、款冬花等。若病及于心，血脉瘀阻，则加丹参、三七、桃仁、红花等活血祛瘀；若肾不主水，水泛肌肤，则加猪苓、茯苓、泽泻等利水消肿。

如治周某，男，80岁。咳喘反复8年，加重1周。诊见：咳嗽甚，咯黄痰，动则喘，口干苦，大便结，舌红干、苔黄厚，脉细数。X线胸片示双下肺感染、慢性支气管炎、肺气肿。中医诊断为咳喘，证属痰热阻肺，肺肾气阴两虚。治以清热化痰，止咳平喘为主，兼以养阴。处方：鱼腥草30g，黄芩、浙贝母、桑白皮、瓜蒌皮、葶苈子、款冬花、紫菀、沙参各15g，桃仁、北杏仁各12g。连服14剂，咳痰消失，动则稍喘，余症大减。复查X线胸片为慢性支气管炎、肺气肿。此痰热已去，肺肾气阴不足，治以益气养阴，双补肺肾。处方：西洋参（另炖）、五味子各10g，生地黄、黄芪、海蛤壳各30g，山茱萸、沙参、麦冬、紫菀、

款冬花各 15g，牡丹皮、瓜蒌仁各 12g，川贝末（冲）6g。嘱以此方继续调治以巩固疗效。^[13]

22. 谢昌仁诊治经验

谢氏临床善用温胆汤加苏子、杏仁、前胡等治疗急慢性支气管炎，症见咳嗽，痰色黄稠，呼吸急促，胸闷脘痞，口苦，苔黄腻等痰热蕴肺者。温胆汤出自唐·孙思邈《备急千金要方》，药由半夏、陈皮、竹茹、枳实、生姜、甘草六味药组成。谢氏以此为基本方，常用姜半夏、陈皮、竹茹、茯苓、枳实或枳壳、甘草等，临证灵活加减。其认为本方配伍严谨，寒热并用，方中竹茹、枳实清肝胆之热，降胆胃之逆，重点治热；姜半夏、陈皮燥湿祛痰，理气和胃，止呕降逆，重点治痰；茯苓、甘草健脾利湿，和中安神。全方以半夏、陈皮温性药与枳实、竹茹凉性药相配，清热而不寒，化痰而不燥，共奏清热化痰、理气降逆、和胃止呕、安神定惊之功，临证通过加减治疗痰热内扰之咳嗽有较好的疗效。^[14]

23. 包松年诊治经验

①祛邪重在清化：“老慢支”急性期主要表现为咳、痰、喘、发热，临床常根据痰的色、质、苔、脉等辨其寒热。寒痰宜温化，痰热宜清化。痰黄苔黄者乃痰热之证，但痰白苔白者并非尽是寒痰，只要有痰粘难咯，脉数不静者，多属有热，故临床多从痰热着手。“老慢支”有反复发作的咳嗽，痰伏肺家是其发病基础，长期伏痰必从热化，所谓“阴凝之处，必有伏阳”，是其一也；久病咳嗽，肺阴常虚，肺家易生虚热，则痰从热化，是其二也；现代医学认为，“老慢支”急性期多伴有细菌、病毒的感染，中医认

为是毒，毒者热毒，热从毒生，是其三也；再从临床表现看，患者多有咯痰不爽，口渴脉数，也是痰热津伤之象，此其四也。故祛邪重在清化痰热。清热多用苦寒，或合辛寒，辛则透、苦则降，苦泄邪热，顺降肺气，以复其清肃之权。且苦寒清热之药，大都具有解毒功效，毒解则热除，咳痰喘诸症可平。常用药如：黄芩、桑白皮、大贝母、虎杖、全瓜蒌、鱼腥草等。其中虎杖一味，尤其喜用。据现代药理研究，虎杖可抑制多种细菌，消除炎症，虎杖甙水解后可生成大黄泻素，有轻泻作用；肺与大肠相表里，取其通腑，解除毒素对脏器的影响，腑气通则肺气降，毒素除则肺气宁。虎杖一名清血龙，具有良好的活血作用，“老慢支”常有肺郁血及肺纤维化形成，虎杖通过其活血作用，可改善肺循环及肺纤维化，促进肺脏功能的恢复。且虎杖有镇咳功效，可谓一药多功。兼表者，加银翘、桑菊之类，取其辛凉透散；痰热壅盛，气逆喘甚者，加葶苈子、莱菔子之属，取其泻肺平喘。

②扶正着眼润养：“老慢支”在缓解期固然以虚为主，治以培补，但在急性期也存在正虚一面。虚主要指肺阴虚。因肺为娇脏，其体属阴，病久肺体必伤，是肺阴易伤之一。在病理上，肺家伏痰是发病基础，然痰之形成，一曰热灼肺津成痰，一曰气不布津成痰，故痰乃阴津不归正化所致。痰越多则津越伤，又每次发作，痰热为甚，热则伤阴是肺阴易伤之二。从临床表现上，“老慢支”患者多咳嗽痰粘，难以咯出，口干不欲饮，实为燥痰之象，此燥乃阴虚内燥。因此急性期的正气虚主要指肺阴虚。治疗上治实务必顾虚，治虚以甘寒凉润为主，甘寒养阴，着眼润养肺燥。正如岳美中所说：“凡咳而痰不出者，肺燥盛而痰涩，燥则润，涩则疏，润肺利气是制方之本。”常用药如：南北沙参、麦

冬、川贝母、百部、芦根等。

③时时顾护脾胃：脾胃为后天之本，气血生化之源，气机升降之枢。“老慢支”患者初病在肺，日久子盗母气，必然影响脾胃，使脾胃功能失常，升降乖戾。脾胃已损，水湿不运，聚而成痰，河间谓：“脾湿动而为痰”，上渍于肺而为痰嗽。且脾胃亏损，气血亏虚，使“老慢支”处于虚实夹杂、升降失常、错综复杂的病理状态，除表现出咳嗽喘外，还有恶心呕吐胃脘胀满，不思饮食等脾胃症状。现代医学认为，“老慢支”在急性期常有水、电解质、酸碱平衡紊乱，感染时细菌毒素的影响，发展成肺心病时又有胃肠道郁血，容易出现胃肠道症状。因此治疗过程中时时顾护脾胃，以二陈汤为基础。常用药如：陈皮、制半夏、茯苓、枳壳、甘草等。护脾胃不用四君，因参、术之类易升阳助热。用二陈者，一是与沙参、麦冬相伍，顺其脾胃之性，胃润以降、脾燥以升，并相互制约，润而不膩，燥而不过，相得益彰；二是与苦寒相配，防其败胃。其中半夏、贝母相伍，贝母重于润肺燥，而半夏重在燥脾湿，相互配合，肺燥得润，脾湿能除，痰源自绝。^[15]

24. 赵尚久诊治经验

苇茎汤出自《千金方》，方由苇茎（芦根）、瓜瓣、薏苡仁、桃仁四药组成。具有清肺化痰、逐瘀排脓之效，不但治肺痈有效，对于肺系因痰热蕴结所致其他病症也可用之，如慢性支气管炎，辨证属痰热蕴肺者，可酌情使用苇茎汤。咳甚加矮地茶、枇杷叶；痰多合桔梗汤（桔梗、甘草），或加贝母；阴伤加天花粉、麦门冬等。曾治汪某，女，30岁。咳嗽反复发作两年余，冬月稍瘥，入夏则剧。每咳必吐数口稠粘黄色浓痰，有时痰中夹血；闻刺激性气

味或迎风而行时，咳增剧。经 X 线摄片诊为“慢性支气管炎”。近日又咳甚，吐痰粘滞难出，胸部隐痛，口微渴，精神尚可，纳食稍减，舌紫红、苔黄腻。此痰热久伏于肺，留着不去，治当清肺热，涤伏痰，降气止咳。处以苇茎汤加矮地茶 30g，旋覆花 10g，枇杷叶 10g，连服 25 剂，病始告痊。用本方应注意要有痰热互结，瘀血阻滞化脓的病理特征。症见咳吐稠痰脓血，胸中隐痛，口渴咽干，舌赤、苔黄腻，脉滑数（或弦数）等。且药味分量（除桃仁外）宜重不宜轻。芦根、冬瓜仁可用至 60g，薏苡仁可用至 30g，桃仁一般 10~15g，小儿用量酌减。若病轻者，每日 1 剂，水煎分 2~3 次服；病重者，每日 2 剂，水煎分 4~6 次服。本方诸药皆清降滑利，慎用于孕妇。^[16]

25. 李兰生诊治经验

久病咳喘确实难治，而治疗得法，却可取效。中医学传统认为，慢性咳嗽病的治则是发作时治标治肺，缓解期治本补脾肾。李氏认为，咳嗽病的传统治法要遵循，但不能墨守成规，应有所创新，以提高疗效，从瘀论治就是有效方法。因为肺主一身之气，肺病日久，气机不利，首先是影响到肺络瘀滞而加重病情，进一步发展则波及心、肝等脏发生变化，势必咳嗽逐年加重。因此，久病咳喘不论发作期或缓解期，均应在辨证论治的方药中加入活血药，确能提高疗效。治上实下虚而病咳喘的苏子降气汤中用当归，就寓有活血之意。李氏曾治 1 例久病咳喘患者（慢性支气管炎），辨证为肺病及肾，本着平时治本的法则，令其自秋季即常服《金匱》肾气丸与复方丹参片，服至寒冬，咳嗽发作果然比往年减轻，发作时以苏子降气汤重用当归，效果较好。李氏说，复方丹参片是治疗冠心病、心绞痛的

常用有效药，实际此药不止通心脉，并能通肺络，因此要注重发挥中药一药多效之功。^[17]

26. 蒋天佑诊治经验

蒋氏认为老年呼吸病是临床常见病、多发病，常见症状为咳、痰、喘，临证切忌见咳治咳、见痰治痰、见喘治喘，要找出引起咳痰喘的本质而治之，所谓“治病必求于本”。肺为多气少血之脏，多气易病气壅，少血常罹血瘀，故调理气血之治，在治疗老年呼吸疾病中显得十分重要。肺与心、脾、肾关系密切，互为母子之脏，临床上子病及母、母病及子、母子同病者，屡见不鲜，治当求诸于本。同时，肺、脾、肾是人体水液代谢的枢纽，肺与心气血交流关系紧密，故治疗老年呼吸系疾病的咳嗽、喘咳、喘肿、痰饮、气滞血瘀等病症时，要注意标本缓急。如治史某，女，64岁。经常咳嗽3年，此次感冒后加重2月。咳嗽阵作，痰白粘不利，气喘明显，口干苦，纳欠佳，大便干，伴浑身不适。舌质红、苔黄，脉滑。胸透示两肺纹理增重。诊为咳嗽（慢性支气管炎急性发作），证属痰热壅肺，肺失清肃。治宜清化痰热，宣肃肺气，选清热宣肺方（经验方）加味。处方：连翘 9g，黄芩 9g，瓜蒌仁 15g，前胡 12g，炙冬花 30g，炙紫菀 30g，杏仁 10g，贯众 10g，旋覆花 9g（布包煎），葶苈子 10g，炮鸡内金 10g。6剂，每日1剂，水煎2次，早晚分服。咳、痰、喘减轻近半，守服原方进12剂，诸症消失。本例宿有咳嗽旧疾，感冒引发，症见咳嗽痰粘气喘、口苦便干、苔黄、脉滑等一派痰热壅肺，肺失清肃之象。治用芩、翘、贯众清肺肃肺，前胡、杏仁宣肺散风宁嗽，旋覆花下气行水消痰，款冬花、紫菀润肺止咳祛痰，瓜蒌清润化痰下气。肺气得清、得宣、得降、得

润，咳、痰、喘诸症尽解。^[18]

27. 孟景春诊治经验

当归性温、味甘辛，归心、肝、脾经。功能补血活血，调经止痛，为妇科要药。临床用于治疗咳嗽并不多见。近几年来有人报道，据《神农本草经》当归“主咳逆上气”，及《本草从新》当归“治虚劳寒热，咳逆上气”的记载，用于治疗久咳、夜咳，颇有良效。其用法，大多以辨证施治为前提，再于方中重用当归 20g 左右，而取效。如治刘某，男，50 岁。患者有“慢支”病史。冬季患感冒后，咳嗽达 4 月之久。其间经中西医药多方调治，效果不显。诊见：咳嗽痰多，咽痒，痰白而质稀；面色㿠白，咳甚则汗出，而每至夜晚则剧咳不已，彻夜难寐，舌淡、边红赤、苔薄白而润。此系外感余邪未净，而痰饮阻肺，肺气宣肃失司，更兼肝火内郁，火逆犯肺，亦致肺气失于肃降。治宜温化痰饮，略佐疏解，泄肝。药用：炙麻黄 6g，干姜 6g，五味子 8g，细辛 3g，芍药 12g，法半夏 12g，款冬花 10g，紫菀 10g，当归 20g。5 剂。药后咳嗽减，痰质转稠，咯之易出，夜咳基本控制。前方中麻黄、干姜改为 4g，半夏 10g，五味子 5g，余药量同，另加茯苓 10g。再服 5 剂，以善其后。止咳平喘的方剂中用当归者古亦有之，如张景岳的金水六君煎，《局方》的苏子降气汤，《医方集解》的百合固金汤，均有当归。但当归毕竟属味甘辛而性温的血分药，主要功用为补血活血，故其治久咳、夜咳，必须是病证属寒，或阳气不足，或咳久耗伤营血、血郁而气滞者方可用之。故《本草汇编》说：当归其味辛散，乃血中气药也，况咳逆上气，有阴虚阳无所附者，故用血药补阴，则血和而气降矣。^[19]

28. 徐迪华诊治经验

秋季咳嗽，多感受燥邪，大多表现为咽痒而咳，痰粘稠量少，口干或不干，舌红、苔薄白或薄黄。病机辨属外感燥邪，肺失润肃所致，用桑杏汤常能治愈。但也有一部分患者表现为呛咳阵作，延久不愈，用一般的治疗办法难以奏效。徐氏认为此类病症乃因风邪缠恋或深入留伏，且见胶痰粘着，气道痉挛，遂致呛咳不已。用僵蚕既能疏解风邪，并可解痉祛痰，全蝎加强解痉化痰之功，并能搜剔皮里膜外之痰，二者配合，相得益彰，用之临床，疗效满意。

如治吴某，男，64岁。呛咳10余天。有“慢支”病史10余年，每至秋冬之际发作。此次发作10余天，呛咳阵作，咽痒而痛，口干且苦，痰粘少难咯，二便尚可。舌红、苔薄黄腻，脉弦带数。听诊：右下肺可闻及少许干啰音。此乃风痰留恋，肺失清肃所致。予桑杏汤加减：桑叶10g，杏仁10g，黑山栀子10g，南沙参30g，北沙参30g，僵蚕12g，炙紫菀12g，象贝母15g，全蝎末4g（分2次冲服），生甘草5g。5剂后呛咳即愈。^[20]

29. 朱良春诊治经验

莱菔子，即萝卜子。为下气、消痰、消食药。《韩氏医通》用莱菔子配伍苏子、白芥子组方，名三子养亲汤。治疗咳嗽多痰，气逆而喘；《丹溪心法》用莱菔子配伍山楂、神曲、半夏、茯苓、陈皮、连翘，名保和丸，治食积纳呆。二者皆为常用名方。朱氏指出，善识莱菔子者，当推张锡纯氏，他在《医学衷中参西录》中云：“莱菔子乃化气之品，非破气之品”。“盖凡理气之药，单服久服，未有不伤

气者，而莱菔子炒熟为末，每饭后移时服钱许，借以消食顺气，转不伤气。”回溯《韩氏医通》三子养亲汤之用法，亦是微炒，击碎，代茶水啜用。朱氏治痰喘，如急、慢性支气管炎、肺炎、百日咳等，常用本品，颇能应手。其一方面是依据传统之说，以其善行气，气顺则痰降，咳喘自安；另一方面是据现代药理研究，证明莱菔子含抗菌物质——莱菔素，对肺炎球菌、葡萄球菌、大肠杆菌、链球菌等均有一定抑制作用。

前人又谓莱菔子生用性升，炒用性降，朱氏认为，此说又确又不确。生莱菔子味辛较甚，故生搗之水吞服后探吐，可吐风痰、毒物、饮食，此谓之升犹可。而治肺炎、气管炎、痢疾里急后重、腹胀、食积等，亦屡用生者入汤剂之中而效，岂可谓之升乎？至于何以用生者不用熟者？以莱菔素即含在莱菔子油中，经炒焙之后，其作用即削弱故也。

又有谓人参补气，莱菔子破气，故服人参不宜同时服食萝卜及莱菔子。然人参补气，而补益药何止人参；莱菔子善消，而消伐药又何止此一味！即二者同用，也无非补消兼施之理，仲景之枳术汤，就以枳实、白术同用；厚朴生姜半夏甘草人参汤，即以人参、甘草与厚朴、半夏同用，同一理也。《本草新编》说得好：“……或问萝卜子专解人参，一用萝卜子则人参无益矣，此不知萝卜子而并不知人参者也。人参得萝卜子，其功更神，盖人参补气，骤服气必难受，非止喘胀之症为然，得萝卜子以行其补中之利气，则气平而易受，是萝卜子平气之有余，非损气之不足，……。”张锡纯也说：服莱菔子“能多进饮食，气分自得其养。”若用以行气开郁，正需要“参、芪、术诸药佐之。”可见二者不能同用之说，不可为信。^[21]

30. 洪子云诊治经验

洪氏既娴于辨证，还重视治则治法的研究和应用。其对治法的研究，不仅致力于仲景，而且推崇叶天士，对叶氏的某些治法有深刻的研究和体会。如叶氏在《临证指南医案》虚损病证中多次提到的“上下交病，治在中焦”，是对仲景用建中法治虚劳的发展，在病情危重时，常用此法。

如治陈某，男，65岁，因咳嗽、气急、痰中带血而入院治疗。患者有慢性支气管炎病史多年，近咯脓痰带血丝，有时痰呈咖啡色，胸闷气急，不能平卧。西医诊断为①老慢支并感染，②肺气肿，③肺心病，④肺中叶综合征。经西药抗感染和中药清热化痰、滋阴止血治疗近1个月，诸症无明显改善。现又起发热，下肢微肿，厥冷，神疲欲寐，时有烦躁，小便量少，口干，舌干色紫暗，苔根部黄腻，脉沉细数。辨证为阴阳两虚，正气欲脱，兼邪热郁肺，用茯苓四逆汤合生脉散，另以黄芩45g浓煎兑服。服后病仍无起色，请洪老会诊。洪老认为此属上下交病，宜从中治，兼顾上下，以黄芪、人参、茯苓、玉竹、芦根、厚朴、桂枝、甘草、附子、山茱萸、枸杞子、旱莲草等组方，终使病情转危为安。^[22]

【按语】

慢性支气管炎众医家均从祛痰宣肺、健脾祛湿着手。重视从肝治咳是邵长荣治疗慢性支气管炎的一大特色，用药上以柴胡配前胡，转动少阳枢机，宣达润肺化痰，可资借鉴。许公岩主张推化痰湿治疗慢性支气管炎，其推化痰湿之主方一苍术麻黄汤经多年验证，疗效显著。洪广祥治

疗慢性支气管炎独创“治肺不远温”的思路，是对张仲景“病痰饮者，当以温药和之”学说的深化和发展，具有深远的临床意义。洪广祥在治疗慢性支气管炎常规用药的同时，运用通阳宣窍利鼻法兼顾鼻腔疾患，收效亦甚捷。胡翹武认为久咳络瘀，治疗慢性支气管炎常辅以活血化瘀之品，可起事半功倍之效。吴圣农治疗慢性支气管炎继发感染用自拟经验方“七味清肺饮”、“滋肾养肺饮”等均有较好效果。程门雪常用于姜与五味子同捣，温化痰饮，对慢性支气管炎可起排痰作用，并认为细辛、五味子用量要轻，每味1~1.5g，取“上焦如羽，非轻不举”之意。梁乃津、包松年、蒋天佑均从老年人的生理病理特点出发论治老年慢性支气管炎，具有临床意义。朱良春治疗慢性支气管炎的特点是善用莱菔子，临床常用此药，每能应手。

(吴艳华)

参 考 文 献

- [1] 王发渭，于有山. 高辉远辨治慢性支气管炎的经验. 吉林中医药, 1995, (1): 5~6
- [2] 陈志斌, 连林辉. 林求诚治疗慢性支气管炎合并感染的经验. 福建中医药, 1998, 29 (5): 20
- [3] 张颖, 施红. 邵长荣治疗慢性支气管炎特色举要. 浙江中医杂志, 1998, 33 (10): 440
- [4] 姜春华, 张树一, 林宗广, 等. 慢性支气管炎辨治. 中医药研究, 1988 (4): 2~4
- [5] 戴金豪, 许公岩运用推化痰湿法治慢性气管炎经验. 中医临床与保健, 1992, 4 (2): 30~31
- [6] 林庚庭, 姚真敏老师诊治“老慢支”经验. 浙江中医学院学报, 1994, 18 (1): 38~39
- [7] 黄翠英, 王强. 王有奎对慢性支气管炎的认识及治疗经验. 中

- 医药研究, 1994, (3): 33
- [8] 万文蓉. 洪广祥治疗慢性支气管炎特色. 江西中医药, 1996, 27 (4): 5
- [9] 魏佳平, 钱沈京. 葛琳仪主任医师治疗慢性支气管炎的经验. 浙江中医学院学报, 1999, 23 (4): 40
- [10] 高健. 高复安治疗老年慢性支气管炎经验. 陕西中医, 1999, 20 (3): 121~122
- [11] 胡国俊. 胡翹武治疗老年慢性支气管炎的经验. 中医杂志, 1991, 32 (12): 15~16
- [12] 陈树森, 曹鸣高, 姜春华, 等. 慢性支气管炎证治. 中医杂志, 1985, 26 (11): 4~9
- [13] 黄穗平. 梁乃津教授治疗老年病经验. 新中医, 1995, 27 (5): 1
- [14] 王秋兰. 谢昌仁运用温胆汤经验. 黑龙江中医药, 1997, (4): 1
- [15] 包立振. 包松年治疗“老慢支”经验撮要. 江苏中医, 1991, (7): 1
- [16] 贺又舜. 苇茎汤加减运用的临床经验. 江苏中医杂志, 1982, (5): 14
- [17] 吕志杰. 李兰生老中医谈久病从痰论治的经验. 新中医, 1991, (2): 4
- [18] 蒋天佑, 蒋玮. 老年呼吸病证治发微. 山西中医, 1995, 11 (4): 5
- [19] 孟景春. 当归治久咳、夜咳. 江苏中医, 1995, 16 (8): 24
- [20] 王彩华. 徐迪华老中医巧用药对举隅. 江苏中医, 1992, (8): 20
- [21] 何绍奇. 朱良春三辨莱菔子的功用. 江苏中医, 1988, (7): 17
- [22] 戴玉. 洪子云生平及主要学术经验. 湖北中医杂志, 1994, 16 (6): 3

弥漫性泛细支气管炎

【概述】

弥漫性泛细支气管炎于 1969 年首先由日本学者山中、本间、谷本等提出，是一种不同于慢性支气管炎、肺气肿、支气管扩张的独立性疾病。它以弥漫存在于两肺呼吸性细支气管区域的慢性炎症为特征，可导致严重呼吸功能障碍，病死率较高，多数预后不良。目前国内对本病尚少报道。弥漫性泛细支气管炎主要临床表现为持续性咳嗽、咳痰及活动时气短。此类病人往往合并有慢性副鼻窦炎、慢性咽喉炎。早期咳痰色白，随着病情进展，痰量增多，并转为黄脓痰，感染十分顽固，且易并发绿脓杆菌感染。听诊时两下肺可闻及断续性湿啰音；胸片可示两肺弥漫性散在性颗粒状、结节状阴影，常伴有原灶性肺炎；胸部 CT 示小叶中心性颗粒状阴影。肺功能检查 $FEV_1 < 70\%$ ，病情进展时可伴有肺活量下降，残气量增加；血气分析示动脉血氧分压下降，后期二氧化碳分压升高；血液检查：冷凝集效价增高 164 倍以上。

既往西医采用类固醇激素及抗生素治疗，目前主张运用红霉素或罗红霉素。运用红霉素固有一定疗效，且能使病死率下降，但终究不能长期使用，尤其是胃肠道功能不良的病人无法忍受长期服用红霉素所带来的不良反应。如何提高本病疗效，以及降低红霉素副作用呢？必须同时采

用中药治疗。

【名医经验】

1. 王会仍诊治经验

王氏在长期从事呼吸系统疾病的研治中对本病积累了较为丰富的临床经验。王氏根据弥漫性泛细支气管炎的主要表现，认为其在祖国医学中属于“喘证”范畴，主要病机在于痰热蕴肺，胶固不解，肺气壅滞，瘀浊内阻，气道阻塞，兼有鼻窍不通、咽喉不适。治疗上王氏以清肺化痰、降气平喘为大法，兼以活血化瘀、利咽通窍。待病情控制，再予以固本治疗。现将王氏辨治弥漫性泛细支气管炎经验介绍如下。

①清肺化痰：由于本病炎症部位广泛，感染顽固，主要病理特点是痰热蕴肺，其痰、热、毒之邪气较甚，故在治疗时王氏认为当重用桑白皮、桔梗、天竺黄、黄芩、败酱草、鱼腥草、蚤休、山海螺、海浮石、竹沥、半夏等清肺化痰解毒之品，其中桔梗剂量常用至15g。重在宣肺化痰。虽古人对咳喘病人用桔梗多限在3g左右，认为桔梗有“令人喘促而死”之弊，但王氏在长期临床实践中，运用较大剂量治疗本病，从未发现有这种毒副作用，故不可拘泥于前人之说。认为只有热毒清才不至于使痰液煎熬、稠固不化；只有痰热清才能清除慢性气道炎症，解除气道阻塞，改善通气功能。

②降气平喘：肺司宣发肃降功能，肺气塞阻，肺失肃降，则上逆而喘。气行则津液流通，痰液自化；气降则喘咳自平。正如丹溪所云：善治痰者，不治痰而治气。故王氏在治疗慢性弥漫性泛细支气管炎时善用杏仁、苏子、莱

藤子、降香、厚朴、干蟾皮等降气祛痰、止咳平喘之品。现代药理研究表明，降气平喘药物能舒张支气管平滑肌，降低气道高反应性，从而改善肺的通气功能。

③活血化瘀：肺主气，朝百脉，气为血之帅，血液运行有赖于肺气的推动，气行则血行，气滞则血瘀；津血同源，痰浊内阻，津液流通不畅，则血脉瘀阻。在弥漫性泛细支气管炎患者中，常常气窒、痰阻、血瘀并存于整个病理过程。因此临证施药时必须加用川芎、地龙、当归、紫丹参、赤芍、虎杖等活血化瘀之品，借以溶解痰栓中的纤维蛋白，有助于减轻炎症反应。活血化瘀药物还具有扩张支气管、改善肺微循环、提高动脉血氧分压的良好作用。此外，还能改善药物的分布，促进药物的吸收。

④利咽通窍：弥漫性泛细支气管炎患者往往合并有慢性副鼻窦炎，伴有鼻塞、流浊涕等症状。鼻为肺之窍，副鼻窦炎可诱发呼吸道感染，致使疾病更缠绵难愈，故在治疗时应注意选择加入苍耳子、白芷、辛夷、鹅不食草、蝉蜕、僵蚕、玉蝴蝶等祛风利咽通窍药物。鼻窍通畅，咽喉舒适，则咳嗽、气喘等症状亦能得到一定程度的改善。

⑤益气培本：由于本病感染顽固，迁延难愈，必定存在肺气不足征象，根据“损则益之”、“虚则补之”的原则，治疗时不可拘泥于痰多、痰黄而惟恐运用补益之品导致恋邪。益气能提高机体免疫功能，增强机体抗病能力，以达到扶正祛邪的目的。此所谓“正气存内，邪不可干”是也。大量的临床和实验研究表明，益气药物能提高肺活量、最大通气量，且能提高第一秒时间肺活量百分比（一秒率），提高动脉血氧分压、血氧饱和度，改善通气/血流比例。王氏在清肺化痰祛瘀通窍的同时，往往酌用太子参、党参、黄芪、白术等益气扶正之品，以利于邪气外达，尽早控制

病情。在疾病缓解期，则加大益气固本力度，并根据病人不同体质分别施治。

如治周某某，男，42岁。反复频繁咳嗽，咯痰，气急4年。因咳嗽频繁，咯痰，色黄量多，动则气急，伴有鼻塞、流浊涕，曾在某医院就诊，经胸片、CT、肺功能等一系列检查，确诊为弥漫性泛细支气管炎。予以红霉素、激素等治疗，诸症仍反复发作不愈，而无法正常工作。初诊时舌偏红、有瘀点，苔薄黄腻，脉细滑。治予清肺化痰止咳，佐以活血。处方：桑白皮12g，竹沥半夏12g，桔梗12g，苍耳子12g，黄芩15g，蚤休15g，云雾草15g，瓜蒌皮15g，地龙15g，金银花30g，鱼腥草30g，山海螺30g，太子参30g，苦杏仁10g，紫丹参18g，甘草6g。初期在运用中药的同时服用罗红霉素0.15g，每日2次，以后以服中药为主，间断服用罗力得。经此治疗1月后，患者诸症减轻，精神状况明显好转。以后继续坚持服中药半年，病情稳定，能如常生活。

王氏认为由于本病属于慢性的、难治性疾病，故须嘱患者坚持长期服药，巩固疗效。在本病治疗中应注意避免使用具有收敛、麻醉作用的镇咳之品如诃子、罂粟壳等，以免碍邪。^[1]

【按语】

弥漫性泛细支气管炎临床报道较少，中医论述更是鲜见。王会仍根据中医病机，立清肺化痰、降气平喘、活血化痰、利咽通窍、益气培本等法，给临床以启发，为中医治疗本病开其先河。

（郭桃美）

参 考 文 献

- [1] 蔡宛如, 骆仙芳, 王会仍治疗弥漫性泛细支气管炎经验. 浙江中医杂志, 2000, 35 (3): 93~94

【概述】

感冒多由病毒引起，常在家庭中传播。病原体在成人以鼻病毒为主，儿童以副流感病毒和呼吸系合胞病毒多见。全年均可发病，以冬末春初较多。潜伏期约1天，起病急骤，早期有咽痒干燥、喷嚏、鼻塞、流清涕、畏寒、乏力，可有发热、头痛、腹胀、便秘等。36~48小时后，鼻涕变为脓性。如病变侵入喉、气管、支气管，则可出现声音嘶哑、咳嗽、胸痛。病程4~7天，可自愈。如继发细菌感染，症状加重。胸部检查一般正常。感冒一般无特异性治疗。中医认为感冒是由风邪侵袭人体所引起的常见外感疾病，证候表现上有风寒风热两大类，夹湿夹暑等兼证，以及体虚感冒的不同。感冒的治疗原则，根据邪在肺卫的特点，应以宣肺解表为主，并结合病情辨证施治，证属风寒者治疗以辛温发汗；风热者，或风寒郁久化热者，治疗以辛凉清解；病情复杂者可采取表里双解法；体虚者，固其卫气，兼解风邪。

【名医经验】

1. 王子良诊治经验

王氏常用危亦林《世医得效方》中的玉屏风散治疗体

虚感冒，多收满意效果。危氏玉屏风散中黄芪 18g，白术 6g，防风 6g（按比例折算），大枣 5g，生姜 3 片（姜、枣为自加，原方中无）。主要用于中虚卫阳不振，表虚自汗，易感风邪者。《内经》云：“邪之所凑，其气必虚。”李杲曰：“内伤脾胃，百病由生。”体虚感冒，多因饮食不节，内伤脾胃，或疲劳过度，起居酒色无常，加之久居内室，紧张工作，生活无规律和缺乏必要的体育锻炼等，致使正气虚弱，机体抗病力低下，卫表不固，病邪乘虚侵袭而为病。此类病人每年感冒次数较多，感冒持续天数，少则半月二十天，多则一至数月，天长日久体力暗耗，多影响正常工作。从临证来看，本病多见于中老年、久病、妇女月经过多、产后、久居内室、过度疲劳的体质虚弱之人。开始为一般感冒症状：常见微恶风寒，鼻塞流涕，打喷嚏，头痛头胀，身疼不适，咳嗽吐痰；继则倦怠无力，食欲不佳，咳嗽不止，吐痰不爽，或腰酸腿软，喷嚏不断，善静喜暖，似欲眠状，或微发热不适，心烦不寐，咽部痒痛或干涩不适，恶心欲吐，纳谷不香，自感工作一天来，极度疲乏无力。如持续日久，损及阴阳、脏腑，亦能酿成他疾。本病一般偏气虚与阴虚者较多。初期多由于卫表不固，汗出，感冒症状虽不重，但多持续 10~15 天不去，自汗出尤为明显。此时可连服玉屏风散 10~30 剂，一般均能恢复健康。

如治张某，男，62 岁，1974 年 12 月 3 日初诊。感冒半月来，微恶风寒，头痛咽痒，鼻塞流涕，声重，打喷嚏，肢体疼楚，倦怠乏力，食欲不振，自觉汗出。曾服感冒类成药，症状稍减，但仍汗出，恶风，纳差，神疲乏力。服本方 12 剂，汗止，纳呆，体力恢复，感冒自愈。处方：黄芪 18g，白术 6g，防风 6g，大枣 5 枚，生姜 3 片。水煎服，

每日1剂。本例为卫表不固，风邪乘虚侵袭，卫气虚弱，无力抗邪而致。方中重用黄芪补气固表止汗，白术健脾补中焦，以资气血之源，佐防风走表而助黄芪益气御风，且黄芪、防风两药合用，相畏相使，其功益彰。黄芪得防风即不虑其固邪，防风得黄芪亦不虑其散表，实为散中寓补、补中兼疏之剂。生姜、大枣二药合用和中固表、调和营卫；生姜得大枣可缓和其辛散之性，助防风驱邪外出而不伤正；大枣配生姜可防止补血过壅之偏，并健脾和中，助正气恢复，二者相伍，一气一血，一补一散，一营一卫，对虚体感冒利于扶正祛邪。故只服12剂，病邪自除。

偏于气虚者，多见脾肺气虚，因于饮食不节，内伤脾胃，或起居不慎，感受风邪，气虚托送无力，邪不易解；临证多见神疲倦怠，身体疼楚，食欲不佳，或微恶风寒，久咳不止，咳痰不爽，声重，喷嚏不断，自汗出等，诸症持续时间比较长，脉多浮而无力，舌淡苔白。处方：黄芪18g，白术6g，防风6g，党参12g，山药15g，黄精10g，川贝母9g，紫菀9g，半夏9g，甘草9g，大枣5枚，生姜3片，水煎服，每日1剂。

如治唐某，53岁，干部，1984年3月7日诊。自述1~2年来，工作1天，自感神疲乏力，肢体酸痛不适，纳差，每逢天气变化稍有不慎即感冒，微恶风寒，头胀咽痒，咳嗽不止，咳痰不爽，声重流涕，喷嚏不断，自汗出，多延续1~2个月，服感冒类药，效果不理想；查见脉浮无力，舌淡苔薄白。本例患者系干部，常年久居内室，工作紧张，疲劳过度，缺乏必要的体育锻炼，致使正气虚弱，风邪侵袭，气虚托送无力，故拖延日久。方中黄芪、党参、白术、山药、黄精、大枣益气健脾，和胃固表止汗以扶正；川贝母、紫菀、半夏、甘草、防风、生姜养阴润肺、化痰

止咳，辛散以驱风。故服上方 10 剂后，自感食欲好转，气力增加，他症亦减轻，继服 15 剂后，诸症皆除，感冒痊愈。病人自我感觉良好。此后年感冒次数较前大为减少，且持续天数为 1~3 天左右，为了巩固疗效，患者开始规律生活，自觉坚持必要的体育锻炼，几年来，身体较前大为好转。

偏于阴虚者，多由于阴液素亏，外感风邪，津液不能作汗达邪，致使风邪久居不去。临证多见身微热、干咳痰少，舌红少苔，脉细数。药用：黄芪 18g，熟地 20g，当归 12g，白芍 12g，白术 6g，山药 15g，党参 12g，北沙参 12g，玉竹 10g，防风 6g，大枣 5 枚，生姜 3 片，水煎服，每日 1 剂。

随证加减：阳虚肢冷者加附子、人参各 6~12g，以益气助阳，驱邪外出。食欲恢复缓慢者加鸡内金 12g，焦三仙 12g，大枣改为 20 枚，以助消化，增进食欲。老年、产后患者兼大便秘结者加郁李仁、何首乌各 10g，肉苁蓉 10g 以润肠通便。肺虚久嗽难愈者，党参易人参，加五味子 6g，罂粟壳 6g，以增强养阴润肺、化痰止咳之力。自汗、失眠多梦者加龙骨 15g，牡蛎 15g，酸枣仁 12g，浮小麦 12g，以固表止汗，宁心安神。头痛日久，时发时止，加川芎 6~12g，赤芍 6~12g，红花 6~12g，地龙 6~12g，以活血化瘀，祛风止痛。鼻塞、声哑者加辛夷 9g，胖大海 9g，桔梗 9g，以通窍清音、宣肺利咽。老年久病兼肾阳虚者，酌加温肾助阳药。^[1]

2. 江尔逊诊治经验

江氏以仲景理法为规矩准绳，善用小柴胡汤治虚人感冒。江氏指出，汉唐以后方书论治虚人感冒，约皆于省察

病者气、血、阴、阳孰虚之前提下，分别运用益气解表、养血解表、滋阴解表、助阳解表等方药。若认证无差，方药丝丝入扣，自能取效。但由于解表药与扶正药之比例难掌握，稍一不慎，不是发散太过，便是闭门留寇，难免犯“虚虚实实”之戒。而运用小柴胡汤治虚人感冒，包括疮家、衄家、汗家、淋家、产后等外感后有表证而不可发汗者），不仅稳妥允当，免于斯弊，且大能执简驭繁、驾轻就熟。具体用法为：凡虚人感冒之用小柴胡汤者，除悉遵原方七种或然证之加减法外，尚有四种常用的加减法：气虚的加黄芪、白术；血虚的加当归、白芍；阴虚去半夏，酌加玉竹、生地；阳虚去黄芩，酌加制附子、巴戟天。

如治张某，女，45岁。久患崩漏，气血亏虚。一日，忽遭火灾，外出冒风，卧床不起，辗转延医治疗2月余，病势日笃。时届盛夏，驱车迎江氏，午刻至其家，见其卧于斗室，密闭窗牖，且下重帷。其人恶风自汗，头昏心悸，呕恶不食，舌苔薄白，脉弦细数无力。检视前服方药，多为补中益气汤、归脾汤之类化裁。江氏诊为气血俱虚感冒，用小柴胡汤加黄芪、白术、茯苓、当归，服1剂，汗减热退，诸证亦轻。守方再服1剂，汗止，知饥索食。继调补气血，旬日而痊。

再如治罗某，男，66岁。素有痰饮宿疾，每届冬春两季，辄屡感屡发，缠绵难愈。1981年2月复又外感。发热恶寒，咳喘痰清量多，曾先后服小青龙汤加党参，参苏饮等祛邪扶正方药8剂，病情虽一度减轻，但稍不留神风寒，则随感随发，迁延月余。江氏诊时，其人仍微恶风寒，咳喘夜甚，痰多呕恶，胸闷纳呆，腰背冷痛，手足不温，舌苔白滑，脉弦紧。断为阳虚感冒咳喘，投以小柴胡汤加制附子、巴戟天、桂枝、干姜、五味子（原方去黄芩），调服

2剂，恶风寒已，手足转温，腰背冷痛、咳喘均减。上方去桂枝续进2剂，诸症渐平，惟偶尔咳嗽，纳少，头昏乏力，改投香砂六君子汤加黄芪、防风收功，追访2月未复发。

江氏用小柴胡汤治虚人感冒有年，历试不爽。小柴胡汤为治伤寒少阳病之专方。为何可治虚人感冒？江氏认为，《伤寒论》97条言：“血弱气尽，腠理开，邪气因入，与正气相搏”者，非独指少阳病之病因病机，乃总论虚人外感之病因病机也。治此证不可发汗者，恐耗散虚人之气血阴阳，虚其虚也。仲景出小柴胡汤以和解之。方中之柴胡、黄芩、半夏能曲运少阳枢机以达太阳之气；人参、甘草、大枣、生姜补助中焦脾土以领邪外出，于稳妥平和之中，大具扶正达邪之力。诚治虚人感冒之佳方。

柴胡有“发散升阳劫阴”之弊，何以能治虚人以及诸亡津、亡血者之感冒？江氏认为，《神农本草经》谓柴胡主“寒热邪气”，并未言及有发散作用。仲景云：“少阳不可发汗，发汗则谵语”，是畏其发汗耗伤津液，转属阳明。《伤寒论》云“本太阳病不解，属少阳者，……与小柴胡汤”。夫仲景对禁汗之少阳病主以小柴胡汤，足征本方实非发散剂者明矣。至于柴胡能否“升阳劫阴”的问题，古今均有争议，值得进一步研究。但须知单用柴胡一味药疗病之机会殊少，尤于阳亢阴亏之际，舍它药而独任柴胡者，更闻所未闻。而柴胡与小柴胡汤之功用并不相等。仲景揭示小柴胡汤之功效为使“上焦得通，津液得下，胃气因和”，何来“升阳劫阴”之弊？

感冒初起，大多属太阳病范畴，何以知虚人感冒均为邪在少阳而当用小柴胡汤？江氏认为，虚人感冒有属少阳者，有不属少阳者。但小柴胡汤出于《伤寒论》太阳病篇，

该书除少阴篇外，其余各篇均有此方之证治，并非少阳病之专方，实为从少阳之枢以达太阳之气的方药。况仲景明言“血弱气尽，腠理开，邪气因入，与正气相搏”。盖腠理者，少阳之分也。体虚之人，卫气不固，外邪侵袭，可直达腠理。故虚人感冒后，不论邪气是否客于少阳，均可以本方运转少阳枢机，匡扶正气以驱除稽留腠理之邪。此等治法，较诸后世方书论治虚人感冒，多泥于滋阴、助阳、益气、养血者，其义尤深。

小柴胡汤中，半夏温燥，黄芩苦寒，均不宜于津亏血耗之证，何能用于诸亡津亡血之人复感外邪者？江氏认为，复方之作用，并不等于方中各个单味药作用的机械相加。且仲景立法用方，无不圆机活法。观小柴胡汤方后加减法有七，何况方中还有人参一味，大有精义。《神农本草经》云：“人参味甘，微寒无毒，主补五脏……”，陈修园注曰“主补五脏者，以五脏属阴之也……今五脏得甘寒之助，则有安之、定之、止之、明之、开之、益之之效矣。”故仲景于汗、吐、下伤阴之证用之以救津液。小柴胡汤用人参配甘草、大枣、生姜补助中焦脾土之气，滋养汗源，为胜邪之本，使其他性味有偏之药赖以扬其所长而避其所短，是为有制之师，所以战无不胜。^[2]

3. 张琪诊治经验

石膏为治疗急性热病的有效药物。仲景《伤寒论》中的白虎汤清阳明大热，竹叶石膏汤治热病后余热未清、津伤少气，均以石膏为主。《名医别录》谓：“除时气头痛、身热、三焦大热……解肌发汗”。但石膏须用生者，更须大剂量方效。江涵暾《笔花医镜》及《吴鞠通医案》中皆重用石膏以除大热；余师愚治瘟疫的清瘟败毒饮方中用石膏

至八两，治大热烦躁、渴饮干呕、头痛如劈、昏狂谵语、发斑吐衄等症；《医学衷中参西录》张锡纯尤善用生石膏治温热病，谓生石膏性凉而散，有透表解肌之力，为清阳明实热之圣药，无论内伤外感用之皆效。张氏以生石膏为主，与它药配伍，治疗各类发热性疾病，常随手奏效。其退热之功，直胜过犀角、羚羊等名贵药品。

①治疗温热型流行性感冒，包括春温和冬温。临床主要表现为壮热头痛、微恶寒。口渴、舌尖红、苔白、少津、脉象浮数。《本经》谓石膏治“中风寒热……”，乃指风温而言。因风为阳邪，风邪挟温，不同于风寒，初起即壮热头痛、口渴、脉浮数、舌尖赤等。治疗此症，银翘、桑菊效皆不显。张氏常用生石膏 50g，加葛根、连翘各 15~25g，一般药后得汗而热退，即所谓“体若燔炭，汗出而散”。

如治刘某，男，34 岁。发病 2 日，壮热（ $T39.8^{\circ}\text{C}$ ）头痛、口渴、肢节酸楚、微恶寒无汗、舌尖赤、苔白少津、脉浮数。用羚翘丸等无效。病属冬温，宜清热解表。处方：生石膏 30g，薄荷 15g，连翘 25g，葛根 20g，金银花 30g，甘草 15g，玄参 15g，天花粉 20g。服药 3 剂，周身汗出热除而愈。

②治疗外寒里热之重感冒。临床表现为发热恶寒、肢节酸痛难忍、头痛、口干渴、兼有呕恶、舌苔白干、脉浮滑带数。此为外感寒邪内蕴伏热，宜疏解表邪，加生石膏以清内热。处方：柴胡 25g，桂枝 15g，黄芩 15g，白芍 15g，半夏 15g，生石膏 75g，甘草 10g。此方仿柴胡桂枝汤意，加石膏以清里热。服药后汗出，诸症悉解。本方除了治疗外寒内热之新感外，亦治外邪入里之伏邪。此伏邪非温病之伏邪，乃寒邪入里潜伏与内热互结，患者长期发热，时起时伏，发作时则先寒后热，甚至有终年累月不解者。

此方用柴胡、桂枝疏解外入之伏邪，使之透表外出，生石膏以清内热，则顽固不解之发热可以消除。

如治吕某，男，40岁。患者20天前突然发热发冷，胸闷后背痛，全身肢节痛，经某医院用解热药无效。约1周后下肢有出血点，拟诊风湿热，又用可的松治疗，发热不退。检查血红蛋白100g/L，白细胞 $4.6 \times 10^9/L$ ，血小板 $8.4 \times 10^9/L$ ，分叶核0.67，淋巴0.31，杆状0.02。舌红、苔白腻，脉浮数。初诊投以清热解毒凉血之剂治疗1周后，复见发热（ $T 40^\circ C$ ），持续3小时后，热逐渐下降，同时伴有恶寒、肢节酸痛，但关节未见红肿。此乃外邪内伏化热，挟痰浊互结不得外透。予柴桂疏解外邪，重用生石膏清内热。生石膏与柴胡、桂枝合用，辛凉与辛温配伍，透表解肌之力尤强；辅以半夏、常山以蠲除痰饮，内外分消治之。处方：柴胡30g，黄芩15g，半夏15g，桂枝15g，生石膏75g，甘草10g，常山15g，青蒿20g。连服上方10余剂发热退，诸症悉减。后又发作1次，恶寒发热（ $T 39^\circ C$ ），继用上方数剂热除，从此不再发作。^[3]

4. 汪履秋诊治经验

感受四时六气、时行病毒所致的高热，主要见于现代医学的病毒性和部分细菌性感冒。治疗时首先要辨清病邪的六气所属：恶寒重、发热轻者多为风寒，治当辛温发表，方选荆防败毒散之类；发热重、恶寒轻者多属风热，治宜辛凉疏解，方投银翘散加味；头身疼痛较著者，多为风湿之邪，困遏卫表，治疗则用羌活胜湿汤疏风胜湿。若病邪侵犯呼吸道，咳嗽等肺经症状突出，则应注重凉散清宣，桑菊饮为常用之方；若吐泻等脾经症状较著，多为病邪侵入肠胃，治疗以疏表清利为先，葛根芩连汤为首选之方。

若病在炎夏，伴有胸闷、烦渴等，多系暑湿为病，必投以新加香薷饮；病在秋令，口咽干燥者，多夹燥气，治用桑杏汤疏风润燥。若时行病毒伤人，病变多急而重，常有流行之势，则应投以辛凉重剂，必要时配以清热解毒之品。辛凉解表法是以辛散凉泄之剂疏散风热卫表之邪，适用于外感风热表证或温病初起，代表方为桑菊饮、银翘散和麻杏石甘汤，常用药物有金银花、连翘、牛蒡子、薄荷、葛根、菊花、荆芥、豆豉等。本法是临床最常用的治法，相当一部分患者通过本法的治疗，高热下降，病变向愈。临床上凡高热初起，伴恶寒、少汗、苔薄黄或口干渴者，均以本法施治，所谓“有一分恶寒，并有一分表证”，如若不然，一见高热，即大剂苦寒清泄，往往可使病邪冰伏不解。汪氏曾用银翘散加减治疗病毒性或细菌性感冒和部分肺炎，均取得较好的疗效。在此基础上研制的“退热灵”合剂，疗效亦令人满意。^[4]

【按语】

众医家治疗感冒各具特色，王子良用玉屏风散辨证加减治疗虚体感冒多获满意效果。江尔逊以仲景理法为规矩准绳，善用小柴胡汤治疗虚人感冒，历试不爽。张琪治感冒高热善用石膏，汪履秋治感冒高热善用银翘散，均属经验之谈，可资借鉴。

（郭桃美）

参 考 文 献

- [1] 王奎武，崔岩. 王子良老中医治疗虚体感冒的经验简介. 吉林中医药，1994，(1)：10

- [2] 余国俊. 江尔逊老中医运用小柴胡汤治虚人感冒的经验. 北京中医杂志, 1983, (3): 9~10
- [3] 张琪. 谈临床运用石膏治疗急性热病的经验. 黑龙江中医药, 1983, (3): 1
- [4] 汪履秋. 谈高热的临床辨治. 江苏中医杂志, 1987, (12): 40

支气管哮喘

【概述】

支气管哮喘（简称哮喘）是一种气道过敏性疾病，其特征为广泛性气道痉挛狭窄，表现为带有哮鸣音的呼气性呼吸困难发作，持续数分钟到数小时，可自行或经治疗后缓解，严重者可持续数日至数周或呈反复发作的慢性经过。长期反复发作可并发慢性支气管炎和肺气肿。支气管哮喘具有反复发作、缠绵难愈的特点，严重危害人民的身体健康。目前西医治疗本病仍以解痉平喘，抗感染及脱敏治疗为主。虽然在控制症状方面疗效较好，但停药后复发率高，且有些药物如茶碱类、激素等久用有一定副作用。茶碱类药物其临床治疗量与中毒量很接近，安全血浓度范围极窄；经常使用激素易产生自身内源性激素分泌的抑制及机体免疫力的下降和代谢紊乱，激素剂量越用越大，易发生并发症。中医认为，宿痰伏于体内，遇某种诱因而触发，以致痰气搏击于气道，是哮喘发作的基本病理。其治疗根据发作时攻邪为主，缓解期扶正为主的原则，在哮喘发作阶段，分冷哮、热哮而施治。前者以温肺化痰，降逆平喘为主；后者以清肺化痰，降逆平喘为主；若系寒热混合型，又宜寒温并进。在缓解阶段，视患者全身症状分别治以补肺固表、健脾化痰、益肾固本等。

【名医经验】

1. 顾丕荣诊治经验

顾氏积 60 年临证经验，揣摩出过敏性哮喘其标是痰气，其本是肾虚。而其最根本之病因，乃是湿毒。所谓湿毒，有先天后天之分。先天大多发自孩提奶癣之时，后天大多得之麻疹、百日咳等病之后。因为顾氏在长期临床观察过程中发现，过敏性哮喘患者多伴皮肤湿疹或鼻、耳、眼等官窍作痒。询之大多幼有胎癣，且其发作与居处潮湿及嗜食肥甘时鲜、或接触瘴雾之气有关。患者大多脉濡，苔腻，为湿毒之明证。

顾氏治疗本证，发作时辨证治其标。因其为外受非时之邪或鼻吸异气而引动膈间胶固之痰发病，当宣肺化痰，疏肝达郁。药用：炙麻黄、杏仁、五味子、黄芩、制半夏、麦冬、干姜、炒苏子、炒葶苈子、柴胡、射干、生甘草、生石膏。缓解期则补肾固本。常用方：补骨脂、胡桃肉、钟乳石、熟地、五味子、巴戟天、淡附片、肉桂。与此同时，以自拟“化哮八宝丹”化湿泄毒，并贯穿始终。方用：琥珀 2g，珍珠 2g，朱砂 2g，钟乳石 8g，冰片 1g，羊胆 6g，蜂胶 12g，乌贼骨炭 12g，研极细末，蜂胶糊丸如绿豆大，每次服 1g，每日 3 次，每次以土茯苓 30g 煎汤送下。本方脱胎于《外科正宗》及《景岳全书》的五宝丹（八宝丹前五味药）。五宝丹中琥珀气平味甘，能疗蛊毒；珍珠擅长清热解毒，朱砂能除毒气，解胎毒痘毒，钟乳石辛温味甘，温肾纳气，主治咳逆上气。五宝丹原主治杨梅结毒及湿毒疮疡，顾氏常用以治小儿胎毒奶癣，内服外搽，均有卓效。在临证中，顾氏发现：①许多胎毒幼儿每易病发哮

喘；②经服五宝丹后的奶癣胎毒患者同时哮喘也获痊愈。如是引申用于属湿毒致哮的成年患者，均获佳效。蜂胶，现代药理认为有良好的抗过敏作用，乌贼骨炭来自一民间单方，功用化湿敛疮，对远年哮喘长服有著效。再以健脾胃、祛湿毒之土茯苓 30g 煎汤代茶送服化哮八宝丹，效果更著。

如治周某，女，29岁，农民。1989年10月2日初诊。哮喘起于产后，感冒久喘而得，历时6年，发作无常。由于外邪引动膈间胶固之痰，无形之邪与有形之痰交搏上焦，上壅气道，呀呷有声，胸胁郁闷。舌质淡红，苔薄腻，脉弦细。治当宣肺化痰，佐之疏肝达郁。药用：炙麻黄 6g，生石膏 12g，制半夏 10g，五味子 6g，干姜 3g，炒苏子 15g，炒葶苈子 12g，柴胡 6g，射干 12g，当归 15g，炒白芍 12g，炙甘草 6g，地龙干 15g。另以钟乳石 9g，琥珀 6g，朱砂 6g，珍珠粉 6g，冰片 3g，乌贼骨 60g，河车粉 60g，共研细末，每次服 4g，每日服 2 次，每次以土茯苓 50g 煎汤送下。上方连服 10 剂，哮喘已缓，但易受外邪，鼻痒善嚏，因肺虚，卫外不固，再以前法佐之益肺固表，药用：炙黄芪 30g，焦白术 15g，防风 10g，炙麻黄 6g，制半夏 10g，炙桑白皮 12g，黄芩 12g，银杏肉 15g，炒苏子 15g，柴胡 6g，当归 12g，炒白芍 15g，射干 12g，凤凰衣 15g，地龙干 12g，生甘草 6g。8 剂连服。另以钟乳石 12g，琥珀 6g，珍珠 3g，合成牛黄 3g，朱砂 6g，冰片 3g，土茯苓末 120g，共研细末，每次服 5g，每日 2 次，2 料。药后哮喘已平，但仍易罹外邪，因卫外失误，未发时以补肾为主，参合益肺固表，佐之化痰以治其根。炙黄芪 30g，焦白术 15g，防风 12g，熟地 20g，山药 15g，山萸肉 6g，茯苓 15g，补骨脂 12g，制半夏 10g，炒苏子 15g，射干 12g，柴

胡 6g, 炒白芍 15g, 炙甘草 5g, 配以化哮喘八宝丹 6g, 每日 2 次, 连服 2 周。

哮喘之症, 发时以攻邪为主, 宣肺化痰。患者胸胁郁闷, 郁不离肝, 因肝郁犯肺, 以致肺气贲郁, 佐之柴胡、白芍、当归疏肝以达郁, 肝郁既解, 则肺郁亦舒。后哮喘平息, 治疗改以补肾固本, 参合益肺, 俾得精气则邪不可干。景岳谓“哮喘有夙根, 宜丸以缓图”。最后以化哮喘八宝丹化湿泄毒, 以治其根, 则远年哮喘, 终获根治。^[1]

顾氏治疗喘, 除常用加味八宝散蠲除湿毒病因之外, 同时重视辨证论治, 专方与辨证结合。如哮喘患者平时容易感冒, 鼻痒善嚏, 甚者眼痒、耳痒、身痒, 是因肺虚卫外不固所致, 待哮喘平定之后, 以玉屏风散合生脉饮, 以益肺固表。方中五味子, 在邪去后可以多用, 意在敛肺固肾以治本。喘发甚轻, 或昼平夜发者, 夜属阴, 是阳不用事之征, 为虚中挟实证。顾氏自拟补肾化饮汤(熟地 20g, 茯苓 15g, 五味子 15g, 补骨脂 15g, 胡桃肉 15g, 山药 15g, 山萸肉 12g, 制半夏 12g, 钟乳石 12g, 细辛 5g, 炙甘草 5g)以治本。若哮喘发作, 胸胁郁闷, 呼吸困难, 为肝气犯肺, 肺气贲郁证, 上方加入当归、炒白芍、柴胡、桔梗、射干、枳壳等舒肝以泄肺。

对病程久远, 症情顽固者, 以大方复治, 自拟四黄克哮喘丸。宣上导下, 益肺补肾, 祛湿解毒, 蠲饮涤痰。将攻、补、温、清数法融于一炉。用治过敏性哮喘, 取效甚佳。方药组成: 麻黄 100g, 射干 100g, 山豆根 100g, 制半夏 120g, 生石膏 120g, 生黄芪 200g, 熟地 300g, 五味子 150g, 细辛 50g, 生大黄 50g, 干姜 60g, 牙皂 30g, 明矾 30g, 生甘草 30g, 土茯苓 500g, 钟乳石 36g, 琥珀 18g, 朱砂粉 18g, 珍珠粉(或珍珠母 36g) 18g, 梅花冰片 3g。

制法：①将钟乳石、琥珀、朱砂、珍珠粉、梅花冰片研极细末；②除熟地、土茯苓外，将其他药共研细末；③土茯苓煎汤去渣，入熟地煎取浓汁去渣，代水泛丸如绿豆大，每服6~9g，日服2~3次，小儿减半。连服2料为1个疗程。^[2]

顾氏诊治干咳逢秋必发，而因有痰鸣者，自定其名为干咳性哮喘。现代医学命名为非典型性哮喘。此种干咳，临床颇为多见，但治疗非易，温化、清润、辛散、补泻均难取效。顾氏认为肺虚叶燥是其内因，新凉外束是其外因，而邪郁易生内热为其重要的病理特征，故拟辛温解外与甘凉润肺参合运用，俾卫无邪束，肺获清肃，则娇脏复其治节，顽咳可告蠲除。曾治潘某，男，52岁。每逢秋凉则喉痒干咳，咽有痰鸣，咳甚则喘，唇燥口干，舌红少苔，脉细滑。西医诊断为非典型性哮喘。盖凉燥属次寒，寒客背膂，而素禀肺虚叶燥，外寒所加，内热易生，所以喉痒干咳，咳甚则喘，直待春暖咳缓。治当辛温以解外邪，甘凉以润肺燥。处方：细辛3g，制半夏6g，五味子3g，鲜生姜3片，瓜蒌皮15g，远志15g，炙马兜铃15g，天浆壳10g，麦冬12g，玉竹15g，炙甘草5g，炙枇杷叶9g。上方持续服药24剂，宿恙告瘳。本例用细辛、生姜温肺宣卫以解外束之寒；麦冬、玉竹甘凉滋润以济华盖之燥；马兜铃、天浆壳、瓜蒌皮、枇杷叶肃顺肺气；半夏下气降逆；远志化痰解痉；五味子酸以敛肺；炙甘草甘以缓急。全方温而不燥，润而不膩，辛不过热，苦不过寒，药证契合，而获良效。^[3]

2. 祝谌予诊治经验

①以发止辨虚实，重视脾肾：祝氏认为哮喘病机虽繁，

证候虽多，但病位总不离肺。前人治喘常分为虚实两型，新喘、体壮者属实证，久喘、体弱者属虚证。祝氏则常根据本病发作与缓解交替的特点辨析虚实。如哮喘发作时声如拽锯，不能平卧，不论病程新久，均按实证治疗。因患者每因感寒而发，或引动内饮，或本为郁热之躯，与外邪一拍即合，导致痰阻气逆。治宜表里双解，内外兼顾。属外寒内饮者，常用小青龙汤或射干麻黄汤化裁，以外散风寒，内蠲痰饮；外寒内热者（俗称寒包火），常用麻杏石甘汤加味，以宣泄肺热，化痰平喘。麻黄是仲景治疗肺实作喘之良药，唯因其发越阳气，体虚之人服后易致心慌、躁烦，可伍用生石膏、白芍、五味子等监之。痰多常加苏子、化橘红；胸闷加厚朴、陈皮。此时要慎用敛润之药，以免闭门留寇。哮喘缓解后多属虚证，但病位有肺、脾、肾之分，肺为气之主，肾为气之根，肺主出气，肾主纳气，脾居中焦，为生痰之源。哮喘日久，必然由肺累及脾、肾，故培补脾肾，固本定喘，可冀杜其夙根。如肺卫不固，腠理不密，屡易外感，动则气喘者，常用升陷汤或生脉散加味以实卫固表，气阴两补；脾不健运，痰湿内生，纳差便溏者，用香砂六君子汤或参苓白术散以健脾化痰，培土生金；肾失摄纳，呼多吸少，肢冷浮肿者，用真武汤或桂附地黄汤、七味都气丸以温肾纳气，补益下元。鉴于本病为沉痾痼疾，祝氏常仿施今墨先生用法，在主方基础上加补骨脂、胡桃肉、菟丝子、紫河车、大蛤蚧等纳气定喘药，配制蜜丸常服，以缓图竟功。

②以治痰为要法，调畅气机：祝氏尝谓：“治喘不治痰，非其治也”。乃因肺脏所伏之痰浊水饮，是哮喘屡发屡止的潜在病因。此即《金匱要略》所说之“留饮”和“伏饮”，或后世所称之“窠囊之痰”。痰浊水饮久踞肺脏，每

因感受寒邪、饮食劳倦、情志变动而诱发，搏击气道则出现痰涎涌盛，粘稠不爽，胸膈满闷，纳差便秘，苔腻，脉滑等。治疗用五子定喘汤（炙苏子 10g，葶苈子 10g，莱菔子 10g，杏仁 10g，白芥子 3g）加味。本方以豁痰下气的三子养亲汤为基础，加杏仁宣肺平喘，葶苈子泻肺行水，一宣一泻，气机通畅，哮喘自平。但只宜在无表邪情况下应用，若属风寒闭肺则非所宜。兼咳嗽加前胡、白前、紫菀、款冬花；兼食欲不振加菖蒲、佩兰叶；胸闷加厚朴、陈皮；便秘加全瓜蒌、薤白。

如治王某，女，34岁，售货员。因发作性哮喘4年就诊。每于入秋始咳喘发作，痰涎涌盛，持续至次年夏季方止。经变态反应科检查，对多种致敏原呈阳性反应，确诊为支气管哮喘。此次发作3月有余，服氨茶碱、舒喘灵、酮替酚等平喘西药无效。痰多白粘，大便不爽。舌质黯，苔白厚腻，脉弦细。辨为痰浊阻肺，气机不畅。予五子定喘汤加前胡、白前、紫菀、款冬花、桔梗、桑白皮、防风等药治之。服药7剂，痰减喘定；再服1月，诸症悉平。乃将原方加麻黄、连翘、赤小豆、炙枇杷叶配成蜜丸，长期巩固疗效。1年后随访，哮喘未发。

哮喘因痰浊阻肺者固多，因肺胃气逆或肝经郁火致病者亦不少。祝氏治疗时非常重视人身气机的调畅，所谓“气顺则一身痰涎自消”。除宣肺、肃肺之外，有时还常以降胃气和舒肝气为主治喘。如旋覆花汤在《伤寒论》中主治呕吐、呃逆等胃肠疾患，而祝氏独用其治疗肺胃气逆之喘证，盖旋覆花、代赭石既有镇喘降逆之功，半夏、生姜又有和胃化痰之效，相得益彰。而对于精神紧张或情志不遂，肝经郁火犯肺致喘者，则常用逍遥散，加丹皮、黄芩、地龙、钩藤、杏仁、桑白皮等平喘解痉、宣肺止咳之药，

寓有调畅气机、气顺痰消的涵义。

③以抗敏为特色，辅以活血：典型的季节性哮喘与过敏因素关系密切，患者由于体质因素，接触花粉、尘螨、药物等变应原后，引起支气管平滑肌痉挛和管腔狭窄，导致哮喘发作，故又称为过敏性哮喘。此类病人大多见于儿童或青少年。祝氏主张要辨病用药，常选验方抗敏煎（银柴胡 10g，炒防风 10g，乌梅 10g，五味子 10g，生甘草 6g）以抗敏解痉，平喘，止咳。方中银柴胡甘寒益阴，凉血退热；防风辛温，祛风解表；乌梅酸涩化阴生津，五味子酸温敛肺益肾；生甘草调和诸药。对血燥受风之过敏性疾患确有良效。治喘时随证加钩藤、薄荷、蝉蜕、地龙等解痉药物，而且药理研究发现上述方药均有抗变态反应作用。

如治李某，男，16岁，学生。自幼患哮喘，每年均发，白昼无恙，入夜则喉中痰鸣如水鸡声，痰粘不畅，口干喜冷饮，手足心热。舌质红，脉细弦。辨证为肝肺郁热，血燥受风。方用过敏煎加香附、五灵脂、黑白丑、旋覆花、黛蛤散，以清肺平肝，抗敏解痉。药服 5 剂，未再哮喘。守方加丹参 15g，茜草 10g，10 剂后诸症皆愈。

部分哮喘病人经西医确诊为肺气肿、肺心病、肺间质纤维化或慢性心功能不全者，病程日久，可见面色晦黯，唇甲青紫，颈静脉怒张，舌质紫黯或有瘀斑、瘀点等体征，表现为气虚血瘀之候。盖因肺主气，助心脏以行血脉，肺病日久，宗气不足，无力以畅血行，则血脉瘀阻，宜从活血化瘀治疗，随证加当归、川芎、丹参，用川芎走上，当归行下，丹参活一身之血。血瘀甚者径用桃红四物汤，活血化瘀治其标，配合益气养阴固其本。这种权衡轻重，气分病从血分治疗的方法，往往比单纯补气有效。^[4]

3. 邵长荣诊治经验

中医学认为哮喘自幼发作者，多与先天不足，肾气虚衰有关。邵氏应用补肾法有独到见解。补肾的中药不仅用于培本，逐渐解除对激素的依赖，同时可纳气平喘，用于治标。在临床上有许多哮喘患者，长期使用皮质类固醇激素来控制哮喘发作。但有些病人由于用量大、周期长，往往形成激素依赖，容易产生多种副作用。对于这类哮喘患者，邵氏使用平肝纳肾法治疗取得独特效果。因为大多数顽固性激素依赖型哮喘，常有虚肿、疲劳、情绪烦躁、易激动、易汗、大便秘结等症状，邵氏认为这类患者往往属肝气郁结，气郁化火，肝木克金，肺气不降之病机。另一方面，追问病史自幼有奶癣史及鼻炎等先天不足之宿根。而肾为先天之本，“肾主纳气”、“肝主条达”是邵氏使用平肝纳肾法的依据，同时在辨证中抓住病症特点，同病异治，异病同治，采用通腑豁痰平喘法、健脾利湿平喘法、培土补肾平喘法、温肺助阳平喘法，异中求同。邵氏常用麻黄，认为此药可松弛支气管平滑肌，缓解支气管痉挛，有极好的平喘作用。历代医家均认为麻黄为辛温解表、宣肺平喘之要药，因其性温，故多用于实喘中之偏寒者，但邵氏认为若经适当配伍，寒热之喘均可应用，但用量应当因人因地因证制宜。总之，喘证因其个体差异、病程长短、复发频率以及有无并发症等不同，临床上多出现寒热错杂、虚实夹杂的情况，需要攻补兼施，辨证加减，方可奏效。

如治张某，女，35岁，哮喘病史10余年，近年来均靠激素强的松控制病情。诊见：患者面色萎黄，满月脸，易出汗，胸闷气急，动则加剧，痰多烦躁，腰膝酸软，舌质淡红、苔薄白，脉小滑。治以平喘化痰止咳法。处方：黄

荆子 9g, 白芍 18g, 炙麻黄 9g, 丹参 9g, 平地木 30g, 功劳叶 12g, 细辛 4.5g, 射干 12g, 辛夷 4.5g, 茯苓 12g, 灵磁石 30g, 苏子 12g, 苏梗 12g, 陈葫芦 30g。每日 1 剂, 水煎服。服药后, 强的松已逐渐减量, 但咳嗽、胸闷易叹息, 此时采用疏肝法为主。处方: 柴胡 9g, 白蒺藜 9g, 白芍 9g, 射干 12g, 旋覆花 12g, 藿香 9g, 桔梗 6g, 茵陈 9g, 野菊花 9g, 桂枝 6g, 瓜蒌 12g, 北沙参 12g, 杏仁 12g, 黄芪 12g, 甘草 6g。服上药后, 胸闷气急、痰量明显减少, 强的松剂量由每天 20mg 减至 10mg, 随访 1 年, 强的松逐渐停药, 哮喘基本稳定。^[5]

邵氏治喘常用法则有如下几点。

①通腑豁痰法: 邵氏认为气郁痰壅而致喘, 要考虑适当用通泻药物。中医学认为“肺与大肠相表里”, 六腑以通为用, 而大黄等攻下药能“开导阳邪, 宣通涩滞”, 起“开门逐贼”的作用。肺肠热盛, 宜用清泻, 自古以来大黄即用作泻剂。如《本草经》称本品能“荡涤肠胃, 推陈致新, 通利水谷”。据研究, 大黄具有较强的抗菌作用, 可促进肠蠕动, 从而加速血液循环, 有利于炎症吸收。邵氏运用大黄, 不拘一格, 剂量根据患者的体质及耐受力调整增加, 既不伤正气, 又达到治疗目的, 腑气畅通则肺肠热清, 肺气肃降则喘自平。其运用芦苇更具特色, 芦苇有清肺热生津液之功能, 虽属性寒, 但味甘淡而力薄, 最大的优点是性不滋腻, 生津而不恋邪, 与大黄相伍, 共奏润肠通腑作用。

②利湿平喘法: 适用于水湿内停者。水湿有两种含意: 一是有形的水分在体内滞留形成水肿, 尤以下肢为甚, 邵氏常用陈葫芦、葶苈子、茯苓、车前草等, 渗湿而不伤脾胃, 利水而无损正气。临证时常加用茵陈一味, 此药具有

清热利湿之效。药理证明，茵陈中含有 6,7-二甲氧基香豆素，有平喘作用。配以藿香芳香化浊，效果更佳。加用车前草利尿消肿，它既可利颜面及下肢水肿，又能清肺中之水。咳喘不息，多是痰饮壅肺，水湿之邪作祟，也可用车前草清利之，水清饮除，肺野清轻，气道通畅，则咳喘可平也。

③培土补肾法：哮喘反复发作，导致肺气日益耗散，而肺气赖水谷精微以充养；肾主摄纳为气之根，故久病不已可出现肺脾肾皆虚，当为调理。除一般辨证用药外，均加入补骨脂、五味子。补骨脂系辛苦、大温之品，具有补肾壮阳、温肾纳气之功，对肾不纳气之虚喘患者，是一味治本之药。本药不仅治本也可治标，对于即使不是肾虚的哮喘患者，只要热象不太明显，且无咯血等表现，可加强祛痰平喘之效。邵氏治喘经验方三桑肾气汤中就重用了补骨脂。五味子上敛肺气，下滋肾阴，对肺肾两亏所致的久咳虚喘效果显著。加用此药，具有纳气，补肝肾之功，治喘效果尤佳。^[6]

邵氏治疗哮喘用药颇具特色，疗效显著。

麻黄首载于《本经》，自汉代张仲景创制麻黄汤以来，历代医家都认为它是一味辛温解表，宣肺平喘的要药。因其性味辛温，故多用于实喘中之偏寒者。但邵氏认为，若经恰当配伍，寒热之喘均可应用，麻黄的用量应当因人因地因证制宜。近来其用量有加大的趋势，偶可用至 15g，但须蜜炙以濡润其燥烈之性；有时则重配白芍 30g、桂枝 9g，调和营卫，以纠麻黄过汗之弊。在临证中邵氏还根据患者体质的差异善用麻黄根来治疗兼有自汗的哮喘患者。而对素患高血压、心脏病及体质虚弱者则当禁用或慎用。

射干为治咽喉疾患之要药。但邵氏独喜用于治喘，其

机会有时甚至多于麻黄。他认为，本药性味苦寒，具利咽清肺之功，而无麻黄发汗之弊。咽喉乃肺气出入之道，咽利路通，则哮喘可平。其用量多为 9~12g。

款冬花具有较好的止咳化痰作用。邵氏和已故名医程门雪均认为它是一味治喘良药，不过，单味应用药力较薄，故邵氏多喜在复方中配用之，且因其性稍嫌温燥，故常蜜炙使用。

补骨脂系辛苦、大温之品，具补肾壮阳、温肾纳气之功。对肾不纳气之虚喘患者，它本是一味治本之药，常与胡桃肉等温补肾阳之品合用。邵氏认为，八纲辨证中的“阴阳”、“寒热”、“虚实”、“表里”这四对矛盾是既对立又统一的，“标证”和“本证”也是如此，只是不同疾病在不同阶段有所偏重而已。所以本药不但可以用于治本，也可用于治标，对于即使不是肾虚的哮喘患者，只要热象不太明显，且无咯血等表现者，即可应用，以加强祛痰平喘之效。

车前草一般用于利尿消肿。邵氏认为它既然可利颜面及下肢之水，必定也能清肺中之水。咳嗽不息，多是痰饮壅肺，也是水湿之邪作祟，当然也可应用车前草清利之。水清饮除，肺野清虚，气道通畅，则喘咳可平。因而，邵氏在治疗喘咳不休、痰饮壅盛者多有加之，疗效颇佳。

胡颓叶《中藏经》载它能治“喘嗽上气”，《本草纲目》曰其能补“肺虚短气”，民间也有用之以治疗哮喘者。邵氏认为本品既可治喘，又能补气，攻补兼任，确是一味治喘佳品，因而他在平时也常喜用之，尤其是对治疗发育期前后的少年哮喘患者，常奏奇效。^[7]

4. 周仲瑛诊治经验

“发时治标，平时治本”，此为治哮之常法。周氏认为，

发作之时，虽以邪实为多，但正虚为主者亦不少见。哮喘之证多有夙根，每因遇感触发，经久反复，耗散肺气，尤损肾元。“肾为气之根”，肾之真元亏虚，根本不固，则气失摄纳，上逆于肺。若执祛邪治标之说，纵投大剂祛痰降气，鲜有效验。叶天士云：“实则治肺，虚则治肾。”故不必囿于常法，当慎审阴阳之偏虚，或温肾阳，或滋肾阴，标本兼顾，扶正祛邪，方能切中肯綮。

如治曹某，女，32岁。1988年9月17日诊。素有过敏性鼻炎史。产后哮喘发作，反复迁延，经年不愈，每日均作，多在夜晚，发作时胸闷气塞，气逆作喘，不得安枕，吸气尤难，伴有烦热多汗，痰稠色黄味咸。舌质黯红，苔淡黄腻中灰，脉沉细滑数。证属肾元下虚，痰热蕴肺，肺气升降失司。治拟补肾纳气，清肺化痰。药用：南沙参10g，北沙参10g，当归10g，竹沥半夏10g，炙桑白皮10g，知母10g，天花粉10g，炒苏子10g，炙僵蚕10g，诃子肉8g，沉香（后下）8g，生地12g，炙射干6g。另海蜇（漂）50g，荸荠7只同煮，代水煎药。服7剂后，哮喘旋即控制，唯咳频痰稠，汗出量多，苔淡黄灰腻，脉细滑。肺实肾虚，治守前意观察，原方去诃子肉加五味子3g，山茱萸6g。续服7剂，诸症悉平。

患者素禀不足，产后体虚，阴血耗伤，复加感邪诱发哮喘。每投治标之剂少效，酿成痼疾。痰稠色黄，苔黄腻，脉滑数，纯属痰热之象，但审其痰有咸味，脉兼沉细，乃肾元已亏，故须扶正祛邪。以南、北沙参、天花粉清养肺阴，生地、当归、山茱萸、沉香滋养肾元，纳气归肾，复予射干、知母、苏子、竹沥半夏、桑皮、僵蚕清肺化痰，配伍诃子肉、五味子收敛耗散之气，清补相济，毫无恋邪之弊，且仿王孟英雪羹汤，海蜇味咸入肾，荸荠甘寒生津，

有助滋肾润肺化痰。诸药合参，肺得清宁，肾能蛰藏，痰消气降而哮喘自平。

医者多以麻黄配干姜、半夏治冷哮，配黄芩、桑白皮治热哮。周氏认为治哮未必皆用麻黄，本品宣散，邪少虚多者用之，恐伤正气。^[8]

5. 姜春华诊治经验

①关于哮喘的辨证：姜氏认为，治喘用平喘法，凡在临床上有寒热可辨者疗效好，若无证可辨者疗效平平，古方定喘汤即用于无证可辨者。哮喘的治疗，有时不必平喘，观其主要矛盾所在。喘本是主要矛盾，但一有表证，则表证转为主要；痰多壅塞则痰多为主要；咳嗽剧烈则咳为主要。解其一端则一端自平。

②关于哮喘的治疗：姜氏认为，若要预防哮喘发作，平时益气补肾。青年女性着重肾阴，老年男性着重肾阳，幼少培补先天，改善体质，体质改善则少发作，少发则体质更好，转不良循环为良性循环。如预防儿童哮喘发作，可常服胎盘粉 1.5g，每日 2 次、或河车大造丸，每次 6g，每日 2 次。中、老年可常服左、右归丸，或七味都气丸亦可。前人有发时治标（肺），平时治本（肾）。姜氏也照这个规律治喘。后来临床发现，当哮喘发作剧烈时，服治标药无效，可以标本同治，止喘药与培补药同用，可收到较好效果。具体治疗应视哮喘主要矛盾所在：有表者解之，寒则用温，热则用寒，寒热交错则寒热同用，痰多者祛之化之燥之，痰多壅滞气道，往往使喘缠绵不止，除痰则气道通，通则喘也平，痰多者禁麻醉药。无痰者润之，胶凝者稀释之。咽峡红肿者清之消之。咳剧不止引起哮喘，用镇咳方法，咳止喘也平。若气上冲者下之平之。闷憋者宽

之。又闭者开通之。无汗则发，尿少则利，便闭则通。总之随着矛盾转化而灵活用药。不限于成方规格，不限于平喘药。^[9]

哮喘辨证有表里寒热虚实之分，凡辨证明确者效果良好，如热者寒之，寒者热之，皆易见显效，独无证可辨，用通常治喘药不易见效。宋人治喘，常用罂粟壳，此药有麻醉作用宜慎用，对痰多阻塞气道者禁用。曾有人用度冷丁一针致病人痰滞气管而死，可以引为教训。痰多者以祛痰为急，咳剧者以止咳为急，有表者解表为先，便秘者通便为急。老年喘作，须防痰火上升。

多年来治喘无不用麻黄，如大小青龙、麻黄、三拗、千缙、定喘等汤，无一不用麻黄，近年知其药理，用者更坚信，过去用三五分、二三钱者，近人或见其效不佳竟用至三五十克，不可为训。

姜氏对发作持续顽固不止者，常采取标本兼治法，以温肾益气加入平喘药。古人有平时治本，发时治标之说，后人奉为守则，然亦非绝对。治本以补肾益肺为主，益肺常用人参、黄芪、五味子，补肾用巴戟、熟地、仙灵脾、菟丝子、破故纸等。经探索治喘新药，佛耳草、旋覆花、碧桃干、老鹳草、防风、全瓜蒌合用颇有效，治喘不一定用麻黄也。

治病有专病专方，更有辨证论治。有一老妇自北方来，途间感受风寒，至沪喘作，面色苍白、舌淡、痰多呈白沫样，投以小青龙喘立止，至春感受风温，喘又作，自配药方服之无效。诊时面色渐红，唇舌亦红，投以桑菊饮加味即效。又一次因操劳过度复作，又自配前方，服之无效，就诊于余。诊时神情憔悴，气短懒言，投以补中益气遂愈。又一老人喘作不停，医以其年老，作虚喘治不效，余见患

者体力尚可，苔黄黑，大便不行近10日，老人自言往日大便通喘即平，于是投以大承气汤，大便得通，其喘平，此又不用平喘药而喘平也。^[10]

6. 俞岳真诊治经验

喘证“在肺为实，在肾为虚”。治喘之要，全在明辨虚实。俞氏治疗喘证，辨证详尽透彻，尤以问诊颇详，如动静之变化，寒热之有无，起病之暴久，无不一一审察。从而于复杂的证候中，首先辨明虚实的所属，病位的所在。

①审动静之变化：俞氏认为，以动静论病，可知病源。如以喘证为例，外感之喘在肺，则动亦喘，静亦喘，因外邪壅肺，肺气失宣降之司，故其喘不因动静增减。唯虚喘之源在肾，静则阴凝，气尚可纳，动则阳化，阴弱失纳，乃遂吸遂喘，故症见动辄喘促是下元之虚、肾气不纳之据。这是说明动则气喘属肾气不纳的虚喘。若不因动静增减，便属邪气闭肺的实喘。

②审寒热之有无：外感之喘属实，必有寒热之象，无寒热多属虚喘，故寒热之有无，是辨别虚喘与实喘的关键之一。风寒喘，恶寒而无汗，风热喘，发热而有汗。痰喘和虚喘不挟外感，则无寒热。阳虚喘，畏寒而无热象，阴虚喘，虽热而无寒象。

③审起病之暴久：赵晴初云：“盖肺肾为俯仰之脏，《内经》所谓肾上连肺是也。肺气开张，上而不下，久久震动气海，波及肾矣。”说明肺肾间关系至为密切。初病暴喘，病变在肺，在肺属实，多为邪气壅肺，肺失宣降。倘久发不已，势必由肺累及于肾，在肾属虚，多为肾气虚弱，气不摄纳。故先贤“暴喘属实，久喘属虚”、“在肺为实，在肾为虚”，实有至理。若久病触邪而发，多属本虚标实之

证，与初病暴发之实证迥异。法应标本同治，虚实兼顾，不可专事攻邪为治。

俞氏认为，以上三审，须相互合参，并结合脉证，方为全面确切。

苔脉的舍从，是辨别疾病的重要途径，俞氏治喘，有从脉不从苔，或从苔不从脉，在临证时极宜取舍，这对临床上辨别证候真假，具有指导意义。

①实喘重苔：实喘以寒喘、热喘为多。寒喘与热喘，其喘虽同，而其喘之因非一。亦有喘之因虽同，而所现之脉证有异，应以苔色为重。譬如以小青龙汤证来说，《伤寒论》“伤寒表不解，心下水气”之喘，其脉证既有表不解的恶寒发热、头痛脉浮等太阳表证，又有心下水饮证。《金匱要略》治溢饮及支饮条中云：“支饮亦喘而不能卧，如短气，其脉平也。”“咳逆倚息不得卧，小青龙汤主之。”条中未言脉浮等太阳表证，反言脉平，他条文中又言脉沉、脉沉而弦、脉沉紧等，均属饮病脉象。可知本方既治外寒内饮喘，又治支饮喘，二者脉象虽异，寒饮咳喘则一，而寒饮之苔，必白而润。故俞氏凡见咳喘暴起，苔白润，痰多清稀者，不论表证有无，脉之浮沉，既无热象，又无虚象，每投此方，屡收药到病除之效。若苔黄燥，多属热喘，则不可与也。

②虚喘重脉：如肺癆咳喘，多现肺阴亏损或肺肾阴虚之证。阴虚则火动，火动则痰生，阴虚挟痰热者甚多，而痰热阻塞肺络未必尽现于舌，应以脉为依据。《内经》云：“寸口脉实者，肺实也”，“寸口脉虚，肺虚也。”临床虽见舌质光红为阴亏之象，但只要右寸滑大，咳喘并见，咯痰不爽，是肺阴亏损，痰热逗肺之候，不可因舌光红而谓无痰热也。应于养阴润肺之中，佐以清热化痰之品。若一味

滋润，闭热壅痰，反致加重。叶天士“在肺为实”一句，实寓虚亦不忘挟实之意。右寸虚弱，才纯属肺虚。若右寸虚，两尺弱，为肺肾并亏。右寸滑大，两尺虚弱，是下虚上实。

又如肾虚喘，以两尺虚弱，动则喘息为据，不论苔之厚薄，痰之多少，皆以摄纳为主。俞氏曾治一患者，喘已数月，动则尤甚，痰多色白，苔白腻似粉堆积，脉两尺特虚。检前医所处之方，尽是理肺化痰之剂而无效。俞氏从肾气不纳论治。处方：熟地、山药、五味子、山茱萸、怀牛膝、胡桃肉、车前子、苏子。俞氏认为，此例腻苔是为假象，不足以信。盖痰多是肾虚不能主水，水泛为痰，痰随气上升所致。腻苔是痰饮浊气，随喘息之气上逆于舌而成。动辄喘甚，尺脉特虚，是为真据，宜从脉之真虚，不从苔之假象。至复诊，果得中病。病者自述，服2剂后气喘稍减，5剂后痰减喘平，舌苔已转薄。如此之案，所见极多，收效亦佳。程门雪氏亦有如此卓见。就临床所见，肾虚喘中，多现假苔，并不鲜见，然医者极易为假苔所惑。^[11]

③治喘三原则：一是喘证有邪，其病多实，当治其邪：实喘在肺，多由风寒、风热、痰浊、肝郁气逆而致邪壅于肺，肺失肃降，当治其邪，用宣肺、化痰、清热、降气等法。常用小青龙汤、定喘汤、麻杏石甘汤、葶苈大枣泻肺汤、二陈汤、三子养亲汤、泻白散、黛蛤散、五磨饮子等方加减出入，祛邪利气，以使其平。然咳喘病位在肺，却与大肠相关。肺失宣肃，逆而为喘为咳，大肠传导失司，大便秘而难行。腑气不通，浊气上逆，肺气不利，咳喘更甚，肃肺通腑，亦治咳喘一环。咳喘方中加入紫菀、知母通利肺气，润肠通便，或用麻杏苈黄汤加减，肺与大肠同

治。二是喘证无邪，其病多虚，重在治虚：虚喘无邪，多属脏气亏虚。前人谓“呼出心与肺，吸入肝与肾”。呼气困难，重在治肺。吸气困难，重在治肾。呼、吸皆难者，肺肾同治。肺肾为子母之脏，故咳喘日久，必肺肾同病。治肺常用生脉散、五味子汤。治肾则用都气丸、济生肾气丸。肺肾同治以五味子汤、都气丸加减化裁。而人参、蛤蚧、胡桃肉、五味子、河车、沉香等药随证加减，每收良效。此外，肺虚补肺，当重脾肾。子病及母治脾，培土以生金；母病及子治肾，金水相生。补肺治肾，当兼顾脾胃，脾胃健运则正气充沛，不致滋生湿痰，又可资助肾脏元气，补养肺金。尤其是肺肾亏虚，湿痰内阻，健脾和胃，运痰化湿尤不可少，否则补而不化，徒补无益。三是虚喘挟邪，或先固本，或暂治标，或标本同治。肺肾亏虚，又兼外邪，其病多急，轻重悬殊。轻者先治其标，宣散外邪。用青龙、定喘汤之类，邪退之后，以肾气丸、都气丸、补中益气汤等固其本。或标本同治，一面补肾纳气，一面宣肺化痰、祛寒清热。若兼浊痰困脾可肺脾肾三脏同治。若病危重，邪少虚多，元气虚脱，当急固元气，益气固脱。因此，虚喘挟邪，当权衡虚实轻重，邪之多少，挟痰挟瘀，随机应变。^[12]

7. 唐福安诊治经验

①寒喘：又名风寒喘急，因外感风寒，内郁于肺而致的喘急。指肺主皮毛，一受风寒，内闭肺气，则气逆不降，呼吸气急，故作喘也。发热无汗，宜以华盖散（苏子、赤茯苓、橘皮、桑白皮、杏仁、麻黄、甘草）汗而散之；风寒又夹痰热郁滞用定喘汤（麻黄、半夏、款冬花、桑白皮、苏子、黄芩、杏仁、甘草、白果）。

②热喘：指气喘而肺热炽盛者。多由肺受热灼，水津不能下行，痰火壅阻气道所致。症见气喘，痰多黄稠，烦热胸满。治宜清肺泻热涤痰为主。用泻火清肺汤（《万病回春》方：黄芩、枳实、栀子、桑白皮、麦冬、沉香、朱砂、陈皮、杏仁、苏子、赤茯苓、贝母、竹沥）。如肺有热邪，又外感于寒，中有积痰，亦可导致气喘，通常称寒包热喘，往往遇寒即发，治宜宣解郁热，用麻杏石甘汤、麻黄定喘汤（《张氏医通》方：麻黄、杏仁、厚朴、款冬花、桑白皮、苏子、甘草、半夏、黄芩）。

③痰喘：指气喘因于痰浊壅肺者。多由痰湿蕴肺，阻塞气道所致。症见呼吸急促，喘息有声，咳嗽，咯痰粘腻不爽，胸中满闷等。治宜祛痰降气平喘。用二陈汤，苏子降气汤（《局方》）等方，平地木、佛耳草可配合使用。痰喘缓解后宜培补脾肾，用六君子汤，金水六君煎等方。

④水喘：指气喘因于水饮犯肺者。多由肾脏聚水，脾湿不化，水气上凌，肺失宣降所致。症见气逆喘急，胸膈满闷，腹胀，怔忡，面目或肢体浮肿，小便不利等。治疗须分标本缓急，治标宜逐水利湿，宣降肺气；治本宜运脾温肾；先喘而后胀者以治肺为主；先胀而后喘者以治脾为主。如小青龙汤，葶苈散（《医学入门》方：葶苈子、黑枣），加减泻白散（《医学发明》方：桑白皮、茯苓、地骨皮、甘草、陈皮、五味子、人参）以泻肺行水；苓桂术甘汤，真武汤，肾气丸等以运脾温肾。

⑤火郁喘：指火邪郁阻于肺所致的气喘。多由邪火内蓄，肺气遏郁，失于宣散而成。症见气逆喘促，神情闷乱，四肢厥冷，脉象沉伏。治宜散蓄热为主。用逍遥散、左金丸加减。喘平后用六味地黄丸调理。

⑥气虚喘：指元气不足或脾肺气虚所致的气喘。症见

呼吸急促，似不能接续，身倦乏力，言语低微，动则汗出，喘逆更甚等。治宜补气平喘，用人参平肺散（《症因脉治》方：桑白皮、知母、茯苓、甘草、人参、地骨皮、青皮、陈皮、天冬、薄荷叶），四君子汤等方。

⑦阴虚喘：指阴虚阳浮而致的气喘。多由阴血亏损或肾阴虚耗，阳气失于依附，直冲清道而成。症见气喘发作时有气从脐下冲上，可伴有潮热、盗汗等。治宜滋阴养血或补肾益阴。可选四物汤，生脉散，麦味地黄丸，河车大造丸等方，亦可配合潜阳纳气药。

⑧真元耗损喘：指肾虚不能纳气的气喘。多因喘咳久延或大病后本元受损，真阳虚惫，肾气不能归元所致。症见喘促气短，呼多吸少，动则易汗，喘息更甚，形瘦神疲，甚则唇甲青紫，心悸，肢体浮肿，脉沉细数；严重的可见四肢厥冷，面赤烦躁，气急不续等危象。治宜温阳培元，补肾纳气。可选用附桂八味丸，都气丸，人参蛤蚧散，黑锡丹等方。

唐氏认为，治喘证须辨清实喘和虚喘，虚中挟实，实中有虚，错综复杂，须细加分析，对症用药才能获效。如喘证日久，往往本虚标实；内伏宿痰，肺气壅盛为实，脾虚不运，肾虚失纳则为虚；或肺脾肾三脏均虚之体，新感引动伏饮；或痰食互积等等，均宜宣肺祛痰饮或消食治标，补肺健脾，益肾扶本，标本兼顾是为常法。

唐氏认为，喘证之痰，有白稀粘痰，有泡沫痰，有黄稠痰，有甜味之痰，有咸味之痰等，用药有所不同。一般白稀之痰多为寒痰，泡沫痰多为风痰，痰黄而稠不易咯出多为热痰，痰多而白稀易于咯出或痰有甜味多为湿痰，痰胶粘而易吐出或带血丝咽干痒多为燥痰，痰有咸味则为肾水不摄，津液上泛。根据痰色和质量辨证用药。

唐氏认为，实喘多伴有咳嗽。如外感风寒、风热、痰饮、痰热等引起咳嗽不止而致喘者，均宜宣邪清散，使肺气宣则咳嗽松爽，喘自平；如过多用平喘或止咳药，如苏子、桑白皮、枇杷叶、款冬花等效反不显，甚至喘更甚。

唐氏认为，古人有“肺不伤不咳，脾不伤不久咳，肾不伤不喘”的说法。故治疗慢性咳嗽而兼喘者，咳少气喘，表邪清后，须兼顾肺脾肾三经之虚，以扶本为主。^[13]

8. 叶德铭诊治经验

①寒性哮喘：叶氏认为，寒性哮喘临床比热喘多见，症见喘促急，喉间哮鸣，痰色白而清稀，胸膈痞闷，面色晦暗，口不渴，苔薄白，脉弦滑或浮紧等，治当温肺化痰，止咳平喘。叶氏以小青龙汤配伍甚妙。可灵活运用其法。若偏于风热者，加石膏，若有咽痛用射干。

如治胡某，男，28岁。有哮喘病史。经常发作，气喘咳嗽遇寒即发。近来喘更加剧，气闭呼吸不调，卧难着枕，稍有发热，心烦。脉滑，舌红尖绛。严重发作时，每天需服氨茶碱，有时要用肾上腺素才能缓解。拟小青龙加石膏汤。药用生石膏15g，麻黄5g，桂枝3g，生白芍9g，生甘草3g，杏仁9g，生姜3片，五味子3g，姜半夏9g，旋覆梗9g，炙细辛2g，炒苏子9g。服3剂。药后气逆喘急已平，发热已退，咳嗽痰多，喉系不利，漉漉痰声，脉滑，苔薄。前方减石膏9g，苏子减半，姜半夏减用6g，除旋覆梗，加白前9g，葶苈子5g，远志5g，桑皮9g。3剂尽，气逆已平，能安卧，咳嗽痰多稀白，脉弦滑，苔薄质红。原方去石膏、生姜、白前，加生牡蛎12g，鹅管石9g。以巩固疗效。

②热性哮喘：临床症见发热，气促胸高，喉中哮鸣，

声若曳锯，咳呛不利，痰色黄而胶粘浓稠，口渴喜饮，大便秘结，舌质红，苔黄腻，脉滑数，治当宣肺清热，豁痰利气。热哮喘当有肺热和痰热内蕴之异。叶氏对肺热用大青龙汤或麻杏石甘汤为主，两方均属解表邪而清内热，外寒重而内热轻者，用大青龙汤，外解寒邪而兼清里热；如肺热重而外邪轻，则用麻杏石甘汤，清泄肺热。两者之运用，大青龙汤以不汗出而烦者始为对证；麻杏石甘汤，不论其有汗无汗，只是肺经有热而喘即可用之，因麻黄不与桂枝同用，只能泄肺邪，不至于大汗，故用麻黄散肺经热，石膏清肺热。如挟有痰热内结，当用开泄之法，地道得通，天气自降，扰乱平而喘息自定。

如治江某，男，46岁。哮喘有七八年，入冬发作住院，X线胸透示两肺纹理增粗，肺门阴影加深，伴有钙化点。此次发作后4天，气逆喘迫不得卧，痰粘不易咯出，胸膈作痛，呼吸时尤剧，发热持续不退，体温38.5℃，汗出涔涔，脉浮数，舌绛，苔黄。宿恙感新邪复发，先以开泄。生石膏12g，麻黄3g，杏仁9g，生甘草3g，生冬瓜仁12g，芦根15g，冬葵子9g，葶苈子6g，炒苏子6g，海浮石9g，莱菔子12g，全瓜蒌12g。3剂。药后发热已退，体温正常，气逆喘迫较平。咳嗽亦减，痰不应声，胸闷胁痛减轻，舌绛，苔黄，脉弦，清泄热痰而养液以巩固疗效。药用石斛9g，生冬瓜仁12g，杏仁9g，全瓜蒌10g，海浮石9g，葶苈子6g，甘草3g，桑白皮9g，枇杷叶9g，麦冬9g，芦根9g，冬葵子9g。

③补法：叶氏认为，哮喘病缓解期以本虚为主，虚者当补，而虚证既有偏阳虚亦有偏阴虚，所以临床上当辨证论治，偏阳虚以苓桂术甘汤或肾气丸等，偏阴虚者，七味都气丸为主。

如治李某，男，41岁，1985年11月12日初诊。哮喘自1970年起，经常发作，有肺结核史，气逆息急，咳嗽痰多，口干燥，舌绛无苔，脉弦滑，肝肾阴亏，失摄纳之职，治以滋降。药用生白芍9g，生地12g，山茱萸9g，麦冬6g，五味子3g，紫石英12g，白石英12g，磁石9g，生冬瓜仁12g，石斛12g，桑白皮9g，枇杷叶9g，吞蛤蚧尾2g。5剂。药后哮喘已轻，咳嗽亦减，能安卧，痰稀白粘滞，口咸味，冲气上逆，舌绛，口干燥，脉弦。原方去冬瓜仁，加牡蛎15g以巩固疗效。^[14]

9. 张沛虬诊治经验

张氏认为，哮喘主要是一种发作性的痰鸣气喘病，发作时喉中痰鸣有声，呼吸困难，不能平卧，故有外寒诱发或外感风热时，必须以祛邪为先，用辛温解表，发散风寒或用辛凉解表，清肺化痰。佐入平喘化痰之品。哮喘发作时只治喘，不急祛邪，则哮喘往往不能平，效果亦不好。孩童在生长发育阶段，哮喘能减轻或缓解。妇女在怀孕期间，往往引起哮喘的发作或加剧。故张氏认为平时主要在于培补脾肾，扶正可以增强患者的抗病能力，进一步改善患者之体质。

哮喘在发作时，往往痰涎壅肺，胸闷气塞，即使有阴虚之兼证，亦不宜用滋腻之养阴药。张氏认为，喘发时应先治喘化痰，俟喘平后再顾其阴。哮喘在急性发作时，病人往往大汗淋漓，但张氏在多汗的情况下仍用较大剂量麻黄。因为麻黄平喘作用较其他中药明显，临床上并未致使汗出亡阳的情况，而多数病人在哮喘缓解后，汗出逐渐减少，喘平汗自止，汗出不已是喘甚之故。患者如有高血压，可加降压药，出血或鼻衄，痰中带血，可与止血药同用。

地龙有平喘作用，可解除血管、支气管平滑肌的痉挛。古方的“补阳还五汤”、“大小活络丹”中取其活血通络作用。民间用其通乳汁。张氏常用于哮喘取得良好疗效。民间单方地龙煎红茶治哮喘有一定疗效。紫河车以古法焙干研粉，效果最好；胚胎组织亦有同样效果。

张氏认为，仲景桂枝汤方有桂枝加杏朴汤，其实桂枝无平喘作用，是协助麻黄解表或有增强麻黄作用。

支气管哮喘长期反复发作的病人，晚期可并发肺气肿和肺源性心脏病，所以应积极寻找病因避免接触致敏原，避免各种激发哮喘的因素，及时治疗过敏性鼻炎，上呼吸道感染等，并经常开展体育和劳动锻炼。

张氏治疗支气管哮喘，主张辨证施治，发作期分寒痰阻肺型、热痰阻肺型，缓解期分肺气不足型、脾气不足型、肾失纳气型。

①发作期：寒痰阻肺型：症见形寒肢冷，脊背发凉，恶寒怕风，发热不重，头痛身痛，呼吸气促，喉间痰鸣如水鸡声，胸闷如窒，咳痰稀薄，色白多沫，或痰少而粘，咳吐不爽，面色滞暗，舌淡，苔白滑，脉弦紧或浮紧。治宜温肺散寒，祛痰平喘。方用小青龙汤加减：麻黄、桂枝、细辛、干姜、法半夏、橘红、紫菀、款冬花、苏子、五味子、苍耳子。

热痰阻肺型：症见声高息粗，呼吸急促，喉中哮鸣，痰粘色黄，咳痰不畅，胸闷，发热面红，口干喜冷饮，舌红，苔黄腻，脉滑数或弦数。治宜清热泄肺，化痰平喘。方用泻白散合麻杏石甘汤加减：炙麻黄、杏仁、黄芩、知母、桑白皮、款冬花、石膏（先煎）、地龙、金银花、甘草。哮喘严重，张氏常加佛耳草、葶苈子；痰多黄稠加鱼腥草、开金锁；咯痰不利加蛤壳；喉头有水鸡声加炙射干；

有过敏史者加苍耳子。

哮喘发作时张氏常用如下验方：生麻黄 10g，杏仁 12g，甘草 10g，地龙 15g，百部 15g，细辛 3g，枳壳 6g，石韦 15g，五味子 5g，紫菀 10g，佛耳草 30g。有感染者加金银花 15g，鱼腥草 30g；鼻塞声重加苍耳子 15g。

②缓解期：肺气不足型：症见喘气短促，动则喘甚，言语无力，或因遇风寒，哮喘即被诱发，下肢虚浮，舌淡脉沉细。治宜补肺化痰，佐以降气。方用参麦散合苏子降气汤加减：党参、麦冬、五味子、苏子、陈皮、姜半夏、款冬花、甘草。

脾气虚弱型：症见哮喘，平素痰多，乏力倦怠，四肢困重，食少纳呆，腹胀便溏，常因饮食不当所诱发，舌体胖大有齿痕，苔白腻，脉沉滑无力。治宜益气健脾。方用六君子汤加减：党参、白术、茯苓、制半夏、生姜、山药、五味子、炒扁豆、佛耳草、海浮石。

肾失纳气型：症见腰膝酸软，气短息促，呼多吸少，动则尤甚。肾阳虚兼见形寒肢冷，面色苍白，自汗或肿而浮，夜尿频，舌淡，脉沉细弱无力，治宜温补肾阳佐以纳气，方用肾气丸合参蛤散加减：熟地、山茱萸、山药、丹皮、茯苓、熟附子、肉桂、蛤蚧尾、五味子。气喘明显前方加黑锡丹，每次 3~6g，每日 2 次吞服。肾阴虚兼见自觉五心烦热、面颊升火，盗汗，口干尿黄，舌红少津，脉细数，治宜滋阴补肾，佐以纳气，方用七味都气丸合参蛤散加减：熟地、山药、茯苓、山茱萸、丹皮、泽泻、五味子、苏子、复方参蛤散。如肾阴阳两虚，左、右归丸各 9g 和匀，分 3 次服，平时常服，持之以恒。

张氏常以下方用于哮喘缓解期而收效：紫河车 60g，蛤蚧粉 45g，地龙粉 75g，五味子 24g，苍耳子 60g，甘草

30g, 研粉或蜜丸, 每次服 9g, 每日服 2 次, 早晚吞服。^[15]

10. 赵子贤诊治经验

赵氏长期致力于肺系疾病的临床研究, 造诣颇深。运用经方化裁治疗哮喘发作, 疗效显著。赵氏认为, 临床上应根据患者个体差异、病情不同、所处环境不同及有无并发症, 灵活掌握证候的寒、热、虚、实, 作出相应的治疗。

①治寒哮, 善用小青龙类方: 赵氏治疗寒哮, 常选用小青龙汤及由此演变而出的厚朴麻黄汤、射干麻黄汤、小青龙加石膏汤等。认为小青龙汤虽然原文为外寒内饮而设, 但临床运用时主要针对肺胃水气, 正如徐灵胎所云: “此方专治水气。”表证不是必具, 扩大了本方的应用范围。若外受寒邪, 里有水饮, 饮邪化热而见烦躁者, 可用小青龙加石膏汤, 或厚朴麻黄汤。运用厚朴麻黄汤时, 须抓住本方证的两个主要特点, 一是喘甚, 一是满甚, 如《千金方·咳嗽门》云: “咳而大逆上气, 胸满, 喉中不利, 如水鸡声, 其脉浮者, 厚朴麻黄汤方。”正是突出本方证的特点, 所以用厚朴、麻黄为君药, 以厚朴宽胸利气, 以麻黄宣肺降逆平喘。射干麻黄汤适用于寒饮郁肺而见有咳嗽、喘急、痰多者, 为治寒痰哮喘的常用有效之方。

以上各方中, 均有麻黄、细辛、半夏、五味子等药, 临床运用时, 尤其应注意它们的配伍、用量等。赵氏认为麻黄为治喘要药, 不论寒热虚实均可应用, 但应注意生麻黄发汗力大, 取其宣肺平喘功用时应加大白芍、五味子的用量; 炙麻黄发汗力小, 止咳平喘效果好, 为赵氏喜用之品, 寒哮配桂枝, 热哮配石膏, 清肺配黄芩, 降气配杏仁或葶苈子, 祛痰配射干, 理气配厚朴, 益气配党参 (老年人用太子参), 滋肾配熟地, 温肾配附子; 若患者有高血压

可伍牛膝、生龙牡等或用黄荆子代麻黄。细辛具有窜透开滞的特点，为治寒痰喘嗽常用之品，临床应用不可泥细辛不过钱之说，应根据实际情况而定。赵氏对寒饮重者，常用至6~9g。经云“肺欲收，急食酸以收之”，方中芍药、五味子等正是据此而用，酸味收逆气而安肺。对于五味子，先贤多认为外感用早有“闭门留寇”之患，不知仲景伤寒咳喘多用五味子，但应配伍干姜、细辛等才能使气机开阖有常，升降有度。赵氏喜用清半夏，认为清半夏辛味犹存，不仅能祛痰，更能以辛散逆气，正合寒痰哮喘之病机。

②疗热哮，加味麻杏石甘汤：麻杏石甘汤为治疗肺热壅闭哮喘常用方剂，全方药仅4味，但配伍精当。方中麻黄配石膏清宣肺热，麻黄伍杏仁宣降肺气，甘草益气缓中，调和诸药。石膏可用至30~60g，若热象明显可加黄芩、金银花、连翘、蒲公英、鱼腥草等清热解毒药；若痰黄而稠者加竹沥、瓜蒌、海浮石、浙贝母等药以清热化痰；若咳喘不止，大便秘结，可加大黄以通腑泻热，俟腑气一通而哮喘自平。

③除顽哮，活血、虫类搜剔良：哮喘病人尤其是久病者多见有面色晦暗，口唇紫绀，舌质紫红或紫暗，舌体瘀斑或瘀点等瘀血征象。朱丹溪云：“若无瘀血，何致气道如此阻塞，以致咳逆倚息不得卧哉。”说明瘀血内阻是哮喘难治的原因之一。因此，治疗哮喘需在上述辨证的基础上酌加丹参、赤芍、桃仁、红花、川芎、当归等活血化瘀药，方可收到较好效果。

对于顽固性哮喘，赵氏认为一般草木之品难以胜任，须加用全蝎、蜈蚣、僵蚕、水蛭、地龙、蝉蜕等虫类搜剔药以搜剔肺经伏邪，增强平喘、降逆之功。

哮喘急性发作，一般经上述辨证治疗往往可收到较好

疗效，但不易根除。赵氏特别强调只有加强缓解期治疗，才可能减少哮喘发作次数，以至达到完全缓解。

如治柴某，男，40岁，画家。因喘憋、痰鸣反复发作20年加重15天，于1997年1月8日初诊。患者20年来，每于春、夏季节遇冷或异味刺激即喘憋，发作前常伴有鼻塞流涕等先兆症状，每次发作自服支气管扩张药方能缓解。半个月前因受凉喘又发，于某医院作肺功能检查示：轻度阻塞性通气障碍。给予必可酮、喘定等药物，见效甚微。诊见：喘憋，不能平卧，咳嗽于夜间加重，痰多色白易咯，形体肥胖，疲乏无力，畏寒，口唇略紫绀，双肺满布哮鸣音，舌淡，苔白，脉沉迟。证属外寒束表，痰瘀内阻。治宜宣肺散寒，活血化瘀，祛痰平喘。方用小青龙汤加减：生麻黄9g，桂枝9g，细辛9g，清半夏9g，五味子9g，干姜9g，赤芍15g，白芍15g，射干9g，地龙9g，黄芪15g，当归10g，党参10g，沙参10g，甘草6g。6剂。每日1剂，水煎早晚各服1次。1月23日二诊：诸症明显减轻，效不更方，上方继服6剂。1月30日三诊：咳痰、喘憋消失，听诊无哮鸣音。后予调理之剂以善后。

本例患者正气素亏，痰饮内伏，每因外邪引动伏痰而发病，故治疗以祛邪为主，兼以扶正。方中麻黄、桂枝、白芍行气而平喘；五味子、白芍敛肺之逆气；当归、黄芪、党参、沙参益气养阴，扶助正气以托邪外出。全方共奏解表散寒、活血化瘀、祛痰平喘、益气养阴之功。方证相对，故二诊之后，哮喘发作即被控制，但仍需调理之剂以善后，方能巩固疗效。^[16]

11. 刘明达诊治经验

①初发急发者以清热祛痰、宣肺平喘为治：支气管哮

喘属中医之哮喘证，以膈上伏痰为发病的主要原因，以寒热之邪为诱因，并与饮食、精神、劳倦等有一定关系，正如《证治汇补·哮喘》所言：“哮喘为痰喘之久而常发者，因内有壅塞之气，外有非时之感，膈有胶固之痰，三者相合，闭拒气道，搏击有声，发为哮喘病。”因此发病时的基本病理变化为痰阻气闭，痰气搏结，以邪实为主。病人多表现哮喘、咳嗽、咯黄色稠痰或干咳无痰，口干，舌质红，苔黄腻，脉滑数等症，治则为清热祛痰，宣肺平喘。常用方药：麻黄、射干、黄芩、黄连、板蓝根、栀子、紫花地丁、芦根、苏子、天竺黄、桔梗、杏仁、紫菀、北沙参、甘草。方中麻黄、射干宣肺平喘；苏子降气平喘；黄芩、板蓝根、栀子、紫花地丁、芦根、天竺黄、紫菀清热祛痰；北沙参滋养肺阴；桔梗宣畅肺气；甘草调和诸药。病人服此方后，往往痰由黄稠转为白色泡沫痰，症状明显减轻。若兼恶寒发热等表证，方中酌加金银花、连翘以疏风解表；兼口干，舌红，少苔，干咳无痰者，去天竺黄、黄连，酌加麦冬、罂粟壳以滋阴敛肺止咳。

②年老体虚、病程日久、正虚邪实者当扶正祛邪并举：本病长期反复发作，导致肺气日益耗散，必然累及脾、肾。肺虚气不化津，痰浊内蕴，肃降无权；脾虚不能化生水谷精微上输养肺，反而积湿生痰，上贮于肺，所谓“脾为生痰之源，肺为贮痰之器”是也。痰湿蕴肺，必然影响肺气之升降；肾虚精气虚亏，不能化气行水，则阳虚水泛为痰，或阴虚生热，热灼津液成痰，上干于肺，致肺气出纳失司。肾气虚则肾不纳气，出现气喘气短（中医肾气与包含现代医学的肾上腺皮质激素、性激素、前列腺素等功能有关），因此年老体虚、病程日久者常表现正虚邪实，既有痰热内蕴、邪实闭肺之表现，又有脏腑虚衰之征，此时治疗不能

一味地祛邪为主，而应扶正与祛邪并举，才能收到较好疗效。常用方药：麻黄、射干、黄芩、紫花地丁、梔子、黄芪、防风、枸杞、补骨脂、炙苏子、百部、北沙参、甘草。方中除有清热祛痰平喘之药外，并加上黄芪、防风益气固表；枸杞、补骨脂补益肾气；北沙参养阴润肺，使之攻邪而不伤正。

③缓解期补益肺脾、滋阴润肺、温肾助阳：哮喘的基本病理因素以痰为主，而痰的产生责之于肺不能蒸化津液，脾不能运输精微，肾不能输布水液，其发病虽主要在肺，但与脾肾关系密切，且三者之间互为影响，可合并同病。反复久发，气阴耗损，肺脾肾渐虚，正虚则腠理不固，更易发病。因此，一俟哮喘缓解，则应注意补益肺脾、滋阴润肺、温肾助阳。常用方药：黄芪、党参、山药、白术、北沙参、麦冬、玄参、枸杞、补骨脂、菟丝子、大贝、紫菀、陈皮、甘草。方中黄芪、山药、党参、白术补益肺脾；北沙参、麦冬、玄参养阴润肺；枸杞、补骨脂、菟丝子滋肾助阳；陈皮、大贝、紫菀祛痰止咳。达到扶正固本、减少发作次数的目的。长期服用，可增强机体抵抗力。

总之，治疗哮喘初发、急性发作时以实证为主，治宜祛邪为重；对于病程长，年老体虚者常见虚实夹杂，治宜扶正与祛邪并举；对于缓解期的病者，则以扶正固本为治，从补益肺脾肾入手。

如治张某，男，63岁。有哮喘病史30多年，发作频繁，此次复发2周多，于1997年4月10日到门诊诊治。症见：哮喘入夜尤甚，胸闷发热，咽干口渴喜饮，鼻涕带血丝，痰黄稠难咯，舌暗红，苔黄腻，脉滑数。双肺呼吸音粗糙，吸气时间闻及较多哮鸣音及湿啰音。法当清热祛痰，宣肺平喘，佐滋阴润燥。处方：黄芩15g，梔子10g，黄连

10g, 紫花地丁 20g, 麻黄 10g, 射干 10g, 玄参 12g, 麦冬 12g, 天竺黄 10g, 苏子 10g, 天花粉 10g, 泽泻 10g, 桔梗 10g, 甘草 10g, 白茅根 10g。上方服 10 余剂后, 哮喘明显减轻, 痰为白色泡沫痰, 易咯, 气短, 舌淡红, 苔薄黄腻少津, 脉细滑。此时痰热清之大半, 本虚之象显露, 方中去黄芩, 易天竺黄为大贝, 加北沙参 12g, 黄芪 12g, 枸杞 12g, 补骨脂 12g。再服上方 10 余剂后, 哮喘基本缓解, 感纳差乏力, 动则汗出, 畏寒, 舌淡红, 苔薄白, 脉细。此时标实已去, 而以本虚为主, 上方去紫花地丁、紫菀、白茅根, 重用黄芪 20g, 并加桂枝 10g, 菟丝子 10g, 防风 6g, 砂仁 6g, 经服药 10 余剂后, 哮喘稳定, 半年未复发。^[17]

12. 曹世宏诊治经验

曹氏长期从事中西医结合医、教、研工作, 尤对中西医结合治疗哮喘、慢阻肺、支扩、肺间质纤维化等肺系病症积有丰富经验。临床既博及医理, 又精于辨证遣药, 故每获著效。从脾胃论治支气管哮喘即是其特点之一。

①脾胃气虚与哮喘发病: 曹氏认为, 古代中医先辈们从大量的临床实践中得出“哮喘有夙根”、“夙根专主于痰”之论, 非常难能可贵。由于脾胃气虚不仅可造成“土不生金”, 肺气薄弱的病理格局; 更可导致正气亏乏, 肾气虚弱的严重正虚状态。而肺脾肾三脏功能失调, 又是水液代谢失常的直接动因, 正如《素问·经脉别论》所云: “饮入于胃, 游溢精气, 上输于脾, 脾气散精, 上归于肺, 通调水道, 下输膀胱, 水精四布, 五经并行。”明确指出了脾虚失运、肺失布津、肾失蒸化导致水湿内停、为饮为痰的病理过程。而三脏之中, 尤以脾运失司, 首当其要。因脾阳一

虚，上则不能输精以养肺，水谷不归正化，反为痰饮而干肺；下则不能助肾以制水，水寒之气反伤肾阳，而致水液内停中焦，流溢各处，波及五脏，故有“脾为生痰之源”之说。这更说明了脾运失司在哮喘发病中的重要作用。故曹氏常常应用“脾胃气虚—肺气不足—肾失蒸化—卫外不固—痰饮内生—哮喘发作—脾胃气虚”的模式图来分析哮喘发病的机理和病理过程，颇符合临床实际。

②健运脾胃有重要意义：脾与胃相表里，统摄大肠，主四肢肌肉，共同完成水谷消化吸收与转输功能，以供全身营养。脾主运化，胃主受纳，同居中州，通连上下，为气机升降之枢。脾健胃纳正常，气机升降有序，则肺气宣发肃降才能如常；反之，若贪食生冷，痰湿内停，或嗜食酸咸、煎炸肥甘，损脾伤脾胃，酿湿生痰，或过食海腥发物，或过度劳累，脾胃受戕，气机升降失常，则饮食水谷不能消化，水谷精微不能化生，谷反为滞，津反为湿，水湿内停，痰饮内生，痰阻气郁，阻遏肺气，则宣降失常，哮喘发作矣。另外，肠腑通降有序，浊气排出有路，则清气上升无阻，尤可促使肺气之肃降。现代医学已经明确：食物过敏、食道反流、过度运动、腹压增高均是引起哮喘发作或加剧的重要因素。所以，从脾胃辨治哮喘，不但是中医理论的特点之一，亦为临床实践所证实，更是哮喘缓解期调理机体、增强免疫、防止复发的重要治法。

曹氏认为，脾胃为“气血生化之源”、“为后天之本”、“胃为卫之源”及“四季脾旺不受邪”之说，既有实践根据，又有科学依据。研究发现，健运脾胃方药可通过调整肠管紧张度及消化腺体分泌功能，增进食欲，可促进营养物质消化吸收，从根本上改善营养不良状况。资料显示：

健运脾胃方药，均富含微量元素铁、铜、锌、硒、锰及维生素B₁等，且复方煎剂中含量更高。因此通过健运脾胃治疗，既可补充微量元素及维生素，又能调整其体内的分布异常，提高机体利用率，有利于减轻哮喘患者微量元素不足致超氧化物歧化酶等酶类的合成减少及活性降低时氧化剂对肺组织的损伤，从而延缓哮喘病程的进展；研究还认为，健运脾胃方药能够调整以副交感神经功能亢进为主的植物神经功能紊乱，影响腺体分泌，舒张支气管，减轻和改善呼吸道症状，提高下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴的功能，增加皮质激素分泌，降低组织胺等对血管的通透性，提高淋巴细胞增殖及网状内皮系统和肺泡巨噬细胞的吞噬功能，增加免疫球蛋白，提高机体应激能力，增强机体防御、免疫能力。故健运脾胃之法，在支气管哮喘的治疗中无疑具有积极的现实意义。

③健运脾胃法贯于始终：曹氏通过多年对支气管哮喘的临床研究，认为本病应从三期分治，即应按急性发作期、病情迁延期和哮喘缓解期的不同病理特点进行辨治，提出以虚实寒热为纲、病变三期为目，以健运脾胃为本，祛风化痰为标的论治总则，匠心独具，疗效确切。

急性发作期以祛风化痰为主：曹氏认为，本病急性发作期多以风动挛急、痰气交阻为其主要病理特点。对阳盛体质，或病情久发郁而化热的患者，则可表现伏风痰热之证；而对女性患者，或痰浊积久不化的病人，尤可见到风痰夹瘀的机转。因此，该期治疗总以祛风化痰、止痉平喘为主，或佐以清肺，或辅以化瘀。然善治痰者，当治生痰之源，故临床不论运用何种化痰措施，都不应忽视健脾助运以堵生痰之源。《金匱要略》有“病痰饮者，当以温药和之”之训，推崇“哮喘夙根专主于痰”的朱丹溪亦谓：“实

脾土，燥脾湿，是治痰之本。”故本病急性发作，曹氏常选苍术、白术健脾燥湿，以堵生痰之源；择枳壳、郁金、苏子、海蛤壳理气宽胸、降气化痰；用麻黄、蝉蜕、防风、乌梅以祛风宣肺抗敏；选射干、葶苈子、地龙利咽泻肺，解痉平喘。诸药共同组成基本方，具有祛风抗敏平喘、健脾调气化痰之功。临床具体运用时还可随病情变化，灵活变通化裁。如痰热明显，可加桑白皮、黄芩，或一枝黄花以加强清化痰热之力；若痰浊痹阻胸阳，则合瓜蒌薤白半夏汤，以加强通阳泄浊之功；若风痰夹瘀，则加川芎、丹参、桃仁之辈，以增活血化瘀之力。

病情迁延期当健脾化痰同施：曹氏认为，该期多为脾虚与痰蕴之虚实兼夹证，故应以健脾化痰并举之法治疗。临床若表现脾虚夹滞，见哮喘喘逆，痰多色白，脘腹胀满，纳少等症者，常以异功散加平喘化痰药；若表现脾虚湿盛，见哮喘痰喘，痰白较稀，便溏，肢肿等症，常用参苓白术散加减；若脾虚及阳、痰饮内停，表现哮喘痰鸣，咳痰稀白如泡沫，畏寒怕冷，舌质淡者，则可选用理中汤、三子养亲汤加细辛辈，健脾助运，温化寒痰；若脾虚肺经有热，表现哮喘痰白粘或黄，口干而饮不多，舌质淡，苔淡黄腻者，则应选用二术二陈汤加泻白散、千金苇茎汤化裁以健脾化痰，清肃肺气。健脾助运以治本，化痰祛邪以治标，法随证变，法中有法。

哮喘缓解期之治重在补益脾气：曹氏认为该期主要以巩固疗效预防复发为目的，故以补虚治本为要。由于肺为娇脏，不耐邪侵，极易感邪发病。因有“胃为卫之源”、“四季脾旺不受邪”之说，故保持脾气健旺，可使机体正气强盛，肺气充实，以抵御外邪侵袭。脾胃为气血生化之源，故曹氏主张以健运脾胃为先，补益脾气，上可荫肺，下可

制水。现代研究证实，补脾益气方药，确能提高机体免疫功能，增强新陈代谢。此外，缓解期补脾，对于刚从急性发作期治疗而来的哮喘者，还有另一层含义。即急性期患者由于缺氧和应激常常导致胃肠道充血，使病人食欲不振，而且较多的病人使用过各类解痉平喘药或抗生素药，亦可影响脾胃功能。因此，此时运用性味平和的健运脾胃法有其特殊意义，远较滋腻补肾之法为优。具体用药，曹氏喜用玉屏风散和六君子汤加减，常用药如党参（气阴两虚时则用太子参）、黄芪、苍术、白术、山药、茯苓、生薏苡仁、法半夏、陈皮、杏仁、苏子、冬瓜仁、款冬花等，长期服用，可达健脾扶正、减少哮喘复发的目的。另外，曹氏据金土相生的理论，从健脾扶土着手，创制的“百合苡仁莲子羹”用于哮喘、慢阻肺缓解期的防治，系药食合一，方便实用，疗效显著，颇受病人欢迎。

如治陈某，男，29岁，工人，1997年9月初诊。主诉哮喘咳嗽反复发作近10年，再发并加重10余天。诊见：近10天来喘息咳嗽，夜间为甚，痰多色白，喉间鸣响，胸闷，纳差，口干，大便欠实，舌苔薄腻，脉细弦。两肺闻及散在性哮鸣音。曹氏诊为风痰伏肺，肺失宣肃，治拟祛风健脾化痰法。处方：苍术10g，白术10g，射干10g，枳壳10g，杏仁10g，郁金10g，蝉蜕10g，葶苈子15g，海蛤壳15g，连皮茯苓20g，地龙12g，麻黄6g，乌梅6g。药服7剂，哮喘即得控制。二诊时诉：易于感冒，胸胁稍闷，时有咯痰，舌苔薄白，脉细，两肺偶闻哮鸣音。转予健脾助运化痰肃肺治其本，药用太子参12g，苍术10g，白术10g，炙黄芪15g，山药12g，防风6g，蝉蜕6g，炙麻黄6g，杏仁10g，枳壳10g，海蛤壳15g，郁金10g，瓜蒌皮12g等，服药5个月余，随访未再发作。^[18]

13. 崔玉衡诊治经验

崔氏致力于支气管哮喘的临床研究，对哮喘病采取三步治疗法，取得较好疗效。

①缓急平哮法：哮喘病发病急骤，以喉中哮鸣有声，呼吸困难，胸闷气憋，甚则张口抬肩，不能平卧为特征。当务之急是缓急平哮，控制哮喘发作。最常用的药是氨茶碱、舒喘灵、喘息定等一些缓解支气管平滑肌痉挛的药物。但有些病人长期服用，对这些药物的敏感性就会降低，因而来寻求中药治疗。为能迅速解痉平喘，崔氏拟定缓急平哮法，并用辛温有毒的洋金花作为主药，制成平哮灵胶囊，药物组成：洋金花 0.3g，地龙 5g，椒目 3g（1 日量）。共研细面，装胶囊，在哮喘急发期服用，每次 4~6 粒，每日 2~3 次，孕妇及青光眼患者忌服。药中洋金花辛温有毒，有较强的解痉平喘止咳作用；椒目辛温，地龙咸寒，二药均能平喘利水，且寒热互制互用，共用协助洋金花而达即刻平喘之效。大多数患者在服药 60 分钟内闷喘得以缓解，给下一步中药辨证治疗赢得了时间。

②标本兼治法：平哮灵胶囊为治标之药，为使哮喘从根本上缓解，还须根据患者病情辨证分型，标本兼治。崔氏认为，哮喘发作时，支气管粘膜充血水肿，粘液腺分泌增加，所以痰液增多，是由内外病邪引起哮喘而后产生痰液。痰是哮喘之标，内外寒热之邪侵袭是该病之本。因此治疗时须按疾病性质，选用有针对性的药物进行治疗。此即第二法，标本兼治法。

小青龙汤治寒哮，重用细辛有卓效：寒哮以呼吸急促，喉中痰鸣，痰液稀薄，口不渴或渴喜热饮、畏寒流涕、苔薄白、脉浮紧为特征。崔氏以小青龙汤为主方：炙麻黄 6~

9g, 炒杏仁 13g, 半夏 12g, 干姜 6g, 细辛 6~9g, 五味子 6g, 桂枝 6g, 茯苓 15g, 徐长卿 15g, 葶苈子 20~30g, 炙甘草 6g。崔氏治寒哮, 细辛用量超过常规 1~2 倍, 疗效颇佳。常谓“细辛不过钱”, 是指单服细辛末而言, 煎服即无此虞, 可以大胆使用。

麻杏石甘汤加味, 治疗热哮功甚伟: 热哮以呼吸急促, 胸膈满闷, 痰黄粘稠, 口渴喜饮, 舌红, 苔黄, 脉浮数为辨证要点。崔氏以麻杏石甘汤加味: 炙麻黄 6g, 炒杏仁 13g, 生石膏 30g, 桑白皮 15g, 地龙 13g, 黄芩 15g, 鱼腥草 30g, 射干 12g, 徐长卿 15g, 僵蚕 13g, 蝉蜕 9g, 甘草 6g。麻黄一味是治喘要药, 寒热之喘皆可应用。崔氏治热哮必配石膏, 以制麻黄燥热之性, 二者用量之比是 1:3 至 1:5。

哮喘持续不解, 佐用虫药来驱邪: 有的患者哮喘发作后, 持续数日不缓解, 有的症状虽减, 但呼吸仍感不利, 崔氏称此为持续期。治疗时于宣肺开闭方中佐以虫类药物搜风驱邪, 解痉脱敏。常用自拟验方“平哮汤”治疗。药物组成: 炙麻黄 6~9g, 炒杏仁 13g, 桑白皮 20g, 地龙 13g, 蝉蜕 6g, 蜈蚣 2 条, 当归 12g, 石韦 20g, 细辛 5g, 徐长卿 20g, 甘草 6g。偏热者加生石膏 30g, 鱼腥草 30g, 僵蚕 13g; 咳剧加白前 10g, 款冬花 15g, 紫菀 15g, 气虚加太子参 15g, 白果仁 15g。哮喘患者大都有过敏史, 徐长卿、蝉蜕有较强的解痉脱敏作用。石韦镇咳祛痰, 平喘利水, 对哮喘单味大量应用即有良效。蜈蚣熄风解痉, 通络散结, 协当归之活血, 能改善肺及气管的血液循环, 改善气管通气量, 达到治喘平哮的目的。

③扶正固本法: 哮喘缠绵难愈, 屡屡发作, 一则在其有“宿根”, 不易治愈; 另一方面在于治疗不彻底。哮喘反

复发作，正气必虚，但哮喘患者往往在病情缓解后便不再继续治疗，因此稍遇外邪即诱发病。崔氏认为，症状缓解，应当坚持培本扶正防复发。常用自拟验方“益气固肾汤”。药物组成：黄芪 15g，白术 10g，防风 6g，熟地 20g，菟丝子 15g，太子参 15g，五味子 6g，地龙 13g，徐长卿 20g，白果仁 15g，蜈蚣 1 条，甘草 6g。水煎服，隔日 1 剂，亦可做水丸或片剂，每次 6g，每日 3 次。本方把补肾益气与解痉脱敏结合起来，在哮喘缓解后服用半年以上，可使哮喘发作次数逐渐减少，发作时症状逐渐减轻，最后达到治愈的目的。

三步方法治哮喘，是崔氏在借鉴前人经验的基础上结合自己多年临床实践制定而成。三步方法既可单独使用，又相互联系。如缓急解痉法的平哮灵胶囊，病人就诊时一经明确诊断，当时就让病人服用 4~6 粒，并留观 1 小时，留观期间，每 20 分钟听诊 1 次患者肺部哮鸣音变化情况，最快的服药 20 分钟哮鸣音就可减少一半以上，闷喘随之减轻。同时根据脉舌症状辨明寒哮热哮，给予标本兼治之方药，直至哮喘完全缓解，再改用第三法扶正固本。在培补期间，哮喘复发者，仍须应用第一、二法。^[19]

14. 曾庆骅诊治经验

不论内因或外因所致之哮喘，其病机都是气机的升降出纳失常，使肺气失宣、失降、失纳所致。因此，对于哮喘的治疗，曾氏认为关键在于理顺气机，而理顺气机的要点，可总括为“宣、降、纳”三法。因为肺气以宣为用，以降为顺，以纳为益（受纳于肾）。

①宣法：宣法，即宣畅肺气法。肺气以宣畅、布达为用。肺气只有宣达、顺畅，才能有效地吸清呼浊，维持生

命之需要。若肺内夙有隐伏之痰饮，复感外邪，或饮食不慎、情志所伤，引动伏痰，则使肺气失宣，发为哮喘。其治则当用宣法，以宣通肺气。临床上根据病因不同，宣法又具体分为“温宣法”、“清宣法”和“祛宣法”。即冷哮者，温宣以通；热哮者，清宣以通；浊哮者，祛宣以通。

温宣法：是用性味辛温之方药，以温散束肺之寒邪，分解互结之寒痰，从而宣畅肺气，以收止喘平哮之功。此法用于冷哮证，症见：哮喘因感受风寒，或进食生冷之物而诱发，哮喘急迫，胸闷气促，形寒肢冷，面青唇紫，痰白而粘，舌苔白腻，脉弦滑，喉间有水鸡声，肺部有哮鸣音等。曾氏常用射干麻黄汤合小青龙汤加减。药如射干、麻黄、细辛、法半夏、桂枝、生姜、五味子、甘草等。曾氏谓麻、细、姜、桂都是辛温散寒宣肺之药，尤以细辛辛温走窜，善通关窍为开通气道之先锋；麻黄辛苦温，上宣肺气，下降逆气，既开鬼门，又洁净府，是宣肺平喘之主将。生姜、半夏善化寒痰，射干、桂枝寒温并用，善利咽通滞，少佐五味子收敛肺气以防宣散太过而伤肺气，甘草调和诸药而本身亦善平喘。如此则寒散痰化而气道通畅，哮喘自平。

清宣法：是用寒凉性质的方药，来清热化痰，宣通肺气，从而达到止哮平喘的一种治法。它适用于痰热交阻，壅塞气道的热哮证。症见：哮喘声高息涌，胸胀气粗，膨膨然若气不能容，张口抬肩，倚息难卧，以呼出为快，或兼发热，口干，汗多，舌红，苔黄，脉滑数。听之喉间痰鸣如拽锯，肺部有哮鸣音，甚至于湿性啰音（多系合并感染）。曾氏常用自订的清宣平哮汤，即麻杏甘石汤加葶苈子、马兜铃、桑白皮、鲜竹沥等药。曾氏认为麻杏甘石汤辛凉宣泄，清肺定喘为主体，辅以葶苈子、马兜铃苦寒降

气、桑白皮、竹沥甘寒润肺，合用之，使肺热得以清泄，痰热能够化解，两邪既除，气道自通，哮喘焉作？

祛宣法：是用祛逐风邪法（包括烟尘、浊气，及某些过敏性性病邪），曾氏认为，过敏性哮喘，其来迅速，其去也疾，符合风邪的“善行而数变”之特点，因而将过敏源病邪归属于风邪一类较妥。祛宣平哮法用于风邪偏胜的哮喘，症见：哮喘突然发作，胸闷气逼，喉痒，呛咳，痰少或无痰，舌苔净，脉浮滑。曾氏常用祛风汤（自制验方）：防风 10g，荆芥 10g，白芷 6g，细辛 3g，地龙 10g，蝉蜕 6g，木蝴蝶 5g，薄荷 6g，苍耳子 10g，甘草 10g。曾氏认为，风性轻扬，善客上焦，故用药宜“轻”，不仅药量宜轻，而且药质宜轻，如荆、防、辛、蝉蜕、木蝴蝶等。还要药性轻扬，宣泄上焦，才能起到祛风止哮之功，此所谓“上焦如羽，非轻不举”矣。

②降法：降法，即通降肺气法。肺主肃降，肺气以清肃下降为顺，以壅塞上涌为逆。肺气的壅塞多因痰饮内伏窠白，复感外邪引动，故而痰气交阻，闭拒气道，发为哮喘。因此，治疗哮喘常用降气法。

理气降逆法：多以涤痰、宽胸、下气药物组方，治疗以痰气交阻为甚的哮喘。症见：哮喘发作，声高息涌，喉间痰鸣如拽锯，胸闷气粗，痰涎壅盛，或见恶心呕吐痰涎，舌苔厚腻，脉滑或弦滑。曾氏常用苏子降气汤合三子养亲汤：苏子、白芥子、莱菔子、橘红、半夏、当归、前胡、厚朴、生姜、桂枝、沉香、甘草。本方以三子、橘红、半夏、前胡除痰实为主药，其中莱菔子、橘红、厚朴、沉香宽胸下气为辅，当归、桂枝、生姜、甘草能通利血脉，因肺朝百脉，百脉通则有利于肺气降。全方既能除痰降气，又能通利血脉，气道乃通，哮喘可宁。

釜底抽薪法：曾氏认为，肺与大肠相表里，若肺气不降，则大便难通；反之，若大便不通（大肠腑气不通），则肺气难降，两者都可诱发或加重哮喘。一般多见于肺热痰结型哮喘，或已发哮喘而兼见大肠热结者。症见：哮喘发作，哮喘响亮，胸闷腹胀，大便秘结，数日不通，或兼见额头大汗，口干渴，舌暗红，苔黄厚，脉滑数。曾氏常用宣白承气汤加味，以清肺降气，泄痰通下。药如生大黄、生石膏、杏仁、瓜蒌、桑白皮、枳实、厚朴、莱菔子。便秘甚者加芒硝。若病情紧急，不便煎汤药者，也可单用生大黄粉一味3~5g吞服，每日2~3次，亦有效果。

③纳法：曾氏认为，肺气以呼、吸相合，宣、纳互济为治。若肺气只呼不吸，或只吸不呼，则肺气将绝矣。若宣多纳少，则肺气耗散无根，而形成虚喘。若纳多宣少，则肺气壅塞而成实喘。是故肺气的升降出纳与哮喘之成因关系密切。纳气法多用于单喘无哮者，多见于慢性哮喘的间歇期，不哮单喘，动辄气喘吁吁，呼吸短促者。临床上根据证候不同，而有补肾纳气法与镇纳浮阳法两种。

补肾纳气法：用于肺肾两虚之虚喘证，症见：呼吸短浅，急促似喘，易出汗，活动更甚，常伴头晕耳鸣，腰酸腿软，夜尿多，尺脉弱。曾氏喜用人参蛤蚧散加减，偏肺气虚，汗多易感冒咳嗽者，加玉屏风散、五味子、紫菀；偏肾气虚，阳虚怕冷、腰腿酸软、阳痿、夜尿多者，加胡桃肉、仙灵脾、肉苁蓉、鹅管石等；偏阴虚，五心烦热、盗汗、口干不饮、形瘦、脉细数者，加熟地、麦冬、五味子，或改用麦味地黄汤。

镇纳浮阳法：用于哮喘多年，正气极虚，元气耗散者。症见：喘促急迫，呼吸短浅，汗出肢冷，面色红或苍白，

惶惶然若气欲断，脉微细或浮散无根。选用参茸黑锡丹吞服，或参附龙牡汤。曾氏认为，此证多属现代医学中的呼吸循环衰竭，若中药一时不能应急，可加用西药呼吸兴奋剂如可拉明、洛贝林或给氧等，以助急则治其标。待危急状态缓解后，再用中药扶正固本，以善其后。

兹举曾氏所治病例如下以佐证。

釜底抽薪止哮喘案：邹某，男，15岁，1981年3月9日初诊。哮喘发作10多年加剧5天入院。缘于3岁开始患哮喘，喉间痰鸣漉漉，张口抬肩，面唇青紫。每于冬春季节受凉辄发，久经中西医药治疗不愈，逐年加重。本次复发后服氨茶碱及用哮喘喷雾剂喷射等均无效，故来住院。入院时查体见发育不良，形体瘦小而矮，口唇紫绀，胸廓变形，胸前隆起呈鸡胸状。听诊两肺满布哮鸣音，心率162次/分，律齐。舌质暗红、苔黄厚腻，脉弦滑数。辨证为痰热壅肺，肺失肃降。先用中药清肺化痰，降气平喘治疗几天无效，加用氨茶碱静脉推注，可获短暂缓解。后因大便秘结1周，哮喘明显加剧，发作时跪于床上，呼吸急促，胸胀气粗，张口抬肩，哮喘声如拽锯，面色铁青，汗出肢冷，再注射氨茶碱无效，后从肺与大肠相表里考虑，故用釜底抽薪法，急以大黄粉5g吞服，每日3次，结果服药仅2次后，于当晚腹胀肠鸣，腹痛泄泻，泻下大量黑色鼻涕样大便，随即哮喘缓解。再调理脾胃半月而好转出院。

温宣止哮喘案：张某，男，58岁，1988年3月4日初诊。患者夙有哮喘，经常复发。此次因贪吃冷红烧肉，致使当晚哮喘大发作，胸闷气喘，端坐呼吸，张口抬肩，声高息涌，面青肢冷。先自用舒喘膜和频频喷射哮喘气雾剂无效。当时查心率114次/分，律齐，两肺满布哮鸣音，口

唇发绀，舌质紫暗，苔白腻，脉细弦滑。先用氨茶碱加地塞米松静滴无效，再用肾上腺素及酮替芬等西药均不能缓解。后采用艾灸肺俞穴、定喘穴，哮喘减轻，继用小青龙汤加減（麻黄10g，桂枝10g，细辛3g，生姜3片，法半夏15g，射干10g，五味子3g，甘草6g）治疗1周，哮喘完全缓解，症状、体征消失。

补肾纳气平喘案：袁某，61岁。哮喘多年，近因喘促加剧而住院治疗，病情好转，肺部啰音消失，哮鸣音尚存。为防哮喘复发，特请中医会诊以扶正固本治疗。诊见：患者动则气喘吁吁，易出汗，易感冒，说话语音低而断断续续，形寒怕冷，四肢不温，纳可，大便平，夜尿3~4次，耳鸣，腰酸。舌淡胖嫩，苔薄白，脉细弦尺弱。治以肺肾两补，纳肾平喘。处方：红参30g，蛤蚧1对，胡桃肉50g，黄芪60g，五味子20g，仙灵脾30g，山茱萸50g，川贝母30g，炙甘草30g。上方1剂为末，炼蜜为丸，每次3g，每日2次。1年后哮喘未再复发，而且精神很好，走路不喘气，感冒也很少发生，即使偶然患感冒，症状也轻，未出现哮喘。^[20]

15. 洪广祥诊治经验

洪氏擅长治疗肺系疾患，尤精于治疗哮喘，对于预防哮喘复发，有丰富的经验和独到的见解。在继承前人“发则治肺，缓则治肾”的传统经验基础上，提出独具特色的预防哮喘复发4法。

①祛除“夙根”：洪氏认为“痰瘀伏肺”是哮喘反复发作的“夙根”，因此，涤痰化瘀同治以断“夙根”，实乃是预防哮喘复发的关键。“夙根”未除，随时感邪而复发。因为哮喘缓解期气道中的顽痰、老痰并未彻底清除，这些

“痰栓”在一定条件下仍阻塞气道，引起血瘀。且缓解期仍可见患者唇暗，舌下静脉延伸增粗，舌紫暗，苔黄腻，足以说明痰瘀仍存在。此时，洪氏仍坚持辨证论治的原则下继续用经验方“蠲哮汤”以清除痰瘀夙根。达到涤痰祛瘀、调畅气机预防复发的目的。该方由葶苈子 15~20g、牡荆子 15g、青皮 15g、陈皮 15g、槟榔 10g、卫矛 10g、生大黄（后下）10g、生姜 3 片等组成。胶痰粘着难咯出者加礞石 20g，海蛤壳 20g，瓜蒌 20g；瘀证明显者加红花 6~10g，桃仁 10g，川芎 10g，水蛭胶囊 6 个（每次服 2 至 3 个，每日 2 次）。

②预防外感：哮喘缓解期不少患者仍有怯寒背冷、极易患感冒等阳气不足之症。洪氏认为这与肺阳不足、腠理疏松、卫气不固、抗邪能力低下有关。故采取温阳护卫，以提高机体御邪能力，控制感冒，达到预防的目的。洪氏创制的“温阳护卫汤”，用于缓解期肺卫阳虚突出者。该方由黄芪 20~30g、制附子 10g、路路通 20g、防风 15g、桂枝 10g、白芍 10g、卫矛 15g、炙甘草 6g、生姜 3 片、大枣 6 枚组成。方中黄芪益气固表，附子温补肾阳。以卫阳根于肾阳之故。桂枝汤调和营卫，攻补兼施，标本同治，既可发散风寒，又可顾护脾胃，扶正固本。路路通、防风、卫矛，意在祛风脱敏，御风抗敏。该方共奏温阳护卫、调和营卫，增强机体抗御外邪之效，以期实表安内，扶正固本，控制复发。

经临床观察，凡患者坚持用药 2 个月后，大多数发作间歇期明显延长，发作程度显著减轻，发作次数减少，或可控制哮喘复发。说明本方确有预防哮喘复发的作用，且服用时间越长可明显提高固本疗效。

③固本补虚：洪氏赞赏前人药疗和食疗的经验，以及

“药补不如食补”之说，并具体运用到哮喘预防上，以提高固本作用。洪氏认为，固本以健脾补肾为主，脾旺则四季不受邪，又能杜绝其生痰之虞，常用药为：黄芪 20~30g，太子参 20g，防风 10g，山药 20g，薏苡仁 20g，茯苓 20g，法半夏 10g，陈皮 10g，炙甘草 6g。偏于肾阳虚者，宜温补肾阳。常用药为：制附子 10g，肉桂 3g（冲服），熟地 15g，山茱萸 15g，山药 20g，紫河车 10g，鹿胶 10g（烊兑），枸杞 15g，巴戟天 10g，仙灵脾 10g，仙茅 10g，菟丝子 15g。偏于肾阴虚者，宜滋肾纳气。常用药为：熟地 15g，山药 20g，山茱萸 15g，麦冬 20g，五味子 6g，龟胶 10g（烊兑），黄芪 20g，紫河车 10g，沉香 5g，黄精 15g。洪氏食疗以固本蛋为主。制法：备瓦罐或瓷盆 1 个，留置健康儿童或患者的 24 小时尿液，取新鲜蛋 7~10 个，先在蛋壳上按序编号，将蛋略破壳但不能破膜，然后将蛋浸入盛有尿液的容器内，尿液应高出鸡蛋面 1.5 厘米左右，每天换新鲜尿液 1 次，连浸 3~5 天（夏季 3 天，冬季 5 天）即可食用。每天早晨按编号顺序，依次取出固本蛋 1~2 个，洗净连壳煮熟，然后去壳空腹服用。每次取出鸡蛋后，应及时补充，并与原序号的尾数相连接，1 个月为 1 个疗程，连食用 3 个疗程。用于哮喘缓解期，预防复发。食蛋期间如遇哮喘发作，可同时配合辨证用药治疗，不需停服固本蛋。平时对鸡蛋过敏者忌服。固本蛋是一种寓医于食的方法。《本草纲目》谓“卵白，其色清，其性微寒；卵黄，其色浑，其性温；卵则兼黄白而用之，其性平。精不足者，补之以气，故卵白能清气……形不足者，补之以味，故卵黄能补血……卵则兼理气血”。人尿，《本草思辨录》云：“人尿咸寒入血，又兼走气，益阴清热消瘀，而不能利水，故于益阴清热消瘀，愈显其用”。又《重庆堂随笔》说“童子

小便，最是滋阴降火之妙品，故为血证要药”。近代研究人尿中含有血管舒缓素尿激酶、激素等多种生物活性物质，尿泡鸡蛋之法虽源自民间，其实是一种极科学的生物萃取法，使尿中的多种生物活性物质萃取于蛋中，而发挥其预防效应。洪氏应用固本蛋预防小儿哮喘复发，取得良好效果。

④宣利肺窍：多数哮喘患者伴有鼻腔疾患，它不仅是哮喘发病的诱因之一，同时也是影响疗效的不可忽视之因素。洪氏认为注意治疗鼻腔疾患，常可提高预防哮喘复发的效果。宣通鼻窍法主要用于合并鼻腔疾患的患者。如过敏性鼻炎，治以祛风通窍，常用药为：苍耳子 15g，辛夷花 10g，防风 15g，路路通 20~30g，蝉蜕 6~10g，刺蒺藜 10g，白芷 10g，细辛 3g。若鼻甲肥厚瘀血明显者加用活血化瘀之红花 10g，桃仁 10g，川芎 10g；若以肺或痰热证候突出者，常选用生麻黄 10g，南杏仁 10g，生石膏 30g，生甘草 6g，苍耳子 15g，辛夷花 10g，黄芩 10g，鱼腥草 20g，蒲公英 20g 等。

如治舒某某，女，19 岁。哮喘反复发作 3 年，多因受寒加重，久治不愈。1991 年 2 月就诊时正值发作期，痰鸣喘促，不能平卧。经洪氏温肺散寒、涤痰祛瘀治疗，哮喘进入缓解期。洪氏抓住缓解期肺卫阳虚的病机，应用温阳护卫汤加减：黄芪 20g，熟附子 10g，桂枝 10g，白芍 10g，炙甘草 6g，生姜 10g，大枣 5 枚，路路通 20g，防风 10g，水蛭胶囊 6 个。经坚持服用 4 个月，患者感冒基本控制，哮喘半年未发。

哮喘是常见而又棘手的病症，洪氏独具慧眼，抓住痰、瘀、虚以及兼鼻腔疾患之病机特点，圆机活法，总结了综合预防哮喘复发的经验，堪称杏林医苑一奇葩！^[21]

16. 刘方英诊治经验

刘氏行医数十余年，临证治喘颇具匠心，今择要整理其治喘经验如下。

①正邪消长祛邪务当扶正：中医理论认为疾病发展的过程就是正邪斗争，互为消长的过程，邪胜于正则病进，正胜于邪则病退。因此，治疗疾病就是要扶助正气，祛除邪气，以改变邪正双方力量之对比，使之有利于疾病向痊愈方向转化。刘氏认为哮喘一症乃沉痼之病，缠绵反复，正气已虚，发作时又多表现为虚实夹杂之候，所以治疗不可拘泥于“凡喘未发，以扶正为主，已发以散邪为主”之说，应注意培补正气，扶正以祛邪。临床上确实有许多患者虽用了宣肺化痰平喘之剂，而疗效不佳，究其原因，就在于忽视了扶正。因此，刘氏非常强调哮喘无论是初起还是病久，均当兼顾扶助正气，从肺、脾、肾三脏着手。

临证对初患哮喘者常用三拗汤配以补益肺、脾、肾之品，常用黄芪、玄参补气养阴，扶正以助祛邪；白术、茯苓健脾和胃，使中焦健运，生化有源，土运金固；细辛温肾平喘，量必重用，一般多用至5g，而不因其喘病初发而纯用宣肺平喘之品。哮喘既久，正气亏耗，气阴两虚，扶正培本更为重要，当此之时，除重用补益气血之品外，还应慎用辛燥之品，以防耗气伤阴。刘氏多重用黄芪、玄参、白术、茯苓、百合、五味子之品，不用或少用宣肺清热平喘之品，体现了其“喘之所治，重在治本”的学术思想。

②痰瘀相关祛痰务当化瘀：刘氏非常推崇“痰瘀相关”之说，认为痰与瘀虽然是两种不同的病理产物和致病因素，其病理变化和致病各异，但两者同源，往往相因而生，相兼为病，相互影响。因为痰源乎津，瘀本乎血，而津血同

源，故而痰瘀同源。如痰积日久，肺之宣降功能受累，不但呼吸功能减弱，而且会影响宗气之生成，宗气不足，血运无力，则凝滞为瘀；反之，血液运行不畅，气机失顺，又会影响肺之宣降，肺失宣降，水津不能通调输布，则聚而成痰，故言“痰瘀相关”。临床见许多喘证病人伴有痰多时，都往往兼有唇甲发绀，舌紫暗等瘀血之象。对此类患者单纯治痰平喘，收效不大，而佐一两味活血化瘀之品，不但瘀象好转，而且咯痰骤减，喘息渐平，说明了“痰阻则血难行，血瘀则痰难化”之理。因此，必须痰瘀同治，避免见痰治痰，见瘀治瘀之弊。刘氏临证治喘时，常加用川芎、地龙、桃仁、当归四味活血化瘀之品，认为川芎为血中之气药，走而不守，是瘀证之良药；地龙下行降泄，非但能清热通络，且能平喘利尿，有舒张支气管之功，故能解痉而平喘，两味药为痰瘀同治，解痉平喘必备之品；桃仁质润入血分，为破瘀行血常用之品，每于新病体质实者用之；当归既能补血，又能活血，为血证之良药，每于久病体虚者用之。药简意赅，痰瘀同治，足见其治喘用药之妙。

③肺肠相关治喘必当通便：中医理论认为肺与大肠相表里，一阴一阳，肺主宣发肃降，大肠主传导排泄，肺气肃降则大肠传导如常，反之大肠传导不利，则肺失肃降。故刘氏治喘时，主张务使大便通畅，使腑气通而肺气降。临床常喜用润肠通便之法，治喘方中，每含有润肠丸之意，以火麻仁润燥滑肠通便，生地黄滋阴滑肠，配伍既能宣肺除痰平喘，又能润燥下气通便之杏仁，以及既能养血活血，又能润肠通便之当归、桃仁。治喘方中不重在乎喘，而重在祛痰化瘀润肠，体现了其“治病必求于本”的精神。

④神气相随治喘亦当安神：刘氏非常重视精神因素在

喘证中的作用，认为精神因素与人体脏腑功能关系密切，不良的精神因素能影响人体的生理功能，使气机升降失常，气血运行紊乱，如“怒则气上”、“惊则气乱”等等。反之，良好的精神因素又能改善脏腑的功能状态，有利于疾病的治愈。因此在临证治喘时，强调对精神因素的调节，常以性善宣泄之远志养心安神，定志以平喘；以柴胡调达肝气，疏理气机，使脾气条达，疏泄有常，如此则神定气顺，喘证自平。此外除用药上注意调节精神因素外，还常常在精神上给病人以安慰，注重心理治疗。

⑤痰热饮寒祛痰宜清宜润：刘氏力主“痰热而饮寒”之说，认为痰为热邪炼液而成，饮为寒邪聚湿所就。非常推崇李中梓“痰即有形之火，火即无形之痰”之说，因此，在用药上主张宜清肺、润肺而化痰，临床常以善于润肺化痰、清泄胸中郁结之气火的川贝母，配伍长于泄肺火，清大肠之热的黄芩，或喜用善于清解上焦热邪的连翘，以共奏清肺润肺化痰之效。

⑥同病异治用药因时因人而异：人生活在自然界中，其生理病理无不受自然环境的影响，自然界的一切变化都可直接或间接地影响人体，故虽同为喘证，但由于四时气候变化的不同，其表现也各异。因此在诊治喘证时，要掌握季节和气候变化对人体影响的特点，而酌情用药，做到“必先岁气，无伐天和”，因时制宜。刘氏常谓喘证日久，多阴阳俱虚，秋冬季节，气候由凉转寒，阴盛阳衰。人体腠理致密，阳气敛藏于内，致使喘证病人，阳气愈虚，不能卫外为固，而风寒之邪乘虚侵入而致喘证加重。故当此之时，应慎用苦寒之品，以免伤阳，应重用附子、桂枝、半夏、紫菀、款冬花等温阳平喘之品。春夏季节，气候由温转热，阳盛阴衰，阴液愈耗，此时应慎用辛热之品，以

防助热伤阴，应重用玄参、麦冬、五味子、黄芩、连翘之品。此其因时制宜之谓。

因人制宜是刘氏临证治喘用药的又一特点。刘氏常说人之先天禀赋和后天调养各异，故而人的体质也各有其特点。临证要善于抓住其体质强弱的特点，而酌情用药。在治疗老年喘证患者时，刘氏常考虑老年人五脏精气衰减，脏腑功能低下，机体适应能力和抵抗能力均降低，因此在用药上多偏重温补，如黄芪、玄参、白术、茯苓、生地、白及、百合之属。^[22]

17. 周炳文诊治经验

虚喘之证范围广泛，但病变不出肺脾肾三脏，并成为老年性慢性支气管炎、肺气肿、肺心病之主症，即其他衰竭病人，亦无不以此为主要症。对其病变机理，前贤医家多着重于肺肾，故有“在肺为实，在肾为虚”的论点，而主张“益气定喘，补肾纳气”。至于培养中土，健运脾胃，往往忽略，影响效果的巩固，病体的恢复。脾为“生化之源”、“后天之本”。而喘证多起于久咳，咳之症，皆由痰浊壅肺，饮邪阻隔。痰饮乃脾失健运积湿所化，因而又有“脾为生痰之源”之说。治喘必先杜其有形之痰，始能理顺无形之气，痰清咳止，喘必自平。周氏根据这一思路，结合临床验证，经过多年总结，摸索规律，制订方剂，其中以理脾为主，兼顾心肾之“三脏养肺汤”颇具效验。方药组成：党参 15~30g，白术 9g，茯苓 10g，陈皮 5g，半夏 8g，炙甘草 6g，五味子 5g，麦冬 10g，当归 12g，熟地 15~20g。即以六君子汤健脾理中、利痰化饮为主，合生脉散益心养肺，贞元饮补肾纳气、填补元海，三方合成，取从心脾肾间接治肺之意故名。主治痰饮久咳成喘之肺脾心

肾俱伤者。苔腻纳呆加谷芽，气短似喘加枣皮，心悸浊痰难咯加远志，痰饮俱多、胸膈痞满加葶苈子，痰稠黄粘加贝母，面浮足肿加桑白皮、薏苡仁，一般主方不宜删减，药量增减须按比例。

如治李某某，男，74岁，1988年5月19日初诊。患者以慢支并感染、肺心病、主动脉瓣关闭不全、慢性肾炎肾功能不全入院1个月，疗效不显。诊见：咳甚痰喘，胸闷呕恶，通身水肿，小便日少夜多，每夜5~6次，大便溏泻，纳呆不食，头晕不能起坐，舌淡胖，苔粘腻，脉乱至数不清，整天吸氧仍呼吸迫促。为肺心肾俱衰之症，但关键在于中土衰败，脾失健运。升降之机失衡，无权驾驭上下所致。与“三脏养肺汤”颇为合拍，治疗过程中或加远志、薏苡仁、谷芽化痰渗湿醒脾健胃，或加黄芪、泽泻益气利尿，或加细辛、炮姜温肺行饮，或加大腹皮和中利气，或加枣皮补敛肝肾以纳气。连服1个月诸症基本控制，肿消喘平食增睡安，体力有所恢复。停中药2旬，因咽喉干燥微痛，舌赤，苔少而取拯阴理劳汤加减数剂即安，再与“三脏养肺汤”加枣皮、远志又连服38剂，疗效步步巩固，动作不喘，每日整衣草履外出游逛并无喘象，于10月25日出院。嘱携原方间或服3~5剂作预防，冀收远期疗效。^[23]

18. 杜昌华诊治经验

杜氏认为，由于本病具有本虚标实的特点，因此在急性发作期也常是虚实兼见、寒热并存、痰浊互结，三者可相互夹杂或转化。在治疗上，就需要标本虚实细分辨，发作时治标，缓解时治本，初病祛邪，病久扶正；虚实兼见者，补虚泻实兼顾之。不忘扶正祛邪，才能获得良效。杜

氏通过对 112 例的观察认为，可将本病分为风邪袭肺、痰壅气道和肺卫不固、脾肾不足两型。

风邪袭肺、痰壅气道的基本方：胆南星 6~9g，葶苈子 9~15g，秦皮 9g，竹茹 9g，陈皮 3~6g，半夏 6~9g，茯苓 9~12g，白术 9~12g，莱菔子 6~9g，枳壳 6~9g，僵蚕 6~9g。曾治彰某，女，1 岁，1984 年 6 月 8 日初诊。低热缠绵伴咳嗽 3 月。3 月前因高热、咳嗽、痰吼诊为哮喘，经用青霉素、链霉素等治疗，1 周后高热渐低，但低热缠绵，徘徊在 38.5℃ 左右，咳嗽、痰吼未见好转。平素纳呆、盗汗、便秘，3~4 天 1 次，两肺布满痰鸣音，舌红，苔薄黄腻。此为痰热壅肺，肺失肃降，以致肺气不通。治宜清热化痰，泻肺通膈。方以胆南星 9g，葶苈子（包）12g，秦皮 9g，竹茹 9g，桑白皮 9g，黄芩 12g，炙麻黄 5g，玉竹 9g，生决明子 30g，炒柴胡 6g，制半夏 9g，生石膏（先煎）30g，寒水石（先煎）15g，生甘草 3g，每日 1 剂，连服 4 天。服药 1 剂后，大便时排出大量泡沫样粘痰，痰吼大减，热退，盗汗也少。服药 4 剂后，咳嗽、痰吼消失，大便每日 1 次，两肺听诊清晰。

肺卫不固、脾肾不足型，多见于久病反复发作。基本方：黄芪 12g，防风 3g，白术 9g，桂枝 3~6g，白芍 9~12g，干姜 3g，大枣 9g，柴胡 6~9g，炙升麻 6g，仙灵脾 9g，枸杞子 9g，炙甘草 3g，党参 9g，补骨脂 3~6g。又治徐某，男，2 岁，1984 年 1 月 3 日初诊。痰声漉漉已有 2 月，每于晨起及白天为甚，迁延难愈。使用抗生素及止咳化痰药未见好转。寒温不适即患感冒，咳嗽、痰吼也随之加重，每月 2~3 次，缠绵难愈延年。平素纳呆、便溏，完谷不化，不喜玩耍，体重增加缓慢。舌淡红，苔薄腻，痰鸣音满布。诊为肺虚卫外不固，命火式微，火不生土，脾

虚失运，聚湿生痰，上贮于肺，肺脾肾三脏俱虚，复受外感：风邪夹痰，阻于气道。急则治标，先以祛风化痰，佐以健脾化湿之方。服药5剂后，咳痰消失，纳食已馨，外邪已去，再予调治肺、脾、肾三脏以扶正固本。加减调治1月，胃纳大增，精神振作，喜玩耍，2月后体重增加2500kg，面色红润，随访半年，未再感冒。^[24]

19. 屠揆先诊治经验

尽管哮喘发作时为实证，但应考虑到本病之所以反复发作和常用平喘化痰药物不能根治，必然有内脏功能虚衰的方面。也就是说，哮喘病人的共性是正虚。屠氏认为，凡哮喘病获得根治的，多是在缓解期持续用补虚方法取得成功的。因此“对该病应采取未发宜扶正，已发用攻邪”的治疗原则。

一般哮喘发作时，根据其脉证之寒、热，采用小青龙汤或麻杏石甘汤等，不难控制其发作。但亦有一些患者，由于病程较长，耐药性的产生，或发病时情绪的紧张，影响了肺肾对呼吸的调节功能，以致治疗困难，使哮喘持续而不解。如是者，屠氏常选用人参定喘汤（人参、麻黄、阿胶、半夏、麻黄、罂粟壳、甘草、桑白皮）。方中的人参、麻黄、罂粟壳不能减去一味，其中麻黄与罂粟壳等量。如属寒喘，去阿胶、桑白皮，加干姜、桂枝。如属热喘，加生石膏、苦杏仁。

亦有部分病人年老体弱，在哮喘严重时，可以发生危险。征象是头面、四肢冷汗淋漓，脉象转为细数无力或沉细，这时要提高警惕，须急投人参四逆汤（人参、干姜、甘草、附子）。特别要加重人参、甘草的用量，人参一日量可用30g。

缓解期治疗以补肺肾为主。二者谁为主，可按辨证而定。屠氏经验，在哮喘缓解期：补肺用生脉散方（党参、麦冬、五味子）。肺阴偏虚者，加沙参、百合、生甘草。肺气偏虚者，加黄芪、炙甘草。补肾用都气丸方为主（生地、丹皮、茯苓、泽泻、山药、山茱萸、五味子）。肾阴偏虚者加知母、黄柏。肾阳偏虚者，加补骨脂、仙灵脾、沉香。肾阳极虚者加肉桂、附子。如哮喘发作时伴有鼻塞、咽痒、耳痒或皮肤发疹者，须于方中加蝉蜕、僵蚕、防风。平时咳嗽痰多，加葶苈子、制南星、佛耳草。如痰化咳平，单用补肺、肾方即可。一般服补药须持续服半年以上，方能奏效。另外，有先天不足者，可服紫河车粉，每日3次，每次3g，开水送服。^[24]

20. 吴凡诊治经验

支气管哮喘属于中医喘证、哮证的范畴。为冬春二季的常见病、多发病。中医认为病位在肺。根据中医肺与大肠相表里的理论，吴氏在治疗支气管哮喘中，多采用平喘与通腑同治的方法，常可获得较好的疗效。

肺与大肠通过经络而构成表里关系，肺气肃降，则大肠传导如常，肺气上逆，肺失肃降，则大肠传导失常，腑气不通，大便停积难行。故用平喘与通腑同治的方法，使大便畅通，有益于上逆之气的下行。

吴氏曾遇一患慢性支气管哮喘多年的病人，近日起居不慎，宿疾又起，喘促多日，咯痰黄稠，咳吐不利，口浊喜饮，心烦腹满。观前医多投定喘汤、麻杏石甘汤之剂，服药后，气喘不减。细问病史：病人平素嗜烟酒，现大便已五日未行，舌红，苔黄，脉滑有力。循“急则治其标”的法则，遂用通腑泻热的大承气汤进服。次日，病人述：

服药后，自觉肠鸣漉漉，后泻下大便许多，便后全身清爽，气喘亦较前明显好转。后改用清热化痰平喘之剂，调理其后。真是不治气喘而喘自平。

支气管哮喘的病人，多为本虚标实，在喘作邪盛时，治疗上以祛邪利气为主。辨证施治的同时，可适当配伍大黄等通腑之品，往往可以取得事半功倍的效果。在精气亏虚时，用培补摄纳，也要注意腑气的通畅。此时，虽不宜选用苦寒峻烈之品，也可适当选用当归、肉苁蓉、熟地、郁李仁、白果仁、胡桃肉等品，使培补的同时，又保证了肠腑的润滑。使肠腑通畅，利于失主之气的回纳。

当归一味，辛温补血，润肠通便。又可用于“治虚劳寒热咳逆上气”。同时，《本草汇编》认为：“当归其味辛散，乃血中气药也，况咳逆上气，有阴虚阳无所附者，故用血药补阴，则血和而气降矣。”所以说，对于哮喘病人，尤其是久病体弱的哮喘病人，应当配伍使用当归，既可以温补、润肠，又可以使耗散上逆之气收敛肃降。^[24]

21. 张翰清诊治经验

①冷哮：素体阳虚，气不化津，痰饮内停，每因风寒外袭，入舍肺系，宿邪阻气阻痰发为冷哮。其症：恶寒无汗，头身疼痛，呼吸急促，喉中哮鸣，咯痰清稀多泡沫，胸膈满闷如窒，甚则唇青，不得平卧，口不渴，苔白滑，脉浮紧。多因风寒袭于肌表，皮毛开合失司，致肺气郁，以宣通肺气，化痰定喘为急。张氏首选华盖汤（麻黄、紫苏子、杏仁、生桑白皮、赤茯苓、橘红、甘草）。若内有停饮，外感寒邪诱发者，症见咳而上气，喉中如水鸡声，方用《金匱要略》射干麻黄汤（射干、麻黄、生姜、细辛、紫苑、款冬花、五味子、大枣、半夏）以散寒宣肺，降逆

化痰。喘逆不平，可合用三子养亲汤（苏子、莱菔子、白芥子）加强降气定喘作用。外寒已解，气机不畅而声急者，可用苏子降气汤（苏子、橘红、半夏、当归、前胡、厚朴、肉桂或沉香、甘草、生姜），气顺则哮喘自平。

如治患者，男，49岁，住院号：980。哮喘1年余，每次均因外感风寒诱发。本次发作2周末缓解，喘鸣，喉中如水鸡声，汗出，恶风，发紺，不得平卧，痰涎稀薄量多，两肺满布哮鸣音，诊为支气管哮喘急性发作。曾用青、链霉素及红霉素、庆大霉素、氨茶碱等，喘不能控制，加用激素后稍有缓解，但仍不能控制。经张氏会诊：脉弦滑右寸尤甚，舌质暗红，苔白滑，谓外寒已解，痰涎壅肺，肺失肃降，气机不畅，拟苏子降气汤化裁。药用清半夏10g，橘红10g，前胡10g，当归10g，厚朴10g，枳壳10g，杏仁10g，石韦10g，葶苈子12g，苏子12g，地龙15g，生桑白皮15g，甘草6g，白芥子6g，沉香1.5g（冲服）。服3剂，喘息渐轻，痰涎减少渐能平卧，继守方服1周，两肺哮鸣音消失，喘平出院。

②热哮：饮食不节，恣食肥甘，积湿生热，熏蒸于肺，或寒饮久郁化热，炼津为痰，痰热阻塞于肺，每因外感诱发。其症：呼吸急促，喉中痰鸣，咳呛阵作，痰浊稠黄不易咯，面赤自汗，烦闷不安，口渴喜饮，尿赤便秘，舌质红，苔黄腻，脉滑数。多因内有痰热，外为风寒所束，或寒郁化热。兼有恶风寒者，方用千金定喘汤（炙麻黄、白果、生桑白皮、款冬花、杏仁、苏子、黄芩、甘草、半夏、橘红）；肺胃蕴热，痰热内阻，为外感风热引发者，麻杏石甘汤加黄芩、瓜蒌、浙贝母、桑白皮之属；火郁作喘者，葶苈泻白散（葶苈子、生桑白皮、地骨皮、甘草、粳米）；痰浊壅肺而发者，千金苇茎汤合葶苈大枣泻肺汤（葶苈子、

大枣、薏苡仁、冬瓜子、桃仁、芦根)；内有痰热，风入肺经而作哮喘者，用费氏鹅梨汤（鹅管石、炙麻黄、瓜蒌仁、杏仁、川贝母、茯苓、橘红、竹沥、半夏、苏子、射干、梨汁、生姜汁）。

常用加减法：痰多稠黄加瓜蒌、天竺黄、胆南星、三蛇胆、陈皮末；痰浊胶结，不易咯出者加海浮石、黛蛤散、竹沥水；燥痰粘连，咳而不爽加北沙参、天冬、麦冬、枇杷叶；哮喘兼胸膈满闷者加枳壳、桔梗；哮喘兼痉咳者加地龙、石韦、钩藤、僵蚕；肺络瘀滞气失输布，唇口发绀者，加赤芍、桃仁、红花、丹皮、丹参、橘络等；兼有肺部感染加黄芩、栀子、金银花、连翘、鱼腥草、蚤休等。

如治患者，女，42岁，住院号：1775。自幼哮喘，后间断有不同程度的发作，近2年频发加重。本次因外感诱发，夜间突喘憋醒，喉中哮喘，不得平卧，形寒恶风，咳嗽阵作，痰色白粘，不易咯出，胸膈满闷，两肺满布哮喘音，舌质稍红，苔薄黄，脉左寸浮滑，诊为支气管哮喘。证系内蕴痰热，外为风寒所束，拟千金定喘汤加味。药用桑叶10g，黄芩10g，橘红10g，生桑白皮10g，款冬花10g，清半夏10g，苏子10g，海浮石10g，地龙10g，炒白果10g，瓜蒌皮10g，麻黄3g，甘草1.5g。服3剂喘大减，痰浊松动，渐能平卧。继服3剂，两肺哮喘音消失，喘平。

③久哮：肺主气为气之标，肾主气为气之本，脾湿胃浊为痰嗽之本。若脾阳不足，则痰湿内生，肾气亏损，则气失摄纳，故哮喘迁延日久，则见肺、脾、肾三脏虚候。其症，肺气虚则怯寒自汗，咳而无力，痰涎稀薄，稍遇风寒即易诱发哮喘；脾虚则兼见咳嗽痰多，胸脘痞闷，倦怠无力，食少便溏；肾气虚则动则喘甚，虚汗淋漓，唇口发绀，腰酸腿软，心悸肢冷，下肢浮肿。临床常见肺气虚、

肺脾肾三脏俱虚及肺心肾三脏俱虚之证。

肺气虚用钟乳补肺汤（人参、麦冬、五味子、款冬花、紫菀、桑白皮、桂枝、钟乳石、白石英、糯米、生姜、大枣）；肺脾两虚用六君子汤合苓桂术甘汤加味（党参、白术、茯苓、甘草、橘红、清半夏、桂枝、紫菀、款冬花、苏子、杏仁、川贝母）；肺肾阴虚用七味都气汤（熟地、山药、山茱萸、茯苓、泽泻、丹皮、五味子），送服人参蛤蚧散（人参、蛤蚧尾、生桑白皮、橘红、杏仁、茯苓、知母）；肺肾阳虚用金匱肾气汤，送服黑锡丹；心肾阳衰欲脱用参附汤益气回阳固脱，表虚自汗加黄芪，脾虚便溏加白术。张氏常在哮喘缓解期及平时用平补阴阳的河车大造丸以扶正固本。平时适寒温，调饮食，加强锻炼以增强体质。

如治患者，女，50岁，住院号17923。患支气管哮喘10余年，近2年频发加重。曾用西药效不显，改用“哮喘疫苗”亦乏效。某日突然加重，呼吸急促，喉中哮鸣，不能平卧，胸膈满闷如室，咳呛牵引胸痛，痰白色，粘不易咯出，头汗淋漓，唇口发绀，甚则二便失禁，两肺满布哮鸣音，舌质暗红，苔薄黄，脉右寸稍浮滑，两尺沉而无力，诊为慢性支气管哮喘急性发作，肺气肿。系久哮致虚，肺气不足，肾失摄纳，兼痰热内蕴，外感风邪，入舍肺系，致肺失肃降，痰搏气逆而发哮喘，为本虚标实之证。治宜降气纳气，化痰定喘。药用钟乳石10g，瓜蒌10g，川贝母10g，橘红10g，苏子10g，补骨脂10g，胡桃肉10g，射干10g，茯苓12g，地龙12g，丹参15g，炙麻黄15g，杏仁6g。服2剂，哮喘明显减轻，痰松动，可平卧。继进3剂喘平，两肺呼吸音清晰，守方巩固疗效，并拟扶正固本的丸剂善后：白人参15g，蛤蚧尾1对，甜杏仁15g，橘红15g，川贝母15g，生桑白皮15g，地龙15g，麦冬30g，补

骨脂 30g, 胡桃肉 30g, 紫河车 30g, 钟乳石 30g, 丹参 24g, 苏子 24g, 炙甘草 10g, 茯苓 10g。炼蜜为丸, 重 12g, 每日服 2 次。^[25]

22. 吴银根诊治经验

吴氏从医近 40 年, 对中医药治疗呼吸系统疾病有丰富的经验, 尤精于治疗哮喘, 远期疗效显著。

①发作期温阳散寒祛痰饮: 哮喘多因胸膈间宿有痰饮, 复遭风寒外邪侵袭, 内外合邪, 搏于气道, 阻碍气机, 致肺失宣降而发。常用麻黄 10g, 附子 10g, 制半夏 10g, 细辛 5g, 白果仁 30g, 桑白皮 30g, 紫菀 15g, 款冬花 15g 为基本方。痰多而粘, 加白前、前胡; 痰难咯出, 加生半夏、生南星, 但宜中病即止; 喉间痰鸣, 加射干; 多汗者, 合桂枝汤。吴氏还善用治风治肝之药, 认为具有抗过敏及解痉作用, 如易感冒而诱发者, 加防风、柴胡; 哮喘气急难平, 加蜈蚣、全蝎、蝉蜕等; 对偏热而见舌红、口干、口苦、情绪易于激动者, 加白芍、当归、地龙; 痰黄而粘, 难以咯出, 便干者, 加黄芩、熟大黄等; 对于各种气味过敏诱发者, 加蒲公英、紫花地丁。哮喘发作每每伴有过敏性鼻炎, 可选加苍耳子、辛夷、白芷等通窍利肺之药, 不但治鼻, 亦可预防发作。小儿脾常不足, 多痰食积滞, 可加鸡内金、莱菔子以消食祛痰; 老年多虚多瘀, 可加丹参、川芎等活血化瘀, 仙茅、仙灵脾、菟丝子等补肾纳气。

②迁延期化痰止咳养气阴: 哮喘迁延日久, 痰湿未净, 气阴已伤, 故易反复发作, 时发时止。患者体力下降, 易于感冒, 平素多咳多痰, 痰粘难咯, 胸闷, 气息不畅, 咽喉不利, 睡眠欠佳。常用南沙参 30g, 党参 30g, 玉竹 30g, 黄精 30g, 山药 30g, 紫金牛 30g, 黄荆子 30g, 黄芪 20g,

紫菀 15g, 款冬花 15g, 制半夏 10g 为基本方。易感冒者, 加防风、苏叶; 胸闷者, 加陈皮、厚朴、瓜蒌皮; 咽喉不利, 痰粘难咯者, 加射干、桔梗、鱼腥草; 咳嗽影响睡眠者, 加合欢皮、夜交藤、远志、茯神等安神养心, 既利于睡眠, 有助于体力的恢复, 又可调节神经系统功能, 以防哮喘发作; 有短气乏力, 腰膝酸软等肾虚征象时, 加巴戟天、仙灵脾、仙茅、菟丝子、补骨脂等以补肾纳气; 若干咳日久不愈, 可加罂粟壳以收敛肺气。迁延期治疗时间较长, 用药需注意同类药物之间的调换使用, 以减少副作用和提高疗效。

③缓解期调补本元用膏方: 患者呈过敏体质, 不耐风寒易感冒, 体力减退易疲劳, 经中西药物治疗, 发作减轻后, 可用膏方调理, 巩固疗效。吴氏认为用膏方调理不能单纯从补着眼, 必须结合患者具体情况辨证用药, 在健脾补肾、益气固表以治本的同时, 结合化痰平喘止咳、祛风止痉、通窍利肺等, 并根据阶段不同而有所侧重, 在哮喘尚未完全控制时, 重在祛邪, 辅以扶正, 或攻补并重, 常用麻黄、杏仁、白果仁、桃仁、蒲公英、连翘、黄荆子、胡颓根、紫菀、款冬花、地龙、蜈蚣、全蝎、辛夷、苍耳子、防风、丹参、厚朴、南沙参、黄芪、党参、白术、黄精、山药、熟地、女贞子、菟丝子、补骨脂、仙灵脾、白参、蛤蚧为基本方, 连续服用 40~50 天。待哮喘渐平, 基本不发作时, 则以扶正为主, 提高机体的抗病能力。常用黄芪、党参、白术、黄精、南沙参、麦冬、玉竹、薏苡仁、山药、山茱萸、仙茅、仙灵脾、巴戟天、补骨脂、桑椹、杜仲、枸杞子、制首乌、紫金牛、黄荆子、苍耳子、丹参、黄芩为基本方, 随证加减, 务期贴切证情。一般来说, 患者初次服用膏方后, 翌年上半年的发作明显减轻, 甚或不

发，下半年体质又会有所下降，再用膏方进行调补，哮喘就会逐渐稀发直至停止。

如治谢某某，男，5岁，门诊号：125364。1998年10月27日初诊。近日哮喘发作，胸闷气急，咳嗽，喉间痰鸣如水鸡声，痰难咯出，以后半夜为重。舌苔薄白，脉细。证属痰壅气逆，治以化痰宣肺，平喘止咳。药用：麻黄6g，附子5g，地龙5g，款冬花5g，紫菀5g，苍耳子5g，辛夷5g，甘草5g，桑白皮15g，白果仁15g，黄荆子（包）15g，苏子（包）15g，莱菔子（包）15g，紫金牛30g，全蝎3g，蜈蚣2条。7剂。水煎，早饭后、晚饭后与临睡前分3次服。11月5日二诊：药后哮喘平，咯痰易，但后半夜仍咳嗽，喉间有水鸡声，苔薄白，脉细缓，治宗原法，辅以益气固表。上方去麻黄、附子、紫菀、款冬花，加黄芪20g，党参15g，白术10g。7剂。水煎，早晚分服。12月12日三诊：咳嗽已控制，唯夜间偶发，苔薄白，脉细。治以益气养阴、止咳化痰。药用：南沙参30g，玉竹30g，紫金牛30g，麦冬15g，党参15g，黄荆子（包）15g，莱菔子（包）15g，生地20g，黄芪20g，白术10g，苍耳子10g，辛夷10g，防风6g，甘草5g。7剂。后以此方出入调治月余，诸恙悉平，嘱其入冬后膏方调理。

又如治陈某某，男，16岁。门诊号：53057。1992年12月12日初诊。哮喘3年，经治已经减轻，但仍时有发作，发则咳嗽气促，痰少胸闷，易感冒。舌苔薄白，脉细滑。证属肺气不固，肾元不足，治以补肺益肾，平喘止咳化痰，膏方缓图。药用：麻黄100g，杏仁100g，前胡100g，白前100g，地龙100g，桃仁100g，川芎100g，丹皮100g，百部100g，白术100g，防风100g，鹿角片100g，柏子仁100g，法半夏100g，麻黄根150g，紫菀150g，黄

荆子(包) 150g, 丹参 150g, 山药 150g, 仙茅 150g, 茯苓 150g, 补骨脂 150g, 菟丝子 150g, 赤芍 300g, 熟地 300g, 仙灵脾 300g, 南沙参 300g, 黄芪 200g, 甘草 50g, 加入白参 150g, 阿胶 350g, 蛤蚧 2 对, 核桃肉 500g, 冰糖 500g, 饴糖 250g 收膏。1993 年 12 月 8 日来诊: 去年膏方服后, 哮喘仅发作 1 次, 在冬季寒流到来时受凉触发, 1 天后即缓解, 现仅感疲乏, 舌红, 苔薄白, 脉细。治宗原法, 上方去赤芍, 加厚朴 100g, 胡颓根 150g, 如法收膏。1994 年 12 月 16 日来诊: 上方服后哮喘未再复发, 唯时有感冒不适, 服银翘散即可缓解, 全身情况好转, 再宗原法, 加以化裁, 药用: 桑白皮 300g, 白果仁 300g, 黄精 300g, 丹参 300g, 仙灵脾 300g, 菟丝子 300g, 补骨脂 300g, 胡颓根 300g, 蒲公英 300g, 黄芪 200g, 熟地 200g, 麦冬 150g, 首乌 150g, 苍耳子 150g, 黄荆子(包) 150g, 山药 150g, 仙茅 150g, 地龙 100g, 射干 100g, 白术 100g, 防风 100g, 厚朴 100g, 辛夷 100g, 山茱萸 100g, 巴戟天 100g, 金银花 100g, 甘草 100g, 五味子 60g, 全蝎 30g, 蜈蚣 20 条, 另加白参 60g, 胎盘粉 60g, 蛤蚧 2 对, 饴糖 250g, 冰糖 500g 收膏。1998 年 12 月 18 日来诊: 上方服后至今, 哮喘未再发作, 自觉体力增加, 不易感冒, 眠食良好。^[26]

④擅用药对: 麻黄与麻黄根: 哮喘多发于冬春季节, 经常在夜间发作或加剧, 诱因多为外感风寒, 辨证多属寒哮。治当温肺散寒, 宣肺开郁。常用麻黄等宣肺平喘之品, 但麻黄发汗之力宏, 且哮喘病人体质多虚, 恐麻黄发散太过, 损伤正气, 甚至引起气脱等症; 麻黄根善于引气药至卫分, 收敛肺气, 固腠理而止汗。两药配伍, 一宣一敛, 既达到宣肺平喘的目的, 又可防止正伤邪侵而使病情加重或复发。吴氏对哮喘急性大作者, 不论有无表证或汗出,

常用此药对，且麻黄根剂量用至 30g，大于麻黄的剂量约 2 倍，目的在于抑制麻黄发散太过，加强平喘作用。麻黄要后下，以防其挥发油丢失。

桂枝与厚朴：哮喘病人多为肺（阳）气亏虚，卫外不固，易感外邪，尤其是风寒之邪，引动肺中“伏痰”，致肺失宣降，使哮喘发作或加重。治当散寒解表，降逆平喘。桂枝和营血，利肺气；厚朴下气降逆，消痰平喘，即《伤寒论》中桂枝汤加厚朴、杏仁之义。此药对与麻黄、麻黄根药对比较，一偏体虚，一偏体实，而意义相同。桂枝与厚朴的用量，可因具体情况而有所偏重。

桑白皮与白果：痰伏日久，常郁而化热，痰热胶固于膈上，成为哮喘发作的夙根。临床上常见哮喘病人易合并肺部感染，或因上呼吸道反复感染而使哮喘复发或加剧。治当清热化痰，降气平喘。常取白果定喘汤中桑白皮清热肃肺；白果收敛肺气，定喘止嗽。两者散敛结合，共奏肃肺敛肺、化痰平喘之效。其用量常至各 30g。此药对作为治疗痰热壅肺的哮喘轻、中度发作的主药。

前胡与白前：肺中“伏痰”遇感引触，痰气相搏，壅塞气道，肺失宣降，常可引发咳嗽、喘促等症。治当宣降肺气，化痰定喘。前胡既能宣散风热，又能降气化痰；白前长于泻肺降气。两者一宣一降，宣降清化，调理肺气，化痰止咳平喘。吴氏常用此药对治疗喘势渐缓，咳嗽吐痰仍作者。

桃仁与杏仁：哮喘日久，久病入络，气滞血瘀。哮喘若为气血瘀滞或燥邪伤肺者，均可加入辛润之品，以活血润燥，止咳平喘。杏仁味苦微温，行气散结，润肺止咳，使肺脏郁闭之势得以解除；桃仁活血化瘀，泻肺缓肝，凡见肺气郁闭，咸可投用。杏仁治上，桃仁治下，气行则血

动，瘀血乃祛，且两者都有润滑之性，既可润肺止咳，又可滑痰通下，引邪下行，给邪以出路。治疗哮喘非急性发作期的咳嗽，尤其痰少或无痰者效佳。桃仁用量可大于杏仁，但两药之剂量均不可太大，以免中毒。

当归与苏子：痰气壅盛而气血亏虚的哮喘患者，治当降气消痰，活血止咳。治痰须和血，血旺而痰易化，活血和血之品可增强化痰止咳平喘之作用。苏子降气祛痰，止咳平喘；当归养血和血，《本经》谓其“主咳嗽之气”，为血中气药。两药配伍，一走气一走血，气血双调，寓苏子降气汤之意，降气化痰以行血畅气道，行气活血助化痰滞，相辅相成，增强消痰止咳喘之功，且两药均可润燥滑痰，用于治疗久患哮喘之虚实夹杂者。当归用量一般大于苏子。

苍耳子与辛夷：许多哮喘患者兼有过敏性鼻炎史。肺开窍于鼻，鼻与喉相通联于肺，所以外邪袭肺，多从鼻喉而入。鼻塞流涕，喷嚏阵作，也是哮喘发作的先兆。故治肺的同时，要重视治鼻与喉，常用宣肺利窍之品，以改善鼻喉功能，防治哮喘。用辛夷散风寒，通鼻窍；苍耳子祛风邪，通鼻窍，两者为《证治准绳》中苍耳子散主药，合用可加强祛风除湿，宣肺利窍功能，以治疗哮喘的过敏症状。

蜈蚣与全蝎：痰气郁结，气血运行不畅，而致气滞血瘀。痰郁、气滞、血瘀常相互影响，兼而为病，致哮喘反复发作。如气血津液运行通畅，痰液得消，瘀血得散，则气机正常。虫类药能搜风通络，使肺中伏痰顽瘀消散，肺气得以宣降。吴氏认为两药有搜风解痉平喘之功。用量为蜈蚣每日2条，全蝎每日3g，可长期应用，尤其是反复发作的顽固性哮喘。

生半夏与生南星：哮喘发作的主要原因是外感引动

“伏痰”。痰的产生多责之于脾虚不能运化水湿，肺虚不能通调水道，以至津聚成痰，贮于肺脏。肺脾气虚不能卫外而易感外邪，引动“伏痰”致哮喘发作。半夏尤善健脾燥湿，降逆散结；南星祛风除湿化痰，两者合用，燥湿化痰之力雄厚，为治疗各种痰湿的基本药。吴氏认为两药惟有生用，效果才更显著，其用量为每日各 15g，入煎剂，未发现明显毒副作用。

菟丝子与补骨脂：哮喘反复发作，久病及肾，气阴耗损。缓解期可表现为短气息促，动则喘甚，劳累后哮喘易复发等症，所谓“急则治其标，缓则治其本”，“肺为气之主，肾为气之根”，治当补肾固精，纳气平喘。常用菟丝子补肝益肾，偏于益精，温而不燥；补骨脂偏于补肾暖脾而纳气固阳。两者共用，补肾纳气。吴氏常用此药对治疗哮喘见肺肾气虚者，从而减少或控制本病的发作。

仙茅与仙灵脾：哮喘的病因虽多，究其产生的根本原因（内因）则是阳虚寒盛。肺、脾、肾阳虚，不能温化水湿津液，致津液停聚成痰，痰阻气滞，瘀血乃生。而肾阳是一身阳气之根本，肾阳虚则肺脾等诸脏俱寒，寒、痰、瘀均为阴分，阳虚不能制阴，致哮喘反复发作。吴氏通过统计发现，哮喘多在秋冬或冬春季节转换之时，并多在夜间发作或加剧，诱因多为外感寒邪，约 30% 的患者辨证属寒哮，故哮喘患者不论急性发作或缓解期，均需加入补肾纳气、温肾壮阳等药，以扶正祛邪，祛寒除湿，且可加强健脾化湿药之功效，杜绝痰瘀的产生，如此才能从根本上防治哮喘。仙茅补命门，壮阳除寒湿；仙灵脾温补肝肾，壮阳益精。两者配伍，温阳补肾，纳气平喘。吴氏常用此药对与大蒜素等制成胶囊，用于哮喘缓解期的固本治疗。

吴氏根据哮喘各期的特点，选用不同的药对。发作期

多调气散寒、化痰祛瘀为主，佐以温补脾肾；缓解期多温补肾阳为主。吴氏在长期临床中积累的药对应用经验，不仅体现了中医辨证施治的理论，而且也结合了现代中医药研究的新成果，故临证应用颇有效验。^[27]

23. 王会仍诊治经验

王会仍长期从事呼吸系统疾病的研究，治疗支气管哮喘经验独到。

①调气治痰：丹溪认为，哮喘“专主于痰”。《症因脉治·哮喘》亦指出：“哮喘之因，痰饮留伏，结成巢臼，潜伏于内，偶有七情之犯，饮食之伤，或外有时令之风寒束其肌表，则哮喘之症作矣。”哮喘发病的主要病机为伏痰遇外邪引触，痰随气升，气因痰阻，相互搏击气道而致喉中哮喘，气息喘促诸症。痰气交阻是本病发病的关键，故治疗必须以祛痰化痰、调畅气机为先。“人之气道贵乎顺，……气顺则痰自化矣”，而痰去则气亦顺，顺气与治痰两者有机结合运用，哮喘自平。哮喘发作期有寒哮，热哮之分。寒哮为寒痰阻肺，肺气上逆所致，治宜温肺化痰、降气平喘，方以小青龙汤、射干麻黄汤、三拗汤等化裁，常用药物：麻黄、射干、细辛、五味子、姜半夏，炙苏子、杏仁、生甘草等。麻黄宣泄气机，专疏肺郁，为平喘要药；细辛辛散温通，温肺化痰；射干开痰结，降肺气；苏子降气消痰，止咳平喘，开郁利膈；杏仁降气祛痰，宣肺平喘。诸药相合，宣降得法，利肺气、化痰饮而喘逆平；伍以半夏、生甘草健脾化痰，五味子敛肺，效用尤强。药理实验证明，麻黄、细辛、杏仁、甘草、姜半夏等能抑制过敏介质释放，降低 IgE 水平及增加 cAMP 含量，从而舒张支气管平滑肌达到平喘效果。热哮为痰热壅肺，气机升降失司而致，治

宜清热泄肺，豁痰下气，方以定喘汤加减，常用药物：白果、麻黄、黄芩、桑白皮、炙款冬花、杏仁、七叶一枝花、老鹳草、羊乳、丹皮等。王氏认为，白果敛肺定喘，麻黄宣肺平喘，一开一收，可制止哮喘发作。伍以黄芩、桑白皮、七叶一枝花、羊乳、炙款冬花、杏仁、老鹳草、丹皮等药，一则清泄肺热，化痰平喘，二则可制麻黄燥热之性。其中黄芩药量须在 12g 以上。有高血压、快速型心律失常或年高体弱者，麻黄可改用黄荆子 12g，黄荆子能行气祛风，降痰平喘，有类似麻黄之作用，而无麻黄之弊端。药理研究表明，黄芩、丹皮、老鹳草、七叶一枝花等能抑制过敏介质的释放，对肺炎球菌、链球菌等多种细菌及流感病毒均有明显抑制作用，故诸药相合，既可平喘，又能抗菌消炎，颇具效验。

②活血化瘀：宿痰内伏，壅于气道，气壅而血瘀，即“有痰必有瘀”；哮喘反复发作，日久肺气必虚，气虚无力推动血液，而致气虚血瘀，亦即“有虚必有瘀”、“久病必瘀”。因此，无论在哮喘发作期，或是缓解期，王氏都力倡加入活血化瘀之品，主张气、痰、瘀同治。常用黄芪、党参、甘草、白术、陈皮、降香、香橼皮等益气、理气之品，并与当归、川芎、丹参、赤芍等养血、活血药物进行配伍，达到益气活血或行气活血之目的，这对提高和巩固哮喘的治疗效果很有裨益。实验研究亦证明，活血化瘀类药物能够拮抗血小板激活因子（PAF），降低 IgE 水平，改善微循环，舒张支气管平滑肌，具有明显的平喘作用。

③祛风通窍：肺主气，外合皮毛，开窍于鼻，外邪从表自上而入，内合于肺而诱发哮喘，此时鼻窍、皮毛首当其冲，出现鼻塞、鼻中作痒、鼻流清涕、喷嚏等先兆症状。临床上所见支气管哮喘患者多伴有过敏性鼻炎，吸入花粉、

烟尘、油漆味等即出现鼻塞流涕等症状，即使无明确的过敏原，亦常伴有上述症状。因此，适当加入一些祛风通窍之品，如辛夷、苍耳子、防风等，常能收到令人鼓舞的效果。

④祛风镇痉：支气管哮喘是由肥大细胞、嗜酸性粒细胞等许多细胞参与的慢性气道炎症性病变，具有气道高反应性和可逆性气道阻塞之特征，存在着平滑肌收缩和支气管痉挛。一些虫类药物如广地龙、蝉蜕、僵蚕、蜈蚣等，能祛风镇痉，有助于加强疏通气道壅塞及血脉痹阻，抗过敏，缓解支气管痉挛作用，从而达到平喘目的。故可在辨证施治基础上，酌情配伍应用。但本类药物中僵蚕、蜈蚣有燥血伤阴之弊，宜中病即止，不可久用。

⑤标本同治：无论是哮喘发作期，还是缓解期，王氏都自始至终坚持“治标不离本”、“治本不离标”的治疗原则，将治标、治本有机地结合在一起。哮喘为一沉痾顽疾，其病迁延，正气亏虚，发作时多表现为虚实错杂之候。诚然，哮喘发作时以祛邪为急，但治疗时若一味投以宣肺化痰、降气平喘之剂，虽症状暂时可除，但药力过后，诸症复萌，疗效不易巩固。因此，必须在祛邪同时酌加扶正之品，如黄芪、太子参、广地龙、仙灵脾等，以促进病情尽快恢复。其中黄芪用量 15~24g，太子参 18~30g，仙灵脾 9~15g，广地龙 15g。其中黄芪与太子参合用，补肺健脾作用更强，从而能鼓舞正气，祛邪外出；广地龙性寒，味咸属阴，仙灵脾性温，味辛甘属阳，两者相伍，既可避免地龙之助寒伤阳，又可防止仙灵脾之助火伤阴，一阴一阳，燮理阴阳，对于哮喘长期反复发作兼有性功能减退的中老年患者尤为合适。在哮喘急性期缓解后，由于宿根伏邪留恋，应在扶正固本的同时，适当加用宣肺、清肺、化痰等

祛邪药物，如桑白皮、金银花、七叶一枝花、云雾草等，以奏“邪去正安”之效。

⑥脏腑同治：“肺与大肠相表里”，肺主宣发、肃降，大肠主传导、排泄，肺气肃降有序，则大肠传导正常。王氏根据脏病治腑、脏腑兼顾的治疗原则，治疗哮喘时不忘保持腑气的通畅。尤其是痰热壅肺而腑气不通的实证哮喘，适当加入通腑泄热或润肠通便之药，如瓜蒌仁、桃仁、大黄、枳壳等药，能使腑气通而肺气降，从而更快地达到平喘目的。在运用通腑药物时，还应注意患者的体质强弱及正气盛衰，如药后出现腹痛等症状，当减轻剂量；若腹泻严重，甚至有阴竭阳脱之征兆，应及时停药，以防发生变证。

⑦因时制宜：哮喘反复发作，迁延日久，阴阳俱虚，春夏季节，气候由温转热，阳盛阴衰，阴液愈耗，此时应慎用辛热之品，以防助热伤阴，治疗以清肺平喘为主；秋冬季节，气候由凉转寒，阴盛阳衰，人体腠理致密，阳气敛藏于内，致使哮喘病人阳气愈虚，不能卫外，一旦风寒之邪乘虚入侵即引起哮喘发作，此时应慎用苦寒之品以防伤阳，治疗以温阳平喘为主，这样方能顺乎自然，切中病机。

⑧因人制宜：人之先天禀赋和后天调养各异，临床时需善于抓住各自的体质特点而酌情施治。对于女性，特别是经期前后发作的患者，因其以血为本的生理特点，治疗时应配伍一些养血活血之品，如当归、赤芍等，尤其是当归，本身具有止咳逆上气之功效，用之甚妙。老年哮喘患者机体适应能力、防御能力均低下，肾阳必虚，故用药上多偏于温补，可酌情选择仙灵脾、补骨脂、紫河车等。对于一些反复发作，并伴有胸胁苦满、少寐的哮喘患者，系

由于情怀不遂，忧思气结，肺气痹阻或郁怒伤肝，肝气上逆于肺，肺气不得肃降，气逆而发。因肝是通畅全身气机的枢纽，运用一些疏肝解郁、安神定志的药物，如柴胡、白蒺藜、远志、合欢皮、石菖蒲、夜交藤等，往往能使之神定气顺，止喘于顷刻之间。^[28]

24. 许建中诊治经验

许氏为著名的呼吸病专家，他自古今中医浩瀚的文献中发掘精华，并结合自己几十年的临床经验和反复实践，从中西医结合的角度出发，对治疗哮喘有独到见解。

①坚持辨病与辨证相结合的原则：哮喘急性发作一般病势比较急重，因此许氏认为，哮喘的急性期必须要辨病与辨证相结合。

辨病治疗：此阶段适当配合西医方法，如解痉、抗感染、糖皮质激素等，比单纯用中医治疗见效快、疗效好。

辨证治疗：许氏强调，根据患者痰的色、粘稠度、气味，结合舌脉以及整体状态，按“急者治其标、缓者治其本”的原则治之。急性期辨证分别采取温化寒痰法和清肺利痰法、燥湿化痰法、养阴润燥法，并结合降逆平喘，均能起到较好的疗效。缓解期则根据证型分别采取益气固表法和健脾益气法、补肾纳气法、扶正固本法，防止哮喘复发或延长复发时间，可以避免某些患者长期依赖激素，甚至可以不再使用激素。中西药取长补短，相得益彰，使病情得到控制，从而提高生活质量。

②坚持标本兼治的原则：许氏认为，对于慢性反复发作的哮喘应坚持标本兼治的原则。由于支气管哮喘的病因为宿痰内伏于肺，复感外邪，加之饮食不当，冷暖失宜，情绪不畅等诱因引发，使痰随气升，气因痰阻，互相搏结，

壅塞气道，肺失宣降而出现喘促哮喘。宿痰的成因与先天禀赋不足，脏腑功能失调有关，古代文献中广泛提到，本病与肺、脾、肾三脏有密切关系。患者多表现有不同程度的肺脾肾三脏亏损不足，尤其是慢性反复发作性哮喘患者更为明显。患者大多虚实夹杂，本虚标实，以宿痰、外感等因素为标，以肺脾肾三脏虚损为本。在这种前提下，对于反复发作缠绵难愈的患者，应标本兼治、肺肾同治或肺脾同治，益气养阴、攻补兼施。许氏认为，标本兼治是从中医整体观点出发，结合现代医学研究总结出的原则。现代医学研究认为，治以清肺（温肺）化痰平喘，可以取得缓解支气管痉挛的效果，而治以益气养阴、补肺健脾、固肾纳气，则可提高肾上腺皮质轴功能，促进肾上腺皮质激素分泌，影响变态反应和非变态反应的主要环节，抑制炎性细胞、炎性介质释放，能控制炎症、降低气道反应性，从而缓解哮喘发作。

③坚持“治病必求其本”的原则：《景岳全书·喘促》说：“喘有夙根，遇寒即发或遇劳即发，亦名哮喘”。所谓“夙根”是指内伏于肺的宿痰。中医认为，哮喘的病理因素以痰为主，痰之产生责之于肺不能布散津液，脾不能运输精微，肾不能蒸化水液，以致津液凝聚成痰，伏藏于肺，成为“夙根”。随着现代医学的不断发展，人们认识到支气管哮喘的发病机制与气道变应性炎症及气道高反应密切相关。因此，如何从不同角度改善气道高反应以及抗御某些炎性介质的释放和侵犯，是防治本病的关键所在。许氏认为，从中西医结合的角度分析，气道变应性炎症、气道高反应就是中医所说“夙根”的内涵，也是哮喘病的病机根本。因此必须抓住这一根本，不仅在急性发作期要“温肺化痰、清肺化痰”，缓解期更应抓住这一环节，或健

脾以化痰，或补肺以助其输布津液而化痰，或补肾以助其气化水液而化痰。目前西医治疗气道变应性炎症、气道高反应性，用药首推糖皮质激素，但长期使用糖皮质激素会出现严重的副作用。许氏认为从中医的角度出发，抓住“宿痰”这一“夙根”，同样能起到控制气道变应性炎症和气道高反应性，而且可以避免长期使用激素的副作用，从而达到了平喘和恢复体质的目的。“喘有夙根——治病必求于本”的观点充分发挥了中西医结合治疗哮喘的优势，应引起重视。

④坚持中西医结合不断吸收新成果的原则：近十年来有关支气管哮喘的研究取得了很大进展，例如：在免疫学研究方面即有如下几点重大发现：提出了气道变应性炎症是哮喘的主要发病机制；细胞因子参与了哮喘发病的调节；证实除肥大细胞外，淋巴细胞、嗜酸性粒细胞和巨噬细胞等炎性细胞均是哮喘患者气道变应性炎症中的主要效应细胞；发现了许多参与哮喘调节的新型炎性介质，如白细胞三烯、血小板激活因子等。许氏认为，通过现代免疫学药理技术进行单味和成方的研究是防治哮喘的又一有效途径。目前已进行的免疫学药理研究已证实中药对哮喘的疗效是肯定的。如降低哮喘患者体内 IgE 的中药有甘草、柴胡、生地等；成方有小青龙汤、麻杏石甘汤、柴朴汤、小柴胡合半夏厚朴汤等。抑制呼吸道炎症细胞粘附和趋化作用的中药，有从柴胡中提取的柴胡皂甙，可抑制炎症细胞向炎区的粘附。抑制炎症细胞释放炎症介质的中药有黄芩、麻黄、辛夷、细辛、郁金、五味子等；成方有麻杏石甘汤、小青龙汤、柴朴汤、清肺汤等，均能抑制肥大细胞增殖分化和释放炎症介质。可拮抗炎症介质的中药有银杏叶，可拮抗白细胞三烯的中药有甘草、细辛、五味子、小青龙汤，

可拮抗组织胺的中药有细辛、五味子、干姜、莪术、苍术和小青龙汤等。由此可见，从免疫学的角度研究中医中药大有可为，但还有更多工作有待进一步研究和发掘，从而达到彻底治愈哮喘的目的。^[29]

25. 方和谦诊治经验

方氏临证近 50 载，用药轻灵，立方简赅，疗效卓著。他对仲景学术理论进行过深入研究，对其中许多方剂有独到见解。现介绍其对《伤寒论》治喘诸方的应用经验。

①表里同病的喘证用葛根芩连汤：“太阳病，桂枝证，医反下之，利遂不止，脉促者，表未解也，喘而汗出者，葛根黄芩黄连汤主之”，这段条文讲的是由于误下之后，造成胃肠受伤，中气受损，但正气不虚，仍能抗邪，外邪尚未完全陷于里，而表证仍在，又可见到患者有喘而且多汗，知邪热已经内传，影响了大肠的传导功能。更由于肺与大肠相表里，里热壅盛，上蒸于肺则喘逆。其病为表里同病，治法亦用表里两解之法，以葛根芩连汤治疗，热清利自止，喘自平。方氏认为本条文所现之喘是兼证，而不是主证。主证还是下利证。因为它是误下之后首先造成胃肠受伤，中气受损，邪热内传，影响了大肠的传导功能，又因肺与大肠相表里，间接影响肺而致喘。所以下利为主，喘为次证。在临床应用时主要还是以现代医学所说的肠炎、痢疾等为其主治者多见。

②水热胶结的喘证用大陷胸丸：方氏认为大陷胸丸是治疗结胸证的一种缓治方法，虽然它与大陷胸汤的证机相同，皆是由于邪陷与水饮痰浊相结而成，病性属热属实，但病变的部位不同。大陷胸汤病变部位在胸膈，大陷胸丸邪结位置偏高，在胸膈以上。正象原文所云：“结胸者项亦

强……”，由于邪结部位偏高，所以不用大陷胸汤而改用大陷胸丸以图缓治。病位偏高，势甚于上，肺气不得舒展，可有呼吸迫促气喘等证，故仲景于本方中以葶苈、杏仁泻胸水利肺气，大黄、芒硝泻热破结。由于甘遂峻猛有毒，所以别捣甘遂，配以白蜜解毒为辅助药，既可达逐水破结，又不失峻药缓攻之目的。在方氏所治疗的呼吸道疾患如慢性喘息型气管炎急性发作时以用葶苈、杏仁，兼以清降利肺之病例也不为鲜见。

③邪踞半表半里的喘证用小柴胡汤：“伤寒五六日，中风，往来寒热，胸胁苦满，嘿嘿不欲饮食，心烦喜呕，或心中烦而不呕，或渴，或腹中痛，或胁下痞硬，或心下悸，小便不利，或不渴，身有微热，或咳者，小柴胡汤主之”。这条原文，方氏认为小柴胡汤中也可出现因咳致喘证。这就要从少阳病的病因病理谈起，病因是由于气血虚弱，肌腠疏松，卫阳不密，因而邪气直入，由于邪气侵入虚弱的机体，呈现出一系列的病理变化，如胸胁苦满，往来寒热，心烦喜呕，嘿嘿不欲饮食。因邪踞半表半里，出与阳争则热，入与阴争则寒，其中咳证就是与阴争时肺寒气逆证，咳急咳甚则可出现喘，咳喘时所出现的痰多为白色泡沫状。因此在治疗时以柴胡汤去参、枣，生姜易干姜，加五味子。这样既可温肺，又可敛肺平喘。^[30]

26. 李仁生诊治经验

肾上腺糖皮质激素（以下简称激素）具有抗炎、抗毒、抗过敏等作用，常与平喘药配合用于治疗多种呼吸系统慢性疾病所致之哮喘，平喘效果较好。但是，长年累月滥用情况较为常见，导致体内激素分泌调节功能受损，哮喘反而发作频繁，喘势加重，多系统的并发症也相继发生。

依赖性哮喘一旦形成，单纯靠逐渐撤减激素易发生反跳，甚则出现危象，治疗较为棘手。李氏运用中医药分期辨治，对平息喘逆，配合减停激素，效果较好。

①哮喘急性发作期：多以肺肾阳气、阴精虚衰欲脱的危急重证为主要表现，症见喘憋鼻煽，张口抬肩，胸高气粗，端坐不能平卧。伴有面白，大汗出，畏寒肢冷，少尿浮肿，烦躁神昧，舌质淡，脉沉微等阳虚欲脱证者，治宜回阳救逆固脱。急用参附龙牡汤加干姜（人参 20g，熟附子 20g，干姜 10g，龙骨 30g，牡蛎 30g），浓煎频服，每日 1~2 剂。如见颜面潮红，汗出如油，心烦躁扰，舌红绛少苔而干，脉细疾等气阴欲竭者，治宜益气救阴，急用参麦散加味（人参 20g，麦冬 30g，五味子 30g，山茱萸 30g，白芍 30g，龙骨 30g，牡蛎 30g，炙甘草 15g，每日 1~2 剂。服药 3~5 日后，随着阳气阴精的回复，其哮喘就会明显改善，反复性亦明显减少。

②哮喘缓解期：哮喘缓解后，痰浊饮邪为患表现突出，咳嗽，咯痰量多，胸部闷胀。若痰色白、质稀，面壅肢肿，舌苔白滑厚腻，脉沉弦或滑者，为寒痰饮邪内壅外溢，用桂苓五味甘草汤加细辛、杏仁、干姜、半夏，温化寒痰饮邪。虚实夹杂者，则温化与温补同施。若痰色黄，质稠粘，舌红，苔黄，脉滑数者，为痰热蕴肺，用生地、玄参、麦冬、瓜蒌、贝母、法半夏、胆南星、海浮石、竹茹、鱼腥草、芦根等养阴清化痰热。虚实夹杂者，则滋补与清化同施。

③恢复稳定期：经上述两期治疗后，大多喘平咳减，而以神疲，肢软无力，动辄心累气促，纳呆脘痞等肺脾肾亏虚证显见。偏于阳气不足者，形寒怕冷，面色少华，少尿肢肿，舌淡脉弱，用《金匱》肾气丸方或右归饮加党参、

炙黄芪、白术、炙甘草温补肺肾阳气；偏于气阴亏虚者，颜面潮红，夜热汗出，大便燥结，小便黄少，舌瘦红少津，脉细或大而无力的，用参麦散合六味地黄汤滋养肺肾气阴。平时以人参 30g，虫草 30g，山茱萸 60g，胡桃肉 60g，黄芪 90g，蛤蚧 1 对，紫河车 1 个为基础方，偏阳不足者加鹿茸 30g，补骨脂 30g，淫羊藿 30g，偏气阴虚者加麦冬 30g，生地 30g，五味子 30g，龟板胶 50g，碾末加等量蜂蜜和为丸，每丸重约 9g，早晚各服 1 丸。此丸剂一般要坚持服用 1~2 年。长期使用激素的患者，不同程度的存在着厌食、脘痞腹胀、进食量少等脾胃虚弱情况，须重视先调补脾胃，使精气血生化有源。

④激素减停方法：哮喘缓解期即可逐渐减停激素，一般以强的松 20mg，每日早上 1 次服，1 周后改为每隔 2 日 1 次，每周递减 5mg，4 周后未见哮喘复发即可停用，只服汤药丸剂。经观察，凡胃纳脾运强健，进食量增能化者，则神疲肢软、心累气短等虚弱证明明显改善，激素可在 1 月内减停完毕，并无反跳现象发生。若胃纳脾运差，肺肾精气未充，虚弱证改善不明显者，在调补肺脾肾的同时，还应适当延长激素减停时间，过快过陡则易发生反跳。

如治黄某，男，62 岁，1991 年 7 月 12 日入院。患慢性支气管炎、肺气肿病 8 年。近 3 年中长期无规律、剂量轻重不等的口服或静注激素。1 月来，喘憋发作频繁。入院后每日静滴先锋 V 5g，加地塞米松 20mg、喘定 0.25g，用药 1 周，喘仍有加重之势。症见呼吸急促，鼻煽口张抬肩，端坐不能平卧，心烦躁扰，神倦，面色潮红，夜热大汗出，舌红绛无苔而干，脉细疾无力。辨证为肺肾气阴亏虚，有耗竭之势。治宜益气救阴，纳气平喘。急投参麦散加味：人参 20g，麦冬 30g，生地 30g，龙骨 30g，牡蛎

30g, 山茱萸 30g, 五味子 30g, 炙甘草 15g。服 6 剂后喘逆明显缓解, 汗出少, 咳嗽痰多、色黄质稠, 舌质转红津回、浮有粘腻黄色垢苔, 肺肾气阴渐复, 痰热蕴肺。治宜养阴清化痰热。药用: 生地 20g, 麦冬 20g, 玄参 20g, 瓜蒌 20g, 海浮石 20g, 鱼腥草 30g, 芦根 30g, 法半夏 10g, 胆南星 10g, 贝母(冲粉兑药汁) 10g。服 6 剂后, 咳减痰少, 神疲肢软, 动辄心累气促, 时潮热汗出, 颜面浮红, 舌红少津, 脉细促。痰热已去, 肺肾气阴亏虚。用参麦散合六味地黄汤滋肾益肺。激素改用强的松 20mg/日, 照法递减, 4 周后停用。守方固本调治 2 月, 喘咳未见复发。出院时处以滋补肺脾肾之丸药方, 嘱坚持服 1~2 年。2 年后随访, 胃强纳增体健, 其喘逆发作较以往大为减少减轻, 不用激素亦能很快控制。^[31]

27. 董建华诊治经验

肺为华盖, 外邪侵袭, 首当其冲, 导致肺失宣发肃降。若体内素有停痰积饮, 为其引动, 痰随气升, 气因痰阻, 相互搏结, 阻于气道, 以致气急鼻煽, 张口抬肩, 喝喝而喘。西医之喘息性支气管炎、支气管哮喘、肺气肿等皆属此病范畴。喘病初起病位在肺, 多实, 施以宣肺、化痰、定喘之法, 如寒痰宜温, 热痰宜清, 湿痰宜燥, 燥痰宜化, 加之降气、行气之剂, 庶可得平。

然肺为娇脏, 不耐寒热, 若未得到及时治疗或治疗失宜, 则痰浊匿于体内窠白, 偶有七情之犯, 饮食所伤, 或外有时令之风寒, 则喘发作。若经久频作, 终成宿喘之症, 导致肺气日益耗损, 肺虚而高源化竭, 脾虚不能化生精微, 均造成肾虚精亏。肺主呼气, 肾主纳气, 肾为气之根, 肾虚失纳, 气浮游于上, 动则喘甚。虽喘在肺, 但其根在肾,

因宿喘用一般的宣肺化痰定喘之剂已无济于事，精气亏损，常难骤复，故治之较难。治当益肾填精，纳气归原，亦渐向愈。但补肾尤应防滋腻太过，助湿生邪，病更难祛。需依具体病情，调整用药比例，伍用得当。董氏根据多年实践经验，总结出一张治疗宿喘验方，临床用之，疗效颇佳。方药组成：生地 12g，熟地 12g，山茱萸 10g，冬虫夏草 5g，紫石英 15g，沉香粉 0.9g（冲），川芎 6g，全蝎 3g，五味子 6g，杏仁 10g，砂仁 3g（后下）。方中冬虫夏草性温，既补肾阳，又益肺阴，配以生地、熟地、山茱萸以益精填髓，补肾纳气。紫石英质重，起重镇降气而平喘作用，配以温肾纳气、降逆调中之沉香，可纳气归丹田。气为血帅，血为气母，喘虽属气机升降失调，但须方中参入川芎、全蝎入血分之药，确能使气道通畅，达到活络解痉之效。宿喘之证肺肾之气耗散太过，可用少许五味子收敛之。杏仁宣肺利气，此乃肺肾同治之理。另少佐砂仁醒脾，兼防补肾之剂过于滋腻，助湿生痰。加减：新加外感，痰多，加入桑白皮、苏子、海浮石等宣肺化痰，防引动宿喘。腰膝酸软、畏寒肢冷明显，加入肉桂、制附子等温肾助阳。倦怠乏力，动则汗出，加入黄芪、牡蛎益气固表止汗。喘憋气急，可增入地龙、生蛤壳解痉纳气平喘。大便干，数日 1 次，可加入酒大黄、全瓜蒌等，通利大肠而起到宣肺降气之作用。

如治陈某，男，60 岁，1988 年 11 月 2 日初诊。咳喘反复发作 20 余年，每遇气候稍变或轻度活动后咳喘加重。西医诊为慢性喘息性气管炎、肺气肿。经多种中、西药治疗效果不显。现用氨茶碱、强的松等药维持。诊见：咳喘不能平卧，动则尤甚，痰少，面红，体胖，自汗出，腰膝酸软，畏寒肢冷，舌暗，苔薄白，脉沉细。董氏诊过此宿

喘患者，认为是本虚标实之证，当补肾纳气、解痉平喘、标本兼顾，以求肺气得平、肾气得纳、其喘自止之效。处方：熟地 10g，山茱萸 10g，冬虫夏草 6g，全蝎 3g，川芎 6g，紫石英 15g（先下），沉香末 0.9g（冲），杏仁 10g，五味子 5g，砂仁 3g（后下），生牡蛎 15g，肉桂 3g。服 7 剂，喘息渐平，已能平卧，四肢转温，自汗已止。守方加减，进 20 余剂后，喘息已平，可以下床活动。仍嘱守方继服，以巩固疗效。随访 1 年，喘未再作。^[32]

28. 曹鸣高诊治经验

曹氏认为，哮喘有宿根，每因寒冷或劳累而诱发。在暴发时，必须发散攻邪为先，宜华盖散加减为主。表邪得解，闭路得开，则痰自利而气自下，肃降复而喘自平。哮喘遇冷即发者有二：一是中外皆寒，即仲景小青龙证；二是寒包热，越婢加半夏汤、麻杏石甘汤，寒甚于热者大青龙加减主之；发病时如咽痒阵呛，痰吐黄浓或如粉条，咯吐困难，烦躁自汗，脉弦滑数，舌苔黄，边尖红，此属积痰蕴热，肺气上壅，宜麻黄、射干、生石膏、枳壳、桔梗、白杏仁、葶苈子、生甘草、莱菔子等，以泄肺化痰，下气清热；如发作次数频繁，日夜数次，能俯不能仰，阵呛痰鸣，痰吐黄稠或如泡沫，胸膈满闷，便秘，脉数大有力，舌质红，口干，究其发作与缓解过程，每与饮食、大便有关，如多食则发作更甚，大便畅通，次数增多，则能减轻或缓解，是痰火蕴蒸，上迫肺金，阳明通降失常，急宜滚痰丸、承气法从下夺之，对体实病实者效如桴鼓；哮喘发作，咳窒胸闷，伴以寒热往来，状如发疟，两胁胀满，此属痰火郁结、阳气拂遏以致营卫分争，非疟也，宜用木郁达之，火郁发之之法，可用柴胡、射干、枳实、桔梗、茯

苓等等，得吐大量顽痰，则气自顺而哮喘自平；小儿哮喘，寒包热为多，一般宜射干麻黄汤、葶苈大枣泻肺汤或黄芩半夏汤加减（黄芩、半夏、枳壳、桔梗、麻黄、紫苏、杏仁、生甘草），慎勿妄用小青龙汤法。

哮喘平时治本，宜温中健运，以绝生痰之源；补肺益元，以增抗病之力。自拟丸方如下：紫河车 30g，吉林人参 30g，潞党参 30g，炒白术 60g，茯苓 45g，苏子 30g，款冬花 45g，全当归 45g，桂枝 21g，白芍 30g，陈皮 20g，法半夏 30g，炙鸡内金 30g，焦神曲 30g，金毛狗脊 30g，鹿角胶 30g。上药共研细末，水泛为丸，丸如绿豆大，每日早晚各服 6g，开水送下。^[33]

29. 沈仲圭诊治经验

哮喘的病机，主要由于伏痰内阻肺气不利所致。此病有寒、热、虚之别，寒证较多。又哮喘久发不已，常致肾阳不振，水泛为痰，或阴虚火升，灼液成痰。沈氏认为此病以冷哮为常见，其症呼吸急促，喉间痰鸣，痰清而稀，胸膈满闷，舌苔白滑，脉象浮紧，治宜温肺散寒，豁痰开窍，费氏鹅梨汤主之。方用：杏仁 9g，苏子 9g，瓜蒌仁 9g，半夏 9g，橘红 4.5g，茯苓 9g，梨汁 1 杯冲入，钟乳石 12g，麻黄 6g，桑白皮 9g，当归 6g，水煎。本方用杏、苏、二陈加桑白皮降气豁痰，麻黄发表散寒，梨汁甘寒润肺，钟乳石甘温助阳，当归和血。全方以攻邪为主，但攻中寓补；以祛寒为主，但温中有润，配合精妙，宜于寒证。平肝降逆理气豁痰法治喘逆咯痰不顺，舌苔黄腻，方用，川贝 6g，杏仁 9g，半夏 9g，化橘红 4.5g，竹沥 30g，加生姜汁 10 滴，旋覆花 6g，紫石英 12g，西洋参 6g（可用北沙参 9g 代），蛤蚧

尾 6g, 白蒺藜 9g, 丝瓜络 6g, 水煎。此病肺肾双亏, 故以西洋参补肺气, 蛤蚧纳肾气, 又用杏、贝、夏、陈、竹沥、旋覆花、紫石英等清热豁痰以治标, 立方工稳, 用于热哮之虚证有一定功效。^[33]

30. 颜德馨诊治经验

哮喘剧作, 多因寒痰胶滞, 气失升降, 投麻黄附子细辛汤辄有立竿见影之效。附子温肾散寒, 麻黄宣肺平喘, 相得益彰, 麻黄得附子平喘而不伤正, 附子又能制麻黄之辛散。颜氏治哮喘之偏于寒胜者, 最喜冠此 2 味, 颇为应手。细辛通阳平喘, 喘息甚时非此不克, 量必重用, 一般用 4.5g, 喘剧者可用至 9g 以上。临床常见顽固性哮喘, 用大量激素亦不为功, 端坐喘息, 日以继夜, 投麻黄附子细辛汤 (每味用量皆为 9g) 1 剂而安。

哮喘为沉痾之病, 缠绵反复, 正气溃散, 精气内伤, 症状错综出现, 但毕竟寒痰阴凝于内者居多, 用附子麻黄偕细辛, 离照当空, 阴霾自化, 能使喘平痰减。即使舌质稍红, 津液不足, 但实质寒凝为本; 经用麻附后阳气来复, 津液上承, 舌色反转润泽, 故治哮喘时用药不可拘泥。

生半夏化痰之力甚著, 颜氏治哮喘亦习用之。一般用 9g, 加生姜 2 片, 无副作用。水蛭粉能改进缺氧现象, 每次服 1.5g, 每日 2 次, 其效亦著。

哮喘预防, 中医学之“冬病夏治”观点颇有临床意义, 颜氏尝于夏季嘱久喘病人服苓桂术甘汤, 每日服 1 剂, 连续服用 1 个月, 即可减少发作或不发作, 此法可取。^[33]

31. 陈耀堂诊治经验

陈氏认为前人对支气管哮喘的治法, 大多宗朱丹溪

“凡喘未发，以扶正为主，已发以散邪为主”之说。其实不然，因哮喘大多自幼即发，来诊时发作多已几年或数十年，病久必虚，即使外感风寒而发，但“邪之所凑，其气必虚”，其表现可如张景岳形容之实喘象，如“气长而有余，……胸胀气粗，声高息涌，膨膨然若不能容，唯呼出为快也”也属真虚假实。陈氏认为哮喘发作时，呼长吸短，乃肾气不足，吸入之气不能归肾所致，治宜标本兼顾。有一通用方：蜜炙麻黄 9g，光杏仁 9g，生地 12g，熟地 12g，山茱萸 6g，五味子 3g，干姜 3g，旋覆花 9g（包），生甘草 3g。寒加附子 9g，黑锡丹 9g（包煎）；热加黄芩 9g，地龙 9g，桑白皮 9g；阴虚加沙参 9g，麦冬 9g；痰多加白矾 6g，半夏 9g；痰不易咳出加白芥子 6g，炙远志 6g；动则喘甚加补骨脂 9g，核桃肉 9g；湿重加厚朴 9g，半夏 9g。

在 50 年代初，陈氏参加中医学习西医。认识到哮喘有过敏与感染两种类型，他对过敏引起者，在处方中常加入凤凰衣 4.5g，蝉蜕 4.5g，露蜂房 6g 等；对感染型痰黄者，常加用鱼腥草 30g，四季青 9g，野荞麦根 30g 以控制之，疗效更有提高。

对支气管哮喘久咳不已，纳食衰少，食后作胀而喘更甚，陈氏认为这是“肺咳不已则胃受之”，在处方中常加橘白 4.5g。陈氏认为现药店只有橘皮，而不分橘红、橘白，实则这两者作用不同，橘红用作化痰，橘白则以和胃为主，不要混用。

对哮喘的预防，他主张用河车粉长服。因哮喘大多自幼发病，先天不足，如能在儿童期持续服用河车粉 3g，每日 2 次，至发育时即可停止发作，若错过这一时期，哮喘常缠绵难愈。

陈氏之子陈泽霖认为支气管哮喘发作期只要解除支气

管痉挛，使痰能咯出，即可缓解。在上述方中常加枳实 9g，紫菀 9g，以助痰液排出。白芥子对痰咯不爽者有较好疗效。若属热痰胶结，则用淡竹沥 10ml 冲服，可使痰液稀释，易于咯出。另用洋金花少许卷成烟抽，对临床解除发作也有一定疗效，但不宜长用。对顽固哮喘，诸药不效，呼吸困难，痰涎壅盛，似欲窒息者，可用猴枣散一瓶，即可吐出痰液，有急救之功。

对哮喘的预防，凡中秋节前后发作者，宜在 8 月份即开始服药，以往曾用生地 15g，熟地 15g，山茱萸 4.5g，山药 9g，菟丝子 12g，灵芝草 9g，巴戟天 9g，以此制成浓缩煎剂，1 剂药可服 3 天，每次服 20ml，每日 3 次，也可制成丸药服用，效果尚可。另用芥子饼在三伏天敷贴肺俞穴，处方组成为白芥子、甘遂、延胡索，共研细末，用生姜捣汁做成药饼外敷，每周敷 2 天，也有一定预防作用。^[33]

32. 董秀芝诊治经验

①和解少阳，疏肝调肺：人体气机的升降出入，虽然是诸多脏腑功能的反映，但是其中肝胆的疏泄功能尤其重要，因为少阳胆经主枢，是上中下三焦气机升降的枢纽，枢纽不利，直接影响肺气的宣发肃降，出现哮喘。临床常见的哮喘患者，除具有咳嗽、气喘等症状外，往往兼具胸胁胀满、口苦咽干，或二便不利等少阳证候。董氏治疗哮喘的方法之一为和解少阳，疏肝肃肺。方选小柴胡汤加桔梗、枳壳、郁金、瓜蒌等。小柴胡汤是疏利三焦的主方，能使“上焦得通，津液得下，胃气因和，汗出而解也。”桔梗为肺经气分药，苦辛性平，善于宣开，提升肺气，宽胸快膈，祛痰止喘而排脓，为诸药之舟楫，可载药上浮；枳壳苦微寒，具苦降下行之功，疏肝理气，宽中除胀满，消

心下痞闷，泄中焦气滞，两药合用，宣肺降气，有利于肺之功能的恢复；郁金疏肝解郁，条达气机；瓜蒌清热化痰，宽胸理气。诸药合用，共达和解少阳、疏肝肃肺之功。

②培土生金，健脾化痰：脏腑功能失调是化生痰浊的病理基础，痰阻气机、升降失常是哮喘发病的主要病机。脾与肺共同主宰机体气的生成与津液的输布，脾虚则运化失职，水液集聚生痰，痰浊阻肺，肺失宣肃而致气喘痰鸣，故有“脾为生痰之源，肺为贮痰之器”之说，董氏认为，哮喘病人多有脾虚肺弱之象，而肺为脾之子，脾为后天之本，肺虚卫外不固多与脾胃失调、生化乏用有关。内伤脾胃，百病由生。善治病者，唯在调和脾胃。方选四君子汤合三子养亲汤以培土生金、健脾化痰治疗。四君子汤益气补中、健脾养胃，三子养亲汤主治中虚运化失常、湿聚成痰之证。二方合用使体内水湿水谷运化正常，而消生痰之源，脾气健以养肺气，使肺之宣降功能得以恢复，既治已成之痰，又除生痰之源，而达标本兼治之功。

③补益肺气，扶正固表：哮喘发作一由肺胃先有伏热，后感风寒诱发；二由风寒客于上焦，久则化热伤肺。二者均与外感风寒有密切关系。肺为清肃之脏，主一身之气，肺虚则不能主气，腠理不密，卫外不固，易于感受外来之邪，邪乘于肺，而肺失宣降，气不化津，聚而为痰，痰塞气逆，而致哮喘发作。患者平素怯寒多汗，发作前鼻塞、喷嚏、流涕；发作时呼吸浅促，面色苍白，喉间声嘶，语音低弱。董氏用补益肺气、扶正固表法治疗，用补肺汤加减化裁。药用党参、黄芪、紫菀、桑白皮益气肃肺；熟地黄、五味子益肾固元。同时酌配宣降之品，如麻黄、桔梗、苏子、杏仁等，使补而不滞，敛而不涩，宣中有降，降中有宣，肺气出入有常。若肺之气阴两伤，咽干口燥、便秘

者，加沙参、乌梅、天冬以滋阴润肺；若表虚自汗者，加玉屏风散益气固表。总之，补益肺气、扶正固表法，为治疗哮喘行之有效的的重要方法之一。

④温肾纳气，治病求本：肾为先天之本，主纳气，为气之根，呼气在肺，吸气在肾。故有“肺为气之主，肾为气之根”、“气出于肺而根于肾”之说。顽固性、反复发作性哮喘，久病已虚，穷必及肾，患者常表现为咳嗽吐痰、动则气喘、畏寒肢冷、头晕心悸、耳鸣、腰酸等本虚标实之象。董氏在治疗过程中注重温肾纳气，治病求本。常用六味地黄丸合麻黄附子细辛汤加减化裁，六味地黄丸补肾阴，附子、肉桂温肾阳，使阳归于阴，肾气得以固藏，则喘息自平。麻黄、杏仁、桔梗、枳壳、葶苈子宣降并用，使补中有散，敛中有宣。细辛温肺化饮，既能助麻黄以宣肺，又能助附子以温阳。若咽干口燥、喘促面赤者为肾阴偏虚不能敛阳，可加五味子、白芍等滋阴纳气。总之，久病及肾、久病必虚，温肾纳气为治疗反复发作性哮喘的治病求本之法。^[34]

33. 许济群诊治经验

①发时不囿于标：哮喘为病，缠绵难愈，常反复发作，病史少则10多年，多则30~40年。对反复发作的病人来说，发时既有外邪客肺、痰阻气机之实证，同时又有肺脾不足，尤其是肺气不足之本虚表现。许氏立足于祛痰利气攻邪，或散其风，或温其寒，或清其痰热；对肺脾肾三脏兼有虚象者，益肺补脾纳肾，兼扶其正，尤其是从“发久者，气无不虚”（《景岳全书》）的病机出发，方中加入补气药或补气阴药，如黄芪、太子参、玉竹之类。对临床表现为发作时汗出过多，没有明显热象者，均酌用之，可以达

到扶正祛邪、虚实兼顾的目的，而无壅邪之弊。哮喘反复发作，或发作日久而一般药效果不明显者，用此法，甚为满意。

如治周某，女，42岁，1994年4月28日初诊。诉曾因油漆喷雾引起咳嗽、气喘，以后经常发作。2个月前哮喘大作，咯吐白粘痰，伴咽痒，胸闷，两肺满布哮鸣音。予青霉素、地塞米松静滴，口服氨茶碱、输氧等1周，症状部分控制。其后仍时有哮喘，并胸闷、气短。其间明显发作3次，均以激素、抗生素、扩张气管药及中药宣肺平喘等治疗部分缓解。4月27日哮喘大发作，哮喘痰鸣，紫绀，心率120次/分，予地塞米松、氨茶碱静滴，输氧，症状未能完全控制。第2日症状明显加重，诊见患者面色苍白，紫绀，气短，喘息不已，张口抬肩，呈三凹征，呼吸频数，咳嗽，咯吐白粘痰，伴见头面汗出。听诊心率120次/分，两肺呼吸音轻。舌质淡胖，苔薄白微腻，脉细数。证属痰浊阻肺，肺失肃降，正虚不能纳气。治以扶助正气，利气化痰。处方：黄芪20g，太子参12g，葶苈子10g，苏子10g，炙麻黄4g，细辛3g，五味子8g，制半夏10g，陈皮6g，鱼腥草15g，佛耳草10g，地龙10g，乌梅8g，丹参15g。服上方2剂后喘即渐减，胸憋气喘大为改善。听诊肺部哮鸣音（+），仍感纳气无力。上方继用，加砂仁4g。7剂，喘平，偶尔咽痒，咯少量痰。曾接触油漆，未致再作。予健脾化痰以善其后。随访5个月喘未再发。

本例患者哮喘缠绵2个月，来诊时，证见哮喘伴冷汗量多，面色苍白，舌质淡胖，苔薄白微腻，脉细数，故以黄芪、太子参扶助正气，炙麻黄、制半夏、五味子、细辛取小青龙之意，化痰利气平喘；葶苈子、苏子降气泻肺，乌梅与五味子收耗散之肺气。并用鱼腥草、佛耳草、地龙

助清肺化痰平喘，全方配伍得当，故收到显著疗效。

②痰壅攻逐为先：痰饮壅肺型哮喘，临床颇为多见，张子和云：“痰即是病也，痰去则病去。”许氏认为由于痰饮之邪其性粘滞，易于胶固凝着，造成重疾，而一般化痰药难以一时奏效，攻逐痰饮是急则治标之法，对痰饮实证效果尤好，使有形之痰饮得以祛除，积者下，逆者降。张景岳云：“实痰者何？谓元气犹实也”（《景岳全书》）。临证所见，患者大多形体壮实，哮喘如吼，呼吸急促，咳嗽声浊，咯痰量多，痰色白粘或白浊。或痰凝胶粘，不易咯出，只闻喉中痰鸣，兼见胸满闷，或有泛恶。舌质胖，苔白腻，脉滑或沉滑。许氏攻逐痰饮喜用控涎丹，改为胶囊剂型，早晨空腹枣汤送服 0.6~1g，连服 2~3 天，其后辅用健脾化痰方药，以绝生痰之源。

如治祁某，男，56 岁，1983 年 3 月 27 日初诊。哮喘迄今 6 年余，近 1 年加重呈季节性发作，3~9 月份哮喘持续不断。有明确过敏史，哮喘前有打喷嚏、咽痒、咳嗽等预兆。本次就诊时哮喘已作月余，虽用舒喘灵等，但未能控制，一旦停用，即哮喘大作。诊见：喉中痰鸣如拽锯，咳嗽，胸闷如窒，痰灰暗成块状，量多难咯。舌胖略红，苔白厚腻，脉滑。检查：桶状胸，听诊两肺哮喘音（+++），心率 90 次/分，律齐。周围血白细胞在正常范围，X 线提示轻度肺气肿，皮肤试验副交感神经反应（+）。诊断为外源性支气管哮喘，证属痰饮壅肺，肺失肃降。治以攻痰逐饮平喘，处方：控涎丹 0.9g，每日 1 次，清晨枣汤送服，服用 3 天。利气化痰方：苏子 10g，白芥子 8g，制半夏 10g，陈皮 6g，桔梗 10g，甘草 4g，鱼腥草 15g，4 剂。于控涎丹服完后服。服药后略感腹痛，泻稀大便，日 2~3 次，后泻之物似痰状。咽中痰也松动，易于咯出。每日约

咯出 300ml 左右，痰出后胸闷顿舒，舒喘灵停用，喘势大减。予上方继用。9 剂后，喘已渐平，听诊呼吸音粗糙，未闻及干湿啰音及哮鸣音。处方转以健脾化痰巩固之。随访 1 年，哮喘未有明显发作。

本例痰饮壅肺致反复哮喘者，乃因痰饮未能祛除，哮喘不易控制，一般化痰难以取得捷效。选用攻逐峻剂控涎丹，方中甘遂、大戟攻逐水饮，并以白芥子搜剔一切痰结。全力专效宏，能入邪气痰饮互结之处而攻之，有形之邪得以祛除，宣畅壅塞之肺气，开上焦之闭郁，邪去而正安。再以健脾化痰以绝生痰之源。经实验观察，控涎丹具有抗炎、平喘、排痰的作用，为临床提供了客观依据。

③内治外治并举：哮之一证，古人专主痰，《陈修园医书》中谓：“痰窠结于肺膜”，气为痰阻。《喻嘉言医案》中说：“窠囊之中，痰不易除，即肺之外，膜原之间，顽痰胶结多年，如树之有罗，如屋之有游，如石之有苔，托附相安”。独行内治，常难以“断其浊痰之根株。”任行驱导涤涌，徒伤他脏。许氏以内治、外治并举，利用外治法，使药力入经络，循经隧，直达病所，取效甚佳。外治之法，古人多用于三伏天，取冬病夏治之意。许氏根据临床诊疗近万人次之经验，认为组方适宜的定喘膏能攻逐内伏之痰饮，可于哮喘正发时迅速平喘。外治选用穴位以背俞穴为主，常用肺俞、膈俞、定喘，以及天突等穴。5~7 天贴敷 1 次，每次 12~24h。

如治胡某，男，60 岁，1992 年 1 月 3 日初诊。哮喘史 10 余年，有轻微肺气肿，1982 年曾患右肺中叶肺不张，10 年来喘息性支气管炎伴感染反复发作。目前咳喘持续 10 余日，入夜不能平卧，端坐呼吸，喉中哮鸣有声，痰多不易咯出，每夜痰量约 100~200ml，呈白沫状，口干，乏力，

一般活动受限，动则喘甚。诊见：形体消瘦，紫绀，呼吸急促，听诊两肺哮鸣音（+++），右肺中叶呼吸音低。舌质黯红，中有裂纹，苔少，脉细，证属痰气交阻，肺阴不足。治疗：定喘膏，取穴肺俞、定喘、膈俞、天突，以润肺清化拟方：北沙参 12g，苏子 10g，葶苈子 10g，黄芩 5g，瓜蒌皮 12g，黛蛤散（包）10g，桔梗 10g，甘草 4g，鱼腥草 15g，白毛夏枯草 15g，桃仁 10g，冬瓜子 10g，制半夏 10g，5 剂。于贴药第 2 天服用。用上方后症状缓解，但夜间仍有短时间喉中哮鸣，气短，口干。听诊未闻及哮鸣音及干湿啰音，舌脉如前。继用定喘膏，取穴同前。内服方去冬瓜子，加南沙参 10g，麦冬 10g，炙桑白皮 10g。5 剂后，诸证明显缓解，痰量亦明显减少，胸部舒畅，寐安，纳佳，精神愉悦，唯口仍干，舌质有裂纹，脉滑。定喘膏取穴同前，以养阴润肺兼以化痰辅之。处方：南沙参 10g，北沙参 10g，瓜蒌 12g，玉竹 10g，川贝 5g，葶苈子 10g，麦冬 10g，制半夏 10g，鱼腥草 15g，桔梗 10g。5 剂，于贴药后 24h 服用。其后病情稳定，哮喘未发作。

本例内治与外治共用，平喘之功显著。定喘膏由麝香、甘遂等组成，麝香走窜经络，辛散宣通，利气豁痰，甘遂攻逐痰浊水饮，共奏利气逐痰平喘之功。对痰闭致喘尤为适宜。选穴以背俞穴为主，一身阳经均集中于背部，对祛逐痰浊阴邪功效甚佳。痰多难咯者，加用天突穴。外治之理，亦内治之理，但药力循经入络显然比内服更为快捷。内外治疗合用，作用相得益彰。

④标本兼顾三焦：哮喘久发不已，肺虚必累及脾肾。脾为生痰之源，肺为贮痰之器，痰恋不化，气机阻滞，一触风寒，喘即举发。临床所见哮喘患者未发之时，也常有怕冷，表虚汗出，脉偏细数，有时出现花剥苔。《王旭高医

案》中谓：“此有下焦阴虚，中焦痰盛，上焦肺弱。肺弱故畏寒，阴虚则脉数，喘之频发，痰之盛也有所感触，病遂发焉。”许氏认为病有三层，治需兼顾，在上治肺胃，在下治脾肾，若欲除根，必坚持标本兼顾，否则单纯以补一脏而概其全，恐难奏效。

如治某女，7岁，1993年11月8日初诊。咳喘反复发作3年，感寒、食凉物即易引发。诊见咳嗽，痰鸣，喉中如有水鸡声，形体消瘦，面色苍白，喘作伴汗出。听诊两肺哮鸣音（+++）。心率98次/分。舌质淡红，苔黄微腻中间光剥2块。治以定喘膏外敷，辅以清化拟方。二诊症状明显缓解，肺部未闻及哮鸣音。11月31日来诊，主诉因饮食不调，外受寒凉，哮喘又作。复以上法施治，复诊2次，病情稳定，舌质略红，苔仍花剥。转以扶正为主，养阴益气，和胃化痰：南沙参10g，北沙参10g，麦冬10g，黄精10g，太子参10g，黄芪15g，玉竹12g，乌梅8g，砂仁4g，炒六曲10g，白术10g，制半夏10g，桔梗10g，甘草4g，鱼腥草15g。1剂量服用2日，每日2次服。半月后，胃纳、虚汗均明显改善，再进7剂。冬春季患儿未再发病，体重增加，面色红润。

本例患者，哮喘常作，乃表虚不固，脾虚痰盛，故方用养阴益气，和胃化痰，乃治本之法。方中黄芪、太子参益气固表，麦冬、玉竹、黄精滋阴以培肾元，砂仁、白术、六神曲和胃，制半夏、鱼腥草、桔梗共化留伏之痰饮，更伍乌梅敛肺气。全方配伍得当，临床治疗数十例，收效显著。^[35]

34. 沈自尹诊治经验

①宣肺治喘：哮喘引发是由于外邪犯肺，肺失肃肃，

痰恋于肺，肺气闭合，气机阻滞之故。现代医学认为，哮喘是一种气道慢性炎症性疾病，由于气道粘膜上皮组织中大量炎性细胞浸润，上皮纤毛细胞受损、坏死，或基底膜免疫球蛋白沉积增厚形成伪层，或大量炎性渗出造成气道粘膜水肿、充血及渗出物形成粘液栓，或粘液下腺体增生等原因，导致气道通气障碍。对其治疗，中医采用宣肺化痰平喘之法，西医采用抗菌消炎解痉之法，沈氏根据中、西医对哮喘发病机理认识，认为哮喘主要发病环节在“气道不畅”，痰液需要排出，而解决气道通气功能是治喘关键所在。因此提出，凡管道形态发生病变，其治疗原则以通为顺，用疏通方法，肺气开，方能降。治喘先开肺，肺开喘自息。宣肺气包含两个含义：一则调节平滑肌收缩与舒张，增强呼吸肌的调节功能从而改善气道通气效应；二则清除管道障碍物，控制炎症细胞浸润，消除水肿，引流痰液，保持管道畅通。在哮喘发作期间，以实证为多见，故不论由过敏之故，还是感染之因，治疗原则均应“宣肺”，宣肺可使邪气及痰液外达不致收闭于内。现代药理证实，一些宣肺平喘药物如麻黄、前胡等药有调节平滑肌收缩与舒张功能，从而改善气道的通气效应。常用的宣肺方药有麻黄汤、三拗汤、小青龙汤、麻杏石甘汤等方。如见痰黄粘稠者，表明患者肺部感染有炎症、热证，故常配以清热解毒药物。采用清热解毒药物，目的在于减轻气道炎症，消除管壁肿胀，减少分泌物渗出，缓解或防止气道狭窄，从而清除管道障碍物，使气道保持通畅无阻，改善通气功能。常用清热解毒药物有鱼腥草、野荞麦根、九头狮子草（四季青）等品。

②补肾防喘：预防支气管哮喘复发是治疗哮喘病重要环节。以往认为支气管平滑肌的痉挛是引起哮喘不断复发

的病理基础，而现在认为气道变应性炎症更为重要。对于哮喘防治，历代医家有“治喘咳不离于肺，不只于肺”和“发时治肺，平时治肾”之说。在哮喘缓解期西医采用脱敏疗法、激素消炎、酮替芬拮抗组胺受体、色甘酸二钠保护细胞膜稳定性等方法，虽有一定疗效，但尚欠理想。在长期临床研究中沈氏发现，大多数哮喘患者表现为本虚标实，且70%患者有肾虚征象，同时发现有肾虚或无肾虚哮喘患者下丘脑—垂体—肾上腺皮质功能均有不同程度低下改变，使得气道慢性变应性炎症不易消退。前者较后者为重，肾阳虚者更为显著，若用补肾法能改善下丘脑—垂体—肾上腺皮质功能不足。由于无肾虚哮喘患者也存在潜在性肾上腺皮质功能不足，肾阳虚哮喘患者的下丘脑—垂体—肾上腺皮质功能不足的现象更为显著，而温补肾阳法有调节下丘脑—垂体—肾上腺皮质功能效应，可改善哮喘的发作。经远期观察，温补肾阳方药能提高T抑制细胞功能，抑制血清IgE季节性升高、降低组胺释放率，能有效调节下丘脑—垂体—肾上腺皮质功能，因而可以改善气道变应性炎症。

③辨病辨证相结合：对于支气管哮喘诊断与辨证要点，沈氏认为，首先是鉴别过敏性哮喘还是感染性哮喘。一般来说，过敏性哮喘常与气候变化有关，疾病易反复；感染性哮喘常与上呼吸道反复感染有关。然后辨虚实，如由外因诱发兼有表证，如痰多、发热，在发作期为实证，缓解期为虚证。再辨寒、热，如痰多清稀如沫、怕冷等为寒证，临床以过敏性哮喘为多见；如每由感冒诱发痰黄粘稠、口干等症，为热证，临床以感染性哮喘或过敏性哮喘继发感染者为多见。

过敏性哮喘常见于春5月、秋10月，其临床特征犹如

风之性，善行数变，故在治疗原则上，发作期以宣肺为主，加大祛风力度，配以徐长卿、苍耳草等。现代药理证实，上两味药具抗过敏作用。缓解期则用补肾加祛风抗过敏药调之，常用中成药补肾防喘片加藿胆丸，小儿用六味地黄丸加藿胆丸。感染性支气管哮喘临床以黄粘稠痰为特征，热证为多见，故发作期除宣肺外，加大清热解毒用量，配以鱼腥草、野荞麦根、四季青、虎杖之品，达到控制感染目的。缓解期仍以补肾调之，以防复发。

哮喘在发作期间，痰液壅滞之时，切忌用镇咳药物，以免抑遏肺气闭门留寇。此时，需要用理气之品一枳实来协助痰液排出。现代药理研究证实，枳实能帮助平滑肌恢复张力，加强平滑肌收缩功能。但用量不宜过大，以免耗伤正气。^[36]

35. 胡国俊诊治经验

胡氏认为，支气管哮喘虽好发于严寒隆冬，但仅在夏季发病者亦复不少。胡氏于长期的诊治中，发现哮喘只发夏季者常有如下三型，若能晓其机理，窥其症结，对控制病情将起积极作用。兹将其哮喘夏季发病辨治体会介绍如下。

①肺蕴痰火，遇热辄发：哮喘患者，痰饮为其夙根，已为古今医家所共识，其中寒痰冷饮为夙根之主体。但随着时间的变化，人们生活水准的提高，加之气候渐暖之温室效应，及甘温辛热之滥补误治，积弊经久，由寒痰转为热痰者已屡见不鲜。此类患者但发夏日，而冬季反而无恙。考肺蕴痰热之患，一遇暑热交蒸之季，即感胸膈憋闷，气息不匀，喘促痰鸣随之而发。此阳逢阳旺，痰火肆虐，夏日即发之理也。患者大多躯体肥胖，体质不衰。所见之症

有面色晦滞，唇色紫绀，舌暗红，苔黄腻，脉浮滑有力、两寸独显。此痰火搏击，气道被壅，若不化痰泻火，畅达气道，非其治也。拟葶苈大枣泻肺汤、泻白散、唐氏豁痰丸化裁，药用：葶苈子、鲜竹沥、桑白皮、全瓜蒌、鱼腥草、黄芩、枳实、射干、桔梗、败酱草等，若大便秘结者加大黄、芒硝。方中葶苈子泻热决壅、下气定喘，鲜竹沥荡痰热之窠臼，开痰涎之壅塞，为此证不可缺少之品，病情缓解后，小其量而用，或佐以生脉散类药以补益被痰火耗伤之气阴，对症状缓解后的形体修复、巩固疗效，可起十分重要的作用。

如治张某，男，36岁，1996年6月8日初诊。入夏即罹哮喘，直至深秋方愈，已达4年。此次又发半月，胸闷气憋，喘促不已，痰少质稠粘色白，难以咯出，夜难入寐，面色紫绀，额汗淋漓。纳可，便结尿黄，两肺满布哮鸣音，舌暗红，苔黄腻浊厚，脉浮滑。此痰热蕴肺，肺失宣肃，入夏之季则内外交蒸，粘稠痰浊阻遏气道。亟拟清泻，佐以宣达，冀痰消热清，治节复司而哮喘能平。处方：葶苈子30g，鲜竹沥40ml（分2次冲服），桑白皮10g，桃仁10g，枳壳10g，全瓜蒌30g，大黄10g，芦根30g，地龙10g，黄芩10g，青礞石20g，泽泻20g，竹茹10g。3剂后大便畅通，痰易外排，哮喘锐减，夜能平卧，他症亦随之缓解。二诊时浊腻之苔退之过半，暗红之舌也转淡红，两脉浮细滑数，此痰热清解，而气阴有待充复。遂以上方去泽泻、青礞石，葶苈子减为10g，加石斛15g，麦冬10g，南沙参20g，百合10g，5剂而安。并嘱其经常调治，以杜后患，一夏无恙。随访2年，夏季虽有小犯，服药则安。

②阳热宣泄，更耗气阴：气虚阴伤之人，大多形体清瘦，虽不耐严寒，但也更畏暑热。以其气虚肺弱，卫外不

固，津难敷布；营阴亏虚，虚火内生，液炼为痰。其不足之体加之内凝之痰，实已为哮喘发作埋下了祸根。寻常之时，气息尚平，不足之肺金尚能吐纳自如。寒冬之季，自知体弱而将息谨慎，除自觉保暖避寒外，腠为冷密，火为寒减，入冬之日反觉舒泰，故哮喘少发。然一至暑夏阳热宣泄之季，不固之表，汗常自泄，不足之阴，为之更伤，虚火有加，蚕食其气，本虚之气为之更耗。肺之气阴进一步伤耗后，其治节乏权，宣肃不能，凝聚之痰稠粘交结，闭阻气道，喘哮痰鸣遂作。此症大多形体不丰（也有久服激素而见虚胖之体者），面颊白、或淡红，唇舌淡红乏津，口干不欲饮，痰或黄或白、量少难排，多汗乏力，气不足息，纳差，手心灼热，苔薄黄，脉虚细数、或浮滑无力。治当补益气阴，清化痰热，用生脉散、苇茎汤、新制清肺饮化裁。药用：南沙参、北沙参、太子参、西洋参、五味子、仙鹤草、麦冬、百合、山药、甘草、薏苡仁、冬瓜仁、玄参、枇杷叶、瓜蒌皮、知母、石斛、海蜃皮、地栗等。其中生脉散益气阴不热不腻，苇茎汤化痰热不寒不燥，甚合此型病机。若肺肾两虚者，宜麦味地黄汤，或七味都气丸合生脉散增损亦佳。如痰热较甚时，小量葶苈子、鲜竹沥亦可随症加入。

如治沈某，女，34岁，1994年6月20日诊。哮喘反复发作，寒冬无恙，入夏即发已有3年。且随气温增高而症状加重，直至秋凉方解。此次发作20余日，治之乏效。患者形体消瘦，语声低微，胸闷气短不足以息，行走登楼则喘促不已，痰多质稀，偶夹稠痰，难以外排。严重时彻夜无以入睡，纳差神疲，口干不喜饮，两肺哮鸣音满布，腰膝酸软，带下淋漓，舌淡嫩红，苔薄白微黄乏津，脉虚细数。此气阴不足，肺肾两虚，不布之津凝炼为痰，交暑

热开泄之令，愈耗其气阴，致痰浊无力外排，阻碍气机之出入而哮喘作矣。治当益气阴以扶正托邪，化痰热。处方：南沙参 30g，麦冬 10g，五味子 6g，仙鹤草 20g，太子参 10g，山药 15g，黄精 10g，川贝 10g，芦根 20g，薏苡仁 20g，海蜇皮 30g，冬瓜仁 30g，瓜蒌皮 10g，西洋参 10g（另炖冲），冬虫夏草 3g（研末吞）。5 剂后神健力加，夜寐稍安，排痰甚多，哮喘锐减。继予上方出入 20 余剂即安。

③贪凉饮冷，诱发宿恙：炎夏之日，虽以暑热之邪为主，但风冷之邪亦或时客。哮喘之疾虽有夏日无恙者，但突遭寒邪之袭，或冷饮之侵，卫表郁闭，肺气不宣，肺卫之症即作，若再触及夙根者，喘促痰鸣无不焕发。故辛温解表宣肺以撤风寒客邪为其急务，迟疑失表则邪恋胶着，哮喘之症有增无减，三拗汤为最佳之方选，虽暑夏之季麻黄也在所不忌。此时若失于疏表宣肺，或专投纳气平喘镇咳等方，无异闭门逐寇。若兼肺内伏热者，加生石膏、黄芩、桑白皮、地骨皮，以外解表寒内清伏热；若有饮邪内伏者，加干姜、桂枝、细辛、芫花、茯苓等，以外散风寒内蠲水饮；若肾阳虚惫、下元不足者，合金匱肾气丸，或阳和汤化裁，以上宣肺气下填肾精。

如治李某，男，16 岁，1998 年 5 月 30 日初诊。哮喘半月，治之少效，宿有哮喘病史 6 年，冬日无恙，春夏之交辄发。咽痒微咳，胸膈憋闷，微恶风冷，两肺满布痰鸣之声，心悸不宁，难以平卧，痰多清涎，口淡乏味，舌淡润、苔薄白滑，脉浮滑。检阅所服之方，除西药消炎平喘解痉外，中药则非平喘镇咳化痰，即两补肺肾之参蚘制剂。半月来症状有增无减，审其原委，方知半月前因冒雨涉水感受风寒潮湿，肺卫同病，诱发宿恙。即病后失于疏表，反投镇敛补涩之剂，致使哮喘之症逐日加重。所幸表邪尚

存，正气尚有抗争之力，治当因势利导，亟予辛开宣透以撤客袭肺卫之邪。处方：麻黄 10g，杏仁 10g，细辛 6g，旋覆梗 10g，僵蚕 10g，猪牙皂 3g，苏子 10g，苏叶 10g，生姜 4 片，甘草 6g。1 剂后咳减喘平，痰鸣显减。3 剂服完诸症悉平。继予上方减麻黄为 6g，去猪牙皂、生姜、苏子叶，加桂枝 10g，茯苓 15g，干姜 6g，炒白术 10g，姜半夏 10g，橘红 10g，砂仁 6g，党参 10g，7 剂，作善后巩固之用。^[37]

36. 王有奎诊治经验

王氏从事呼吸系统疾病的研究治疗 20 余年，采用自拟哮喘汤加减治疗支气管哮喘，取得了显著疗效。现结合临床治验，将哮喘汤治疗哮喘的经验介绍如下。

哮喘汤组成：桑白皮 12g，苏子 12g，冬瓜子 24g，炙麻黄 9g，杏仁 12g，地龙 18g，熟地 18g，党参 18g。方中桑白皮、炙麻黄、杏仁宣降肺气；冬瓜子、地龙利痰解痉；熟地、党参补肺健脾益肾。治疗中可随证加减：有热或在夏季发作者加石膏；便秘加瓜蒌；咳嗽加款冬花、百部；经常感冒者加黄芪、防风；每因郁怒而导致哮喘发作者去党参、熟地，加香附、白芍、枳壳、沉香；兼食后腹胀，不欲饮食者加陈皮、半夏、白术等。

如治梁某某，女，16 岁，1988 年 7 月 24 日初诊。患支气管哮喘 8 年余。自幼体弱，每因遇热则感冒，且常引发哮喘，近日胸憋、气喘明显加重，伴食欲不振，倦怠无力，舌淡、苔白，脉数。就诊前每日口服氨茶碱、异丙嗪、地塞米松各 2 片，每日 3 次维持治疗。治予哮喘汤加减治疗。处方：炙麻黄 10g，生石膏 24g，杏仁 12g，甘草 9g，桑白皮 12g，熟地 18g，苏子 18g，莱菔子 15g，党参 24g，

陈皮 12g, 半夏 12g, 每日 1 剂, 水煎服, 并嘱停服西药。7 月 27 日二诊: 服药 3 剂, 并遵嘱停服西药, 哮喘未再发作, 现仍感食欲不振, 倦怠无力, 手足心热。上方继服 3 剂, 服药后精神明显好转, 食欲增强, 唯仍感手足心热。上方加地骨皮 30g, 黄芪 18g, 继服以巩固疗效。

该患者虽无典型的肾气虚表现, 但自幼即喘达 8 年之久, 且遇热而发, 故治疗时除宣降肺气以平喘外, 还须加用石膏清热, 佐以补脾肾之品方能取效。

又如治赵某某, 男, 29 岁, 1992 年 9 月 21 日初诊。患者自幼体弱, 素易感冒, 每因感冒或过劳而引发支气管哮喘, 近 1 年哮喘发作频繁, 伴咳嗽, 痰多不利, 夜间胸憋而喘, 并伴有腰背酸困, 舌苔薄白, 脉数。哮喘汤加減: 桑白皮 15g, 苏子 18g, 天花粉 30g, 冬瓜子 30g, 杏仁 15g, 地龙 18g, 甘草 10g, 炙麻黄 10g, 紫菀 15g, 党参 24g, 黄芪 30g, 防风 9g, 熟地 21g, 山药 15g。每日 1 剂, 水煎服。9 月 29 日二诊: 服药 6 剂咳嗽好转, 痰量减少, 劳累后仍喘。上方加狗脊 30g, 款冬花 12g, 继服 6 剂。服药后哮喘未发作, 嘱原方继服巩固疗效。1 年后随访哮喘未复发。

该患者自幼体弱, 每因感冒或过劳即引发哮喘, 近 1 年发作频繁, 伴咳嗽, 痰多不利, 胸憋而喘, 腰痛酸困。故治疗时除以基本方宣降肺气, 兼补肺脾肾外, 更加祛痰止咳的紫菀、款冬花和补肺固表的黄芪、防风, 哮喘并治, 标本兼顾, 最终哮喘得到控制。

又如治张某某, 女, 25 岁, 1996 年 9 月 10 日初诊。患支气管哮喘 16 年, 一年四季皆喘, 每因恼怒即引发或加重。现症: 喘促, 不咳, 无痰, 胸憋, 咽干, 腰困, 食纳尚可, 二便正常。本次发作亦因恼怒诱发。药用哮喘汤加

味，佐舒肝理气之品：桑白皮 15g，炙麻黄 9g，杏仁 15g，甘草 10g，地龙 18g，熟地 18g，山药 12g，香附 15g，枳壳 15g，沉香 6g，射干 18g，白芍 18g，每日 1 剂，水煎服。9 月 14 日二诊：胸憋显效，腰困、哮喘明显减轻，自觉气短不足以息。上方加党参 24g，继服 3 剂。哮喘未发作，腰困止，仍感咽干，口干欲饮。上方去沉香、香附、白芍，加麦冬 24g，天花粉 30g，继服。

该例的特点是哮喘发作与情绪有关，每因恼怒则引发，伴有胸中憋闷之症，属木反侮金，肺失宣肃之证，故治以哮喘汤加味，宣降肺气，兼舒肝理气而获效。

又如治张某某，男，47 岁；1989 年 9 月 4 日初诊。患发作性气喘，伴喉中痰鸣 13 年。患者于 1976 年夏季因劳累、潮湿引发哮喘，间断发作，以夏季多发。现症：咳嗽，痰多，胸憋不能平卧，每于夜间突发气喘，胸憋伴喉中痰鸣，经用西药止喘剂及休息可缓解。纳差，腹胀，大便秘结，苔薄白，脉缓。处方：桑白皮 12g，苏子 18g，炙麻黄 9g，杏仁 15g，党参 18g，陈皮 12g，半夏 12g，厚朴 12g，紫菀 12g，白术 9g，枳实 12g，代赭石 21g。每日 1 剂，水煎服。9 月 7 日二诊：服 3 剂后哮喘明显好转，胸憋、咳嗽减轻，大便已不干，仍感痰多而凉。上方去厚朴，加熟地 21g，山药 18g，干姜 10g。继服 3 剂后，哮喘基本控制，痰量减少，无凉感，继服上方巩固疗效。

该例症见胸憋，胃腹胀满，食欲不振，大便秘结，痰多而凉，属脾肺气虚，虚中挟实，故在哮喘汤的基础上加陈皮、半夏、白术、枳实、代赭石等健脾通便药而愈。

王氏认为，哮喘一病，若非持续严重发作，一般无生命危险之虞。但因患者常感胸憋，喘息，气短难续，痛苦不堪，严重影响生活、工作质量。传统认为哮喘的形成是

由于“宿痰内伏于肺”所致，对哮喘的治疗主张以祛痰平喘为主，但往往难以奏效。据王氏多年临证体会，本病的发生主要是由于肺、脾、肾气虚，尤以肺宣通肃降的功能失常所致，采取宣降肺气为主，配合调补脾肾药物进行治疗，疗效较为满意。从以上4则病例中可以看出，虽然其病程有长短，临床表现及诱发因素各有不同，但具有共性表现，即肺、脾、肾虚，肺失宣肃，4例患者均以哮灵汤为基础方，随症加减进行治疗而获效。^[38]

37. 孙恩泽诊治经验

孙氏对支气管哮喘的治疗具有丰富的经验和独到的见解，兹介绍如下：

①首要治肺，须分寒热：哮喘的主要原因是“伏痰”为患。哮喘的临床症状除呼吸急促外，其特征为喉间有哮喘鸣、胸闷、咯痰不爽等现象。哮喘复发必有诱因，每因外邪触动内饮，痰阻气道，从而因痰而咳因咳而哮，为此治哮必先祛痰，祛痰首当宣肺达邪，使邪去痰消。本病发于肺，波及于脾，影响于肾，而咳嗽一症贯穿始终，故宣肺化痰为其首要，不容忽视。只有在积极改善肺功能基础上，兼及脾肾两脏之本，才能达到事半功倍之效。否则，弃肺咳于不顾，单用补益脾肾之品，不仅补益得不到应有的效果，相反肺中痰浊因补益而固涩，咳喘反见增剧，故不可不慎。

本病既为外邪触动内饮，且外邪有寒热之异，故用药有温凉之别，临证当须详辨。若为风寒之邪触动内饮，肺失宣降，治宜宣肺散寒降气化痰。药用麻黄、杏仁、苏子、葶苈子、陈皮、半夏、射干、地龙等。取其宣肃同用之意，紧扣宣肺祛邪，化痰利气两个环节。邪不外达，痰不蠲化

则咳喘难平也。若为外寒内热或痰热蕴肺之证，治宜清肺泻热，化痰定喘。药用麻黄、白果、黄芩、桑白皮、瓜蒌、大贝等。无论寒热，麻黄是宣肺平喘主药。临证体会，用麻黄治哮喘必须善为配伍：寒哮喘用桂枝、热哮喘用石膏、清肺配用桑白皮、下气配葶苈子、化痰定喘配用射干。且麻黄之辛散与地龙之咸降相配以宣肺平喘，一散一降以调节肺之开合，松弛支气管平滑肌，缓解支气管痉挛，有极好的平喘作用。

如治齐某，男，54岁，1997年11月7日诊。哮喘已反复发作3年，每逢秋冬之交，感邪后发作。近因风寒外侵，咳嗽加剧，喉中痰鸣，鼻流清涕，痰白呈泡沫状，咳吐不爽，舌质淡，苔白滑，脉浮紧。查体：T 37.4℃，P110次/分，R28次/分，双侧肺野可闻及哮鸣音。辨证为素有哮喘宿痰，风寒外袭，痰浊壅肺，肺失肃清而发生本病。治以宣肺散寒，化痰降气。处方：麻黄 20g，射干 15g，杏仁 20g，苏子 15g，葶苈子 15g，陈皮 20g，茯苓 20g，半夏 15g，枳壳 15g，紫菀 15g，地龙 20g，甘草 10g，5剂后哮喘平，咳痰已少。后仍守上方随证略有化裁，治疗2周而诸症消失。

②当顾调肝，重在理气：哮喘治疗多以肺、脾、肾三脏为着眼点，忽视了肝脏在本病发病过程中的作用；盖肝属木，肺属金，金本克木，而一旦肺金病变，则又常易受木气反侮，慢性反复的肺病患者尤其如此。或肝失调达，一身气机升降乖乱，肺失肃降；或木郁化火，火性上炎克伐肺金；或肝阴不足，下吸肾水，子盗母气，肺少清润。故临证每于一般常用治疗哮喘方法基础上，配合以清肝、疏肝、养肝之法，临床应用效果奇佳。

清肝平喘法用于肝胆火旺，木火刑金，肺失肃清之哮喘。

症见咳嗽气喘或有哮喘，头胀眩晕，目赤口苦，舌红苔黄，脉弦滑。药用瓜蒌、杏仁、桑白皮、麻黄、连翘、山栀等。

疏肝平喘法用于肝失条达，气机郁滞，肺失宣降之哮喘。症见咳喘不已或者哮喘，胁胀不舒，胸脘胀闷，苔薄白，脉弦。药用香附、郁金、苏子、枳壳、白芍、麻黄、紫菀等。

养肝平喘法用于肝阴不足，燥气上逆，咳嗽气喘之证。症见久咳不已，气急哮喘，口燥咽干，胸胁不舒，脉细数。药用沙参、杏仁、玄参、地骨皮、女贞子、麻黄、紫菀等。

如治那某，女，46岁。1998年7月20日诊。哮喘反复发作3年，每因气候变化及情志不遂而发作。静点氨茶碱及激素类不缓解，用异丙肾上腺素喷雾吸入，仅能缓解数分钟。近日因恼怒而症状加重：哮喘持续发作，入夜尤甚，呼吸急促，咳喘不已，痰少色白，汗出不已，不能平卧，胁肋不舒，纳呆暖气，舌质淡，苔白微腻，脉弦细。查体：T36.2℃，P90次/分，R30次/分，双侧肺野可闻及哮喘音。辨为肝失条达，气机郁滞，肺失宣降，治以理肺平喘，疏肝解郁。处方：柴胡20g，枳实25g，青皮20g，白果20g，麻黄15g，射干20g，地龙20g，郁金25g，龙骨25g，牡蛎25g，贝母15g，海浮石20g。服药7剂后，哮喘渐平，胸胁转舒，汗止，已能平卧，药已对症，宗法调理而愈。

③肺肾同调，固本为要：哮喘反复发作，迁延日久，由肺及肾，且痰饮内伏而宿根难除。据“呼出心与肺，吸入肾与肝”之说，对呼气困难者重点治肺，吸气困难者重点治肾。呼与吸皆困难者为肺肾同病。肺与肾为金水之脏，病则可互为因果，肺失宣降则气逆痰涌，肾不纳气则水泛为痰为饮，久之必肺肾俱病。西医提倡用激素一类平喘。

初则效如桴鼓，久则失效，且难以停药，易复发。激素类药物久用莫不伤肾，病人常有背寒畏冷、面目虚浮等特征，故治疗上宜肺肾同治，固本平喘，以元气为念，必使元气渐充，庶可望其渐愈。

如治王某，男，65岁。1996年8月12日诊。患哮喘10余年，发病不分季节，经中西医药治疗初则皆有效，久则失效。每发病必用激素类药物方能缓解。年复一年，病情日渐加重，激素用量逐年增加，尚需配伍氨茶碱等维持。近日因外感暑热而发病，用前药及抗生素仍不能缓解。见病人端坐呼吸，气短喘促，汗出，伴有微咳，痰粘白难出。虽在炎夏季节病人仍感背恶寒怕风，不欲饮食，六脉沉细而数，两尺微弱。此肺肾俱虚，伏痰由外感而诱发。施以肺肾同治，标本兼顾之法。处方：麻黄15g，白果20g，杏仁20g，葶苈子15g，地龙15g，党参25g，熟地20g，枸杞20g，生赭石20g，生龙骨20g，生牡蛎20g，甘草10g，服药4剂，哮喘逐步缓解，但于18日起哮喘又作，程度较初诊时为轻。仍用初诊方加减，3天后又缓解。此后，平时服培补脾肾方：党参20g，茯苓15g，胡桃肉20g，熟地15g，枸杞20g，山药20g，五味子10g，地龙15g，补骨脂15g，甘草10g，若感风寒风热之邪以此方加减：麻黄15g，射干20g，地龙10g，党参15g，茯苓20g，陈皮15g，胡桃肉15g，生龙骨20g，生牡蛎20g。以上2方，随机应变，交叉使用3月余，随访1年未见复发。

孙氏治疗哮喘在发作期以治标为主，以宣肺化痰为要，宣肺平喘首推麻黄，麻黄的配伍是关键。在缓解期，肺肾两虚为关键所在，应长期坚持服用补益肺肾丸散剂，以防止或减少哮喘的发作，对个别长期依赖激素控制发作者，可使激素逐渐递减以至停用。并且重视情志因素对哮喘的

影响。^[39]

38. 田玉美诊治经验

田氏认为，哮喘系内有壅塞之气，外有非时之感，膈有胶固之痰，临床可见呼吸急迫，喉中痰鸣，咳痰白粘等症。因此哮喘证以冷哮为多，用药大忌过度寒凉。因寒性凝滞，更易壅塞肺气，凝闭痰浊，而加剧病情。治以温肺散寒、祛痰理气，宣降相伍，以平哮喘，常用射干麻黄汤加蠲痰降气之品。待哮平后，或以健脾为主，以杜生痰之源；或以实肺为主，以增固表之力；或以补肾为主，以复纳气之能。其止哮常用方药为：射干 10g，炙麻黄 10g，紫菀 10g，款冬花 10g，法半夏 10g，陈皮 10g，杏仁 10g，厚朴 10g，川贝母 10g，生姜 10g，茯苓 15g，地龙 15g，五味子 6g，炙甘草 6g，细辛 5g。^[40]

39. 吕同杰诊治经验

对于哮喘的辨治，历代医家多主张发作期祛邪治标，缓解期扶正固本。对于发作期之虚，与缓解期之实的病理改变则少有重视。吕氏认为，气有盛衰，哮有虚实，实哮为气盛邪伏，痰宿于肺；虚哮则气虚痰贮，数脏并亏。发作期不同，缓解期有别。凡体强感受外邪失于表散，邪毒深入肺脏或因食生冷腥咸之物内酿成痰，上干于肺，聚敛不散者，其邪属实；而素体虚弱，将息失宜及病后失养者则易脾虚生痰贮伏于肺，此属虚邪为患。宿痰一旦形成多沉痾难解，成为各种诱因的夙根。哮喘发作期，主因与诱因往往同气相求，内外相应，伤而即发；哮喘缓解期，喘息虽停，但夙根未除，气虚者，邪退正衰，常出现肺、脾、肾亏虚的征象，而气盛者则痰降气顺，形如常人。因此缓

解期并不尽虚，发作期亦非都实。临床辨治当以详查夙因，明辨虚实，攻补皆施，力荡宿痰。

发作期治法：①温肺散寒，降气化痰。适用于风、寒、湿郁袭肺，引动寒痰之实痰冷哮证。证见：呼吸急促，喉中痰鸣有声，痰白如泡沫，胸闷憋气，面色晦滞，舌质淡、苔白滑，脉弦紧或浮紧。常用青龙三石汤加减（自拟）。处方：桂枝 9g，白芍 18g，细辛 3g，半夏 15g，干姜 9g，五味子 9g，麻黄 9g，杏仁 9g，苏子 15g，葶苈子 15g，甘草 9g，胆星 9g，皂角炭 3g，石韦 30g，鹅管石 15g，海浮石 15g，代赭石 15g。每日 1 剂，水煎服。②润肺化痰，通宣泻热。适用风、热、燥、暑等邪引动肺中内伏热痰之实痰热哮证。证见：哮喘发作，憋喘气促，喉中痰鸣，咯痰黄稠，口干咽燥，或有面赤发热，或有五心烦热，便秘尿赤，舌质红、苔黄腻，脉弦滑或滑数。常用养阴清肺汤加减（自拟）。处方：生地 30g，玄参 24g，麦冬 18g，杭芍 15g，黄芩 15g，桔梗 9g，麻黄 9g，杏仁 9g，生石膏 45g，桑白皮 24g，川贝 9g，山豆根 15g，枸杞子 30g，甘草 6g。每日 1 剂，水煎服。③固摄定喘，扶正祛邪。适用于肺虚不固，脾虚气弱，肾虚失纳，感冒则喘，遇劳则作之虚哮证。证见：喘促痰鸣，呼多吸少，胸闷气短，面色黧黑，口唇及皮肤紫绀，咯痰不爽，纳呆乏力，畏寒肢冷，自汗或盗汗，或五心烦热，舌质暗、苔白或厚腻，脉沉细弱。常用固摄纳气汤加减（自拟）。处方：熟地 30g，枸杞子 30g，附子 15g，炮姜 15g，鹅管石 30g，玄参 20g，麦冬 18g，麻黄 9g，杏仁 9g，苏子 15g，葶苈子 15g，鹿角胶 9g（烊），阿胶 9g（烊），沉香粉 3g（冲），甘草 6g。每日 1 剂，水煎服。

缓解期治法：①宣肃豁痰。适用于实哮缓解期，体强

气盛之实痰宿肺证。证见：喘息缓解，形如常人，舌质淡或红、苔白或黄，脉弦滑或滑数。常用扶夙散加减（自拟）。处方：瓜蒌、炙百部、皂角炭、黄芩、紫菀、川贝母、苏子、葶苈子、半夏、胆星、麻黄、杏仁、甘草、鹅管石、黄连、明矾。据病情适量，共研细粉水泛小丸，每次服3~5g，每日2次。遇风热而作者酌加蝉蜕、薄荷；遇风寒而作者加桂枝、杭芍；遇暑湿而作者加藿香、苍术。

②扶正化痰。适用于虚哮缓解期，体弱气虚痰内伏证。证见：素体虚弱不耐邪侵，遇劳则发，或哮喘发作大势已去，但轻度憋喘仍绵绵不断，气短乏力，动则加重，伴有咯痰不爽，畏寒肢冷，或烦热盗汗，舌质暗淡、苔薄白，脉沉细弱。常用正气化痰丸加减（自拟）。处方：台参、黄芪、白术、炒山药、半夏、云苓、苏子、葶苈子、枸杞子、鹅管石、天冬、熟地、阿胶、鹿角胶、桔梗、沉香粉、橘红、甘草。据病情适量，共研细粉水泛为丸，每次服5~9g，每日2次。^[41]

40. 晁恩祥诊治经验

针对哮喘病人及家族中多有哮喘、湿疹、荨麻疹等病史；多发于春冬季节，具有明显的季节性；发作前多有鼻痒、眼痒、鼻塞、喷嚏、流涕和咳嗽的先兆症状；发病迅速，时发时止，反复发作，发作时痰鸣气喘的特点，认为本病与风邪“善行数变”的性质相符，因此“风盛痰阻、气道挛急”是哮喘病急性发作时的主要病机。“风盛”是哮喘病的主要因素，而发作时病人表现的痰壅、气道壅急、肺管不利而痰鸣之状，是风邪侵袭机体后产生的病理结果。因肺主气，司呼吸，主宣发肃降，外合皮毛，具有通调水道的功能。风邪袭肺，肺失宣发肃降，津液停聚为痰，正

如《症因脉治》所说“风痰之因，外感风邪，袭人肌表，束其内郁之火，不得发泄，外邪传内，内外熏蒸，则风痰之证作矣”。痰作为继发性致病因素，又可碍肺之宣降，气之升降。“风盛则挛急”，风痰相搏，内阻于肺与气道，致使气道挛急，肺管不利而发哮喘。肺管不利，又可影响痰的外排，使“上气喘逆，鸣息不通”更为严重。由此可见，“风盛”是哮喘病的主要因素。哮喘病的治疗，历代一般都遵循丹溪的“凡久喘之证，未发宜扶正气为主，即发以攻邪气为急”之旨。疏风解痉法就是针对哮喘病人急性发作时表现的“风盛痰阻，气道挛急”的病机而设的治疗方法，属于治标、治肺之法。在哮喘病的治疗中，采用疏风之法，古今医家亦有论述。清·蒋宝素指出“哮喘发，发时以散风为主”（《问斋医案》）；沈金鳌曰“哮之一症，……治需散表”。现代著名中医内科学家印会河教授认为，哮喘病的主因是“风”，其治疗虽有冷哮、热哮两型，但其间定风又是共同的，并善用地龙、全蝎、蜈蚣等药物以定风。通过疏风，可使表邪外达，肺气清肃得行，气道通利，痰去络通而喘自平。现代研究结果也证明，具有疏风的许多药物，都有很好的免疫作用，确有改善机体的体质，降低其易感性的功能。解痉就是解除气道挛急，使肺管通利。因为只有气道通畅，痰浊之邪才有出路，痰浊才易排出，肺之宣发肃降得复常态。疏风与解痉相对而言，疏风是治本之法，是主要的；解痉是治标之法，是次要的。但在临证中，又因急性发作时“风盛”与“气道挛急”兼见，故两者多并举。^[42]

41. 王左诊治经验

王氏认为本病多因先天禀赋不足，由外邪侵袭、饮食

所伤或他病诱发发病，病机则以痰气交阻、肺失宣降为主，病位在肺，与肝、心、脾、肾四脏皆相关。

①从肺论治。发作期：外感风寒或风热之邪，未能及时表散，邪蕴于肺，壅阻肺气，气不布津，聚液生痰，痰闭气道，发为呼吸急促，喉中哮鸣声诸症。此时肺、脾、肾诸脏或虚或实，痰壅于肺，标实甚急，急则治其标，故治肺为先，宜宣肺、肃肺、清肺、泻肺。方用二三汤加减治之，即二陈汤、三拗汤合三子养亲汤加减。二陈汤燥湿化痰、理气和中，三拗汤宣肺平喘，三子养亲汤降气化痰，三方合用燥湿化痰、宣肺降气平喘。发作期患者有喘、咳、痰、热主次症之不同。喘为主者，可选加银杏、地龙、葶苈子泻肺利水平喘；喘促持续不解，出现“喘脱”危候，加黑锡丹镇纳浮阳平喘；痰涎多者，加川贝母、天竺黄化痰平喘；痰稠量多，难以咳出，壅塞气道，加礞石滚痰丸逐之；咳多者，加紫菀、款冬花、旋覆花、百部肃肺止咳平喘；热者，加黄芩、石膏、鱼腥草、野荞麦根、四季青清热利湿解毒。缓解期：哮喘日久，患者多怯寒、背冷、鼻头清冷，易受外寒侵袭，治肺宜补，多温肺、润肺、补肺。用《济生方》之参蛤散（人参、蛤蚧）合坎离散加减治之，寒者加桂枝、干姜温肺，燥者加沙参、麦冬润肺，虚者加补骨脂、胡桃肉补肺。

②他脏分治。王氏在支气管哮喘治疗中，强调五脏的相互影响，当分而治之。肾为先天之本，主纳气，肾阳虚损而不能固纳肺气，故治以温肾纳气为主，急者用黑锡丹，缓者用蛤蚧一对合肉桂 10g 研末服之；肾阴亏虚无以滋肺者，用金水六君煎。脾为生痰之源，脾胃不健，运化无权，水湿内停，凝聚为痰，故以治痰为先，治痰当治湿，健脾燥湿，二陈汤治之；缓解期，可用香砂六君丸调养。肝主

升而肺主降，肝开太过则为火，肝火引动心火亢盛，火旺则刑金，肺降无权，治在清肝降逆，用柴胡清肝散治之。

王氏在支气管哮喘治疗中，还强调气血同治，重视活血化痰。哮喘日久，肺主气失职，气机阻滞或肺气亏虚，气为血帅，血为气母，气滞则血瘀，清·吴澄曰：“气滞者血也滞也，血不自行，随气而行，气滞于中，血因停积，凝而不散，愈滞愈积愈滞”。气虚则血运无力亦可致瘀，因此哮喘各期必调气活血。发作期用《圣济总录》双仁丸（桃仁、杏仁）活血平喘，缓解期用补阳还五汤补气活血。^[13]

42. 顾玉龙诊治经验

顾氏治哮喘重症，每宗《医话》阳和饮立意，授方应效者颇多。如治张某，男，52岁，工人。因受凉引动宿疾，复发哮喘。每发端坐达旦，甚则连月卧不着枕。连用中西药物，屡进单验方药，终因医治无效，赖激素以维持，病情渐进已越五载。诊见：哮喘倚息，呼粗吸短，痰稠如丝。两颧赤色，唇紫面青，额上粘汗。舌质淡红、苔白腻根垢，脉寸关浮数尺沉微。病始为外因之寒邪与肺中之窠囊顽痰互结，搏击气道，发为哮喘。日久迁延，邪郁化火，遂见胶痰如丝。呼粗肺实，吸短肾虚。肾中之真阴虚衰，上浮之亢阳无制；坎内真火式微，显现诸般阳虚之候。且询得进地冬则作泄，投麻桂则痰血，下寒上热之候明矣。拟《医话》阳和饮加减旨在实下清上。处方：熟地 60g，黑附块（先煎）9g，山药 15g，鹿角霜 20g，白芥子 12g，麻黄 12g，上安桂（后下）6g，菟丝子 30g，胡桃肉 30g，茯苓 15g，百部 15g，石韦 45g。上药浓煎，合一、二煎之药汁，分早、中、晚 3 次服完。另进人参蛤蚧精。服药 3

剂后，哮喘轻咳稀，汗止，唇转红活，苔垢清，脉转濡数，效不更方。惟粘稠之痰难出，于原方中减黑附块为 6g，加北沙参 30g，桑白皮 15g。10 剂后症趋平稳。但晨哮喘未罢，上方去胡桃肉，减白芥子、麻黄为 6g，嘱隔日 1 剂，续服 1 月，哮喘得以控制。小剂量激素续用，后值大伏天行化脓灸，届秋令进服阳和饮 1 个月，连续 3 年，临床治愈。

《椿田医话》阳和饮为清代名医蒋宝素治哮喘得意方。蒋氏谓，哮喘一证“盖伏风痰饮，凝结肺胃曲折之处，为窠为血”。此痰生发于脾而源于肾，入肺如蜂子之穴于房中，一俟外邪交互，发作无度。因此，任用驱导涤涌之剂，势难中的。蒋氏认为，肾虚窠囊之痰，“必借真火以煦和，真水以濡润，方能融化。”立方阳和饮，以熟地大补肾阴为君，鹿茸生精助阳，配麻黄温通肺窍，山药、山茱萸、菟丝子、胡桃肉平补肾中阴阳，摄纳肾气；于大剂滋阴药中少配附桂，寓阴中求阳，水中补火，以鼓舞肾气，使肺气得降而归肾，龙雷尾随入海；参苓建中，白芥子、麻黄决壅宣滞。集实下、运中、宣上于一方，滋阴不腻，补阳不燥，配伍得宜，相得益彰。此方导源于金匱肾气丸，得力于景岳右归丸，取法于《外科证治全生集》之阳和汤。方中剂量乃参合三方而定。唯熟地腻滞之性，不可不知。哮喘重症，每因肺气上逆而胃失和降，肝木乘侮，中运不健者有之，方中须加莱菔子、青皮、陈皮。还须注意进服法，晚近张锡纯投大剂熟地时每每采取“徐徐温饮下”之法，可谓至德之见。^[11]

43. 奚凤霖诊治经验

过敏性支气管哮喘，属中医学“哮证”。患者多为过敏体质，素体肺卫不固，外御失司，一旦气候季节交换，或

接触致敏原，则哮喘接踵而发。

如治吴某，男，14岁，素患过敏性鼻炎，每届秋末冬初，或闻异气异味，或饮食不慎等，哮喘咳痰必发，发则胸闷气粗，喉间哮吼连声。即以玉屏风散为主，配藿胆丸、三拗汤等方药以扶正固本，抗敏平哮，止咳化痰，降逆肃肺。处方：生黄芪15g，白术15g，麻黄6g，防风10g，杏仁10g，甘草6g，地龙10g，蝉蜕3g，僵蚕10g，青葱2支，藿胆丸30g（包煎）。服药1周哮喘见平。为进一步巩固疗效，宜标本兼顾，补散并进。去三拗汤，加河车大造丸化裁，再治1月，历经秋冬未发。

本例乃肺卫不固，致肺气不宣，痰浊阻塞气道，肺气壅塞不通，发为哮喘。治以益气固卫，抗敏平哮，得以控制。^[45]

44. 盛国荣诊治经验

支气管哮喘，是一种发病率较高的慢性过敏性疾病，一年四季均可发病。若患者因感寒而发咳喘，以标实为主，治遵朱丹溪“凡久喘之证，未发宜扶正为主，已发用攻邪为主”之旨，取温肺散寒之射干麻黄汤加减；若病程较长，正气虚弱，发作时应以宣肺祛痰平喘治其标，兼见肺阴耗伤，宜益肺阴而固本。标证缓解，肾气虚损，以补肾纳气，培补下元为主。正如张景岳所云：“于消散中宜酌加温补，或于温补中宜加消散，此等证候，当倦倦以元气为念。”盛氏还根据中医学“久喘必虚”之说，拟金匱肾气丸以及玉涎丹（川贝、蛤蚧）加胎盘粉、麝香，以防治哮喘之发作。^[46]

盛氏善用白虎汤，其主药石膏更喜用。临证配伍不同，治法各异，然清热养津作用则同。本品尚有降逆镇静之功。

配知母滋阴降火，退虚热。《名医别录》谓石膏性大寒，后世医家多畏之。对白虎汤的应用过分拘谨于“大热、大渴、大汗出、脉洪大”四大症。而盛氏认为不必四大症具备，只要掌握“里有蕴热，脾胃无虚寒”这个特点，多获良效。常用于哮喘的治疗。其认为中焦脾胃病以“实则阳明，虚则太阴”，阳明主热，胃火灼盛，可炼液为痰，热痰胶固，滞于肺道，气失宣降可致哮喘频发。治热哮多用白虎汤清热降逆，以杜其痰热之根，复加麻杏定喘止咳，莱菔子降气化痰，鱼腥草清热解毒，共奏清热化痰，降气定喘之功。

如治林某，男，46岁。春秋两季，每于晚间八、九点哮喘发作，已3载。诊见患者面色潮红，胸闷咳嗽，喘促，喉间有哮鸣声，痰粘而黄，不易咯出，口干舌燥，喜冷饮，胃纳欠佳，大便秘结，小便短。西医诊断为支气管哮喘。辨证为热哮，拟清热化痰，宣肺降逆。处方：麻黄8g，苦杏仁12g，知母10g，冬瓜仁10g，紫苏子10g，莱菔子16g，生石膏60g，鱼腥草30g，苇茎30g，粳米20g。先煎石膏、鱼腥草、苇茎、粳米，去渣纳余药再煎。连服3剂，喘咳减轻，痰已转白而稠，烦躁口干减轻，大便仍秘。继用清气化痰法。处方：沙参10g，苦杏仁10g，瓜蒌仁10g，茯苓14g，陈皮8g，枳实8g，黄芩8g，胆南星8g，制半夏8g。连服5剂，诸症大减。后用：胡桃肉16g，沙参14g，麦冬10g，五味子5g，煎汤冲服金匱肾气丸每次10g，每日1次连服1月，以善其后。

石膏系白虎汤主药，盛氏用石膏最少30g，和粳米先煎，去渣用汤液煎余药（若无粳米，可用山药代之）。石膏生用或熟用，见仁见智，各有不同看法。盛氏认为清热泻火石膏宜生用，效果较佳，降逆镇静以煅石膏为宜。用煅石膏治疗各种出血证（如咳血、咯血、衄血等），临证灵活

配伍，止血效果颇佳。^[47]

45. 王文鼎诊治经验

哮喘有新、久、虚、实之分。新喘、实喘责之于肺，有邪即为实；久喘、虚喘责之于肾，无邪为虚。初起多系感寒而发，急则治其标。对脉促数而喘者，轻则半夏厚朴加减，重则越婢术夏汤增损；胸腹胀满者，厚朴麻黄汤主之；痰饮较甚，喉间痰曳如水鸡声者，射干麻黄汤甚佳；寒包火者，用麻杏甘石汤或白果定喘汤；兼烦躁者，大青龙汤加重石膏；表寒里饮，咳唾白色泡沫状痰，小青龙汤最为合拍。以上方剂中，举凡（干或生）姜、（细）辛、（五）味（子）配伍并用者，三药一定要等重量，倘担心细辛量大，小量投服之，其效立减。所谓“辛不过钱”之说，系指细辛入散剂而言；复方汤剂内每剂酌用细辛6~9g，煎汁日2~3次分服，多无大碍，反具顿挫病势之殊功。

及至哮喘中期，有虚有实，即本虚标实，此时三拗汤、大小青龙汤及射干麻黄汤均不相宜，后人参定喘汤、人参麻黄汤皆标本同治之方，不过均偏重在气虚者。久病喘促之发，已不受季节气候之影响。但见脉上部浮数、下部两尺沉细，为上盛下虚，以下虚为主，治宜大补肺气、纳气归肾，予全真一气汤：人参30~60g（或野台参或潞党参60~90g），熟地30g，山萸肉12g，麦冬15g，五味子3g，怀牛膝10g，白芥子6g，生姜5片。曾用此方治愈或控制多例此型远年哮喘患者。王氏经验认为，人参小剂量应用其性往上浮，大剂量应用则下沉。半虚半实用人参定喘汤，乃人参与麻黄同用即此意。

后期痰如泉涌之哮喘，可用桂附地黄汤，以温化痰饮、填补下元。久虚之体，每多中州运化失职，痰涎产生不已，

若不及时采取对应措施，渐至正气虚甚，则肾水上泛，龙雷之火上亢。后期肺脾肾俱虚之哮喘，人参、熟地既治其本，亦为上好之化痰药。久病暴喘，用蛤蚧尾 0.2g 研末顿冲服，劫喘甚效。平素每日佐食蜜炙核桃 3~5 个，对治疗虚喘颇有助益。病情得以控制后（静止期），可先投肾气丸加沉香、五味子以纳气归根；继用脾肾同治法，即先后天并重，晨服五味异功散或六君子丸，晚服肾气丸，以扶正培本，巩固疗效。^[48]

46. 王正雨诊治经验

王氏认为哮喘的病理因素是以痰为主，痰属湿，津液所化，气不化则津液变生痰涎。由于患者体质、病情有异，用药分别按燥湿化痰，泻木宁肺，养血润燥，通腑豁痰，清宣理肺立法，收效颇佳。

①燥湿化痰法：脾为生痰之源，肺为贮痰之器，病久则痰饮如水之津，如鱼之涎，遍身皆是。入肺则喘满咳嗽，痰稠量多，胸闷不得安卧，入脾则嗜卧，肢体沉重，腹胀、食难消化，脉象弦滑。拟燥湿利痰法，选二陈汤加味治之。患病迁延日久，致脾肾两虚，脾虚不能运湿，当助健运之功能，使湿从气化而消散，为治湿之本。肾虚不能化湿，当补肾纳气，使湿邪不致浸淫上下，此补肾为理湿之源。方中半夏燥脾湿，陈皮利滞气，茯苓渗湿安中，甘草缓中益胃，胆星清化热痰，苏子降逆平喘，黄芩清肺热，地黄、当归补肾养血纳气，诸药合用，痰自化，喘可平，此行气化痰之剂，为痰盛气逆之专方。

②泻木宁肺法：哮喘反复发作，影响肝的疏泄功能，日久必致肝火上炎。肝火者阴中之阳火，郁蒸而发，阴湿蕴结而炎，久之导致胸闷喘息，两胁不舒，气短咳嗽，面

黄形瘦，少气无力，脉数弦等。治从疏肝宁肺，养血润脾着手，常选用加味逍遥散治之。用此方意在疏肝补脾治其本，润肺平喘治其标。但遣方用药要注意补而不壅滞，疏而不耗气，寒温适当。方中柴胡、薄荷疏肝解郁，调达气机；地龙平喘清热，杏仁降气理嗽；入连翘、金银花清心热，透邪疏散；白术、山药、茯苓、甘草建中培土，白芍、当归养血润脾，佐以冬瓜皮、赤小豆清利痰湿。用木贼草代麻黄宣肺平喘，其气不猛。此乃解郁之剂，标本兼顾之方。

③清肺润燥法：燥气由五行之金所化，金受火克。肺燥不能生水而上源枯，津血少，致胸闷干咳喘息，痰黄质稠，唇干咽燥等，治宜清热养血，润燥平喘法，多用加味清燥救肺汤主之。方中重用生石膏清肺金燥热，入地骨皮退肌热，辅南沙参、麦冬，麻仁滋阴生津润肺止咳；加阿胶、山药补脾胃、益肺肾；佐桑叶、桑白皮清肺气，泻湿热；加枇杷叶、杏仁降逆平喘，以使燥润痰行，肺气通利，喘咳自愈。治久病咳喘者，在利气祛痰之品中加入活血化痰药，常可提高平喘之疗效。

④通腑豁痰法：临床常见某些痰火重的患者，烦热胸痛，脉数面赤，咳喘噎噎，口干唇燥，便秘，其痰坚而脉数实。治宜开导阳邪，宣通涩滞，常选加味凉膈散主之。因肺与大肠相表里，气郁痰火重的患者要适当用些通泻药物，腑气通畅，肺肠热泻，则喘咳自平。凉膈散中之大黄泻热结，连翘清心散热，黄芩清肺宽肠，栀子清三焦之火，甘草缓中州之气，薄荷清胸咽之邪，竹叶疗膈上之热，另可加南沙参、芦根滋阴生津，丹皮凉血活血，桑白皮清肺平喘。但王氏认为即使肺中痰火盛者，用此方亦不得过度，避免损伤中州。本方使火降痰净，肺金清肃，敷

布有权，喘急壅闭之疾自愈。

⑤清宣理肺法：肺虚则玄府不闭，风邪乘虚而入，加之焦热壅，内火不得疏泄，乃表里两实之证。其主证为咳喘胸闷，鼻塞，流浊涕，咳甚痰多，痰必稠浊，舌红、苔薄黄，脉浮数。治宜宣肺清热平喘，常用麻杏石甘汤加味意在表里双解。方中麻黄开表逐邪，石膏清泻肺热，杏仁宣利肺气，甘草缓肺急。可加荆芥散风理血，薄荷疏风解热，辅金银花轻宣解表，地龙清热平喘，配枇杷叶、桑白皮清肺化痰，降气止咳，佐麦冬、沙参滋阴润肺，丹皮凉血化瘀通肺络。全方配伍辛凉宣泄，润肺平喘，使风邪外解，内热得除，气顺痰消。^[49]

47. 费开扬诊治经验

哮喘发作期，一般属于实证或本虚标实证。以宣肺豁痰平喘为要务。费氏认为宣肺平喘首推麻黄。但医者用麻黄，多虑其有发汗、耗肺气、伤宗气之嫌，况哮喘大多反复发作，本虚标实，易自汗出者为多见，故临证选用时有所顾忌。但麻黄经炮炙后，去掉了挥发油，保存生物碱，已无发汗之力，仅存平喘之功，费氏认为关键在于配伍得当。如麻黄与射干同用，此药对选自仲景射干麻黄汤，常用于哮喘或慢性支气管炎咽痒干咳者。无论冷哮热哮用之均效。麻黄配射干，辛开苦降，宣肃并行。一般用量为麻黄6~9g，射干9~12g为宜，个别可用至12g~15g。小儿、老人酌减。在此配伍的基础上须加甘草3~9g以监制之，更为稳妥。喉间有水鸡声者，加白前12g。冷哮口不渴，痰清稀者，加干姜6g、五味子9g、细辛3~5g（入煎剂过3g无妨）、制半夏10g；痰多再加白芥子3g、苏子9g、炒莱菔子9g，或合二陈汤；尿少加车前子9g。热哮，渴喜冷

饮，痰黄粘稠者，加葶苈子 9~12g（可重用至 20g）、地龙 12g、生石膏 15~30g、桑白皮 12g；发热、血白细胞增高者加黄芩 12~15g、鱼腥草 15~30g、败酱草 15~30g、冬瓜子 30g、生薏苡仁 20g、鲜苇茎 30g。个别畏服麻黄者，费氏则仿张锡纯重用赭石处方：煅赭石 30g，葶苈子 20~30g，旋覆花（包）10g，杏仁 9g，厚朴 9g。再如上述之冷哮、热哮之加味即可。但此方更适用于热哮。其中葶苈子一味，人多畏其“泻肺”之名而不敢多用，费氏认为用量不够每每乏效，其平喘之功亦不能体现出来。

哮喘在缓解期多表现为虚证，治法不外降气敛肺、培土生津、补肾纳气诸法。常用药有人参、黄芪、五味子、山药、熟地、蛤蚧、紫石英、紫河车、枸杞子、菟丝子、补骨脂、山萸肉、胡桃肉、龟板、鹿角胶、仙灵脾等。但有些哮喘患者，反复发作，或伴有肺心病、肺气肿。久病属虚、久喘属肾。如单纯使用补气敛肺、益肾纳气之品，效果并不显著。费氏则在大队补益固本方药中，酌情佐以适量麻黄，常可获得意想不到之疗效，而未见不良反应。说明麻黄与熟地这一药对与大队补益纳气之品同用，有动静结合、寓通于补、刚柔相济之妙，为治上实下虚、本虚标实而以虚为主之哮喘的绝妙配伍。此与六味地黄之三补三泻的配伍构想是一致的。

历来方书记载葶苈子为苦寒泻肺平喘、行水消肿，治实喘良药。但费氏用治心源性哮喘，特别是肺心病虚喘浮肿，效果显著。其中奥妙之处也在配伍与用量上，除配伍大队补益药外，用时一定要超过 9g 之常用量。成人虚喘患者，经配伍后，葶苈子可用至 20g，个别用至 45g，未见不良反应，而平喘消肿疗效即显。费氏认为在哮喘缓解期应长期坚持服用补肾之丸散剂，以防止或减少复发。对个别

长期依赖激素控制发作者，坚持用补肾药，可使激素量逐渐递减以至停用。补肾药亦应根据病人体质偏于肾阴虚或肾阳虚，灵活配伍。费氏通用方是：人参（或西洋参）30g，蛤蚧2对，紫河车60g，地龙60g。共研细末，装入胶囊，每晨空腹服3g，或早晚各服1.5g。偏肾阳虚者配合服用金匱肾气丸；偏肾阴虚者配合服用七味都气丸，均为每晨空腹服3~9g。^[50]

48. 李石青诊治经验

①表里分治，麻黄主表：哮喘之治，传统多以“发时治标（肺），平时治本（肾）”为原则，而发作期习从寒热分治。李氏认为哮喘发作用表里分类，可以抓住病机重点，加强治疗的针对性。仲景在《金匱·咳逆上气篇》云：“咳而脉浮者，厚朴麻黄汤主之；脉沉者，泽漆汤主之”。这是藉脉之浮沉以定表里的先例，《中藏经》进一步充实《金匱》的内容，提出：“虚实寒热，则皆使人喘咳，其脉沉浊者，病在内（里），浮清者，病在外（表）。”这不仅以浮沉定表里，并以邪的清浊分内外。肺为清肃之脏，喜温而恶寒。喜润而恶燥。肺主皮毛，开窍于鼻，凡是外邪侵入皮毛鼻孔而犯肺者，此为病从外受；而饮寒食冷入胃从肺脉上干，阳气被遏，寒饮内停，痰不得出，郁而化热，气不得降，气逆作喘，是为内淫。大凡风寒外束，或挟饮邪、饮热等，皆属表，为清邪；若痰火、胶痰、浊气、食积、瘀阻等皆属浊邪，病在里；此外，由它脏影响及肺，或由腑及脏（肺），也是属里喘范畴。属表之喘，清邪在上，必用轻清气药，故多选用麻黄配制，以辛散外邪，宣肺平喘。如发病急骤，外感风寒，内有饮邪之咳逆倚息不得卧，咳吐泡沫痰涎，苔白滑，脉浮紧或浮弦，宜用小青龙汤外开

太阳，温化痰饮，宣达肺气；如兼烦躁、口渴，上半身汗，脉浮数，苔薄糙，则合麻杏石甘汤；喘逆甚，腹胀满加川厚朴；若春秋易作，伴鼻痒等，常加苍耳子、蝉蜕、马兜铃等；咳逆气喘，反复发作，目如脱状，脉浮大者，宜越婢加半夏汤；若属风寒束表，肺气失宣；或挟气火上逆，可分别选用九宝汤（麻黄汤加苏叶、薄荷、桑白皮、大腹皮、姜、葱）及华盖散。属里之喘用麻黄，多为表里同病，如寒包火证。症见哮喘声粗，痰黄气逆，口苦，鼻塞，苔粘或黄，脉细滑数。病机重点是里有痰热，客寒郁闭，故多用定喘汤，取半夏、苏子化痰降逆，黄芩、桑白皮、白果清金保肺，款冬花、甘草甘润益金安里，取麻黄发表定喘以散客寒，且与甘涩白果同用，既开且合，相制为用。又素禀阳虚，久哮难愈之喘，因虚易感寒，若但施温里则外邪难去，徒行发散易伤阳气，故宜温开同施，表里兼治，方如麻黄附子细辛汤，用治哮喘急作，畏寒，痰鸣色白，面呈青黑，脉沉细。一般化痰平喘药无效时，常合理中、六安煎辈，颇著其功。

②痰恋气痹，开泄通阳：宿哮久喘，每因伏风痰浊，久踞气道，痰阻气郁，胸阳痹阻，肺气膹郁，升降失常。此时，哮喘多反复，症可见喘息咳唾，胸闷如窒，或有胸痛，口粘不爽，咯痰不利，苔白粘腻或浊腻。此证若恣用宣散，或专司降气，可致气逆不羁，痰浊郁遏不达。李氏独倡开泄豁痰、通阳泄浊之法。方取自拟“薤白开降汤”（薤白、瓜蒌、法半夏、射干、杏仁、石菖蒲、紫菀、枳壳、桔梗、川贝、郁金、蛤壳、姜汁、鲜竹沥等），以瓜蒌薤白半夏汤通阳散结，豁痰下气；王孟英之开降汤以开泄降逆，搜剔伏痰；参吴鞠通之上焦宣痹汤微辛微凉，宣通气滞。诸药合用，可使痰者化，痹者开，达肺气宣畅。若

痰气郁久化热，则加黄芩、桑白皮以清肃；痰粘胶着难化，喘息难平，则加海浮石、萝皂丸（莱菔子、皂荚）加强软坚化浊痰；若病久痰滞络道，气痹血瘀，则加白芥子、旋覆花、桃仁入络搜剔，化痰滞；若苔糙、口渴，痰气久郁化燥，则加知母、花粉雪羹汤等轻开护阴、去燥痰。

③哮喘兼呕逆，当治肝胃：哮喘急发，气逆痰壅，脘胁胀满，呕苦吞酸，必兼治肝胃。哮喘逆明显时，多涉肝胃。盖肝主升发，胃性和降，肺喜清肃。肝气条达疏泄有致，胃气冲和斡旋有序，肺气始宣发肃降不悖；若肝失疏泄，胃失和降，则气机郁滞，升降逆乱，势必影响肺气宣降之职而发哮喘。从临床看哮喘发作多在夜半丑时，而丑时为肝气所主，肝气大过，侮金动喘；肝气不足，疏泄无力，也致肺气宣降失职。另一方面，研究已证实：胃食道反流、胃酸刺激也会造成支气管收缩引发哮喘。症状除有哮喘逆外，多有暖气嘈杂，恶心呕吐，口苦泛酸，或呕吐清涎、脘胁作胀等肝胃见症。方取苏子降气汤去当归、肉桂，加吴茱萸、桑白皮、旋覆花等，抑肝和胃，化痰降逆，不仅呕酸胁胀肝胃症除，哮喘气逆之候也多可平定。如舌心红边白，痰饮之中寓郁火灼津，则去厚朴、肉桂，加泻白散，合金水六君意，育阴化痰两不误；若症见寒热往来，胁痛呕苦，则可合小柴胡汤、黛蛤散、桑丹汤等和解清降；若兼腹痛，四末作冷，口苦，舌边尖红，乃为木郁不达之象，遂取四逆合小陷胸、青皮、竹茹等，以疏和气机，清化肃肺。

④哮喘久发，尤重扶正：哮喘的发病与持续时间的长短，与患者的正气状况密切相关。正气不足，抗邪力弱，是易感受外邪、诱发哮喘的原因，又常是哮喘持续发作的根由。临证时每可见到哮喘痰鸣、胸闷咳逆等症同时，又

有纳差乏力、舌淡脉细等脾虚失运，胃虚不纳之象；甚而有动则气喘、腰腿酸软、小便清长等肾气不足，摄纳无权之兆。若一味祛邪泻实，不顾正气，则易犯“虚虚实实”之戒，往往是哮喘迁延不易平复之因。即使有些被认为是邪实壅肺之证，由于病人体质各异，侵袭致病外邪不一，也可表现寒热错杂、虚实夹杂的复杂局面，切不可恣用开破泄肺，而应酌情加用扶正保肺之品，以补泻同施，标本兼顾。因此，对于哮喘持续发作的治疗，以“邪动则虚中求实，邪静则实中求虚”的治疗原则，并根据正虚浅深，分别气血阴阳，灵活应用益气健脾助运，或补肾填精镇冲之法。脾胃乃后天之本，气血生化之源，调补脾胃上可荫肺，下能提防肾水泛滥。而补肾治本，当分阴阳，不可一派温补，补阳要从水中补火，所谓“无阴则阳无以化”，“善补阳者，当阴中求阳”。此对反复难愈的顽症哮喘辨治确有指导意义。^[31]

49. 原明忠诊治经验

喘证，是指呼吸急促，甚则张口抬肩，不能平卧的证候。一般病情急，宜及时治疗。临床上大体分为实喘与虚喘两类。实喘：病在肺。多因素有痰湿，复受风寒，肺失宣降而致。症见呼吸急促，气粗声高，甚则不得平卧，胸膈满闷，咳吐白痰，舌质偏暗、苔白薄，脉弦滑。治宜宣肺平喘，方用华盖汤加减：麻黄 9g，杏仁 12g，苏子 10g，甘草 9g，桑白皮 12g，橘皮 12g，百合 12g，贝母 10g，枇杷叶 12g，水煎服。若兼见痰黄或痰白稠粘不利，苔少津等肺热证候者，上方加黄芩 15g，百部 12g，葶苈子 10g，瓜蒌 20g，以清肺化痰。若兼有恶寒甚发热轻等表寒证者，上方加桂枝 10g，生姜 9 片，以助解表散寒。虚喘：病在肺

肾。多因久患痰饮，缠绵不愈，耗伤肺气，母病及子，致伤肾气。症见呼吸急促，动则喘甚，音低息短，不得平卧，面色晦暗，唇、舌、爪甲暗紫，脉多虚或数无力。治宜补肺肾益气平喘。方用生脉散合人参胡桃汤加减：党参 30g，麦冬 20g，五味子 25g，丹参 30g，山茱萸 10g，补骨脂 10g，红花 10g，黄芪 30g，木香 9g，水煎服。并宜吸氧。视病情间断使用。或加服人参粉，每日 3~5g，分 2 次冲服。若兼有轻咳吐白沫痰，上方加茯苓 20g，清半夏 10g。若兼见畏寒、肢冷等阳虚者，加附子 9~15g。若兼见下肢浮肿者，合五苓散服之，以利水消肿。^[32]

50. 曹惕寅诊治经验

哮喘是一种顽固性反复发作的疾病，包括现代医学所称的喘息型支气管炎和支气管哮喘等。一般好发于秋冬或冬春气候冷热变幻的季节。其主要症状有咳嗽、气急、胸闷、痰声嘶鸣等。其发病因素主要是由于体内积热蒸痰，复感外邪，气机升降失常所致。曹氏认为咳喘多属温热性杂病范围；以脏腑而论，其初发病在肺，久则及于脾肾。治疗咳喘常根据具体病症，分别采用汤、散、丸三种剂型进行治疗。

①汤剂：适用于咳喘发作时形寒发热，鼻塞流涕，咳嗽，气急，痰声嘶鸣等症。常用桑叶、薄荷、葶苈子、紫菀、杏仁、枳壳、旋覆花、生蛤壳、白前、炒莱菔子、保和丸等药物随症加减。如气逆喘甚属实者，加银杏肉（生打）冲服；咸痰虚喘者，加胡桃肉（生打）冲服、七味都气丸（包煎），亦可用蛤蚧尾（研末）冲服；兼见喉蛾者，加僵蚕、马勃、飞人中白；胁痛者，加青葱管、丝瓜络；平素喜饮酒者，加陈皮、薏苡仁、茯苓；外感寒邪者，上

方去桑叶、薄荷、牛蒡子，加苏叶、防风；咳嗽不爽，口干舌红者，加黄芩、竹茹、生甘草等。

②散剂：适用于咳喘发作时期或缓解期。常用四一定喘粉（竹沥半夏 30g，炙紫菀 21g，僵蚕 15g，杏仁霜 21g，炙橘白 21g，白前 15g，共研细末，分成 41 包），每次 1/2 包（约 3g），每日 2 次，温开水送服。连服 41 天为 1 疗程，一般服 2~3 疗程。八一定喘粉（川贝粉 45g，生紫菀 30g，远志 30g，竹沥半夏 60g，象贝母 48g，橘白 30g，共研细末，分成 81 包），服法与上方相同。一般于冬至时始服，连服 81 天，取冬至阳长阴消之意，可以促进疾病的向愈。此外，还可根据痰涎性质和症状加减用药，如顽痰者，僵蚕加量；老痰者，远志加量；热痰者，竹沥半夏加量；风痰者杏仁、象贝加量；表卫不固者，加玉屏风散；干咳气急者，加黛蛤散；干咳无痰者，加北沙参、麦冬等。

③丸剂：适用于咳喘缓解期。临床应用时，如禀赋薄弱，脾虚积食不消者，用资生丸、参苓白术丸；气虚痰多者，用六君子丸；肾气失纳、痰咸者，用七味都气丸。此外，曹老还常用自拟人参培元丹（移山参、北沙参、天冬、五味子、白术、山药、百合、橘白、神曲、炒谷芽）。

如治曹某，女，23 岁，幼年患麻疹之后即罹哮喘之疾，每年发作 1~2 次，经治疗后即平。此次复发治经数月仍未缓解，气急咳嗽，鼻塞痰鸣，背重胸闷，胁肋牵痛，便艰瘦少。舌尖红、苔白，脉弦数。此乃痰浊内蕴，肺气失宣。法当宣肺化痰，泄浊化滞。处方：大力子 9g，苏子 9g，莱菔子 12g，生紫菀 4.5g，杏仁 12g，瓜蒌皮 12g，冬瓜子 15g，保和丸（包）12g，生蛤壳 30g，白前 6g，通草 3g。并随证略事加减，调治月余，病情好转，惟寐醒作咳。此肺胃之痰热未清，当再清肺泄热，降气化痰。处方：桑

叶 9g, 薄荷(后下) 2.4g, 葶苈子 9g, 瓜蒌皮 12g, 杏仁 12g, 枳壳 4.5g, 炙紫菀 4.5g, 冬瓜子 15g, 丝瓜络 9g, 青葱管 1 尺, 生蛤壳 30g, 白前 6g, 通草 3g, 鲜芦根 30g。另服用四一定喘粉 1 剂, 晨服参苓白术丸 6g, 晚服资生丸 6g。

曹氏认为哮喘病属热证, 但其温热性与温病的温热性又有严格的区别。前者属于杂病范围, 多因内有积热蒸痰, 复感外邪而成, 治疗重在宣泄化痰; 后者多因温邪外袭, 化热入里所致, 治疗注重清热救阴, 两者不可混同。汤、散、丸剂的联合应用是曹氏治疗哮喘的特点。主张“发时汤散同服, 平时丸散同服”, 即配合汤、丸同服化痰为主的定喘粉, 以豁痰除根。三种剂型联合应用, 可达到彻底治愈或减轻发病的目的。曹氏用药以轻灵稳健著称, 主张发病之初治以辛凉轻清宣达之剂, 忌用辛温表散之品, 以防宣发太过, 重伤卫分而加重病情; 对于舌红痰稠的哮喘病人, 则少用大寒大苦之剂, 以防苦寒伤脾化燥, 痰浊难化。治本则以健脾助运为主, 不宜用滋腻厚味之补品; 确无表邪者, 方加益肾之品, 惟恐闭门留寇, 助纣为虐。此外, 用药还注重调气化痰, 助运导滞。常用紫菀、杏仁、旋覆花、枳壳等宣肺调气; 远志、竹沥半夏、神曲、保和丸等助运化痰。药虽平淡轻灵, 但可收到缩短病程, 提高疗效的效果。^[53]

51. 朱锡祺诊治经验

哮喘一证, 临床常见, 但根治困难。哮喘之因有风寒、内火、痰饮、食积、气虚、阴虚、伤损等。李东垣认为: “诸经皆令人喘, 而多在肺胃二家。哮喘的发生, 虽然表现在肺, 实际上与脏腑的功能、经络气血的盛衰有着密切关系。朱氏认为哮喘有虚有实, 常见虚实夹杂, 是标实本虚,

治宜标本兼顾。每以大补元气之剂，资助先天，培补后天，同时兼取平喘祛邪之品，以折其标。固本培元是常用的方法之一。其目的在于顾护正气，培补已虚衰的元阴元阳。自拟固本培元方（紫河车、地龙、煅蛤壳、苍耳子、蝉蜕、甘草）研末吞服，缓补元气。而在配方中注重药性及配伍后的效应。哮喘发作阶段，一般都存在着继发性肺部感染，类似祖国医学中所说的“热毒”。因此，在处方选药时，伍用鱼腥草、山海螺、开金锁等清热解毒药，以增强疗效。

如治刘某，男，35岁。15岁时发哮喘，每年10月发病。平时每遇煤气、寒冷、灰尘必发哮喘。来诊时哮喘又发，呼吸急促，短气不足以息，喉中喘鸣，喘不得卧，辗转不宁，痛苦异常。精神疲倦，形体消瘦，咽喉肿痛。舌苔白腻，脉细濡。证属痰热壅肺，肾不纳气。治拟清热化痰，宣肺平喘，摄肾纳气。处方：党参12g，白术9g，茯苓9g，淮山药9g，菟丝子12g，五味子6g，麦冬15g，黄芪12g，陈皮6g，半夏6g，鱼腥草30g，山海螺15g，开金锁15g，地龙粉（吞）3g。服药14剂，病见起色。上方稍作加减，连进2年余，哮喘未再发作。续予调补善后，以资巩固。处方：党参15g，麦冬15g，五味子6g，菟丝子12g，淮山药12g，茯苓12g，南北沙参各12g，半夏6g。本例患者病经20余年反复发作，病根深而病机复杂。由于久病，导致下元虚损，出现肾不纳气，复感时令之邪气，致使肺气失宣，气机上逆，形成上盛下虚之象。病未发，治应扶正；病已发，宜祛邪。本例就诊时适值病发甚剧，痰热壅盛，阻碍清道，故哮喘不已。方取多味清肺化痰平喘之品，挫其病势，松动病根。同时，针对病人肾不纳气，已有下元虚亏的特征，施以培补正气，摄肾纳气之药。扶正与祛邪并举，故获效。^[54]

52. 印会河诊治经验

治咳喘，印氏重在辨痰。

如治一女青年，患哮喘3年，每逢秋冬哮喘发作，每次发作约20余分钟，夜间尤甚。在某医院诊为过敏性支气管哮喘，经治疗未能控制病情。来诊时适逢喘发，咳嗽连声，呼吸不续，咳吐白沫，胶粘难出，继则鼻中滴血数滴，舌红、苔少，脉细数。诊为热哮，治以清燥润肺。处方：沙参30g，甘草6g，枇杷叶10g，石膏20g，杏仁10g，麦冬12g，黑芝麻15g，全蝎6g，僵蚕6g，蜈蚣3条（研末吞服），桑白皮10g。2剂药后喘停发，续服4剂，喘未发作，再以前方稍事增减巩固疗效，共服药30剂。随访2年余未发作。

印氏认为，治咳喘重在辨痰，痰的有无与痰的质地、颜色，咳出爽与不爽均为辨治咳喘的关键。痰白稀量多，咳吐甚爽者宜温化痰阴，治以小青龙汤加石膏为主；白痰量少成块，不易咳出，兼见喉痒者，宜化痰宣肺，以程钟龄之止嗽散化裁治之；白痰量多成块，咳唾爽快喘重者，宜除痰降气，治以苏子降气汤加沉香为主；痰黄稠量多，甚或腥臭呈脓状，宜清肺化痰，治以清气化痰汤为主；痰黄量少不易咳出，兼喘者，宜清降肺热，治以麻杏石甘加桑白皮、葶苈子；痰黄白相兼，咳唾爽快，喘重者，宜宣肺平喘，方以定喘汤为主；干咳少痰甚或无痰，舌红苔少者宜清热润燥，治以桑杏汤合泻白散；咳唾白沫，粘于口内，难以咳出者，宜清燥救肺。^[55]

53. 胡翘武诊治经验

肺居上焦，为五脏六腑之华盖，外合皮毛，上系咽喉，

开窍于鼻。具宣发治节之职。外邪袭入，无论是从皮毛而侵，还是由口鼻而入，均可传至于肺。故内脏受邪，肺则首当其冲。且其脏既轻虚又娇嫩，不耐病邪之克伐。一旦外邪相克，即壅闭不宣，其应有之职能随之失司。此时若能调补肺金，振奋其宣发治节功能，对驱邪外出，阻止截断病邪之深入传变，起到积极的作用。

①温肺补气法：肺素虚冷，气阳不足者，卫外失固，腠理稀疏。稍一不慎，即客外邪，内舍于肺。两虚相得，经久不愈，症见终日洒淅恶寒，手足欠温，自汗或少汗，遍体酸楚，神疲乏力，少食懒言，呼吸气短，面色萎黄，咳唾清涎，鼻塞流清涕。或邪恋日久，兼有化热时，可见痰黄口干等症。舌质淡红且润，苔薄白或黄白相间。脉虽浮数、浮缓、浮滑，但总以虚软无力为多见。此乃肺金气阳不足，表邪客著，无力行宣发透达之机以逐邪外出。若只投以宣肺解表止咳化痰、调和营卫、祛风固表、清宣肺金、辛凉宣透等法，皆舍本逐末之举。殊不知肺之气阳一日不复，外客之邪即一日不解。应在辨证选用之方药中，辅以干姜、党参、炙甘草温肺补气，以复肺之气阳振奋其宣发透达之机，以利驱邪外出。且三药合用，亦寓温运脾土以生肺金之义。

②滋肺益气法：外感温热之邪，最易灼伤肺阴，邪热炽盛则“壮火食气”，肺气又每无不虚，或肺之气阴素本不足之人，外感温热之邪后，必呈本虚标实之候。其与肺之气阳不足虽有属性之别，但失宣发透达之机则一。其不同之治法，彼用温肺补气之品振肺以透达客邪，此用滋肺益气之味兴金以宣逐痰热。临床所见之症除发热不恶寒或微恶寒，咳喘气急，胸闷痰阻，面赤如妆，口干、苔黄腻等症外，气短不足以息，头昏乏力，自汗，舌嫩红，脉浮虚

数及喉间痰声漉漉，但无力咳出，有时施尽全力只咳出一小口痰时，即见大汗淋漓，神疲倦怠，静卧片刻乏力稍复等。治此痰时，若徒用清热化痰止咳平喘之剂，不辅以滋肺益气之品助肺金以宣逐痰浊，必不为功。曾治一女性患者，向有宿喘，又感暑热之邪，症见发热多汗，哮喘气急持续不已，喉间痰声漉漉，胸膈憋闷，呼吸极度困难，面赤唇红，目突抬肩，头发终日湿润；无力咳出一口痰，有意用力咳时，痰至胸膈或咽下即还，且大汗淋漓，神疲体倦，舌淡红中有裂纹，苔黄白微腻，而两脉浮虚。此乃暑热袭肺，耗气伤阴，引动宿喘，煎熬津液，痰热交阻，呈本虚标实之证，亟拟固正祛邪。处方：冬瓜仁 30g，葶苈子 10g，桃仁 10g，滑石 18g，南沙参 20g，麦冬 12g，五味子 6g，鲜芦根 2 尺，甘草 4.5g。1 剂热退汗敛，哮喘大减，再剂气息均匀，痰易咳出，胸膈舒泰，后以清养肺金，健脾化痰之剂调治而愈。本例患者在就诊前已迭进中西药多日未效。检视方药皆清热化痰止咳定喘之品。此非药不对症，乃是无力托邪排痰，使气道闭塞不畅，而呈咳喘持续状态。故在清热化痰的同时，重用滋助益气养阴之品，故收事半功倍之效。^[56]

54. 郭振球诊治经验

老人哮喘，以痰喘之久而继作哮为常见。临床以喉间痰气作响，胸中多痰，粘结喉间，与呼吸之气相触成声为特征。其发病可因食味酸咸太过，或遇风寒湿热，气郁痰壅即发。哮喘发作时，宜分冷哮、热哮、痰哮，理肺以治标；哮喘停止发作后，则宜固肾以治本。

冷哮：多因外感风寒，邪入肺俞，寒饮内停，痰浊壅聚，阻滞气道而成。症见呼吸急促，喉中有哮鸣声，咯吐

粘痰或清稀痰涎，胸膈窒闷，面色灰暗，苔白，脉紧。治宜温肺散寒，豁痰利窍。方用射干麻黄汤、三子养亲汤、温肺汤加减；若冷痰凝固者，可酌用冷哮丸。

热哮：多因痰热胶固，肺气壅逆所致。症见喉有痰鸣声，胸高气粗息促，咳痰黄稠，胸膈烦闷，面赤自汗，口渴喜饮，舌红苔黄，脉滑数。治宜宣肺清热，方用定喘汤、桑白皮汤之类。若因受寒引起者，为寒包热证，宜散郁祛寒，方用三拗汤、越婢加半夏汤，发散寒邪以解郁热。

痰哮：多因风寒外束，痰浊壅盛所致。症见气急喘促，喉中痰鸣，声如拽锯，治宜宣肺降气，祛痰清火。方用五虎汤、白果汤加减。

肾哮：多因精气亏乏，摄纳失常，下虚上盛所致。症见气逆易喘，短气息促，痰吐起沫，动则心慌，腰酸肢软，脑转耳鸣。治宜补肾摄纳。方用肾气丸，或紫河车粉。

此外，症状虽已消除，还须避免各种诱发因素。首先注意气候影响，防止外邪侵入。老人卫外之阳不能充实腠理者，宜用益气固卫之剂，如玉屏风散少量调蜂蜜，日服2~3g。同时生活起居当有定时，避免疲劳和情志刺激，耗伤正气。慎饮食、薄滋味，以杜生痰之源。^[57]

55. 赵锡武诊治经验

赵氏认为哮喘与气候有极其密切之关系，有的冬季反复发作，有的夏季反复发作，凡遇季节更迭气候变化即发病；有的嗅到异样气味或吃某种食物亦发病，所谓酒哮、盐哮、醋哮和糖哮等。一般而言，实喘则责之于肺，治当祛邪为主。初起外寒引动内饮者，咳咯白色泡沫状稀痰，小青龙汤最好，兼烦躁者加石膏尤宜；若系咳咯黄痰，出热汗，脉滑数有力，予厚朴麻黄汤加味：麻黄 9g，厚朴

9g, 杏仁 9g, 干姜 9g, 细辛 9g, 五味子 9g, 白术 12g, 石膏 9~30g, 大枣 7 枚, 浮小麦 30g。气虚加党参, 喘甚加白果, 痰多加二陈汤。虚喘则责之于肾, 此多为实喘迁延日久发展而来, 症见咳痰黄稠, 动则气喘, 张口抬肩, 乃上盛下虚, 方选六味地黄丸或加五味子、沉香以纳气归根; 肾阳虚者, 金匱肾气丸主之。

“春夏养阳, 秋冬养阴”。对夏日静止期患者服用金匱肾气丸, 到冬天有不少病人发病次数和程度都明显减少或减轻, 说明这对哮喘病的控制有积极意义。对本病患者胃气之强弱, 应予以重视。盖脾虚胃弱可致湿浊停聚而水泛为痰, 酿致发病, 是故用药应兼顾脾胃, 不可滥投损戕胃气之药; 嘱患者力戒肥甘、荤腥炙煿之饮食, 以免助湿生痰。临床中常见患者食欲转佳, 表示脾运健畅, 为病趋好转或向愈之佳兆, 有助于判定病情之轻重及其转归。^[58]

56. 江心镜诊治经验

江氏治哮喘善用苏子降气, 配沉香温肾镇逆。曾治任某, 女, 54 岁。诊见: 患者病发 3 天, 倚息不得卧平, 喘吸张口, 呼多吸少, 两眼呆滞, 时而上翻, 形体瘦弱。辨证为肺气闭塞, 脾湿壅滞, 肾气上逆。以降气宣肺, 潜镇为宜, 方用苏子降气汤加沉香。处方: 炒苏子 10g, 法半夏 10g, 陈皮 10g, 厚朴 10g, 前胡 10g, 当归 9g, 沉香 4.5g (后下)。2 剂喘平过半, 已能稍进米饮, 原方加太子参 10g, 胆星 5g。3 剂痊愈, 继以调脾肾药善后。

江氏认为哮喘一证致病因素多端, 寒热皆可见, 应分型论治, 辨证着眼五脏, 不只限于肺, 其机制大概相关肺, 根在脾肾, 发作时逆气而上, 势不可挡, 乃肾间动气之作, 肺气膹郁, 脾湿痰盛, 故宜先镇纳潜降, 燥湿化痰, 宣肺降气

为急，喘平后着重补脾肾。沉香既可温肾，又可降气，为诸降气药所不及；如痰湿重配海蛤壳、胆星；气阴不足而喘配白果仁、北沙参；属寒饮加干姜、细辛、白芥子。^[59]

57. 王正公诊治经验

王氏认为随着时代的变迁，社会的进步，科学的发展，疾病的种类和特点发生了较大的变化。随着人口密度增加，环境污染的日趋严重，哮喘和慢支的发病率在逐年上升。而哮喘皆因反复感受风寒，失治误治，致肺失宣达、邪郁肺系，酿成痰浊，肺气肃清之令失行而造成。关键是“寒”邪，诚如《内经》所言“肺喜温而恶寒”。当遵《金匱》之法“病痰饮者当以温药和之”。并提出了“风为百病之长，寒乃六淫之首”观点。认为治疗秋凉外感，亦宜辛温宣透入手，切勿早用清燥润肺之品，以致留邪貽患。哮喘病人的过敏是“因病致虚，因虚致敏”，这种过敏随着合理的调治和体质的改善，是可以逐步缓解以至消失的。为了彻底根治哮喘，王氏提出了一套整体防治方案：①探本求源，审因论治。治疗上强调攻病宜早，达邪务尽。预防上逐步戒断西药，严防寒邪，重视忌口。②顺其生机，因势利导。③扶正固本，复其生机。并认为咳不离外感，痰不离肺脾，喘不离心肾。咳嗽乃机体固有之保护性反射。肺属金，叩则鸣也，只有顺其生机，驱邪外出，宣肺透达，始能肺气肃清而咳止。坚决反对一遇外寒咳嗽，即用大青叶、板蓝根、川贝母、蛇胆、竹沥、半夏之类，及非那根、氯化氨之类西药。若逆其生机，遏邪于里，胶着胸膈，易成哮喘。透邪咳自止，豁痰喘自平，故强调探源治本。肺为贮痰之器，脾乃生痰之源，治痰之道，在于制源畅流，故须温振脾阳，开肺豁痰，必要时用涌吐痰涎之法，以畅其流净其

肺。哮喘发作时，若能涌吐大量痰涎，必能迅速缓解。涌吐之法，非必皂荚、礞石之类，桔梗、白前亦有涌吐之功，只是剂量不同。肺病日久，必累及心肾。心阳衰、水饮不化，血行凝泣；肾气虚，肾不纳气，气不归元。故久病必瘀，久病必虚，久病及肾。对策是扶正固本、复其生机。但因哮喘素有宿根，仍须标本兼顾，不忘清除余邪。王氏常以丸方、膏方加工之作缓解期的调理。并采用4:4:2之比例，即四成益气活血、温心肾，四成宣肺平喘祛邪，二成健脾和胃化痰，疏补并进、邪正兼顾。

此外，王氏还善用大黄治哮喘，认为大黄治喘乃经典之法：《金匱·痰饮篇》有“支饮胸满者，厚朴大黄汤主之。”又有“腹满口舌干燥，此肠间有水气，己椒苈黄丸主之”。《神农本草经》亦谓大黄可治留饮。《千金·咳嗽》紫菀汤、五味子汤，皆用大黄合麻黄治咳嗽之症。而哮喘患者大多见大便干结，因肺与大肠相表里，肺经郁热，移于大肠，引起肠液干燥；气管痰涎分泌增多，均会导致水液平衡失调而致肠燥便秘。反之，肠失传导亦会促使肺气痹阻，清肃失行。故用大黄能通便泄热，且大黄有祛瘀通络之功，能祛胸膈胶固之老痰，故亦能平喘。^[60]

58. 黎炳南诊治经验

顽固性哮喘，指哮喘发作频繁，或发作持续，迭用中西药物难以缓解者。黎氏认为本病病机复杂，沿用常法往往难以奏效。故应根据患者的病理特点，灵活施用多种治法。

①温下清上：据黎氏观察，患者出现上热下寒者不少，而单纯实热证则不多。若见痰黄、咽红，或唇舌偏红、苔黄等症，未可遽下“实热”之定论。四诊详审，常可发现

部分患者有脾肾阳虚的表现，如面色苍白、自汗、肢冷、尿频、便溏、脉细无力，甚至张口抬肩、气短不续等气不归根之症。本病多起于感寒饮冷。夜寒阴盛时症状益甚，用过清凉病反增剧。上热，多为局部之兼症，而非哮喘发作的主要病因。下寒，才是病发之主因。辨证时须注意，唇舌暗红色深，为气郁血瘀之征，但易误作热证；喘作时，不论寒热虚实，其脉必数，不能单凭此作热证之据。黎氏的经验，哮喘切忌用过苦寒，若忽视下寒而把上热作为主因，甚至把假热误作真热治疗，必然加重病情。下寒上热者，治以温下清上法。可选补骨脂、巴戟天、紫河车、肉桂、当归、白术以温补脾肾；选用蚤休、毛冬青、黄芩、射干等以清上热。一寒一热，各有归经，自能温下清上，各行其功。

②祛瘀通络：顽固性哮喘患者肺病既深，血脉不畅，甚者可致心血瘀阻，治疗时应在宣肺降气的同时，早用、重用祛瘀通络之品，如毛冬青祛瘀通络而兼清肺，宜于夹热者；当归具活血补血且“主咳逆上气”（《神农本草经》），用于阴血不足者；桃仁、丹参适于瘀证明显者。此外，黎氏亦常选用地龙、全蝎、僵蚕等虫类以搜络行瘀、祛风解痉。气血相从，血和则气顺，脉络畅通，有利于气机恢复。若待瘀证外现才予处治，则气滞血瘀互为因果，治疗十分棘手。黎氏曾指导研究生检测 17 例哮喘发作患者，发现均有微循环障碍，在方药中加用活血通络药物治疗 1 周后，患者哮喘症状明显缓解，复查甲皱微循环，均见毛细血管管径扩大，血流瘀滞现象消失。

③攻补兼施：久喘多有正气不足。脾虚者痰浊易生，虚者卫外不固，故屡为外邪所袭、触动伏痰引发哮喘；若专于治标攻邪，则痰浊随去随生，若致正气内馁，更无力

逐邪外出，病多缠绵或虽暂愈而时时复发，此为哮喘顽固难愈之症结所在。对肺脾气虚者，常加党参、白术、五爪龙等健脾以绝生痰之源，补肺以固表御外。阴虚者，加人参叶、麦冬、沙参等养阴生津。肾虚不纳气者，选加补骨脂、肉桂、鹅管石等补肾纳气。如患儿李某，女，5岁。哮喘发作8天。初起发热气喘，经服中、西药物，热退而喘益甚。现症喘咳鼻煽，痰鸣漉漉，流涕，多汗，纳呆，便溏，面色苍白，唇舌俱淡、苔白滑，脉细无力。证属肺脾气虚、痰浊内壅。乃投六君子汤合三拗汤以健脾化痰、宣肺平喘，佐五味子、龙骨敛肺止汗，配用当归养血活血，全方攻补兼施，散中有收，气血同调。药进3剂，喘咳减半，痰鸣不甚。原方略作加减，继服4剂病愈。

④疏肝通腑：哮喘病发在肺，而其因则非独在肺。肺主一身之气，其他脏腑气机失调，均可影响肺气之宣降。除注重调理脾肾外，黎氏尚注意疏理肝气与降气通腑。顽喘患者往往精神苦闷，导致肝气郁结，反侮于肺，又可加重病情。肺与大肠相表里，气机相通。气逆而喘者，每致腹胀便秘。腑气不通，又令肺气不降。黎氏常用枳实、川厚朴、胖大海降气通腑；夹热者酌加大黄，用量以大便畅通为度。

⑤益气升阳：哮喘者肺气逆上，一般慎用升提之品。用之不当，每见喘咳加剧。若患者气喘不甚、但绵绵不已，且伴脾虚气陷见症，如气怯声低，动辄出汗，腹泻便溏，或尿频遗尿，面色苍白，舌淡苔白，脉弱无力者，可用益气升阳与降气定喘并进之法。人参、黄芪益气升阳，能健旺脾胃之气而上充于肺，肺气旺则有助于其肃降功能之恢复，故与宣肺气之品合用，有相辅相成之效。

⑥顽症药量：哮喘患者多为本虚标实，用药宜及病则

已。但顽喘者病情深痼，邪正相持不下，黎氏主张在病机关键处重兵击之，且兼以扶正，可获捷效。若以“轻清”自囿，则药力不济，迁延时日，正气更伤，如用细辛，古有“细辛不过钱”之说，黎氏指出，此为用于散剂之限量，若作汤剂，可投 6~8g（小儿 1~4g），对顽喘者有较好的散寒化饮效果，未见有明显的不良反应。桂枝温通经脉，黎氏常重用于寒性顽喘者，小儿用 8~12g，年长儿可投 15g 以上，成人常需 15~30g。如治某 14 岁男孩，其喘而痰白，恶寒喜暖，面白肢冷，脉浮而紧，证属感寒作喘。初拟小青龙汤加减，桂枝用 15g，药进 3 剂，症稍减而未见显效。虑其寒凝经脉，桂枝量轻难以为功，乃加量至 30g，余药不变，续进 2 剂，患儿自觉全身温暖，喘咳大减。^[61]

【按语】

顾丕荣认为支气管哮喘最根本的病因是湿毒，因而主张用化哮八宝丹化湿泄毒根治哮喘。祝湛予治疗支气管哮喘以抗敏为特色，其经验方“抗敏煎”临床运用，确有疗效。邵长荣治疗支气管哮喘激素依赖者采用平肝纳肾法取得独特效果，其治疗支气管哮喘用射干、款冬花、补骨脂、车前草颇有特色。俞岳真诊治支气管哮喘注重三审二重，可供临床参考。张沛虬治疗支气管哮喘在辨证论治的同时，善用地龙，取得较好疗效。赵子贤治疗支气管哮喘善用经方辨治，扩大了经方的运用范围。从脾胃论治是曹世宏治疗支气管哮喘的特点之一，以健运脾胃为本，祛风化痰为标，匠心独运，疗效确切。洪广祥抓住痰、瘀、虚的病机特点，圆机活法，治疗支气管哮喘取得良效。吴银根治疗支气管哮喘善用药对，如麻黄与麻黄根、桂枝与厚朴、当

归与苏子等，临床应用颇有效验。王会仍根据脏病治腑的原则，治疗哮喘不忘保持腑气之通畅，尤其是痰热壅肺而腑气不通的实证哮喘，适当加入通腑泄热或润肠通便之药，如瓜蒌、桃仁、大黄、枳壳等，能使腑气通而肺气降，更快地达到平喘的目的。李仁生对激素依赖性哮喘运用中医药分期辨治，对平息喘逆，配合减停激素效果较好。颜德馨根据冬病夏治的原则，常于夏季嘱支气管哮喘患者服苓桂术甘汤，即可减少发作或不发作，此法可取。晁恩祥认为支气管哮喘的病因病机与风邪“善行数变”的性质相符，其疏风解痉法颇具临床意义。

(郭桃美)

参 考 文 献

- [1] 满叔梁, 程建英. 顾丕荣运用化湿泄毒法根治哮喘. 吉林中医药, 1990, (6):9
- [2] 汤淑良, 石建芳. 顾丕荣治疗过敏性哮喘的经验. 湖北中医杂志, 1992, 14 (4):4
- [3] 汤淑良. 治验三则. 辽宁中医杂志, 1989, 13 (8):30
- [4] 董振华, 季元, 范爱平. 祝谌予治疗哮喘的经验. 浙江中医杂志, 1994, 29 (1):19~20
- [5] 唐忆星. 邵长荣老师治疗呼吸系统疑难病案四则. 黑龙江中医药, 1997, (5):22
- [6] 唐忆星. 邵长荣老师治喘三法. 辽宁中医杂志, 1988, 12(3):17
- [7] 刘亚生. 邵长荣老师治喘常用的若干药与方. 福建中医药, 1986, 17 (2):30~31
- [8] 周学平. 周仲瑛临床经验举隅. 浙江中医杂志, 1990, 25 (7):292
- [9] 戴克敏. 姜春华治疗哮喘的经验. 安徽中医学院学报, 1990, 9 (3):17

- [10] 姜春华. 三言两语医话. 黑龙江中医药, 1987, (4):34
- [11] 王仁尧. 俞岳真老中医治喘经验. 浙江中医学院学报, 1983, (4):33~34
- [12] 陈子涵. 俞岳真治疗咳喘经验. 中国中医急症, 1996, 5 (2):79
- [13] 唐福安. 喘证辨证施治. 浙江中医学院学报, 1987, 11 (3):22~23
- [14] 叶德铭. 从临证谈哮喘. 浙江中医学院学报, 1990, 14 (3):25~26
- [15] 张沛虬. 支气管哮喘的证治. 浙江中医学院学报, 1987, 11 (6):22~23
- [16] 崔秀芹, 韩镠, 张天嵩. 赵子贤教授应用经方治哮喘发作的经验. 国医论坛, 1998, 13 (3):22~23
- [17] 程枫. 刘明达主任医师治疗支气管哮喘经验介绍. 贵阳中医学院学报, 1998, 20 (2):9~10
- [18] 史锁芳. 曹世宏治支气管哮喘经验. 江西中医药, 1998, 29 (6):7~8
- [19] 王虹. 崔玉衡治哮喘三法. 河南中医, 1998, 18 (4):227~228
- [20] 宾学森. “宣、降、纳”为曾庆骅常用的治哮喘方法. 江西中医药, 1993, 24 (4):3~4
- [21] 蔡灿林. 赵凤达. 洪广祥预防哮喘复发的经验初探. 江西中医药, 1993, 24 (6):2~3
- [22] 张智龙, 刘方英. 治喘经验. 江西中医药, 1989, 20 (4):7~8
- [23] 周炳文, 周绎彬. 谈治“虚喘”经验. 江西中医药, 1989, 20 (4):9
- [24] 刘弼臣, 杜昌华, 屠揆先, 等. 支气管哮喘证治. 中医药研究, 1987, (5):2~5
- [25] 刘德清. 张翰清教授治疗支气管哮喘的临床经验. 天津中医, 1990, (1):9~10
- [26] 要全保. 吴银根提高哮喘远期疗效的经验. 浙江中医杂志, 1999, 34 (7):286~287
- [27] 冯新格. 吴银根妙用药对治疗支气管哮喘. 浙江中医杂志,

- 1999, 34 (12):507~508
- [28] 骆仙芳, 蔡宛如. 王会仍辨治支气管哮喘的经验. 浙江中医杂志, 1999, 34 (4):147~148
- [29] 冯德华. 许建中中西医结合治疗哮喘的学术思想简介. 湖北中医杂志, 2000, 22 (3):3~4
- [30] 赵铁良. 方和谦谈《伤寒论》治喘诸方的运用. 中医杂志, 1994, 35 (9):567~568
- [31] 李仁生. 糖皮质激素依赖性哮喘分期辨证经验. 中医杂志, 1994, 35 (11):657~658
- [32] 田海河. 董建华治宿喘经验. 中医杂志, 1990, 31 (6):18
- [33] 曹鸣高, 姜春华, 邵长荣, 等. 支气管哮喘证治. 中医杂志, 1984, 25 (10):4~7
- [34] 张玉洁, 郭玉萍, 董秀芝治疗哮喘的经验. 山东中医杂志, 1999, 18 (10):464~465
- [35] 范欣生. 许济群教授治疗哮喘经验. 山东中医杂志, 1995, 14 (6):273~275
- [36] 王兴娟. 沈自尹治喘经验. 中医杂志, 1999, 40 (3):139
- [37] 胡国俊. 支气管哮喘夏季发作辨治体会. 中医杂志, 1999, 40 (6):331~332
- [38] 王有奎. 哮喘汤治疗支气管哮喘的经验. 山西中医, 1999, 15 (2):7~8
- [39] 杨质秀, 刘姝. 孙恩泽治疗支气管哮喘的经验. 黑龙江中医药, 1999, (4):22~23
- [40] 祁守鑫. 田玉美临证经验撷菁. 湖北中医杂志, 1995, 17 (6):2
- [41] 包培蓉. 吕同杰哮喘证论治经验. 中国中医急症, 1995, 4 (1):29
- [42] 张洪春, 晁恩祥. 疏风解痉法治疗过敏性支气管哮喘的临床研究. 中国中医急症, 1998, 7 (2):54
- [43] 崔儒涛. 王左教授治疗支气管哮喘的经验. 中国中医急症, 1997, 6 (3):116

- [44] 顾玉龙.《医话》阳和饮治哮喘案议. 黑龙江中医药, 1984, (3): 21
- [45] 奚凤霖老师加味运用玉屏风散的经验. 江苏中医杂志, 苏州吴中医学研究所, 1993, (1): 3
- [46] 林越汉. 盛国荣治疗哮喘经验简介. 江苏中医杂志, 1987, (12): 4
- [47] 柯联才, 盛云鹤, 陈炳焜, 等. 盛国荣教授运用白虎汤的经验. 辽宁中医杂志, 1983, 7 (7): 7
- [48] 李兴培. 王文鼎治疗哮喘经验琐谈. 江苏中医杂志, 1984, (1): 15
- [49] 李中南. 王正雨治喘五法. 湖北中医杂志, 1991, 13 (2): 2
- [50] 李平. 费开扬治疗哮喘病用药经验. 江苏中医, 1998, 19 (6): 10
- [51] 史锁芳. 李石青治疗支气管哮喘持续发作的经验. 江苏中医, 1995, 16 (8): 3
- [52] 原明忠. 喘证. 山西中医, 1986, 2 (6): 10
- [53] 郭天玲, 郑昌雄. 曹惕寅治疗咳喘的经验. 江苏中医杂志, 1981, (1): 14
- [54] 周荣根. 朱锡祺老中医治疗哮喘的经验. 辽宁中医杂志, 1982, 6 (9): 35
- [55] 全汉明. 随师小记. 辽宁中医杂志, 1985, 8 (9): 34
- [56] 胡翹武. 感证调补举隅. 辽宁中医杂志, 1985, 8 (3): 1
- [57] 郭振球. 老人喘咳哮喘的调治. 辽宁中医杂志, 1985, 9 (3): 8
- [58] 李兴培. 赵锡武教授临证遗珠采撷. 辽宁中医杂志, 1987, 11 (5): 1
- [59] 章新亮. 江心镜运用沉香经验举隅. 辽宁中医杂志, 1991, 18 (11): 14
- [60] 张家骏. 王正公老师治学之道. 辽宁中医杂志, 1992, 19 (7): 1
- [61] 黎世明. 黎炳南教授治疗顽固性哮喘经验. 新中医, 1994, 26 (12): 10

慢性阻塞性肺病

【概述】

慢性阻塞性肺病是一类以持久性气道阻塞为特征的慢性呼吸系统疾病，包括慢性支气管炎、支气管哮喘、慢性阻塞性肺气肿等。本病的病理特点均有不同程度的气道阻塞，或粘膜分泌亢进，其共同的临床表现为慢性咳嗽、进行性气急和阻塞性功能障碍，病情严重者可引起低氧血症，乃至呼吸衰竭。本病病因复杂，可能与吸烟、大气污染、感染、变态反应和遗传等因素有关。其治疗应针对引起气道阻塞的原发性疾病，在急性发作期往往合并呼吸道感染，可选用磺胺类药物或抗生素进行治疗。中医认为，慢性阻塞性肺病与痰瘀阻塞、肺脾肾功能失调有关，其治疗多根据临床表现分型论治。

【名医经验】

1. 梁乃津诊治经验

梁老认为，慢性阻塞性肺病的发生，虽然表现一派肺系症状，但实与脾、肾密切相关。若平素饮食不节、贪凉饮冷，损伤胃气而导致脾虚，脾运失司，水湿停滞，影响正常气机升降而波及肺气虚；先天肾气不足或后天消伐可

致肾虚，而肺气根于肾，肾虚则影响肺亦虚。肺气一虚，卫外失职，六淫之邪，特别风寒、风热每易反复袭肺，或邪盛正虚，或迁延失治，导致虚者更虚，实者更实，而易诱发本病的发作。肺气肃降受扰上逆而为咳，升降失常则为喘；脾虚运迟，津液停积而化为痰浊，风痰相扰，阻塞气道，出现痰多气闷，气促喘鸣等症。病久络脉瘀阻，痰浊瘀血互结，导致疾病难愈。对于本病的治疗，梁老认为，发作时以控制症状为主，缓解时以培正固本为重；控制症状又以祛风消痰为先，培正固本则以培补元气为要。梁老治本病很重视祛散外邪，使肺气得以舒展，恢复正常升降。常用方药有三拗汤（麻黄、北杏仁、甘草）、防风、苏梗、薄荷、青蒿、蝉蜕等。其次是除痰，祛除痰液是本病治标的关键一环。但本病多见虚实夹杂、寒热互错情况，在遣方用药上要注意除痰勿伤正，扶正勿助痰，勿过寒过热。若从寒化，多用三子养亲汤、陈夏六君汤、制南星、橘红丸等，以温肺化饮，健脾除痰；如饮郁化热，痰热郁肺，则用桑白皮汤（桑白皮、黄芩、黄连、山栀子、浙贝母、北杏仁、苏子、法半夏）、葶苈大枣泻肺汤、鱼腥草、青天葵、天竺黄、冬瓜仁等，以清热肃肺，祛痰平喘。治疗过程中可适当加活血祛瘀药，如桃仁、当归等以疏通脉络。缓解期的治疗除了益肺健脾外，梁老认为更重要的是培补肾阳，临证时多见肾阳虚症状，畏寒肢凉，腰酸尿频等，故在对症基础上酌加补骨脂、紫河车、杜仲、肉苁蓉、核桃肉、巴戟等，使肾阳振复，肺气有根。^[1]

2. 邵长荣诊治经验

邵老认为本病的发生和发展，与先天不足、后天失养有关，根据不同的个体差异，采用保肺、健脾和补肾等方

法治疗。邵老在治疗中常喜用麦冬一味，认为本品根据动物实验证明有提高耐缺氧能力，对心肺功能的提高和适应环境能力的增强有一定的作用。为防治本病，邵老还提出了保护肺功能的措施。①增强自身御寒能力，因为气候一旦转凉易得伤风感冒导致肺气肿复发，因此锻炼身体提高抗寒能力是做好自我保健的重要措施。②呼吸操的训练。邵老以传统的气功吐纳基本法则配合呼吸肌的操练创造了一套动静结合的“保肺功”，对改善肺功能有一定的疗效，使肺功能中最大通气量增加，残气量减少，横膈运动幅度成倍上升。③注意保肺健脾药食的调养，常用药有太子参、黄芪、白术、茯苓、莲子、薏苡仁、山药等，并配合足三里穴位注射核酪或黄芪注射液以培土生金，常可协助药食不足。^[2]

3. 李石青诊治经验

慢性阻塞性肺部疾病（简称慢阻肺），是一组慢性进行性呼吸系疾病，包括慢性支气管炎、哮喘、肺气肿，后期常并发肺源性心脏病，反复发作，迁延不愈。急性发作期以咳嗽痰鸣，喘息气逆为特征，属于中医的咳嗽、哮、喘、痰饮、肺胀等范畴。临床多见胸满如窒，胸痛短气，呼吸欠畅，甚至喘息不得卧。其痰饮浊瘀，痹阻胸阳，又与胸痹病机一致。李氏常用辛苦降泄，滑利通阳之品，如杏仁、瓜蒌、橘红、橘络、郁金、菖蒲、半夏、薤白等，辛以宣肺，苦以降逆，滑以泄痰。

李氏认为胸痹病在心肺。胸痹者，胸阳痹阻之谓。胸痹病位不独在心，尤其关肺。盖肺主气，朝百脉，君火健旺，如离照当空，尚需肺气以辅佐宣散，温煦百骸。外邪袭肺，久咳气喘，痰痹气窒，胸阳乃闭，而为胸满短气，

呼吸欠伸之候。慢阻肺由内伤久咳、支饮、喘、哮等积渐而成，以痰浊潴留，气还肺间，肺气壅阻为发病基础。肺气闭郁，久病心虚，卫外不固，屡为邪乘，病情日加。而发作期咳逆上气，痰鸣喘息，胸闷如窒，短气吸促，甚则不能平卧，口唇青紫等，气痹邪盛更为显著。以其肺卫虚弱，外邪直趋肺经气分，故少见表证，多为实证、里证。

慢阻肺之胸痹证主因胸阳为阴浊邪气所闭。清·尤在泾谓：“阳主开，阴主闭，阳虚而阴干之，即胸痹而痛。痹者，闭也。”在这里：阳，乃指上焦宣发温煦功能；阴，多指痰浊寒饮之类。痰浊水饮，留闭肺络，肺气失展，耗伤胸阳，阳虚推动无力，气化障碍。又生痰饮，遂致迁延。所以胸阳不振，气痹邪恋，往往互为因果，相互影响，导致痰浊互结，胶固不解。

李氏认为慢阻肺之胸痹证属肺经气分，病理性质属寒属实，常易化热成瘀。盖胸痹久郁，失于宣泄，易于化热，形成寒热互结。又肺气失展，阳气不运，不能辅心行血，导致心血瘀闭。病位初在肺、上焦，日久三焦受之，病及脾肾；病性由实致虚，由阳及阴，虚实夹杂。重者热动肝风，痰蒙神窍，气失治节，由虚致脱，而见抽搐、神昏、水肿、喘脱等危象。慢阻肺胸闭痹以胸阳不振，气痹邪恋为主要矛盾，治当通阳宣痹，理气化痰。《金匱要略》之用辛苦温泄，辛香走散，辛滑通阳药治疗胸痹证，树开泄之先帜。其后，《苏沈良方》载桔梗汤，寓开泄于升降法中。清·叶天士以轻苦微辛，具流动之品，“宣通气滞，以达归于肺”；“微苦微辛，能开上痹”治疗肺痹。《金匱要略》栝楼薤白半夏汤为治疗胸痹的代表方。方中薤白辛苦性温，辛温通阳宣痹，辛苦降逆泄热；栝楼涤郁热垢腻；半夏辛滑化痰散结。在此基础上，选用杏仁、半夏、厚朴、苏子、

蛤壳、竹沥、姜汁、连翘等酌情配伍，治疗慢阻肺急性发作期获较好的疗效。然本病因涉及寒热转化，痰气兼并，气病及血，虚实夹杂等，更多的还须与他法配合运用。

①配苦泄法：对痞气未开，气郁化热，痰从热化，内热偏重者，常用杏仁、菖蒲、紫菀、半夏、山栀子、黄连、豆豉等。若痰黄喘鸣，肺经热盛，加黄芩、桑白皮、射干；悸烦尿赤，心经有热，宜加连翘、丹参。②配化痰法：对肺痹未开，气郁生痰，症见舌苔粘腻，脉弦滑，胸闷痰多，咳吐不利，呼吸不畅，常配用半夏、旋覆花、川贝母、杏仁、桔梗、橘皮、紫菀、枳实等。痰郁化热，耗伤肺津，常参入清化痰热药，如知母、花粉、蛤壳、雪羹汤（海蜇、地栗）、莱菔子、竹沥、姜汁之类。痰从寒化，水饮阻气，拟加茯苓杏仁甘草汤、苓桂术甘汤等。③配化瘀法：对气滞血瘀，胸闷如窒，心胸作痛，舌紫苔腻，脉细滑或涩者，常配用菖蒲、郁金、桃仁、丹参、海藻、桂枝、甘草等。④配补养法：本病多为年老体弱之人，发作期虽以实证为主，但往往夹杂虚证。若偏气虚者，常用党参、茯苓、白术、桂枝、薤白；喘加厚朴、杏仁；偏于阴虚者，常用沙参、麦冬、知母、贝母、花粉、瓜蒌、紫菀、射干、蛤壳、莱菔子（煎汤代水）。若偏于肾虚，气失摄纳者，常用杏仁、紫菀、白前、白石英、山药、胡桃肉、冬虫夏草等，治疗伤实下虚之咳嗽。^[3]

4. 曹世宏诊治经验

①豁痰泄浊，以通其气：肺为娇脏，不耐寒热，且居上焦，为五脏之华盖，外邪侵袭，肺首当其冲，外邪犯肺，宣肃失司，升降失常，气机壅滞，肺气胀满。肺病日久，涉脾及肾，脾失健运，肾失蒸化，津液不归正化而为痰，

滞留气道，痰气交阻，胸阳痹塞发为咳痰喘息乃成慢阻肺。因此，痰浊遏肺，气道阻塞为本病发病的主要机理。发作期主要表现为咳嗽咯痰量多，气喘痰鸣，胸闷气堵，不能平卧，或伴寒热，甚者动则心悸，舌苔多厚腻，脉弦滑。肺部听诊可闻及明显干、湿啰音。治疗上以豁痰泄浊，行气通阳为首要。常用《金匱》瓜蒌薤白半夏汤、射干麻黄汤及葶苈大枣泻肺汤化裁。基本方药为薤白、全瓜蒌、法半夏、葶苈子、炙麻黄、射干、杏仁、桑白皮、大贝母。方中薤白辛可宣痹散滞，苦可降逆泄浊，极尽豁痰宽胸，行气通阳之能，合瓜蒌、半夏为本方主药；葶苈子下气利水，泻肺平喘。诸药合用共奏豁痰泄浊，通阳行气，宣痹散滞，肃肺化痰，止咳平喘之功。临证再据证之寒热略作加减，若痰从寒化，酌佐小青龙汤方中数味；若痰从热化则酌增定喘汤方中数味，每获佳效。

②清化宣散，继祛其邪：慢阻肺急发期虽经积极治疗，然余痰留肺者仍不在少数，此为慢阻肺迁延期。肺家余痰内伏，日久极易化热，痰热蕴肺，致使症情迁延不愈。因此清化宣散以祛其邪成为治疗慢阻肺迁延期的中心环节。辨痰方面，只要见痰粘质稠，苔腻脉数者，不论其痰色是黄或白，大多属热，不过有热轻热重而已。临床表现为喘鸣不甚，咳嗽咯痰间作，痰粘质稠色黄或白，咯吐不爽，胸闷，口干或苦，脉弦滑或略数，肺部听诊或可闻及少许干、湿啰音。基本方为桑白皮、瓜蒌、生蛤壳、一枝黄花、蒸百部、杏仁、炙马兜铃、法半夏、郁金、枳壳、丹参。津伤加芦根、南沙参养阴生津；喘甚者加射干、葶苈子泻肺平喘。诸药合用，共奏清肺化痰，行气活血，养阴生津之功。

③燥湿健脾，以顾脾胃：慢阻肺日久子盗母气，由肺

涉脾，脾运失健，津液不归正化积聚而为痰湿，与肺之余痰相合，壅遏气道，每可使慢阻肺患者再发或加重。因此，燥湿健脾以顾脾胃，杜绝生痰之源是治疗慢阻肺的重要手段。临床症见：咳嗽，气喘，或有痰鸣，咯白色泡沫样痰或稀痰较易咯出，伴胸闷，脘痞，纳呆，口不渴，舌苔白腻或滑腻，脉细濡。在用苏杏二陈同时，每喜用苍术、白术、党参、连皮茯苓、薏苡仁、冬瓜仁健脾燥湿利水；淡干姜温阳化饮，取“湿为阴邪非温不化”之意；枳壳、郁金行气，炒谷芽助运；喘甚者加麻黄、射干、葶苈子。

④清养肃肺，以善其后：慢阻肺患者日久每有阴虚津伤之征象。由于痰热余邪未尽，气阴两虚是本病迁延期或缓解期容易反复，难以除根之机理。因此养阴肃肺对于本病善后尤为重要。临床症见：气喘痰鸣不显，偶有咳嗽，咯痰间作量少，口干或渴，唇干或裂，便干，小便或黄，舌质偏红或有裂纹而少津，苔薄或黄而干，脉细弦滑或数，肺部听诊大多无明显干湿啰音。在用桑白皮、象贝、葶苈子、杏仁、百部清化同时，每喜用南北沙参、麦冬、太子参、百合、山药、芦根、花粉益气养阴生津。

⑤益气生津，以固其本：肺病日久，由肺涉脾及肾，致使健运失司，肾气不固，肺脾肾皆虚，甚则肺病及心，心气亦虚。临床表现为年高体弱者，咳痰喘息症状大多较缓，然动则气喘、胸闷，甚则心悸咳少声低气怯，神疲肢倦，腰酸膝软，头晕耳鸣，遇劳尤甚，面色少华，或有唇紫，舌质淡红或暗红、苔薄或少，脉细或弱。治疗上虽着重补养，但不废清化。此时患者余邪未尽，肺脾心肾皆虚，气阴不足，肺虚为主者以补肺汤为主化裁，脾虚为主者则以六君子汤为主加减，肾虚为主者以平喘固本汤出入。有心虚者佐以生脉饮，表虚不固者酌加玉屏风散。补气喜用太子参、党参、黄

芪；养阴用麦冬、南北沙参、百合；健脾喜用白术、淮山药、炒薏苡仁；肾虚者则加沉香粉、紫石英等；咳者加百部、杏仁；有喘者加地龙、五味子。在治本同时酌佐桑白皮、象贝予以清化，虽为扶正固本之治，但决不纯补，且熟地、阿胶等滋腻之品从不轻用，可谓擅治者也。^[4]

5. 蒋天佑诊治经验

蒋氏认为治疗老年呼吸系病，应注意以下4点。①老年呼吸系病，常见症状为咳、痰、喘，临证切忌见咳治咳、见痰治痰、见喘治喘，要找出引起咳痰喘的疾病本质而治之。②肺为多气少血之脏，多气易病气壅，少血常罹血瘀，故调理气血之治，在治疗老年呼吸系病中，显得十分重要。③肺与心、脾、肾之间关系十分密切，互为母子之脏，临床上子病及母、母病及子、母子同病者，屡见不鲜，治当求诸于本。同时，肺、脾、肾是人体水津代谢的枢纽；肺与心气血交流关系紧密，故治疗老年呼吸系病的咳嗽、喘咳、喘肿、痰饮、气滞、血瘀等诸病证时，要深究这些脏器之间的生理、病理关系，才能提纲挈领，得中肯綮。④要注意标本缓急，应遵循急则治其标；缓则治其本；标本俱急，标本同治；标急于本，当先治标；本急于标，当先图本的治则。

如治肖某，男，68岁，干部，患慢性支气管炎20余年，慢性阻塞性肺气肿10多年，肺心病1年多。现症见气短明显，动则益甚，吸气性呼吸困难，痰白粘不利，痰量每日约20ml，有咸味，咳嗽时作，口干，纳差，便干，尿畅，或腰酸困，下肢不肿，舌质暗红、苔淡黄白，脉沉弦。诊为喘咳，证属肾虚不纳，痰饮喘咳。治宜补肾纳气，化痰平喘，止咳活血。方用补肾定喘方（经验方）加味：熟

地黄 12g, 炒山药 10g, 补骨脂 10g, 丝瓜络 9g, 五味子 9g, 炙黄芪 15g, 葶苈子 12g, 炙麻黄 9g, 炒地龙 10g, 代赭石 15g, 露蜂房 9g, 炙款冬花 30g, 炙紫菀 30g, 金银花 12g, 麦门冬 9g。每日 1 剂, 水煎 2 次, 早晚分服。先后共服药 24 剂, 症状基本控制, 改丸药调理。肺主出气, 肾主纳气, 一出一纳, 呼吸乃成。本例始为咳嗽, 病浅在肺; 继则喘咳, 病深入肾。故而气短, 吸气困难, 动则为甚; 咯痰味咸, 腰酸且困, 此皆肾虚不纳, 痰饮喘咳之为患也。治疗此等虚实夹杂证, 当补肾纳气以扶正固本, 化痰、平喘、止咳、活血以治其标, 药证相投, 疗效自著。^[5]

【按语】

梁乃津治疗慢性阻塞性肺病重视祛散外邪, 使肺气得以舒展, 恢复正常升降, 在遣方用药上注意除痰勿伤正, 扶正勿助痰, 勿过寒过热, 缓解期治疗除益肺健脾外, 梁乃津认为最重要的是培补肾阳, 颇有临床意义。邵长荣治疗慢性阻塞性肺气肿, 喜用麦冬一味, 认为此药能提高耐缺氧能力, 对提高肺功能有一定作用。为防治本病, 邵长荣还提出了一些保护肺功能的措施, 其中的呼吸操很有特色。曹世宏则从四个方面辨治慢性阻塞性肺气肿: ①豁痰泄浊, 以通其气; ②清化宣散, 继祛其邪; ③燥湿健脾, 以顾脾胃; ④清养肺胃, 以善其后。对临床治疗慢性阻塞性肺病不无指导意义。

(肖达民)

参 考 文 献

- [1] 罗振华. 梁乃津教授治疗慢性阻塞性肺病的经验. 新中医,

1996, 28 (11): 7

- [2] 唐忆星. 邵长荣老师治疗呼吸系统疑难病案四则. 黑龙江中医药, 1997, (5): 23
- [3] 奚肇庆. 李石青论慢性阻塞性肺疾发作期从胸痹治. 江苏中医, 1988, (2): 1
- [4] 孙子凯. 曹世宏诊治“慢阻肺”经验. 江苏中医, 1995, 16 (11): 5
- [5] 蒋天佑, 蒋玮. 老年呼吸系病证治发微. 山西中医, 1995, 11 (4): 5

肺间质纤维化

【概述】

弥漫性肺间质纤维化是由原因不明或已知原因引起的弥漫性肺部感染性疾病，前者称为特发性肺间质纤维化。该病主要发生于肺间质，可累及肺泡上皮细胞，肺毛细血管内皮细胞和肺动、静脉。其病因已明者只占 35%，原因不明者占 65%。该病早期基础病变为肺炎，起病后逐渐加重。急性型会很快出现呼吸困难，平均存活 4 年；亚急性型可存活数年至 10 余年，最后死于呼吸衰竭或心力衰竭。本病目前尚无有效的治疗方法，是目前呼吸系统疾病中的难治性疾病，严重威胁着人类的生命健康。在治疗上，西医主要以激素治疗，但效果不理想且副作用明显。中医认为本病与先天不足、禀赋薄弱、肺肾两虚有关。肺部反复感染，邪气稽留，宣肃不彻，肺中津液受损，渐生痰浊瘀血等病理产物。其病位在肺，与脾肾密切相关。病性以虚证为主，本虚而标实，虚在肺脾肾，实在痰热瘀浊。尤其是长期应用大剂量激素治疗的患者，其痰热瘀浊、痰瘀交阻的内伤实邪更为突出。而特发性肺间质纤维化急性型病势凶险，多在半年内死亡。慢性型病势缓慢，自然病程 2~4 年。病初即出现肺脾胃三脏功能受损，终至肺叶痿弱，失其宣降功能，故呼吸困难。总之，本虚与邪实相互影响，互为因果，形成因虚致实，因实致虚，虚者更虚，实者更

实的病理特点。本病病情复杂，缠绵难愈，治疗难于速效。

【名医经验】

1. 曹世宏诊治经验

曹氏认为临床最常见的辨证分型有肺肾两虚、痰瘀互结证和肺肾两虚、痰热蕴肺证两类。前者症见活动后呼吸困难，胸闷气短，动辄气喘，咳嗽，咯少量白粘痰，面晦唇绀，舌紫暗，舌下静脉怒张、苔薄白腻，脉滑或涩迟。后者症见活动后呼吸困难，胸闷气短，动辄气喘，咳嗽，咯中等量以上白粘痰或黄脓痰，时有发热，大便干结，舌红、苔黄腻，脉滑或细数。据临床观察应用大剂量皮质激素冲击疗法的初治病人，其阴虚内热之候往往比较明显，故以养阴清热为法，药用南沙参、麦冬、玄参、桑白皮、地骨皮、黄芩等。对于应用皮质激素而继发肺部感染的病人，其气阴两虚、痰热内蕴之候同样明显，故以益气养阴、清热化痰为法，药用太子参、南沙参、苍术、白术、猪苓、茯苓、黄芩、全瓜蒌、桑白皮、生蛤壳、葶苈子等。对于长期应用小剂量皮质激素而病情相对稳定的病人，以益气养阴、活血化痰为法，药用南沙参、黄芪、苍术、白术、杏仁、桃仁、枳壳、郁金、紫石英等。而活血化痰法必须贯穿于本病治疗始终。但活血化痰药物的选择应以邪正盛衰为原则，避免破血伤正之品，常用药物有郁金、桃仁、川芎、丹参、泽兰等。单味口服药剂量不宜过大，否则有碍胃伤脾之弊。静脉制剂可选用川芎嗪、丹参液和脉络宁等。^[1]

2. 赵子贤诊治经验

赵氏对本病潜心研究多年,认为运用融多种中医治法于一方中的复方治疗本病,与单纯西医治疗相比,具有患者自觉症状好转明显且持久,生命质量提高,增强机体抗病能力,减少肺部感染机会等优点。

①病理机制:中医学尚未见本病明确记载,但可散见于“短气”、“咳嗽”、“喘证”等论述中。对于本病的病因病机,赵氏认为:致病因素侵入人体,留滞肺内,损伤肺脏,继则累及肾脏,造成肺肾俱虚。病位初在气,久则及血,病机涉及气阴两虚、痰瘀互结、热毒浸淫等多方面。病机虽复杂;但仍有一定的阶段性规律可循:初期致病因素侵入体内,损伤正气,正虚不运,痰瘀等邪气内生;痰、瘀蕴久化热,痰、瘀、热进一步加重正气损伤造成恶性循环;而且由于患者正气素亏,加上长期服用激素,机体御邪能力低下,易致外邪侵犯,更加损伤正气,从而形成正虚邪实的局面。总之,本病证属本虚标实,本虚为肺肾气阴两虚,标实为痰、热、瘀蕴肺,但以本虚为主,从而见有呼吸困难,动则喘甚,甚则不能活动,平卧则舒,乏力,干咳痰少,或咯黄粘痰,胸闷胸痛,口干,低热,汗出,口唇、四肢末端紫绀。舌质紫黯、有瘀斑,舌下静脉瘀滞等症状。

②立法用药:赵氏认为,对本病的治疗,应根据辨病与辨证相结合的原则选用药物。所谓辨证选药,就是选择治证的药物。由于本病以气阴两虚为主,兼有痰、瘀、热之邪,故治宜益气养阴为主,兼用活血化瘀、清热解毒、化痰定喘等治法,才能兼顾病机的诸多方面,取得较好的疗效。用药规律:益气药如党参、黄芪、黄精、茯苓、甘

草等；养阴药如沙参、麦冬、五味子、熟地等；活血化瘀药如当归、川芎、丹参、地鳖虫、地龙等；清热解毒药如金银花、连翘、黄芩、桑白皮等；化痰药如半夏、川贝母、款冬花等；行气药如陈皮、苏梗等；纳气药如山茱萸、白果等；定喘药如麻黄、苏子、炒杏仁等。其中党参“治肺虚，益肺气”，“能补脾养胃”；黄芪“补肺健脾，实卫敛汗”，“为补气诸药之最”；黄精“补肾润肺，益气滋阴”；茯苓“味独甘淡，甘则能补，淡则能渗，甘淡属土，用补脾阴，土旺生金，兼益肺气”。随证选择2~3味相伍，共奏脾肺双补，先天养后天，金水相生之功。沙参“清肺气，生肾水”；麦冬“味甘气平，能益肺金，……体润质补，能养肾髓”；山茱萸“益精，安五脏”；熟地“补五脏之阴”；五味子“敛气生津之药也”、“治喘咳燥嗽，壮水镇阳”。随证选用2~3味相伍则益肺肾之阴而平喘。金银花性味甘寒，平和无伤正之虞，善清热解毒，为治热毒之要药，清中寓宣散之力；连翘味苦微寒，“总清三焦诸经之火……一切血结气聚无不调达而畅通也”；桑白皮甘寒，治“肺气喘满”；黄芩苦寒，“除上部之积血”，治“胸高气喘”。以上诸药均入肺经，选用2~3味则清热解毒力更强。当归“辛甘温润，血滞能通，血虚能补”，“主治咳逆上气”；川芎“补五劳”，“消瘀血”；丹参“专入血分，其功在于活血行血，内达脏腑而化瘀滞”；地鳖虫“破留血聚集”；地龙“有解热、利尿、舒展支气管作用，可治气喘等病”。选用2~3味合补气药相辅相成，使气血畅行。半夏“燥胃湿，化痰，益脾胃气，消肿散结，除胸中痰液”，“下肺气”；川贝母“消痰，润心肺”，“清肺金而不败胃气”；苏子“主降，味辛气香主散，降而且散，故专利郁痰”，“治肺气喘急”；款冬花“主肺病，能泄郁结，定逆止喘，专主咳嗽”。

选择2~3味相伍可化痰定喘，伍活血药除胶结之痰瘀。陈皮“上则泻肺邪，降逆气，中则燥脾湿，和中气，下则舒肝木，调肾命。主于顺气、消痰、去郁”；苏梗“能使郁滞上下宣行，凡顺气诸品惟此纯良”。此二味同补药则补，且能促使血行痰浊化。麻黄配杏仁，一升一降，宣降肺内郁阻壅滞之气；麻黄合白果敛肺定喘不伤正。要之，遣方用药，要始终不忘益气养阴固本这一治疗大法，有外邪则祛，有痰浊则化，有瘀血则通，有热毒则清。

所谓辨病选药，就是选用治病的针对性药物。由于本病的发病机制可能与免疫、氧自由基损伤、胶原调节失衡有关，其病理特点为肺泡炎演变为间质纤维化的过程，而且在同一肺野中可见到各阶段的病理变化。现代药理研究表明，党参、黄芪、甘草、沙参、麦冬、五味子等益气养阴药，当归、川芎、丹参等活血化瘀药，金银花、连翘、黄芩、桑白皮等清热解毒药，均有调控免疫，提高机体抗氧化系统的抗氧化功能，清除氧自由基，抗炎等作用；活血化瘀药还能改善肺部微循环，改善血流变，抑制血小板聚集，其中丹参、当归、川芎具有抗肺纤维化形成作用；半夏、款冬花、桑白皮等化痰药及麻黄、白果、杏仁、苏子等定喘药具有抗炎、改善临床症状等作用。

总之，选用上述药物组方，应符合辨证与辨病相结合原则，同时还应据情随证加减：咳吐脓性痰加鱼腥草、瓜蒌、浙贝母、竹沥；胸痛加丝瓜络、旋覆花、茜草；纳差加焦三仙；心慌加桂枝、生地；下肢水肿加益母草、薏苡仁、茯苓等；喘甚加全蝎、蜈蚣、僵蚕、地龙等。由于本病虚实夹杂，迁延难愈，须守法长治，正如李中梓所云：“治实者攻之即效，无所难也；治虚者补之未必见效，须悠久成功”。

如治王某某，女，60岁。因“进行性气促2年，加重4个月”于1997年2月15日就诊。患者有类风湿病史20余年。2年前无明显诱因出现劳力性呼吸困难，初不为意，未加治疗。近4个月来病情加重，稍一活动则喘甚。至某省级医院诊治，拍胸部正侧位X片、肺部CT片示：双肺中下野弥漫性网状、斑点状阴影；肺功能检查示：限制性通气障碍。经专家会诊诊断为：弥漫性肺间质纤维化。给予强的松每日60mg口服及抗生素治疗3个月后未见明显效果，经他医介绍，求诊于赵氏。诊见：呼吸困难，平卧时轻，活动则加重，咳嗽，咯黄色痰质稠，纳差，乏力，口干，汗多，面色晦黯，口唇紫绀，杵状指，呼吸频率30次/分，双肺呼吸音粗，右下肺可闻及啰音。舌质黯红、舌下络脉瘀滞、苔薄黄腻，脉滑，重按无力。证属肺肾气阴两虚，痰热瘀蕴肺。治宜益气养阴，清热解毒，活血化痰，化痰定喘。处方：党参15g，全瓜蒌15g，生黄芪、金银花各30g，山茱萸12g，麦冬12g，黄芩12g，桑白皮12g，浙贝母12g，款冬花12g，丹参12g，当归12g，白果12g，苏子12g，苏梗12g，生山楂12g，清半夏9g，川芎10g，炙麻黄10g，甘草6g。6剂。每日1剂，水煎分早晚2次服，同时兑服竹沥10ml。2月22日二诊：服上药后，咳嗽咯痰明显减轻，气促稍减，续服6剂。3月1日三诊：服上药后，咯痰已止，偶有咳嗽，仍有活动后气促、乏力、口干等症，双肺呼吸音清，右下肺仍可闻及啰音。上方去全瓜蒌、浙贝、桑白皮、金银花、竹沥，加沙参12g，全蝎（研冲）10g，蜈蚣（研冲）2条，改党参为30g。随后据方加减调治3月余，活动后气促明显减轻，无咳嗽咯痰、乏力、口干等，面色红润，紫绀消退。采用Watters LC人等提倡的CRP计分法评定疗效为显效。并能参加一般性体力

活动。

【按语】

曹世宏认为肺间质纤维化与先天不足、禀赋薄弱、脾肾两虚有关，临证辨治常分肺肾两虚、痰瘀互结型和肺肾两虚、痰热蕴肺型，并认为活血化瘀应贯穿本病治疗的全过程，选择活血化瘀药应以邪正盛衰为原则，避免用破血伤正之品。赵子贤治疗肺间质纤维化，主张辨病与辨证相结合选择药物。辨证选药就是选择治证的药物，辨病选药就是选用治病的针对性药物，同时还要根据病情随证加减，对临床用药具有指导意义。

(肖达民)

参 考 文 献

- [1] 万毅刚. 曹世宏论治间质性肺病与特发性肺间质纤维化. 江苏中医, 1998, (2): 11
- [2] 张天嵩, 马君, 韩镭. 赵子贤辨治弥漫性肺间质纤维化经验. 浙江中医杂志, 1998, 33 (3): 102~103

慢性肺源性心脏病

【概述】

肺脏、胸廓或肺血管疾病使肺循环阻力增高、肺动脉高压、右心负担加重、右心室肥厚，临床上伴有肺、心功能不全者，即为慢性肺源性心脏病（简称肺心病）。肺心病患者按其心、肺脏功能代偿程度分为肺、心功能代偿期（缓解期）和肺、心功能失代偿期（急性加重期）。缓解期以治疗肺部慢性疾病为主，急性加重期以控制感染和纠正心、肺功能衰竭为主。中医学认为，肺心病属于心悸、喘证、咳嗽、痰证、饮证、水肿等范畴。主要病变部位在肺，但与脾、肾关系密切，进而影响于心，病性复杂，变化多端。临床常有寒痰壅盛、痰热壅肺、肺肾气虚痰浊壅盛、脾肾阳虚水湿浸渍、痰迷心窍、肝风内动等证型。肺心病的临床表现虚中有实，实中有虚。只有辨清虚实，才能施以正确的治疗。一般来讲，急性发作期以祛邪为主，缓解期宜扶正与祛邪相结合，恢复期以扶正为主。从现代医学的观点来看，肺心病的急性发作，喘咳、水肿等症的突然加剧，其关键原因在于感染。只有消除控制感染，病情才能迅速得到缓解。这个感染，中医称之为感受外邪。同样，只有驱除外邪，才能邪去正安。在这一点上，中西医是一致的。因此，在急性发作期，疏散外邪、清热解毒是行之有效的治疗方法。

【名医经验】

1. 董志中诊治经验

中医学没有肺心病的名称，根据其临床表现，与“肺胀”、“支饮”病类似。董氏根据临床体会，对本病有以下几点认识。

①肺心病的根源在肺，但肺与心又可互为因果：肺心病的病理变化主要是由于久咳损肺，气阴两伤，痰浊塞络，气道受阻，使肺脏之宣发肃降功能不全，吸入之气不能下贯心脉，积于胸中发为肺胀，故令呼多吸少，咳逆而上气，痰粘稠而不易咯出。习惯说：“肺主呼气，肾主纳气。”这是说在正常的生理状态下肺脏吐故纳新的功能。肺主呼气指的是吐故，肾主纳气指的是纳新，是说吸入之气和水谷之气相结合之后贮存于肝肾之中。在病理状态下，由于肺和心都失去了正常的生理功能，气虚则血瘀，血瘀又阻滞了气机，气胀于肺络，血瘀于心脉之中，液溢于脉外，停于心下，充于肌肤，成为咳逆倚息不得卧、全身水肿的支饮病。

②痰生于肺，饮停于心，痰因燥热，饮以寒凝：痰和饮既是肺心病的病理性产物，又是肺心病的发病根源。痰因肺脏燥热而生，饮是心阳虚损而成。历来认为，脾为生痰之源，肺为贮痰之器，董氏认为此说欠妥。因为，“脾气散精上归于肺”，乃是脾之正常生理功能，此种功能有赖于脾之阳气。若饮邪困脾，则脾阳虚弱而失去了运化水湿之功能，冷饮怎能成为燥痰上归于肺呢？痰既因肺家燥热，饮亦非脾不运化，因为心含百脉，主血液之运行。血指营血，液为水液，这是两种物质。心之阳气虚损则脉道不畅，致

使营血瘀积而血液滞留，水液自支络外溢于肌肤故称之为支饮病。由于肺心之功能不全，血瘀气滞不能化饮，水道不利，痰饮充斥三焦，既困脾阳，又伤肾气，造成了出入废、升降息的危急证候。

③辨证从天人相应着眼，立法从谨守病机入手：肺心病的发生与发展，有着一定的区域性和季节性，它多发生在我国的黄河流域以北，发病又多在小雪以后，清明以前。因此，自然界的变化与本病有着密切的关系。中医学认为，高寒区域，其气主收敛，发病多寒束于外而热伏于内。小雪以后冰封大地，清明之后才阴阳和谐。在此期间，自然界处于封闭和收敛状态，人们在生活中都闭门塞牖而居，所以室外气温寒冷室内气温干燥。肺为娇脏，外合皮毛而性喜宣发，入则燥热伤阴，出则风寒伤气，痰火伏于内而寒邪伤于外，久咳不已则痰浊阻络，肺气不宣，由气及血，由肺及心，更进一步则脾肾俱损。经云：“谨守病机，各司所属。”又说：“病发而有余，本而标之，先治其本，后治其标。病发而不足，标而本之，先治其标，后治其本。”由于本病的病机是肺脏功能损伤，导致了心阳虚损，心血瘀阻，水液停留，进而湿浊久渍，脾肾阳虚，因此，恢复肺脏的治节功能才能使其他证候迎刃而解。但是本病又是一个邪气有余而正气不足之证，故临床上应以攻邪为主。又由于本病为痰热内伏而寒饮外侵，既不可重用寒凉，又不可多用温热，故仲景有“病痰饮者，当以温药和之”之论。

④用药以温化为主，处方要加减自如：肺心病多以痰饮留著于内，风寒复感于外，加重了肺心功能不全而发病。董氏常用射干麻黄汤为基础而随证化裁，由于五味子酸敛有碍肺气而以熟地黄易之。李时珍谓地黄有生精华、补五脏、通血脉之功能，根据董氏的临床经验，熟地佐麻黄可

增强宣肺之功能而不散；麻黄伍熟地可加强通血脉功能而不膩。若寒饮外感加附子仿麻黄附子细辛汤之意以通阳解表，若痰盛于内加三子养亲汤用葶苈子减白芥子，可平喘定息而逐饮，如果寒饮已除症状平稳者，加茯苓、陈皮，以祛痰平喘为主，气虚自汗者可加人参。在用药剂量问题上，如果麻黄与熟地为伍，麻黄可用到 15g 以上，熟地可用 100g 左右，往往定喘有奇效。而生姜至少应用 25g 以上，否则就起不到散寒逐饮之效。^[1]

2. 杨继苏诊治经验

杨氏在对肺心病的成因、机理探讨方面有其独特见解，在治疗上积有丰富的临床经验。

①病因病机：肺心病多由于反复感受外邪，渐致肺失宣降、肺气日虚。“肺朝百脉”、“贯心肺而行呼吸”。肺可协调和辅助心脏所主的血液运行。肺气虚时，可损及心营，使心气不足，血脉瘀滞，以致肺心同病。亦可累及其他各脏。累及脾则脾失健运，酿湿生痰；累及肾则肾不纳气，动即气喘，甚则肾虚水泛上凌于心；若病情加重，邪热引动肝风则出现神昏、烦躁、抽搐等肝风内动之症。杨氏认为，本病虽然发展缓慢，证候相继出现，一旦形成，已为虚证，而反复感染是促使肺心病形成与病情进展的主因。其特点为“热”、“痰”、“瘀”、“虚”。

“痰因热成”：肺心病因痰作咳，因痰致喘。痰本为人身之津液，因受肺热煎熬，凝结而成，热乃生痰之因由。痰与热在一定条件下可互为因果，杨氏强调肺心病急性感染期的病机主要是“痰由热生”。

“瘀化痰水”：气血运行不畅，血脉瘀滞亦可生痰化水。痰可因气血瘀滞积热而成。一方面是“气滞痰聚发而为喘

为咳”，一方面是血瘀水停，水液渗于脉外，泛滥肌表而为水肿。

“本元皆虚”：杨氏认为，肺心病是在肺之肃降、心之行血、肝之体用、脾之运化、肾之摄纳功能失调或低下的内因基础上形成的。痰、喘也有虚实之别。景岳曰：“虚痰者何？谓其元气已虚也”。又曰：“凡虚喘之症，无非由气虚耳，气虚之喘，十居七八。”本病患者多年虚衰，形羸气弱，本元皆虚，其痰、喘亦属虚痰、虚喘。若兼有风寒、火热者，亦为本虚挟感之标证。

热、痰、瘀、虚病理特点之间彼此并不孤立，而是互相关联的。

②辨证施治：肺心病的临床表现错综复杂，既有虚实之互见，又有外邪、痰热、水饮、血瘀等夹杂之症。临床辨证分型方法颇多，但杨氏据多年临床经验认为在急性发作期，绝大多数偏重于痰热，故治疗可不作分型，至缓解期则予分型培本治疗。

急性发作期：急性呼吸道感染是本病的最主要诱因，患者多为饮痰内伏，外感引发，以致痰热壅阻。症见咳逆，喘息，痰黄或白稠不易咯出，苔腻，脉浮、滑、数等。杨氏多选用大剂清泄痰热药。如黄芩、大黄、鱼腥草、野荞麦根、七叶一枝花、金银花、连翘、桔梗、桑白皮、竹沥半夏等。并适当加入丹参、桃仁、赤芍、冬葵子等活血清热药。因为肺心病人血流缓慢，其郁滞之血，往往利于细菌生长而不利于清除代谢产物。杨氏常在清热药中伍以活血药，以降低血液粘度，改善血氧的渗透压，使药物易达病所，从而加强清泄作用。

若热邪未获控制受累心、脾、肾，出现心悸，胸闷，气短，唇舌爪甲青紫，浮肿和腹水等心功能不全症状，治

疗上杨氏在应用清热、宣肺、涤痰的基础上加入利水药，如葶苈子、车前子、地骷髅、冬瓜子与皮、茯苓皮、泽泻、茶树根等。然大量利尿药的运用，可致血液浓缩。故常佐泽兰、丹参、桃仁、虎杖根、马鞭草等活血利水药。使血粘稠度下降，心肺循环得以改善。

由于肺心病人的心、肺功能均有不同程度的损害，处于抵抗力低下的状态，对病原体侵袭的反应能力减弱，起病往往呈隐袭式。临床表现多不明显，不具发热、咳脓痰和白细胞增多的特征，但只要有咳、喘、痰多症状，仍应看作是肺部感染而不容忽视。当通气功能发生严重障碍时，易于诱发呼吸衰竭，甚至出现肺性脑病。肺性脑病是引起肺心病死亡的主因。此期治疗宜采用中西医结合治疗措施，在抗感染，畅通呼吸道，纠正缺氧、心衰的基础上，迅速纠正酸碱平衡失调和电解质紊乱。杨氏认为，因通气障碍，清浊之气不能纳吐，壅盛之痰热蒙蔽心窍，引动肝风，症见神昏谵语，惊厥抽搐，嗜睡等，治拟清泄痰热、芳香开窍、养阴熄风交叉并用。药如鲜菖蒲、郁金、连翘、天竺黄、鲜石斛、至宝丹等。并加入丹参、莪术、桃仁等活血药。若病情恶化，出现喘急，汗多肢冷，脉细微或结代等真阴耗竭，元阳欲脱之症，当急用别直参、参附汤扶正固脱。再辅以前法泄热、醒脑、活血、涤痰，标本兼顾。总之，急性发作期的治疗，控制肺部感染是治疗中的关键。杨氏在这一期的各个阶段始终重用大剂量的清泄肺热药，并调整服药方法，每日1剂半或2剂，同时针对病机，于各个阶段均佐入活血药以增强疗效。

缓解期：当感染基本控制进入缓解期，往往仍具有痰多、余邪未净的情况。在治疗上，仍应始终应用清热化痰、宣肺降逆药，予扶正祛邪并施。此期的突出矛盾是“虚”

和“瘀”，故处方用药应虚瘀并顾。肺心病人多气虚表疏，卫阳不固，常因新感引动宿疾。杨氏对表虚易感者往往在清宣活血药中伍用益气固卫之品，并指出益气固卫法不仅适用于反复易感患者，同样适用于具有变态反应素质的人。如黄芪等具有提高机体免疫功能的作用。肺心病多见40岁以上。《内经》曰：“年四十，而阴气自半也，起居衰矣。”何况有病之体，虚火内炽，阴液暗耗，在老年人中，气阴不足者，十之七、八。对高龄肺心病患者，更应顾及气阴，杨氏对咳声低弱，言语无力，舌质红，脉细数者，常选用南沙参、北沙参、山海螺、天冬、石斛、芦根、当归、赤芍、红花、丹参等养阴活血和营。

临床上有相当一部分患者，在急性发作期经用清宣化痰药后，咳嗽减轻，痰色由黄转白，痰质由粘稠变为清稀，痰液由难咯趋于咳吐松畅。然痰量反多未减。杨氏认为，这是肺热未得尽除而脾气已虚，脾失健运，酿湿生痰之故。治疗上不能单用清宣化痰或温化痰饮。杨氏常采用清宣活血、扶中化饮等法而多获效。方选四君、苓桂术甘加减合清宣活血药而成。

由慢支、哮喘而致的肺心病，因喘促日久，气不得续。历来以喘属肾不纳气，益肾纳气乃治喘之大法。本病患者的支气管常处于痉挛状态，由于通气功能及换气功能障碍所致的“喘”，虽其根在肾，但与其他脏器的虚损也密切相关。同时由于呼吸表浅，肺边缘部的肺泡活动减少或不活动，互相粘合，常有瘀滞。杨氏治喘，常在补肾的前提下与益气固卫、活血化瘀、宣肺化痰等法兼施。这对增强机体防御能力，改善心肺功能，无不相得益彰。

杨氏在治疗肺心病急性发作期，以清为主，结合化痰，佐以活血，并注意患者禀赋体质，权衡虚实。既顾其本，

又不碍邪，寓补于清之中。缓解期以益气养阴，扶正固本为主，佐以清热、活血。杨氏始终抓住“血瘀”这个共性。注重活血行瘀，达到改善心肺功能的目的。在肺心病的整个治疗过程中，都贯穿着清、活、补三法。只是所处阶段不同，其用药各有侧重罢了。^[2]

3. 洪广祥诊治经验

慢性肺源性心脏病，常因久病正气渐衰，复因外邪侵袭而发病，引起心衰。洪氏对本病潜心研究数十年，积累了丰富的临床经验，用于临床疗效显著。

①痰瘀伏肺是基本病机：肺心病患者素有咳喘痰多之患，病位以肺为主，就大多数病人来说，痰是一个主要矛盾。该病患者不仅痰浊壅盛，而且排痰不畅，极易痰郁化热（或称为继发感染）而兼见痰热证候。肺是血液进行气体交换的场所，全身的血液都是通过经脉而聚于肺，然后再输布到全身。因患者素有肺阳虚弱，或久咳久喘伤及肺气，或医者过用寒凉之药损伤肺阳，抑或过食寒凉生冷重伤肺阳。肺阳不足，肺失宣肃，肺不能布散水谷精微，肺津凝聚成痰，当素体肺阳虚，加之外邪束肺，使肺气不能推动血液正常循环，影响血液进行气体交换，而致血液瘀滞，造成血瘀。痰瘀互为因果，造成因果恶性循环。痰瘀伏肺是内邪，风寒外袭为外邪，内外合邪造成肺功能低下，而出现诸多症状。因而洪氏提出“痰瘀伏肺是肺心病心衰的基本病机”。

②重在治肺而不在治心：肺心病由于痰瘀伏肺日久，肺、肾、心、脾脏器亏虚，复感受外邪，出现虚人受邪特点。本病病位在肺，涉及脾、肾、心诸脏。平素痰瘀伏肺，而致肺气宣肃不利，出现喘咳不休、咯痰不止，在感受风

寒之后，咳喘明显加重，痰量骤增，肢末及唇发绀，不能平卧，并见肢肿尿少等症。因肺心病患者多为素体阳虚，抗御外邪无力，据临床观察本病绝大部分在寒冷冬季或春寒季节，气温骤降时发病。寒邪易伤阳气，致使肺、脾、肾、心阳气更虚，出现本虚标实之候。因肺素有痰瘀内伏，加之外邪束肺，使肺功能更加低下，肺的功能失常，不能进行正常的体内外气体交换。肺失通调水道之功，发生水液停聚而成痰、成饮。肺主治节，肺为相辅之官，助心行血。内外合邪，肺气壅塞，助心行血功能无力，导致心脉瘀阻。心主营运过度，进一步加重瘀血内停，血不利化为水，水邪留滞，渐至颜面及肢体浮肿和尿少。肺气为外邪郁闭和痰瘀壅塞，以致心血瘀阻，只有宣散外邪，涤除痰瘀，使肺气得宣、得降，则水道自通，瘀血之症也能缓解。

洪氏独具特色地提出“重在治肺而不在治心”。本病在缓解期，在未感受外邪或外邪很轻的情况下，即使有脾肾心阳气不足，而无肺气不宣的表证存在，并不发生水肿。只有复感外邪以后，肺气壅塞，水道失于宣通，发为水肿。故水肿的发生尤关于肺。在肺心病心衰时用涤痰除瘀、宣散外邪法，促使肺的各种功能复原。肺主气功能恢复，则帅血运行全身，促进血液进行气体交换，心主营运功能得到辅佐，即不出现心血瘀阻。人体气血运行畅通，心衰就可以得到纠正。这同西医认为治疗该病重在控制肺部感染，而不是重在强心的看法一致。

③外邪犯肺必须及时宣散：前已述及痰瘀伏肺是肺心病的主要矛盾，痰瘀留滞肺内损伤肺气，肺气虚极易感受外邪，内外相引而发生心衰。因此必须及时宣散外邪，涤除痰瘀。不少肺心病心衰患者，突发食欲骤减，精神萎靡，痰量增多，并无恶寒发热，化验血白细胞不高，无明显外

感征象。选用温阳利水、涤痰止咳法疗效不佳。洪氏观察病情细心，凭脉辨证，其绝招在于凭右寸脉浮以判定外感，验之临床，非常灵验。本病多在气温骤降时发病，由于患者素体阳虚，不能抗御外邪，气温突降身体难以适应，易感外邪。阳虚之人感受风寒，往往易从寒化，此时必须及时宣散风寒，避免留邪作祟。择药为：麻黄 10g，苏叶 10g，杏仁 10g，炙甘草 6g，生姜 3 片，细辛 5g，法半夏 10g，紫菀 10g，款冬花 10g，辛夷花 10g，苍耳子 10g。

若表现为肺部继发感染证候者，择药为：生麻黄 10g，南杏仁 10g，生石膏 30g，生甘草 6g，黄芩 10g，茯苓 15g，法半夏 10g，陈皮 10g，枳实 10g，竹茹 10g，金荞麦根 20g，天葵子 15g，蒲公英 30g。

④温阳利水、涤痰除瘀是基本治法：该病本虚为素体阳虚，诱因为风寒犯肺，痰瘀伏肺是基本病机。急性发作期往往因气候寒冷，气温骤降，病人出现咳嗽加重，痰量增多，神疲乏力，食欲减退，并无明显恶寒发热之症，渐至唇周及肢末发绀，颜面及下肢浮肿，尿少，不能平卧，需依赖输氧以维持呼吸，肺部可闻及湿啰音或哮鸣音等，显系阳虚不能温煦全身，阳虚不能推动血脉运行，心血瘀阻，血不利化为水。阳虚不能抗御外邪，易为外邪所侵，且寒邪重伤阳气。痰瘀日久，损伤肺气，肺病及肾，肺肾阳虚不能蒸化水液而泛滥肌肤，水气凌心，心血瘀阻。痰浊为阴邪，非温不化。因此温阳利水、涤痰祛瘀是其基本治法。择药为：制附子 10g，茯苓 20g，白术 15g，红参 10g，干姜 6g，泽泻 20g，山茱萸 10g，葶苈子 15g，牡蛎子 10g，青皮 15g，陈皮 15g，生大黄 10g，桃仁 10g，水蛭胶囊 4 个。若兼有气阴两虚可选加生脉散，制附子、白术、茯苓、泽泻、干姜共达温阳利水；红参、附子、干姜温阳

固脱防变。洪氏治疗本病善用葶苈子，究其因，据《中药大辞典》记载：“葶苈子……下气行水 治肺壅喘急，痰饮咳嗽，水肿胀满。……均使心缩加强，心率减慢，心传导阻滞，对衰竭的心脏可增加输出量，降低静脉压。”此药一药多用，既可涤痰利水，又可强心抗心衰，但用量一般在10~20g为宜。山茱萸可纳气平喘，同时还可预防喘脱。桃仁既可活血化瘀，又可通便以降肺气，一举两得。牡蛎子祛痰浊。青皮、陈皮疏利气机，洪氏常说治痰治疗要以治气为先，因为气顺痰易消，气行血亦活，从而达到痰消瘀散的目的。生大黄通腑气，腑气通则肺气自降。水蛭胶囊既治瘀阻，又能改善毛细血管供血，缓解气管平滑肌痉挛，使气道通。肺心病多易内闭外脱，内闭为痰瘀闭阻，外脱为阳气暴脱。全方共奏温阳利水、涤痰除瘀之功，确实能收到开闭防脱的疗效。

如治喻某某，女，67岁。慢性咳喘心悸10年，伴唇周及肢末发绀、下肢肿5天而求治。诊见：气逼，不能活动，难以平卧，胸前闷胀痛，倦怠，嗜睡，形寒背冷，咳嗽咯少许粘白痰，舌质暗紫，苔白黄相兼厚腻，脉弦滑数，右寸脉浮。诊为慢性肺心病并心衰。辨证为心阳虚衰，痰瘀阻肺，风寒引动夙根。治宜温心（肾）阳，化痰瘀；佐散肺寒。处方：生麻黄10g，熟附子10g，细辛5g，红参10g，肉桂5g，茯苓15g，白术15g，炙甘草6g，法半夏10g，陈皮10g，生姜3片，水蛭胶囊6个。服5剂，诸症悉减，能平卧，唇周及肢末发绀消失，下肢浮肿明显消退。继续温阳涤痰化瘀，方选苓桂术甘汤、真武汤合蠲痹汤（洪氏经验方）加减以善其后。本案抓住标实本虚的病机，标实为风寒外束，兼有痰瘀伏肺，引发咳喘；本虚为心肾阳虚，法选表里同治，麻黄附子细辛汤温阳解表，参附汤

配合真武汤以温心肾之阳，离照当空，阴霾四散，配以蠲哮汤涤痰化瘀，故病情可迎刃而解。

又如治曾某某，女，54岁。反复咳嗽气喘40多年，肢肿不能平卧3天而入院。诊见：咳嗽气喘，痰多粘白，动则气喘，需依赖输氧以维持呼吸，形寒背冷，肢末及唇周发绀，面色晦滞，舌质暗，苔白，脉细弦滑，右寸脉浮滑。诊为慢支并感染、肺气肿、肺心病、心衰Ⅲ度。辨证为外寒引动痰瘀夙根。治宜温肺散寒，涤痰行瘀，利气平喘。处方：射干10g，麻黄10g，细辛5g，生姜10g，法半夏10g，紫菀10g，款冬花10g，葶苈子15g，青皮15g，陈皮15g，水蛭胶囊6个。服药7剂，咳嗽气喘明显减轻，已能平卧，撤除给氧。仍觉形寒背冷，肢末不温，咳多量白泡沫痰，舌质暗，苔白，脉细弦滑数，显系外感风寒渐除。继续温补肺阳，涤痰祛瘀以平喘。洪氏经验，见右寸脉浮以判断外感，参以临床症状综合分析，辨证为风寒引动痰瘀夙根，治以温肺散寒以解表，涤痰祛瘀以治痰瘀伏肺，因而疗效显著。^[3]

4. 曾庆骅诊治经验

①病机见解：肺心病是慢性支气管炎及许多肺系疾病的结局，症状表现属于中医学的“咳喘”、“痰饮”和“水气”等病范畴。肺、心、脾、肾四脏的虚损是此病之本，外邪侵袭则形成本虚标实的证候。本病既往均有长期慢性咳喘过程，大多有受凉则发、形寒怕冷、咳嗽痰多等特点。本病之始，起于肺脏，然后累及他脏，形成肺心病。

首先，肺脏自病。肺主气，司呼吸，开窍于鼻，通于外气，又主皮毛，司汗孔，宣行卫阳之气。外邪入侵，多首先犯肺，故肺有“娇脏”之称。肺气以清肃下降为顺，

以壅塞为逆，只受纳清气（清新的空气与水谷精气），受不得浊气（风、寒、燥、热、烟尘与痰饮等），浊气干之，则生呛咳。若浊气干之日久，则久咳伤肺。咳伤肺气，则卫阳虚而生外寒，故见形寒背冷，呼吸短气。久咳伤津，则见口干咽燥，痰少难出，甚或潮热消瘦。咳伤肺络，则血络瘀阻，呼吸不畅，肺气壅塞而成为“肺气肿”。

其次，影响他脏。《内经·咳论》云：“五脏六腑皆令人咳，非独肺也。”是说他脏疾病能影响肺脏；反之肺脏之病，也可累及他脏，如肺病及心、肺病及脾、肺病及肾等。肺病及心者，因肺朝百脉、心主血脉，汇合于肺。而肺主气，气行则血行，气滞则血瘀，若肺气壅塞日久，必然导致心血瘀滞而症见口唇、爪甲、舌青紫，面暗无华，颈腹青筋暴露（静脉曲张）等症。肺病及脾者，主要见脾失健运。《内经》云：“饮入于胃，游溢精气，上输于脾，脾气散精，上归于肺，通调水道，下输膀胱……。”今肺气壅塞，不能受纳脾所运输的水谷精气，从而导致脾失健运，或运化水谷不利而见食欲不振，或运化水湿不利，而聚湿生痰（饮），故有“脾为生痰之源，肺为贮痰之器”之说。或聚水而肿，出现腹水或双下肢水肿。肺病及肾者，乃肺为气之主，肾为气之根，肺主出气，肾主纳气，若肺气不降，则肾气无以受纳，而出现呼吸短促，动则气喘等症。肺为水之上源，主通调水道，下输膀胱；肾主水液，司二便，二脏失职，可致水肿。

总之，肺心病的形成是“外有非时之感，内有壅塞之气，膈有胶固之痰”，气滞血瘀，痰瘀互结，以肺为主，累及多脏。其病理产物不外乎痰饮、瘀血与水气。其病症以咳嗽、气喘、心慌心悸、水肿为主。若水饮凌心，可见咳嗽倚息不能平卧，心悸水肿加重而形成肺心病心衰重症。

少数病例还可痰浊阻肺，一时气机痞塞，逆传心包，痰迷心窍而形成神志不清的肺性脑病之危候。

②辨证论治：曾氏采用中西医结合诊断分型法防治肺心病，将肺心病分为临床缓解期与急性发作期。临床缓解期的主要矛盾为肺肾气虚，本虚邪微或邪去正衰（以肺功能不全为主）；急性发作期表现为本虚标实，病症多变，而气虚血瘀证可贯于两期之始终（以合并感染、心功能不全为主）。

临床缓解期：

肺肾气虚型：咳嗽，气短，动则益甚，或有少量泡沫痰，腰酸腿软，或畏寒肢冷，舌质淡，边有齿印，苔薄白，脉沉细。或邪去正衰，动则气喘，痰咳不畅，发紺，纳差，肢肿，舌红绛无苔，脉细滑。治宜益肺补肾，佐以活血化瘀。药用党参、百合、沙参、麦冬、补骨脂、丹参、泽兰。兼脾虚痰湿证（痰稀白，量多，少食，乏力，苔白腻，脉滑或细无力），佐以健脾化痰，加茯苓、白术、法半夏、陈皮、甘草。偏阴虚证（口干，心烦，手足心热，痰少，舌质红，脉细数），佐以养阴清热或养阴润肺，用百合固金汤加减，或麦味地黄汤加减。兼心气虚证（除有肺肾气虚证外，心悸明显，脉沉细或有结代），佐以益气养心，以补肺汤（参、芪、地、味、菀、桑）合生脉散加减。

急性发作期：

肺肾气虚外感型（肺功能不全并呼吸道感染）：肺寒型（喘咳气短，咳白痰，或恶寒发热，寒多热少，鼻塞流涕，头身痛或周身不适，苔白，脉浮紧），治以宣肺散寒，祛痰平喘，杏苏散合止嗽散加减（苏叶、杏仁、荆芥、前胡、陈皮、法半夏、桔梗、枳壳），喘重痰多加苏子、莱菔子、葶苈子，或小青龙汤加减。痰热型（咳嗽，喘促或不能平

卧，痰黄粘稠，发热，舌质红、苔黄腻，脉滑数），治以清热化痰，佐以平喘，麻杏石甘汤合泻白散、千金苇茎汤加减（炙麻黄、杏仁、生石膏、甘草、鱼腥草、金银花、黄芩、瓜蒌、冬瓜仁、桑白皮、芦根）。

脾肾阳虚水气凌心型（心功能不全）：浮肿，心悸，气短不能平卧，尿少，口唇紫绀，舌质紫暗、苔白或白腻，脉沉虚滑数。治以温肾健脾，利水宁心，或益气温阳，健脾利水，佐以活血化瘀，真武汤合五苓散、生脉散加减（附子、白术、茯苓、猪苓、泽泻、车前子、党参、麦冬、五味子、赤芍、丹参、川芎）。

痰浊蔽窍型（肺性脑病）：意识朦胧，神昏谵语，甚至昏迷，呼吸急促或伴有痰鸣，舌紫，苔腻，脉滑数。治以除痰开窍，局方至宝丹或涤痰汤加减（菖蒲、远志、茯苓、白矾、天竺黄、陈皮、法半夏、制南星、竹沥水），可加刺人中穴。兼肝风内动证（除上述症状外，兼有烦躁不安，抽搐），佐以平肝熄风，以羚角钩藤汤加减（黄芩、黄连、栀子、玄参、菖蒲、茯苓、钩藤、麦冬、全蝎、赤芍、龙骨、牡蛎）。

元阳欲绝型（休克）：面色晦暗或苍白，呼吸微弱，汗出肢冷，或烦躁不安，卧床不语，舌质紫暗，脉细数，或脉微欲绝。治以回阳救逆，益气复脉，生脉散合参附汤（人参、附子、麦冬、五味子）。

热瘀伤络型（伴有出血倾向）：皮肤瘀斑，或有咯血、衄血，舌质紫胀，脉细数或滑数。治以清热凉血，活血止血，犀角地黄汤加减（犀角现用水牛角代替、生地、丹皮、丹参、茜草等），如有气不摄血之吐血、便血，加黄芪、党参。

必须说明，对上述肺心病分期辨证施治，在临床实践中，往往错综复杂，寒热虚实互见，或多证型相兼，故临

证时，切勿刻舟求剑，务必灵活掌握，方能切合临床实际。另外，在治疗上，某些病例需要配合西药治疗者，则应合理选用西药，以期取长补短，提高疗效。

如治毛某某，男，77岁。1986年5月14日初诊。咳嗽20多年，双下肢浮肿、乏力2年。自1961年开始有慢性咳嗽史，每年均发作。近2年每次发作都伴有双下肢踝部浮肿，乏力，纳差，腹胀，夜尿多，心慌气短，痰白粘、量不多，咳声低微，面白唇紫，舌质淡嫩，苔白厚，脉结代。T37℃，R21次/分，BP19.5/12kPa。神清，贫血外貌，口唇紫绀，颈软，颈静脉怒张，胸廓对称，呈桶状胸，肋间隙增宽，双肺部呈过清音，呼吸音低，可闻及湿啰音。心率74次/分，律不齐，早搏5~6次/分，心尖部可闻及Ⅲ级SM，腹稍隆起，移动性浊音(+)，肝大肋下1指，剑突下2指，脾(-)，双下肢凹陷性水肿。理化检验：Hb85g/L，RBC 3.03×10^{12} /L，WBC 5×10^9 /L。诊为老年慢性支气管炎、肺气肿、肺心病、慢性右心衰Ⅱ度。中医辨证属肺肾气虚，脾虚水泛，水气凌心，气虚血瘀，治宜健脾利水，益气活血法。处方：黄芪30g，白术12g，茯苓15g，泽泻10g，猪苓15g，益母草30g，当归12g，红花6g，赤芍12g，川芎12g，桃仁12g。采用西药。上方出入治疗23天，浮肿消退，其他症状与体征基本消失，好转出院。^[4]

5. 周次清诊治经验

周氏对慢性肺心病的治疗，主要分二个期，用四个法。

①急性期：治疗重点在于祛邪。主要采用清热泻火化痰、解表散寒涤饮的方法。因为肺心病的急性发作，大多由于外感风热，痰因火动；或风寒袭肺，饮从寒发，导致

肺失宣肃而出现“咳喘”、“痰饮”、“水气上逆”等证。外感热邪，一般除有痰量多、色白粘稠或脓性痰的特征外，多有热象盛、体温高等实热证，甚至出现热陷心包诸症。治疗必须早期重用清肺泻火，同时须配用适量的化痰药物，主方用五虎汤（《增补万病回春》）：炙麻黄 9g，生石膏 30g，甘草 6g，炒杏仁 9g，细茶 6g，桑白皮 12g。加金银花 30g，连翘 12g，鱼腥草 30g，黄连 6g，黄芩 9g 清热泻火；加生薏苡仁 30g，海浮石 9g，龙葵 12g 祛湿化痰；热陷心包，兼服安宫牛黄丸；抽搐加白芍 30g，甘草 9g，羚羊粉 1.5g（冲），钩藤 15g。

其证有时虽有热邪内侵，痰因火动，而初起外感征象并不明显，只有痰量于短期内明显增多，或痰由稀变稠，如果这时失去清热泻火的机会，甚至误为脾虚生痰，或肺阴不足的病症，采用了健脾化痰，养阴益肺的方法，势必造成不良后果。

外感寒邪，一般病程较久，体质较差的患者，除有痰量多、色白、清稀或泡沫样痰的特点外，一般先发热或有低热。治疗用解表散寒、温肺涤饮的小青龙汤合苏葶定喘丸（《医宗金鉴·删补名医方论》方：苦葶苈子、苏子研泥，大枣为丸），疗效相当可靠。有烦躁、发热加生石膏；尿少浮肿加茯苓、车前子、泽泻。

有时由于年老体弱，久病正虚，虽有外邪犯肺，只表现神疲、体倦、短气咳喘、食欲减退等身体条件突然变坏的现象。除非出现水气凌心犯肺，阴衰阳脱的危证，宜速用回阳返本汤（《伤寒六书》方：熟附子、干姜、甘草、人参、麦门冬、五味子、腊茶、陈皮）合五苓散进行急救外，治疗仍宜采用小青龙合苏葶定喘丸。切忌误用补肺纳气的方法，固表恋邪，贻误病机。

②缓解期：多属热邪已除，气阴两伤，痰火未消，或外寒已解，气阴始复，痰饮存留的病变。病证从热邪转变而来的，其主要临床表现有舌红，少苔，短气乏力，自汗，痰粘稠咳出不爽，脉细数或促，方用清金汤（《统旨》方：黄芩、栀子、知母、桑白皮、桔梗、甘草、麦冬、贝母、瓜蒌仁、橘红、茯苓等），生脉散。方药要根据气阴与痰火虚实的程度不同，用之以主次。病证从寒邪转变而来的其突出症状有痰色白，量多而稀，因痰而咳嗽，心悸，头晕，脉沉迟细弱或结代。方用六君子汤，苓甘姜味辛夏仁汤。病中出现结代脉，一般可随益气养阴，温阳化痰的治疗而消失，不需作特别处理。^[5]

周氏治疗肺心病时，还善于详察病情，透过复杂的外观症状，抓住病变的实质，往往使沉疴得愈。

①气逆喘咳，当分虚实：外邪犯肺是肺心病复发的主要诱因，应出现表实证，但不少患者因久病体弱，虽有外邪侵袭，却既无恶寒发热、头痛鼻塞之表证，又无但热不寒、口渴汗出之里证，而表现为短气喘促、咳嗽痰多突然加剧、神疲懒言、四肢困倦、食欲减退等全身症状。此时若不细察，往往把外邪遏阻的实证，误认为肺肾不足的虚证，采用补肾纳气之法，造成“闭门留寇”之弊。二者如何辨别？周氏认为，正盛邪实的实证，多见于素体较强壮之人，表现为寒热症状突然出现、咳喘气粗、痰多或粘稠或黄稠难咯。邪盛正虚者，多见于年老体弱之人，表现为咳喘气短，并在短时间内痰量突然增多。对这种邪盛正虚之气逆喘咳者，须采用祛邪为主或先祛邪后扶正的治法；如属风寒引动痰饮，证见咳喘痰多、无汗畏寒、周身酸楚、舌淡、苔白滑等，以喘促为主者，首选小青龙汤，咳逆明显者，用参苏饮。若外感风热，痰火内动，证见咳喘痰多、

色黄质稠、汗出口干、身微热等，以喘为重者，宜用五虎二陈汤（麻黄、杏仁、石膏、甘草、半夏、茯苓、陈皮、桑白皮），或外台神秘汤（麻黄、杏仁、厚朴、陈皮、苏子、柴胡），若以咳嗽为重者，宜选用银翘散合千金苇茎汤加减。对于邪盛正虚、虚实夹杂证，切忌过早投以壅补之品。周氏曾治一老年女性肺心病患者，喘促气短、神疲懒言、纳呆乏力，酷似肺肾亏虚之证，但细问之，晨起咳嗽喘促剧烈、痰稠量多、心烦口干，辨为虚实夹杂，痰火内动，给予五虎二陈汤，服药3剂即明显见效。

在方药的运用上，周氏特别强调，药量不宜过大，服药时间不宜过长，处方忌大而杂。病情缓解后，可改用清补兼施法。在治疗过程中，若出现心烦、发热、体温升高，乃为正盛邪实，宜用大量清热泻火、宣肺化痰之品。

②痰涎壅盛，须辨火盛与脾虚：咯痰量多是肺心病发作期的一个突出症状。如何辨痰？周氏认为，在一般情况下，咳痰量多、色白易咯者为湿痰，色白清稀者为寒痰，痰多泡沫者为风痰，色黄质稠者为热痰。但肺心病急性发作期的痰多色白易咯，并非湿痰或寒痰，乃是外邪壅闭，火气内发，痰因火动，热象尚未外露之象。其特点是：痰量于短期内突然增多，以咯出为快；咳嗽、喘促等症状突然加剧，全身状况明显变坏（神疲乏力、烦躁不宁等），小便色黄，舌质偏红，脉滑数。治疗必须采用辛凉疏肺、泻火化痰法。若证属内外合邪，宜用麻杏石甘汤合金苇茎汤；若郁而化热、痰因火动者，首选清金汤（黄芩、栀子、知母、桑白皮、桔梗、麦冬、贝母、瓜蒌仁、橘红、茯苓、甘草）或桑白皮汤（桑白皮、半夏、苏子、杏仁、贝母、黄芩、黄连、栀子）。待痰量明显减少、全身状况明显好转后，再酌情改用健脾益肺或补肾纳气法。湿痰的特点是：

多在肺心病的缓解期出现；患者多形体肥胖，恣食肥甘及晨起体位变动时加剧；全身疲乏无力，喜静卧；舌体胖大有齿痕，苔白腻，脉濡或滑。治疗采用健脾燥湿法，方选二陈三子汤（陈皮、半夏、茯苓、甘草、苏子、白芥子、莱菔子），或香砂六君子汤加减。若寒痰在感寒1~2日内发生，痰色白质稀量多易咯，并伴有风寒表证者，应采用温肺化痰法，方选小青龙汤合三子养亲汤。

③喘咳、心悸、水肿，有肺失宣肃与肾阳虚衰之别：阳虚水逆、上凌心肺与肺失宣肃、决渎失司都可表现为咳逆喘息不得卧、心悸不宁、小便不利、下肢浮肿等症状，临证时，二者不可混淆。周氏认为，肺心病发作期所出现的喘咳、心悸、水肿，多为肺气的宣发肃降功能失司所致。其临床特点：发病前必有外邪犯肺的病因，不论表证是否出现；咳逆痰喘的症状先于心悸、水肿；常伴有紫绀、满闷、呼吸困难等。治宜宣肺降逆、化痰利水法。若证属外感风邪、内停水湿，方用导水茯苓汤（紫苏、桑白皮、大腹皮、砂仁、木香、陈皮、槟榔、木瓜、白术、泽泻、茯苓、灯芯草、麦冬）；证属外感风热、水湿不降，方用越婢加术汤合越婢加半夏汤、葶苈大枣泻肺汤；决渎失司、水肿较甚阻碍阳气运行时，必须急用利水行气法先治其标，方用五苓散合五皮饮（茯苓、猪苓、泽泻、白术、桂枝、桑白皮、橘皮、大腹皮、茯苓皮、生姜皮）。但在肺心病中使用利水法时必须注意：利水药量不宜过大，以防伤阴耗气，必要时可佐以养阴益气之品；慎用温阳利水法，以防伤阴燥痰；实邪消除后，需采用阴阳双补、化生肾气之法，以扶正固本。

肾阳虚衰导致的水气凌心犯肺之喘咳、心悸、水肿，在肺心病中虽不多见，但也间而有之。其辨证特点：多发

生在肺心病危重阶段或晚期；②发病前无明显外邪犯肺的表现；心悸、水肿等证先于咳喘，即咳喘症状是在肺肾阳虚的基础上发生的；常伴有面色青灰、汗出肢冷、呼吸气短等阳气欲脱的征象。治疗应益气温阳、健脾利水，方用真武汤合五苓散。待病情基本缓解后，改用金匱肾气丸或蛤蚧定喘丸以固肾纳气、平补肾气。

④阳虚血瘀紫绀，忌单用活血化瘀法：一般病人出现唇甲紫绀、舌质紫暗、肝脏肿大、颈静脉怒张等症时，治宜活血化瘀法，但对于肺心病患者则不能同之。周氏认为，肺心病病人出现瘀血证候，多为肺气虚衰、无力运血所致，是一种因虚而致实的瘀血证。单用活血化瘀法不但不能减轻症状，反而可引起疲乏无力、食欲减退、肝区疼痛等不良反应。这种气虚血瘀证的特点：除上述所说的瘀血症状外，病人多伴有少气懒言、疲乏无力、舌质紫暗、舌体胖大，治宜益气养血活血法，方选保元汤（人参、黄芪、肉桂、甘草、生姜）合芎归散（川芎、当归）。阳虚血瘀者则在上述症状的基础上，伴见畏寒肢冷、尿少浮肿等，治宜益气温阳、养血活血，方选六味回阳饮（人参、炙甘草、附子、炮姜、熟地、当归）合黄芪桃红汤。若见气阴双虚者，宜用生脉散合桃红四物汤。

另外，部分肺心病患者，即使外邪已除，心阳得复，但瘀血征象也仅表现为减轻，而很难完全消失。此为病久及肾，血气失荣，肾之真脏色外露。可长期服用金匱肾气丸或济生肾气丸，切忌活血化瘀，以防伤其本。

总之，慢性肺心病的基本治疗法则是急则治其标，缓则治其本。即在急性发作期以祛邪为主，缓解期应攻补兼施，慢性期以扶正为主。但在疾病过程中，因感邪的轻重、正气的强弱及正邪消长转化不同，临床常出现症状相同、

本质不同或症状不同而本质相同的复杂变化，此时应细察病情，综合分析，知常达变，审因论治，方能奏效。^[6]

6. 周燮昆诊治经验

肺心病是肺循环阻力增加，肺动脉高压引起右心室肥厚、扩大甚至衰竭的心脏病，属中医“喘咳”、“肺胀”、“心悸”、“水肿”等范畴，临床属难治病证。周氏对肺心病并感染以致出现肺心功能不全者具有丰富的治疗经验。周氏认为，肺心病肺心功能不全的病机变化是气阴不足，痰热瘀水流注于机体，复感外邪，邪从热化，再伤气阴，加重痰瘀形成；其病位在心肺，涉及脾肾。病性以虚为主，涉及气血阴阳。

肺心病多由肺胸疾病迁延不愈产生，其病情缠绵，痰饮久伏于肺，郁而化火，以致耗伤气阴，患者平素即可表现气短、口干等一系列气阴两虚的症状。而痰饮的形成又与肺脾肾三脏相关，肺气虚损，水道失于通调而聚湿为痰；脾气虚衰，水谷精微不化其津而壅滞生痰；肾气虚弱，气化不利，水湿上泛而为痰饮，饮为阴邪，伤及心阳，故常见心悸、短气；痰饮日久，又从热化，胶滞粘凝，聚于贮痰之器，肺络受阻，血行不畅，瘀渐生成。痰瘀交阻，肺气不利则喘咳。心肺同居上焦，肺气不利则心血不畅而见胸闷胸痛及面青唇绀等症状。若感受外邪，邪入阴伤之体，易从热化，热则痰瘀胶粘加重，壅塞气道，以致喘咳及面青唇绀更为加重。气机不利，原已受损之心阳虚之更甚，以致出现水气凌心，动则喘甚或不动也喘并下肢浮肿等症状。总之，肺心病患者是气阴不足与痰热瘀水同时并存，气阴不足导致痰热瘀水阻滞的加重，而痰热瘀水久则化热必伤气阴，以致使病变发展到不易控制的局面。再感外邪，

气阴两伤及痰热瘀水更为加重，则出现以心肺脾肾四脏相关而以心肺表现为主的各种复杂证候。由此说明肺心病合并心衰存在本虚标实的病机，气阴不足为其本，痰热瘀水为其标。

根据以上认识，周氏制定了益气养阴以扶正固本，活血化痰与清热利水以治其标作为治疗肺心病合并心衰的基本原则，自拟了肺心汤专方：人参 10g，麦冬 20g，玉竹 30g，黄芩 12g，连翘 20g，陈皮 15g，桔梗 15g，半夏 10g，川芎 12g，白茅根 30g，车前子 15g，砂仁 10g，甘草 6g。每日 1 剂，水煎服，每次 150~200ml，每日 3 次。方中人参益气，麦冬、玉竹养阴，三者合用取生脉散之意，川芎活血化瘀，桔梗、陈皮、半夏宣肺化痰，黄芩、连翘清肺热，白茅根、车前子利水消肿，砂仁纳气定喘，甘草调和诸药。通过临床治疗肺心病肺心功能不全 12 例，收到良好效果。

如治王某，男，68 岁，农民，1992 年 11 月 6 日初诊。慢性喘咳病史 10 余年，反复发作，冬季尤甚，此次因外感诱发喘咳加重 5 日而来诊。症见喘促抬肩，咳嗽痰稠，颜面唇舌青紫，心悸气短，纳差口苦，寒热不适，下肢浮肿，便干尿黄，舌质紫黯，苔薄黄。查：一般情况差，口唇紫绀，颈静脉怒张，肺气肿征阳性，双肺呼吸音粗糙，左下肺可闻及散在湿啰音，心率 102 次/分，律齐，三尖瓣区可闻及二级收缩期杂音，腹软，肝脏触诊剑突下 4cm，右肋下 2cm，肝颈静脉回流征（±），腹水征（-），双下肢中度浮肿。血常规：WBC $11.2 \times 10^9/L$ ，N0.82，L 0.13。心电图示窦性心动过速，肺型 P 波。X 线胸片示：左下肺纹理增粗，左下肺感染。诊断为慢性肺源性心脏病并感染，心功能 II 级。因患者无条件住院，只能在门诊治疗。嘱患

者少活动，进清淡少盐饮食，除给青霉素常规抗感染外，中药以益气养阴，活血化痰，清热利水为治。予自拟肺心汤加柴胡 12g，桑白皮 15g，杏仁 12g，3 剂，水煎服。11 月 10 日二诊：患者颜面口唇紫绀减轻，双下肢浮肿略退，心悸喘促均有好转，口不苦，寒热不作，但仍感气短乏力，食欲不佳，舌质黯红，苔薄黄微腻。守方去柴胡加白术 24g，槟榔 15g，厚朴 18g 以化痰开胃，2 剂。11 月 12 日三诊：诸症均减，食欲好转，双下肢浮肿减退，仅有轻微气喘，舌红苔薄白，脉弦滑。考虑标实渐去，停用青霉素，调整肺心汤，处方如下：白术 15g，太子参 30g，麦冬 20g，玉竹 30g，茯苓 15g，连翘 18g，黄芩 12g，陈皮 15g，法半夏 10g，川芎 12g，车前子 10g，甘草 6g。3 剂。11 月 16 日四诊：诸症已消，精神渐好，做少量家务亦不作喘，时有痰，色白易咯出，饮食睡眠一般，舌淡红，苔薄白，脉细滑。复查血常规：WBC $7.3 \times 10^9/L$ ，N0.72，L0.23。服陈夏六君子汤加川芎、黄芩、麦冬以善后。3 个月后因伤食腹胀就诊，后因感冒复发时，采用此方治疗，仍能稳定和控制病情。^[7]

7. 周仲瑛诊治经验

根据肺心病的临床表现，与中医学的“肺胀”病类似，为多种慢性肺系病证，如久咳、喘、哮等反复迁延而成。病理基础为久病肺虚，痰浊潴留，导致肺气胀满不能敛降，进而累及心、脾、肾诸脏；病理因素主要为痰浊、水饮、瘀血互为影响，兼见同病；病理性质多属标实本虚，外邪痰瘀阻肺，气阴耗伤，辨证应区别虚实的主次，偏实者辨其病邪及病理因素，偏虚者辨其病理性质与脏腑病位。治疗以发作期治标，缓解期治本为原则。

①肺病及心，痰瘀阻碍肺气：病由痰浊滞留，肺失节，心血营运不畅，而致肺病及心，痰瘀阻碍肺气，瘀滞心脉。临床既见喘咳短气，痰多色白粘腻，舌苔浊腻，脉小滑数等痰浊壅肺证，又见心慌不宁，胸闷，颈脉动甚，面唇、爪甲、舌质暗紫，脉来三五不调等心脉瘀阻之候；或血瘀水停而身肿；或血瘀络损而咯血。治当化痰行瘀，降气平喘，可予杏苏二陈汤合桃红四物汤加减。药如：法半夏 10g，杏仁 10g，陈皮 6g，炙甘草 3g，炒苏子 10g，葶苈子 10g，旋覆花 5g（包煎），降香 3g，当归 10g，丹参 10g，桃仁 10g，红花 6g。肺痹失降，心脉不利，而致肝气不疏，肝血瘀阻，右胁肋痛者，加虎杖 15g，平地木 15g，莪术 10g；气虚血瘀者加黄芪 15g，党参（或人参）12g；出血者去桃仁、红花，加仙鹤草 10g，茜草根 10g，煅花蕊石 10g，三七粉 3g（分吞）；如属瘀热伤络，可配水牛角片 10g，赤芍 10g，丹皮 10g，紫珠草 15g。

②虚体受感，邪实正虚错杂：肺胀病久，卫外不固则邪易乘袭，邪犯于肺则肺气更伤，促使病情恶化。虽曰发时标实为主，缓解期本虚为主，但从病机演变总的趋势衡量，愈发必致正气愈虚。《诸病源候论·咳逆短气候》明确指出：肺胀为“肺本虚，气为不足，复为邪所乘，壅否不能宣畅，故咳逆短气乏力也。”并有“肺虚为微寒所伤”，“肺虚为微热所客”等不同。提示外邪应辨其寒热属性。同时外感势必触动内伏之痰浊，而致内外合邪，同气相召，互为关联影响，如寒痰（饮）蕴肺者易为风寒所乘，痰热郁肺者易为风热所伤；或见外寒内热、寒痰化热等错杂演变情况。从邪正的关系而言，寒痰（饮）易伤阳气，痰热易伤阴津；而阳气虚者外邪易从寒化，阴虚者外邪易于化热。治疗既应遵守发时治标的原则，采用祛邪宣肺法，又

不能忽视扶正祛邪的要求，具体处理当辨其病性的寒热施治。外寒内饮证，喘咳胸闷，痰多粘白泡沫，恶寒，发热，无汗，舌苔白滑或白腻，脉浮紧，可取小青龙汤解表散寒，温肺化饮；复合苏子降气汤温肺化痰，降气平喘。药如：炙麻黄 6g，桂枝 6g，法半夏 10g，细辛 3g，苏子 10g，厚朴 5g，杏仁 10g，橘皮 5g，白前 10g，生姜 3 片；酌配太子参 10g，炒白术 10g，炙甘草 3g，五味子 3g，当归 10g，炒白芍 10g 等补敛肺气。痰热郁肺，证见喘急胸满气粗，痰质粘稠，色黄或白，心烦口渴，身热微寒，有汗不多，苔黄质红，脉滑数，可取越婢加半夏汤、桑白皮汤清肺化痰，降逆平喘；复合沙参麦冬汤补益肺阴，药如：炙麻黄 5g，生石膏 30g，炒黄芩 10g，桑白皮 10g，鱼腥草 15g，葶苈子 10g，竹沥半夏 10g，知母 10g；酌配南沙参 10g，北沙参 10g，麦冬 10g，炒玉竹 10g，天花粉 10g 等清养之品。

③上盛下虚，肺肾出纳失常：多因正虚感邪，诱致急性发作，促使病情加重，肺虚气不化津为痰，痰浊上逆壅肺，肾虚不能助肺纳气；甚则上下寒热错杂。症见咳逆痰多，喉中痰涌有声，胸闷如塞，不能平卧，气短息促，吸气不利，动则喘甚，舌质淡或红，苔腻，脉细滑数。治当化痰降逆，宣泄其上；补肾纳气，培益其下。区别上盛与下虚的主次，针对具体病理表现施治。上盛，因痰气壅结者，降气化痰宣肺；因寒饮伏肺者温肺化饮；因痰热郁肺者清肺化痰。下虚，因肾阳虚者温养下元；因肾阴虚者滋填阴精。方选周氏自制平喘固本汤（党参、冬虫夏草、五味子、胡桃肉、坎脐、沉香、磁石、苏子、款冬花、半夏、橘红）、苏子降气汤、金匱肾气丸加减。祛痰利气类药，可用苏子 10g，款冬花 10g，紫菀 10g，白前 10g，法半夏

10g, 白芥子 5g, 厚朴 5g, 寒痰配肉桂 3g, 干姜 3g, 细辛 3g, 热痰配知母 10g, 海浮石 10g, 鱼腥草 15g, 另用雪羹汤代水煎药。补肾纳气类药可用山茱萸 10g, 熟地 10g, 胡桃肉 10g, 五味子 3g, 冬虫夏草 5g, 坎脐 2 条。肺肾气虚配党参 10~15g, 黄芪 15g; 肾阳虚配制附子 5g, 鹿角片(胶) 10g, 补骨脂 10g, 钟乳石 10g; 肺肾阴虚配沙参 10g, 麦冬 10g, 玉竹 10g, 生地 10g, 当归 10g; 气逆于上, 酌加紫石英 15g, 玄精石 10g, 磁石 25g 以镇纳之。若上盛之势缓解, 而肺肾两虚, 不能主气纳气, 喘息气短难续者, 当补肺纳肾, 降气平喘, 用补肺汤、金匱肾气丸, 辨其阴阳化裁, 参照下虚证用药组方。

④浊邪害清, 痰瘀蒙蔽神机: 由于痰浊壅塞气道, 或肺虚吸清呼浊功能减弱, 心脉营运不畅, 瘀滞窍络, 而致痰瘀阻遏清阳, 蒙蔽心脑神机。症见神志恍惚, 烦躁, 撮空理线, 表情由淡漠渐至嗜睡、昏迷。喘促短气, 咳痰不爽, 舌质暗红或淡紫, 苔白膩或淡黄膩, 脉细滑数。治当涤痰泄浊, 化瘀开窍。可取涤痰汤合加味旋覆花汤增减。药如: 竹沥半夏 10g, 陈胆星 6g, 天竺黄 10g, 炙远志 5g, 茯苓 10g, 橘皮 6g, 石菖蒲 10g, 炙甘草 3g, 旋覆花 5g (包), 郁金 10g, 丹参 10g, 桃仁 10g, 泽兰 10g。气阴耗伤加太子参 10g, 麦冬 10g; 肝风内动加炙僵蚕 10g, 地龙 10g, 炙全蝎 3g, 石决明 30g, 另服羚羊角粉 0.3~0.6g, 每日 2 次; 痰热蕴肺者, 另予竹沥水 20~30 毫升, 每日 2~3 次; 喉中痰涎壅盛, 加猴枣散 0.6g, 每日 2~3 次; 窍闭神昏, 属痰热内闭者, 可予至宝丹或安宫牛黄丸(或用醒脑静注射液)凉开, 每次服 1 粒, 每日 1~2 次; 属痰浊内闭者, 用苏合香丸温开, 每次服 1 粒, 每日 1~2 次。

⑤三阴交病，水饮泛溢肌表：久病喘咳，肺、脾、肾三脏交病，阳气虚衰，通调、转输、蒸化失职，水饮内生；或因瘀阻血脉，“血不利则为水”，水饮泛溢肌肤，而致面浮，肢体浮肿，脘痞腹满，尿少，甚则饮停胸胁，上迫肺气而喘急咳逆；水饮凌心而心慌心悸，面唇青紫，舌胖质暗、苔白滑，脉沉细。治当健脾温肾，化饮利水。方选附子理中汤、新订己椒苈黄汤（黄芪代大黄，易泻为补）。药如：制附子 5~10g，炙桂枝 5~10g，白术 10g，黄芪 15g，猪苓 15g，茯苓 15g，木防己 10g，车前子 10g，椒目 3g，万年青根 10g，炙蟾皮 3~5g，北五加皮 10g。水在胸胁加白芥子 6g，葶苈子 10g，苏子 10g；水停大腹另予黑丑粉 1g，沉香粉 0.5g，吞服，每日 2 次；瘀阻水停身肿者，加苏木 10g，泽兰 10g，路路通 10g，天仙藤 10g，同时并服济生肾气丸 10g，每日 2 次，助阳化气行水。

⑥肺气耗散，心肾衰竭致脱：肺心病后期，因肺气虚耗，气阴交亏，累及于肾，而致肺不主气，肾不纳气，命门火衰，君火不用，心肾阳气垂绝，由喘致脱，症见气短息促，呼吸微弱，时停时续，喉中痰声如鼾，心慌动悸，汗出肢凉，四肢厥冷，神志由烦躁不安转为淡漠，甚至昏昧不清，面色暗晦，唇甲青紫，舌质淡紫或舌红少津，脉微细欲绝，或微弱细数、三五不调。治当补肺纳肾，益气救阴，回阳固脱。用参附龙牡汤合生脉散。药如：人参 15g，黄芪 20g，制附子 10g，山茱萸 10~15g，五味子 5g，龙骨 30g，牡蛎 30g，炙甘草 3g，玉竹 10g。烦热，汗出粘手，口干，舌红，人参改西洋参，加麦冬 10g，北沙参 10g，去附子或减其用量；神昧不清加丹参 10g，炙远志 5g，石菖蒲 10g。呼吸短气乏力，另服蛤蚧粉 2~3g，每日 2~3 次；喘急面青，烦躁，足冷，阴火冲逆，真阳暴脱

者，另服黑锡丹 3~4.5g，每日服 2 次。

上述辨治六要，病机每多演变、转化，临证当联系互参，权衡其主次处理。^[8]

8. 奚凤霖诊治经验

肺心病在迁延期、代偿期或缓解期时，奚氏常用古方皱肺丸（或作汤剂）治疗，取得较好效果。

肺心病属中医“肺胀”、“支饮”范畴。症状为喘息、短气、咳唾、虚满等，由于水饮上迫于肺，肺气不得宣降，久则肾气摄纳无权所致。因肺胀、支饮均有肺气壅滞而使胸廓肋间隙膨满的形态变化。为此，奚氏从古籍方书中找到了许多首皱肺丸，遴选其中三首，作为治疗主方。而且认为凡称皱肺，事非偶然，皱肺的“皱”字，顾名思义，有收敛皱瘪之意，使其原来已经失其收敛扩张之能的肺叶恢复正常的浊气呼出，换取清气吸入的吐故纳新作用。由此推想古人，当时已对本病有所认识，而且专为此而设方，定以皱肺之名。经多年临床实践证明，认为确有疗效，可谓名副其实。现将三首皱肺丸方，分为益气皱肺、养阴皱肺、祛痰皱肺三个方面，介绍于下。

①益气皱肺法：《百一选方》皱肺丸（药物：人参、五味子、桂枝、紫菀、款冬花、杏仁、羯羊肺。一般煎剂，不用羊肺）。为补益肺气，摄纳肾气，平喘止咳，化痰薙饮之良方。药性和平，久服无妨。本方使用，一般无外感时服用为宜。或虽有外感而不甚，可酌配辛散以治之。若易于外感者，可合玉屏风散以益气固卫；若痰多食少，可合六君子汤以健脾化痰；若喘促短气，慌张气怯，声低息短，乃肾虚不纳故也，合二味黑锡丹（吞服）以温壮下元，摄纳肾气；若虚浮喘嗽，短气少气，合参蛤散以补益肺气，

纳肾平喘。

②养阴皱肺法：《证治准绳》皱肺丸（药物：款冬花、知母、秦艽、百部、紫菀、贝母、杏仁、阿胶、糯米、羊肺），适用于肺结核、矽肺、支气管扩张等继发的肺气肿、肺心病患者，多属气阴两虚，偏阴虚证者。为滋阴补肺，清热润肺，补血治癆之方。若喘息短气，胸满久咳，可合人参胡桃汤以益肺纳肾；若阴血亏虚，面白神少，短气虚喘，可合贞元饮以养血滋阴。若阴虚多痰，可合金水六君煎以滋阴化痰；若肾虚气喘，肺虚失敛，可合都气丸或麦味地黄汤以敛肺纳肾，滋阴止嗽。

③祛瘀皱肺法：《普济方》皱肺丸（药物：五灵脂、柏子仁、胡桃肉等分，研末为丸，木香甘草汤送服），适用于肺心病，低氧血症时出现喘息短气，咳嗽痰浓，心悸，紫绀，胸满胸痛，或肝肿压痛，颈脉怒张，虚肿尿少等气血瘀滞或气虚血瘀之证。本方功能活血化瘀，敛肺平喘，常与六紫汤（奚氏验方：紫苏子、紫菀、紫沉香、紫石英、紫丹参、紫衣胡桃肉。或加紫河车，名七紫汤）合用，以化瘀平喘，止咳化痰，敛肺温肾，养心纳气，疗效更好。

以上治疗，多先作汤剂服用，俟病情稳定，再结合其他防治措施，如防寒防冻、体育锻炼、劳逸结合、精神愉快、饮食宜忌等综合治疗。^[9]

9. 汪履秋诊治经验

汪氏把肺源性心脏病（简称肺心病）的临床表现归为五大症状，治疗分为五个证型和四大危象，并制定相应的治法、方药。汪氏认为，闷、咳、喘、痰、悸乃肺心病常见的五大症状，据此可了解患者病情轻重，辨别虚实寒热。闷越重，表明病人肺功能越差，预后欠佳；咳嗽剧烈常可

能是患者正气尚旺，病情较轻，能通过气逆作咳而逐邪外达；喘当辨虚实，实喘乃痰气郁结所致，虚喘又分肺肾，肺虚者为操劳后少气不足以息，肾虚者为静息时也有气短，活动后更甚；痰分寒热，白痰多为寒，黄痰多为热，但痰白质粘则是热象，黄痰质稀亦可见寒象；悸是肺病及心，心气、心阳虚弱，常为病情危重的表现。汪氏治疗肺心病多从五型论治。

痰浊阻肺证：症见咳嗽气喘，胸满闷胀，痰多粘腻，舌苔白腻，脉滑。治拟化痰降气，方选苏子降气汤、三子养亲汤加减。药用法半夏、陈皮、茯苓、苏子、白芥子、莱菔子、苍术、厚朴等。若痰从寒化为饮，又外感风寒诱发，喘咳痰多，色白而有泡沫者，为表寒里饮，可用小青龙汤加减以散寒化饮。

痰热蕴结型：症见咳嗽气粗，胸膈烦闷不安，痰黄或白，痰粘难咯，舌红、苔黄腻，脉滑数。治拟清肺化痰，降逆止喘。方选泻白散或三子养亲汤加金荞麦、鱼腥草等清热之品。药用桑白皮、黄芩、贝母、竹沥半夏、莱菔子、白芥子、苏子、金荞麦、鱼腥草、一枝黄花、平地木等。

肺肾两虚证：症见呼吸浅促，声低气怯，咳嗽痰白如沫，咯吐不利，舌淡或红，脉沉细或有结代。治拟养肺阴，益肾气，方选生脉散合人参胡桃饮加减。药用太子参（或党参、人参）、麦冬、五味子、沉香、炒熟地黄、钟乳石、紫石英、蛤蚧等。

脾肾两虚证：症见食少痰多，短气息促，纳后脘痞，腰酸腿软，舌淡、苔薄，脉沉细。治拟健脾补肾，方选桂苓理中汤、金匱肾气丸加减。药用桂枝、茯苓、白术、附子、党参、熟地、山茱萸等。

心阳亏虚证：症见咳喘心悸，咯痰清稀，面浮肢肿，

小便量少，舌质淡胖、苔白滑，脉沉细。治拟通阳化气，方选真武汤加减。药用附子、桂枝、白术、猪苓、茯苓、赤芍、生姜等。

汪氏认为，喘脱、出血、痰厥、昏迷为本病四大危象。

喘脱者症见咳喘甚剧，鼻煽气促，心慌动悸，面青唇紫，汗出肢冷脉浮大无根或歇止或模糊不清。治拟扶正固脱，方选参附龙牡汤送服蛤蚧粉或黑锡丹。药用人参、附子、生龙骨、生牡蛎、干姜等。出血者症见皮肤、粘膜出血，咯血，便血等。多为气不摄血，热盛动血，治拟益气摄血，凉血止血。方选归脾汤加地榆、槐花、丹皮、水牛角等。

痰厥者症见面色青紫，胸闷如窒，喉有痰声，不能咯出，舌苔腻，脉沉滑。治拟开胸结，化痰浊。方选香附旋覆花汤、半夏厚朴汤加减。药用香附、旋覆花、苏子、杏仁、法半夏、厚朴、橘皮、瓜蒌等。

昏迷者症见神志恍惚，撮空理线，表情淡漠，嗜睡，昏迷，或肢体颤动，抽搐，咳逆喘促，咯痰不爽。治拟平肝化痰，熄风开窍，方选天麻钩藤饮加减，另服至宝丹或紫雪丹。药用天麻、钩藤、半夏、黄芩、茯苓、石菖蒲、郁金、胆南星等。

如治张某，男，62岁。患者原有慢性支气管炎、肺心病史8年，反复发作。近1周来，咳嗽气喘又作，痰多色白粘腻，胸满闷胀，舌淡苔白腻，脉细滑。证属痰浊阻肺，治拟化痰降气。方选苏子降气汤和三子养亲汤加减。处方：苏子10g，制半夏10g，前胡10g，苍术10g，茯苓10g，莱菔子10g，葶苈子10g，杏仁10g，陈皮6g，紫金牛15g。每天1剂，水煎分2次服。服7剂药后，咳嗽、胸满闷胀减轻，咯痰减少，但觉脘痞纳少，短气喘息，怕风易汗，

此乃痰浊渐去，肺虚脾弱之象显露。原方去紫金牛、莱菔子、葶苈子等祛痰之品，加党参、黄芪、白术各 10g 以补肺健脾，续服 7 剂后，诸症均减，再服 7 剂以图巩固。^[10]

10. 赵锡武诊治经验

赵氏认为，慢性肺源性心脏病属中医学“痰饮”、“哮喘”、“水气”等范畴。其本为心肾阳虚，其标为肺气壅塞，痰饮停蓄，治疗应分清主次，标本兼顾。当肺气壅塞，哮喘严重，痰多、恶寒、发热时，先宜小青龙汤散寒祛邪，有里热者加石膏。“喉中如有水鸡声”者，可选用麻黄射干汤；若喘咳多年，胸中气短，咳逆倚息，兼心痛者，可用心咳汤；表证轻，心肾阳虚为主时，宜温阳宣肺利水，可用消水肾愈汤（《时方妙用》），即桂枝汤去芍药加麻黄、附子、细辛、知母；如心肾阳虚兼心肺气阴不足，可温阳化水，益气生津，用真武汤合生脉散，也可酌情加化痰利湿药，水肿明显者，还可加车前子、白茅根，或加用活血药，如苏木、桃仁、红花、藕节以协助利尿。^[11]

11. 何炎燊诊治经验

清燥救肺汤乃喻嘉言治燥气伤肺之方，以甘凉养胃阴，甘寒清肺燥为主。药用：桑叶、石膏、人参、麦冬、甘草、阿胶、胡麻、杏仁、枇杷叶（蜜炙）。何氏用此方治疗慢性肺源性心脏病急性发作，颇能顿挫病势，缓解症状，近期疗效满意。肺心病乃慢性支气管炎、支气管哮喘并发肺气肿之后果。由于长期呼吸功能减退，气体交换障碍，导致机体缺氧，二氧化碳潴留，此种病理产物，中医学认为是机体阴阳失调所产生之“邪”，即由虚而生实，故本病多出现本虚标实之病机。寒暑更迭，气候之异常，肺心病患者

易招外感，以致内外合邪，肺卫心营受其熏灼而变生诸症。从大量临床资料表明，肺心病急性发作时，用辛凉解表、清热涤痰之法（如麻杏、银翘诸方）远较用温阳利水、温补肺肾之法（如青龙、真武、肾气诸方）为优。然而，此病毕竟是本虚标实，清热祛邪固然重要，而患者本身心肺功能不全，又不可不顾护其虚，清燥救肺汤则是两者兼顾之良方。并将清燥救肺汤分成两组。一组是：桑叶、枇杷叶、杏仁、石膏、甘草。此与麻杏石甘汤大致相同，不过用桑叶、枇杷叶之辛凉微苦，解表降气，以代麻黄之辛温而已，此组药物治标实者也。另一组是：人参、麦冬、阿胶、火麻仁、甘草。此即复脉汤去姜桂枣及生地，有补肺气，养心阴之效，此组药物治本虚者也。运用此方加味治疗肺性脑病亦有效。肺性脑病乃肺心病最凶险之并发症，必须及早防治。肺心病急性发作期，凡身热不退，或虽退而脉数象不减者，应随时考虑肺性脑病之发生。应细察患者之舌，若舌尖独绛，或虽不甚绛而有红色小粒者，是热邪将犯心营，乃肺性脑病之先兆。即于清燥救肺汤中加入羚羊角、天竺黄、竹沥、郁金、连翘等，化服安宫牛黄丸（每天可用2~3丸），虽未能完全控制其发病，但症状较轻，预后较好。^[12]

12. 杨百葦诊治经验

杨氏认为肺胀病是因内伏痰饮，感寒而发，以咳嗽、喘息、咳痰为主症，或见发热恶寒，甚则身肿、心悸、周身动则振颤，不能自主，面色黧黑。此痰饮内闭，肺气胀满之症，与现代医学之肺气肿、肺心病等相似。临床见证多为本虚标实。杨氏强调，临证时应详辨急性发作期、慢性迁延期与缓解康复期的特点，分别给予不同的治疗方法。

急性发作期：病情较重，病势迅急，若不及时治疗，易酿成厥脱危证。症见：咳喘加重，恶风畏寒，背部寒冷，咳痰清稀，胸闷气促，甚则不能平卧，或见少尿，身肿，舌紫暗、苔白滑，脉浮紧或弦滑。此期多发于春季或天气骤变时，因宿有痰饮，易感寒而发。治当以散邪、温肺、化痰为主。杨氏常用宣散表邪、温肺化痰法，方用自拟经验方温肺蠲饮汤治之。药用：麻黄、法半夏、杏仁、苏子、厚朴、枳壳、细辛、五味子、干姜、茯苓、甘草等。若属痰热咳喘者则不可妄投。

慢性迁延期：病情较轻，但往往缠绵难愈，常因起居不慎而时有加重，或导致急性发作。症见：咳喘时发时好，痰少色白，或晨起痰多，胸闷不舒，劳则汗出，怕风恶寒，倦怠乏力，脘痞纳少，大便稀溏或秘结，舌暗淡、苔白，脉偏弦或沉滑。此时虽多见虚证，但不可一味进补，痰饮不去则病无宁日，故祛痰化饮为当务之急。杨氏常用温脾益气、化痰祛饮法。药用：桂枝、茯苓、党参、当归、白术、陈皮、法半夏、苏子、杏仁、甘草等。

缓解康复期：此期主要表现为虚证，久咳肺胀已形成肺、脾、肾三脏虚损，甚则脾肾阳虚。症见：咳嗽痰少，劳作甚则气短，偶感心慌喘气，口不渴喜热饮，恶寒喜暖，极易汗出外感。舌淡苔白，脉细或弦滑。治宜扶正为主，方用益肾固本，阴阳双调法的固本平喘汤治之。药用：西洋参、桂枝、茯苓、白术、橘红、炙枇杷叶、枣皮、当归、阿胶、山药、桔梗、甘草等。根据“冬病夏治”的观点，对本病在夏季未发时，服用固本平喘汤以扶正培本，尤为适宜。^[13]

13. 田玉美诊治经验

肺心病其病以肺为主，往往影响于心，临床表现以咳

喘、短气、胸闷、心悸等为主要特征，反映了肺与心两个脏器的病变，所以有肺心病之称。本病的形成不外乎两种因素，一是起居不慎感受风寒之邪，使肺气不宣，胸阳受阻，产生里寒之气，以致浊阴之邪为患，咳喘短气等证迭出，甚则心悸；一是脾胃虚弱，水精不能四布停而为饮，加之胸中阳气不足，浊阴之邪上犯于肺为喘，凌于心为悸。亦有肾虚之人，阳气衰微，不能化气，使水饮上犯为喘、为悸，因此，脾肾阳虚是本病形成的内在根据。本病的辨证治疗：

①内外合邪：是指风寒、痰饮郁热等而言。其临床表现有轻重之分，兼挟之不同，所以在治疗方面各有特点。如外感寒邪，内有水饮，恶寒发热、无汗、咳喘倚息不得卧等症并见，用小青龙汤外解表邪，内涤水饮；如外寒轻，内饮重者，咳喘、喉中有水鸡声者，因痰阻气道，气触其痰，搏击所致，故用射干麻黄汤散寒宣肺，降逆化痰；如寒饮挟热，咳喘并见烦躁，是外寒内饮挟热之候，饮重于热，用小青龙加石膏汤解表邪，涤水饮，清郁热；如外感风热，内有水饮，症见咳喘气急目如脱状，乃饮热合邪，热重于饮，用越婢加半夏汤宣肺泄热，降逆平喘；如咳喘、烦躁、胸满、倚息不得卧，以胸满、烦躁为主者，用厚朴麻黄汤散饮降逆，止咳平喘，清热除烦。如咳喘身重脉沉，应有小便不利之证，用泽膝汤逐水通阳，止咳平喘，此证重在脾虚，虽化饮平喘是正治法，而扶脾行水更为重要。

②肺肾虚弱：肺为娇脏，不耐寒热，《金匱要略》论肺痿分虚寒、虚热两型，立温肺复气、止逆下气两法。前者乃肺中虚冷，用甘草干姜汤之意，以温补脾土的手段，达到温肺复气的目的，体现了虚则补其母之法；后者因肺胃津伤、虚火上炎，用沙参麦门冬汤滋养肺胃之阴，使津液

充沛，虚火下降，咳止喘平。而肺心病肺虚之候，可仿其法，可效其方，但不可拘泥。肺气虚者以咳喘痰多为主，舌淡、苔白厚，以茯苓五味姜辛夏汤加厚朴、杏仁、瓜蒌仁，佐以红参，使饮化痰消喘平则气自复；如肺气阴两虚，咳喘少痰，短气自汗，食少便溏，舌红少苔，脉细，以六君子汤合生脉散，扶脾益气滋养肺阴，并佐以煅龙牡固涩。肾气虚者以咳嗽，动则喘甚为主，自汗出，舌淡、苔白，脉沉细，方用七味都气丸、二陈汤，佐以人参、白术、黄芪补肾益气。若咳嗽等症缓解后，偏于脾虚者用苓桂术甘汤，偏于肾虚者用肾气丸，均属治本之方；偏于肺虚者，用人参蛤蚧散。虚寒之体，可用参桂鹿茸丸。至于本病的危重证，如喘日久，面部浮肿，呼吸极度困难，脉浮大无根，甚至下利，此属肾气衰竭，不能纳摄，阳气外越，阴阳两脱之候，宜急用生脉散，重用人参；如四肢冷、汗出，用参附汤。^[14]

14. 赵尚久诊治经验

苇茎汤由苇茎（芦根）、瓜瓣、薏苡仁、桃仁四药组成，具有清肺化痰、逐瘀排脓之效，不但治肺痈有效，对于肺因痰热蕴结所致其他病症也可用之。如用本方为主加味，对肺心病心衰合并感染的患者，往往有控制心衰、感染以及改善症状的效果。但必须具有“痰热壅肺”的临床指征者，方可用之。如治王某，女，70岁。西医诊断为“肺心病”。数年来，气促，心悸，胸满，浮肿，反复发作，经常使用抗生素、强心剂、利尿剂等化学药品。本次因感冒后，汗出而热不退，咳嗽，气促气喘，吐粘稠绿痰，心悸，全身浮肿，小便短少，不能平卧，且神疲乏力，口渴索冷饮，四肢不温，面唇青紫，指端肥大，舌淡、苔黄厚

臑，脉促无力，经多种方法治疗 5 天不效。此外感引动肺中痰热，加之素体心阳衰弱，故病情虚实并见。治以清肺涤痰与振奋心阳、兼益心气为法。处方：芦根 15g，薏苡仁 25g，冬瓜仁 25g，桃仁 10g，桂枝 6g，白术 10g，茯苓 15g，葶苈子 6g，甘草 3g，金银花 10g，黄芪 10g，防己 10g。服 2 剂热退咳减，水肿渐退，4 剂症去十之七、八。继用上方化裁 10 余剂而症平。后旧恙复发，仍用上方有效。^[15]

15. 朱良春诊治经验

《金匱·水气病》篇载：“气分，心下坚，如盘，边如旋杯，水饮所作，桂枝去芍药加麻黄附子细辛汤主之”。何谓“气分”？尤在泾云：“曰气分者，谓寒气乘阳之虚，而病于气也。”水饮之得以停聚，乃气运失职使然。水饮聚于心下，最多见的有两种情况，一为脾失健运，一为心阳失旷。前者，《素问·至真要大论》所谓“太阴之复，饮发于中”。盖脾病则不能制水，中枢失运，升降失司，津液不归正化，以致饮聚于胃。后者则因心阳不足，心气内结，寒水内停而发生，与肺肾功能失常尤为密切。从心肺关系来看，两者同居膈上，一主血，一主气，相互为用，病变相因，例如心阳不足，就可导致肺之宣发、肃降功能减弱，使停聚的水液无以下输膀胱，排出体外。从心肾关系来看，心阳根于肾阳，肾阳不足，则心阳为之衰弱，以致水湿滞留；如肾阳亏虚不能化水，还可出现寒水凌心的病机。这两种情况，病因各别，证情上有轻重之殊。而仲景在《水气病》篇所主的“枳术汤”与“桂枝去芍药加麻黄附子细辛汤”两方，就是为这两种证情示人以用药的大法。仲景称枳术汤证曰“边如旋盘”；而称桂枝去芍药加麻黄附子细

辛汤证“边如旋杯”，虽系一字之差，但其中极有分寸。诚如程云来所云，如盘不如杯，“是水饮散漫之状”；而如盘复如杯，“是水饮凝聚之状”。前者健脾强胃，消痞祛水可矣。后者则健胃药不能缓其苦，非振奋心阳，温运大气不为功。

从临床实际来看，一些风湿性、肺源性心脏病的患者，在病情发作期，可见心下坚大如杯，此系“气分”证乃心气内结使然。除心下坚满外，这类患者常伴有下肢浮肿，进一步可出现腹水，其腹水的征象类石水，但与石水似同而实异，盖一则病源于心，一则病源于肾，当然，在治则上也有某些可通之处。心气内结造成的病理产物除水饮以外，必有瘀血的存在，然而行水消瘀之剂，不过治标而已，且易伤正气。仲景则着重温运大气，以助气化。大气运转，则宿瘀自消，停饮自散。现代药理研究认为，麻黄中所含的麻黄碱其作用与肾上腺素相似，但较和缓而持久，主要作用为松弛支气管平滑肌以及兴奋心脏、收缩血管、升高血压等。近几年来，不少报道表明，一些含有麻黄配伍的方剂，如麻黄附子细辛汤、阳和汤等，对病态窦房结综合征有较好的疗效，可以证明其确有通心气和发舒心阳等作用。桂枝能通心阳，行水气，附子能温阳强心，细辛既是心经引经药，又有散寒透窍作用。因此本方是一个良好的强心行水剂。

如治一姬，61岁，夙患肺源性心脏病。3月前，因咳嗽、心悸、腹水而住院治疗月余，诸恙均已平复。近因受寒、劳累，诸恙复作，咳嗽较剧，夜难平卧，心下坚满，按之如盘如杯，腹大如鼓，下肢浮肿，小便不多，面色灰滞，舌质衬紫、苔薄，脉沉细。此为心阳不振，大气不运，水邪停聚不化，予桂枝去芍药加麻黄附子细辛汤原方，连

进5剂，咳喘遂平，心下坚满已软，腹水稍退，但下肢依然浮肿。续予原方加黄芪、防己、椒目，连进8剂，腹水退净，下肢浮肿亦消十之七八，再以温阳益气、调补心肾之剂以善其后。^[6]

【按语】

杨继荪治疗肺心病急性发作，以清为主，结合化痰，佐以活血，并注意患者体质，权衡虚实。既顾其本，又不碍邪，寓补于清之中。缓解期以益气养阴，扶正固本为主，佐以活血、清热。杨继荪始终抓住“血瘀”这个共性，注重活血行瘀，达到改善心肺功能的目的。在肺心病整个治疗过程中，都贯穿着清、活、补三法，只是所处不同阶段，其用药各有侧重罢了。洪广祥认为“痰瘀伏肺”是肺心病的基本病机，因此其治疗重在治肺而不在治心，以温阳利水、涤痰除瘀为基本治则。在用药上，洪广祥善用葶苈子，认为葶苈子一药多用，既可涤痰利水，又可强心抗衰，用量一般以10~20g为宜，颇有特色。曾庆骅采用中西医结合诊断分型法辨治肺心病，将肺心病分临床缓解期和急性发作期予以施治，但又强调临证时务必灵活掌握，切勿刻舟求剑。周次清治疗肺心病善于详察病情，透过复杂的外在现象，抓住病变的实质，如指出气逆咳喘要辨虚实、痰涎壅盛要辨火盛与脾虚、肺心病紫绀忌单用活血化瘀法等均有临床指导意义。周嫦昆认为益气养阴以扶正固本、活血化瘀与清热利水以治其标是治疗肺心病合并心衰的基本原则，其所拟的“肺心汤”专方，效果良好，可资借鉴。周仲瑛治疗肺心病从六个方面辨治：①肺病及心，痰瘀阻碍肺气；②上盛下虚，肺肾出纳失常；③虚体受感，邪实

正虚错杂；④浊邪害清，痰瘀蒙蔽神机；⑤三阴交病，水饮泛滥肌表；⑥肺气耗散，心肾衰竭致脱。奚凤霖治疗肺心病常用古方皱肺丸。益气皱肺用《百一选方》皱肺丸，养阴皱肺用《证治准绳》皱肺丸，祛瘀皱肺用《普济方》皱肺丸，临床疗效好，可供参考。汪履秋把肺心病的临床表现归纳五大症状，治疗分五个证型和四大危象，有提纲挈领的作用。何炎荣善于用喻嘉言清燥救肺汤治疗肺心病急性发作，颇能顿挫病势，缓解症状，近期疗效满意，可作参考。杨百菲诊治肺心病强调应辨急性发作期、慢性迁延期与康复缓解期的特点，分别予不同的治疗方法。

(吴艳华)

参 考 文 献

- [1] 董志中. 对肺心病的几种认识. 吉林中医药, 1989, (1): 9
- [2] 潘智敏. 杨继森老师治疗慢性肺源性心脏病的经验. 浙江中医学院学报, 1987, 11 (5): 29
- [3] 蔡灿林, 赵凤达, 洪广祥治疗肺心病心衰的经验. 江西中医药, 1993, 24 (3): 8~9
- [4] 宾学森, 杨香生. 曾庆骅治疗肺心病经验. 江西中医药, 1992, 23 (2): 12~13
- [5] 窦钦鸿, 周次清, 邵念方, 等. 肺气肿、肺心病的辨证施治. 中医药研究, 1988, (2): 2~5
- [6] 路广晁. 周次清治疗肺心病经验. 山东中医杂志, 1992, 11 (2): 40~41
- [7] 李建萍. 周嫦昆老师治疗肺心病经验. 云南中医学院学报, 1999, 22 (2): 42~43
- [8] 周仲瑛. 慢性肺源性心脏病辨治要点. 中医杂志, 1990, 31 (1): 23~25
- [9] 奚凤霖. 皱肺丸治疗慢性肺源性心脏病经验. 中医杂志, 1990.

31 (2) : 13

- [10] 奚肇庆, 程永红. 汪履秋老中医治疗肺心病经验. 新中医, 1996, 28 (5) : 2
- [11] 张问渠, 郭玉英. 赵锡武对心脑血管病的治疗经验. 新中医, 1988, (7) : 6
- [12] 何炎燊. 清燥救肺汤新用. 新中医, 1991, (4) : 17
- [13] 郑晓瑛. 杨百荪论治肺胀纲要. 湖北中医杂志, 1994, 16 (2) : 2
- [14] 田玉美. 肺胀病病因证治述要. 湖北中医杂志, 1995, 17 (1) : 32
- [15] 贺又舜. 苇茎汤加减运用的临床经验. 江苏中医杂志, 1982, (5) : 14
- [16] 朱良春. 对《金匱》两个方证之我见. 江苏中医杂志, 1982, (5) : 33

咳 嗽

【概述】

咳嗽是肺部疾病的主要症状之一，慢性支气管炎、肺炎、肺气肿、肺心病、肺结核等均可见咳嗽症状。中医认为，外邪侵袭、脏腑功能失调均可导致咳嗽的发生，但肺脏功能之失调是咳嗽发生的关键所在，不论外邪或其他脏腑有病，均必累及肺脏，始可导致咳嗽，正如《医学三字经》所指出：“然肺为气之主，诸气上逆于肺则呛而咳，是咳嗽不止于肺，而亦不离乎肺也。”咳嗽的治疗首当分辨外感与内伤。外感咳嗽起病多较急，病程较短，初期多伴有表证，实证居多，治疗疏散外邪、宣通肺气为主，一般不能过早使用苦寒、滋润、收涩、镇咳之药，以免碍邪。内伤咳嗽起病较慢，往往有较长的咳嗽病史和其他脏腑失调的证候，虚证居多，治疗调理脏腑为主。虚实夹杂者，应标本兼顾。

【名医经验】

1. 尤松鑫诊治经验

《河间六书·咳嗽论》谓：“寒、温、燥、湿、风、火六气，皆令人咳嗽。”说明六淫之邪最易侵表犯肺，致肺气壅遏不宣，清肃之令不行而发为咳嗽。张景岳又曰：“六气

皆令人咳，风寒为主。”说明外感咳嗽之中以风寒引发为多见。通常，外感咳嗽之治疗可通过辛温宣肺、化痰宁嗽之法而数剂见安。然而由于失治、误治，迁延日久而致顽固缠绵者往往有之。故临床上遇久咳患者经多种治疗乏效，而作各种常规化验检查，以及X线检查，往往无明显异常可见，病程少则半月，多则有达数月者，宜详询病史。可发现多数患者病初都滥用抗生素，如先锋霉素、螺旋霉素之属，以及过早投用寒凉中药，如桑菊饮、银翘散、板蓝根冲剂等。张景岳曰：“大抵治表邪者，药不宜静，静则留连不解，久必要生他病，故最忌寒凉收敛之剂，如《五脏生成》篇所谓‘肺欲辛’者此也。”若本宜辛散之风寒，因误治、失治而外邪留恋不去，伤及肺阴，气机痹阻则胸闷；风邪上干则咽痒、咳嗽频急；治节失司，津聚水泛，则咳痰清稀；每于阵咳后邪有出路，郁滞暂解，则咳亦顿减。患者舌苔多薄白腻，脉多弦紧。于此风寒留恋，饮聚于肺，治疗上非用辛温宣散、化痰蠲饮不可。宜《医学心悟》止嗽散合《金匱要略》苓甘五味姜辛汤。止嗽散方中7味：荆芥辛而微温，能祛风解表、宣肺利咽；百部甘苦微温润，紫菀苦而微温润，二药均能润肺止咳，且温而不热，润而不膩，新久咳嗽皆宜；桔梗辛苦，白前辛甘平，均能祛痰止咳，但一升一降，不论属寒属热，皆可使用；橘红辛苦温，能降气化痰；甘草甘平，缓急止咳，调和诸药。全方能宣通肺气，温而不燥，润而不膩，苦不过寒，辛不过热，能宣能肃，能升能降，尤氏认为用治风寒留恋于肺之迁延性咳嗽甚为合拍。至于经方苓甘五味姜辛汤，方中干姜辛热，既能温肺散寒以化饮，又温运脾阳以化湿；细辛辛散，温肺散寒，助干姜散凝聚之饮；茯苓甘淡，一以杜生痰之源，一以化既聚之饮；五味子酸敛肺气而止咳，与细辛一

收一散，收不留邪，散不伤正；甘草和中，调和诸药。以上二方合用，共奏宣肺达邪、化饮止嗽之功。若咽痒甚，时有畏风恶寒者，加苏叶、杏叶、杏仁、防风；咳甚似喘，加麻黄；痰多清稀加桂枝；咳呛面红、便秘口渴，加大黄、石膏；年事已高，形神衰惫，配服金匱肾气丸，于证情缓解后续服该丸2~3月。

剂量上应遵“治上焦如羽，非轻不举”之旨，宜偏轻。治风寒咳嗽常可用五味子3g，细辛2g，干姜1g，蒸百部5g而获效。

如治杨某某，男，28岁。1995年9月诊。咽痒咳嗽已3月，甚则气喘，痰少而色白，时有心悸，舌苔薄白，脉紧而细，乃风邪久稽，痰饮内生，宜疏风宁嗽，理肺化痰，药用苏叶10g，杏仁10g，茯苓10g，半夏10g，桔梗5g，前胡5g，枳壳5g，干姜3g，细辛3g，五味子3g，甘草3g，服5剂症减，又服5剂咳嗽消除。^[1]

2. 沈宗国诊治经验

沈氏擅长肺系疾病的诊治，常用“清宣金脏法”治疗外感咳嗽。“清宣金脏法”源于清代名医雷少逸所著《时病论》。原方由牛蒡子、贝母、马兜铃、杏仁、瓜蒌、桔梗、桑叶、枇杷叶等8味组成。沈氏认为，肺为清虚之脏，其气宜清不宜浊，最不耐外邪。外感六淫袭人，皮毛先受，皮毛应肺，邪入肺金，则肺失宣肃，壅遏不畅，上逆而咳。故谓：“一物不容，毫毛必咳。”因此，治法上当以祛邪为主，而肺为脏腑之华盖，位高居膈上，故施药当以轻扬，药力易达病所，即“治上焦如羽，非轻不举”之意。沈氏认为“清宣金脏法”即“清肺”与“宣肺”并举，切中咳嗽的病机，重点突出，使痰清气顺，肺气宣畅，全方8味

药物药性平和，不寒不热，不燥不腻，轻清灵动，开达上焦，且有配伍简单、化裁方便之特色，因此适宜作为外感咳嗽的基本方。

沈氏认为，根据外感咳嗽感邪的性质，各证型均可用本方稍加变通，适当加减，即有确切的疗效。加减法如下：风寒袭肺：症见咳嗽声重，咯痰色白，恶寒或发热，无汗，苔薄白，脉浮紧，宜上方加荆芥、紫苏叶、柴胡、陈皮。风热犯肺：症见咳嗽气粗，咯痰粘白或黄，咽痛或咳声嘶哑，或有发热恶寒，口微渴，舌尖红，苔薄黄，脉浮数。宜上方加金银花、连翘、菊花、鱼腥草。燥热伤肺：症见干咳少痰，咯痰不爽，鼻咽干燥，口干，舌尖红，苔薄黄少津，脉细数，宜上方加栀子、知母、麦冬、沙参。痰热壅肺：症见咳嗽气粗，痰多稠黄，烦热口干，舌质红，苔黄腻，脉滑数，宜上方加黄芩、生栀子、苇茎、桃仁、红花。

如治欧某某，男，32岁，1995年4月19日初诊。咳嗽1周，痰黄而粘稠，咯吐不爽，量多，口干，吹风后咳甚，伴发热，畏冷，汗出，大便秘结，舌质红，苔薄黄，脉弦数。胸透提示：肺纹理增粗。辨证属风热犯肺，肺失清肃，营卫失和。治宜“清宣金脏法”。拟方：桑叶9g，枇杷叶9g，杏仁9g，瓜蒌24g，浙贝母9g，牛蒡子9g，马兜铃9g，桔梗6g，金银花9g，连翘9g，鱼腥草24g，薄荷6g，水煎服，每日1剂。3剂后，咳嗽顿减，痰易咯出，发热已退，大便通畅。但仍微恶风，口干，自汗，考虑卫外不固，上方稍加调整，加防风6g，白术9g，生黄芪12g，再进3剂，诸症悉愈。^[2]

3. 蔡友敬诊治经验

蔡氏对外感咳嗽的诊治，有独特见解。既掌握辨证施

治的规律，又明确辨病施治的方法，故临床收效甚佳。

杂病之中，最难治者，莫如咳嗽。以其原因复杂，治法繁多，不易辨，不胜记也。尤其外感咳嗽，多见而莫测。常使医者感到困难，患者缠绵受苦。但蔡氏诊病之时胸有成竹，认为肺为娇脏，外应皮毛，位处最高，而司其表。一切外感六淫，最易侵犯。从皮毛而内应于肺，致肺气壅遏不宣，清肃之令不行，气逆即咳嗽。故一切咳嗽初起之时，均以开肺邪，疏表分为主治。而风为六淫之长，百邪之先。外感咳嗽虽有寒、热、燥、湿之不同，其兼风则一也。感寒而咳者曰风寒，感热而咳者曰风温，感湿而咳者曰风湿，感燥而咳者曰风燥。开肺祛风为主而各用寒、热、温、燥以佐之，思过半矣。风寒之咳，鼻塞声重，清涕痰多，形寒头痛，骨节酸楚，脉浮紧或浮缓，苔薄白。治以辛温散表，宣肺解邪。风温之咳，鼻干而鸣，鼻孔中热痛，身热痰多，口干咽燥，苔薄黄，脉浮数。宜辛凉疏解，肃肺清热。风湿之咳，声如瓮中出，身重头重，骨节烦疼，胸闷不适，渴不欲饮，小便短，苔厚腻，脉浮濡而缓。宜祛风渗湿，宣通行气。风燥之咳，皮肤干涩，鼻孔热燥，咽中如有毛梗，痰难于出，或无痰干呛，舌质红，苔燥，脉浮数。宜辛凉清散，宣肺润燥。

言及治法，蔡氏认为三拗汤可为治外感咳嗽主方。麻黄为开肺祛风正药，外邪束肺者所必需；杏仁降气行痰，专治上气咳逆。咳逆无不由于上气。虽上气之原因有种种不同，而其致咳则一。气上者，则咳逆自平，麻黄去其致咳之原，杏仁则制其致咳之具，一君一臣，其功已明；益以甘草和之，无不调之疾矣。再察其所夹何气，佐以加减：兼寒者加桂枝，则为麻黄汤法，以治脉浮紧无汗之表邪重症。若轻症则用香苏、葱豉、荆防等时方亦可矣。兼热者，

加石膏则变为麻杏石甘汤法，轻症则用桑菊、银翘、薄荷、牛蒡子、杏仁、川贝之类。兼湿者，加薏苡仁则又变为麻杏苡甘汤法，再重者则用麻黄加术汤或三拗汤合平胃、二陈之类亦可。兼燥者，加麦冬、玉竹、天花粉则更变为葶菹汤法，祛风润燥，兼而有之。

蔡氏认为三拗汤的应用贵在麻黄一味。麻黄辛温，解表祛风，发汗平喘，凡是风邪束肺者为必需之药。但对兼温、兼燥者是否有助火伤阴之弊？蔡氏临证处方时，灵活应用麻黄，达到兴利去弊之功。如果风邪兼寒、兼湿者，多以生麻黄投入方中。遇风邪兼温、兼燥者，多用蜜炙麻黄，以减温燥之过，存其祛风之性。更有甚者，伤阴较重或暑热之时感受风邪，即用麻黄插入白茅根之中，以增滋阴润燥之功，同样达到祛风开肺之效。

更有一种寒热咳，余无他症，惟咳不止，逢寒则甚，逢热亦剧。当以百部、款冬花、紫菀、远志、旋覆花、苏梗、桑白皮之类加减治之，亦即程钟龄止咳散之意。百部为寒热咳主药，非此不效，不可不知。此外感寒热夹杂、内外合邪，而不同因者之大要治法也。

蔡氏在辨证基础上更用辨病方法加以运用，如咳嗽不止与过敏有关者，在辨证方中加蝉蜕、防风、乌梅之类以祛风脱敏；属于肺炎而咳嗽者，在辨证用方基础上，加球兰叶、鱼腥草等以清热解毒疗效更佳；属小儿百日咳者，在三拗汤基础上加侧柏叶、百部、川贝以祛痰镇咳。无论寒热之咳，如入夜咳剧或喉痒即咳，在辨证之外再加蝉蜕、枳壳等以祛风解痉；属于素有肺结核而复新感者，其症状见两胁作痛，寒热阵作，胸中痞热，痰如弹丸，色带青绿，舌苔黄腻。可用《沈氏尊生》方柴前连梅散为最妙。前、柴之一升一降；连、梅之一泄一收；薤白、秋石之一开一

引，层层相制其短，而用其长，其效甚佳，历试不爽。

总之，蔡氏对外感咳嗽的治疗是以三拗汤为主方，根据兼证不同加以散寒、清热、祛湿润燥之药。使后学者一目了然，易学使用，必获良效。^[3]

4. 陆拯诊治经验

陆氏认为，治疗咳嗽仅以类证分型辨治，如六淫外邪咳嗽、脏腑虚损咳嗽，仅列数种证型，设立治法，尚欠精细，难获确效，故提出：咳嗽宜辨时间、宜辨咳声、宜辨咳形、宜辨痰色量质、宜辨病程、宜辨妇幼之不同，如此区别深究，条分缕析，方能切中病机，施治得法。陆氏的这些经验应用于临床，屡试不爽。

①辨咳之时间，判宣降之失常：肺主气，其功能一主宣发，一主肃降，宣降功能正常，呼吸平匀，胸中舒畅，则无咳嗽出现。陆氏认为，若肺气应宣而反闭，应降而反逆，即可发生咳嗽。因此，咳嗽有肺气失宣和失降之不同，并可在咳嗽发作（或加剧）时间上进行鉴别。一般来说，若咳嗽以晨起为甚者，多属肺气失于宣泄，治疗应以宣肺利气，药用麻黄、鹅不食草、桔梗、牛蒡子、僵蚕、薄荷、蝉蜕之类；如入暮增剧者，多为肺气失于肃降，治疗应以肃降肺气，药用桑白皮、杏仁、金沸草、前胡、川贝母、葶苈子、苏子；若日晡为甚者，多属痰热阻肺，气机失于通降，治疗应以通降肺气，清热化痰为主，药用竹沥半夏、天竺黄、瓜蒌、鱼腥草、蚤休、猴枣散；昼夜均甚者，多为肺气壅阻，宣降俱为失常，治宜利肺止咳，宣降并顾，药用紫菀、款冬花、白前、百部、桔梗、枳壳；子夜干咳甚者，多为肺阴不足，痰热内伏，治宜滋阴润肺，清热止咳，药用麦冬、北沙参、南沙参、玄参、马兜铃；若大便

干结者，可加蜂蜜、瓜蒌仁增强滋肺润肠作用。

②辨咳之声音，审邪正之盛衰：咳嗽既可见于外感疾患，又可见于内伤病证。在外感疾病中常为推邪外出的表现，在内伤疾患中则是脏腑虚损功能失调的现象。但外感咳嗽和内伤咳嗽的咳声有所不同。故陆氏认为从咳嗽的声音中也可判断邪正之盛衰。如咳声重浊者，多属寒邪犯肺之实证，治疗宜以宣肺散寒，药用麻黄、桔梗、甘草之类。若咳声洪亮者，多为热证（包括火证）、实证，或风热犯肺，或燥邪淫肺，或痰火阻肺，或肝火侵肺等。风热者，常兼表证，治以清热宣肺，药用牛蒡子、薄荷、黄芩、鱼腥草、象贝；燥邪者，也兼表证，但咽干口燥明显，治以清燥润肺，药用桑叶、杏仁、南沙参、天花粉、梔子；痰火阻肺者，为热象显著，咳势较剧，治以清肺化痰，药用天竺黄、竹沥半夏、蚤休、川贝母、瓜蒌；肝火侵肺者，为气火明显，咳时面红气逆，胸胁作痛，烦躁易怒，治以清肝肃肺，药用生代赭石、桑白皮、青黛、海蛤壳、梔子；如肝火伤及肺阴者，宜再加北沙参、麦冬、蜂蜜等；若咳声低沉者，一为肺气不足、寒痰内伏，二为肺中气阴俱伤，三为肺脾两虚，四为肺肾同虚。肺气不足、寒痰内伏者，常见咳声不甚响亮，神疲怯寒，舌淡、苔白，脉缓滑，治以补肺祛痰，药用黄芪、五味子、紫菀、款冬花、苏子；肺中气阴俱伤者，常见咳声不响，咽喉觉干，或语声嘶哑不扬，状如金破不鸣，治以润肺益气，药用麦冬、天冬、羊乳、西洋参、川贝母、杏仁、马兜铃；肺脾两虚者，常见咳声低沉，咳时易于自汗，倦怠乏力，面色苍白，大便不实，治以益肺补脾，药用党参、黄芪、白术、茯苓、甘草、款冬花；肺肾同虚者，常见咳声低沉无力，咳时兼喘，精神衰惫，头晕耳鸣，腰膝酸软，治以补肺益肾，药用红

参、紫菀、款冬花、山茱萸、五味子、补骨脂，若喘促明显者可再加胡桃肉、蛤蚧，以增强益肾平喘之功。

③辨咳之形状，定病位之高低：《内经》云：“五脏六腑皆令人咳，非独肺也。”咳嗽虽以肺为主，但与其他脏腑有密切关系，如“脾为生痰之源，肺为贮痰之器”，“肺主呼气，肾主纳气”等等。陆氏认为，肺及其他脏腑所引起的咳嗽，可从咳嗽的形状上加以区别。如喉痒而致咳嗽者，多为肺气失宣，治以宣肺祛痰，药用桔梗、麻黄、甘草、牛蒡子；干咳喉痒者，多为肺阴不足，治以润肺止咳，药用马兜铃、枇杷叶、北沙参、麦冬、川贝母；喉痒、气逆相兼作咳，且咳嗽连续不止，多为痰阻于肺，气机失于通降，治以肃肺祛痰，药用桑白皮、杏仁、葶苈子、瓜蒌、竹沥半夏。胸中气逆上冲作咳者，兼见咳时面红耳赤，咳声不爽，眼目流泪，多为肝火犯肺，气火有余，治以清肝肃肺，药用海蛤壳、青黛、生代赭石、梔子、木蝴蝶；胃中有气上逆而作咳者，常见呕泛痰涎，多为胃气累肺，治以和胃利肺，药用旋覆花、半夏、煅代赭石、苏子、生姜；小腹有气上冲至胸而作咳者，常见咳中兼喘，多为肾不纳气，水邪上泛，药用桂枝、五味子、茯苓、甘草、干姜；如胸中气道有痰上升至喉而作咳者，多为脾湿酿痰，上贮于肺，治以健脾理肺，药用半夏、陈皮、白术、党参、厚朴。如咳嗽阵作，咳形不爽，涕泪俱出，多为风痰着肺，气机失于肃降，治以肃肺祛风，药用僵蚕、地龙、百部、桑白皮、蝉蜕、灵磁石，若风痰阻络者，可酌加制南星、全蝎搜风祛痰。

④辨痰之色质，别寒热之不同：痰涎阻于肺中，上行气道即可咳嗽。咳咯之痰色质量，陆氏认为对辨证颇有意义。如痰之颜色黄白与青黑，质之厚薄与稠腻，量之多少

等，对辨别寒热，指导治疗，有重要意义。

如痰色黄者，咯而不爽，多为肺热邪盛，痰热互阻，治以清肺化痰，药用黄芩、鱼腥草、蚤休、牛蒡子、生石膏；痰黄咯而爽者，虽为肺热较盛，但邪已有出路，治以清肺泄火，药用一见喜、栀子、桑白皮、黄芩、竹沥；痰黄如脓而腥臭者，多为热毒阻肺，气机壅滞，治以清肺解毒，药用半枝莲、败酱草、芦根、冬瓜仁、金银花、瓜蒌仁；痰黄而夹血丝者，则为肺热伤络，治以清肺安络，药用侧柏叶、黄芩、川贝母、知母、橘络。如痰白咯而爽者，多为寒邪犯肺，为邪有出路之象，治以理肺散寒，药用白前、荆芥、紫菀、苏子、半夏；痰色青绿如水者，多为寒饮内伏，肺气不利，治以化痰利肺，药用桂枝、干姜、细辛、五味子、款冬花、紫菀。如痰色灰黑而偶然见者，多为尘埃犯肺之故，可不予治疗；若黑痰多而味咸者，则为肾虚水泛，上犯于肺，治以益肾理肺，药用补骨脂、五味子、诃子肉、茯苓、苏子等。

察痰质而辨病者，如痰涎厚者，多为热象，或是痰热内盛，或是寒从热化，或是湿从燥化，治以清热化痰，药用竹沥半夏、天竺黄、瓜蒌、川贝母。痰厚而稠，咯之不爽者，多属湿痰内阻，肺气不利，治以化湿祛痰，理肺止咳，药用半夏、陈皮、茯苓、苏子。痰厚似成块者，咯之爽快，多属邪气渐出，肺气渐利，治以肃肺推邪，药用羊乳、桔梗、生甘草。若痰涎稀薄如泡沫者，多为寒象，或是寒痰阻肺，或是水饮伏肺，治宜均用温化痰涎为主，寒痰阻肺者，药用麻黄、细辛、干姜、紫菀；水饮伏肺者，则用桂枝、茯苓、白术、甘草、款冬花。痰薄而腻，咯之不松，吐之难出，多属水湿内蕴，酿痰贮肺，治以燥湿化痰，药用半夏、制南星、陈皮、茯苓。痰涎稀薄，吐出后

不久即成水样物，多为脾虚水湿内停，肺气失降，治以健脾理肺，药用白术、党参、茯苓、陈皮、半夏。痰涎稀薄而味咸者，多属脾肾两虚，肺气不足，寒痰内阻，治以益肾补脾，利肺化痰，药用补骨脂、干姜、五味子、熟地、白术、甘草等。

察痰之多少而辨病者，如咯痰量多，见于新感者，虽是痰涎阻肺。但为邪有出路之象，治以宣通肺气，因势利导，药用桔梗、甘草、象贝母，若偏于热者，再加牛蒡子、冬瓜仁、瓜蒌；偏于寒者，则加苏子、半夏、荆芥。如咯痰量多，见于热病中期或饮病复发，多为痰涎壅盛，肺气不畅，为病进之表现，治以肃肺化痰为主，偏于热者，药用天竺黄、竹沥半夏、川贝母、葶苈子、蚤休；偏寒者，则用苏子、莱菔子、金沸草、杏仁、细辛。若咯痰量少，见于新感者，则为外邪犯肺，气失清宣，治以宣肺散邪为主，偏于风寒者，药用荆芥、紫苏、桔梗、杏仁；偏于风热者或燥热者，则用桑叶、薄荷、牛蒡子、象贝母，或南沙参、麦冬、生地、蜂蜜。喉痒干咳，咽红而燥，为肺系郁热，阴液不足，治以清喉利咽，药用玄参、西青果、胖大海、夏枯草、土牛膝等；火热盛者可加六神丸少量含服，其效更著。

⑤辨咳之病程，明虚实之多寡：咳嗽之病程有短有长，陆氏认为，病程短者，多属实证，为六淫犯肺居多，或风热犯肺，或风寒犯肺，或燥热犯肺等，治以宣通肺气为主，风热者药用薄荷、牛蒡子、象贝、鱼腥草、桔梗、黄芩；风寒者药用麻黄、杏仁、甘草、荆芥、前胡；燥热者则用桑叶、南沙参、天花粉、麦冬、生石膏、川贝母等。病程约在1周至2周间者，常表现为咳嗽剧烈，外邪均已化热，痰热交阻，肺气壅阻，或因热伤津，肺津受伤，治以清肺

化痰为主，药用桑白皮、野荞麦、黄芩、鱼腥草、竹沥半夏，或用生石膏、瓜蒌、川贝母、麦冬、知母等。病程长者，多为实中夹虚，虚中夹实。或肺阴不足，痰热内阻，或气阴两虚，痰滞于肺，如实中夹虚者，以肃肺为主，兼顾扶正，药用黄芩、杏仁、桑白皮、川贝母、羊乳、南沙参、麦冬；虚中夹实者，治以益肺养阴，止咳化痰，药用北沙参、麦冬、生黄芪、党参、紫菀等。此外，病程长者还有其他脏腑犯肺而致咳者，或肺病累及他脏而咳嗽不止者，如肝火犯肺、心火凌肺、脾虚累肺、肾虚及肺等。若肝火犯肺，宜以柔肝润肺，药用生白芍、桑叶、梔子、生代赭石、杏仁、川贝母、北沙参；心火凌肺，治以清心利肺，药用百合、知母、莲子芯、丹参、远志；脾虚累肺，治以补脾益肺，药用党参、白术、黄芪、茯苓、陈皮、苏子；肾虚及肺，治宜补肾疗肺，药用胡桃肉、五味子、诃子肉、补骨脂、冬虫夏草等，如咳甚者再加杏仁、川贝母、紫菀，喘甚者则加蛤蚧、人参。

⑥辨妇幼之咳，治法当有异同：妇女因其经、带、胎、产之生理现象，陆氏认为，妇女月经期或妊娠时之咳嗽治疗当异于男人，如月经前咳嗽，乳房作胀，胸胁不舒，多属肝气失畅，肺金受累，治以疏肝理肺，药用柴胡、枳壳、木蝴蝶、青橘叶、桔梗、甘草；月经前咳嗽少痰，或痰中夹血，多为肝经气火偏旺，冲任不调，肺失清肃，治以理肝调冲，清肺止咳，药用白芍、青黛、梔子、蛤壳、麦冬、玄参。若月经期咳嗽，多为肺气不利，冲任失调，治以肃肺安冲为主，月经量多者，药用生地炭、白芍、茜草炭、川贝母、马兜铃、杏仁；月经量少者可用当归、丹参、桃仁、香附、桑白皮、紫菀、郁金。月经净后即作咳嗽，小腹空痛，胸中少气，多为冲任空虚，肺气不足，治以补冲

理任，益肺止咳，药用当归身、补骨脂、山茱萸、黄芪、款冬花、五味子。妊娠咳嗽者，不宜大宣泄，亦不宜猛肃降，更不宜重镇坠痰，影响胎元。所以在妊娠早期而见咳嗽者，常以清肺和胃为主，药用竹茹、佛手柑、桔梗、牛蒡子、生甘草；妊娠中期而咳嗽者，则以理肺安胎为主，药用黄芩、苏梗、杏仁、川贝母、桑寄生、续断；妊娠6个月以上而咳嗽者，则以肃肺和胎为主，药用桑白皮、前胡、紫菀、款冬花、黄芩等。

小儿咳嗽虽同于大人，但小儿为稚阴稚阳之体，脏腑娇嫩，形气未充，易于感受风毒时邪，发为顿咳；或禀赋特异，过敏致咳；或风寒侵袭，饮食停滞，肺胃同病；或虫积内阻，虫毒射肺等。如顿咳者，偏于肺热痰蕴，治以清肺祛痰，解毒搜风，药用桑白皮、麦冬、川贝母、僵蚕、蝉蜕；偏于痰湿内阻，肺气壅滞，治以理肺化痰，败毒熄风，药用百部、白前、半夏、制南星、全蝎、蜈蚣；偏于痰气血互结，肺失肃降，治以祛痰活血，理气肃肺，药用紫菀、款冬花、当归、白芍、桃仁、地龙等。如过敏致咳者，偏于风热，治以清肺疏风，药用野菊花、一枝黄花、蝉蜕、牛蒡子、杏仁、象贝母；偏于风寒，治以疏风寒，宣肺气，药用麻黄、鹅不食草、辛夷、苍耳子、桔梗、防风、全蝎等。风寒夹食而咳嗽者，治以通降肺气，兼以消食，药用杏仁、枳实、厚朴、荆芥、桔梗、前胡，如邪从热化，口苦，大便秘结，可去荆芥，再加大黄、黄芩等。虫积而致咳嗽，多见咳嗽反复不已，形瘦面黄，或面有虫斑，时有腹痛，治以杀虫化积，理肠利肺，药用百部、胡黄连、鹤虱、雷丸、苦楝根皮、白前等，大便秘结者，可加葶苈子、玄明粉，以祛痰通便。

以上6种辨证，是属具体方法，临证之际尚须综合研

判。如咳嗽上午为甚，咳声重浊，咳形不爽，咯痰色白，病程短者，如此症状均为风寒犯肺之现象，合而进行全面分析，其属风寒犯肺无疑。又如咳嗽子夜阵作，咳声响亮，咳形不爽，痰少或无痰，病程长者，均是肺阴不足、痰热互结之状，进而综合归纳、全面分析，更能证明肺阴不足、痰热互结之病证。同时还必须注意兼症情况，如有无寒热，有无胸痛，有无气急、有无痰中夹血等，从兼症中常可了解病变在表在里，是寒是热，属虚属实，一一明白。^[4]

5. 蒋士英诊治经验

蒋氏善以温病学理论作指导，辨治咳嗽每有独到的见解。

①治咳喘无论外感内伤，总以“肺系”为指针，以此为辨：蒋氏认为，《素问·咳论》“五脏六腑皆令人咳”其至要处在于突破了单一的证治模式，而拙处在于辨证条析包罗一切，令医家难以切中主证法规。蒋氏指出，咳喘虽病因各异，兼挟诸证纷繁，但治疗应紧紧抓住“肺系”这一指针，分型治疗。

外感咳嗽：上焦手太阴肺经卫分证，主药共有5味：杏仁9~12g，桔梗10~12g，紫菀12g，款冬花9~12g，蒸百部5~10g。风热型：发热重于恶寒，咽疼，舌边尖红，脉浮数。主药加金银花12g，连翘12g，荆芥9g，牛蒡子10g，薄荷6g，鲜芦根30g。风寒型：恶寒重于发热，尤以大椎穴怕冷且重滞，舌白，脉稍紧。主药加防风9g，羌活12g，前胡12g，葱白2支，白前10g。若夏天“冒暑”诱发咳嗽，主药加新加香薷饮。若秋冬寒湿外袭咳嗽，主药加羌活胜湿汤化裁。

病毒性感冒咳嗽：单纯型：除咳嗽外，发热恶寒程度

均比普通感冒严重：鼻咽颊部充血，四肢骨节剧疼。主药5味加蝉蜕5g、鱼腥草25g、鸭跖草25g、板蓝根、大青叶各20g。肺炎型：除咳嗽外，伴有手太阴肺经的气分证，即邪热壅肺，身热面赤气粗。主药5味再加黄芩10g，知母9g，生石膏30g，麻黄5g，梗米20g，鸭跖草30g。中毒型：除咳嗽外，可以出现高烧持续不退，神志昏迷，呕吐，或伴有脑膜炎症状。主药5味加玳瑁15g（代犀角），玄参心15g，莲子芯10g，竹叶心10g，连翘心12g，连心麦冬15g。

温燥干咳：手太阴肺卫分证，口舌唇、咽喉之津液干燥，舌边尖红，以夜间干咳为显。主药5味加桑叶12g，桑白皮12g，北沙参20g，山梔皮10g、浙贝母12g、雪梨皮25g，淡豆豉10g。

凉燥干咳：手太阴肺卫分证，周身畏寒以项背部大椎穴为显，头疼无汗，咳痰清稀。主药5味同上，再加紫苏12g，法半夏12g，化橘红10g，前胡10g，枳壳10g，生姜汁3~4滴。

百日咳（顿咳）：阵发性痉挛，持续咳嗽不止，一昼夜可阵咳数十次，尤以夜间为甚，且发病人群多是儿童。百日咳风热型：胸闷气急，唇红，手足拘牵，头倾胸曲，声出似哮喘，咳剧可兼痰中带血丝。主药5味加南天竺子5~10g，蒸百部5~8g，罂粟壳5g，腊梅花6g，以上4味药仅选1~2味，再加清炙麻黄6g，杏仁12g，生石膏15g，金银花12g，连翘12g，牛蒡子10g，山梔子10g，甘草6g。百日咳风寒型：恶寒无汗，头痛，舌苔白滑而薄。主药5味加南天竺子6g，蒸百部8g，麻黄9g，细辛5g，五味子9g，法半夏12g，干姜3g。

虚劳咳嗽：以肺结核型居多。症见低热唇红，夜寐不

安，潮热咳嗽痰稠粘，烦躁，脉细弦。主药 5 味加南沙参 18g，北沙参 18g，黄芩 10g，天门冬 15g，知母 6g，蒸百部 5g，砂仁 3g。

内伤咳嗽：以脾胃气虚或实证挟痰浊湿邪波及于肺所引起，治宜养阴清肺，疏通脾胃之气。蒋氏的常用方药：生地 20g，玄参 20g，南沙参 15g，北沙参 15g，川贝粉 6g，炙枇杷叶 6g，柿霜 6g，生甘草 9g，痰多加海蛤壳 20g，气促加煅磁石 30g，肾不纳气加蛤蚧尾 1 对，西洋参 6g（另冲）。

喘证挟咳：久咳伤肺，或病久肺虚，则肺气不能肃降而成气短而喘。然喘证日久必损及于肾，故无论实喘虚喘，治疗着重于肺肾两脏，治宜祛邪平喘以培补摄纳下焦真元。喘证属寒者，喘急胸闷，伴有咳嗽咯痰清稀色白，初起恶寒头痛无汗，苔白脉紧者，蒋氏常用药：麻黄 9g，杏仁 12g，生甘草 6g，细辛 9g，法半夏 12g，五味子 6g。喘证属热者，喘促气粗，重至鼻翼煽动，咳嗽痰黄而粘稠，口渴喜冷饮，胸闷烦躁，汗出，甚则发热面红，舌质边红，脉浮数，蒋氏每以重用生石膏 30g 与麻黄 6g 成药对，加杏仁 12g，桑白皮 12g，黄芩 10g，生甘草 10g。虚喘肾不纳气，喘促日久，呼长吸短，动则喘息更甚，形瘦神惫气不得续，汗出，肢冷面青，两肩峰上耸，大椎穴以下似冷水浇。甚则肢体浮肿，小便不利，心悸不安，舌质淡，脉沉细。药用别直参 20g，蛤蚧尾 1 对（研细末吞），再加五味子 6g，补骨脂 12g，胡桃肉 30g，沉香 6g，菟丝子 15g，枸杞子 15g，覆盆子 15g。

②用药经验：蒋氏擅治咳喘于新感时令之邪，惯用温病学理法方药为指南，而病在内伤宿疾时善博采诸家，尤其对明清两代医家研究颇深。其用药配伍有独到之处。

蒋氏认为，治咳应学大禹治水法，须以疏导为先，切不可堵塞闭流。一见咳使用大队苦寒镇咳，易铸大错；治咳不开肺气非其治也。无论风热风寒咳嗽毋忘宣泄肺气，药宜质轻灵动，“治上焦如羽”，轻扬肺气用5味主药加减。桑菊饮、银翘散、止嗽散、三拗汤都是常用有效方。肺气上逆较重者，极需肃降肺气，可选用苏子降气汤、三子养亲汤、葶苈大枣泻肺汤，此谓降气法。咳嗽日久肺阴虚者，用清润法施之，选用瓜蒌仁、天冬、青黛、海蛤壳、天竺黄、竹沥等。后期以培补肾气本元，方用七味都气丸、百合固金汤、人参蛤蚧散。

咳嗽不论外感内伤，证发1周以上者，施药时要添加开肺气药物；新感类往往加重杏仁与桔梗及淡豆豉的用量。由表入里卫分证消失后咳嗽仍不止时酌加温通之荆芥穗、生麻黄。

咽喉瘙痒而引起的干咳，夜半咽颊部似猫抓样干涩痒，干咳半月至一二月不止，蒋氏认为，应追加生白芍、凤凰衣、玉蝴蝶、西青果、生麻黄。蒋氏喜用冬桑叶，因其叶纹理似肺，性轻扬，是手太阴肺治咳佳品，干咳日久引起胸膜疼痛拟瓜蒌薤白白酒汤加橘络、生香附、片姜黄。

辨治咳喘不离于肺亦不限于肺，治实必顾虚，治虚兼顾实；实喘治肺，虚喘治肾。蒋氏认为，紫菀、百部、款冬花三药同用止咳力强，可谓“三灵”，无论外感内伤咳嗽，但凡诸咳均可用。

咳则气喘为肺气不降，动则气喘是肾气不纳，新喘实喘病责于肺，虚喘宿疾病根于肾。麻黄合五味子平喘止咳有殊功。麻黄生用其宣肺力更强，五味子敛肺，一宣一敛肺气升降趋衡，达到止咳平喘的目的。广地龙配五味子对定喘有效，因有摄纳肾气之功。肺气不降用苏子降气汤，

肾气不纳拟定喘汤加六味丸合用。

咳嗽之病发于肺，波及于脾，影响于肾。但咳嗽之症终为三期所共见，故蒋氏认为，理肺治咳必须贯彻始终。对表寒里饮，咳唾白色泡沫状痰，脉浮紧者用小青龙汤最是合拍，细辛干姜五味子法半夏宜同用，量应相等，如细辛量过小，效果难取，汤剂不可拘泥细辛不过钱论。

久咳气喘心悸动者，拟填补下元，药用补骨脂、覆盆子、菟丝子、淫羊藿，即“三子一羊汤”。寒喘肾阳虚者，诸药无效用局方黑锡丹 6~9g 包煎或酌减吞服，病解即止勿过服。此类病家待胃纳馨开时可小剂量频服紫河车粉，每次早晚饭后吞服 3g，有效。^[5]

6. 唐福安诊治经验

唐氏治疗咳嗽常以止嗽散加减，其药物组成为：荆芥、桔梗、炙百部、前胡、炙紫菀、车前子、甘草、陈皮。如外感发热者，加金银花、连翘、黄芩、焦山栀；肺气上逆，咳喘气急者，加炙苏子、桑白皮、葶苈子、旋覆花、代赭石；痰湿阻遏气道，喉间痰鸣者，加炙麻黄、杏仁、象贝母；喉痒者加黛蛤散；肺有郁热，大便秘结或不畅者，车前子易车前草，加杏仁、瓜蒌子、麻仁等；邪热内郁，小便黄短者，加黄芩、六一散。唐氏在临床中分以下几型进行辨治。

①风寒束表：风寒外袭肌表，肺失肃降而上逆。症见头痛，形寒身热，骨节酸疼，鼻塞流清涕，咳嗽痰白，脉浮紧或浮缓，苔薄。用止嗽散合三拗汤加一枝黄花；夏季合香薷饮加味；如邪郁日久化热，表邪未解者，合麻杏石甘汤或加鱼腥草、鹿含草、野荞麦根；痰多白粘加姜半夏、象贝母；痰黄量多加胆南星、竹沥半夏、天竺黄，气阴不

足加山海螺、平地木、太子参等。

如治朱某，男，59岁，工人。1984年12月18日初诊。近3天来畏寒，鼻塞流清涕，咳嗽咽痒，痰白粘，咳而不爽，食欲欠佳，大便偏干，脉浮，舌淡红苔白。治拟解表宣肺止咳：荆芥9g，前胡9g，炙百部9g，炙紫菀9g，象贝母9g，苏叶6g，桔梗6g，杏仁6g，黛蛤散12g，车前草12g，甘草5g，陈皮3g。3剂。12月24日复诊：药后咳嗽大减，余症消失，唯食欲欠振。上方去苏叶、黛蛤散，荆芥、象贝各减为6g，加焦建曲20g，炒麦芽20g，炒谷芽20g，5剂而愈。

②风热袭肺：风热之邪侵袭或素阳盛感邪，邪易热化，症见头痛，微恶寒，身热鼻塞，咳嗽不爽，痰黄白而稠，或见口渴，咽痛，双蛾红肿，或声音不扬，脉浮数，舌红苔薄黄。用止嗽散加黛蛤散、冬桑叶、蝉蜕、牛蒡子、玉蝴蝶。双蛾红肿疼痛，加板蓝根、玄参、金银花、连翘，鼻流黄脓涕加贯众、大蓟。

如治朱某，女，28岁，工人。1984年12月19日初诊。2月前，受风热侵袭，咳嗽，头痛，鼻微塞，曾经中西药治疗无效。来诊时咳嗽甚剧，咳甚则气喘，咽痒痰少，咳痰黄白而稠，脉浮数，舌红苔薄黄。治拟疏风清热，宣肺安嗽：冬桑叶9g，桔梗9g，荆芥6g，炙百部6g，大蓟6g，甘草6g，黛蛤散24g，前胡10g，炙紫菀10g，野荞麦根15g，车前草15g，鹿含草15g，玉蝴蝶3g。5剂，另参耳合剂（蔓参、佛耳草、车前草、鱼腥草、生甘草）1瓶，睡前服2匙。12月28日复诊：药后咳嗽骤减，咯痰较松，咽痒亦减。上方去大蓟，继服5剂而安。

③燥热犯肺：秋冬感受时令燥邪，燥气烁金伤阴，肺失清润。症见口鼻干燥，咽疼，干咳无痰或痰少不松，痰

白粘稠，咳甚则胸痛，脉浮数或沉细数，舌红。宜止嗽散加南沙参、北沙参、麦冬、玉蝴蝶、玄参、鹿含草、鱼腥草、山海螺、冬桑叶。口干渴饮加天花粉、鲜（或干）芦根；咯痰带血加白茅根、侧柏叶、生地炭、仙鹤草。去桔梗或减量。

如治郑某，男，59岁，干部。1984年10月6日初诊。患者有高血压史。每逢秋冬季节易感外邪。近5天来咳嗽咽痒，咯痰不松，痰少粘稠，口干燥，时有胸痛，脉浮数，舌光红，治拟养阴解表，宣肺安嗽，佐以平肝清热：荆芥5g，甘草5g，冬桑叶9g，前胡9g，炙紫菀9g，桔梗6g，炙百部6g，黛蛤散24g，玄参10g，野菊花10g，鱼腥草15g，鹿含草15g，车前子15g。4剂。10月11日复诊：药后表邪已解，咳嗽止，口燥渴亦减，脉细数，舌红。原方去冬桑叶、野菊花，加麦冬10g，山海螺15g，5剂善后。

④痰湿内蕴：脾虚湿困，湿聚生痰，症见咳嗽痰多白沫或黄痰，头晕肢软，食欲不振，胸闷腹胀，大便溏薄或滞下不畅，小便量多或黄少，脉濡或滑数，苔白腻或黄腻。用止嗽散合二陈汤加薏苡仁、扁豆衣、厚朴、六一散。如痰湿偏寒加藿苏梗、省头草；郁久化热，痰热互滞者加生石膏、黄芩、野荞麦根、金银花、鹿含草；脾运不健加焦建曲、炒薏苡仁、莱菔子、炒扁豆。荆芥用量宜轻。

如治傅某，男，40岁，干部。1984年8月30日初诊。近旬来头晕肢软，时有脘腹作胀，睡则多梦，咳嗽痰多，咽痒，胸闷气喘，脉濡，苔腻略黄。此乃痰湿内阻，肺失肃降。治拟健脾利湿，化痰宁嗽：荆芥6g，姜半夏10g，炙紫菀10g，前胡10g，焦建曲9g，桔梗9g，炙百部9g，扁豆衣9g，茯苓12g，六一散12g，车前子、黛蛤散各12g，陈皮5g，炒薏苡仁15g，厚朴3g。7剂。9月6日复

诊：药后痰少，咳嗽已止，余症大有改善。原方去黛蛤散、厚朴，加太子参 12g，焦白术 9g。7 剂。

⑤木火刑金：木火亢盛，肺金受烁。症见气逆咳嗽，无痰或咳痰不爽，咳时面赤并引胁作痛，烦躁易怒，咽干，症随情绪变化而增减，脉弦数，舌红。用止嗽散加焦山栀、夏枯草、野菊花、旋覆花、代赭石、黛蛤散、清气化痰丸；或加桑白皮、野荞麦根、鱼腥草、竹沥半夏、鹿含草、地龙等。

如治姚某，女，47 岁，干部。1984 年 10 月 21 日初诊。咳嗽 20 余日，咽喉有痰感，咯痰不松，咽痒口苦，咽干而疼，易怒，便干，脉弦，舌红苔黄。此乃肝火犯肺，肺失清宣。治拟平肝泻火，宣肺止咳：旋覆花 6g，桔梗 6g，焦山栀 6g，野菊花 6g，清气化痰丸 6g，前胡 9g，夏枯草 9g，炙百部 9g，炙紫菀 9g，车前草 12g，生甘草 5g，代赭石 15g，黛蛤散 24g。5 剂。10 月 12 日复诊：服药第三天诸症缓解，今咳嗽已止，唯感烦，咽喉微干，原方继服 7 剂而安。

⑥久咳伤阴：素体阴虚，感受外邪失治或误治，以致病程较长。症见久咳不止，无痰或痰少白粘，或痰中带血，或口燥咽干，声音嘶哑，或午后潮热，颧红盗汗，手足心热，心烦失眠，脉细数，舌红无苔。用止嗽散合沙参麦冬汤。如外邪较轻或余邪未尽者加山海螺、玄参、天花粉；阴虚肺热加鹿含草、鱼腥草、野荞麦根；久咳损伤肺络兼有咯血，或痰中带血丝者，选加侧柏炭、白及、白茅根、仙鹤草、参三七；午后潮热颧红加玄参、地骨皮、青蒿、黄芩；盗汗加浮小麦、稽豆衣、煅龙骨、煅牡蛎，兼气喘加五味子、太子参。解表药用量宜轻。

如治占某，女，82 岁。1984 年 12 月 6 日初诊。咳嗽

反复多年。近5天来咳嗽咽痒，痰少白粘，咯痰不松，时有气喘，食欲不振，咽干口燥，鼻塞，脉数，舌光红。系阴虚内热，肺失清润。治拟养阴清肺安嗽：南沙参6g，北沙参6g，荆芥6g，桔梗6g，黛蛤散24g，山海螺15g，鱼腥草15g，野荞麦根15g，前胡9g，玄参9g，车前子12g，贯众10g，甘草5g，竹沥半夏3g。6剂。另参耳合剂1瓶，每晚睡前服2匙。12月15日复诊：前方服后，鼻塞、口燥、咽痒已解，咳嗽亦减。原方去贯众、荆芥、黛蛤散、野荞麦根，加麦冬10g，炙百部6g，炙紫菀9g，伸筋草12g。服7剂而安。

对于咳嗽一症，唐氏认为，不论外邪或内伤，均易化热，故在止嗽散中以微温之白前易寒降的前胡，与桔梗之轻清升提相配，起到一升一降，协调气机作用，如是则肺宁嗽安；加车前子或车前草，以利湿杜生痰之源。唐氏十分强调辨证论治，重申因，他说，治疗咳嗽不能见咳止咳，否则延误病情，缠绵难愈。他还重视民间草药的临床运用，如山海螺常用于气阴不足或外感余邪未尽的咳嗽，具有益气养阴润肺之功，起到补正不恋邪之效。验之临床，疗效确切。^[6]

7. 胡翹武诊治经验

①风痰之辨与疏风化痰法：风痰咳嗽，多为风邪外袭，郁闭肺气，肺失宣肃，治节通调受挫，气不化津，悉变为痰，遂致风痰合邪；或饮痰素盛之人，失于温化，上渍于肺，或遭淫风外袭，激动停痰宿饮，风痰搏击华盖，气道痹阻，呼吸不利，故咳逆上气连绵不已也。其痰清稀，色白，多泡沫。以风性轻扬易动，痰为阴邪，风激痰间，痰无以聚，故清稀不稠，且多泡沫；无热内灼，故色白也不

粘。咽痒声哑，喉间稀薄粘液缠绵不断，或微恶风寒，鼻塞流涕。其咳常阵作不已连声不断，移时可止，待后再咳，舌淡，苔薄白，脉浮或浮滑等为其常兼之症。肺金客袭风痰之咳，治当宗“在上者引而越之”之法，因势利导地择用疏风化痰为法，则风去痰化而咳嗽顿已。切不可滥投肃肺收敛止咳之品，以免敛邪锢痰之弊。《医学心悟》之止嗽散最佳，全方轻清宣透，疏风化痰，胡氏常增轻清开肺散风之蝉蜕，与功擅去风化痰之僵蚕参伍其间，其效更显。如兼有热者，其痰由清稀转为白粘，仍带泡沫。可予上方加牛蒡子、桑叶、连翘等；若兼寒者，其痰又为白稀带泡沫，仍于上方加细辛、麻黄、生姜等。疏风化痰方药一定要质轻量小，始符合“治上焦如羽，非轻不举”之旨。也不可久煎，以免散失宣透疏散之功用。对证投方，合理煎服，常能收一剂知再剂已之效。

②寒痰之辨与温肺化痰：寒痰客肺，多为阳虚痰饮内盛之人，复被外寒冷饮而诱发，致络脉凝涩，气道闭阻，肺失治节宣肃之权，故气无以吐，新气无以纳。遂致咳嗽气急，胸闷，甚则紫绀心悸，咳喘抬肩。证急病笃，于虚实疑似之间，验其痰可得其机因也。其痰色白清冷，质稀似饮，量多，或有咸味，落地即化为水。寒为阴邪，痰与之合，则阴冷更甚，故咳痰色白而清冷，咳出之痰多有清冷之感；阴凝质重，故痰稀如饮，与风痰之多泡沫者迥异。阳虚阴冷，大多肾阳先伤，寒痰咳嗽多伤肾气，故味咸；落地成水也为阴凝质重之故。此证以形寒肢冷，四末不温，口淡无味，或但以脊背冷凉，或头身疼痛或面目浮肿，舌淡，苔薄白而润或滑，脉浮紧或沉细弦为其常兼之症。“寒者温之”、“病痰饮者当以温药和之”，故寒痰凝滞之咳嗽，温肺既可散寒凝，又可化痰饮，再辅以宣肃肺气，化痰止

咳之品，其效更佳，方宜小青龙合苓桂术甘汤化裁。胡氏常以旋覆花、生姜相佐。旋覆花性温入肺，善下气化痰，且有泄水导湿之功。因其对胃粘膜有刺激之副作用，宜饭后服用。生姜集发表散寒化饮开痰之功于一身，于寒痰咳嗽之恙，与温中散寒之干姜同用，有温、散、守相辅相成之功。如属肾督阳虚，寒痰凝肺而致咳喘者，阳和汤为其最佳之方，稍事化裁，其效更宏。

③热痰之辨与清热化痰法：热痰蕴肺为咳嗽最常见之证型。多由辛热烟酒长期刺激，或肥甘恣服不忌，或久咳误治而成。其势缠绵，轻重不一，虽无外因诱发，也多咳逆不已。其痰黄粘稠，有如脓涕状，量多，一般较易咳出，或有腥臭之味，落地着水有形，不易融化。痰为热灼，色多黄变；熏蒸时久，痰液浓缩，其质当稠；蕴腐交结，时有腥臭之味；因质稠又粘，故成形而不易速融。如为风痰郁而化热，痰虽色白不稠，但颇粘，或在白粘痰中挟有少许黄稠之痰。此证多兼口干且粘，胸膈灼热憋闷，或唇红颧赤，尿黄便结，舌红，苔黄腻，脉滑数等症。治此者，当清化肺金痰热，方宜泻白散合葶苈汤加葶苈子、鱼腥草等。泻白散为肺热咳嗽灵验之方，但少化痰之品，葶苈汤虽为仲景主治肺痈之剂，但痰热内蕴则一，与泻白散合用治此型咳嗽尤宜。葶苈子功擅下气行水，泻热祛痰，鱼腥草尤能清肺泄热解毒，痰热咳嗽必配之味。如兼腑气秘结者，加通幽泻浊之大黄、瓜蒌仁、莱菔子等通腑泻浊。另有痰热初蕴肺金，咳嗽气逆胸膈憋闷，痰或不易咳出，咳出之痰并不黄稠，似与痰热有黄稠之痰有违，此乃痰浊得热则粘滞缠绵，交结难分，性粘质重，故不易外排；痰热一体未久，且津液未伤，故痰少黄稠。但经清化而证将近愈时，反有黄稠易咳之痰者，此为邪热渐清，痰浊将尽，

痰由量多且粘复为量少且稠，交蒸时久虽有黄变，但已正胜邪却，肺之吐故排浊之能有复，故易于排出也。故常有见黄痰咳之将愈之说，不可不知也。

④湿痰之辨与燥湿化痰法：湿痰蕴遏之咳嗽，多由脾虚失健之人，其不化精微与不运水湿互结为祟，悉变为痰浊，上渍肺金，阻遏肺气，其通调治节无能，水津不能四布，湿浊更难外泄，上渍内停之湿浊有增无减，气道壅塞，呼吸不利，故咳嗽连绵难已。其痰白粘重浊，量多，容易咳出，时有甜味，落地入水不易骤化，着物粘滞有如糍糊状。盖湿、痰皆性阴重浊，二邪相合，粘滞重浊无疑；无热内灼，故痰色始终为白，痰源不断，渍贮日增，故痰量特多，湿体流滑则易出也。常兼纳差身困，神疲乏力，或面目肢体浮肿，尿少便溏，舌淡润，苔白腻滑，脉濡缓或濡滑等症。湿痰蕴渍之咳嗽，非燥湿化痰不为功。因脾为生痰之源，肺为贮痰之器，故未可不求本于足太阴而只着标于手太阴，方宜六君二陈送服控涎丹较为合拍，以六君二陈健脾益中燥湿化痰，以杜生痰之源，小量控涎丹祛痰逐饮以驱器中之蕴痰，如此标本兼治，缓缓予服，多能收湿痰渐去、咳嗽渐止之效，所兼之症也可逐日消除。其善后巩固之法，可予香砂六君子汤合苓桂术甘汤化裁，长期服用，使痰源减或不生，湿痰咳嗽则少犯或不发也。

⑤燥痰之辨与润燥化痰法：燥痰之咳，多因肺津本伤之人，或邪热灼耗，伤及肺阴，或秋令燥气灼金，致喜润恶燥之肺金失却清润之性，虚火内生，灼津为痰，气道痹着不畅而致。其痰白粘，量少，极难咳出，或夹有血丝。缘由虚火内灼，已伤之津又被灼炼为痰，故痰少且粘；因燥痰由虚火而致，并非实热邪火内燔，故痰色少黄多白，津伤液耗，肺失濡润，气道干涩，则痰难咳出，或有肺络

燥灼受伤，血溢痰中，故痰中常夹血丝。此证多兼口干咽燥疼痛，以夜间为甚，形瘦颧红，手心灼热，尿黄便结，舌红少津，或有裂纹，苔薄黄，脉细数等症。治此应润燥养阴，清化痰热，桑杏汤合清燥救肺汤化裁甚宜。胡氏遇此症常易石膏为生津润燥化痰之鲜芦根，易人参为滋水清热养金润肺之玄参更佳。因石膏性寒质重，肺无大热者不宜用，人参甘温益气，阴伤而无气虚者亦当避。如属肾阴亏虚，肺失滋润，肺金燥痰不化之咳嗽，金水六君煎也甚合拍。尚有凉燥之咳，其痰之色质量同上，也不易咳出，但多伴形寒微热，鼻干且寒，口干唇燥不甚喜饮，治当温润散寒，宣肺化痰，以杏苏散合止嗽散化裁多能奏效，胡氏常以细辛当归参伍方中，二药既可辛润散寒，养血润燥，以疗凉燥之本，又可止咳下气，以治凉燥之咳嗽，诚为不可多得之品，用之则验。^[7]

8. 陈乔林诊治经验

陈氏对喉源性咳嗽的辨治颇具特色，疗效显著。

①病因病机：肺主气，司呼吸，以宣发肃降为顺。喉者呼吸之门户，肺之关口。外邪侵袭人体，除由皮毛而入外，也从口鼻咽喉而入，引起咽喉发干发痒，红肿作痛，令气道受阻，肺气壅遏不宣，失其清肃而咳。风热燥邪或风寒化热犯喉，或久咳不止，易伤津液，耗气伤阴，故喉源性咳嗽多表现有燥邪伤津证候，特征为：干咳无痰或少痰，必有咽喉作痒，一痒即咳，咳声嘶哑，甚至作冲气状连咳不止；恶食香燥，食即引发咳嗽；有咽部充血、粘膜干燥体征。

②治疗原则：针对该病的病理特点，陈氏认为，组方用药须体现宣、清、润、收四法并施的治疗原则，方能切

中病机，获取佳效。宣者，宣解、宣透、宣散也，即宣发病邪，令肺气畅达，咳逆遂止。肺气不宣则作咳，宣肺开提乃治咳的第一要义。常用荆芥、蝉蜕、桔梗、杏仁等宣肺之品。清者，清热、清解、清宣之谓，即清除邪热，祛火解毒。燥邪湿热侵袭，或风寒入里化热，热毒缠喉犯肺，“热者寒之”，故当清热解毒，常用金银花、连翘、牛蒡子、鱼腥草等药；润者，润燥、润肺、滋润之意，即滋阴润肺，培虚固本。燥热伤津，或久咳不已，耗气伤阴，“燥者润之”，更当润肺滋阴，常用沙参、麦冬、贝母、玄参等配伍。收者，收敛、收涩、收纳之说，即收敛肺气，纳气归元。咳嗽日久，肺气阴耗伤，金不生水，肾水亏虚，肾气不固，摄纳无力，治当敛肺纳肾，适用收法。常用生脉饮合六味地黄汤化裁。宣清并举，润收同用，是治疗喉源性咳嗽的用药特点。

③辨证施治：根据喉源性咳嗽的临床表现，陈氏分外感燥邪、肺燥津伤、阴虚肺燥、肺肾阴虚4个常见证型辨证施治。

外感燥邪：起病较急，可有恶风，鼻阻鼻燥，干咳无痰，或痰少粘稠难出，口干咽燥，咽充血（++~+++），粘膜乏津，舌尖红，苔薄白或薄黄，脉浮数。治宜清燥宣肺。方用蝉蜕10g，荆芥10g，桑叶10g，杏仁10g，玄参15g，麦冬15g，牛蒡子10g，射干10g，金银花15g，连翘15g，桔梗10g，生草15g。

肺燥津伤：有半月以上干咳史，咽燥干痒，咳甚则胸痛，咽充血（+++），咽后壁淋巴滤泡增生，粘膜乏津，频咽水，舌质偏红，苔白或淡黄少津，脉稍数。治宜润燥生津。方用沙参10g，麦冬15g，玄参15g，芦根20g，射干10g，藏青果10g，杏仁10g，川贝母8g，桑叶10g，桔

梗 10g, 生甘草 15g。

阴虚肺燥：有久咳无痰病史，咽燥干痒，咳声嘶哑。并见阴虚火旺诸症，如午后潮热，手足心热，失眠盗汗，形体消瘦等。咽充血（+++），咽后壁淋巴滤泡丛生呈葡萄串状，粘膜干燥无津，甚则如镜面样。舌红少津，脉细数。治宜养阴清肺，方用生地 15g，玄参 15g，麦冬 15g，赤芍 15g，丹皮 10g，桔梗 10g，薄荷 10g，芦根 20g，川贝母 8g，金银花 15g，连翘 15g，生甘草 15g。

肺肾阴虚：除有阴虚肺燥证候及体征外，可见头晕目眩，耳鸣耳聋，腰膝酸软，舌红，少苔，脉沉细数。治宜金水相滋。方用五味子 10g，麦冬 15g，生地 15g，枣皮 10g，杏仁 10g，山药 15g，丹皮 10g，泽泻 15g，茯苓 15g，玄参 15g，桔梗 10g，生甘草 15g。

陈氏认为，喉源性咳嗽的治疗，要抓住燥邪伤津特点，立足于《内经》“病生于咽喉，治之以甘药”的原则，宣、清、润、收兼施。注意感邪轻重，病位深浅，脏器受损等情况。运用常法时不能忽视变法。选用方药时，应根据证情灵活变通，才能取得满意疗效。^[8]

9. 郭子光诊治经验

郭氏治咳，卓然独见，如洞墙垣，总结出如下几个关键之处，只要在辨证的基础上重视之，往往可收良效。

①治咳先治感：咳嗽一症，由外感所致者十之八九，而纯粹的内伤咳嗽则较少。新病自不待言，久病也多以内伤夹外感的形式出现，“凡有外感先治感”是先生一贯的主张。六淫之邪皆能致咳，而常以风寒、风热、风燥为多。感证重者，以治感为主，感证微者，兼疏其邪，其中，近来称为“喉源性咳嗽”的一类，常缠绵难愈，多表现为咽

痒而咳，咳则痒止，郭氏巧喻之为“肤痒用手挠，咽痒以咳挠”，治之每有妙法。治咳须治痒，有痒多有邪。咽痒而咳，口中和，责之于风者多，常选用蝉蜕、防风、僵蚕、桔梗等疏之。咽痒而干、咳嗽，责之于风燥者多，以上面治风药配合玄参、青果等清润咽喉。咽痒而痛、咳嗽，责之于风热者多，以上面治风药配合射干、板蓝根、虎杖等清利咽喉。咽痒向胸骨下延，提示邪气有向气管蔓延趋势，可再配以金银花、连翘、鱼腥草等。若患者频咳不止，无痰或少痰，影响休息，当以粟壳 10~15g 加入辨证方药。咽痒咳嗽，不宜过早使用苦寒药物，因为苦易化燥，寒致气涩，于病情不利。若咽痒而咳久治不愈，咽不红，苔润口和者，或治以寒药不愈者，多属风寒，又须以干姜、细辛、五味子温散止咳。

②治咳要宣肺：肺之宣发肃降，是维持呼吸功能的一个重要作用，若肺失通宣，往往导致肺气闭郁，轻则可见呼气不利、胸闷、气紧；重则为喘。肺气郁极而伸，常诱发或加重肺气上逆，引发咳嗽，证诸现代医学，如气道阻力增加，则肺内残存气体增多，导致肺膨胀，刺激肺牵张感受器，常可诱发咳嗽。因此，临床上凡有肺气闭郁之象者，应注意宣肺一法的运用。闭郁之浊气不出，大地之清气不入，肺得宣发，则肃降自行。

郭氏认为，宣肺平喘，首推麻黄，凡咳嗽伴胸闷，气紧，或喘，或肺上听到哮鸣音，而又无高血压，皆可随证加入，或选用麻黄剂。若血压偏高者，则不用之，而选用地龙。若肺气闭郁较甚，尚可加细辛、五味子、葶苈子等。

宣肺一法，用于咳嗽伴肺气闭郁的患者可获良效；而咳嗽不伴有肺气闭郁之象的患者，则应注意保护肺气的宣发肃降功能，这样可缩短咳嗽的病程，如不宜过早使用收

敛止咳药物，以免妨碍肺气宣发，导致邪气恋卫入肺，久稽不去，引起久咳。

③治咳要治痰：痰触气管则咳，痰阻气管则喘，同时痰液潴留，郁久化热，又易耗气伤阴，加重咳嗽，故治咳要治痰。临床上，除干咳无痰，频咳不止，影响休息者，应以止咳为主外，凡因痰致咳，痰出咳止者，则须治痰为主。治痰有三要，一是治痰要治因，分别寒痰、热痰、湿痰、燥痰等进行治疗，辨治之法，一般是痰色白、清稀、易咯、无腥臭属寒，常用半夏、干姜、陈皮等治疗；色黄、粘稠、难咯、腥臭属热，常用浙贝母、瓜蒌皮、天竺黄、竹沥；痰稀量多，滑而易出为湿痰，常用半夏、苍术、茯苓等治之；痰少难咯，涩而难出，谓之燥痰。郭氏认为，燥痰又当细辨虚实，实者咳声洪亮，燥热伤肺多，宜天花粉、瓜蒌皮、沙参、麦冬等，虚者肺气虚衰，无力排痰，此时宜适当益气，如肺气肿、肺心病病人，郭氏喜用《伤寒杂病论》所载之顺阴阳五味子汤（人参、麦冬、五味子、麻黄、生姜、大枣、杏仁、陈皮），以扶正治痰。凡痰经久难消，顽固不化，可酌加海浮石、蛤粉等消之。二是治痰要治气，气顺则痰降，常用陈皮、枳壳、桔梗等。例如郭氏治疗胸膜炎病人咳声不扬，痰粘涩难出，认为这是炎性疼痛抑制了肺气的通宣，导致肺气闭郁所致，治疗上则当宣畅胸肺气机为主，常用小柴胡汤加降香、延胡索、枳壳等。三是治痰要治瘀，久咳病人，震动肺络，易致瘀滞，血行不畅，影响津液的输布，也容易生痰。此时兼治其瘀，则顽痰易消，常用桃仁、矮地茶、虎杖等。

④久咳兼治络：郭氏认为，津液的正常流通，有赖于肺之治节功能，咳嗽则肺气不利，易致津停为痰，血滞为瘀，久之痰瘀互结于肺络之中，而往往又成为外邪的伏藏

之所，而致邪与痰瘀纠结。因已入络，非在气管，咳欲祛之，反复不能，易致咳引胸痛或胁痛，甚则频咳、痉咳，咳引胸痛或胁痛可用降气祛痰之品如杏仁、枇杷叶、旋覆花、冬瓜仁、薏苡仁等配合桃仁、茜草等理络止咳。而对于频咳、痉咳则须用虫类通络之法，选全蝎、僵蚕、地龙三味，加入辨证方药，搜剔络脉，常收速捷之效。郭氏指出，使用时须注意两点，一是三药有协同之功，宜同用；二是全蝎性燥，个别病例服后常有咽干口燥之感，此时可停用，或配以石膏、麦冬之类。^[9]

10. 王祖雄诊治经验

陈修园说：“咳不止乎肺而亦不离肺”。故王氏主张治咳首先还是要从治肺入手，根据标本虚实，辨证论治，分别采用宣肺祛邪、肃肺化痰、敛肺止咳三步，可取得满意的效果。

①宣肺祛邪止咳法（第一步）：此法适用于外感初期的咳嗽，或素有咳嗽宿疾复因外感急性发作，表邪尚在者，先以祛表邪为主，邪去则正安。常见为风寒、风热、风燥三个证型，风寒外束，肺气不宣，可选用麻黄汤、三拗汤解表宣肺；若素有痰饮水气宿疾，新感风寒咳嗽发作者，选用小青龙汤较好。外感风热咳嗽，选用桑菊饮加味，必要时与银翘散合用，以辛凉解表宣肺止咳。风燥、温燥用桑杏汤，凉燥选杏苏散。另外，王氏认为，程钟龄《医学心悟》止嗽散一方，为祛邪宣肺轻剂，加减得法，寒温皆可用，止咳效果很好。上述各种类型之外感咳嗽较重者，均可在相应的解表祛邪方中合用止嗽散；若表邪解而未尽，以咳嗽为主者，可单独用之。

如治翁某某，女，61岁，素有咳喘宿疾。西医诊断为

慢性支气管炎，轻度肺气肿。近因外感后加重，咳嗽喘促，恶寒发热，体温 38.7°C ，血常规：WBC $9 \times 10^9/\text{L}$ ，N 0.78。胸片提示：慢性支气管炎并感染。经中西药治疗后体温已正常，血象不高，但咳嗽未能控制，诊见：微恶寒热，口渴喜饮，大便干燥，已3日未解，手心热，舌质黯红，苔薄黄，脉细数。辨证为肺阴虚，外感风热，肺热不宜，拟养阴清热，解表宣肺，方用桑菊饮、止嗽散、生脉散去五味子加贝母，服3剂后表邪解而咳嗽也随之减轻。继用生脉散、止咳散合方加大贝母、枇杷叶、瓜蒌，连进5剂而咳嗽平。

②肃肺化痰止咳法（第二步）：肺主治节一身之气，肺气有升有降，即既有向上向外宣发的一面，又有向下向内肃降的一面，邪气犯肺，使肺气壅遏，不得宣发，也不能肃降。故王氏认为，当宣肺祛邪仍不能止咳时，就应宣肃并用，使宣发和肃降相辅相成，以顺应肺之升降，可提高疗效，增强止咳效果。王氏常用的肃肺之品为枇杷叶、杏仁、瓜蒌、旋覆花等。王氏认为，痰与咳嗽互为因果，咳嗽每多有痰，痰阻遏肺气又可加重咳嗽，故王氏治咳，非常重视化痰除湿，特别对痰饮宿疾，力主温药和之，常用苓桂术甘汤、二陈汤、苏子降气汤等。

如治郭某某，男，58岁。外感咳嗽4月余，痰多，伴恶心，时有呃逆，胸闷，舌苔黄，脉弦滑。王氏详阅病历所记方药，宣肺化痰止咳剂都用过，但效果不佳。根据脉症，王氏辨为痰气交阻，肺胃失于和降，治以肃肺化痰，和胃理气，方用二陈汤、四七汤、平胃散合方，并加瓜蒌、枇杷叶、紫菀、款冬花、前胡、杏仁，3剂后症减，连服9剂咳止。

③敛肺止咳法（第三步）：王氏认为，治疗咳嗽，宣肺

与收敛时或并用，起相反相成的作用。特别是病人久咳不已，反复发作，多伤正气，况久服辛散宣肺之剂，走泄正气，故不收敛肺气，则咳嗽必不能止。仲景制小青龙汤，是治咳逆上气的名方。方中五味子与姜、辛配伍，就是宣散与收敛相结合的止咳法。王氏经验，凡久咳不已，无表邪、郁热、痰火者，均可在主方中酌加敛肺之品，如五味子、诃子、罂粟壳，选用1~2味，可增强止咳效果。

如治吕某，女，25岁。6个多月前因外感后，恶寒发热、咳嗽，在医务室按急性支气管炎用抗生素治疗后，又服中成药，感冒似愈，但咳嗽未止。诊见：咳嗽，痰粘而黄，喉痒即咳，微恶寒，手凉，时有胸闷，舌红，苔黄少，脉弦。辨证属肺之气阴两虚，寒邪痰浊郁肺，治以益气养阴，散寒宣肺化痰，方用生脉散、止嗽散、二陈汤加干姜、细辛、麻绒、煨诃子，连服6剂后，咳嗽明显减轻，后用生脉散、香砂六君子汤、二陈汤合方调理而愈。

止咳三步法即宣肺、肃肺、敛肺，是王氏从前人丰富的医疗经验中总结提炼出来的，并经王氏长期临床实践检验，是行之有效的。王氏认为，宣、肃、敛三步法，特别是敛肺法一般不单独使用，每根据辨证，配合在主方中。三法可以分步使用，也可以合并使用。

敛肺之品每多酸涩，故前人强调有外邪未尽，或属痰火郁热者，不可轻用。据王氏经验，若用于敛肺止咳，除痰多不可用罂粟壳外，其余如五味子、诃子、款冬花等，只要辨证准确，配伍得宜，完全可以使用。^[10]

11. 廖清泉诊治经验

补肺阿胶汤系《小儿药证直诀》方，原用于小儿肺虚气粗喘促。廖氏则根据自己的临床经验，应用本方治疗不

同年龄肺虚燥咳日久不愈的患者，获效甚好。药物组成：阿胶 15g（烔化兑服），马兜铃 10g，杏仁 10g，牛蒡子 10g，甘草 6g，糯米 30g（布包煎）。以上剂量为成人量，小儿据年龄酌减。口干燥明显选加沙参、麦冬、天冬、芦根、百合等，胸闷去糯米加枳壳、瓜蒌壳、郁金，咽痛加桔梗、射干，咳引胸胁疼痛加枳实、佛手、郁金，喘促加苏子、前胡，痰中夹血加白茅根、白及、百合。

如治陶某，男，64岁。50天前因连续劳累复加淋雨后，突然高热寒战，咳嗽咯铁锈色痰，胸闷，呼吸急促入院。诊为肺炎球菌肺炎收住呼吸科，经治疗1月除咳嗽外临床症状基本消失，X片示：右下肺炎变大部分吸收好转。继续治疗20日，咳嗽仍不已，再次复查胸片右下肺部炎变仍未完全吸收，转请中医诊治。患者咳嗽阵作，早晚明显，咽喉干痒，气逆，呛咳无痰，口干思饮，舌红，苔少，脉细稍数。以补肺阿胶汤加沙参、麦冬、贝母连服4剂，咳嗽明显减轻，口干少饮，咽喉痒，胸闷时作，上方加枳壳、郁金，服4剂，咳嗽基本消失，转调气方6剂，复查胸片中右下肺部炎变完全吸收。

补肺阿胶汤中，阿胶补肺养阴兼能养血止血，马兜铃清热化痰止嗽，牛蒡子宣肺利膈滑痰，杏仁下气定喘，糯米、甘草培土生金，全方具有养阴补肺，宁嗽止血之效。廖氏依据该方补肺养阴宁嗽力专的特点，参考“阿胶、糯米为补肺之正药”（《本草纲目》）、牛蒡子“降肺逆与山药并用最善止嗽”（《医学衷中参西录》）及马兜铃“善治喉痒气逆咳嗽”，积数十年临床经验，广泛使用于婴幼儿至老年各个不同年龄时期，系久咳伤肺，肺虚有火，咳嗽无津液而现喉痒气哽的患者，常获良效。对钱乙所言之“气粗喘促”，廖氏认为，其病机虽有因肺虚有火，津液受灼致肺逆

于上引起者，但更多者则为郁热壅肺、痰浊内阻、肺肾气虚等所引起。而本方虽有降气平喘之功，然无如补肺养阴宁嗽之力专，故其主要作用是治咳而非治喘。廖氏指出，临床使用本方应抓住久咳，咳无痰或咳痰甚少，咽喉干痒气哽，无明显表证或痰浊四点，其中咽（喉）痒干咳为其关键。急性呼吸道感染的多种疾病在处于稳定缓解吸收阶段而具喉痒干咳不已者为本方的最佳适用期。观察表明，有明显表证或痰浊者，不宜用本方。^{〔1〕}

12. 张浩然诊治经验

张氏行医数十载，医理精深，临床经验丰富，对咳嗽一证独具卓识，疗效十分显著。张老治咳，要点是分清病因，外因咳嗽重在识别风、寒、燥、热、湿诸邪致咳的证候要点，以驱邪、清宣肺气为主，兼顾对全身体质因素和兼杂证候的调整。内因咳嗽则先别阴阳，重在调节肺、脾、肾、膀胱、大肠诸脏腑的平衡，治标又治本。

①外因咳嗽：伤风咳嗽：此类患者素无咳嗽，多因气候转变，感受风邪或本外感风寒而肺经原有伏热复感风邪形成此型。症见自汗，恶寒，甚至恶寒发热，鼻塞流涕，头昏头痛，咽痛，咳嗽不已，脉多见浮数，浮滑，初起一般舌质无明显变化，热较重者，初起可见舌质较正常为红，苔薄黄。治宜解表清肺，方用薄防杏苏饮（薄荷、防风、杏仁、苏梗、枳壳、桔梗、前胡、牛蒡子、瓜蒌、射干、竹茹、甘草）。若表邪重加葛根，发热加芦根、黄芩，若痰中夹血或鼻衄者去苏梗、枳壳，加栀子、淡豆豉。

伤寒咳嗽：症见恶寒，头痛或发热无汗，咳嗽痰清而多，或咳嗽兼喘，苔薄白或苔白稍厚而润，脉浮弦滑或脉紧。治宜辛温解表，宣肺散寒。方用麻茸杏苏饮（麻茸、

荆芥、苏梗、杏仁、枳壳、桔梗、陈皮、法半夏、厚朴、生姜、甘草)；若寒邪较重者，用麻辛杏苏饮(麻黄、细辛、桂枝、白芍、苏梗、杏仁、枳壳、桔梗、陈皮、法半夏、厚朴、生姜、甘草)；若寒伏火者，上方加瓜蒌、炒黄芩、桑白皮；若表里皆寒，心下有停水，咳即呕吐者，用小青龙汤加苏梗、杏仁、枳壳、桔梗、厚朴；若表证已不明显，仍咳不止，咳嗽有痰，胸闷不舒，缠绵不愈者用麻根杏苏饮(麻根、苏梗、杏仁、枳壳、桔梗、半夏、陈皮、厚朴、白芍、瓜蒌、茯苓、生姜、甘草)。

风痰咳嗽：症见咳嗽反复发作，时轻时重，痰多色白，喉间痰鸣，或伴呼吸喘促，或伴发热，唇淡或唇紫，舌苔白腻，脉浮滑或浮弦滑。治宜祛风化痰。用辛附杏苏饮(小白附子、细辛、姜南星、苏梗、杏仁、枳壳、桔梗、陈皮、法半夏、麻茸、桂枝、白芍、厚朴、生姜、甘草)。

肺热兼外感咳嗽：症见发热，胸痛，咳嗽，痰稠或兼喘，口渴，或见便秘，舌红，苔黄而干，脉滑大而数，治宜清肺宁咳，兼以解表。方用麻杏石甘汤加苏子、桔梗、枳壳、桑白皮、黄芩、瓜蒌、竹茹、芦根。

燥气咳嗽：初秋燥而热，或秋冬久晴无雨，感受温燥，患者多有阴虚肺燥的内因。症见咳嗽少痰，或痰不易咳出，或胸痛，或痰中见血，咽干口燥，舌苔少而干，脉多细。治宜清燥润肺，阴虚体质兼滋阴补肾，其咳自止。用二母杏苏饮(知母、贝母、苏子、杏仁、桔梗、枳壳、麦冬、沙参、桑白皮、芝麻、枇杷叶、瓜蒌、甘草)。若痰中见血加栀子、淡豆豉、薄荷。深秋燥而凉，多感受凉燥。症见头微痛，畏寒，咳嗽，无汗鼻塞，舌苔薄白者，用苦温平燥法(《时病论》方)：荆芥、苏梗、杏仁、前胡、陈皮、桔梗、桂枝、白芍，加麻茸、法半夏、枳壳、甘草。

伤湿咳嗽：此类患者素无咳嗽史，由于感受湿邪而起，多因淫雨不晴，或久居湿地，或冒雨受湿所致。症见咳嗽有痰，身重头痛如裹，胸痞腹胀，倦怠不食，或出汗，舌苔白厚，脉多浮缓。治宜解表化湿，方用香苏饮（藿香、苏梗、杏仁、枳壳、桔梗、陈皮、法半夏、厚朴、苍术、防风、冬瓜仁、竹茹、神曲、荷梗）。其无汗，恶寒，身痛，咳而微喘者及舌淡、苔白厚腻者，是寒湿在表，用羌活杏苏饮（羌活、苍术、杏仁、苏梗、枳壳、桔梗、陈皮、法半夏、麻黄、厚朴、桂枝、甘草）。

②内因咳嗽：肺阴虚咳嗽：症见干咳，多汗，痰少或无痰，下午低热，咽干口燥，或有喉痛，唇舌均偏红，脉细数或细滑数。治宜宣肺养阴润肺，用沙参杏苏饮（沙参、麻根、知母、贝母、杏仁、桑叶、桔梗、苏梗、紫菀、芝麻、枇杷叶、小枣、甘草）。

肺气阴两虚咳嗽：多见于久病及老人，多年久咳，心累气少，脉象虚数，舌红少苔，多为肺气虚而兼见肺肾阴虚及心气虚证。治宜补肺气，养肺肾之阴兼补心气，用加味生脉饮：条参、麦冬、五味子、黄芪、桔梗、苏梗、杏仁、莲肉、芝麻、紫菀、陈皮、茯苓、法半夏、甘草。

肝火犯肺咳嗽：由肝郁气滞，木郁生火，或肝热素重而来。症见咳则两胁下痛，引及少腹，目赤，眼睛干涩，眵多，口苦口干，舌红，苔黄，脉弦数。治宜泻肝清肺为主，用柴芩枳桔汤：柴胡、炒黄芩、枳壳、桔梗、杏仁、苏梗、前胡、青皮、白芍、薄荷、桑白皮、甘草。

伤食咳嗽：多见于儿童。小儿肠胃稚嫩，脾气不足，食停中焦，脾气受伤，则运化失职，土失健运，则不能化生精微运化水湿而致水不化气而化为痰，痰邪壅滞，随食积之火流入三焦，饮邪上千，归于肺经，肺失清肃而致咳

嗽。症见咳嗽痰多为主，且以夜半五更咳甚，不思饮食，暖腐吞酸，口出臭气，夜卧不安，手足心热，大便稀溏或完谷不化，唇舌红，苔白腻，脉多沉滑。治宜消谷滞，祛痰除湿。方用楂曲二陈汤加杏仁、苏梗、枳壳、桔梗、竹茹、枇杷叶。

脾湿犯肺咳嗽：由于脾虚生痰或脾湿生痰，痰湿犯肺而咳。其特征为因痰而咳，多喉间有痰，痰为透明状或带灰黑。形如藕粉之成团块者，一般无其他急剧证候，脉象多弦滑，舌苔黄白厚或白腻，痰湿甚者可见灰黑腻苔。其治宜分虚实。脾湿生痰：多由长年久饮茶酒而致水津化为痰湿，此证偏实，宜燥湿祛痰，用菖朴二陈汤加味（菖蒲、厚朴、苏梗、杏仁、枳壳、桔梗、陈皮、法半夏、茯苓、冬瓜仁、远志、甘草）。若痰湿化热加竹茹、瓜蒌、炒黄芩、马兜铃。脾虚生痰：脾阳素弱，水湿不化，食少胸闷，大便稀溏，脉滑，苔白厚腻，治宜健脾祛痰。香砂六君汤加杏仁、苏梗、枳壳、桔梗、炒谷芽、炒麦芽，药平淡而效殊著。脾湿生痰复感寒邪：症见恶寒，咳嗽，咳痰量多，痰白而清稀，身酸困，食欲不振，口不渴，治宜祛寒燥湿。方用麻辛附二陈汤：麻黄、细辛、附子、陈皮、茯苓、法半夏、苏子、杏仁、枳壳、桔梗、厚朴、葶苈子、生姜、甘草。

气郁咳嗽：本患咳嗽或哮喘之人，久久难愈，但平时症状尚不明显，每遇情志不遂即发为喘咳。症见两胁胀闷，咳嗽不爽，且兼木郁乘土，以致腹胀，恶心欲呕，舌淡或微红、苔白或厚，脉弦。方用四逆散加味（柴胡、枳壳、白芍、苏梗、杏仁、桔梗、陈皮、法半夏、厚朴、枇杷叶、神曲、甘草）。

膀胱咳：指咳即遗尿，小便失禁。此并非老年体弱气

虚之人，每见于中年之女性（年老体弱之咳则遗尿属肾虚证，不属此类）。此咳多属寒热兼夹，每咳即流尿，有膀胱不约之症，苔白或黄，脉多见弦滑，治用麻根杏苏饮（麻根、苏梗、杏仁、陈皮、法半夏、桔梗、紫菀、白果、益智仁、五味子、炒黄芩、桑白皮、甘草）。

肾阳虚咳喘：肾主纳气，肾亏则不能纳气，使肺气上逆，肾阳不足即阴寒盛。症见畏寒，咳喘，气短，气少，四肢不温，舌淡苔白滑，脉大无力或沉细少力。治宜温补肾阳，纳肾气。方用加味桂附八味汤：附子、熟地、枣皮、山药、茯苓、泽泻、丹皮，加西洋参补元气，罂粟壳、五味子以纳肾气，陈皮、法半夏、款冬花、杏仁化痰平喘治咳。另有一种肺肾阳气均虚，以致水气不行，浮肿，咳喘或不渴，尿少者，宜温阳补气行水，方用麻附五皮饮：麻黄、附子、桑白皮、大腹皮、白术、桂枝、茯苓皮、猪苓、泽泻、陈皮、法半夏、五味子、生姜皮、甘草。

张氏治咳，对外因咳嗽，把握住风、寒、燥、热、湿诸邪致咳的证候特点，及抓住邪气之间转化的规律进行施治。以杏苏散为基础方，根据各证型特点加减变通，灵活应用。杏苏散是《温病条辨》方，针对燥咳及肺失宣降的病机而设。主要功用：轻宣凉燥，宣肺化痰。方中杏仁苦温而润，宣降肺气，广泛用于各种咳嗽气喘证。有表证者配伍解表药，有热者，配伍清热药，有寒者配祛寒药。苏叶辛温，微发其汗，开宣肺气，苏梗发表力较苏叶薄，善于行气开胸，桔梗、枳壳一升一降助杏仁宣肺止咳；二陈理气化痰，不偏寒热；前胡宣散表邪，降气化痰，寒性不大，风寒风热咳嗽均可选用；姜枣调和营卫协调诸药。全方药性平正，基本上不偏寒热，便于临床加减化裁，故适用于各型咳嗽，而风寒咳嗽最为合适。常嫌其疏风散寒力

弱而选加麻黄、荆芥、细辛、桂枝等以疏风宣肺散寒。风热咳嗽，苏叶易苏梗去姜枣，随症选加桑叶、牛蒡子、薄荷、淡豆豉、栀子、枇杷叶等以疏风清热宣肺。燥热咳嗽苏叶易苏梗，去生姜、茯苓、法半夏，加知母、贝母、桑叶、沙参、芝麻、百部等以清肺润燥化痰。肺热咳嗽，方中苏叶易苏梗，去姜枣，选加瓜蒌、牛蒡子、黄芩、桑白皮、马兜铃等以清热泻肺化痰。肝火犯肺选加柴胡、炒黄芩、薄荷、白芍、桑白皮、青黛等清热泻肝。痰湿咳嗽，原方随症加厚朴、南星、石菖蒲、小白附子等加强除湿化痰。

对内伤咳嗽的治疗，一般多从调护正气着眼，恐宣散伤正，而张氏注重患者的体质，掌握其阴阳偏盛偏衰，分清虚实主次，更分标本缓急轻重进行治疗。如伤食咳，气郁咳，膀胱咳，肝火犯肺咳，脾湿犯肺咳，治以祛邪为主，其他在调理肺、脾、肾等脏腑的功能时，扶正补虚兼祛邪止咳，故张氏在治内伤咳嗽的方中多加杏苏散方的主药如苏梗、杏仁、枳壳、桔梗、前胡、陈皮、法半夏宣肺透邪，化痰止咳，治标又治本。^[12]

13. 赵金铎诊治经验

①表邪未解者宣之：表邪未解，肺失宣降的咳嗽，一般来说，常见的有两种情况，一是风寒束表，肺失宣发，表现为咳嗽声重，鼻流清涕，身恶风寒，周身酸懒，无汗，舌淡，苔白，脉浮有力，治宜辛温宣肺，成方可用三拗汤，主要常用药物有麻黄、苏叶、荆芥穗等。二是风热束表，肺失宣和，表现为咳嗽声重，鼻塞咽干，干咳或有少量粘痰，身有微热，无汗或有微汗，脉浮数，舌质边红，苔薄白，治宜辛凉宣肺，成方可用桑菊饮变通，常用药物有竹

叶、桑叶、薄荷、淡豆豉等。

如治一妇人，患咳嗽月余，曾服牛黄上清、牛黄解毒等丸药数十粒，咳嗽不减，日益加重。症见咳嗽声重音哑，胸闷不舒，饮食无味，全身酸楚，苔白满布，脉见浮紧。此乃表证未除，过早过多服用寒凉药物，以致药过病所，冰伏其邪，致肺气失宣，邪不能外达，遂用宣肺解表法，以加味杏苏散 3 剂，服后微汗出，随之咳嗽减，周身和，饮食增，数日而痊。

②邪热熏肺者清之：素有内热、熏蒸于肺，或表邪入里化热的咳嗽，临床主要表现为咳嗽，咯痰色黄而粘稠，或痰带腥味，且不易咯出。常伴有口干舌燥、欲饮冷饮等症状。治宜清凉之剂，可用泻白散变通，常用药物有枇杷叶、黄芩、知母、竹茹等。清凉药物不宜过量，中病即可。因肺为娇脏，苦寒太过则易化燥伤津。但当病重之时，药量太轻，犹如杯水车薪，无济于事。这就要权衡病情轻重，合理选用药物，使之恰到好处，无太过不及之弊。

如治刘某，男，45 岁，1982 年 10 月 18 日初诊。自诉 1976 年以来感胸闷，咳吐黄粘痰，季节变换、气候转化时尤为明显，近 1 年来未见减轻。四肢常见大片红色荨麻疹，大便干，小便黄。外院支气管镜检查报告为：右肺炎症，支气管内膜淋巴结核。现自觉乏力明显，颜面蜡黄，舌质红，苔黄腻，脉右弦细而滑，左尺弱。辨为痰热交阻，兼有肺阴虚，治以清热化痰，佐以养肺阴。处方：知母 9g，瓜蒌仁 9g，杏仁 9g，冬瓜仁 12g，赤芍 9g，丹皮 9g，白茅根 20g，芦根 20g，桑叶 9g，南沙参 12g，北沙参 12g，天冬 9g，桃仁 9g，甘草 6g。服药 20 剂，病情大减，后守方出入，调治半年而安。

③燥邪伤肺者润之：燥邪伤肺的咳嗽，临床主要表现

为干咳无痰，或少量黄粘痰；痰中常带血丝，口干欲饮，手心干燥而觉热，舌苔少而无津，脉细数。多因内热久羁化燥伤其肺阴，或因在高温条件下工作，汗多饮少，耗伤肺阴，酿成燥咳。治宜润肺清燥，可用清燥救肺汤或桑杏汤变通，常用药物有天冬、麦冬、沙参、贝母、梨皮等，以上是指温燥而言。还有凉燥咳嗽证，要从病因、季节上辨识，不多赘言。治燥咳不要只着眼其无痰或痰量多少，要从四诊全面分析，才能作出正确的诊断。

如治一老年妇女，患咳嗽数日，吐大量白色粘痰，唇干舌红，舌上无津，脉细数无力，赵氏诊为温燥咳嗽，拟桑杏汤加味，服3剂而愈。

④肺气欲闭者降之：肺气郁闭的咳嗽，主要临床表现为咳嗽胸满，气促痰多，两胁胀痛，善太息。多因气郁上逆，肺失肃降所致。成方可用苏子降气汤，常用药物有苏子、杏仁、瓜蒌皮、莱菔子、沉香、枳壳等。必须注意，运用降气药物不可太过，否则易伤正气。

如治刘某，男，54岁，1983年9月19日初诊。反复咳嗽咯白痰10余年，每于气候转凉时发作。近半年来咳嗽不断，咯白色泡沫痰，咽痒，喉中痰鸣，口干欲饮，尿黄便干，舌暗红，脉弦滑小数。胸透示：慢性支气管炎、轻度肺气肿。治拟理肺降气，佐以清化。处方：瓜蒌15g，杏仁9g（炒打），桑白皮（炙）9g，牛蒡子9g（炒打），黄芩9g，知母9g，赤芍12g，丹皮12g，苏叶6g，葛根9g，枳壳9g，生甘草6g。1983年12月5日再诊：药后诸症好转，唯仍感天凉时晨起咳嗽有痰，口渴，口苦，纳食、睡眠、二便均调，舌质暗，苔薄黄，脉沉细而弦，仍守上方去甘草加百部9g续服，病情渐平。

⑤营卫不调、少阳气郁者和之：营卫不调者主要表现

为咳嗽上气、汗出恶风，胸闷气短，舌质正、苔薄白，脉浮缓。多因风邪伤卫所致，成方可用桂枝加厚朴杏子汤。少阳气郁者主要表现为咳嗽胸闷、两胁胀痛、寒热往来，口苦咽干，舌边红，苔薄白，脉弦小数。多因少阳枢机失灵，气逆犯肺所致。可用小柴胡汤加杏仁、桔梗、枳壳等。

如治一男性老人，素有喘疾，近患感冒，咳喘并作，汗出恶风，胸闷，难以平卧，脉见浮缓，舌质正，苔薄白。拟桂枝加厚朴杏子汤加葛根 9g，服 3 剂诸症缓解。

⑥肺、脾、肾虚者补之：肺虚咳嗽有肺气虚与肺阴虚之别。若肺气虚者，多因素体阳虚损伤肺气所致，主要临床表现为咳嗽声低、气短乏力、自汗、畏寒怕冷，可用保元汤变通。若肺阴虚者，多因素有内热，喜嗜辛燥食物，耗伤肺阴，或房事无度，耗阴伤精所致，主要表现为干咳少痰，骨蒸盗汗，五心烦热，可用沙参麦冬汤、百合固金汤或秦艽扶羸汤，随证投之。

脾虚咳嗽多由脾气虚弱，或因饮食不节，痰浊内生，或因久泻伤脾，致使土不能生金，肺失肃降所致。主要表现为咳嗽气短，腹胀纳差，痰多清稀，可用六君子汤变通。

肾虚咳嗽多因肾阳不足，肾不纳气，水湿上泛所致。主要表现为咳时遗尿，痰多清稀，呼吸困难，不能平卧，腰膝酸软，亦常兼肾阴不足证，可随证选用肾气丸、纳气汤、金水六君煎。

如治赵某，男，48 岁。因工作劳累，又无条件注意营养，于 1964 年春患咳嗽，咯少量痰，午后低热，乏力，纳差，食后腹胀，大便稀，右肋时痛，经某医院检查确诊为肺结核，用抗痨药物链霉素、雷米封等治疗，全身症状未见好转。症见舌体胖，质淡嫩，苔薄白、脉浮无力，此乃虚嗽也。因劳累过度营养不足，脾土失健，生金无力，肝

失制约，横犯脾土所致，宜培土生金抑木法，用六君子汤合痛泻要方加味投之。处方：党参 15g，白术 12g，茯苓 15g，甘草 9g，陈皮 9g，清半夏 9g，白芍 12g，防风 3g，百部 12g，阿胶 9g。连服月余，诸症均减，后用本方改配丸药调理近 1 年。1966 年春复查，病灶趋于钙化，病情稳定，今已痊愈。

⑦久虚欲脱者涩之：久虚欲脱之咳嗽，多因久嗽伤肺，肺气失敛所致，主要临床表现为咳嗽时大汗出，气不接续，遗尿便稀，面色苍白，精疲乏力，成方可用独参汤、参附汤、诃子散加五味子等。

如治袁某，男，48 岁，农民。近患咳嗽，汗出乏力，早泄失精，县医院检查排除结核病，中医治疗效亦不显。脉浮无力，舌质淡，苔薄白。此为劳累过度，肺气受损，卫外失职，长期汗出耗阴伤液，阴损及阳所致。处方：炙黄芪 15g，桂枝 9g，白芍 9g，炙甘草 9g，煅龙骨 20g，煅牡蛎 20g，麻黄根 6g，浮小麦 30g，百部 12g，桑螵蛸 15g，益智仁 6g（打），大枣 8 枚（劈）。连服 20 余剂，咳嗽及诸症均减，逐渐康复。

诊治咳嗽的关键是要有准确的辨证，辨证准确，论治才能恰当。在辨证时，既要注意到主证，又要注意到兼夹证，既要注意到肺脏疾患，又要注意到其他脏腑的病变。在论治时，既要善于运用常法，又要注意运用变法；既要抓住一法的恰当运用，又要善于根据证情的复杂性而配合运用两法或三法。选用方剂时，既要有主方，又要善于变通，灵活运用。这样才能取得较好的疗效。^[13]

14. 李岩诊治经验

李氏对外感咳嗽采用四步分期疗法。李氏认为，“邪之

所凑，其气必虚”。肺卫之气不足，则多遭风邪的侵袭，从而使肺卫失调，出现恶寒、发热、咳嗽、喘逆等症状。而这一病理过程的变化，多随时间的变化由表及里，有一定规律可循，因而治疗上亦不相同。

①一期用宣法：方用《温病条辨》桑菊饮：桑叶 10g，菊花 10g，连翘 12g，薄荷 3g，杏仁 10g，桔梗 10g，生甘草 6g，芦根 10g。这期见于表证初起，风邪外袭肺卫，出现恶寒、发热、咳嗽、舌苔薄、脉浮。因此，治以清宣肺胃，桑菊饮加減。

②二期用降法：方用《和剂局方》苏子降气汤：苏子 10g，半夏 10g，炙甘草 6g，肉桂 3g，陈皮 10g，厚朴 6g，当归 10g，生姜 3 片。此期多为外邪不解入里，郁而化热，使肺失清肃，出现口干、咳逆上气、痰多色黄、大便干、小便赤、舌红、舌苔黄、脉滑数等。治疗宜采用清肺止咳，降逆化痰之法。素体肺肾气虚之人多为上实下虚，以苏子降气汤加減。若年轻体盛之实证则可用《伤寒论》麻杏石甘汤加減：麻黄 6g，杏仁 10g，生石膏 30g，生甘草 6g。

③三期用润法：方用《重楼玉钥》养阴清肺汤：生地 15g，麦冬 10g，玄参 10g，丹皮 10g，赤芍 10g，贝母 10g，甘草 6g，薄荷 3g。本期多为正气虚而不能驱邪外出，邪热内攻，日久消灼肺阴。患者因肺阴不足出现口干咽痛、咳嗽气喘、痰少而粘稠、难以咯出，或痰中带血、舌质红、少苔、脉细数等。治宜养阴清肺，润肺化痰。养阴清肺汤加減。

④四期用收法：方用《证治准绳·女科》五味子汤：党参 10g，麦冬 10g，五味子 10g，杏仁 10g，橘皮 6g，生姜 3 片，大枣 3 枚。此期多为咳嗽后期，邪气虽祛，而正气亦伤，肺之气阴亏虚，动则汗出，甚或喘息，干咳不止，

舌淡红，脉沉细数等。治宜扶正收涩，兼祛余邪。五味子汤加减。

临床上常见到某些外感咳嗽患者以时间先后呈现出上述四期的发展变化。但由于病人体质强弱与感邪性质和轻重的不同，病情变化亦不一，四期之分只是相对而言，不能截然分开。但掌握这一基本的病机变化规律，将对提高辨证治疗外感咳嗽的疗效有很大益处。^[14]

15. 印会河诊治经验

印氏治疗咳喘病，首先抓住“痰”这个主证。痰是脏腑病理产物，但又影响脏腑功能。就狭义的呼吸道分泌之痰来讲，多责之于肺，因脾气散精，上输于肺，如邪气伤肺，肺失肃降，水道通调障碍，精气必渍肺成饮，聚而成痰，贮于肺中，阻塞气道。痰的色泽、稠浊的变化，反映了肺的寒热虚实。慢性咳喘病人，大多吐白痰、黄痰、黄白相间痰，也有的吐皂沫样泡沫，印氏称之为“吐白沫”。主证不同，治疗亦异。

①白痰：咳喘病不论新久，吐白痰最为常见。新感者多是风寒袭肺，咳嗽不止，气急而喘。久有咳喘者，多因外感而触发宿痰。其共同点皆为白痰，但同中有异。有咯痰色白、稀薄、量多而爽者，印氏惯用散寒除饮的小青龙加石膏汤化裁。咳甚加杏仁、炒苏子；喘甚者加地龙、蝉蜕、僵蚕；胸膈满闷者加三子养亲汤降气化痰。必用石膏者，因有热可清热除烦，无热可制麻黄、姜、桂、细辛之温燥。如舌苔淡滑，下元虚惫者，可改用苏子降气汤合三子养亲汤加味。若痰粘、量少、难咯、喉中痰鸣者，则多用麻杏石甘汤加葶苈子、桑白皮，临床辄效。

如治刘某，女，25岁。患者自幼有气管炎病史，感冒

即发。1981年8月因重感冒咳嗽不止，又增气喘，张口抬肩，日夜不得安眠，并伴有胸闷、心悸。西医诊为喘息性气管炎，经多种治疗，时轻时重，反复无常。1982年11月9日诊时症如上述，唯痰色发白，质地稀薄，量多而爽，舌苔白而水润，脉滑而数，拟小青龙加石膏汤治之：麻黄9g，桂枝10g，细辛6g，半夏10g，五味子10g，干姜6g，白芍12g，生石膏30g（先下），甘草10g。11月16日二诊：服药7剂，咳喘轻，痰量减少。原方加炒苏子10g，炒白芥子6g，以温化痰湿。12月1日三诊：咳喘渐平，仅晨起有10多分钟轻微的气逆发喘。肺为娇脏，易因过敏而反复，于原方加蝉蜕、僵蚕化痰开腠，以去络中之风，更用地龙通经活络，搜剔风邪，意欲消除其“过敏内源”。上方加减，共服药42剂，诸症悉退，食欲倍增，睡眠安稳，身体康复，随访未复发。

②黄痰：咳喘吐黄痰，屡见不鲜，甚则痰黄而稠，腥臭难闻，为邪热郁肺，灼伤肺津。轻者用泻白散加味，重者用千金苇茎汤加板蓝根30g，鱼腥草30g，效果很好。

如治魏某，男，21岁，1983年2月7日初诊。咳喘吐黄痰，稠而腥，有时带血已近2月，每天下午发热，体温38℃左右，体倦、纳呆，日渐消瘦，经西医检查，诊为支气管扩张，要求服中药治疗。观舌苔中间黄厚，舌尖赤红，六脉细数，大便尚好。印氏以清肺凉血行瘀为法，处以千金苇茎汤加味：生薏苡仁30g，桃仁10g，冬瓜仁15g，白茅根30g，鱼腥草30g，丝瓜络10g，丹参15g，北沙参30g，紫菀12g，款冬花10g，生石膏30g（先下），枇杷叶10g。上方加减共服药41剂，诸症消失，饮食大增，已恢复工作。

③黄白相间痰：咳喘病，十有八九吐黄白相间痰。印

氏认为，外为风寒所诱，内有痰热互结，肺气壅滞不宣，使用定喘汤宣肺定喘很是得心应手。

如治苏某，女，37岁。1982年10月11日初诊。患咳嗽病9年，西医诊断为支气管哮喘，平时咳喘肩息，痰浊上涌，气喘嘘嘘，胸闷痰鸣，昼夜不安，晨起痰多，痰色时黄时白或黄白相间。平时怕热，热则咳喘加剧。脉弦数有力，舌尖红，舌苔黄腻。治以宣肺定喘，拟定喘汤加味：白果10g（打），麻黄6g，款冬花10g，半夏6g，桑白皮15g，炒苏子10g，杏仁10g，黄芩12g，生薏苡仁30g，冬瓜子30g（打），鱼腥草30g，紫菀10g，7剂。10月18日二诊：咳喘稍好，痰粘不易咯出，咽仍干燥。原方加竹茹12g，生石膏30g（先下）。11月29日三诊：上方服用10天，咳喘日趋平和，仅早晨有10多分钟的咳喘，痰呈米黄色，有时是白粘痰。原方加白芥子6g，橘红10g，制南星6g。12月28日四诊：咳喘已稳定，仅早晨吐1~2口痰，量极少，饮食增加，睡眠正常，气色好。患者连续服药70余剂，诸症悉愈。半年后，曾感冒发热1次，亦未诱发咳嗽。

④白沫：发病缓慢，气逆咳喘，咳引胁下作疼，吐大量皂沫样白沫，无块痰、粘痰。喉干咽燥。印氏认为，白沫不能与泡沫痰混为一谈，泡沫痰，总是有痰的。白沫是小白沫子。此属肺燥阴伤，治以清燥润肺，使肺金得以滋润，肺气之郁得以肃降，诸症自能随之而愈。印氏坚认白沫不同于痰饮，须从燥论治，确有其独到之处。

如治周某，女，53岁。1982年9月6日初诊。患者咳嗽气喘已6年余，吐大量白沫，从不吐痰，每天晨起要咳吐半碗沫子，咳后气喘嘘嘘，胁下引痛。其余时间也咳吐白沫，较早晨少些。平时口干咽燥，气喘行走困难。西医诊断为肺气肿。舌红，苔薄黄，脉细数。近年余加重。印

氏诊为阴津不足之肺燥，拟清燥救肺汤加减治之：桑白皮 10g，桑叶 10g，杏仁 10g，沙参 15g，麦冬 12g，石斛 15g，生石膏 30g（先下），阿胶 10g（胶珠亦可），黑芝麻 10g，黛蛤散 15g（包），枇杷叶 10g，芦根 30g，钟乳石 6g（先下）。上方服用 14 剂，咳喘明显减轻，白沫减少，白沫中出现粘痰扯丝，为津液初复之兆，有效续服。10 月 8 日二诊：咳喘继续好转，行走气可接续，白沫减少一半，粘痰较前增多，仍咽干口燥。原方加天花粉 30g，服半月，咳喘大减，仅早晨咳喘一阵。原方加蝉蜕 10g，地龙 10g，又服半月，白沫已无，惟有少量粘痰。原方加僵蚕 10g，全蝎 6g。先后治疗 2 个多月，早起咳喘已无，情况趋于正常，可以料理家务。^[15]

16. 赵锡武诊治经验

赵氏治疗咳喘，首先辨虚实外感内伤。治疗原则：急性喘证多由外邪侵犯，重点在祛邪。慢性者多由正虚体衰，邪留恋不去所致，重点在扶正。平素不发作时，应固表扶正以防外感。病发作时祛邪以治标，喘止咳停则应补正以治本。正虚邪盛时则应标本兼治，扶正以祛邪。无论何种情况，赵氏始终重视治痰。

①外感咳喘：大致分风寒风热两大类。风寒喘咳为麻黄汤证，以发热、恶寒、无汗而喘、脉浮紧、头痛、体痛、骨节疼痛等症为主，其主要症状为无汗。而麻黄汤之作用即在于发汗，如汗得出则身觉温暖，恶寒消除，余证皆随之而解。但是，若感冒而不恶寒，体不痛或脉沉弱者，则不可用麻黄汤类方剂，若麻黄汤证兼见项背强急者可加葛根。风热或风湿咳喘，可用麻杏石甘汤或越婢加半夏汤。治疗多用辛凉方剂，但桑菊饮类不如麻杏石甘汤类疗效显

著。麻黄不仅能发汗，且能开达肺气；再重用生石膏，更能急清肺热以定喘。麻黄乃治喘之要药，临床见到重症喘者，用麻黄能止喘，但见汗，使邪从尿利下。凡属新感暴喘或久病急性发作，表现为高热、咽痛、口渴、脉数以及咳喘均以麻杏石甘汤合增液汤加金银花、连翘、板蓝根、黄连等药急清其热，可以缩短病程。

另外，小儿顿咳，乃热邪袭肺犯血。日久不愈可转为肺炎或脑病等危候。表现痉咳顿作，面赤胸闷，气憋欲死，喘息吸气时可出笛声，痰稠不利，眼睑浮肿，日轻夜重。对此不可轻视，当急治之，宜清热宣肺凉血，用麻杏石甘汤加白茅根、生地、白芍、丹皮、百部、生侧柏叶、胆南星。急重者可加局方至宝丹。

②内伤咳嗽：多为老年病，久病，职业病，以虚证居多，其中也兼有实证，但为数较少。久病必虚，但本病并非纯虚。治疗重点在于补虚，或扶正祛邪，但与肾不纳气纯虚之喘本质不同。

轻度痉挛性咳嗽：痰粘稠不易咯出，并气逆上冲，或咳声嘶哑者，麦门冬汤加厚朴杏仁半夏汤治疗。

湿性痰饮性咳嗽：有浮肿、贫血、手足易冷、小便自利，无发热恶寒头痛肢酸之表证，故不用小青龙汤，而用二陈汤加味。

胃咳：心下痞塞，肋下坚硬，大便秘结，频发咳嗽，各药无效者，此即“腹满而喘病在胃”之证，可用大柴胡汤下之。

酒湿咳嗽：酒客嗜酒日久，多于秋末冬初咳嗽，兼见胸背胁腹挛紧而恶寒。可用桂姜草黄辛附汤治疗，年老者尤多用之。

脾虚咳嗽：平素胃肠虚弱，咳久不愈者用六君子汤补

之。虚弱小儿，脾胃不健，易感冒而咳嗽不止者，以小建中汤加味治疗。

肾燥脾湿咳嗽：上咳下利，胃纳不振，用黑地黄丸治疗。

火郁干咳：火郁干咳而无痰者，先以逍遥散治疗，继以清燥救肺汤补阴清肺。

支气管扩张之咳嗽：以千金苇茎汤、小陷胸汤、甘桔汤、葶苈大枣泻肺汤化裁治疗。

肺源性心脏病之咳嗽：以真武汤合麻杏石甘汤加唐氏参苏饮治疗，浮肿甚者加消水圣愈汤，兼见肝大腹水者以真武汤、越婢汤加活血、利尿药物。

心咳：即咳喘多年，胸闷气短，咳逆倚息，呈桶状胸，指端粗大，咳兼心痛，中医旧名心咳，因其多见心虚证象，宜用清代王旭高心咳汤治疗。

此外，赵氏还注意随证加减：痰黄者，不论新感或旧病发作，均可用麻杏石甘汤合增液汤加金银花、连翘等清热解毒药。树胶液状稀痰，听诊为湿性啰音者，可用小青龙汤，若烦躁者加生石膏。稠痰，喉中水鸡声，听诊为干性啰音者可用射干麻黄汤治疗。泡沫痰而脉数心悸者，宜麻杏石甘汤合瓜蒌薤白半夏汤及生脉散治疗。稀稠混合痰而听诊为混合啰音者，可用厚朴麻黄汤治疗。脓痰，晨起量多，胸痛并有周期性吐血者，用千金苇茎汤治疗。肺结核的三层痰，以生脉散、麦门冬汤、竹叶石膏汤等方化裁治疗。痰胶粘难出，量多，咳逆倚息，时时唾浊，坐不得卧者，可用皂荚丸治之。^[16]

17. 邵健民诊治经验

邵氏精研中医咽喉部疾病，临床治疗多应手而愈。尤

其是用桑射汤加减治疗咽喉源性咳嗽，治法、用药具有与众不同之特色，临床应用多年，屡治屡效。

①病因病机：邵氏认为，咽喉源性咳嗽是急慢性咽炎、喉炎及声门下区变态反应等疾病过程的一种症状，是诸多咳嗽证中的一种特殊症状。首先是部位之特殊：发生于咽喉及声门下，临床常见咽喉作痒即咳嗽。检查咽喉部充血，扁桃体有时肿大；其次是病因之特殊：常与变态反应等因素有关，遇风或油烟刺激、饮食不节及饮酒则加重。

②治疗方法：以自拟桑射汤加减。基本方：金银花 15g，炙桑叶 9g，木蝴蝶 9g，射干 9g，蝉蜕 9g，赤芍 9g，桔梗 6g，杏仁 9g，甘草 9g。辨证加减：外感引发者遇风即咳，无痰，属风寒束表者加荆芥、防风，属风热束表者加菊花、薄荷；咳则气逆憋喘、泪涕俱出者属肺气郁闭，加炙麻黄、白果、苏子；咳则呕吐，脘闷，苔腻者属胃中积热，加黄连、竹茹、半夏、陈皮；咳则面红，夜难入寐，小便淋漓者属相火偏亢，加知母、黄柏、牛膝；咳则面红口干，心烦，属肝火上逆，加旋覆花、代赭石、降香；咽干痰粘难咯出者属阴虚，加沙参、麦冬。

如治杨某，男，57岁，教师，1995年11月30日就诊。患者素有慢性咽炎，每因感冒即引发咳嗽，往往是咳嗽达3个月之久，应用抗生素治疗无效。本次发作亦是感冒引起，咳嗽已有2个月余。症见咽喉作痒即咳，往往连声作咳、憋闷，咳时面红耳赤，甚则呕恶发呛，小便失禁，夜间加重，咳后如常人一般。开始口服螺旋霉素、炎得平片等不见好转，又静脉滴注青霉素、丁胺卡那霉素等药亦不见好转，辗转治疗2个月。体检：咽部、悬雍垂均充血，扁桃体不肿大，双肺呼吸音清，未闻及干性或湿性啰音，胸透血常规均属正常范围。证属热邪留恋，上壅咽喉，肺

失宣降。治宜清热解毒，宣肺利咽，并引热下行。处方以桑射汤加黄柏 9g，知母 12g，牛膝 9g。服用 3 剂后呛咳次数减少，无呕恶及尿失禁。原方去黄柏、牛膝，加五味子 9g，麦冬 12g，以滋阴敛肺。又予 3 剂，诸症悉除。

咽喉是肺之门户，咽喉部的病变直接影响肺的清肃宣降，所以咽喉源性咳嗽是诸多咳嗽证中的特殊病症。它有两种情况：一是原有急慢性咽喉炎，遇油烟、粉尘等刺激后引起咽喉作痒即咳；另一种情况是由感冒引起，感冒症状消失，但遇风或劳累后仍有阵发性、痉挛性咳嗽。桑射汤是桑菊饮去菊花、薄荷加射干、蝉蜕、木蝴蝶而成。桑菊饮用于风湿之邪入侵手太阴肺经所致的发热、恶风、头痛等表证为主，治疗上偏于疏散风热。本方则加强解痉利咽的药物，意在外透内清，祛风解痉，开宣敛肺，故治疗咽喉源性咳嗽恰到好处。^[17]

18. 邵长荣诊治经验

邵氏擅长治疗肺系疾病，尤精于治疗慢性顽固性咳嗽。邵氏认为，咳嗽一症，虽然病因各异，兼证不一，但揆其要，无不由于气机违和，气血流通受其阻滞，通而不畅，甚或不通，津液的输布代谢受到干扰，痰饮停滞，咳嗽由是而起。为治之道，贵在求通。通则气机调和，百脉流畅。调通气机之法，以疏通肝气为先，临证归纳有 6 法。

①疏肝祛风法：肺乃清虚之府，为脏腑之华盖。呼之则虚，吸之则满，只受得本然之正气，受不得外来之客气，客气干之则咳矣。多种外邪，常随风邪袭之于肺，素有七情内伤，肝气郁结之体，复感风邪，清虚之体受扰，肺气壅遏不宜，宣肃失司在所必然。临床可见咳嗽时缓时剧，经久不愈，每逢忧思、烦恼、受风、感寒、天气变化时咳

嗽加剧，伴咽痒、脉弦。邵氏用荆防败毒散加减治之，使风邪疏散，肝气条达，气机调和，肺气即能宣畅。

如治汪某某，女，41岁，1993年11月2日初诊。患者咳嗽反复多年，时轻时重，西医诊断为慢性咽喉炎，经多方治疗，鲜有疗效。近因疲乏后受凉，咳嗽加剧，干咳少痰，伴有胸闷心烦，口干咽痒，苔薄白，脉细弦，治宜疏肝祛风止咳。处方：荆芥，防风，羌活，独活，桔梗，柴胡，前胡，赤芍，白芍，川芎，枳壳，黄芩，射干，山豆根，蚤休，半边莲，细辛。服药7剂，多年咳嗽停止，随访半年，咳嗽未作。

②疏肝化痰法：肝与肺为人体气机升降之通道，肺居上，主一身之气的宣降；肝居下，主疏泄，其经之别支由下而上贯膈注肺，挟生发之气，循经而舒启肺气，使之宣降而行治节之权。若性情沉郁，肝气失于条达，肝气郁结则阻碍肺气宣肃而发之为咳，久则津液不布，聚而成痰。前贤对肝郁挟痰的病机早有论述，“善治痰者，不治痰而治气……”。邵氏认为，气机郁滞，津液失布是产生痰饮停滞致咳的基础。患者表现既有咳嗽证候，又有胸胁胀闷，情志不舒，喜叹息，脉弦的肝气不利之象。邵氏常用疏肝利气的方法调利气机，使郁滞的气机通顺，气顺则一身津液随之而顺，痰浊亦随之而降，实为治咳之本。临床上气滞痰凝多为互兼，以气滞为主者咳嗽症状多为间歇，每因情志不畅而发或加重，治疗用四逆汤或半夏厚朴汤加减为治。以痰凝为主者，证见痰粘咽喉感，咯之不爽，时轻时重，常加用温胆汤为治。痰郁化热者，参照平肝清肺法治疗。

如治陈某某，女，50岁，1994年3月5日初诊。患者平时多愁善感，半年来咳嗽断续，痰多粘稠，咽喉不舒，西医诊断支气管炎，久治不愈，伴胸胁满闷不舒，苔薄腻，

脉弦细滑。辨证肝郁气滞，痰气互结，治宜疏肝解郁，理气化痰。处方：柴胡，前胡，赤芍，白芍，枳壳，枳实，川芎，郁金，丹皮，白术，陈皮，姜半夏，炙苏子，生甘草。7剂后咳嗽减轻，惟觉胸胁不舒，舌苔薄白腻，脉弦滑。上方加川楝子，再服7剂。药后咳嗽痊愈，胸闷亦舒，精神转佳。

③平肝清肺法：肝气郁结，久郁化火，日久不散，上逆犯肺，火灼肺金，即“木火刑金”，烁津为痰，肺失肃降，引起咳嗽。症见气逆咳嗽，面红，咳引胸胁作痛，痰黄而粘，头晕目眩，咽喉干燥，舌红，苔薄黄少津，脉弦数，邵氏常用小柴胡汤合野菊花、鱼腥草、败酱草等药治疗，并重用黄芩，使肝火平熄，肝气调畅，肺经通利，肺得安宁。

如治朱某，男，48岁，1994年10月18日初诊。患者平素性急，头晕频作，3天前因劳累后咳嗽剧作，伴发热，痰黄难咯，咳甚则两肋下满闷疼痛，不可转侧，外院诊断肺部感染，渗出性胸膜炎。并伴有口苦口干，大便秘结，舌红，苔黄，脉弦数。证系肝病为本，肺咳为标，肝火犯肺而为咳。治宜平肝清肺，化痰止咳。处方：柴胡，半夏，黄芩，赤芍，白芍，瓜蒌皮，丹皮，野菊花，姜半夏，鱼腥草，败酱草，延胡索，川楝子，徐长卿。7剂后咳嗽减半，连服14剂后病情逐渐康复。

④疏肝通腑法：气郁痰壅常伴有腑气不通之症状，邵氏治疗此类病证除了疏肝解郁调气外，还要加入通泻药物。“肺与大肠相表里”，以承气汤为代表的通下药能通腑气，开导阴邪，荡涤肠胃，通利水谷，起开门逐盗的作用，腑气一通，全身的气机也随之而畅，痰浊亦随气而下。现代医学研究证实，大黄具有较强的抗菌作用，可促进肠蠕动，

从而加速血液淋巴循环，有利于炎症吸收。在用药剂量上则根据患者的体质及耐受量调整，既不伤正气，又可达到治疗目的。

如治蔡某某，女，31岁。主诉咳嗽反复不愈2年余。痰粘色黄，咯之不爽，伴咽喉不舒，口干喜饮，大便秘结，每5~7天1次。西医诊断为慢性咽炎、支气管炎，反复用抗生素治疗无效。查体：咽后壁淋巴滤泡增生，两肺呼吸音粗糙，舌苔薄黄腻，脉弦滑。辨证为气郁痰凝，肺气壅塞，治拟疏肝通腑导痰法。处方：柴胡，前胡，赤芍，白芍，平地木，细辛，蚤休，半边莲，全瓜蒌，大黄，枳壳，枳实，江剪刀草，野菊花。服药7剂，大便通下量多，并见痰状粘液，咳嗽明显好转。二诊时上方去枳壳、枳实、大黄，加入蒲公英，再服7剂，咳嗽痊愈未发。

⑤通利化饮法：咳嗽痰多，甚则气促，有时兼有肢体浮肿，类似有支饮的见证。邵氏常用通利化饮的方法治之。在宣通肺气、通调气机的同时加入陈葫芦、猪苓、茯苓、车前草、泽泻等利水化湿药，参入苍术、白术健脾益气化湿，祛痰湿而不伤正气，再参入防己、桂枝祛风通阳，加强利水消肿的作用。咳嗽一症随水饮的通利而日见平息，对于久病脾肾阳虚的患者，则采用熟附子、肉桂温阳利水的方法治之。

如治范某某，女，48岁，1995年1月24日初诊。主诉咳嗽咯痰5年余，为白色泡沫状痰，量多。近2年来动则气促。西医诊断为慢性支气管炎，肺气肿。用一般抗菌消炎化痰治疗未效。今年冬季发作频繁、怕冷、易出汗，伴鼻塞流涕，下肢浮肿，舌苔白腻，脉浮滑，两肺可闻干性啰音。辨证痰饮内恋，风寒外束，治当温肺化饮，通利水湿。处方：黄荆子，麻黄根，赤芍，白芍，桂枝，细辛，姜竹茹，川

芎，干姜，陈葫芦，车前草，苍术，白术，泽泻，防己，7剂。二诊时下肢浮肿已退，咳嗽咯痰亦减，舌根白腻，脉细滑。用上方加减治疗1月后，咳嗽咯痰尽和。

⑥通脉祛痰法：心主血脉，肺主气，两脏同居上焦。《素问·经脉别论》曰：“肺朝百脉”，这就决定了心与肺在生理上和病理上的密切关系。若心脉瘀阻，宗气运行不利，肺络阻滞不通，津液代谢受阻而凝聚为痰，痰阻气机，以致宣降失职，而见咳嗽气喘等症。治为通脉祛痰，行气化痰，方选瓜蒌薤白半夏汤为治。

如治李某某，女，65岁，1994年6月2日初诊。主诉胸闷心悸咳嗽反复10余年，咳嗽加重气短1月。西医诊断冠心病，慢性支气管炎。近日症见心慌气短，胸闷，早搏频繁，咳嗽喘息，咯痰不已，舌淡紫、苔白腻，脉结。胸阳不振，心脉瘀阻，痰浊内滞，肺失宣肃。治拟温通祛痰，行气化痰。处方：桂枝，炙甘草，瓜蒌皮，薤白头，姜半夏，丹皮，丹参，炒蒲黄，桃仁，青皮，陈皮，淮小麦，大枣，郁金，佛耳草，7剂。二诊时心悸早搏稍平，胸闷亦减，咳嗽咯痰见瘥。上方加江剪刀草、车前草，继服14剂后病除。^[18]

邵氏在临床辨证用药时历来崇尚“遵古而不拘泥于古”，运用经方或古方常常举一反三，灵活变通。从他擅用金铃子散加味治疗干咳中可见一斑。

金铃子散出于《太平圣惠方》，方由川楝子、延胡索二药组成。方中川楝子泄气分之热，延胡索行血分之滞，二药共奏清热疏肝、行气止痛功效。李时珍曾高度评价该方：“用之中的，妙不可言，方虽小制，配合存神，却有取效之功，勿以淡而忽之。”但是综观该方的临床应用，似乎多用于治疗胃脘胁肋疼痛、疝气痛、妇女经行腹痛等。惟独邵

氏触类旁通，开辟蹊径，用于治疗干咳。邵氏选用该方的适应证，大致为：干咳或呛咳少痰，或痰粘喉梗，咽痒干痛，且多伴有胸胁胀闷、口干舌燥、头胀头痛、胃胀纳滞、便干等症状。追问病史往往有过于思虑或情志不畅的病前因素。邵氏认为，咳嗽一症，辨证首要，见咳止咳，难以中紫。此类咳嗽大多由于气郁津凝所致。“思则气结”，“郁则气滞”，思虑过度 and 情志不畅日久必然导致肝失条达，气机疏泄不利，肝郁之气循经上逆于咽喉，故而咽喉作梗，干痒疼痛；又气机不利，肺气难以肃降，则气逆咳呛；气郁于胸则胸胁胀闷；气不载津则口干舌燥；气逆于上则头胀头痛；肝气横逆则胃胀纳滞，经曰：“木郁达之。”所以疏肝理气，使肝气条达，气机疏泄通畅，是治疗本病的关键。金铃子散既能行郁结之气，又能泄郁结之热。邵氏选中此方，可谓是合情（病情）、合理（病理、药理），体现出邵氏对古方的熟谙和选方用药的严谨。其次，在临床上邵氏尤其重视结合病情，区分轻重缓急，在处方用药中体现主次。金铃子散的选用也同样如此，若咽痛干咳是主症或在早期，则以金铃子散为主方；若非主症或经治疗后已由重转轻、由急转缓，则金铃子散可为配方。

如治方某，女，43岁。1998年4月4日初诊。咳嗽1月余，加重1周。自诉经常反复咽痒干咳，且每遇工作紧张、思虑过度或烦躁不悦时发作频繁。本次发病也由于疲劳后起病，服用过多种抗生素和止咳中成药欠效。1周前咳嗽加剧，主要是干咳，有气冲咽喉感觉，咽干声嘶，头痛头胀，胸闷纳呆，舌偏红，苔薄少津，脉细弦，辨证属肝郁气逆，肺失肃降，治疗拟疏肝宣肺止咳，佐以祛风活血和胃。方用：川楝子12g，炒延胡9g，西青果9g，广郁金9g，柴胡9g，赤芍18g，白芍18g，平地木30g，功劳叶

12g, 葛根 9g, 川芎 9g, 白芷 9g, 焦神曲 9g, 谷芽 9g, 麦芽 9g, 荆芥 9g, 防风 9g, 石菖蒲 9g。1 周后咳嗽明显好转, 再以原方加味进 2 周巩固疗效。门诊随访半年, 效果持续。该患者从事营销职业, 由于工作紧张和思虑过度经常咳嗽, 根据临床症状和体征考虑为慢性咽炎合并慢性支气管炎。邵氏辨证属肝郁气逆型咳嗽, 治拟金铃子散为主方疏肝理气, 行滞消郁; 西青果清肝利咽, 以消咽喉之郁热; 柴胡、前胡一升一降, 使气机通畅; 赤芍、白芍一走血一走气, 调和营卫气血; 平地木、功劳叶平肝清肺, 化痰止咳; 葛根、川芎、白芷、荆芥、防风祛风活血, 解肌止痛; 焦神曲、谷芽、麦芽、石菖蒲和胃醒脾。诸药合用, 使肝气得平, 肺气得降, 营卫调和, 气机通畅。

再如治黄某, 男, 72 岁, 1997 年 2 月 17 日初诊。有慢性咽炎 40 余年, 平时容易感冒, 且经常出现咽喉干痛、喉中作梗的症状。来诊时诉晨起白痰少许, 咽干喉梗不适, 时有呛咳, 畏寒, 易出汗, 耳鸣腰酸, 胃纳一般, 大便正常。舌偏暗红, 苔薄, 脉弦细, 辨证属肺肾两虚, 肝郁气逆。治拟补肺温肾, 疏肝利咽。方用: 黄芪 15g, 防风 9g, 白术 15g, 川楝子 12g, 延胡索 9g, 平地木 30g, 女贞子 12g, 黄精 12g, 猪苓 12g, 茯苓 12g, 补骨脂 12g, 巴戟天 9g, 山茱萸 9g, 蝉蜕 4.5g, 炙蜂房 9g。服药 14 剂后, 咽喉梗塞明显好转, 再易邵氏自拟的“三桑汤”(桑叶 9g, 桑椹子 12g, 桑寄生 12g) 为主方, 并结合原方治疗 2 周后, 咽喉不适症状消失。之后, 病人仍坚持服用中药近 1 年, 自觉几十年的顽疾已基本消除, 感冒次数明显减少, 畏寒、耳鸣腰酸等症状较往年大有好转。

该患者以前从事轮船冷气机的维修工作, 咽喉部经常受阴寒之气侵袭而感到不适, 久而久之导致了慢性咽喉炎。由

于患者缺乏重视咽喉部的保护和积极治疗，形成顽疾，难以根除。古稀之年，五脏功能本已趋衰，所以难以抵抗风寒之袭，便经常感冒，或引发痼疾。邵氏以为该患者的辨证治疗，当着重于肺、肝、肾三脏。其理一：咽喉居于肺之上端，是肺之门户；肝经循喉后而入咽颚；肾经则“循咽喉，挟舌本”，说明三脏和咽喉在生理上有着密切的关系。其理二：肺主卫而统一身之表，肺之亏虚则难行其职，故“易感冒，易出汗”；寒气伤阳，患者有长年接触阴寒之气的既往史，又为古稀之年，肾阳日亏，故见“胃寒，耳鸣腰酸”；阴寒之气郁于喉则“咽喉干痛、喉中作梗”。患者来诊时尚无明显的急性期症状，因而采用标本兼顾，虚实同治的方法：先用玉屏风散、黄精、猪苓、茯苓补肺固表；金铃子散疏理肝郁之气；杜仲、补骨脂、巴戟天、山茱萸、女贞子调补肝肾，填补命门；平地木、蝉蜕、蜂房平肝利咽。再用“三桑汤”调治肺、肝、肾三脏，使得三脏协调发挥作用。

干咳一症，见之简单，但治之非然，见咳止咳，对症下药，未必有效，邵氏用疏肝理气法，实为良策，值得临床借鉴。^{〔19〕}

19. 段光周诊治经验

段氏认为治咳必求于本，临证务当审明病因、病位、病性而因人制宜，随证立法，故于寻常止咳法外屡获奇中。

①求因：段氏谓咳嗽一症，首当辨明外感内伤。《景岳全书·咳嗽》篇说：“咳嗽之要，止惟二证。何为二证？一曰外感，一曰内伤而尽之矣。”外感必有受病之因与可凭之症。盖六气皆令人咳而有伤寒、温病之异；温病又有温热、湿热、燥热不同。段氏据前贤“温邪上受，首先犯肺”及“凡病温者，始于上焦，在手少阴”等论述，认为外感咳嗽

以温邪为主。因温为阳邪，犯人上部，肺通天气，邪气每从鼻而入，犯手太阴。外感之症，以七日为期。过期而不愈者，若非误治（外感误作内伤则每致久咳不愈；内伤误用发表，轻则咳增，重则为逆），即为素体有偏，如气滞湿阻、停痰留瘀、正虚不能托邪等。若咳吐腥臭黄痰者，需虑热腐成脓；久咳带血或干咳空鸣，症状离奇难辨，治疗虚不受补，实不任攻者，尤虑肿瘤为患。慎寻不愈之因，用药自非泛泛。

如治刘某某，女，70岁。外感咳嗽1周不愈。现鼻流清涕，咳声不扬，背心灼热，舌红，右半苔白厚腻。段氏谓鼻流清涕，咳声不扬乃表邪未解；苔右半偏厚，乃邪热已入少阴界地且挟湿热为患。湿热阻遏气机，枢机不利，自然不能达邪出表。投甘露消毒丹加减：金银花20g，连翘20g，柴胡15g，黄芩15g，藿香15g，射干15g，浙贝母15g，车前子15g，白豆蔻10g，杏仁10g，郁金12g，法半夏12g，蒲公英30g，甘草6g。3剂而愈。

②定位：段氏谓：“凡病必明其所，用药始能中的。”故治疗外感咳嗽，段氏每据鼻、咽喉及气管、支气管、肺的不同断明表里传变。若温热咳嗽，再参卫气营血；湿热咳嗽，复于三焦推求。治疗内伤久咳，段氏每分别三层气化，审定五脏，用药直捣病巢而屡拔顽疾。

辨表里传变：段氏曾谓外感咳嗽，尤当慎防传变。不论新久，凡鼻塞流涕者皆属表邪不解，表不解者咳不自止，小儿鼻涕返流至咽喉，尤易引起刺激性咳嗽，宜用苍耳子散通窍解表。不尔邪气下传，渐致咽喉不适，咳因咽痒，痰由咽出。段氏据《甲乙经》“胆者，中精之府，五脏取决于胆，咽为之使”以及《灵枢·刺节真邪》篇“气往来行，则为痒”等论述，认为咽喉属于半表半里，咽痒多气火为患，治

宜疏解少阳，常用小柴胡汤、四逆散、丹栀逍遥散等方化裁。如表邪未罢加防风、蝉蜕，咽喉梗塞加射干、桔梗，心烦失眠加栀子、淡豆豉，咽干加玄参、梨皮，痰稠难咳加瓜蒌壳、郁金，大便秘结加芒硝、胖大海，奇痒不除加全蝎、僵蚕。若咳痰由咽以下出者，乃病邪入里，断非上法可效，治宜清肺凉血解毒，方如麻杏石甘汤、千金苇茎汤辈。

辨卫气营血：凡卫分不解者，断不可直清气分，更不能妄用收敛。现市面苦寒直折、收涩止咳之成药甚多，咳嗽初起服之每令人久咳不愈，以致有咳嗽数月仍需解表者。此证必待卫分已解，方可纯清气分。若舌绛，少苔，夜间咳甚，心烦失眠、小便短赤者，邪热已入营分，方用清营汤加木通、鲜竹沥。

如治王某某，女，42岁，1998年12月4日就诊。夜间咳甚。心烦失眠，舌红，少苔，脉细数。热入营分，投清营汤加减：金银花30g，连翘30g，丹参30g，芦根30g，水牛角粉（包煎）30g，生地20g，麦冬20g，玄参20g，竹叶12g，黄连10g，甘草10g，鲜竹沥2瓶（分次冲服）。2剂咳减眠安，原方继进4剂而愈。肺主气，咳嗽虽多气分为患，但久咳亦可由气入血。若瘀热壅结为患，每令人久咳不愈，轻者可用仙方活命饮和血败毒，豁痰解郁，重者配吞西黄丸。当归一味，性虽辛温，但具灵动之性，擅于活血通络，甚为常用。

辨三焦：凡纳呆、脘痞腹胀者，邪气由上而中，湿胜者应运脾除湿，方如黄芩滑石汤；中虚邪留者宜托邪外达，不论新久，微助正气则客邪自解，乃四两拨动千斤之法，方如参苏饮或补中益气汤。病后腰胀、尿赤、苔厚者，湿热有下注之势，不可误断肾虚，法宜淡渗，方如越婢汤、五皮饮。若饮食二便、腰膝俱可者，病在上焦，宣上则可，

勿动中下。

定脏腑：《素问·咳论》云：“五脏六腑皆令人咳，非独肺也。”故久咳必明病在何脏。咳嗽据五脏气化不同及邪气深浅之异分为三层：（1）肝肺系：此层邪最轻浅。以金木风燥之性，每见呛咳引动两肋下痛，痰少或痰稠难出，咽痛咽痒，脉弦。证属木火刑金，方宜化肝煎合黛蛤散。蛤粉一味，化燥痰甚速。（2）脾胃系：邪入中土，阻遏气机，运化失司而寒湿内生，方宜参苓白术散。凡太阴虚寒，常法久治不愈者，炮姜一味，温手足两太阴甚效。（3）心肾系：若病邪深入少阴水火之脏，则有寒化、热化之别；而肺为娇脏，不耐寒热，故多久咳不愈。《素问·咳论》曰：“心咳之状，咳则心痛，喉中介介如梗状，甚则咽肿喉痹。”故咽痒梗塞，无外风脉证且伴心悸气短脉涩者，乃属心咳，方用炙甘草汤。远志一味，擅化心经之痰，尤为常用。肾咳者，咳则腰背相引而痛，宜用真武汤、阳和汤、麻辛附子汤及金水六君煎辈，切忌纯辛走表，妄动肾根。

曾治一老年咳喘，本属肾虚痰泛，医者不识，误投小青龙汤发表攻饮。当夜即大汗淋漓，胸闷喘急，大有气高不返之势。急邀段氏会诊，投金水六君煎1剂则喘减，前后共进10余剂痰出喘平，顺利出院。

又如治刘某某，女，53岁，1998年12月20日初诊。咳嗽10月不愈，夜间咳甚，咳吐白色痰涎粘稠难出，舌红，少苔，脉涩。段氏断为心咳，投炙甘草汤加减：炙甘草15g，党参10g，生地10g，麦冬10g，枣仁10g，桂枝10g，五味子10g，炮姜10g，阿胶15g（兑入）。2剂咳止大半。上方去党参加沙参18g，远志，当归，继进4剂而愈。

③明性：段氏云：“咳嗽之性，不外寒热虚实。”寒热之辨，虽多温邪为患，然寒邪亦可见，或外受风寒，或寒

包火郁，或素体阳虚，或湿盛热轻。虚实之异，以温邪为患，轻则伤阴而有肺、胃、肾不同；重则壮火食气，又多气阴两虚。内伤久咳，若非脏虚，即为邪阻。

如治廖某某，女，64岁，1988年12月20日就诊。晨起咳嗽10余日。咳引胸痛腰胀而其声不扬，吐泡沫咸痰。咽痒咽红，畏风，身痛肢冷，脸略浮，夜尿多，舌红，苔白腻。段氏认为此症系患者自服感冒清、咳特灵等药苦寒复加收敛，以致表闭不解而身痛、畏风、脸浮，里邪闭郁而呛咳阵作。咳声不扬，复兼下元暗耗则肢冷痰咸、夜尿频多。证属表寒里热、上实下虚，投桂枝芍药知母汤加減：麻黄15g，杏仁15g，防风15g，白术15g，附子15g，大枣15g，知母15g，炙甘草15g，白芍18g，石膏30g，桂枝12g，生姜12g。4剂而愈。

④因人制宜：段氏曾谓治咳当因人制宜，用药宜随性别、年龄、体质不同而有所分别。女子以肝为先天，肝气易郁，相火易动，故多气火为患，非比外感火热之证可苦寒直折，辛凉透解乃是正治，药如：丹皮、栀子、苏梗、淡豆豉、瓜蒌壳等。老人脾胃多虚，每因气血不畅、清阳不升而正虚邪留，宜用清暑益气汤辈升阳泻火，调畅气机。小儿不知饥饱，饮食易滞，肺与大肠相为表里，腑气不通则咳不自止，轻者以保和丸，重者与凉膈散。青壮年神气过敏者，咽痒咽梗，受风则咳，受凉亦咳，置烟雾粉尘之处则咳甚，伴心烦失眠，宜敛气缓急安神，方如过敏煎，或合甘麦大枣汤、百合地黄汤、酸枣仁汤辈，甚者加栗壳。老年人神气呆顿者，病重而咳轻，最是忧虑。

如治张某某，男，69岁，1988年12月27日就诊。咳嗽1月不愈。夜间咳甚，伴口干，纳呆，舌红，苔白腻。段氏谓宗气者，出于中焦，积于胸中，贯心脉而行呼吸。中虚不

运则纳呆苔腻，宗气不足则久咳不愈，心阴耗伤则夜咳口干。投东垣清暑益气汤气阴并补，升阳除湿。药用：党参20g，茯苓18g，麦冬18g，五味子10g，甘草10g，丹参30g，黄芪30g，当归12g，白术12g，知母12g，丹皮12g，青皮12g，柴胡12g，神曲12g，防风12g，泽泻15g。7剂而咳止。

段氏谓咳嗽必求于本。咳嗽本质上为机体邪正相争的一种保护性反应，故不可见咳止咳，留邪为患；痰为咳嗽之病理产物，亦不可本末倒置，不治痰之因而一味见痰化痰，否则咳不能止，反致变生它端。止嗽散为临床化痰止咳的代表方药，然必待病因已除而痰多不减者方可与之。同时，咳嗽的辨证，可为众多呼吸系统疾病如肺癆、肺胀、肺肿等提供重要思路。抓住咳嗽这一主症，则上述诸病之外感内伤、寒热虚实自明，药中病机而收效自速。^[20]

20. 李仁述诊治经验

咳嗽虽有多种，然无不关乎肺病。《素问·咳论》曰：“肺之令人咳，何也？岐伯对曰：五脏六腑皆令人咳，非独肺也”。人体是一个统一的整体，五脏之间、脏腑之间都是相互关联的，生理固然，病理亦然。咳嗽虽然是肺系的病变，但其他脏腑在疾病过程中，都有可能影响到肺而致咳嗽，肺之咳嗽也同样可以影响其他脏腑而产生不同的病变。此外，人体正气虚馁，免疫功能低下，也可以发生喉源性咳嗽、过敏性咳嗽，或其他方面的咳嗽，这些咳嗽无不与肺之清肃有密切关系，不仅理论上有所根据，而且临床上也可以得到印证。

①外邪咳嗽：《河间六书·咳嗽论》云：“寒、暑、燥、湿、风、火六气，皆令人咳嗽”，其中尤以风、寒、燥、热引起的为多。因人体禀赋有差异、外邪的性质有区别，故

表现亦各有不同。风寒咳嗽宜疏散风寒，宣通肺气，可用辛温解表止咳法，药如麻黄、桂枝、杏仁、甘草、芍药、生姜、大枣、紫苏、前胡、桔梗、枳壳、清半夏、陈皮、茯苓等，如果客寒包火，可酌加生石膏。风热咳嗽宜疏风清热，宣肺化痰，可用辛凉解表止咳法，药如桑叶、菊花、连翘、薄荷、桔梗、生甘草、杏仁、芦根、竹叶、荆芥、金银花、豆豉、川贝母、黄芩、知母、牛蒡子、桑白皮等。燥热咳嗽宜清肺润燥，药如桑叶、杏仁、沙参、梨皮、栀子、豆豉、川贝母、瓜蒌皮、天花粉、苇茎等，如风寒外束，可加荆芥、防风、苏叶、前胡、牛蒡子等。又有疫疠咳嗽，由流感病毒引起，可在上述辨证用药基础上，重用重楼、贯众、败酱草、鱼腥草、白英等。我国北方的流感患者，咳嗽有长达3个月之久而不愈的，其症状为咳嗽，多痰，发热，咽痛，鼻塞，乏力，严重时夜间咳剧，不能平卧入睡，互相传染，缠绵难愈。

如治某人，症如上述，药用玳瑁10g，金银花20g，麦冬20g，金果榄20g，胖大海15g，木蝴蝶15g，白英15g，青果15g，桔梗15g，重楼15g，贯众15g，败酱草15g，川贝母15g，罗汉果1个，服8剂痊愈。

②脏腑咳嗽：心咳之状，咳则心痛，喉中介介如梗状，甚则咽肿喉痹。盖因风温袭肺，引动心包之火上逆，故治法仍宜宣散肺经风热，参入宁心清火之品。王旭高用前胡、杏仁、象贝母、桔梗、射干、麦冬、远志、沙参、小麦，可供参考。肝咳之状，咳嗽胁痛。盖因肺金无权，不足以制肝，肝气犯肺，咳嗽不已，治法当以平肝、疏肝为主，张聿青用川楝子、青皮、陈皮、砂仁、桑叶、制香附、广木香、郁金、山楂炭、茯苓、沉香。肾咳之状，咳嗽面肿，痛引腰背。

如治某某，西医诊断为肾炎，中医诊断为肾咳，药用：

续断 15g, 桑寄生 15g, 狗脊 15g, 青箱子 15g, 射干 15g, 山豆根 15g, 金果榄 15g, 金银花 15g, 杜仲 20g, 枸杞子 20g, 海浮石 30g, 川贝母 10g, 木蝴蝶 10g, 清半夏 10g, 服 12 剂痊愈。

胃咳之状, 咳逆欲呕。有当用甘药者, 叶天士用生扁豆、北沙参、麦冬(米拌炒)、茯苓、南枣、糯稻根须; 有当用苦辛者, 叶天士用小半夏汤加姜汁。叶天士认为脉沉, 短气, 咳甚, 呕吐饮食, 便溏泄, 乃寒湿郁痹阳明胃, 营卫不和, 胸痹如闷, 无非阳不旋运, 夜阴用事, 浊泛呕吐矣。庸医治痰顺气, 治肺论咳, 不思《内经》胃咳之状咳逆而呕耶? 大肠咳之状, 脉弦右甚, 咳嗽, 午后潮热, 畏风便溏。叶天士用生白术、茯苓、赤石脂、禹余粮、姜汁、大枣。前贤法式俱在, 临证活法在人。

③喉源性咳嗽: 一般从喉头作痒开始, 咳嗽多痰, 后期则转为干咳无痰。其原发病多为扁桃体炎、慢性咽炎(多有滤泡)、喉炎及声带炎症等, 或由外感误治, 多进甜食, 转为内伤, 化火犯肺。《内经》谓“诸痛痒疮, 皆属于火”, 火性上炎, 引起咽喉干涩, 阵发性奇痒, 一经咳嗽, 无法休止, 与《丹溪心法》、《医学纲目》、《医学入门》所记载的干咳及郁咳相类似。至于本病的治疗, 临床上多以养阴生津、佐以清相火为主, 药如生地、熟地、天冬、麦冬、川贝母、丹皮、白芍、薄荷、桔梗、甘草、知母、黄柏、玄参、百合、马勃、射干、马兜铃等, 均可随证选用。笔者经验方则用胖大海 20g, 木蝴蝶 20g, 草决明 20g, 麦冬 20g, 金银花 20g, 金果榄 20g, 青果 20g, 天竺黄 20g, 百合 20g, 乌扇 15g, 山豆根 15g, 挂金灯 15g, 川贝母 15g, 罗汉果 1 个。如系声带炎症引起的咳嗽, 多为干咳, 并伴声音嘶哑, 可按上法辨证论治; 少数声带息肉患者,

则以手术摘除为宜。

④过敏性咳嗽：本病多见于小儿，古医书上无明确记载，一般可有家族过敏史，如过敏性鼻炎、湿疹、荨麻疹、药物过敏、蛋白质过敏等。这是一种介于外感与内伤之间虚实夹杂型咳嗽，多为风、火、虚所致。治宜祛风脱敏、清热泻肺为主，常用药物如蝉蜕、白僵蚕、银柴胡、五味子、乌梅、防风可以祛风脱敏，知母、桑白皮、天花粉、杏仁、川贝母、枇杷叶可以化痰止咳，苏子、葶苈子可以泻肺降气，党参可以补气扶元。

如治梁某，男，17岁。中学生。咳嗽2个月未愈，晨起、临睡、活动后加剧，咳嗽时间长短不一，痰少，咽红不适，鼻塞而痒，嚏涕频繁，平时五心烦热，夜间盗汗，便干，舌红，苔薄。听诊肺呼吸音粗，胸透肺纹理增粗，有过敏史。治宜清热泻肺，祛风化痰，并加抗过敏药，选用乌梅、山茱萸、五味子、甘草、白参、银柴胡、防风、黄芪、荆芥、白芷等，调治月余，诸症悉除。

⑤其他咳嗽：除上述几种咳嗽外，还有其他方面疾病引起的咳嗽，如肝著（包括干性胸膜炎）引起的咳嗽，起病较急，恶寒发热，干咳无痰，胸胁疼痛随咳嗽、呼吸加重，可按少阳病的结胸、胁痛及悬饮病论治，也可按五脏咳论治。又如内分泌病，单纯性甲状腺肿大，久病者邻近器官因受压迫而产生呼吸困难，阵咳，吞咽困难，声音嘶哑，可按甲状腺病治疗；肺癌可以引起干咳，可按肺癌处理；急慢性鼻炎声泪俱下兼咳嗽者，可按鼻渊处理；白喉、百日咳引起的咳嗽，则宜按传染病处理。由于妇女在生理上与男子不同，有经带胎产之事，因此一旦发生咳嗽，处理方法亦有其固有规律。一般来说，经前咳嗽宜疏肝理肺，若咳嗽痰少带血，治以理肝调中止血；时值经期，若经量过多，

可加用止血药；经净之后，用补理冲任之品。若妊娠咳嗽，早期清肺和胃为主，中期理肺安中为主，晚期则以肃肺安胎为主。全过程宜时时刻刻顾及胎元，切勿掉以轻心。

《医学三字经》谓“《内经》云：五脏六腑皆令人咳，不独肺也。然肺为气之囊，诸气上逆于肺则呛而咳。是咳嗽不止于肺，而亦不离乎肺也”。“不止于肺”与“不离乎肺”两语可谓深得经旨，探骊得珠。治咳嗽要始终考虑肺金清肃，即使是过敏性咳嗽、喉源性咳嗽、肝著咳嗽、疫疔咳嗽，也离不开肺之清肃问题。至于用药规律，《医宗必读》中说得好：“大抵治表者药不宜静，静则留连不解，变生他病，故忌寒凉收敛，如《五藏生成篇》所谓肺欲辛是也；治内者药不宜动，动则虚火不宁，燥痒愈甚，故忌辛香燥热，如《宣明五气篇》所谓辛走气、气病无多食辛是也”。肺为娇脏，其性属金，金性畏火，过热则咳，金又恶冷，过寒亦咳，选方用药之际，一定要考虑这一特点。咳嗽虽系常见疾病，如率尔投药，治愈亦非易事。更有认为炎症而动辄大剂寒凉者，不但病不得愈，反而缠绵日久。此时亟宜温润辛宣，始克有济。^[21]

21. 韩明向诊治经验

韩氏以祛风法治疗外感咳嗽，取得满意效果，经验独到，兹介绍如下。

①外感咳嗽证候特点：咳嗽是肺系疾病的主要证候之一，其病位在肺，因肺主气，司呼吸，以宣发肃降为顺，肺气不宜，则壅遏不畅，肺气上逆而咳嗽。肺为娇脏，其气宜清不宜浊，故最不耐外邪，受邪则失其清肃之职而咳嗽不已。外感咳嗽是指机体因感受风、寒、湿、热、燥、火六淫之邪所引起的以咳嗽为主症的病证，正如《河间六

书·咳嗽》指出：“寒暑燥湿风火六气，皆令人咳。”《医学心悟·咳嗽》更形象地将其概括为：“肺体属金，譬若钟然，钟非叩不鸣，风寒暑湿燥火六淫之邪自外击之则鸣……”。可见外感咳嗽的病因为六淫外邪犯肺，其病机为肺气不宣，肺气上逆。风为百病之长，六淫之首，因而外邪多以风邪为引导侵袭人体。由于风为寒热兼有之邪，临床常见的风寒咳嗽则为风从寒化；风热咳嗽则为风从热化；而风燥咳嗽，因风为阳邪，易伤津化燥。风性善动，动则痒，风邪致咳多以咳嗽突发突止，咳吐泡沫样痰，咽痒为证候特征。外感咳嗽病位在肺，肺在上焦，上焦如羽，非轻不举，轻清灵动之品可以开达上焦，故临床从祛风论治，使外邪得以宣散，肺气得以宣畅，而又不耗散肺气。祛风之品多具有解除支气管痉挛及抗变态反应功效，多采用疏风散寒、疏散风热、祛风润燥、祛风化痰、祛风解痉等法。方药选用《医学心悟》之止嗽散，此方“温润和平，不寒不热，既无攻击过当之患，又有启门驱贼之势。是以客邪易散，肺气安宁”。方中荆芥、桔梗疏风宣肺，紫菀、白前、百部、陈皮理气化痰止咳，甘草调和诸药，与桔梗同用，且能清利咽喉。

②祛风法临证运用：疏风散寒：韩氏认为气虚阳虚者易于贪凉感寒、汗后当风等而致外感风寒咳嗽。症见咳嗽痰稀色白，伴有头痛，鼻塞，喷嚏，流清涕，骨节酸痛，恶风无汗，舌淡，苔薄白，脉浮紧。在止嗽散的基础上，重用荆芥，加用防风、紫苏、麻黄、羌活等以增强祛风散寒之力。风寒咳嗽轻症，用止嗽散加减治疗；若因素体肺气亏虚感受风寒，则应用玉屏风散加味补益肺气；若属风寒咳嗽重症，咳嗽痰稀伴头痛项强、恶寒发热无汗，当用三拗汤加止嗽散加减治疗。

如治周某，女，28岁，1997年7月6日初诊。反复咳

嗽2年余,近2天来,因气候变凉出现咳嗽,痰多色白,时为泡沫样痰,咽痒,伴有鼻塞流涕,身楚不适,舌淡,苔薄白,脉浮滑。此乃肺气素虚,卒感外邪,风寒之邪束肺,肺气失宣而咳。治拟疏风散寒,宣肺化痰。处方:防风10g,荆芥穗10g,杏仁10g,炙紫菀10g,款冬花10g,炙百部10g,炙麻黄10g,紫苏叶10g,陈皮10g,姜半夏10g,茯苓15g,太子参15g,炙甘草8g,4剂。咳嗽诸症痊愈。续予玉屏风散巩固疗效。

疏散风热:韩氏认为阳热亢盛者易于外感风温、风热之邪,或虽感受风寒亦易蕴而化热,侵袭肺脏,肺失宣发而咳嗽。症见咳嗽不爽,痰稠而黄,口干渴,咽痛声嘶,伴头痛,身热,恶风汗出,舌苔薄黄,脉浮数。在止嗽散基础上重用荆芥配伍薄荷、蝉蜕、桑叶、金银花、连翘、黄芩等以加强疏风清热之力。

如治宋某,男,16岁,1997年9月14日初诊。反复咳嗽10多年,每年咳嗽2月余。近咳嗽1周,痰多色黄,不易咳出,喉先痒,随即咳嗽,舌红,苔薄黄,脉细滑。此乃风热之邪犯肺,肺失宣降而咳。治拟疏散风热,宣肺化痰。处方:金银花10g,连翘10g,荆芥穗10g,杏仁10g,前胡10g,桔梗10g,炙百部10g,炙紫菀10g,款冬花10g,蝉蜕8g,7剂,咳嗽止。续予玉屏风散合生脉散加味巩固。

祛风润燥:韩氏认为风为阳邪,可胜湿伤津化燥,素体阴虚之人尤易外感风燥之邪,肺失清润而咳嗽。症见干咳无痰,或痰少粘稠难以咯出,或痰中带血丝,鼻燥咽干,舌苔薄白而少津,脉浮或浮数,或伴有恶风、头痛等。在止嗽散基础上常配伍桑叶、薄荷、蝉蜕、南沙参、麦冬、玄参、贝母、玉竹等以增强祛风润燥之力。

如治陈某,女,45岁,1998年9月6日初诊。干咳1

周，阵发性加剧，咳嗽无痰或量少，咽干咽痒，舌淡红，苔薄，脉细。此乃风燥犯肺，肺失宣肃而咳。治拟祛风润肺，化痰止咳。处方：蝉蜕 8g，南沙参 15g，荆芥穗 10g，麦冬 10g，杏仁 10g，前胡 10g，炙百部 10g，炙紫菀 10g，款冬花 10g，川贝母 5g。服 5 剂而愈。

祛风化痰：韩氏认为咳嗽时属无表证，或先有表证，表解后咳嗽迁延不愈，症见咳嗽突发突止，痰多泡沫或喉痒，痰鸣，苔薄白，脉滑利者为风痰咳嗽，宜祛风化痰止咳。在止嗽散的基础上加法半夏、茯苓、胆南星、陈皮、防风、蝉蜕等以增强祛风化痰之力。

如治郑某，男，36 岁，1999 年 2 月 8 日初诊。咳嗽 10 余天。受凉后咳嗽、痰多、色白有泡沫，夜间加剧，喉痒，胸脘痞满，纳少，苔薄白，脉细滑。此乃风痰犯肺，肺失清肃之咳嗽。治拟祛风化痰，宣肺止咳。处方：荆芥穗 10g，防风 10g，杏仁 10g，炙紫菀 10g，款冬花 10g，炙百部 10g，前胡 10g，陈皮 10g，炙甘草 10g，茯苓 15g，蝉蜕 8g，服 7 剂而愈。

祛风解痉：韩氏认为咳嗽剧烈，呈现阵发性痉挛性咳嗽，或伴气急呕吐、紫绀等症，常在止嗽散基础上加用蜈蚣、白僵蚕、蝉蜕、川芎等以祛风解痉。外感咳嗽是由于外界冷空气与人体内部温度相差太远，鼻粘膜等首先受刺激而起反应，进一步肺脏气管受刺激而起反射作用则见咳嗽，因而其他各型外感咳嗽，亦可选用祛风解痉之品。

如治夏某，女，41 岁，1999 年 7 月 25 日初诊。哮喘反复发作 30 年，近因受凉而发 1 周，咳嗽剧烈，甚至喉间哮喘，气急，痰色白有泡沫，咽痒鼻痒，风吹后易喷嚏、流涕，时有尿频、失禁、腰酸等症。此乃由于素体肺肾亏虚感受风邪，肺气不宣而致的痉挛性咳嗽。治拟祛风解痉，

补益肺肾。处方：荆芥穗 10g，防风 10g，杏仁 10g，前胡 10g，炙百部 10g，炙紫菀 10g，款冬花 10g，炒白术 10g，补骨脂 10g，胡桃肉 10g，川芎 15g，炙黄芪 15g，蜈蚣 2 条，服 7 剂而咳嗽止。续予补益肺肾之法以巩固疗效。^[22]

22. 赵棻诊治经验

赵氏在临床中经常接触到消化性溃疡、食管炎、浅表性胃炎及慢性萎缩性胃炎（B 型）等病症，在这些病例中，经胃镜和胃液分析等检查，得知由胃酸返流导致支气管刺激而发生咳喘者，其轻者多有饭后饱胀感，嗝气，或胸骨后类似于心绞痛样疼痛；重者有上腹部灼热、胸骨后烧灼、嘈杂感，与此同时呕恶泛酸，咳嗽骤作，多见于进餐后，尤常见于进食酸性食物如醋、橘子水之后，夜间易于发作，常在卧睡中呛咳而醒，此咳少痰。胃病与咳嗽纠缠在一起，单治咳，咳不止；专治胃，咳难宁，殊觉棘手。古人有“五脏六腑皆令人咳，非独肺也”之训，现代医学亦有“胃返流性肺疾病”之说，遂究其理，以解此难治性咳嗽之症。

赵氏认为，此种咳嗽是先有胃肠疾患，后生咳嗽，既无表证，当求内因，所谓诸脏先伤，后传于肺，标见于肺，而其本在脏腑之间。在上述咳嗽症状中，除有胃本身腑气不得通降外，最明显的当涉及肝气作用。推及肝气犯肺病机，又不同于木火刑金、上逆侮肺之证，只是肝胃气机失调，升降失司，肺失肃肃为本病主要病机。现代医学亦认为是酸性胃内容物，逆流于食管，或少量胃酸误吸入气管，或胃酸刺激食管粘膜导致反射性的咳嗽。

本病论治，应以肺为标，肝胃为本，止咳为标，降逆为本。故治法只宜平降肝胃之气，兼予助肺肃降，而咳可宁。自拟“降逆止咳汤”试用于临床，疗效较为满意。方

药组成：木蝴蝶 12g，蜜枇杷叶 9g，苦杏仁 7g，蒸百部 12g，厚朴 9g，枳壳 9g，旋覆花 9g（布包），代赭石 15g，郁金 9g，麦芽 30g，谷芽 30g，海螵蛸 20g，甘草 5g。方中取枇杷叶和胃下气，苦杏仁助肺肃降，百部对新久寒热诸咳皆有止咳之功，三味配合为宁咳之主力，用以治标。厚朴、枳壳通腑导滞；旋覆花、代赭石重镇降逆；木蝴蝶、郁金疏调肝气，三组药物相配，为疏肝降逆之主力，用以治本。另取海螵蛸、甘草解胃痛而止酸，麦芽、谷芽赞助脾胃，升降气机，俾使全方药力运转，以奏其功。综观本病是以胃病在先，咳为继发，故治此咳，重在疏导通降，调其气机，而咳可止，即所谓降肝胃而寓宁肺。然肺为“华盖”，“治上焦如羽，非轻不举”，方中木蝴蝶一味，既能入肺理气，又可疏肝运脾，勿因其轻而等闲视之，是以重用，为治本病最得力之主药。本方在应用时，视具体病情，可酌情加減。

如治林某，男，41岁，工人。1993年3月13日初诊。患者胃脘不适，闷胀，右上腹近胁部有压痛点，已十余年之久。病症反复发作，时轻时重，无明显规律，伴呃逆、泛酸、夜寐欠佳。近2个月来，胃脘部常嘈杂不安，烧心夜甚，其中呛咳少痰，日渐加重，睡卧尤显。纳食一般，二便尚正常。舌淡红，苔薄白，脉弦。经某医院纤维胃镜检查，提示：十二指肠球炎、慢性浅表性胃炎。初诊以治溃疡和胃炎为主，服药10余剂，呃逆、胃脘胀痛有所减轻，但咳嗽仍重。初以为感受外邪所致，细审之后，并无肺卫表证可证，又无痰湿内聚、木火刑金或肺虚内伤因素，再详细询问，方知有泛酸与呛咳并见并重的特点，且脉弦明显，经胃液分析，证实胃酸偏高，联系泛酸、嘈杂等症状，乃悟肝胃气逆，酸泛于上，支气管受刺激所致。给予

“降逆止咳汤”加减，并嘱患者停用西药，避免烟、茶、酒的刺激，不宜进食生冷、燥热食物。睡眠取高枕右侧位，保持大便通畅，力戒郁怒等，前后共进药 20 余剂，始见酸少咳止，随访 3 个月咳无复发，但仍有胃胀等症状，此乃慢性胃炎表现，应另行续治。

赵氏近几年治愈此种咳嗽 17 例，均为中青年人，男性多于女性。一般认为，在胃和十二指肠或食管炎的病变尚未痊愈，胃酸时时逆流，则咳难以治愈，倘若不加治疗，尚无自愈之例，即使治疗，亦需抓住肝胃气逆的主导病机，方可获得止咳良效。本病虽有肝气失疏，但不一定有精神因素作怪，有些患者精神乐观，豁达开朗，亦出现严重的肝胃气逆、酸水上泛，可知此是脏腑经络功能失调所致。胃酸上逆于食管，能引发咳嗽，换言之，酸不上泛，则不咳，但并非所有胃酸上泛者，皆致顽咳，这可能与素体差异有关。

本病治法既经确立，因病理变化有其特殊性，故配方选药，尚需精究。如疏肝理气，不取柴胡、香附，而重用清轻的木蝴蝶及善于行气解郁的郁金等，治咳不取肺风草、紫菀、款冬花、麻黄等，而用枇杷叶、苦杏仁、百部，此乃赵氏经验之处。所拟“降逆止咳汤”，不在单纯止咳化痰，意在和胃降逆，故疗效颇彰。

中医理论虽有“五脏六腑皆令人咳”之说，但因胃酸返流致咳的具体报道至今尚不多见。赵氏参考西说，无非洋为中用，而治法完全体现中医特色。^[23]

23. 蒋士英诊治经验

蒋氏从事临床 50 年，擅长治疗外感温病。其诊治秋燥干咳善用润法，疗效显著。其大法有四：一曰清润，二曰辛润，三曰甘润，四曰通润。

①燥在上焦头目，治以清润：燥热病邪侵扰上焦头目，治以清润法。症见咽喉疼痛，牙龈红肿，双目干涩，口唇干燥，鼻孔内燥，口微渴，舌边尖红，脉数而浮。治拟清宣润滋上焦卫气燥热，蒋氏常用自拟“清润汤方”，药用梔子、密蒙花、连翘、桑叶、甘菊、蝉蜕、薄荷、淡竹叶、木通。如咽痛加牛蒡子、凤凰衣，目赤加夏枯草，耳鸣加苦丁茶，便秘加莱菔子，咳痰不爽加桔梗。

如治马某，女，16岁，1989年9月25日初诊。患者咳嗽已半月余，经服多种中西止咳药无效，X线胸透：肺部无实质性病灶，初起口唇干燥，继而鼻孔内干燥，咽喉疼痛，夜半咽喉感痒即顿咳不止，咯痰稠粘且少，右侧牙龈红肿，偶尔有耳鸣作响，双目干涩而燥，大便秘而不畅，西医诊为急性咽喉炎。咽喉深部及两侧充血，舌边尖红、苔白兼略黄，脉寸口细数。正值秋令燥邪时节，证属燥邪上受，肺气受郁。治拟清润汤加减：桑叶10g，野菊花12g，连翘12g，蝉蜕6g，桔梗12g，淡竹叶10g，木通3g，苦丁茶12g，莱菔子15g。煎法：取鲜芦根30g煎汤去滓，以汤代水浸入以上诸药，香气出即顿服，不可久煎。继服3剂后，咳嗽减半，夜卧得安，双目润；再进3剂耳鸣停作，夜间已不再咳嗽，惟大便仍不畅，目干燥，牙龈尚肿，随投当归龙荟丸6粒，合汤药吞服，3日后舌苔由薄黄转白，目燥眼肿皆消。蒋氏嘱其每日以青皮甘蔗代水常嚼不断，1周后诸症尽除。

②燥邪袭肺，治以辛润：秋燥病邪上受，侵袭人体，以手太阴经为重心。症见胸闷气郁、甚或两胁窜痛、心烦口渴咽喉燥涩而痛、鼻孔内呼气特燥、口唇干燥裂。干咳无痰或气逆而喘，身有热，额头按之热，尺肤抚之亦热，肌肤干燥，苔薄白或薄黄干燥，舌边尖红赤，脉寸关部数，

此为燥犯手太阴肺之特征。治拟辛润宣肺润燥养肺阴，蒋氏自拟常用方“辛润宣肺止咳汤”。药用桑叶、北沙参、麦门冬、光杏仁、紫菀、款冬花、炙枇杷叶（去毛蜜炙）、蒸百部、化橘红、桔梗，若有痰难咯加白前、瓜蒌皮，身热重加生石膏，肺金燥热加胡麻仁，咳嗽日久肺气郁闭加生麻黄，表邪尚存加连翘、牛蒡子。

如治王某，女，38岁，1989年10月22日初诊。半月前感冒，并发烧，自购西药服后体温下降，但咳嗽不止，后求中医诊治，服汤剂20余剂及蛇胆川贝液10余支，反咳嗽益甚，尤以夜间干咳最甚。自诉咽喉痒，日夜频频咳嗽不断，难以安眠，偶尔有血丝状咳出，X线胸片显示：肺部正常，亦无支扩病史。咽峡部充血水肿且呈紫褐色。口唇干燥裂，鼻孔干燥，胸宇气滞而闷，心烦口渴，手心热，舌边尖红，苔薄黄干燥，脉细数，此为肺经燥热郁盛，耗伤肺津。治拟辛润宣肺止咳汤加减，处方：桑叶12g，炙紫菀12g，炙款冬花12g，蒸百部9g，光杏仁12g，生麻黄6g，北沙参15g，麦冬12g，凤凰衣6g，玉蝴蝶10g。煎法：用鲜石斛30g煎汤代水去滓，加入以上诸药煎服，服药3剂后病者诉述每夜酣睡不醒，精神及胃纳转佳；继服3剂后，胸宇舒展，咽疼消失，因病人工作繁忙不任煎汤药，嘱其用西洋参切片，口含嚼之，1周后病人痊愈，未见复发。

③燥邪上受而肺气虚者，治以甘润：肺朝百脉，为五脏之华盖，平素肺气虚者，吐纳功能减弱。每年秋冬季初，极易罹患秋季的燥热病邪，咳嗽频频不止。此类病人多肺气虚，宗气不足以抗燥热病邪，症见身倦乏力，语音低微，呼吸无力或少气不足以息。蒋氏自拟常用方“甘润清肺汤”，药用西洋参、北沙参、麦冬、鲜芦根、苦杏仁、炙紫

菀、炙款冬花、蒸百部、桑叶。

如治黄某，女，73岁，1992年9月28日初诊。患者自诉多年来，每年秋季或冬初，易染咳嗽，平素口干咽燥。望其形体羸弱，肌肤白而肥硕，为阳虚之体。患外感已1周，咽喉痒不已，口唇干裂，口渴引饮以入夜为著，鼻孔干燥，双目燥涩，当风易流泪水，身热不甚，舌红，少苔，脉细弱。X线胸透：肺部两叶纹理增粗。仍干咳少痰，频频不止。证为燥邪上受，肺气虚弱，治以甘润，甘润清肺汤加減，处方：西洋参12g，北沙参15g，天门冬15g，鲜芦根20g，鲜石斛20g，光杏仁12g，炙紫菀12g，炙款冬花12g，蒸百部6g，生甘草5g，煎服。5剂后病人咽燥口干減半，咳嗽大減，继进5剂诸症痊愈。

④秋燥犯肺，肠燥便秘，治以通润：秋燥上受必乘肺经，故上逆而咳；肺与大肠相表里，肺经燥邪不解，必下传于大肠成便秘症。此类病人，感受燥邪，肺气郁闭日久，自卫分传入气分，遂成肺与大肠同病。症见咳嗽阵阵不止，口干舌燥，唇裂，咽喉燥涩发痒，胸闷腹部胀满，大便秘或不畅，苔白略黄，脉沉稍数。蒋氏自拟常用方“开肺通润导下汤”，药用玄参、生地、麦冬、瓜蒌仁、光杏仁、桔梗、郁李仁、橘皮、柏子仁。此方实为取三才汤与五仁橘皮汤之方意组合选用。

如治张某，女，28岁，1992年10月20日初诊。患者产后4个月，1周前感冒，服药、注射青霉素后热退，惟咳嗽频频不断，且以夜间为甚，咽疼口干燥喜冷饮，唇裂发出小疱疹，大便2~3天1次，胸闷，腹部胀气，两肋时有胀痛，舌尖上有红点，舌苔薄黄，脉右寸口数、尺肤按之热，夜间醒后胸部有汗，咳嗽剧时脸部涨红，咯痰稠粘不爽，白中带黄。证属秋燥犯肺，日久不治，肺之燥邪下传

大肠成便秘症。治拟开肺通润导下汤加减。处方：玄参 30g，生地 30g，麦冬 30g，瓜蒌仁 12g，光杏仁 10g，桔梗 12g，郁李仁 10g，百部 6g，火麻仁 12g。服 2 剂后大便秘通，胸宇顺畅，咽痛口干燥大减。上方去玄参、生地、麦冬，加入生麻黄 6g，紫菀 12g，款冬花 12g，服 5 剂后，咳嗽止，诸症痊愈。

蒋氏治秋燥干咳，擅长用“四润法”，旨在宣畅肺气，清润肺经。他说凡秋燥干咳，其重心在手太阴肺经，治以清润。选药一宜质轻，二宜量轻，以轻可祛实邪，法宗吴氏“治上焦如羽”。见咳即投苦寒药物强以止咳，皆不可取。应顺其肺性之势，疏而导之，处处着眼于宣泄和肃降。如见秋燥久咳不愈，大多药过病所，或苦寒克伐太过，郁闭肺气，必要时可用生麻黄 5~10g 以开肺气，勿受温病不可用辛温之拘。如宣开肺气药用后，咳嗽仍不止时，蒋氏常用以下 4 味药伍入：桑叶、炙紫菀、炙款冬花、蒸百部，止咳效果显著。^[24]

24. 吴震西诊治经验

吴氏擅治内科疑难杂症，倡内病外治疗法，尤精于咳嗽的治疗，辨证用药具有独到之处。

①透达祛邪，宣肃肺气：盖肺属上焦，位居胸中，处于脏腑的最高位，为五脏之“华盖”，上连气道喉咙，与大气直接接触，开窍于鼻，外合皮毛，主气司呼吸，为人体升降出入之枢纽，气贯百脉而连他脏，不耐寒热，称为“娇脏”。其功能特点为宣发和肃降，两者相辅相成。只有宣肃协调，才能保证肺气的出入通畅，呼吸均匀。反之宣发失常则肺气不降而上逆为咳；肺失肃降，则肺气不利而咳。故六淫邪气，从口鼻而入或由皮肤侵袭，均客于肺卫，

使肺失宣肃而咳嗽；脏腑内伤涉及于肺或内生五邪累及肺脏，使肺失宣肃而病咳，所以咳嗽不止于肺而不离乎肺。吴氏针对肺为娇脏，易受邪侵和肺失宣肃，痰生气逆之特点，治咳按前贤“治外感咳，以祛邪为先”之意，习用止嗽散加减宣肺肃气，透达祛邪，止咳疗效卓越。吴氏认为，该方药性平和，轻宣透达，舒展气机，不仅可用于寒咳，而且亦可用于热咳，既无攻击过当之虞，大有启门驱邪之功。

如治万某，女，55岁。咳嗽阵作2月，咯痰色白量多，咽痒胸闷，脉滑，苔薄白。证属痰浊内蕴，肺失宣肃，治以宣肃肺气，化痰止咳。处方：紫菀10g，白前10g，前胡10g，炙苏子10g，茯苓10g，法半夏10g，炙僵蚕10g，旋覆花（包）10g，蒸百部15g，橘红6g，桔梗6g，甘草6g。5剂，药后咳嗽大减，痰少，继5剂，病愈。

咳嗽多作于冬令或气候交变之时，昼夜朝暮之轻重变化，有痰无痰或痰之多少，常难恒定。故吴氏临证常予辨证配伍，发热加银翘或知母、黄芩以解毒清热；痰多加大贝母、冬瓜仁或二陈以祛痰；喘急加苏子、地龙以平喘；咽痒加僵蚕、蝉蜕以解痉；瘀重加丹参、当归以活血；咯血加白及、煅花蕊石以止血；咳而吐者加炙枇杷叶、旋覆花以止呕；阴伤加沙参、麦冬以养阴。体虚易感者加玉屏风散以补肺益脾，扶正固本，不止咳而咳自止。

②补肺健脾，益肾固本：久咳不解的慢性咳嗽，病程长，病情重，皆由肺病涉及脾肾，引起肺脾肾三脏俱病。由于肺失宣肃，脾失运化，肾失蒸发，使体内气血津液三者的生理平衡遭到破坏，随之出现各种病理变化和产生病理产物，气机郁滞，升降失常，痰浊内生；气病及血，血脉瘀结，经络痹塞，尤其是痰瘀胶结，协同致病，更易耗

伤肺脾肾，使肺脾肾气日益虚弱，由此形成恶性循环，使咳嗽加剧而难愈。

慢性咳嗽临床表现大多为咳嗽而短气，咯痰多，胸闷乏力。临床以年老体弱者多为。其病本于肺脾肾气虚弱，其标为痰浊瘀血内阻，外感为常见之诱因，稍有不慎，就会引发急性咳嗽。在急性发作时，应着重祛邪。倘若邪气不能外达，痰瘀无以蠲化，肺气壅遏不宣，则咳嗽难止。此时咳嗽之病理变化亦属肺失宣肃，故吴氏临证常辨以寒热两端而治。寒证予轻宣透达，常用杏仁、苏子、桔梗、前胡、橘络、紫菀、款冬花、旋覆花、法半夏、枳壳等药；热证予清肃肺气，常用桑白皮、瓜蒌皮、知母、贝母、黄芩、百部、牛蒡子、杏仁、旋覆花、炙枇杷叶等药。待咳嗽平后，强调扶正固本，补肺健脾益肾以防止和减少复发。盖脾为后天之本，气血生化之源；肾为先天之本，温煦和滋养全身各脏腑。脾肾为生痰之源，肺为贮痰之器。只有脾气健运，肾气强盛，则正气充沛不致滋生痰湿，气机流畅，血脉调和。吴氏喜用党参、黄芪、白术、茯苓、黄精等补益肺气健脾培中；用熟地、淫羊藿、蛤蚧、补骨脂、紫河车等益阳填精，补肾摄纳；用陈皮、川贝母、法半夏、厚朴、当归等理气燥湿化痰。

如治陈某，男，65岁。慢性咳嗽反复发作3年，加剧1周，咳嗽气短，咯痰粘多，苔薄腻，脉滑数。证属痰热蕴肺，肺失清肃，治以清肺化痰。处方：桑白皮10g，瓜蒌皮10g，知母10g，贝母10g，黄芩10g，炒苏子10g，旋覆花（包）10g，杏仁10g，茯苓10g，紫菀10g，百部15g，冬瓜仁30g，甘草6g。7剂，药后诸症好转，再予原法进退10剂而病愈。嘱常服咳喘平胶囊，其疾3年未发。

由于中药剂型的影响，长期服用汤药存在着诸多不便。

吴氏常根据患者肺脾肾虚的轻重缓急，辨证选用成药。偏于肺虚者，用玉屏风口服液以补肺；偏于脾虚者，用固本咳喘片或香砂六君丸以益脾；偏于肾虚者，用咳喘平胶囊（吴氏自拟方，由人参、蛤蚧、川贝母、三七等组成），或金匱肾气丸以益气补肾，克服了服汤药不便之弊端。除此之外，吴氏十分重视食物疗法，针对患者病证，嘱其食梨、百合、山药、核桃、黑芝麻等，持之以恒，皆获良效。

③内外合治，两不偏废：吴氏治咳，不但重视内治（内服药物治疗），而且十分重视外治（药物穴位贴敷治疗）。根据清末吴尚先“外治之理，即内治之理，外治之药，亦即内治之药，所异者法耳”的理论，运用经络学说，结合自己数十年的临证经验，研制了宁嗽贴膏、发泡膏等，治疗咳嗽，疗效显著。

宁嗽贴膏由杏仁、半夏、白芥子等药物组成。用于治疗风寒、风热、燥热、湿痰、痰热等外感咳嗽，均获良效。对于小孩或畏惧服药者尤为适用。每天将药外贴涌泉穴1次。12~24小时揭去，7天为1疗程，最多2个疗程。若喉痒咳剧者，可加贴天突穴。

发泡膏由斑蝥、白芥子等药物组成。用于治疗慢性久咳。因其病多数呈夏轻、秋加剧、冬甚的特点，故在夏季三伏天进行冬病夏治，以改善机体的免疫状态，增强细胞的吞噬功能，提高机体的防御和非特异性免疫功能，预防感冒，减少咳嗽的发作次数，减轻病情程度，缩短疗程，达到防病抗炎之目的。临床应用，效果显著，亦可随时用于支气管哮喘的咳嗽咯痰，能获明显的止咳平喘效果。临床常用天突、肺俞、大杼、定喘、膻中、丰隆、身柱、肾俞、脾俞、命门、足三里等穴位，根据发则治标，缓则治本之旨，选穴施治，7天贴敷1次，（3小时后揭去，儿童酌减），4

周为1疗程。

吴氏常说：“中医治病，强调整体观念和辨证论治，内治必须明脏腑虚实以平衡阴阳，外治必须明经络腧穴以泻实补虚。”经络学说是中医学的重要组成部分，它内属于脏腑，外络于肢节，沟通内外，联系肢体，运行气血，营养全身，抗御外邪，保卫机体，使人体各部的功能活动得以保持协调和相对平衡。若一旦患病，就会引起相应经络的气血不畅而出现各种症状。所以可循经或分部取穴治疗。天突、定喘为位近肺脏，前后相应，宣肺降气之效穴，有化痰止咳之功；大杼是足太阳经而近肺脏，肺之卫表，能益肺固表卫外，祛邪止咳化痰；膻中为气之会，可调顺气机；丰隆为胃之别络，可顺气化痰；肺俞、肾俞有培养肺气，填纳肾气之功，肺肾气充，则上有主而下能纳，气机得以升降，肺气得以宣肃；身柱、命门同属督脉，上下标应，填精壮督，益肾温阳，蒸化水液，止咳化痰平喘；足三里、脾俞调和脾胃以资生化之源，使水谷精微上归于肺，肺气充则自能卫外；涌泉属足少阴肾经，有一支脉出肺络心，再灌注于胸中，药贴涌泉，上病下治，能疗咳嗽等肺部疾患。”

中医应用膏剂敷贴俞穴治疗疾病，渊远流长，俞穴贴药后，可使药力随俞入肺，灌精气而营阴阳，其可能是通过压力、温热、化学、皮肤感受器，经淋巴管吸收而深达脏器而取效，亦可能与神经、体液的作用有关，药物刺激穴位，反射性地刺激了大脑皮质，调整了其兴奋与抑制过程，与内服药力协同起到良好的疗效。^[25]

25. 曹世宏诊治经验

慢性咳嗽是指3周以上的持续或反复发作性咳嗽。由

于病因复杂，经常规治疗常效果不佳。曹氏治疗本病临证颇多效验，兹介绍如次。

①清润宁肺，治肺燥久咳：“肺为娇脏，不耐寒热”，且居高位，为五脏之华盖，易为外邪侵袭。外邪袭肺，化热伤津，或因燥热犯肺，致使咳嗽迁延。《证治汇补》谓“气动火炎，久咳无痰”，而《景岳全书》则云：“肺苦于燥，肺燥则痒，痒则咳不能已也。”临床症见咳嗽频作，日久不已，咽喉发痒，痒则引咳，甚则胸次作痒，少痰或无痰，口干，舌偏红，苔薄，脉细弦。治以清养肃肺，宁嗽止咳，拟方清热宁肺汤合止嗽散化裁。若实火上炎，肺津受燥，咳嗽烦甚，加知母、生地；若咳甚而痰少，咯吐不爽，加川贝、蛤壳；若咳久阴血不足，咳痰不利，加当归；若便秘，加制大黄。

如治吴某，女，42岁，1996年9月8日初诊。咳嗽迁延2月，频作不已，尤以夜间为甚，咽痒引咳，胸次作痒，夜不能寐，痰少粘白咯吐不爽，口干不苦。舌红、苔薄黄而干，脉细弦。双肺听诊呼吸音粗，未闻干、湿性啰音。院外胸片示：两肺纹理增多。肺功能、血象检查正常。诊为急性支气管炎。病机为风邪犯肺，郁久化热，伤及肺津，复因燥气当令，易伤肺津。治以清润兼顾，标本同治，并佐以祛风。处方：桔梗10g，麦冬10g，黄芩10g，马兜铃10g，炙麻黄5g，杏仁10g，僵蚕10g，当归10g，蛤壳15g，紫菀10g，甘草5g。服药7剂，咳嗽大减，仅偶作而已，无痰，口干，舌偏红、苔薄。原方去僵蚕、黄芩、蛤壳，加南沙参15g，淮山药15g，百合15g，又服7剂，咳嗽遂止，未见复发。

②清金逐痰，治深痰顽咳：“肺为贮痰之器”，痰浊伏肺常成肺病咳嗽之夙根。若遇外邪引触，或因肝火刑金，

或嗜食辛辣厚味化热，致使痰热互结，内蕴日久，入络成瘀，痰热瘀互结，成为深痰痼疾，咳嗽难已。症见咳嗽阵作，咯痰稠黄，胸膈隐痛，或痰中带血，舌暗红、苔黄腻，脉滑数。治以清金逐痰、泄热行瘀。方选《千金》苇茎汤合《济生》桔梗汤加减。若热甚便秘，加大黄、金银花；若痰多，加败酱草、金荞麦；若痰血相兼，加大黄炭、侧柏叶、茜草；若气虚明显，加黄芪以托毒排痰；若迁延经久，气血衰弱，加当归、白术、熟地等；若阴虚痰热，加麦冬、百合等。

如治薛某，男，56岁。1994年10月29日初诊。患者幼时曾患肺炎，20年来咳嗽咯脓痰时作，症情时轻时重。每当咳嗽加剧，咳痰量多，经静脉使用抗生素治疗可以好转。10天前症情再发加重，在当地医院使用抗生素及祛痰剂未见缓解。目前咳嗽阵作，咳痰稠黄，胸痛隐隐，胸闷气粗，口干且苦，便干难解。舌红、苔黄腻，脉滑数。双下肺可闻湿啰音。院外胸部CT示：两下肺支气管呈柱状扩张，管壁增厚。血中性粒细胞偏高。诊为脓性支扩。治以清肺泄热，化痰行瘀。处方：桑白皮10g，黄芩10g，桔梗10g，桃仁10g，全瓜蒌15g，冬瓜仁15g，生薏苡仁15g，黛蛤散15g，金荞麦15g，败酱草15g，陈胆星10g，芦根30g。服药7剂，咳、痰皆减，痰色黄白相兼。上方加黄芪、当归，又服7剂，症情进一步好转，少痰，间咳口干，苔薄黄。原方去黛蛤散、金荞麦，酌情加入沙参、麦冬、百合、枳壳、郁金、淮山药等味，服药近半年，症情稳定，不咳、无痰。复查胸部CT亦较前好转。

③培土生金，治痰湿咳嗽：“肺为主气之枢”，“脾为生痰之源”。肺病久咳，由肺涉脾，或脾胃本虚，健运失司，遂使水谷积聚为湿，从阴化饮，从阳化痰，蓄于脾而嗽，

储于肺而咳，痰与饮壅阻气机，肺脾同病。临床症见咳嗽痰多色白易咯，纳少，腹胀，便溏，舌淡红、苔白滑，脉滑。“其标在肺，其本在脾”。治以培土生金，燥湿化痰，脾肺同治。并可适当加入温化痰湿药，以取“病痰饮者，当以温药和之”之意。方取平胃散、六君子汤化裁。药用：苍术、白术、党参、炒山药、炒薏苡仁、茯苓、炒扁豆、大贝母、姜半夏、陈皮。

如治郭某，男，62岁。1995年4月5日初诊。患者咳嗽间作多年，周来再发，晨起痰多稀白，早起大便先干后溏，纳谷欠馨。舌淡红、苔白滑，脉滑。胸透示双下肺纹理增多。诊为慢性支气管炎。证属肺脾两虚，健运失司，痰湿内阻。治以健脾燥湿，佐以温肺化饮。处方：苍术10g，白术10g，党参10g，姜半夏10g，陈皮10g，大贝母10g，炒山药10g，炒扁豆10g，茯苓10g，干姜6g，陈胆星10g。服药7剂，咳、痰遂止，给以参苓白术丸善后，未见复发。

④益肾补血，治久咳劳嗽：虽“五脏六腑皆令人咳，非独肺也”（《素问·咳论》），然“咳证虽多，无非肺病”（《景岳全书》），故咳不止于肺，也不离于肺。肺为气之主，肾为气之根。肺病咳嗽，日久及肾而致久咳劳嗽，甚则虚喘动甚。治以益肾养血、温养肺气。拟方益肾养血汤（经验方）：太子参、黄芪各20g，当归10g，款冬花10g，熟地10g，紫石英15g，沉香5g。若阴虚，去太子参、黄芪，加沙参、百合；若夹瘀，加桃仁、丹参；若痰多，加贝母、瓜蒌皮。

如治李某，男，60岁。1995年2月20日初诊。患者16年来咳嗽反复发作，尤以冬季及深秋好发。近2年来又伴气喘等症。发作时常咳喘，胸闷，咯痰，需经当地医院

输液、抗感染、解痉等处理方可缓解。2月前咳喘再发，虽经抗生素、氨茶碱等治疗，咳嗽未止，咯痰量少，气喘动甚，口唇略紫。舌淡红、苔薄，脉细。轻度桶状胸，双肺散在干啰音，右下肺少许细湿啰音。胸片示：肋间隙增宽，肋骨平行，膈肌下降且变平，两肺野透亮度增加，两下肺纹理增多紊乱，心影呈垂直位。诊为慢性支气管炎、慢性阻塞性肺气肿。属中医“咳嗽”、“喘证”范畴。病机为肺病日久，痰热余邪未净，肺肾气阴（血）不足，治从益肾补气，润肺养血为主。药用益肾养血汤原方，加郁金10g，蛤壳10g，杏仁10g，白前10g。服药7剂，咳减喘平。后又加入淮山药、薏苡仁、白术等健脾之品，肺脾肾同治，气血同理，服药1月，咳喘遂愈。^[26]

26. 许建中诊治经验

燥咳是咳嗽的一个特殊类型，以咳嗽无痰或少痰，或阵咳或呛咳，咯痰不利，咽痒为主症。见于西医学中的上呼吸道感染、或急慢性咽炎、或急慢性支气管炎、或病毒性肺炎、间质性肺炎等疾病过程中。西医多采用抗生素治疗，但疗效不显。中医在辨治过程中若把燥咳与其他咳嗽类型混合辨治，易出现辨治难度大，针对性不强，治疗效果不明显的情况。许氏认为燥咳的病因病机与天行燥烈、久晴少雨、空气干燥有关，燥邪由此而生。燥邪犯肺，灼伤肺津，肺气失宣；或因燥热之邪退去，肺胃津伤未复，肺胃失于濡润，肺气不宜；或肺肾阴亏，金水不得相生，肺系失却滋润与肃肃。因此临床上可以分为燥邪犯肺、肺胃阴伤及肺肾阴亏3型。

①祛风解表，润燥止咳：本法适用于燥咳初期之燥邪犯肺型。肺气壅遏不宜，宣肃失司则出现咳嗽不已，燥邪

易伤津，故咳嗽以干咳无痰或少痰为特征，咳势较甚，影响睡眠，或咳嗽时缓时剧，经久不愈，每遇风感寒而加剧或伴有恶寒发热，口干，舌淡红、苔薄白少津，脉浮。治宜疏风解表，润燥生津，宣肺止咳。常用药：荆芥、防风、薄荷、菊花、桔梗、生甘草、沙参、麦冬、麻黄、苦杏仁、枇杷叶、前胡等。随症加减：表证明显者，加紫苏叶、桑叶等；病毒感染者，加金银花、板蓝根、大青叶；咳嗽剧者加紫菀、款冬花、川贝母、地龙、蝉蜕等。方中以荆芥、防风、紫苏叶、桑叶、薄荷等解表透邪，佐以沙参、麦冬等养阴润燥，从而达到邪去津复咳止目的。对于顽固性干咳者，可适当加入一些抗过敏药物，如地龙、蝉蜕等以增强止咳效果。

如治杨某，女，55岁。近日感冒后咽干痒，偶有咽痛，阵发性咳嗽逐渐加重，无痰，影响睡眠，口渴欲饮，无恶寒发热，舌淡红、苔薄白而干，脉浮。自服头孢氨苄、川贝清肺糖浆未能获效。证属燥邪犯肺伤津。治宜解表宣肺，润燥止咳。处方：防风15g，沙参15g，前胡15g，枇杷叶15g，荆芥12g，薄荷（后下）12g，麦冬12g，苦杏仁12g，川贝母12g，蝉蜕12g，生甘草12g，桔梗12g，麻黄10g，生石膏20g，金银花20g。每日1剂，水煎服。6剂后病告痊愈。

②润肺降逆，宣肺止咳：本法适用于燥咳中期之肺胃阴伤型。因外感后或内伤导致肺胃阴津亏损者，致肺系失于滋润，肺气不宜，出现鼻干咽燥、干咳少痰等症。该型咳嗽的特点：咳势渐缓，但咳嗽较长时间不止。病程一般超过2周，伴见口干欲饮，咽燥，舌质红、苔干燥，脉细。治宜润肺降逆，宣肺止咳。常用药：生地黄、玄参、沙参、玉竹、苦杏仁、生甘草、桔梗、前胡、紫菀、枇杷叶等。

随症加减：口渴甚，大便偏干者，加生石膏、知母、瓜蒌；干咳久恋不去，加诃子、地龙。

如治司某，女，31岁。咳嗽无痰1月余，时而咽痒，干咳阵作，口渴较明显，饮水多，舌红，苔干燥，脉细。证属肺胃津伤。治宜甘寒生津，润肺降逆为主，处方：生地黄12g，玄参12g，苦杏仁12g，生甘草12g，桔梗12g，炙百部12g，沙参15g，玉竹15g，前胡15g，紫菀15g，枇杷叶15g，地龙15g，生石膏20g，金银花20g。每日1剂，水煎服。服6剂后症状明显改善，继服6剂病除。

③滋肾润肺，宣肺止咳：本法适用于一些燥咳证后期之肺肾阴亏型。由于肺肾阴亏，金水不得相生，肺系失却滋润与清肃，肺气失宣，症见咳嗽无痰，或咯极少量白粘痰，咽干鼻燥，口渴欲饮，手心发热，盗汗，颧红颊赤，或伴有其他肾阴虚症状，舌红，苔少而燥，脉细数。治宜滋肾润肺，宣肺止咳。代表方为知柏地黄汤加减。常用药：生地黄、熟地黄、山茱萸、黄柏、知母、天冬、麦冬等。随症加减：阴虚潮热明显者，加炙鳖甲、龟板；夹肝火者，加牡丹皮、栀子、白芍，或黛蛤散；咯痰带血丝者，加白及、三七粉等；盗汗者，加浮小麦、龙骨、牡蛎等。

如治胡某，女，57岁。3个多月前开始咳嗽，咯极少量白粘痰，痰不易咯出，迁延至今未愈，偶有痰带血丝，自感五心烦热，盗汗，舌红，少苔，脉细数，自服急支糖浆未能获效，证属肺肾阴亏，肺气失宣。治以滋阴清热，宣肺止咳。处方：知母12g，黄柏12g，生地黄12g，熟地黄12g，天冬12g，麦冬12g，山茱萸12g，山药12g，牡丹皮12g，炙鳖甲12g，川贝母12g，炙枇杷叶15g，白及15g。每天1剂，水煎服。服药6剂后诸症减半，后继服18剂诸症皆消。

许氏在燥咳的辨治过程中非常注重观察舌苔的润燥来辨别阴津损伤的程度，视津液损伤的轻重来决定使用养阴药味数的多寡。舌苔轻度少津者，用1~2味养阴药；舌苔中度少津者，用3~4味养阴药；舌苔重度少津者，用5~6味养阴药。常用养阴生津药物有生地黄、天冬、麦冬、沙参、玉竹、石斛、知母、川贝母等，既养阴生津，又兼清虚热，用之可以收到津复气和咳止效果。^[27]

27. 万铭诊治经验

①治前重视三问一观：问胸痛之有无：咳嗽病人伴胸痛不适，鼻燥咽干，舌干红，苔薄少津者，多为燥热伤肺或久病肺阴耗伤，肺络失养。治宜清肺润燥，养阴通络，药用南沙参、北沙参、麦冬、橘络、郁金。如果咳而胸胁引痛，或胀满不适，每遇忿事即发，则辨为肝火犯肺，灼伤肺金，治以平肝降逆为主，旋覆花、桑白皮、生白芍、海蛤壳为常用之品。

问便秘之有无：咳嗽病人伴便秘者，因大便秘结，腑中浊气上迫于肺，使肺气不能清肃下行，此时若便秘不解，则邪无出路而咳嗽难愈。万氏认为，此种便秘以痰热烁津，肠燥不润为多见，每用瓜蒌仁、冬瓜仁、杏仁、火麻仁以润肠通便，腑通脏清而咳嗽缓平。

问咽痒之有无：有些咳嗽病人，自觉咽喉部痒燥涩痛，随之咳嗽不止，一直咳至咽喉痒止方罢，反复发作。万氏认为，这种咽痒咳嗽多见于现代医学的上呼吸道感染致咳和过敏性咳嗽，病机关键在于阴液不足，风燥之邪搏结于咽喉，治疗当润燥与疏散风邪并施，常以沙参麦冬汤加荆芥、防风、蝉蜕、牛蒡子、马兜铃为用。

观面浮之有无：万氏在治疗咳嗽过程中，注意观察患

者是否伴有面目浮肿。认为伴有面浮者是因为肺失宣肃，肺主皮毛失职引起，此时车前草（子）为必用之品。因为肺为水之上源，应用车前草（子）利水以通调水道后，有助于肺肃降功能的改善。另外，《本草纲目》记载车前草（子）有协助排痰之功，现代药理研究亦证明该药能缓解支气管痉挛而止咳。

②治咳莫忘调畅气血：调理气机：万氏认为，咳嗽虽有五脏六腑之分，内伤外感之别，而最终皆致肺宣发肃降功能失职，故治疗中应时时注意调理肺脏气机，使壅滞不宣之肺气得宣，令上逆之肺气得以肃降。临床上，万氏擅于将具宣发、肃降作用的药物配合使用，以顺其机制，如麻黄配杏仁，麻黄宣肺散邪，杏仁肃肺止咳；枳壳配桔梗，桔梗行气排痰，枳壳理气降逆；类似的还有白前配前胡，紫菀配款冬花等等。而在组方当中，万氏更重视以清肃为要，故炙枇杷叶、桑白皮、旋覆花每为常用。

活血化痰：肺朝百脉，全身的血液都通过经脉而聚合于肺，通过肺的呼吸进行气体交换，然后再输布到全身。肺失宣肃，则气机不利，推动血行不畅，导致瘀血阻滞。同时在咳嗽过程中，痰作为一个主要病理因素，阻于肺，也促使瘀血形成。故万氏在治疗咳嗽过程中，常于方中加地龙、当归、郁金、丹参等活血化痰之品，不仅有助于痰邪排出，更使气机调和，百脉流畅，而收到从本治咳之功。

如治刘某，女，52岁，1998年4月22日初诊。患者于2月前感冒后，咳嗽迁延不愈，就诊前曾自服橘红痰咳液、克咳、阿莫仙等药治疗，效果不明显。现症：阵发性呛咳，干咳少痰，咳甚汗出，夜间加剧，胸部隐痛不适，咽喉干痒涩痛，大便干结难解，夜寐欠安，舌暗红、苔薄黄有裂纹，脉细小弦。查体：咽部充血，扁桃体不肿大，

双肺未闻及干、湿啰音，血常规和胸部X线摄片检查正常。证属肺阴耗伤，清肃失职，治拟养阴清肺，润燥止咳。处方：天冬 10g，麦冬 10g，沙参 10g，前胡 10g，牛蒡子 10g，杏仁 10g，桔梗 6g，炙紫菀 10g，款冬花 10g，瓜蒌仁 10g，当归 10g，地龙 10g。每日 1 剂，水煎服。5 剂后患者咳嗽次数减少，胸痛、咽痛好转，夜能安寐。上方加百部 10g，橘络 5g，续服 5 剂，患者诸症悉除。

该患者时值更年期，阴阳失衡，气阴双亏，感受外邪后，易入里化热伤肺，耗伤津液，使肺失清润，肺气上逆而致咳。恙延 2 月，病邪由气入血，邪结郁遏不解，肺脏气津两伤。治疗宜润肺散邪兼顾，理气和血同施。方中天冬、麦冬、沙参养阴补肺润燥；前胡味苦辛，辛能宣肺散风，苦能下气祛痰；牛蒡子能“润肺解热，散结除风，利咽喉，理痰嗽”（《本草纲目》），尤擅宣畅肺经之气，气畅则邪易透达，与前胡共用疏散风邪；杏仁和桔梗为肺经之气分药，杏仁下气止咳，桔梗宣肺利咽，一降一宣，疏利气机；紫菀、款冬花同为辛散苦降之品，温润不燥，既入肺经气分，又入血分，能疏利肺经气血，为润肺降逆，止咳化痰的要药；瓜蒌仁既可利气宽胸，又与杏仁、当归共奏润肠通便之功；当归、地龙活血通络，使气流畅，助邪排出。诸药合用，既补又散，既宣又降，于养阴中降气，于散邪中利气，使肺之宣发与肃降功能恢复正常而咳嗽得愈。^[28]

28. 刘竹林诊治经验

刘竹林尤擅长治疗老年慢性咳嗽，其认为本病临床上多见寒邪客肺或阳虚寒证，两者在病理上有本质的不同：寒邪客肺者，肺阳被郁而未伤，关键在“寒”；肺阳虚者，

阳虚生寒，关键在“虚”。两者治则上也有不同：寒邪客肺者宜温肺散寒为主，肺阳虚者宜温补阳气为主。在用药方面，逐寒主要选用辛温药物，如细辛、干姜、陈皮、苏子等，取其散寒护阳；补阳则主要选用甘温药物，如熟附子、肉桂、党参、白术、法夏等，取其益气补阳而逐寒。方用自拟老咳灵验方加减治疗本病，疗效显著。

如治宋某，男，65岁。患者有慢性咳嗽病史10年，且以冬春季为甚，本次发作因天气寒冷，咳嗽加重5天，吐大量稀白痰，胸闷，气紧，常自觉背部肩胛间发冷，纳呆，大便烂，尿清长，舌淡、苔白厚腻，脉沉紧。肺部听诊：呼吸音粗糙，有鼾音。X线检查：肺纹理增粗。辨证属寒邪客肺，肺阳被遏，治宜温肺散寒，止咳化痰，方用老咳灵验方加减。处方：紫苏子、茯苓各15g，法夏12g，杏仁10g，白术、五味子、熟附子各9g，陈皮、远志、干姜、甘草各6g，细辛3g。3剂，每天1剂，水煎服。服药后咳嗽减轻，痰量减少，胸部较舒，原方续服3剂，咳嗽明显好转，痰白量少，胸背不冷，再续服六君子汤3剂善后，病愈。^[29]

29. 谢海洲诊治经验

肺主气，司呼吸，肺脏功能正常则能营运呼吸，吸清呼浊，实现“吸之则满，呼之则虚，一呼一吸，消失自然，司清浊之运化”（《景岳全书》）。肺气宜宣宜降，若肺为邪气壅闭，宣降不利，常表现为咳嗽。一般的咳嗽，新咳治宜发散宣肺为主，久之则内虚，治以补肺益肾。曾治一病例，10年前因扛重物卒然致咳，伴心窝部发热，每逢劳累受凉、食辛辣及性生活之后均易复发。诊见：咳嗽，无痰或少痰，痰色时黄时黑，因咳而致夜寐不安，无发热，时

心慌，多梦，头晕，腰酸耳鸣，食少，大便干，小便量多色黄，舌质淡红嫩胖、苔薄黄，脉弦滑。肺部听诊、胸部叩诊均为阴性，胸透未见异常。此乃强力负重，跌打闪挫，肺络受损，络破血瘀，瘀血内阻，不通则痛，故见胸部隐痛，日久邪瘀化热，炼液成痰，则咳吐黄痰或黑痰。肺与大肠相表里，肺津失布则大便干结，舌暗红有瘀点、苔黄腻，脉弦滑，皆瘀血内阻，湿热内盛之征。观其病史、病程、病症，辨为瘀血内结，湿热壅肺之咳嗽，治以清热利湿，通瘀散结，方用千金苇茎汤合泻白散加减。药用芦根、桃仁、薏苡仁、冬瓜仁清热祛痰化瘀，辅以鱼腥草清热解毒，赤芍凉血化瘀，炙白前、牛蒡子宣肺利气，陈皮、远志温化痰浊，炙百部温涩止咳。综观全方，药味不多，且药无特殊，以辨证准确用药精当而获效。^[30]

30. 孟景春诊治经验

咳嗽之证，原因固多，然而木火刑金之咳者亦不罕见。孟氏认为这种咳嗽多因肝火犯肺所致。因肺主宣降，肝性升发，一升一降，相互制约，相互协调；一旦肝火上炎，肝升太过，可致肺失肃降，气逆作咳。其辨证要点是：呛咳阵作，痰少而粘，常以早晨为重，或干咳无痰，并伴有咳则胁痛，或不能左卧。肝火犯肺，每易灼伤肺阴，所以对这种咳嗽的治疗，须以清泻肝火为主，同时配以滋养肺阴之品。俾肝火得清则病本可除，肺阴充足则肃降乃复。清肝火常用黛蛤散、桑叶、菊花。黛蛤散既能清肝，又能化痰肃肺；桑、菊能疏散风热，亦能清肝肃肺。养肺阴常用南北沙参、麦冬之类。痰粘者加川贝、瓜蒌，口渴者重用北沙参，加芦根、天花粉等。

如治张某，女，30岁。咳嗽2月余，咳呛阵作，少而

粘，有时见绿色稠痰，咳则胸胁疼痛，口渴欲饮，舌质红、苔薄黄，脉弦细。证属肝火犯肺，肺阴受灼，清肃失司。治拟清肝养肺止咳。处方：黛蛤散（包）15g，桑叶10g，黄芩6g，南沙参12g，大麦冬12g，炙紫菀10g，川贝5g，瓜蒌皮10g，芦根15g。服药7剂后，咳嗽、胸胁疼痛均减，唯口渴较甚，原方去川贝，加北沙参12g，天花粉10g，再服7剂告愈。此外，还有肝阴亏损、肝血不足而致肝火旺者，则以一贯煎加减，并加用白芍、甘草等柔肝养肝，疗效亦较显著。^[31]

31. 姜春华诊治经验

姜氏治疗咳嗽，经验丰富。常用方法如下：

解表清肺法：用于风寒外束，肺有痰热证，方用麻黄汤易杏仁为大贝。杏贝同有祛邪化痰止咳之功。但前者苦温，后者苦寒，故肺有痰热选用大贝，并加黄芩清肺热。

宣肃并进：外邪内郁，肺气上逆，非宣肺则外邪不去，非肃肺则肺气不降，故以麻黄、前胡宣肺祛邪，杏仁、瓜蒌仁肃肺降逆，加枳实宽胸。

清泄痰热：凡属痰热恋肺之证，姜氏最喜用胆南星。并认为猪胆苦寒，南星辛温，两者配合，苦寒抑制了辛温作用，对痰热所致之咯痰不爽者有效。其次为全瓜蒌、蛤粉、竹沥、天竺黄等药物。

润肺止咳：凡咽喉干痒作咳，或痰粘成丝、咳而不爽，或干呛无痰，不分急慢性咳嗽，都可用清凉滋润药。百部、千日红为其常用止咳药，尤其新鲜百部止咳效果最好。考百部温润不燥，有开泄降气作用。据现代药理研究，百部对呼吸道及肺部的多种病菌感染有抑制作用，能抑制流行性感冒病毒，能保护支气管粘膜，降低呼吸中枢的兴奋性，

有助于抑制咳嗽反射。

温肺纳肾：《景岳全书》谓“肺为气之主，肾为气之本”。若见患者久咳畏寒肢冷，且喘鸣气急，为肾不纳气之象，故以黑锡丹、坎脐、附片温肾纳气。又见痰多泡沫清稀，肺寒伏饮明显，故可用小青龙汤加减以温肺化饮。

补中止咳：若患者中气不足，外邪乘肺客咽而致咳嗽，治宜补中止咳。方用补中益气汤加减。姜氏常用止咳药物为马勃，有云：“民间单方将马勃研细粉置盆中，以冰糖烧溶滴入成珠含咽，也可研粉作丸含咽，或入煎剂，原治一二十年老咳嗽，对新咳嗽也有效。”

和胃化饮：《金匱要略》谓：“病痰饮者当以温药和之”。若见咳嗽而泛恶清涎，乃病在胃。盖脾阳不振，水饮内停，随咳嗽而上逆也。方用二陈汤和胃降逆，配干姜温阳化饮。五味子也是姜氏常用的镇咳平喘药，认为五味子内伤外感都可用。前人认为五味子味酸收敛，若外邪在肺，则邪被收敛不得发散。而小青龙汤五味子配干姜，干姜辛散，一收一开则无碍。据现代药理研究认为，五味子有良好的抗应激作用，能增强机体对非特异性刺激的防御能力，增强肾上腺皮质功能，能影响糖代谢，加快肝糖原分解，提高血糖及乳酸的水平，所以是强壮药，同时又有较好的镇咳祛痰作用，因此对年老久咳的患者，扶正止咳一举两得。

扶正固本：肾为气之根，肾阳衰微，则气无所主，势有暴脱之变，故主以温肾壮阳之品，并加肾蛤散等扶正固本。

宁肺截咳：姜氏认为，治久咳宜采取宁肺截咳法，一则从速平患，二则慎防他变。故用苏子、莱菔子、款冬花下气止咳。木蝴蝶、天浆壳及南竹子为姜氏喜用的截咳药

物。其云：“天浆壳、南竹子两者，民间用于百日咳。我认为可以推广使用于诸般咳嗽，尤其阵发性咳嗽，疗效良好。南竹子成人用量不超过 6g，天浆壳用 3 只。”

益气养阴：适用于气阴两虚之咳嗽，治取益气养阴，不治咳而咳自止。

补肺宁络：支气管扩张反复咳嗽咯血，属肺虚气弱，络损血溢，治宜补肺宁络。姜氏曾创百合片（白及、百合、百部、麦门冬、天门冬、丝瓜子）治疗本病，临床疗效显著。白及为主药，有补肺止血作用，据药理实验结果，白及的水浸出物，对实质性内脏器官、肌肉、血管出血，用覆盖创面的方法有良好的止血作用。

清肝护肺法：治疗咳嗽咯血属肝气郁而化火刑金，症见：面红目赤，咳嗽并咯血，剧咳时胸胁疼痛，伴咽干，舌红、苔黄而干，脉弦。证属木火刑金，治宜清肝护肺。药用牡丹皮、栀子、木蝴蝶、黛蛤散、百部、全瓜蒌等。方中牡丹皮、栀子、木蝴蝶及黛蛤散泻肝火为主药；海蛤壳化痰；百部与全瓜蒌化痰润肺。姜氏的经验认为，百部为良好的止咳药，内含百部碱，能降低呼吸中枢兴奋，抑制咳嗽反射，而奏止咳之效。^[32]

32. 蒋天佑诊治经验

蒋氏认为肺与心、脾、肾关系密切，互为母子之脏，临床上子病及母、母病及子、母子同病者，屡见不鲜，治当求诸于本。

如治苗某，女，60 岁。咳嗽、咯痰 8 个多月，病起于胃痛后。诊见：咳嗽频作，咯痰白粘，痰量日达 30ml，口干且苦，后背怕冷，恶冷饮食。舌质红、苔薄白，脉左沉细、右弦滑。胸透：肺纹理增重。诊为咳嗽，证属肺脾虚

寒，痰壅于肺。治宜温肺健脾，化痰止咳。选温肺止咳方（经验方）加味。处方：炙黄芪 12g，炒山药 15g，桃仁 9g，红花 6g，炙款冬花 30g，炙紫菀 30g，炒白芍 6g，干姜 3g，白芥子 15g，炒黄芩 10g。4 剂，每日 1 剂，水煎 2 次早晚分服。服药后咳嗽平，痰量减半，上方加胆南星 15g，再进 6 剂，病愈。

胃属土，肺属金，正常时，胃土生肺金，肺气充沛，邪无由入侵。胃病肺金失养，肺气索然，外邪乘虚而入，“肺如钟，撞则鸣”，咳嗽乃作。胃失运降，痰涎由生。治疗上，一方面温肺健脾胃以治痰嗽之本，另一方面化痰止咳以疗痰嗽之标，标本同治，收效故捷。^[33]

33. 原明忠诊治经验

急性咳嗽是指外邪客于肺系，致肺失清肃而产生的咳嗽病证。包括内有伏饮而感受外邪的新咳在内。临床上大体分为风寒客肺、风热客肺、燥邪伤肺三个证型进行论治。

风寒客肺证：由风寒之邪客于肺卫，致使肺失清肃，气逆而成。症见：喉痒咳嗽，咳白痰或无痰，鼻塞喷嚏流清涕，脉浮缓或浮弦。治宜宣肺化痰，方用加减杏苏汤：苏叶 10g，橘红 12g，半夏 10g，茯苓 9g，桔梗 15g，紫菀 15g，杏仁 12g，麻黄 6~9g，前胡 12g，百部 10g，桑白皮 12g，甘草 9g。水煎服。若见恶寒发热，去苏叶，加柴胡 15~20g，葛根 15g。若见喉痒甚，咳急不止，咽颚发红，但咽干不甚，宜宣肺清喉止咳，方用射干麻黄汤：射干 15g，桔梗 15g，麻黄 6~9g，款冬花 9g，紫菀 9g，百部 9g，半夏 9g，干姜 3g，细辛 3g，五味子 3g，水煎服。勿因咽峡发红而畏用。

风热犯肺证：由风热之邪客于肺系，或由风寒客肺郁

而化热所致。轻证者咳嗽吐白粘痰，鼻咽干，咽红，舌尖红苔白薄，脉多浮。治宜宣肺清热，方用宣肺止咳汤：桔梗 15g，杏仁 12g，生石膏 20～30g，麻黄 6～9g，百部 10g，桑白皮 10g，款冬花 10g，紫苑 15g，甘草 9g。重证者若见发热恶寒，咳吐黄痰或稠粘痰，舌质偏红，脉数，治宜清肺止咳，方用麻杏银翘汤：麻黄 6～9g，生石膏 30g，杏仁 12g，百部 12g，连翘 30g，金银花 30g，甘草 9g，黄芩 20g，桑白皮 10g，水煎服。宜早、午、晚各服一煎。即每日服 1 剂半。

燥邪伤肺证：多由秋季气候干燥或由工作环境干燥，燥邪灼伤肺阴所致。症见：干咳无痰，甚至可咯出鲜血少许，口干咽燥，鼻孔干燥，甚或咽痛，舌质偏红、苔薄白少津，脉多沉缓或弦。治宜润肺止咳，用润肺止咳汤：天冬 15g，麦冬 15g，知母 15g，川贝母 9g，桑叶 15g，黄芩 15g，橘红 12g，甘草 10g，枇杷叶 12g，杏仁 12g，水煎服。若咯血者加侧柏叶 12g，白及 10g；若仅有干咳、咽干，而无其他症状，舌苔亦无异常者，宜用养阴清肺汤加减：生地黄 20g，玄参 20g，麦冬 15g，贝母 10g，白芍 10g，牡丹皮 9g，甘草 9g，麻黄 3～6g，杏仁 12g，枇杷叶 12g，百部 12g，桑叶 15g，水煎服。^[34]

34. 刘绍武诊治经验

急性咳嗽多由外邪侵袭，致肺失宣肃，遂咳逆上气。治疗之法当别其寒热，予以宣肺止咳。风热咳嗽为患最多，症见咳痰不爽，色黄粘稠，发热恶寒，头痛口渴，舌尖红，脉浮数。此风热在表，肺气失宣，而见咳逆。治宜辛凉表散，宣肺止咳。方用自拟葛根麻黄汤加祛痰止咳之品，药用葛根、麻黄、杏仁、甘草、生石膏、瓜蒌、桔梗。方中

麻黄伍石膏则变辛温之性为辛凉之用，且能使麻黄发汗有制，使表得解而咳得止。若素日气虚，心悸短气，或脉见促结者，则麻黄又不当轻用，常易以苏叶。若兼见咽痛者，加山豆根以利咽解毒。若咳喘痰稀而色白，甚则干呕，咳唾涎沫，寒热头痛，舌苔薄白，脉浮，证属太阳厥阴合病而兼太阴。治当解表温里、化痰止咳，可与小青龙汤。方用桂枝、麻黄、干姜、细辛、五味子、半夏、甘草、白芍。若烦热者，与小青龙加石膏汤。

若咳嗽迁延数十日，甚至经月不愈，症见咳而胸满，咯痰不爽，甚或心悸气怯，病邪稽迟，正气已伤。斯时也，正气不济，无力退邪，亦无明显之寒热见症，单纯退邪则使正气更加不支，过用补益，又会使病邪胶固，当用协调疗法，与调肺汤（自拟方）。药用柴胡、黄芩、苏子、党参、麻黄、杏仁、生石膏、甘草、川椒、瓜蒌、桔梗、沙参、五味子、大枣。若喉中痰鸣如水鸡声者，合入葶苈大枣泻肺汤。此方对宿有咳喘疾患，合外感转甚者亦有显效。若脉象细数，或无力、或结代者，当去麻黄，易以苏叶。^[35]

35. 郭贞卿诊治经验

治疗咳嗽，不得专以止咳为能事，不消除致咳因素，徒用止咳之剂，则不仅收效不大，甚至反有留邪碍肺、延长病程之弊。但是不用止咳之剂，亦终非治咳善法。治咳要抓住三个要点，即升降、开阖、出纳。其中，升、开、出为散，降、阖、纳为敛。新咳多为外感所致，当以散为主，敛为辅；久咳多为内伤所致，当以敛为主，散为辅。同时，二者皆要注意祛除邪气和与止咳药有机配合，这是治疗咳嗽的总则。

外感引起的咳嗽有表证者，乃肺气不能通达表皮，郁于肺，引起气机不能宣达皮表而咳嗽，此为外邪在表的咳嗽，当以解表宣肺为主，其他如降逆、止咳等治法处于从属地位。感冒风寒者，寒邪外束，皮毛闭塞，肺气失宣，开阖失职，发生咳嗽，临床多见喉痒、鼻塞、声重、恶寒身痛、发热无汗等，当以辛散为主，宜麻黄、紫苏叶、陈皮、枳壳、桔梗之属，还宜适当配合前胡、杏仁等清降之品。在咳嗽时，只要有上述表寒见症，无论是急性或慢性支气管炎发作，还是肺气肿、肺心病，均与宣肺解表，待表证罢，再议治本。支气管扩张，原则上是清肺润咳、通络止血，如果是外寒引起复发，或发作时受寒，在咳嗽胸痛吐血的同时，有明显的表寒见症，亦当宣发肺气，否则肺气不宣，咳呛不已，肺络不宁，吐血胸痛亦难望其缓解。风热犯肺者，肺失宣畅，则咳嗽不畅，喉痒、痰稠或痰色发黄，可见咽红喉痛、恶风发热、头痛等表证，舌苔薄黄或薄白，脉浮数，治当疏风清热，宣肺化痰，可选用桑叶、薄荷、牛蒡子、前胡、杏仁、桔梗等。

外感引起的咳嗽无表证者因病变部位已离肺卫而进一步深入，故治疗须重视升降。一般而言，热邪当重清降，寒邪须重温升。热客于肺，清降失职，多见咽喉不利，苔黄，脉数，咳则连声有力，痰鸣气急，甚至不得平卧，治以清热降肺为主，佐以宽膈祛痰。药用桑白皮、黄芩、葶苈、杏仁、前胡、瓜蒌壳、金银花、芦根、冬瓜仁、鲜竹茹之属，不可妄用升散之剂。有时热邪不在肺部而在气道，出现鼻干涕稠，咽中不舒，喉间有痰不易咯出，喉部燥痒，咳呛不已，咽喉肿痛，则宜着重加用射干、山豆根、马勃、薄荷、蝉蜕、马兜铃之类以清利咽喉。另有咳嗽不已，兼见苔腻胸闷，食少腹胀，则属于痰浊上逆之证，宜用温胆

汤加白豆蔻、杏仁、薏苡仁以化湿降浊，肺气始得清降，而清润药又当禁用。外感寒邪的咳嗽往往呈现表证，入里化热者多，而里寒无表证者少，由于有一分恶寒便有一分表证，因而由寒邪所致的外感咳嗽，多有不同程度的表证，其方剂如杏苏散、金沸草散、小青龙汤等，都兼解表宣肺药。所以寒邪犯肺，当以温升为主。

内伤咳嗽，远非一般清痰降气散寒可愈。当辨虚实、标本，治虚勿忘实，祛邪当顾虚，在扶正治本而不碍邪的情况下，可用补养方药。治湿痰以燥湿祛痰为主，治痰饮当温阳涤饮为要。若仅知祛痰、涤饮，忽视生痰聚饮之源，痰饮则难除，临床上常从肺、脾、肾着手，培补脾肾治其根本。而内伤咳嗽起病缓慢，病程久长，虚为气血、阴阳，实为痰饮、瘀血。病变部位有肺脾肾之别。如久病体弱咳嗽，兼有食纳减少，腹胀便溏，泛涎不已等脾虚见证，应多从培土生金考虑，常用香砂六君子汤加味以健脾摄饮，形不足者加人参、紫河车。内伤咳嗽多见痰湿咳嗽，肝火犯肺，痰阻心肺，且咳嗽多有咳喘并作，易出现心阳不振、饮邪上凌、肾不纳气等证，此时调其出纳就更为重要了。^[36]

36. 陈存仁诊治经验

①温凉并祛风邪：风邪外袭，内舍于肺，清肃失职，气逆而致咳嗽，临床最为常见。症见咳嗽喉痒，鼻塞声重，头胀流涕，微感恶风等。兼寒者恶寒无汗，痰多清稀；兼热者口渴咽痛，痰多黄稠，苔薄白或薄黄，脉浮紧或浮数。治宜解表宣肺，一般均分别使用辛温或辛凉之剂。但陈氏注意到“肺为阴脏，其性娇，其质寒”的特点，从罗天益黄芪鳖甲散治肺癆咳嗽发热，于大队桑白皮、地骨皮、天

冬、知母等清肺药中，加入一味肉桂以温肺，得到启发。在应用辛温宣散时佐以辛凉，辛凉宣散时佐以辛温，温凉并用，相辅相成，大得治肺之妙谛。常用药物如前胡、象贝、化橘红、荆芥穗、旋覆花、苏子、炙紫菀、炙款冬花、瓜蒌皮、海蛤壳、杏仁之类。挟湿加清水豆卷、佩兰梗；挟热加天花粉、黄芩；挟食加神曲、莱菔子；气逆加代赭石、清炙枇杷叶等。

②侧重宣肺治湿热：脾湿胃热，蕴酿成痰，上渍于肺，则发为咳嗽。症见咳喘痰稠，色黄而粘，胸闷口渴，或渴不欲饮，小便短赤，大便或溏，胃纳不振等。治宜清化湿热，为人所共知。但陈氏擅用清宣肺胃之法，尤其注重宣肺。盖“肺主一身之气，气化则湿亦化也”，湿化则热自孤而易清。每取吴鞠通之三仁汤，师其意而不泥其方。常用药物如清水豆卷、杏仁、薏苡仁、瓜蒌皮、冬桑叶、神曲、赤茯苓、车前子、佩兰叶、淡黄芩、碧玉散之类。有表证加荆芥穗、前胡；热重加天花粉、黑山栀子；痰多气喘加青礞石、代赭石等。

③温阳肃肺化寒饮：《内经》云：“太阴之胜，……独胜则湿气内郁，……饮发于中”。指出水湿过盛，脾阳失运，乃是产生痰饮的根本原因。饮之为患，或留于肠胃，或阻于胁下，或溢于四肢，或上犯胸中，甚至波及五脏。其犯肺者，往往以喘咳为主要症状。症见咳嗽气急，甚则难以平卧，胸中窒闷，甚则胀痛连胁，痰多泡沫，色白量多，面目浮肿，遇寒即发，得暖稍减，苔白而腻，或中见淡灰，脉多弦紧，或呈弦滑。治宜“温药和之”，遵《金匱》之旨。每用温阳肃肺之法，取旋覆代赭汤加减，尤喜佐礞、磁之降，术、附之温，标本兼顾，屡奏殊功。常用药物如旋覆花、代赭石、熟附片、炒白术、姜半夏、炒苏

子、青礞石、灵磁石、鹅管石、炙紫菀、炙款冬花之类。有表证加麻黄、苏叶；肺寒较甚加炮姜、细辛；脾弱不运加焦神曲、焦山楂肉；咳痰不爽加海蛤壳、瓜蒌皮；气机不利加菖蒲、橘红；气虚加党参、黄芪皮；命火式微加补骨脂、桂枝；腰膝乏力加杜仲、续断。

④清润理气疗肺虚：肺为娇脏，易受邪侵。若风邪久客，肺阴受伤，或内伤阴亏，虚火灼金；或癆虫传染，蚀伤肺阴，皆能导致清肃失职，肺气上逆而为咳嗽，且缠绵难愈。症见于咳晨剧，多属阵发，或痰吐粘稠，多少无定，或痰中带血，时时咳出，胸膈牵痛，急躁易怒，潮热盗汗，咽干口燥，失眠多梦，消瘦乏力，男子梦遗，女子经闭等，舌质红绛，脉细数。治宜清火润肺，是为常规。而陈氏复佐以理气之品，尤为独到。盖金燥宜润，火炽须清，故投以清润之剂。然阴柔之性，势难速效，已逆之气，亦非其力所能调，惟有配伍理气之品，如菖蒲、枳壳之类，始克有济。且凝静之中杂以流动，不粘不滞，其作用可得尽力发挥，故取效远较单纯使用一法者为优。常用药物如鲜沙参、麦冬、生地黄、阿胶珠、瓜蒌皮、旋覆花、炙紫菀、炙款冬花、鹅管石、海蛤壳、石菖蒲、枳壳（实）之类。外感风寒酌去清润之品，加清水豆卷、荆芥穗、蝉蜕、化橘红等；午后潮热加柴胡、青蒿梗、白薇、板蓝根；夜间盗汗加浮小麦、糯稻根须；梦遗失精加白莲须、金樱子、龙骨、牡蛎；痰中带血加银花炭、地榆炭、黑山栀子、茜草根；失音喉痹加胖大海、桔梗等，并外吹金不换或锡类散；久嗽邪少虚多可酌加米壳、五味子等。^[37]

37. 郭振球诊治经验

老人咳嗽，病原不一。或云有声无痰为咳，有痰无声

为嗽。其实咳可单见，嗽必兼咳。咳咳连声而无痰应者有之；若嗽之有痰者，必由于咳。痰乃随咳而出，所以嗽必兼咳。若无声而痰出者为痰饮。或从呕出，或从唾出，名为呕吐痰涎，并不是“嗽痰”。呕吐之痰，其痰在胃，从咽而上出；若咳嗽之痰，其痰在肺，咳时则痰随咳而上，从喉而出。可见痰在内，有脏腑之不同；痰之上出，有咽喉之各异。至于干咳证、咳嗽病，外感内伤皆有之。而咳证又以内伤最多，或气实胀满而为咳；或火盛灼金而为咳；或水不养津而为咳；或外感内滞而为咳；或水冷金寒而为咳；或脾虚肾虚而为咳。咳虽同而咳之因又不相同。

气实胀满而为咳者，症见胸胀气粗，咳咳连声，唯大呵长嘘为快，脉滑有力。治宜二陈汤加葶苈、苏子、枳实、桔梗、槟榔以降气。然气有余便是火，必佐桑白皮、知母、杏仁以清润其肺。

火盛灼金而为咳者，脉必洪大，体必烦躁，或口渴喜冷饮；或夜重而昼轻。治宜泻火以保津，火降而咳自宁。宜用清燥救肺汤。甚者可加酒炒大黄以泻之。此乃“泻肺热必须引大肠”的缘故。又有阴虚火盛灼金的咳嗽，脉亦洪大，体亦烦躁。日间阳浮于外，咳嗽颇轻；夜间阳伏于内，其咳必甚，或口渴喜饮，大便硬，小便黄。治宜滋阴降火，用知柏地黄汤，或玄麦地黄汤，或百合固金汤。

水不养津而为咳者，其证由渐而起。或久泻、久汗伤阴，引起肾水干枯，水亏于下，不能上腾以润肺，致令肺金失养而燥。症见：时时发咳，不胸胀不气粗，但食物喜润，肤色不润泽，肌肉消瘦，脉滑或大而无力的，口虽渴不喜冷饮。治宜滋补真阴。以左归饮、小营煎加阿胶主之。

外感内滞而咳者，乃因风寒外闭，内气滞逆。症见：发热头痛，或鼻流清涕，治宜发散外邪，兼利其内，外解

则内自舒。宜人参败毒散、参苏饮、止嗽散之类，择而用之。

水冷金寒，阴气射肺而为咳者，与肾虚水泛为痰，同属阴虚类型。水泛为痰者，乃肾中之阳亏，化水之力减弱，若阴气射肺者，为肾中阳气大亏，只能化水下趋，毫无上腾之力，肺虽喜润泽，宜温润清和，下焦之阳气既亏，不能胜阴，而阴气必致上冲射肺，以致咳逆，因其津不上腾，故无痰应而成干咳。此证阳气大损于下，熏蒸无力，致脾胃亦亏，饮食大减。治宜桂附理阴煎温补下焦，加葫芦巴、补骨脂祛阴寒而纳射肺之阴气；更宜加益智仁以解阴凝之滞逆。但得元阳健旺，阴气自降，肺脏自宁，咳必自愈。

脾虚饮食化痰而为咳嗽者，必色淡神倦，脉濡，饮食日减，或腹虽饥而不能多食，或食后而反作饱，咳嗽痰多，痰色或清或白。六君子汤、参苓白术散、寿脾煎之类，随证选择而用。而肾虚水泛为痰而成咳嗽者，其证于脾虚证相近，不同点在于脉象。脾虚者脉大而无力的，间有不大者，亦不微细，或浮而濡软。肾虚者脉必细小而沉，此乃下焦元阳亏弱，化水之力减常，不能尽化入膀胱，反上泛而为痰。治宜补阴中之阳，壮气化水，使痰下趋膀胱，宜用肾气丸及右归饮之类。脾肾俱虚而成咳嗽者，治宜双补脾肾，用理中汤合理阴煎加减。^[38]

38. 苏万方诊治经验

①泄胃热，勿令苦寒伤中：苏氏认为咳血总因肺热络伤，实证尤与肝、胃二脏关系甚大。胃热者，又为平素嗜食辛辣煎煨之品，烟酒过度，以致胃中积热，上熏于肺，迫血妄行。故肺胃热盛，宜用清泄。用药关键在于咳血色鲜红、齿龈肿痛、口臭、大便秘结等证。基本方：桑白皮、

黄芩、地骨皮、生石膏、鲜生地黄、生大黄、黄连。尤以大黄治疗咳血用之得当功效卓著。但不宜滥用，慎防戕伤脾阳，攻伐五脏生气；耗伤阴津，冰伏血瘀等后患。曾治一男性患者刘某，26岁。素患慢性咳嗽，嗜烟酒。2日前酒后，腕部胀闷不适，情绪急躁，下齿龈肿痛，大便不畅。次日见发热咳嗽，咳吐鲜血，面色潮红，口唇干燥，并有臭味，咽红充血，舌质红、苔黄腻，脉数。X线胸透示：两肺纹理增粗。处方：桑白皮 12g，鲜生地黄 12g，黄芩 12g，地骨皮 12g，生石膏 30g，侧柏叶 30g，丹皮 10g，生大黄（后下）6g，黄连 6g。4剂药后热退血止，大便通畅，黄腻苔渐化。再以养胃清热收功。本例系一派肺胃热盛之象，故投清泄之品见效。继予养胃清热，以保胃气。因胃气为脏腑气血之本，胃气健旺则纳运有常，湿化热清，冀渐康复。

②泻实火，尤当滋阴柔肝：实火之咳血，乃肝、胃之火上犯。肝火上犯，多见易躁易怒，呛咳阵作，胸胁疼痛，咳血满口，较胃火为多见。苏氏习用苦寒直折其火，用药除防败伤脾胃，必佐滋阴柔肝之品。缪仲醇有“养肝则肝气平，而血有所归，伐肝则肝虚不能藏血，血愈不止矣”之训。基本方：龙胆草、制大黄、黑山栀、丹皮、黛蛤散、白芍、生地、麦冬。火盛配黄连、黄芩；挟瘀伍三七、茜草炭。如治刘某，男，53岁。慢性咳嗽2年。1周前因发热咽痒，咳出大口鲜红色痰血。经用西药治疗，虽发热咽痒已除，咳血一度控制。但2日前又因心绪烦扰，胸闷气急，大汗淋漓，咳出满口鲜血，咳血时左肋隐痛，易躁易怒，气急汗出，舌苔薄黄，脉弦。证属肝火犯肺，灼伤脉络。拟泻肝清肺。处方：龙胆草 10g，丹皮 10g，黑山栀 15g，侧柏叶 15g，川芎 6g，生地黄 12g，制大黄 12g，白

芍 12g, 黛蛤散 (包) 12g, 白茅根 30g, 三七片 9 片 (分 3 次吞服)。3 剂药后, 咳血顿挫, 1 周后症状稳定。苏氏认为, 肝火犯肺, 常为本虚标实之体; 急当治标, 直折其火, 缓则治本, 滋水涵木。大黄制用, 入血分, 祛瘀止血。佐地、芍滋阴柔肝, 慎防伐肝。^[39]

39. 曹余德诊治经验

曹氏认为咳嗽一证, 虽非大病, 但治不得法则缠绵难愈。无论外感或内伤咳嗽均属肺系受病, 肺气上逆而致咳, 因此治疗咳嗽, 首当治肺。历代对咳嗽的分类名目繁多, 但曹氏认为不必拘泥于分类。因为治疗过程中, 常常会出现寒证化热, 虚中挟实等变化。故临证应辨清寒热虚实, 随证施治。并提出了治疗咳嗽的四个步骤: 宣通、疏理、清肃、润养。大凡咳嗽经过此四步治疗, 可基本治愈。

①宣通肺气, 首举麻黄: 曹氏认为外感咳嗽或慢性咳嗽加剧, 均乃感受外邪所致。外邪客于肺中, 肺气失宣而咳嗽。每见鼻塞流涕, 咽痒欲咳, 咳而不畅, 咳甚胸痛, 痰稠粘附, 咳咯不爽, 此外邪郁结肺中, 阻塞肺气宣通。治疗当先宣肺, 肺气宣通, 方可驱邪外达。宣肺首推麻黄, 曹氏主张用宣散力强之生麻黄, 麻黄虽性温, 但无论寒邪、热邪均可使用, 不必顾忌, 关键在于配伍。风寒以三拗汤, 风热以麻杏石甘汤为基本方, 酌加桔梗、枳壳, 一升一开, 通达气机; 前胡、桑白皮辛散苦降, 宣通肺气, 瓜蒌皮、枇杷叶、芦根止咳化痰, 清热生津。对于要求服成药者, 也在用罗汉果糖浆的同时, 加用单味麻黄煎水冲服, 以增强宣散之力, 简便有效。

在外邪未清之前, 曹氏不主张用敛镇之剂, 强止其咳。临床上常碰到一些数月咳嗽不愈之患者, 此多为过早服用

了西药镇咳剂与抗生素之故。抗生素可能属寒凉性质，寒凉药与敛镇之剂可阻遏肺气的宣通，不能使邪外达，纵然暂时见轻，也常反复，终不能治彻。主要原因是闭门过早，贼未驱走。更不能认为久咳属虚，而妄投补益之剂。理应先开门而后驱邪，必须用麻黄宣通肺气，才能因势利导，则咳嗽可除矣。

②疏理气机，小柴胡辈：小柴胡汤出自《伤寒论》，虽为少阳证之剂，但临床应用范围甚广。曹氏认为小柴胡汤能和解少阳，解半表半里之邪。咳嗽一症，若经宣散，表邪未解，咳嗽仍作，伴有胸胁苦满，隐痛口苦者，除需续用麻黄之剂宣散外，可配小柴胡汤疏理气机，以解胸中痰气郁结。方中柴胡、黄芩一疏一清，既可疏通气机，又能清透解表；人参可用太子参代，扶正攘外；半夏、生姜与黄芩同用苦辛通降，可宣通气机，消痞除满。通常经过宣通、疏理后，则肺气得以宣畅，咯痰畅快而咳嗽减少，胸痛肋胀顿觉舒畅。

③清气肃肺，止嗽加味：曹氏善用止嗽散加味以清气化痰，肃肺止咳。程钟龄的止嗽散中，既有桔梗之升，又有白前之降；既有荆芥之辛散，又有紫菀、百部之润收。临证若见喉燥咽痛，咳吐黄痰，舌质偏红、尖有红点，此乃风邪化热，热伤肺津。在止嗽散的基础上加石膏、知母、黄芩清肺泻热；桑白皮、瓜蒌皮、冬瓜子清化痰热；加沙参、天花粉、芦根清热生津。

曹氏在舌诊方面有其独行的经验。临证中除观察舌质舌苔的变化外，十分注意有否红点、瘀斑及其分布位置，舌下静脉充盈曲张等。若舌尖见有红点，这是蕈状乳头充血的表现，可作为外邪化热的标志，表示肺经有热。若舌质黯兼有瘀斑，舌下静脉粗胀，属血瘀现象。但在咳嗽一

症中，除血瘀外还有气郁的现象，为气机不畅，痰气郁结所致，治疗上除用活血药外，可酌加疏通气机之品。

④润肺养阴，善用生脉：临床经常可见一些咳嗽延绵不休，又易感受外邪，病根较深，难取速效。其咳嗽特征为干咳无痰或少痰，咳声短促，此乃肺阴耗伤，肺气虚弱所致。曹氏认为此时不宜再用宣散之品，以防更伤其正。治当滋润肺阴，敛养肺气，甚则补肾纳气。并十分赞赏生脉散，认为生脉散虽仅三味，气阴两面均能顾及。人参大补元气，若无可以太子参代，如需偏重补阴，可与南北沙参同用；麦冬养肺阴，润肺止咳；五味子能敛肺气，又能纳肾气。若痰少不畅可加杏仁、川贝；肺热加黄芩、知母；阴虚加玉竹、天花粉。^[40]

40. 赵绍琴诊治经验

①重声痰之辨，以明六淫所因：外感咳嗽临床颇为常见。但若施治不当，易使病情延误，或变生他证。赵氏认为声痰之辨是重要一环。根据咳嗽的声音与痰的情况，则易分辨所感为何邪。风寒咳嗽咳声多重而有力，气急欠平，痰少色清或白；风热咳嗽咳声多频剧，气粗，或咳声嘎哑，痰稠而粘或白或黄；暑湿咳嗽咳声闷而不畅，咳嗽似喘，痰多而稀；风燥咳嗽多干咳而频作，连声作呛。风寒兼痰湿则多有痰鸣，痰稀如涎；风热化火成火热咳嗽，则以呛咳、阵发为特点，咳声响亮而脆，咳痰黄稠或白粘；外寒而内热的寒包火咳嗽，则咳声重浊有力但不畅，气急而痰粘，且鼻多流清涕。大凡咳嗽声重浊而不扬的多是肺气不宣；咳声低微而不扬的多是肺气不足；暴咳音哑的多是肺实，即“金实无声”；久咳音嘶的多是肺虚，名为“金破不鸣”。虚人外感咳嗽，咳声多轻而频，其痰或多或少，或稠

或稀，各有不同。

②舌脉并重，以辨病机兼夹：赵氏治病尤重脉学，于外感咳嗽的治疗也重舌象，舌脉并重是其特点。如风寒咳嗽，脉多浮紧或浮缓，脉紧多为寒邪重，而缓则为风邪偏重，舌苔多薄白。但临床每有兼夹，且与病人的体质有关系，内兼痰湿脉多或弦或滑，舌苔多白腻；内兼食积，脉兼滑象，舌苔多厚腻；风寒化热，脉多数按之弦滑有力；虚人感风寒脉浮按之力弱。风热咳嗽，脉多浮数或滑数，舌边尖红苔薄白而干或白或黄；若化火则脉多弦滑且数，舌红边尖起刺，苔白浮黄或干；痰热郁滞不化，则脉弦滑数按之有力，舌红苔黄腻。暑湿咳嗽，多见于夏月暑盛湿重之时，脉多濡或滑，舌苔多白腻；兼有寒湿不化，脉多沉滑或濡软无力沉取细滑，舌苔多白腻而润。风燥咳嗽多见于秋凉时节，脉多浮或弦或细，舌苔多白而干；凉燥脉多弦，舌淡苔白且干；温燥脉或洪或数，舌边尖红苔白干或黄。若因风热化火化燥，则脉多弦数，舌红苔干或黄。

③立法处方，注重因势利导：咳嗽之病因虽多，但总离不开肺，肺主气，有宣发和肃降的功能，肺气失宣或肃降失司，都会引起咳嗽。由于肺本身的功能特点，以及外感咳嗽之病邪因素，治疗外感咳嗽赵氏力求因势利导，调肺气，祛外邪，使肺之宣发、肃降功能恢复正常，用药强调轻灵宣气。风寒咳嗽以疏风散寒为主，寒去风散肺气宣则咳自止。常用药：苏叶、苏子、紫菀、前胡、象贝母、杏仁、枇杷叶、羌活、陈皮等。风寒重，体痛脉紧，加用少量麻黄、桂枝；化热，脉按之数而有力，加旋覆花、芦根、炒牛蒡子；痰湿中阻，加干姜、细辛、茯苓；素体气虚者，加党参、白术；兼有食积不化，加保和丸、焦三仙。风热咳嗽重在疏风清热，但需防凉遏。常用药：桑叶、前

胡、杏仁、茅根、芦根、象贝母、黄芩、连翘、薄荷等。并可适当加用苏叶、防风、炒牛蒡子、桔梗、炒山栀子等。风热重脉滑数有力，可加生石膏、瓜蒌、大青叶；化火痰稠，去桑叶、薄荷，加知母、桑白皮、地骨皮、黛蛤散等。暑湿咳嗽化湿清暑最为要紧，而关键在于化湿，湿去热退，肺气自调。常用药：藿香、佩兰、苏叶、半夏、陈皮、厚朴、杏仁、竹叶、竹茹。表湿重加羌活、独活、海风藤；热重加黄芩、黄连、茅根、芦根、西瓜翠衣；湿重脉濡软，舌胖苔白腻根厚，可加用苓桂术甘汤；中气不足，加太子参、生黄芪。风燥咳嗽疏风润燥最合理，其凉燥用温润，温燥用凉润。常用药：南北沙参、川贝母、桑叶、杏仁、淡豆豉、山栀皮、鲜梨（去核连皮切片）、炙枇杷叶等。若为凉燥，可加苏叶、防风；温燥可加菊花、茅根、芦根等。外感咳嗽，初期病在肺卫，按卫气营血辨证，病多在卫分，不解则入气营，治疗既不可用过用辛温发散之品，也不可寒凉太过。从临床上来看，用过辛温发散之药者固少，但早用、用过寒凉之品却不少，以致寒凉过度，气机郁滞，或中阳被伤，最后还得用升散轻疏，或温经散寒、宣气化痰之剂收功。对于寒包火之咳嗽，内有郁火，外束风寒，热郁不解，发热恶寒，口干唇燥，咽红且痛，或遍体痛，舌红苔白，脉浮紧，沉取弦滑有力且数，临床也不少见，其治疗宜疏风散寒，还要开郁泄火，可用辛苦寒法，辛温、苦寒、辛寒并用，升降散加苏叶、前胡、炒牛蒡子、瓜蒌、黄芩、连翘、淡豆豉、炒山栀子、白茅根、芦根等。

④饮食起居，也当慎重：病在肺，肺气不宣或肃降失司，胃失和降，运化受阻，则不利于外邪的清除。因此，调和肺胃，护好营卫，使气机调畅，营卫调和，有利于疾病康复。而饮食宜限量，以清淡为主，忌食高热量的食品

及不易消化之物。应适当保暖，以免复受外邪的侵袭。寒凉之品应慎重食用，过食寒凉之品，凉遏气机，不利疾病的治疗。^[41]

【按语】

尤松鑫治疗由于失治、误治、迁延日久而致顽固缠绵之咳嗽患者，善用止嗽散合苓甘五味姜辛汤治疗，认为两方合用有宣肺达邪、化饮止嗽之功，药物剂量应遵“治上焦如羽，非轻不举”之旨，宜偏轻。沈宗国常用“清宣金脏法”治疗外感咳嗽。“清宣金脏法”源于清代名医雷少逸的《时病论》，由8味药物组成，药性平和，不寒不热、不燥不腻，轻清灵动，开达上焦，可作为治疗外感咳嗽的基本方。蔡友敬治疗外感咳嗽以三拗汤为主方，根据兼症不同加以散寒、清热、祛湿、润燥之药，使后学一目了然，易学使用。陆拯治疗咳嗽，在辨证分型论治的同时，提出“六辨”学说，即咳嗽宜辨时间、宜辨咳声、宜辨咳形、宜辨痰色量质、宜辨妇幼之不同，可谓切中病机，施治得法。蒋士英以温病学理论作指导，辨治咳嗽每有独到见解。唐福安治疗咳嗽虽分六型辨治，但均以止嗽散为基本方加减，是其特色。胡翹武诊治咳嗽多从痰辨治，风痰者疏风化痰、寒痰者温肺化痰、热痰者清热化痰、湿痰者燥湿化痰、燥痰者润燥化痰，诚为心得，用之辄验。郭子光“久咳治络”的观点有其临床意义，其提出的“理络止咳”、“虫类搜络”之法，临床用之，常有速捷之效。王祖雄的止咳三步法是其经验的总结与提炼，行之有效，值得参考。廖潘泉用补肺阿胶汤治疗不同年龄肺虚燥咳日久不愈的患者，符合中医理法，可参考。印会河治疗咳嗽抓住痰辨治，白痰、黄

痰、黄白相间痰、白沫均有不同的治法与方药，确有独到之处。邵健民善用桑射汤加减治疗咽喉源性咳嗽，治法用药具有与众不同之特色，是屡效屡验之方。邵长荣善用金铃子散加味治疗干咳，合情（病性）合理（病理、药理），体现出邵对古方的熟谙和选方用药的严谨。赵棻用自拟“降逆止咳汤”治疗胃酸返流致咳，参考西说，又完全体现中医特色颇有临床意义。

（郭桃美）

参考文献

- [1] 查安生. 尤松鑫治疗久咳经验介绍. 浙江中医杂志, 1997, (4): 172
- [2] 郑峰. 沈宗国运用“清宣金脏法”治疗外感咳嗽的经验. 福建中医药, 1996, 27 (6): 7
- [3] 蔡光斗, 林禾禧. 蔡友敬老中医治外感咳嗽的经验. 福建中医药, 1992, 23 (6): 1~2
- [4] 方红. 陆拯治咳心法. 浙江中医杂志, 1997, 32 (8): 339~342
- [5] 苏云放. 蒋士英老师治疗咳嗽的理论及临床经验. 浙江中医学院学报, 1994, 18 (5): 30~31
- [6] 钱泽民. 唐福安老中医治疗咳嗽经验. 浙江中医学院学报, 1985, 9 (3): 26~28
- [7] 胡国俊. 胡翹武老中医咳嗽辨痰及治法的经验. 中医临床与保健, 1992, 4 (3): 28~39
- [8] 朱虹江. 陈乔林治疗喉源性咳嗽经验. 云南中医中药杂志, 1998, 19 (6): 8~9
- [9] 刘渊. 郭子光教授治咳经验. 河南中医, 1998, 18 (1): 39~40
- [10] 吴光炯. 王祖雄教授止咳三步法. 贵阳中医学院学报, 1994, 16 (1): 12~13
- [11] 张广麒, 廖伯筠. 廖清泉应用补肺阿胶汤治疗肺虚燥咳 84 例. 云南中医杂志, 1993, 14 (4): 12

- [12] 罗珊珊, 洪秀明, 刘景贤. 张浩然老中医辨治咳嗽经验. 云南中医杂志, 1994, 15 (3): 40~42
- [13] 赵金铎, 朱建贵. 咳嗽辨治经验琐谈. 云南中医杂志, 1985, 6 (5): 20~22
- [14] 王文波. 李岩教授治疗外感咳嗽四步法. 河南中医, 1994, 14 (6): 15
- [15] 史书德, 李淑华. 印会河教授抓主症治疗哮喘的经验. 河南中医, 1984, (2): 17~18
- [16] 张问渠. 己故名老中医赵锡武治疗哮喘的经验. 河南中医, 1984, (4): 26~27
- [17] 杜卫华, 丛丽红. 邵健民治疗咽喉源性咳嗽的经验. 吉林中医药, 1999, 19 (1): 8
- [18] 夏以琳. 邵长荣治咳经验介绍. 中医杂志, 1996, 37 (4): 210~211
- [19] 施红, 张颖. 邵长荣擅用金铃子散加味治疗干咳. 江苏中医, 1999, 20 (9): 7
- [20] 吴雄志. 段光周治疗咳嗽的经验. 四川中医, 1999, 17 (7): 3~4
- [21] 李仁述. 治咳经验谈. 浙江中医杂志, 2001, 35 (1): 4~5
- [22] 程皖. 韩明向教授祛风法治外感咳嗽经验. 安徽中医学院学报, 2000, 19 (2): 24~25
- [23] 赵向华. 赵菜治疗胃酸返流致咳的经验. 中医杂志, 1994, 35 (1): 20~21
- [24] 苏云放. 蒋士英治疗秋燥干咳擅用润法的经验. 中医杂志, 1994, 35 (9): 524~525
- [25] 尤菊松, 吴自强. 吴震西治咳经验. 中医杂志, 1997, 38 (7): 400~401
- [26] 潘正连, 孙子凯. 曹世宏教授治疗慢性咳嗽的经验. 江苏中医, 2000, 21 (4): 3~4
- [27] 唐玲华. 许建中教授治疗燥咳经验. 新中医, 1999, 31 (10): 17~18

- [28] 陈慧. 万铭老中医诊治久咳的经验. 山西中医, 1999, 15 (4): 10~11
- [29] 刘杏琴, 刘任宏. 新中医, 1995, 27 (6): 3
- [30] 谢海洲. 久咳因痰治验. 新中医, 1991, (1): 20
- [31] 姜惟. 孟景春教授临证经验举隅. 江苏中医, 1988, (10): 1
- [32] 戴克敏. 姜春华教授治疗咳嗽的经验. 江苏中医杂志, 1982, (4): 13
- [33] 蒋天佑, 蒋玮. 老年呼吸病证治发微. 山西中医, 1995, 11 (4): 5
- [34] 原明忠. 咳证治验. 山西中医, 1986, 2 (5): 24
- [35] 胡连玺. 咳证治验. 山西中医, 1986, 2 (5): 25
- [36] 张斯特, 张斯杰. 郭贞卿老中医谈咳嗽证治体会. 辽宁中医杂志, 1981, (2): 20
- [37] 方春阳. 陈存仁先生治疗咳嗽的经验. 辽宁中医杂志, 1983, 7 (8): 3
- [38] 郭振球. 老人喘咳哮的调治. 辽宁中医杂志, 1985, 9 (3): 6
- [39] 陈园桃. 苏万方老中医治疗咳血的经验. 辽宁中医杂志, 1986, 10 (10): 20
- [40] 龚锡曾. 曹余德老中医论治咳嗽. 辽宁中医杂志, 1989, 13 (6): 3
- [41] 郑建功. 赵绍琴教授辨治外感咳嗽经验. 辽宁中医杂志, 1998, 25 (3): 101

肺 结 核

【概述】

结核病是人体感染结核杆菌而引起的慢性肉芽肿性传染病。直接吸入带菌的飞沫微粒侵袭呼吸道为最常见的传染途径，因此肺结核是最常见的结核病。肺结核的治疗在于消除排菌，促使病灶愈合和防止复发。抗结核化疗可以在数周内消除排菌，并迅速控制全身毒性症状和咳嗽、咳痰、咯血，病人一般情况迅速好转，体重增加。中医称肺结核为肺癆，属“癆瘵”范畴，是一种具有传染性的慢性虚弱疾患，是由体质虚弱，气血不足，癆虫传染所致。临床以阴虚者为多见，但在整个疾病演变过程中，并可表现为气阴亏耗、阴虚火旺、阴阳两虚等证候类型。辨证必须以此为根据，在治疗时以养阴清火、扶正杀虫为基本原则，而补虚培元的整体疗法是本病治疗的重点。临床常见肺阴亏损、阴虚火旺、气阴两虚、阴阳两虚等证型，分别施治。

【名医经验】

1. 蔡友敬诊治经验

空洞型肺结核（包括浸润型肺结核合并空洞和慢性纤维空洞型肺结核）临床多以咳嗽、咯血为主要见症。蔡氏

认为此证属内伤劳损之候，其致成之因有二：一为外感咳嗽误投补剂，外邪壅而不出，咳久真气耗散，渐成劳咳。一为肾脏素虚，相火又旺，始则精不藏而梦遗滑泄，继则虚火上炎，木火刑金而咳嗽痰红，致成劳咳。劳咳之传亦有二：一则由上损下者。始由肺邪未解，痰热留恋，继则肺阴受伤，真气耗散。或由误补壅肺酿成胶痰。若在肺不解则必传心。心主血，络热血溢则为吐红。如再传脾而见便泻纳减则为不治矣。一则由下损上者。始由房室过度，遗泄频繁，肾阴暗伤，肾火内炽。肾水不供，肾火上炎，肺金受刑，肺无以布，而为干咳或喘咳。若在肾不治，必致传肝。肝藏血而司相火，木火冲腾，血不藏而随火升，则为吐红。木叩金鸣，则咳嗽痰青。若再传脾，亦见便泻纳少则不治矣。无论上损下损，第1期在肺肾，但见咳嗽犹可治疗。第2期在心肝并见吐血咽痛，盗汗不寐，甚则音嘶音哑，颧红形瘦，则损症已深。第3期在脾胃，均见便溏纳少，同为不治。空洞型肺结核多属第2期病变。其病机在于肺肾阴虚，心肝火旺，络伤血溢。治疗必须滋阴润肺，清热化痰，止血生肌。同时，蔡氏更善于辨证与辨病相结合，认为此病空洞内常有大量干酪样坏死组织，更宜排酪化痰，以促使坏死组织吸收和排出体外，使空洞净化和闭合。蔡氏根据以上病因病机的认识，自拟“五味抗痨散”治疗空洞型肺结核。

五味抗痨散组成：白及 150g，百合 150g，薏苡仁 150g，川贝母 30g，杏仁 150g。制法：以上药研末装瓶备用。用法：每次服 10g，每日 3 次。白开水送服。1 服为 1 疗程，一般服用 3 个疗程。

蔡氏常在辨证的基础上，根据不同病情，兼施以汤药，以急则治其标，待标症缓解后，专投散剂固其本。

如治一少女，3个月前出现咳嗽、盗汗，自以为外感之症，服用感冒药未见好转。旬前咳嗽加剧，痰中带血，甚至咯血，午后潮热，消瘦明显。经某医院检查诊断为浸润型双肺结核合并右上肺空洞（2cm×2cm）。患者慕名求诊。诊见：形体消瘦，颧红唇赤，呛咳不爽，痰少咯血，潮热盗汗，头晕目花，心烦失眠，舌质红，苔少，脉细数。此肺肾阴虚，累伤心阴，雷龙之火上炎。急宜滋阴降火，方宗理阴煎。药用：生地 15g，熟地 15g，生鳖甲 15g，地骨皮 10g，秦艽 10g，青蒿 10g，麦冬 10g，银柴胡 10g，百合 15g，百部 15g。水煎服。每日 1 剂。并拟“五味抗癆散”1 服，每次服 10g，每日 3 次，以清热化痰，抗癆抑菌，生肌止血。上药服 3 天后，潮热已退，咳嗽咯血减轻。汤剂中去银柴胡、秦艽，加紫珠草 15g，阿胶 10g。再服 5 剂后，咯血已止，余症均减。嘱服“五味抗癆散”2 服后，经 X 线复查提示：肺结核转入吸收好转期，空洞已初步钙化，自觉症状消失。再服散剂 2 服以善其后。

“五味抗癆散”中白及具有抗癆抑菌、生肌止血之功，为本方主药。百合润肺宁心，清热止咳，并能促进空洞闭合。薏苡仁取其渗淡利湿，清热排脓的作用。川贝润心肺，清痰热，止咳逆。杏仁泻肺解肌，镇咳平喘。故全方具有滋阴润肺、清热化痰、抗癆抑菌、生肌止血作用，用于空洞型肺结核效果显著。^[1]

2. 沈仲圭诊治经验

①辨病机治重脾肾：肺癆乃因身体虚弱，感瘵虫所得，其病程漫长，缠绵难愈。沈氏继承前贤精粹，合己之心得，认为该病的根本病理是肝肾阴虚，虚火上炎。故治法为滋阴降火，即“壮水之主，以制阳光。”多用甘寒养阴之品。

沈氏对裘吉生治癆五法较为推崇，首选于各期治法之中。

沈氏认为，本病虽在肺经，但与其他四脏相关，俱可发病。在肾为腰腿酸软，内热盗汗，梦交失精，耳中蝉鸣；在心为惊悸怔忡，虚烦少寐，口舌糜烂；在肝为胁肋作痛，目涩而痛，颈项瘰病，头晕眼花；在肺为咳嗽痰红，大口咯血，两颧红如胭脂，鼻中气如火热，咽痛喉烂，声嘶音哑；在脾为不思饮食，胀满腹痛，肠鸣泄泻，肌肉消瘦。这些论述体现出中医辨证特点，为临证选方奠定了基础。由于五脏生克关系，肺与脾肾关系至切。肺损日久，上夺母气以自养而致脾虚，下不能滋肾而精液日亏；脾虚失运，谷气不能上达于肺；肾精过耗，阴亏则虚火上乘。故沈氏强调：“治肺癆当注重脾肾。”因肾藏精，命门内寄相火，水火既济，则阴阳平衡。脾为后天之本，胃开脾运，自能生血化精，血足则肝火不旺，精足则肾水不亏。

②酌浅深选方精细：沈氏推崇《理虚元鉴》之“理虚有三本，肺脾肾是也。肺为五脏之天，脾为百骸之母，肾为一身之根。知斯三者，治虚之道毕矣。”的论述，认为劳损在肺，病还不重，到肾则由浅入深，若病势再进必损及肺脾肾三脏，乃至难复之境。指出治疗本病“务须辨明主次，权衡轻重，斟酌病情，妥善立方。”

劳损在肺，证见干咳少痰，咯血时作，或有潮热，手足如灼，口燥咽干，饮食减少，舌边尖红，脉细数。治宜养阴润肺，止咳化痰。选裘氏清肺宁嗽法（玄参、麦冬、地骨皮、川贝母、百合、柿霜、杏仁、蛤壳、紫菀、新会白），滋阴降火、润肺化痰。亦可用《医学心悟》月华丸，滋阴降火，消痰止咳。

劳损在肾，证见咳嗽痰少，或吐黄稠痰，咯血量多色鲜，胸胁掣痛，骨蒸盗汗，心烦失眠，性躁多怒，舌红绛，

脉细数。治宜滋阴降火，潜阳安神。选裘氏三法，即养阴止血法（生地、玄参、麦冬、杏仁、百合、紫菀、仙鹤草、茜草根炭、白茅根、藕节、山茶花炭），滋阴清肺，止血化痰；育阴潜阳法（生地、麦冬、生牡蛎、炙鳖甲、炙龟板、地骨皮、石斛、川贝、杏仁、百合、冬虫夏草），滋肾阴，清虚火；养阴敛汗法（生地、石斛、生龙骨、生牡蛎、磁石、川贝母、杏仁、麦冬、黛蛤散、茯神、燕窝根），养阴潜阳，止咳敛汗。或根据病情选用百合固金汤。若骨蒸盗汗明显者可配用秦艽鳖甲散滋阴退热，除蒸敛汗；咯血甚者，配用四生丸，凉血止血。

若病势再进，则表现为阴阳两虚、肺脾肾三脏俱损之候。证见咳呛咯血，骨蒸盗汗，声嘶失音，形体羸弱，或畏风自汗，喘息气短，面浮肢肿，食少便溏，舌光绛，脉微细等。此虚损已极，调治颇难。沈氏主张填补精血，调理脾胃，培先天之精血，资后天之化源。常用《十药神书》之白凤膏及保真汤。沈氏认为，保真汤以四君培后天，二地二冬滋肾水，黄芪归芍益气血，柴胡地骨除骨蒸，知柏清相火，综合各药性能，滋阴清火，兼补脾肾。用于正虚邪盛之症，是属比较理想的方剂。

肺癆之恢复期，除适当体育锻炼及远房帑、节饮食之外，药物调治仍属必要。沈氏常用裘氏大剂滋养法（生熟地、山茱萸、山药、茯神、女贞子、旱莲草、丹皮、龟板、石斛、鸡内金、新会白、百合、天冬、麦冬），此法系六味地黄汤、人参固本丸、二至丸加减所得，以滋补肾阴为主。或以回生丸（熟地、山茱萸、枸杞子、菟丝子、牛膝、山药、茯苓、白芍、龙眼肉、玄参、天冬、麦冬、五味子、枣仁、地骨皮、女贞子、莲须、龟板胶、鳖甲胶、鱼鳔胶、猪脊髓、黄牛肉、紫河车等）峻补真阴，对肺癆病后虚羸

者可酌情选用，纳谷不香者忌之。

③治虚损强调食疗：饮食疗法为中医学之重要组成部分，慢性病患者及儿童尤易接受。沈氏素善养生，更擅长食疗，对肺癆病在用药物的同时，亦常用下列诸品：百部、柿饼以润肺宁嗽；牛乳、甘梨以消痰降火，润肺止嗽；薏苡仁、莲子、芡实以治肾虚滑精，脾虚便溏；扁豆、红枣以补脾胃；桂圆补益心脾，以桂圆肉加沙参蒸至糜烂，每用一茶匙，沸水冲服；乌骨鸡，猪肺以补虚益肺，洗净，煮烂，蘸白及末食；核桃益肾，止癆喘，捣烂后，另用红枣蒸熟去皮核，两物混合搓成团，当点心食用。

沈氏认为，现代以大蒜治肺癆病，颇有功效。如周凤梧著《中药学》谓：“大蒜用于肺癆咳嗽，紫皮蒜 30g，百部 15g，紫菀 9g，后两味水煎，大蒜捣汁兑入服。也可经常食生蒜，或同米煮粥常服。”又《简明中药辞典》云：“大蒜治结核，消化不良等病，内服 6 至 15g，生食或煨食。”此物虽然辛温，与阴亏火炽的肺癆不利，但有开胃健脾之效，在服滋阴清火药物时，并可调济阴柔药碍胃之弊。^[2]

3. 沈炎南诊治经验

沈氏从事中医事业 50 余年，学验俱丰，对肺结核治疗有独到经验。沈氏认为，对肺结核治疗，一是要燮理阴阳，使之恢复平衡，根据阴虚程度、有无兼火热亢盛，以及有无耗气伤阳等情况来决定治疗大法；二是要根据五行生克乘侮规律调理脏腑，使之恢复正常关系。遵循《难经》治疗劳损的法则：“损其肺者益其气；损其心者调其营卫；损其脾者调其饮食，适其寒温；损其肝者缓其中；损其肾者益其精。”以调理五脏之虚。其中以调理肺、脾、肾三脏为

主，正如绮石《理虚元鉴》所言：“理虚有三本，肺脾肾是也。肺为五脏之天，脾为百骸之母，肾为性命之根。知斯三者，治虚之道毕矣。”并指出：“清金保肺，毋犯中州之土”、“培土调中，不损至高之气”、“金行清化，不觉水自流长，乃合金水于一致”。确为经验之谈。沈氏在吸收前人经验基础上，结合自己临床心得，创立了治疗肺结核的七法。

①清金保肺法：主要用于肺阴虚，选用北沙参、党参、麦冬、玉竹、玄参、生地、百合、桑叶、枇杷叶、百部、川贝母、生牡蛎之类。如阴虚有火，可选加黄芩、桑白皮、鱼腥草、知母、天花粉之类清泻肺火；如兼肺气虚，可选加党参、太子参、茯苓、黄芪、五爪龙之类；如有自汗、盗汗者，可据情酌加糯稻根、浮小麦、五味子、麻黄根、煅龙骨、煅牡蛎之类。

②培土生金法：脾气虚者，选用异功散、参苓白术散；脾阴虚者，选用太子参、西洋参、淮山、黄精、茯苓、扁豆、石斛、麦冬、薏苡仁、莲子、芡实、甘草之类。并可酌加麦芽、谷芽、布渣叶之类运脾化滞。

③滋肾固精法：主要用于肾阴虚，选用三才封髓丹、二仙丹，酌加冬虫夏草、黄精、山茱萸、枸杞子、沙苑子之类。遗精梦泄者，可酌加龙骨、牡蛎、莲子、莲须、莲芯、白果、夜交藤、五味子之类；如阴损及阳，阴阳两虚者，可酌加人参、胡桃、紫河车、山茱萸、肉苁蓉、蛤蚧尾之类助阳生精，但应注意勿过用温燥动火之剂。

④养阴柔肝法：主要用于肝阴虚，选用白芍、甘草、阿胶、黄精、首乌、枸杞子、女贞子、旱莲草、桑椹子、生地、石决明等。如肝火偏亢者，可酌加黄芩、栀子、丹皮、夏枯草、水牛角、羚羊角之类清泻肝火；如肝木横逆

犯土，则重用芍药以平肝木。

⑤养心安神法：主要用于心阴虚，心神不安之证，用生脉散酌加柏子仁、酸枣仁、茯神、百合、珍珠母、夜交藤之类；如心火上炎，可合导赤散加灯芯草以导火下泄。

⑥滋阴降火法：用于阴虚火旺之证，选用知柏地黄丸、犀角地黄汤；如骨蒸劳热者，可选加地骨皮、银柴胡、白薇、秦艽、青蒿、鳖甲、龟板之类。

⑦宁络止血法：用于咳血、咯血之证，选用桑叶、玄参、麦冬、生地、旱莲草、仙鹤草、侧柏叶、茜草根、紫珠草、艾叶、大蓟、小蓟、藕节、白及、白茅根、参三七、花蕊石之类，止血兼化瘀。如为肺络灼伤，与清金保肺法合用；如为肝火上逆，与犀角地黄汤合用；如大量咯血，止血药炒炭用，并饮用新鲜童便以济急；气随血脱者，用独参汤以救脱。

上七法以清金保肺、培土生金、滋肾固精为基本法，其余四法为辅助法，七法既可单独使用，又可相互合用。往往是以一法为主，参以他法。根据辨证圆活变通，自可收良效。

如治罗某某，男，30岁，1959年1月23日初诊。患者于1956年始患慢性纤维空洞型肺结核，先后2次住院用链霉素、异烟肼、对氨柳酸钠等抗结核药治疗，反复不愈，且病情有所发展，乃转请中医治疗。证见潮热气喘，遗精（每周4、5次），舌紫绛、苔微黄，脉弦数，属肾阴不足，阴虚火亢，先以滋阴降火为主，佐以滋肾固精。处方：生地9g，熟地9g，山茱萸9g，丹皮9g，茯苓9g，泽泻9g，黄柏9g，知母9g，淮山12g，百合12g，麦冬12g，百部12g，沙苑子12g，龙骨12g，莲须12g，莲子12g，地骨皮18g，白及末18g（分2次吞服），牡蛎60g，鳖甲30g，白

果肉 6 粒。服 7 剂，潮热减退，气喘亦平，惟遗精尚频。拟滋肾固精为主，佐以滋阴降火：熟地 15g，天冬 15g，沙苑子 12g，龙骨 12g，莲须 12g，桑叶 12g，莲肉 9g，百部 9g，黄柏 9g，牡蛎 18g，莲芯 3g，炙甘草 3g。服 17 剂，药后 2 周已无遗精，潮热退净，上方改龙骨 30g，牡蛎 60g，加白果肉 6 粒，白及末 18g（分 2 次冲服）。以上方为主加减进退调理至 4 月 7 日，诸症大为好转。拟清金保肺合滋肾固精法，以资巩固。处方：党参 15g，熟地 15g，天冬 15g，百合 12g，生地 9g，北沙参 9g，麦冬 9g，黄柏 9g，白及 18g，玉竹 30g，龙骨 30g，牡蛎 60g，炙甘草 3g。服 11 剂，诸症消失，X 线检查结核吸收好转，空洞消失。

又如治丁某，女，25 岁，1983 年 9 月 5 日初诊。患者干咳少痰，胸闷，时有低热，经某医院 X 线胸透检查，诊为右上肺浸润型肺结核，用抗结核药治疗 3 个月，效果不显。患者形体瘦削，面白颧红，时有干咳，自诉每天下午低热，胸闷，口苦，舌质略红、苔薄微黄，脉弦细略数。证属阴虚火亢，拟清金保肺、滋阴降火法。处方：北沙参 15g，生牡蛎 15g，桑叶 9g，麦冬 9g，玉竹 9g，百部 9g，北杏仁 9g，桑白皮 12g，地骨皮 12g，黄芩 6g，甘草 6g。水煎服，每日 1 剂。以此方为主加减进退，治疗 3 个月，下午已不发热，干咳大减，胸部较舒畅，体重增加 2.5kg。12 月 8 日诊，因近来伤食腹泻，泻止后胃纳欠佳，倦怠乏力，口干，胸内有热感，舌淡红，苔略黄腻，脉细软。属气阴两亏，土不生金。拟培土生金，益气养阴运脾法。处方：党参 30g，北沙参 30g，薏苡仁 30g，麦芽 30g，淮山 15g，牡蛎 15g，百部 9g，白术 9g，陈皮 6g，黄芩 6g，甘草 3g。以此方为主，加减进退治疗月余，诸症消失，胃纳佳，X 线检查病灶已基本吸收钙化。^[3]

4. 李修五诊治经验

治肺癆重清金保肺，自拟良方抗癆丸：肺癆乃虛損之疾，其病理性质主要在陰虛火旺，并可导致氣陰兩虛，甚則陰損及陽。因肺喜潤而惡燥，癆蟲侵犯，侵蝕肺葉，肺體受損，陰分先傷，故見陰虛肺燥之候者居多。繼則可陰虛生內熱，終則可陰損及陽。由於肺為五臟之天，司治節之令，秉清肅之化，外可輸精於皮毛，內可灌乎四臟，肺又為清潤之體，損肺者多損其氣陰也，故治癆當有三禁：一禁燥烈，二禁伐氣，三禁苦寒。治肺癆大法有二：一曰養陰肅肺，二曰清金保肺。善用甘寒養陰，清金保肺，用自擬抗癆丸（由黃芪、地骨皮、山藥、茯苓、土貝母、夏枯草、百部、百合、當歸、黃精、白及、黃芩、麥冬、女貞子、生地、玄參、貓爪草、壁虎等組成）獲較好的療效。^[4]

5. 李文欣診治經驗

陰虛發熱乃臨床常見證候，而致使陰陽失和、陰津不足的原因，李氏認為既有素體陰虛，熱病日久耗傷陰液，亦有誤用或過用溫燥之劑而變生者。其發熱機理，為陰衰陽盛，水不制火，虛火內熾所致。此類發熱，每見午後或夜間發熱，手足心熱，或骨蒸潮熱，心煩少寐，多夢顛紅，盜汗，大便干結，尿少色黃，舌質干紅或有裂紋，脈細數。治療上倡《素問·至真要大論》“諸寒之而熱者取之陰”之旨，以滋陰之品培其不足之陰，“壯水之主，以制陽光”，每選熟地黃、山藥、枸杞子、山茱萸、青蒿、秦艽等增陰退熱，鱉甲滋陰潛陽，盜汗甚者易青蒿以牡蠣、浮小麥等固表斂汗，少寐者可酌加炒棗仁、麥冬、五味子、柏子仁

等养心宁神。

如治王某，男，56岁。3年前曾与肺结核患者长期接触，以后遂发咳嗽，经某医院检查诊断为空洞型肺结核。经西药治疗好转，惟有夜间发热，心烦少寐不解。伴见面色苍黄，两颧微赤，大便燥结，尿少而黄，舌红少苔，脉细数。证属肺病日久，伤及肾阴，肺肾阴亏之象，治当养阴除热，滋阴降火。处方：熟地黄 25g，山茱萸 12g，黄精 12g，五味子 12g，柴胡 12g，胡黄连 12g，山药 15g，知母 15g，浮小麦 15g，百合 20g。以上方出入加减连服 15 剂，心烦发热已除，能参加体力劳动。^[3]

6. 赵棻诊治经验

血液从气管、支气管、肺脏伴随咳嗽而出者，谓之咳血，亦有不咳而咯出者，谓之咯血，属中医学咳血范畴。

如治刘某，男，65岁。5年前因咳嗽痰血，经结核病院 X 线透视、痰细菌培养等检查，诊断为肺结核合并支气管扩张，经治疗病情好转。1 个月前因进食油炸品，并饮酒少许，咯血 1 次。1 周前又因感冒风邪，恶寒发热，经服中药疏风发散之剂，外感向愈，又突然剧烈咳嗽，继则呈喷射状咯血约半小痰盂。现仍有少许咯血，伴肢体酸楚，骨节疼痛，形神倦怠，纳食不进，大便干结，小便淡黄，舌淡苔薄，脉细数右弦。辨证为燥火烁金，灼伤阳络。急则治标，先以止血安络为先。处方：藕节 30g，仙鹤草 20g，麦芽 30g，谷芽 30g，蜜紫菀 12g，蜜枇杷叶 12g，川贝末（分冲）6g，紫珠草 20g，白及粉（分冲）9g。2 剂，每日 1 剂，水煎服。另以“回龙汤”（自尿）去首尾不用，于凌晨寅时服下。服药后咯血减，仍有少许陈旧血块咯出，宜标本兼顾，治以益气育阴，养肺安络。处方：西洋参 6g

(另兑), 阿胶 9g (另炖分冲), 五味子 6g, 枸杞子 18g, 白及粉 (分冲) 9g, 生谷芽 30g, 山药 15g, 川贝末 (分冲) 9g, 茯苓 9g, 紫珠草 9g, 牡丹皮 9g, 甘草 3g, 3 剂。另以紫雪丹 3 支, 每次半支, 用煎剂送服。服药后病情明显好转, 继用二诊方加仙鹤草 18g, 3 剂, 咳嗽痰血、咯血均止。用三诊方加生蒲黄 (布包) 6g, 4 剂。药后向安, 随访 1 年未复发。

本例因嗜油炸辛燥之品, 造成阴虚火旺, 火性炎上, 迫血妄行, 酿成咳血咯血复发。因咯血量多, 故以大队止血药物治其标。方中紫珠草、白及, 经现代医学研究, 为治疗肺结核咯血止血之妙品; 仙鹤草亦为治肺经咳血咯血之良药。缪仲醇谓血证“宜降气不宜降火”, 所以在止血之外, 又取枇杷叶、紫菀、川贝等轻肃肺, 以制亢木, 顺调下行之气。考紫菀, 《本经》曰: “止咳逆之气, 胸中生寒热结气”, 为肺经血分药, 能疏利肺经血气; 枇杷叶气味俱薄, 最能和肺胃而下气, 气下则火降痰消, 二味为肺中气血郁滞之常用药。贝母则向导入肺, 疏郁化痰用为使。谷麦芽健运升发, 调理气机, 亦寓补土生金之意。尤其妙在配合“回龙汤”(自尿)于寅时气血流注肺经之际服下, 有强大的降火滋阴, 活血止血之功。次诊见气阴两亏, 故在清肺安络之外, 加入滋补肺肾之品, 使金水相生, 相火亢木在制约涵养中, 得以驯伏安位, 不复上炎。后以生蒲黄收局, 止血而不留瘀。^[6]

7. 奚凤霖诊治经验

肺结核 (包括肺门淋巴结核), 中医属“肺癆”范畴。患者大多肺卫不足, 外邪易袭, 肺气受戕, 发为咳痰; 更因邪火乘金, 灼津伤阴, 则发为低热、咽干、火升。其咳

多呈干咳状。卫阳虚弱则易汗。故以驱邪益卫、固表敛汗之玉屏风散为主，并以养肺滋阴之百合固金汤，参以益气健脾、培土生金的异功散，使之相辅相成，相得益彰，以达调理肺气肺阴之功。

如治王某，男，15岁，去年起患肺门淋巴结核，经西药抗痨治疗半年后，自觉已愈。唯反复“上感”，近发热1周，来诊时热退而未净，伴有咳嗽，动则汗多，疲乏无力，面色萎黄而无华，舌红、苔薄，脉浮弱。拟用益气固卫，健脾和中，补肺养阴之法。方以玉屏风散、百合固金汤、异功散等加减化裁。处方：生黄芪15g，白术15g，防风10g，南沙参10g，北沙参10g，干百合10g，山药15g，砂仁3g（后下），山楂15g，神曲15g，浮小麦30g，碧桃干15g，茯苓15g，炙甘草6g。连服14剂，食欲大增，低热退，咳嗽止，继以原法加减调治月余，未见感冒复发。^[7]

8. 王国三诊治经验

肺结核与中医的劳瘵一证极相类似，治疗上也颇有相同之处。近年来，有人用百部为主药治疗肺结核，均获得良好效果。也有人在试管内证实：“百部对人型结核杆菌，有完全的抑制作用。”古方中治疗劳瘵证，使用百部者甚多。按专病专药与辨证论治相结合的观点，百部似为肺结核之专药。若病程较久，肺之气阴两虚，心神不宁，可加生脉散、酸枣仁、远志、焦栀子等补气养阴安神泄热；由于脾虚胃纳欠佳，则加山药、茯苓、焦三仙。若病程较短，只是肺脏气阴耗伤，则加麦冬、川贝母、苏子等，养阴润肺化痰下气。而用白及治疗肺胃出血者，多有报道。如肺气虚弱，络脉损伤出血，可用白及收效。白及用法：轧细面，白米汤冲服，其效尤佳，此其一。其二，如有肺气虚

损，咳逆上气，痰涎壅盛者，可与款冬花、紫菀为伍治疗。黄宫绣谓：冬花“肺虚得此以为温润，故能服之即止。”又谓紫菀“辛而不燥，润而不滞”，有治虚癆咳嗽之功。两药合用，以治标症咳嗽，可收佳效。

如治李某，男，50岁。患肺结核多年，经治疗后转静止期。因劳累后发热，午后尤甚，咳吐多量白痰，痰中带血，食欲不振，大便稍溏。形体瘦削，精神疲惫，失眠多梦，五心烦热。舌体稍胖，舌尖红，苔薄白，脉沉数无力。X线胸片无明显变化，痰结核菌阳性。其证初为肺脾虚损，脉络损伤，继则心气亏虚，郁热内扰。予润肺健脾，养心安神法，以月华丸加减治之。处方：党参18g，百部30g，麦冬10g，五味子6g，款冬花10g，紫菀18g，山药15g，炒枣仁18g，远志8g，焦栀子5g，白及末6g（分2次白米汤冲服）。服药5剂，即获显效，又服5剂。热退，痰血消失，痰量亦减，渐能入睡。惟食欲、大便尚无转机。脾胃为后天之本，肺金之母，当着重调理之，乃于前方加茯苓15g，焦三仙27g，续服10剂，症状大为好转，痰结核菌转阴。邪势渐去，正气未复，故于前方去焦栀子，加生牡蛎15g，党参24g，再服15剂。后以前方5倍量轧细面，炼蜜为丸，每丸9g，早晚各服1丸以巩固之。^[8]

9. 周仲瑛诊治经验

肺癆是具有传染性的慢性虚弱疾患，由于劳损在肺，故称肺癆。早在《内经》、《金匱要略》均将肺癆（癆瘵）归属于“虚劳”、“虚损”的范围，提示本病的发展，每可导致患者身体日益消瘦，体虚不复，形成劳损。肺癆病位主要在肺，肺癆的病理主在阴虚。从本病临床表现来看，主要类同于西医学所称之肺结核。肺的主要功能是主气，

“療虫”犯肺，理应先伤肺气，但据临床观察，病理表现多以阴虚为主。因肺为喜润恶燥之脏，“肺虫居肺叶之内，蚀人肺系”（《普济本事方》），肺体受损，故易耗伤肺阴，而见阴虚肺燥之候。同时因本病为慢性消耗性疾病，由于有形之阴精日益耗伤，故其全身症状亦以阴虚为多见。若进而演变发展，可至阴虚火旺，或导致气阴两虚，甚则阴损及阳。肺癆的临床特征为咳嗽、咳血、潮热、盗汗，以及身体逐渐消瘦。病轻者诸症间作，重者可以先后相继发生，或兼见并呈。治疗原则为杀虫与补虚。临床可根据体质强弱和病情表现，决定杀虫与补虚的主次。另一方面因正虚是发病的关键，故尤需重视补虚培元，增强正气，以提高抗病能力。对长期应用抗癆西药，痰检仍为阳性，病灶难以改善，已具有耐药性的病例，可有较好疗效。因病位主脏在肺，整体涉及脾、肾，故以补肺为主，同时兼予补脾、补肾；病理性质主要是阴虚，故应以滋阴为大法，火旺者兼以清火，气虚者同时补气，后期阴伤及阳者滋阴助阳。

肺癆的“肺阴亏损证”和“阴虚火旺证”，病理性质都属肺阴虚所致。但“肺阴亏损证”的阴虚程度较轻，没有明显火旺现象，病损主要在肺，病理表现为阴虚肺燥，肺失滋润。“阴虚火旺证”的阴虚程度较重，并有火象，病损由肺及肾，病理表现为肺肾阴伤，燥热内灼。治疗都以滋阴为大法。前者当滋阴润肺，可取月华丸为主方。“阴虚火旺证”则应在滋阴的同时兼以降火，养肺益肾，方如百合固金汤、秦艽鳖甲散等。因脾为生化之源，功能输水谷之精气以养肺，故当重视补脾助肺，“培土生金”的治疗措施，以畅化源。脾为肺之母，“療虫”伤肺，肺虚耗夺脾气以自养则脾亦虚，脾虚不能化水谷为精微上输以养肺，则肺更虚。终至肺脾同病，气阴两伤，伴见疲乏、食少、便

溏等脾虚症状。治当益气养阴，补肺健脾，忌用地黄、阿胶、麦冬等滋腻药。当在甘寒滋阴的同时，兼伍甘淡实脾之药，帮助脾胃对滋阴药的运化吸收，以免纯阴滋腻碍脾，但用药不宜香燥，以免耗气、劫液、动血。方宗参苓白术散意，药如橘白、谷芽、山药、白术、扁豆、莲子、薏苡仁等。肺癆病的阴阳两虚多为肺脾同病，气阴耗伤证的进一步发展，因下损及肾，阴伤及阳，肺脾肾三脏交亏，而致在后期趋于阴阳两虚的严重变局。据临床检查所示，多有肺功能不全或其他合并症。肺虚气逆则咳逆喘息少气；气不化津而成痰，故咯吐白色浊唾涎沫；金碎不鸣，声道失润而声嘶音哑；肺虚络损则痰中带血。脾肾两虚，健运无权，火不居暖土则见浮肿、五更肾泻；肺气不能佐心治节血脉之运行，而致心慌、唇紫；卫虚则形寒、自汗；阴伤则潮热、盗汗；虚火上炎而使口舌生糜；精气虚竭无以充养形体，资助冲任之化源，以致大肉尽脱，男子滑精、阳痿，女子经少、经闭；苔黄而剥，舌光淡质隐紫，脉微细数或虚大，俱系阴阳交亏之候。治当滋阴补阳，温养精气，以培根本，方选《医学心悟》补天大造丸加减。

此外治疗本病适当采用活血化痰通络法，可以取得较好的疗效。这与中医“祛瘀生新”的论点基本一致。活血祛瘀药可以改善肺脏病灶部位的血液循环，疏通血管、淋巴的瘀塞，旺盛新陈代谢，软化病灶的纤维增生，促使病损组织的修复。可对病灶大量纤维增生变形，干酪坏死，局部血管、淋巴破坏及瘀塞，或形成厚壁空洞者配合用之。但经常反复咯血者应禁用、慎用。^[9]

10. 徐景藩诊治经验

藕蜜煮食，可疗肺疾：藕与蜂蜜，本经均列为上品。

《本草纲目》载：“藕甘平，主治热渴，散留血，生肌。”“蒸食甚补五脏，实下焦。同蜜食，令人腹脏肥，不生诸虫……。”“蜂蜜甘平……其入药之功有五，清热也，补中也，解毒也，润燥也，止痛也。”昔日曾闻有单方以藕蜜同煮食，对改善久咳致喘甚良。有一纤维空洞型肺结核患者，每于夏秋以鲜藕煮蜜服之，两年中煮食鲜藕5公斤多，蜜5公斤多，症状改善而体渐丰，精神亦好转，复查病灶亦有改善。饮食治疗对慢性疾患确有帮助。有些慢性支气管炎、肺气肿、肺结核久病、支气管扩张等患者，当痰浊不盛，又无外感夹杂之时，以鲜藕与蜂蜜同煮，待藕煮较烂，吃藕喝汤，颇有裨益。至于用量，一般视病人的食欲及大便秘结与否而定。食欲尚可，喜食甜味，大便干结者，每次鲜藕250g，蜂蜜250g，同煮后2~3日吃完。若食欲欠佳，大便不干，则将鲜藕、蜂蜜以2:1的比例。肺结核病人，虽长期用抗痨药，病灶进步慢，可以百部、葶草加入同煮。慢性支气管炎、咳嗽不已，可根据病情，酌加佛耳草、麻黄（后下）、枇杷叶等药加水同煎。但凡有外感未祛，寒热喉痒，或舌苔白腻，胸闷有痰湿证候者，不宜服。曾用上法治疗慢性支气管炎、肺气肿（慢性阻塞性）、肺心病、肺结核、支气管扩张等患者数10人，均按上述用法，每5~7日煮食1次，药后一般均有不同程度的改善。有的患者原来常患痰红咯血，或动则气短，服后症状改善尤著。^[10]

11. 张谷才诊治经验

张氏认为，麦门冬汤有培土生金的功效。方中麦冬滋养肺胃之阴；参、草、枣健中助脾，与粳米同用，更能益胃生气，化生津液。津液充沛，则虚火自敛，肺阴自复。举凡肺结核、肺脓疡、支气管扩张、矽肺、肺不张等病见

有气阴两虚者，均可以此方化裁，疗效大多满意。

如治王某，男，46岁，肺结核大咯血后10多天，低热不退，面色㿔白，形体消瘦，头眩心悸，语言无力，微咳有痰，咽喉不利，动则气喘，饮食极少，口干思饮，大便稀溏，脉细数，舌光红无苔。乃肺胃阴伤，脾虚失运，土不生金。方拟麦门冬汤加味以调脾胃、益肺金。处方：麦冬10g，党参10g，甘草5g，粳米30g（先煎），大枣5枚，黄芪6g，半夏4g，款冬花6g。服药20剂，低热消退，饮食增加，面转红润，舌苔渐生。脾胃之气来复，肺气亦平。继以原法递进10剂，诸症消失，身体渐佳。病情趋于稳定。^[11]

12. 姜春华诊治经验

姜氏善用止血化瘀法治疗肺结核咯血。

如治路某，男，24岁。3年前曾患肺结核，近来咳嗽发作，咯血盈口，盗汗，下午低热（37.8℃），舌红，脉弱。此为宿疾复发，宜止血化瘀。处方：煅花蕊石9g，蒲黄炭9g，血余炭6g，生地黄9g，麦冬9g，百部9g，川贝母6g。药后咳止，血停。改服芩部丹（黄芩、百部、丹参）加减治本善后。本例肺结核咯血，急则治其标。姜氏认为，止血化瘀并重，瘀去则血能自止，一散一止，有异曲同工之妙。花蕊石、蒲黄炭性涩，为收敛性止血之药，又能活血祛瘀，对各种出血都能适用；生地有止血养阴清热之妙，用于本证最为合拍；血余炭经药理试验证明含有碳素，因而可缩短出血和凝血时间，达到止血的目的。并认为百部为良好止咳药，据现代药理研究，百部内含百部碱，能降低呼吸中枢兴奋作用，抑制咳嗽反射，而奏止咳之效。^[12]

13. 祝味菊诊治经验

祝氏善用健补法加紫河车治疗肺结核。

如治樊某，30岁，因生活不守常规，烟酒不断，为日既久，由失眠开始，继现咳嗽，午后低热面赤，不久咳嗽增剧，痰中带血，失眠更甚，终日头昏目眩，四肢无力，西医诊断为肺结核，局部继续浸润，按时服雷米封，未见起色，改延中医诊治，连服平肝润肺清热止血之剂，形体日瘦，体重减轻，精神委顿，饮食少进，改请祝氏诊治。祝氏认为病虽重笃，非不治之症，用健脾益肾之品，以提高抵抗力，病常可转危为安。处方：附子18g（先煎），党参15g，炒白术12g，姜半夏12g，陈皮9g，白豆蔻9g，炒麦芽12g，茯苓12g，活磁石30g，当归12g，炒白芍12g，桂枝9g。服药3剂，始则胃纳渐馨，但低热未退，有时见红，此病属阴阳俱虚，应用甘温除大热之法。处方：附子18g（先煎），人参12g，熟地18g，桂枝9g，炒白芍15g，青蒿9g，炮姜炭9g，茜根炭9g，活磁石30g（先煎），生龙齿24g（先煎），淮山药12g，山萸肉9g，枸杞子9g。连服6剂，低热减，咳血止，照原方加淫羊藿12g，仙茅12g，再服多剂，低热退清，面色转正，改服紫河车粉6g，每日2次，服1月后，体重增，健康恢复。祝氏曰：“紫河车亦治肺结核之妙药，病虽大愈毋忘常服紫河车。”^[13]

14. 赵锡武诊治经验

赵氏认为结核病相当于中医的癆瘵。而呼出心与肺，吸入肾与肝。“天食人以五气，地食人以五味”。肺为娇脏，合皮毛，司呼吸，主节，性肃降，受藏魄。“癆虫”侵

蚀，灼伤肺阴。症见干咳无痰或痰少色黄或带血丝，胸闷胸痛，口燥咽干，骨蒸潮热，夜间盗汗，五心烦热，纳差失眠，乏力羸瘦，舌质鲜红或淡红苔薄黄中裂，脉沉细数或浮大虚数。古代伤寒家擅发汗，不擅解毒，故病邪乖张时内毒较甚；温病家擅解毒，不擅发汗，故邪不能出。治劳则须二者有机结合。有人认为“仲景方不能治结核病”。对此，赵氏认为“不尽然。治疗只要注重阴阳虚实，掌握好出入升降，仲景方可以解决不少问题。”常以桂枝汤内固外卫，调和脾胃，以预防感冒和治疗初起之感冒风寒；以柴胡桂枝汤治疗太阳少阳合病，尚有验案加牡蛎、乌贼骨增加钙质，促进病灶钙化；以小柴胡汤推陈致新，俾“上焦得通，津液得下，胃气因和”。至若阴虚为主，又当养阴扶正为主，祛邪为辅，此时当以增液汤加北沙参、生地、天冬为主方。高热加青蒿、地骨皮、鳖甲；咳血加白及、白茅根、枇杷叶、贝母、杏仁、藕节，益以杏仁、竹茹降气；大咳血予三黄（黄芩、黄连、大黄）汤加生地、阿胶、竹茹；阴虚盗汗加当归六黄汤；空洞加紫金锭。

若癆瘵之证似支饮，相当于结核性胸膜炎，甚则伴发胸水。筋膜属肝，漏出液属水，应温阳化气行水，可用真武汤加黄芪、桂枝、大枣、甘草。兼喘者以真武汤合越婢汤制之；渗出液属饮，宜开胸疏泄为主，方选小陷胸汤合四逆散加金银花、桔梗、芫花（1.5~3g）、犀黄丸，或木防己汤加茯苓、芒硝。芒硝用12g配茯苓不会泻而令饮邪自小便出；脓胸以犀黄小陷胸汤合四逆散。癆瘵见“腹块”相当于结核性腹膜炎。若体温低热，伴有腹水，投麻黄加术汤（麻黄、生姜、苍术、白术、甘草各6g，石膏25g，大枣3枚）。赵氏恪守上述病理，治愈不少结核病患者。^[14]

15. 陶君仁诊治经验

陶氏认为肺癆咯血当从肾论治。咯血其病位在肺，然病因、病机与肾关系甚为密切。正如唐容川云：“咯血出于肾”。肾为水脏，主津液，水液经肾气化，分别清浊，清者上归于肺，输布诸脏，浊者经膀胱排出体外；若肾水亏损，阴液不足，相火亢旺，以致水不制火；肺为娇脏，主水之上源，今水亏火旺，相火刑金，肺络破损，而致咯血。陶氏主张从肾施治，壮水制火，滋肾补肺，方选六味地黄丸合月华丸化裁。

如治钱某，女，52岁。患肺结核已5年，形体消瘦，胸闷气短，动则汗出，口燥颧红，夜寐不宁，手足发热，咯血频作，腰膝酸楚。脉细数，舌质红、苔少。血沉38mm/1h，X线胸片示：右上中肺见片状模糊阴影，密度淡，边缘不清。证属肾阴亏损，阴精不能上承，虚火灼金，治拟壮水滋肺，降火止血。处方：生地黄15g，山萸肉10g，山药15g，丹皮12g，泽泻10g，天冬12g，百部15g，北沙参18g，麦冬12g，阿胶（烔化）10g，川贝母10g。2剂后，咯血有减，继进3剂血止，后以百合固金丸、白及粉调理匝月，而至康复。本例咯血用壮水之主，以制阳光，意在图本，火降则血不妄行，滋肺止血重在治标，肺肾同调，标本同治。^[15]

16. 岳美中诊治经验

岳氏认为治疗肺结核应分阶段治之。

癆瘵初期一轻型：初起甚轻，往往只有咳嗽，发热，胃纳不佳，周身发懒等。稍进则干咳无痰，痛引胸肋，潮热，食欲减退，机体日渐消瘦，甚则痰带血丝，或咯血。治法：由阴伤阳浮，水涸金燥，喉痒而咳，宜用甘寒养肺，水旺气复而咳自已。药用麦冬、天花粉、生地、杏仁、橘

红、阿胶、桔梗；或由脾胃先虚，不能制水，水泛为痰，水冷金寒而咳，宜用立效方（贝母、杏仁、款冬花、桔梗、五味子、葱白、瓜蒌仁、川椒等共研末，与猪肺同熬，取汁服）加羌活、陈皮、白术；由火烁肺金而咳，宜六味地黄丸；而暴咳喘促，用《圣惠方》款冬花汤（款冬花、桑白皮、五味子、贝母、杏仁、知母、甘草），肺中有寒热，用《千金翼方》竹叶饮子（百部、竹叶、紫菀、紫苏子、白前、生姜），均有效。若咳嗽痰中带血，用《济生方》百花膏（百合、款冬花），可合二冬膏服之，效尤彰；若加白荷花疗痰血、鼻衄有卓效；一般血症，用葛可久《十药神书》十灰散（大蓟、小蓟、荷花、侧柏叶、白茅根、茜草、山梔子、大黄、牡丹皮、棕榈皮，均烧灰存性、为末。用时捣白藕汁或萝卜汁磨京墨半碗，调服 15g），亦可用直指方黑散子（隔年莲蓬、血余炭、棕榈炭），治肺出血可加藕节、旱莲草、茜草根炭、白茅根，效佳，能加重便冲服效也著。潮热骨蒸，可选用秦艽鳖甲汤（秦艽、鳖甲、地骨皮、银柴胡、青蒿、知母、当归、乌梅）；兼五心烦热者，用清骨散（北柴胡、鲜地黄、干地黄、人参、防风、熟地黄、秦艽、薄荷、茯苓、胡黄连）；盗汗者可选用生脉散（人参、麦冬、五味子），并可酌加白芍、浮小麦、煅龙骨、煅牡蛎、稽豆衣、糯稻根等。失眠者，用酸枣仁汤（酸枣仁、知母、川芎、茯苓、甘草）；应该注意的是，初期肺结核咳嗽，要与外感咳嗽严格鉴别，否则一涉误诊，用药有失，病反日深。

癆瘵中期一重型：癆瘵长期不愈，则日晡发潮热，咳嗽不已，或咯血时发，盗汗失眠，厌食，肌肉锐减。治当以平稳而有效的方剂月华丸为主。

癆瘵末期一极重期：症见脉细数而疾，肌肤甲错，大肉尽脱，喘急咳嗽，声音嘶哑，肺部透视有较大空洞，病

至此已极为严重。肌肤甲错可用仲景大黄廑虫丸；有瘀血咳嗽者可用葛可久太平丸（天冬、麦冬、知母、贝母、款冬花、杏仁、生地黄、熟地黄、当归、阿胶、蒲黄、京墨、桔梗、薄荷、麝香）。

本病多阴虚液少，忌用香燥劫阴之药，如半夏、橘红等。亦忌苦寒之药，如知母、黄柏。但若在相互制约的适当配伍下，则常可不在禁忌之列，如麦门冬汤中之半夏，清暑益气汤中之黄柏等，用一味辛燥于大队甘寒药中，或用一味苦寒于多数甘温药中，是取其监制作用，相反相成。

癆瘵末期消耗过甚时，施以滋补，维护其抵抗力，是应当采用的方法，但即使是虚，也不专在一腑一脏，若无目的的漫投补剂则有害。因此必须辨证准确因寒因热，在表在里，是虚是实。此外治疗肺结核于用药物外，还有针灸疗法、饮食疗法等，同时更强调锻炼身体以增进体质，促使本病的恢复。^[16]

【按语】

蔡友敬自拟的“五味抗癆散”具有清热润肺、清热化痰、抗癆抑菌、生肌止血之功，用于空洞型肺结核效果显著可资参考。沈仲圭治疗根据中医病机，多用甘寒养阴之品，对裘吉生治癆五法极为推崇，首选于各期治法之中，如癆损在肺选裘氏清肺宁嗽法，癆损在肾选裘氏养阴止血法，癆损恢复期选裘氏大剂滋养法等等，临床均可借鉴。沈炎南吸收前人经验，治疗肺结核创七法：①清金保肺法，②培土生金法，③滋肾固精法，④养阴柔肝法，⑤养心安神法，⑥滋阴降火法，⑦宁络止血法。李修五治疗肺结核重在甘寒养阴，清金保肺，自拟方抗癆丸有较好疗效，可

资借鉴。姜春华善用止血化瘀法治疗肺结核咯血。祝味菊用健补法加紫河车颇具特色。

(吴艳华)

参 考 文 献

- [1] 蔡光斗, 林禾禧. 五味抗癆散治疗空洞型肺结核. 福建中医药, 1993, 24 (4): 3~4
- [2] 袁海丰, 孙彦章. 老中医沈仲圭治疗肺癆经验举隅. 天津中医, 1985 (3) 12~13
- [3] 杜同仿. 沈炎南治肺结核经验. 江西中医药, 1999, 30 (2): 6
- [4] 周宜强, 韩丽华. 李修五教授治疗疑难杂症的经验. 新中医, 1991, (5): 4
- [5] 张继中, 李冬. 李文欣论治内伤发热经验. 湖北中医杂志, 1994, 16 (3): 4
- [6] 赵莱. 医案两则. 黑龙江中医药, 1987, (1): 30
- [7] 徐若溪. 奚凤霖老师加味运用玉屏风散的经验. 江苏中医杂志, 1993, (1): 3
- [8] 王国三. 支气管内膜炎治验. 江苏中医杂志, 1984, (1): 34
- [9] 周仲瑛. 肺癆十问. 江苏中医杂志, 1985, (3): 34
- [10] 徐景藩. 诊余随记. 江苏医药 (中医分册), 1979, (2): 41
- [11] 王兴华. 张谷才从脾胃论治验案. 湖北中医杂志, 1986, (4): 10
- [12] 戴克敏. 姜春华教授血证治验举隅. 山西中医, 1989, 5 (2): 1
- [13] 王云峰. 祝味菊老中医医案选录. 山西中医, 1990, 6 (5): 27
- [14] 李兴培. 赵锡武教授临床经验撷拾. 辽宁中医杂志, 1986, 10 (7): 3
- [15] 陈启石, 吴孝华. 陶君仁临证治验拾萃. 辽宁中医杂志, 1989, 13 (6): 5
- [16] 岳美中医案

胸腔积液

【名医经验】

陈伯涛诊治经验

甘遂苦寒有毒，《神农本草经》主治：“大腹疝瘕、腹满，面目浮肿，留饮宿食，破癥坚积聚，利水谷”。《别录》“下五水，故膀胱留热，皮中痞，热气肿满”。《药徵》“芫花、大戟、甘遂，同是利水，而甘遂之效最胜矣。”曾治姚某，男，52岁。4个月来，由感冒引起咳嗽，咳吐白沫痰多，入夜咳嗽自汗，纳少，唇干口燥。诊断为左侧胸腔积液。一度病情危急，经吸氧、输液等抢救治疗后，虽有所好转，但咳痰夜甚，呕痰盈罐，自汗纳少，形瘦神疲，一派正虚邪恋之象。诊其脉浮弦滑，舌苔薄黄。风痰互阻上焦，肺气失于宣达，予以加味桂枝加厚朴杏子汤。处方：川桂枝 5g，炒白芍 10g，鲜生姜 3g，肥大枣 12g，炙甘草 4g，川厚朴 5g，杏仁 10g，白芥子 6g，芦根 30g（去节）。先服 3 剂以宣肺、泄浊、达邪，药后咳吐白痰仍多，宗前方去芦根，加入制甘遂 1.5g，甜葶苈 4g，以泻水逐饮，泻肺涤痰。3 剂药后咳吐白痰减半，痰转厚，痰鸣音渐次消失。一度腹鸣大便日行 2 次，伴粘液，病机有下行之渐，药证合拍，惜药力尚不够。原方制甘遂改 2g，甜葶苈改 5g，以增强药力。另加法半夏 6g。再 4 剂而效，吐风痰大

减，痰鸣音消失。大便溏泄夹粘液较多，每日行3~4次后，顿觉胸腹舒适，效不更方，原方加大麦冬9g，以清肺保津，服4剂而诸恙续减。咽部粘痰渐少，自汗减，胃纳开，微呕，口干不思饮。病日久而体气暗伤，遵《内经》“大毒治病，十去其六”之旨。原方去制甘遂，加北沙参12g。续进5剂。胸腔积液既除，邪去正复，原法中加：炒白术10g，茯苓12g，以运脾健中，转方清滋与健运并用，调理半月而痊。^[1]

(吴肇添)

【按语】

胸腔积液，属“悬饮”范畴。本案由外感而停饮咳嗽，因有表证，十枣汤证候不具，因非结胸，大陷胸汤不适用之。方选桂枝加厚朴杏子汤法以宣肺达邪，另加白芥子、甜葶苈协杏仁以泻肺除痰，其间尤以甘遂泻水逐饮为君，效乃大著。方中甘遂与甘草同用，师甘遂半夏汤意，相反相成，法宗仲景，用法而不执方之例证也。

参 考 文 献

- [1] 陈伯涛. 甘遂治疗胸腔积液体体会. 辽宁中医杂志, 1993, 20 (2): 19

结核性胸膜炎

【概述】

结核性胸膜炎常继发于肺结核，可分为结核性干性胸膜炎和结核性渗出性胸膜炎。结核性干性胸膜炎是由于肺结核病灶直接蔓延所致，多发生在肺尖后部，其次为胸下部的胸膜。主要表现为畏寒、轻或中度发热、胸部针刺样锐痛，呼吸运动受限制等。其治疗主要是针对病因治疗和对症治疗。根据肺结核病灶性质及范围给予抗结核药物治疗。结核性渗出性胸膜炎是原发感染后，机体过敏反应高，肺部病灶直接蔓延至胸膜，引起胸膜浆液纤维蛋白渗出所致。主要表现为结核毒性症状、中或高度发热，可持续数日或数周。发病时胸痛明显，积液出现后胸痛消失，大量积液时引起呼吸困难、紫绀，纵隔及心脏移位。其治疗以抗结核药物为主，并积极抽出胸液。中医认为，结核性干性胸膜炎多属气滞血瘀、痰湿内阻之证。结核性渗出性胸膜炎类似中医学的悬饮。可分别按痰瘀证和悬饮辨治。

【名医经验】

1. 陈亦人诊治经验

陈氏认为少阳脉布胸胁。经曰：“邪客于少阳之络，令

人胁痛不得息。”说明胸痛、咳喘与少阳关系密切。中医辨证认为，少阳属胆和三焦，枢机而出水道。邪偏于胆，则枢机郁滞，经脉不利，而发胸胁疼痛；木邪犯肺，而生咳嗽气喘。邪偏三焦，则水道壅塞，而痰湿内生，阻滞胸胁脉络，亦使胸胁疼痛；上犯清虚肺府，更见咳嗽气喘。然津血同源，痰瘀互生。痰湿阻滞，必然影响气血运行，而使瘀血暗生，痰瘀胶固。因而本证瘀血之有无，大要不在可征之舌脉，而在有形之痰水。及其治疗，若偏于胆者宜和解，方用小柴胡汤增损；偏于三焦者，因其病兼痰瘀，故宜在小柴胡汤基础上，更兼化痰活血。至于两者临床鉴别又需借助胸透检查，有积液者病偏三焦，无积液者偏于胆。^[1]

2. 顾丕荣诊治经验

汪昂谓“百病皆由痰起”，顾氏衍其义曰：“百病皆能生痰”，盖痰之为病，必然有以致之，凡因寒、热、气、瘀、风、湿、暑、燥、惊、食、酒、虚，皆能阻遏水津输布，凝而为痰。李时珍谓：“痰涎为物，随气升降，无处不到。”尤其是诸治无效的疑难奇证，诚如前贤所称“诸证怪疾不离乎痰。”顾氏治痰，拟分治痰以祛病，或治本以消痰，尤重补肺以敷布津液，培脾以杜其痰源，补肾以引其归藏，端本澄源，深得古人“见痰休治痰”之旨。

如治迟某，男，18岁，结核性胸膜炎，包裹性积液，胸闷，临暮发热，舌红苔薄，脉右弦左数。此阴虚劳瘵而罹悬饮，控涎丹捣其巢穴，术、苓、苡崇土制水，加芩、部、丹以抗癆，佐生地、鳖甲、知母、银柴胡、青蒿以清蒸透泄。迭进12剂，潮热退清，摄片提示胸腔积液全部吸收。^[2]

3. 朱良春诊治经验

结核性渗出性胸膜炎，中医辨证属“悬饮”之候，治当清邪热，蠲水饮，顾肺阴。

如治胡某，女，19岁。起病20余日，发热（ $T37.8^{\circ}\text{C}$ ），右胸肋疼痛，神疲乏力，在某医院作X线胸透，发现胸腔积液，用西药链霉素、异烟肼治疗，并连续抽胸水计500、800、600ml各1次，病情未能控制。除上述症状外，其舌质红、苔薄腻，脉细弦。此乃悬饮之候，高热虽挫，余热未靖，水阴潜留，并见阴伤之证。处方：桑白皮15g，北沙参12g，杏仁12g，薏苡仁12g，白花蛇舌草30g，鱼腥草（后下）18g，车前子（包）18g，合欢花12g，功劳叶12g。5剂。另用控涎丹3g，1日2次分服。上药服用后大便微泻，小便增多，热已下挫（ $T37.1^{\circ}\text{C}$ ），惟脘闷泛恶，苔薄，脉细弦。X线胸透示：右下肋膈角钝，无明显积液。转方善后，上方去沙参、车前子、合欢花、功劳叶，加山药15g，郁金9g，百合12g，炙枇杷叶9g，红枣5枚。续服5剂。本例始用西药治疗，症状未能控制，因邪热未清，水饮难去，故用汤剂开肺以清热祛邪，兼养肺阴以扶正，并用控涎丹蠲逐水饮，标本兼治，疗效显著。^[3]

4. 赵尚久诊治经验

苇茎汤出自《千金方》，为专治肺痈而设，由苇茎（芦根）、瓜瓣、薏苡仁、桃仁四药组成，具有清肺化痰、逐瘀排脓之效，不但治肺痈有效，对于肺系因痰热蕴结所致其他病症也可用之。如治疗结核性胸膜炎渗出液较少者，用之恰当，每收良效。因胸膜炎有胸腔积液，症见胸闷胀痛、咳逆倚息，可合利水之剂。

如治时某，女，24岁。始胸痛气促，发热盗汗，经某医院诊断为“结核性胸膜炎”，接受抗痨药治疗半年未愈，经X线摄片检查，发现胸腔仍存少量积液。患者自觉胸肋闷痛，咳嗽气急，动则为甚，吐大量黄色稠痰，且全身浮肿，小便量少，脉滑数，舌淡、苔黄腻。此痰热内盛，壅遏肺气，肃降之令不行，首当清热涤痰。先用苇茎汤加法半夏、贝母、茯苓等，服药8剂，咳痰减少，胸闷痛亦略舒，但浮肿未退；继用苇茎汤合苓桂术甘汤，连服20余剂，浮肿消，诸症渐愈。后用苇茎汤合六君子汤调理匝月，病未再发。^[4]

【按语】

陈亦人辨治结核性胸膜炎，偏于胆者宜和解，用小柴胡汤加减；偏于三焦者因其病兼痰瘀，故宜在小柴胡汤基础上更兼化痰活血。朱良春认为，结核性胸膜炎属于中医浮肿之候，治宜清邪热，蠲水饮，顾肺阴。赵尚久用专治肺痛的苇茎汤治疗结核性胸膜炎渗出液较少者，用之恰当，每收良效。

(吴肇添)

参 考 文 献

- [1] 曾庆明. 陈亦人教授从肝胆论治杂病拾零. 江苏中医杂志, 1987, (12): 1
- [2] 汤淑良. 顾丕荣老中医临证经验选介. 江苏中医杂志, 1986, (10): 33
- [3] 任南新. 朱良春临证经验选粹. 江苏中医, 1991, (6): 1
- [4] 贺又舜. 苇茎汤加减运用的临床经验. 江苏中医杂志, 1982, (5): 14

渗出性胸膜炎

【概述】

渗出性胸膜炎又称浆液纤维蛋白性胸膜炎，是由于浆液和纤维蛋白渗出增加，积聚于胸腔内所致，常见于结核性胸膜炎、化脓性胸膜炎和胸膜转移癌的早期。初起胸液不多，故胸痛明显，待胸液增多，壁层与脏层胸膜分开，胸痛消失。大量积液压迫肺脏可出现气急，积液越多，发生越快，症状亦越剧。治疗针对病因及胸腔穿刺抽液，后者可缓解肺、心血管的压迫症状及减轻胸膜增厚。渗出性胸膜炎多属中医悬饮范畴，多从悬饮论治。

【名医经验】

1. 于树正诊治经验

于氏认为渗出性胸膜炎属中医学“结胸”证。

如治张某，男，52岁，因胸痛，伴咳逆、气短、寒热，X线胸透示：心脏边缘隐没，胸腔积液，诊断为渗出性胸膜炎。经中西药治疗，胸腔抽液，病情日趋加剧。诊见：发热（ $T38.2^{\circ}\text{C}$ ）恶寒，头汗出，胸肋隐痛，右侧尤显，胸膈痞胀，懊恼，咳喘气急，痰质稀粘，口干欲饮，便溏，小便短涩。舌苔薄黄，脉弦数右关滑。证属风热内

袭，发为结胸。方选费氏栀子解郁汤，表里双解。处方：豆豉 6g，黑山栀 9g，葛根 5g，薄荷 3g（后下），苏梗 5g，连翘 6g，郁金 5g，白茅根 9g，全瓜蒌 1 枚（打）。2 剂药后汗透热退，胸肋剧痛大减。继服 3 剂，小便增多，胸肋痛、胸膈痞胀均除，咳喘亦平。续作胸透：胸腔阴影消失，心脏边缘清晰。以理气补脾善其后。

于氏谓《伤寒论》所列结胸之证，系因失表早下而得，主用大小陷胸汤（丸）施治。近代费伯雄在所著《医醇膳义》中引申前人学说，云感受风热之邪，直犯胸膈亦能形成结胸。本例发热（体温 38℃ 左右），并非大热，经胸透胸腔有积液，水结胸肋无疑，因其由风热而起，非大陷胸所宜。费氏栀子解郁汤中，豆豉、葛根、苏梗、薄荷善于解表；山栀子、连翘、白茅根清泄里热；瓜蒌、郁金功能除痰解郁宽中。诸药和合，共奏表里双解之功。^[1]

2. 祝味菊诊治经验

祝氏善用温散宣解治悬饮重症。

如治黄某，男，年 30 余岁，体格不健，因气候剧变，初患感冒，咳嗽不爽，连续不断，痰多气急，恶寒发热，胸肋疼痛，倘动作则更甚，病情来势不轻。前医诊为风温痰热，留恋肺络，清肃之令不行，以化痰清热宣肺之品，如淡豆豉、杏仁、橘皮、竹茹、黄芩之类，连服 3 日，无效。诊见：患者咳嗽连声不断，并呼肋肋处痛楚，气急痰声，发热不退，观其胸部状态，胸高膨胀，按之疼痛倍增，舌苔黄白，脉浮滑而数。此乃病在皮里膜外，发炎肿胀，即西医所谓胸膜炎，触诊患处有水声。病症已明，用宣畅气血，宣解化痰，助阳扶正之品，即柴胡、麻黄、桂枝、附子合三子养亲汤法。处方：柴胡 9g，麻黄 6g，桂枝 9g，

炒白芍 9g, 厚附片 (先煎) 14g, 活磁石 (先煎) 30g, 白芥子 9g, 莱菔子 9g, 炙苏子 9g, 制南星 9g, 川贝母 9g, 姜半夏 12g, 橘皮络各 9g。上方用温散化痰佐以强壮之品, 有消炎化痰吸收浆液之功效, 而促使疾病痊愈。服 1 剂后, 热稍减, 痰中无血。2 剂后, 咳嗽爽, 次数少, 痰出较顺, 胸胁之痛大减, 患处肿胀已消失大半, 再连服 3 剂, 病愈, 后以温阳培阴之剂调理善后。^[2]

(吴肇添)

【按语】

于树正从“结胸”证辨治渗出性胸膜炎, 喜用费氏栀子解郁汤表里双解。祝味菊善用温散宣解法治疗渗出性胸膜炎, 处方用药颇具特色。

参 考 文 献

- [1] 于伟勋, 黄万钧. 于树正急症验案撷拾. 江苏中医, 1997, 18 (2): 8
- [2] 王云峰. 祝味菊老中医医案选录. 山西中医, 1990, 6 (5): 27

支气管扩张

【概述】

支气管扩张是指支气管壁炎症性的破坏，以致支气管变形和扩张。临床表现为慢性咳嗽，咳大量脓性痰和反复咯血。自从广泛应用抗生素以来，本病发病率已明显减少。支气管扩张发生的基本因素为支气管、肺的感染和支气管的阻塞。其病位多见于下叶，特别是左下叶支气管，因其管腔较细，且受心脏及大血管压迫而容易发病。支气管扩张的治疗，对病变局限、反复感染、咯血症状明显的病例可考虑肺叶切除。多数病人则因症状轻微或病变太广泛、呼吸功能严重损害而采用内科治疗。在急性感染期应用适当的抗生素、祛痰、体位引流等治疗。支气管扩张属中医“咳嗽”、“咯血”等病的范围。其主要病理是痰瘀阻肺，郁而化热。肺气以清肃下降为顺，气道壅塞为逆，只受纳清气，受不得浊气，浊气犯肺，痰液粘稠难出，郁而化热，可导致支气管扩张反复发作，痰、热、瘀是本症的病机重心。外感六淫之邪以及内因七情所郁，常为本病的诱发因素，也是致病因素之一。病程迁延，郁热伤阴，又可出现肺热阴虚。由于肝脉上注于肺，部分患者可因素体肝旺，易气郁化火，肝火上炎，上逆犯肺，而出现肝火、热证。治疗本病的原则，根据病机，在急性发作阶段，以清热、排痰、止血为主；缓解期以益气阴，行瘀滞为主。

【名医经验】

1. 洪广祥诊治经验

洪氏从以下四个方面进行辨证施治。

①痰热瘀阻证：此证多见于支扩的急性发作阶段。症见咳嗽，气息粗促，痰黄粘稠，咳吐不爽，胸部隐痛，或痰中带血，血色鲜红、紫暗相兼，或发热，舌质红暗，苔黄腻，脉弦滑数，治疗重在泄热祛痰。常用药：葶苈子 10~15g，虎杖 15g，浙贝母 10g，金荞麦根 30g，天葵子 15g，十大功劳 15g，七叶一支花 15g，冬瓜仁 30g，卫矛 10g，桃仁 10g，生大黄 10g。本方具有较强的抗感染作用，如痰及呼吸有臭味，痰培养有绿脓杆菌或厌氧菌感染时，可加用败酱草 15~30g。本方组合意在直挫病势，但药性偏于寒凉，对脾胃虚弱的患者，必要时减量，或稍佐健脾和胃之品，如鸡内金、炒麦芽、法半夏、陈皮等。有气阴两虚见证者，可适当加用孩儿参、北沙参、麦冬、百合等益气养阴的药物。

②肝火犯肺证：症见呛咳阵作，咳时面赤，咽干，情绪急躁易怒，胸胁胀痛，或痰中带血，血色鲜红，舌质红，苔薄黄，脉弦数。此证主要表现火象突出，如果不及时控制，火热之邪伤及气阴，可致气阴两虚或肺热阴虚，治疗重在清肝泻肺，以阻止病情发展。常用药为：青黛 10g，海蛤壳 15g，丹皮 10g，栀子 12g，枇杷叶 10g，黄芩 10g，白头翁 10g，秦皮 15g，桃仁 10g。胸胁胀痛明显者加瓜蒌皮 15g，郁金 10g；大便干结者加生大黄 10g，既可通便，又可使火、热之邪下行。

③热伤血络证：以咯血为主症。症见痰中带血或纯血

鲜红，出血量多，舌红、苔黄，脉弦数。此证常伴痰热壅肺或肝火犯肺的本经证候，治疗重在清热泻火，凉血化瘀止血。洪氏认为，支气管扩张咯血的治疗，重点应放在清肝泻肺而达到止血之目的，所谓“治火即是治血”。澄本清源以治其本。常用药：黄芩 10g，青黛 10g，生地 30g，白茅根 30g，桑白皮 15g，藕节炭 40g，茜草 15g，生大黄 10g，参三七 6g。此证与前证均从肝肺来论治，但前者以清肝为主，后者以泻肺为主。

洪氏认为，咳嗽和咳痰不畅，常常是诱发或加剧咯血的重要原因之一，因此注意“镇咳祛痰”是控制和减少出血的重要环节。对于支扩因咯血量大而引起窒息者，应合理配合西医治疗，以取长补短，提高疗效。中药可试用羊蹄根 50g，接骨仙桃草 30g，紫珠草 30g，三七末 10g，水煎取药液作保留灌肠，每次 200ml，每日 1~2 次。此方法不仅有利于咯血患者克服口服汤药难的弊端，而且可以明显提高止血效果，为大量咯血的患者提供了新的止血给药途径。

④肺热阴虚证：此证多见于支气管扩张症症状缓解的阶段，此时感染控制，咯血停止，仅有咳嗽，气短，乏力，胸部不舒，口舌干燥，或者低热，舌质偏红暗，苔薄少或乏津，脉象细数，治宜益气养阴，化瘀通络。常用药：孩儿参 30g，北沙参 15~30g，麦门冬 10g，百合 15~30g，玉竹 10g，川贝 6g，淮山药 15g，十大功劳叶 15~30g，丹皮 10g，赤芍 10g，桃仁 10g。如脾胃虚弱，运化不及，食欲差者，加鸡内金 10g，谷芽 10g，麦芽 10g，白豆蔻 6g，以健脾助运；有明显的低热者，洪氏认为，不一定都属阴虚，痰热郁遏于肺也会出现低热，如处理不当，将有可能再度出现急性复发。可用金荞麦根、七叶一枝花、天葵子、

鱼腥草之类药物以控制感染；若低热确属阴虚所致，可加用清虚热药，如银柴胡、白薇、地骨皮等。

以上四证是支扩的常见证候，临床应辨证施治，灵活掌握，方能切合实际，提高疗效。洪氏认为治疗本症还应注意以下几个方面。一是根据病人的体质及季节注意选用方药。就大多数患者的体质来看，气火盛旺，阴虚肺燥者居多，而支气管扩张的发作常以春季和秋季为多，这与中医所称的肝气旺于春，和秋燥伤肺的特点有着密切的关系。因此对支气管扩张症的患者要注意在春季服用平肝清肺方药，而在秋季就应服用清燥润肺方药。这对改善患者适应自然界气候的调节能力，控制急性发作有良好的作用。二是缓解期应着重调肝、泻肺以达到治肝理肺之目的。支扩的部分患者常因情绪抑郁，郁而化火或性情急躁，暴怒伤肝，以致肝火横逆侮肺，而激发支气管扩张症的急性发作，此类患者的证候表现，常以咯血为主，多数是出血如注，肝火之盛和邪火迫肺的见证突出，因此对这类患者缓解期着重调肝泻肝为主，可起到预防支气管扩张急性发作的作用。三是积极治疗并发症，减少复发机会，提高临床疗效。支气管扩张症患者多伴有鼻窦炎，扁桃体炎和慢性阻塞性肺疾患，如慢性支气管炎、支气管哮喘、慢性阻塞性肺气肿等，肺结核也常为并发症之一，因此对并发症的积极治疗，有利于减少或控制支气管扩张症复发机会，并有效地提高临床疗效。四是缓解期应注重扶正固本，减少复发机会。支气管扩张症患者，体质多虚，防御能力低下以及痰粘稠，排痰不畅，这是造成反复感染的重要原因。所以缓解期应扶正固本，通过补益肺、脾、肾以提高机体免疫功能，增强抗御外邪的能力；另对排痰不畅者，可在辨证方药中加鲜芦根、冬瓜仁、南沙参、浙贝母、麦冬、海蛤壳

等药，可使痰液变稀有利于痰液的排出，达到驱邪以扶正，邪去正自安之目的，从而减少复发机会。

如治刘某某，男，50岁，干部，1982年10月6日初诊。患者4岁时患百日咳，治疗不彻底而继发支气管炎，常在受凉后咳嗽加重，虽经中西药治疗效果不甚满意。1958年出现气喘，尤以活动后症状加重。1964年痰中带血，黄痰增多，经某医院X线胸片和纤支镜检查，诊断为慢性支气管炎，慢性阻塞性肺气肿，支气管扩张（右下）。本次发病前3天因受凉而诱发咳嗽，以干咳为主，伴咽喉、口鼻干燥，某医院给予枇杷止咳糖浆、蛇胆川贝液和复方新诺明，用药3天症状未见减轻，而来中医门诊求治。症见咳嗽阵作，以呛咳为主，咳时气粗面赤，胸肋作痛，痰黄稠粘而难咯出，痰中见鲜红血丝，口唇鲜红，口苦而干，大便偏结，小便偏黄，患者平素为肝气偏旺之体，性情急躁易怒，舌质偏红略暗，舌苔黄而稍腻，脉弦滑数。证属外感燥热，气火犯肺，痰热郁遏，肺失肃降。治以凉燥泻肝，清肺化痰为主。方用枇杷叶10g，瓜蒌皮15g，桑白皮10g，黄芩10g，净青黛10g，海蛤壳15g，生大黄10g，金荞麦根30g，白茅根30g。服药5剂，诸症明显改善。复诊仍以原方再加丹皮、赤芍以祛瘀宁络，前后共服药3周，症状完全消失。后又以清肝理肺，化痰通络方药（青黛、海蛤壳、川楝子、百合、三七、水蛭、酥鳖甲、金荞麦根，为丸，每日3次，每次10g），连续服药观察半年，未出现支气管扩张症状明显发作，经X线胸片复查，与原片比较，扩张范围有所缩小，纹理粗乱征象亦有明显改善。^[1]

2. 邵长荣诊治经验

①清肺化痰抗感染：支气管扩张是一反复感染性疾病。

病人多有反复长期应用多种抗生素的经历，然而临床上并不能完全控制症状。咳吐黄脓痰、绿痰、分层痰就是肺部反复感染的表现。辨其原因，邵氏认为由于痰热壅遏于肺所致，更由于肺与大肠相表里，腑气不通，胃肠之热熏蒸于上，痰热壅肺不解，肺失宣肃而致咳痰不止。鹿衔草为一祛风湿药，民间多用于肺热咯血。邵氏用此药合大剂量黄芩取其清肺凉血之功，再配以蚤休、鱼腥草、败酱草增强清肺热、化脓痰作用，加入桃仁、生大黄润肠通腑，达到祛痰消炎的目的。

②平肝清火疗咯血：肝脉上注于肺，肝失疏泄，肝火偏旺，木火刑金，灼伤肺络，而出现肝火肺热之咯血症状。邵氏认为，支气管扩张咯血除了疲劳、用力过度引发外，还与患者情绪抑郁或性情急躁有关。支气管扩张的急性发作，常咯血如涌，患者的肝火炽盛和邪火迫肺见症非常突出，治疗应平肝清火为先，以阻止病情发展，火降则血宁静，气顺血自归经。对于少量咯血，长期不愈的患者，邵氏认为，反复咯血往往有瘀血交叉存在，治疗要在平肝清火的基础上加入几味活血法瘀的药物，如川芎、桃仁等，这是行血和止血的辩证关系，往往起到相辅相成的作用。

③健脾化湿祛顽痰：支气管扩张患者常常咯痰不尽，邵氏辨此为痰湿阻肺。痰湿阻肺常使支气管扩张缠绵难愈，此时用一般的清肺化痰药疗效平平，而以健脾排痰祛湿的方法常可获效，这是治疗支气管扩张的关键。肺为贮痰之器，脾才是生痰之源，脾气虚弱，不能运化水湿，久则聚而为痰，痰湿互结，上阻于肺，使患者咯痰不已。治病必求其本，健脾才能使之运化功能恢复。邵氏常用二陈平胃散健脾化湿，配用陈葫芦、防己、车前草加强利湿之功，合黄芪益气补脾，以促进培土生金的作用，使元气恢复。

有的患者咯痰厚粘，且量多，咯之不畅，邵氏认为此乃老痰。因为宿痰伏肺，气机郁滞，升降失常，常可影响血脉运行，出现痰瘀胶结不解，邵氏常用自拟的三海汤，即海浮石、海藻、海蛤壳。其中海浮石、海蛤壳入肺经，具有软坚化痰清肺之功。《本草衍义补遗》称此药具有“消积块，化老痰”之效。邵氏认为，排痰化湿是一个缓慢过程，用药宜渐消缓化。如果猛剂急攻，则痰未消而正气已伤，必须权衡邪正虚实，缓急轻重。必要时用攻补兼施的方法，可酌加功劳叶、仙鹤草益气补虚，提高免疫力。

④副鼻窦炎与支气管扩张同治：副鼻窦炎，中医称之为鼻渊。慢性副鼻窦炎经久不愈，脓涕沿着咽喉，气管壁向下流，沉积于小支气管，使其反复感染，久而久之是造成支气管扩张的重要原因。以右下肺多见，而支气管扩张又常因感冒、上呼吸道感染而导致复发，尤其是合并副鼻窦炎者，使支气管扩张的防治更为复杂。邵氏在长期临床实践中常将两病同治，选用千金苇茎汤加入鹿衔草、黄芩、佛耳草、山海螺、鱼腥草等药清热解毒、排脓痰。对鼻塞严重患者，还在处方中配伍辛夷、苍耳子、路路通等开窍通鼻的中药，可获得意想不到的效果。

如治张某某，男，37岁，1994年6月22日初诊。有支气管扩张病史20余年，平时痰多，经常咯血。1年前因患病毒性肝炎后，咯血增频，每次咯血量多，1碗左右，经X线胸片和肺部CT检查确诊为左下肺支气管扩张。住院用垂体后叶素、止血敏、青霉素等治疗。近日因风邪外感，咳嗽咯血又作。症见：面色萎黄，咯吐黄痰，咯血鲜红，动则汗多，气促，无发热，口淡纳少，两便尚调，舌苔薄腻，脉细滑数。辨证肝火犯肺，痰热内壅，灼伤肺络，拟平肝清肺，凉血止血为治。药用：柴胡9g，前胡9g，丹

皮 9g, 炒蒲黄 9g, 川芎 9g, 连翘 9g, 野菊花 12g, 夏枯草 12g, 茜草根 15g, 鹿衔草 18g, 黄芩 18g, 平地木 30g, 野荞麦根 30g, 7 剂。二诊: 药后咯血已止, 咳嗽痰多, 每日痰量约 100~200ml, 色黄、夹有血丝, 舌苔薄腻, 脉细滑。原方加炒藕节 9g, 7 剂。三诊: 痰血已除, 咳减痰多, 每日痰量约 200ml, 色黄粘稠, 鼻塞流黄涕, 身重胸闷, 胃纳不馨, 口淡, 两便尚调, 舌苔薄腻, 脉沉细。拟清肺健脾, 祛痰通窍。处方: 鹿衔草 9g, 连翘 9g, 佛耳草 9g, 苍术 9g, 白术 9g, 陈皮 9g, 姜半夏 9g, 生甘草 9g, 海藻 9g, 苍耳子 9g, 路路通 9g, 黄芩 15g, 猪苓 12g, 茯苓 12g, 海蛤壳 12g, 海浮石 12g, 14 剂。四诊: 痰咳较爽, 痰量减少, 鼻通, 黄涕仍有, 乏力, 动则汗多, 舌苔薄腻, 脉细滑, 治拟原方去鹿衔草、连翘, 加党参、黄芪、防风, 14 剂。五诊: 咳嗽、咯痰、黄涕基本消除, 再拟益气固表、健脾培本调治, 病情趋向稳定。但不久因劳累感冒, 咯血又起, 但这次咯血量明显减少。邵氏认为这是疾病转归过程中常有的现象。用上述方法复治 1 月, 即控制病情。随访半年, 病未复发。^[2]

3. 曹鸣高诊治经验

本病的病理机制在本为肺阴不足, 在标为痰热瘀阻。肺虚则肺叶不举, 通气不畅, 瘀浊不易排出体外, 聚而蒸热; 另一方面, 原供养肺体之津液, 反化痰浊而肺用为之所困。通调治节, 各失所司。痰浊瘀积堵塞气道, 而致气管扩张。复因反复感染而日益加重, 咯出大量脓痰, 甚至损伤阴络导致咯血。治宜养阴以濡肺体, 益气以复肺用, 百合固金合保元汤加减为主, 佐以黄芩、石膏、鱼腥草、金荞麦、桑白皮、红藤、黛蛤散等以清热化痰。如卫虚易

感，可用玉屏风散固表以防感染。在大咯血时，须急则治标，用醋制大黄、黄芩、茜草炭、牛膝炭、生地、阿胶珠、参三七、童便、白及粉等以止血为急务。^[3]

4. 陆孝夫诊治经验

支气管扩张咯血为内科急症之一。咯血之症，或咳或不咳，血自肺系而来，从口中而出，其病机多由气火上逆，阳络损伤而血随上溢所致。气属阳而易动，血属阴而宜静，如妄动则为病；又“气有余便是火”，火性上炎而灼伤肺络，迫血妄行，使血不循经而上溢，则咯血由此而作。咯血之症，论其病因，又有外因与内因之异，其外因常归咎于风温燥湿的侵犯，而风温燥湿诸邪又均易伤津动血。其内因多为七情过极，五志化火，或素体阴亏，阴虚火旺，火升则血溢。然也有气阴两虚，气不摄血等。陆氏治疗支气管扩张咯血，重视调整脏腑气机，特别是肝肺两脏的升降功能。他认为：咯血的发生与肝肺两脏的气机升降失调关系最为密切，盖人身气机，一升一降，从而保持气血上下左右之周流不息。倘若情志过极，则气机横逆；阴虚水不涵木，则肝阳妄动，肝升太过，势必肺降不及，有升无降则气血上壅而溢矣。朱丹溪说：“有升无降，血随气上，越出上窍，法当补阴抑阳，气降则血归经。”对内伤咯血的辨证，尤其强调“木火刑金”这一点，治疗立法极注重柔肝平肝，抑阳养阴，常用药物有山栀子、黛蛤散、白芍、珍珠母、羚羊角、怀牛膝、龙骨、牡蛎、知母、阿胶、生地、天冬、麦冬、玄参等。对肝火上逆所致的咯血，主张降气不降火，认为气有余便是火，降气即是降火，盖降火必用苦寒，而苦寒伤胃，胃气伤则脾不统血，血愈不止，如使气降从顺，则血自归经，此不求止而自止也。常选用

龙骨、牡蛎、赭石、怀牛膝、旋覆花等随证加減。

陆氏主张止血必行血。盖络伤血溢，离经之血不能复还故道，旧血不去则新血不生，倘若一味寒凉止血，血得凉而陈者不行，新者不生，致使瘀物愈积，而血愈不止。故止血必以行血，治当化瘀止血或“祛瘀生新”。常在止血药中选用三七、丹参、茜草、丹皮、桃仁、刘寄奴等随证加減，其中尤以三七最为常用。其认为，咯血之症，多保留一分自身之血，则多得一分生机，故恰当地选用合宜的药物至关重要。止血选用炭剂要有选择：侧柏炭、小蓟炭、大黄炭、茜草炭、熟地炭、莲房炭、十灰丸等可以用之；止血药中宜佐行血药，如三七、丹参、桃仁、茜草、丹皮等，切忌辛燥耗气之品；止血宜用清热，热清血自止。瓜蒌、山栀子、青黛、海浮石等均可随证选用；反复咯血，血去则阴伤，有形之血不能速生，无形之气当急固。盖益气摄血，方有四君子汤、六君子汤；参、芪亦为常用药。但一味补气又造成“气有余便是火”，又当配合滋润之品，如玉竹、玄参、天花粉、天冬、麦冬、沙参等，以防其偏。^[4]

5. 祝谌予诊治经验

支气管扩张（咯血）中医学认为多为热伤肺络，血热妄行。施今墨先生说：“血从上出，宜降血；血从下出，宜升血；血从下部、上部齐出则治其中。”祝氏选用旋覆代赭汤加味治之，所加药味选取凉血、止血、化瘀之品，如茜草、紫草、三七之属，亦配用对药花蕊石和鹅管石，仙鹤草和血余炭，冬瓜子和丝瓜络。共奏降气、凉血、止血、补络之功。常用药为：旋覆花 10g（布包），代赭石 20g，黄芩 10g，清半夏 10g，党参 10g，茜草 15g，紫草 15g，鹅

管石 20g, 花蕊石 20g, 仙鹤草 15g, 血余炭 10g (布包), 冬瓜子 20g (打), 丝瓜络 10g。出血多加三七粉 2g (分 2 次冲服); 出血久加阿胶 10g (烔); 气短加五味子 10g 以敛肺气。

如治雷某, 男, 74 岁。患支气管扩张 40 余年, 时常咳嗽, 咯血。近半个月来因感冒致使咯血日重, 每晨起连咯数口血, 平时痰中带血或有血丝。伴见面色㿔白, 眼下浮肿, 神疲, 声低, 口干, 纳少, 二便可, 舌淡暗、尖红、舌下瘀紫, 脉弦细数。证属肺阴虚, 迫血妄行。治以养阴、降逆、凉血。用上述基本方去冬瓜子、丝瓜络, 党参改为太子参 30g, 加阿胶 10g (烔化), 五味子 10g, 麦冬 10g, 三七粉 2g (分 2 次冲服), 7 剂。服 3 剂后, 晨起已不咯血。尽剂后痰已不带血, 原方再服 7 剂, 同时配丸药以巩固疗效。丸方: 苏子 30g, 白芥子 10g, 莱菔子 30g, 葶苈子 30g, 桑白皮 30g, 旋覆花 30g, 黄芩 30g, 清半夏 30g, 茜草 50g, 紫草茸 30g, 百部 30g, 血余炭 30g, 阿胶 30g, 仙鹤草 60g, 西洋参 30g, 三七 30g, 五味子 30g, 天麦冬各 30g, 丝瓜络 30g, 冬瓜子 30g, 炙甘草 30g。共研细末, 炼蜜为丸, 每丸重 6g, 每日早、午、晚各服 1 丸。服此方 2 月余未再犯病, 嘱其效不更方, 再配 2 剂常服。^[5]

6. 赵尚久诊治经验

用苇茎汤以治肺系疾病为多, 如用于支气管扩张, 以咯吐痰血、浓痰者为宜。苇茎汤出自《千金方》, 原为专治肺痈而设。方由苇茎 (芦根)、瓜瓣、薏苡仁、桃仁四药组成。具有清肺化痰、逐瘀排脓之效。若偏咯血者, 合黛蛤散。偏咯浓痰者, 加瓜蒌、贝母等。

如治何某, 男, 38 岁。因反复咳吐痰血近 3 年, 曾在

某医学院诊断为“支气管扩张”，屡服中西药罔效。来诊时，咳嗽频作，咯脓血样痰，量多，腥臭，自诉情绪急躁，口渴喜冷饮，每咳甚时，面呈青紫，气喘难回。舌紫黯、苔黄厚，脉弦数。辨证属肝火犯肺，炼液成痰，痰热蕴阻，络脉损伤，故见斯证。处方：芦根 30g，冬瓜仁 30g，薏苡仁 25g，桃仁 10g，青黛 10g，海蛤粉 15g，桑白皮 15g，全瓜蒌 12g，田三七 5g（磨兑）。水煎服 5 剂，咳吐脓血大减，后以苇茎汤合参麦散加味，续服 30 余剂而愈。^[6]

7. 苏万方诊治经验

①除郁热，着眼导赤清心：心肺同居上焦，隔膜相连。心属火，肺属金，火克金，心热易传于肺。苏氏每于心有郁热，化火灼伤肺络之咳血，必从导赤清心论治。心烦与小便短赤同时并见是辨证要点。基本方：生地黄、木通、淡竹叶、山梔子、连翘、白茅根、芦根。用药轻清灵动，符合“治上焦如羽，非轻不举”之意。如治孙某，男，57 岁。恙由郁闷，咳痰咯血已 6 天，初为鲜红色纯血，今日咯出紫暗色夹有粘痰，咳嗽胸膈疼痛，心烦口干欲饮，小便短赤，大便干燥，舌尖红、苔薄有齿痕，脉细数。X 线胸片示：慢性支气管炎、支气管扩张。此乃心肺郁热，灼伤肺络，治拟导赤清心。处方：生地黄 12g，木通 4.5g，连翘 9g，黑山梔子 9g，瓜蒌皮 9g，鲜白茅根 30g，淡竹叶 15g。3 剂药后，痰偶带血丝，胸闷烦热大减。守原方再服 3 剂，诸恙得平。本例心肺同治。方合导赤散、梔子豉汤意，再增芩、蒌以宽胸清热。叶天士对仲景梔子豉汤颇多推崇，谓其方功在解郁热，宣郁结。凡中上焦，气分郁热，用之常效。导赤散移心热于小肠，立法轻清。《丹溪心法》云：“心清则小便自利，心平则血不妄行”。郁热宣清，血

热自宁，故收效迅速。

②补肺气，宜防患于未然：肺阴不足，虚热内扰，血络不宁，以致妄动咳血。苏氏认为临床见证错综复杂，用药时要时刻不忘顾护肺气，防患于未然。《景岳全书·吐血证治》中云：“凡治血证，须知其要，而血动之由，惟火与气耳”。并指出注意察其气虚气实。久咳伤肺，气阴两虚者常较多见，治宜兼顾。基本方：太子参、淮山药、茯苓、沙参、麦冬、黄芩、百合、川贝母、野荞麦根。用野荞麦根，取其甘凉微涩之性，清热解毒，排痰化瘀之功；补气不用参、芪、术，以防温燥动火之弊。

如治张某，女，73岁。有支气管扩张病史30年，每逢冬季咳嗽频繁，并伴有咳血。近半月来，咳血又发，血量每次100~200ml。X线胸片报告：慢性支气管炎，支气管扩张。白细胞计数 $12.4 \times 10^9/L$ ，N0.76、L0.24。自觉乏力，口干烦热，咳血色鲜红，舌胖质红，脉细数。此属阴虚肺热，肺络失宁。法当养阴清肺，佐以益气扶正。处方：太子参12g，生地黄12g，百合12g，北沙参12g，麦冬12g，黄芩9g，炒赤芍9g，淮山药15g，五味子6g，川贝母10g，野荞麦根30g。3剂药后，咳血大减。守方续服数剂，咳血止。本例长期咳嗽，损伤肺阴，阴虚火旺，虽未见明显气虚证候，但已有乏力，故用太子参、山药益气扶正，一使正气得充，先安未受邪之地；二在大队滋阴药中佐以益气之品，有阴中求阳之意。患者病情所以速愈，是因兼顾肺气之故。^[7]

8. 李寿山诊治经验

李氏临床遣方用药，多宗仲景方证对应结构，即以病机为基础，根据主症确定主方，病依症状不同变化，在主

证中对药味作相应的变通加减，以使药病相得，用之于急难重症效验尤著。

如治徐某，男，60岁。患咳喘20余年，反复发作。近半月来由外感诱发咳嗽，伴有大概血不止。经北京某医院诊为支气管扩张、肺结核瘤、肺不张。中西医结合治疗罔效，特邀李氏会诊。诊见：患者精神萎靡，面色㿖白，呼吸困难，不能平卧，形态虚浮，烦躁汗出，语声低微，喉有痰声，咳中带血，其色浅红或黯红有块，每次约100～300ml，心悸乏力，不欲进食，二便尚可。舌质淡而胖嫩、苔黑而润，脉虚数。前医曾用输血、吸氧、控制感染、止血镇静等西药治疗，并用中药十灰散、咳血方等均未效。综观诸症，辨为阳虚挟寒不能摄血所致，宜用《金匱要略》柏叶汤加减。处方：侧柏叶20g，炮姜15g，艾叶10g，西洋参25g，水煎频服，童便100ml，每服药前先服5～10ml。药后咳血渐少。服至6剂，血已全止，遂用生脉散加阿胶，以西洋参代人参扶阳，以资善后，服药10余剂，患者纳增体健，诸症霍然而平。

对于本例，前医用十灰散、咳血方等凉血止血之剂而不效，李氏改用温药敛血而获效，其理安在？李氏认为，治疗疾病，须主症主方，药证相符。盖吐衄病者，一般说属血热妄行者居多，法当凉血以止血，但亦有因失血过多，热随血去，阳气亦虚，不能摄血者，则其治法当用温药温经以止血。仲景方如柏叶汤之用干姜、艾叶，黄土汤之用炮附子，甘草干姜汤之用干姜，皆属此法。本案辨证要点，高龄久病，元气已亏，今咳血反复发作，气阴必虚，临诊面㿖、少气、声微、心悸、舌淡苔黑而滑、脉虚数等，皆系阳气虚弱不能摄血之证，其中脉数属“膈气虚，脉乃数也”之虚数脉。若不识脉证，误用清热止血之品，虽塞流

而血不能止。本方以柏叶汤温经止血，童便代马通汁，咸寒降逆而消瘀，加西洋参以补血敛血，养阴益血而又无人参升发之弊。惟嫌干姜辛热刚燥，故炒黑取其苦温收涩，继以生脉散加阿胶补肺之气阴而善其后，方证对应，药证相符，故收预期效果。^[8]

【按语】

洪广祥从四个方面辨治支气管扩张：①痰热瘀阻证，②肝火犯肺证，③热伤血络证，④肺热阴虚证；邵长荣对支气管扩张亦从四个方面辨治：①清肺化痰抗感染，②平肝清火疗咯血，③健脾化湿祛顽痰，④副鼻窦炎与支气管扩张同治。两医家分型辨治各具特色，足资参考。曹鸣高治疗支气管扩张，主张养阴以濡肺体，益气以复肺用，常用百合固金合保元汤加减为主治疗。陆孝夫重视调整脏腑气机，特别是肝肺两脏的升降功能，立法极注重柔肝平肝，抑阳养阴，对支气管扩张咯血的治疗具有指导意义。祝湛予治疗支气管扩张咯血选用旋覆代赭汤加味治之，所加药味多为凉血化瘀、止血之品，是其经验总结。

(郭桃美)

参考文献

- [1] 赵凤达. 洪广祥治疗支气管扩张的经验. 北京中医, 1995, (1): 10~11
- [2] 夏以琳. 邵长荣治疗支气管扩张的经验. 中医杂志, 1997, 38(1): 15~16
- [3] 曹世宏, 曹蓓蓓. 曹鸣高教授治疗肺系疾病心法举要. 江苏中医, 1994, 15(4): 3
- [4] 丁厚第. 陆孝夫治疗支扩咯血的经验. 江苏中医杂志, 1987,

(4): 4

- [5] 祝湛予. 临床用药经验两则. 山西中医, 1989, 5 (1): 5
- [6] 贺又舜. 苇茎汤加减运用的临床经验. 江苏中医杂志, 1982, (5): 14
- [7] 陈国桃. 苏万方老中医治疗咳血的经验. 辽宁中医杂志, 1986, 10 (10): 20
- [8] 杨容青. 李寿山老中医遣方用药拾萃. 辽宁中医杂志, 1989, 13 (11): 1

肺 炎

【概述】

肺炎是指肺实质的炎症。主要有肺泡内和间质的炎症细胞浸润、浆液和（或）纤维蛋白渗出，乃至实变等变化。肺炎按解剖部位可分为大叶性肺炎、肺段性肺炎、小叶肺炎和间质肺炎，按感染来分，又可分为细菌性肺炎、病毒性肺炎、衣原体肺炎、支原体肺炎等等，根据病因给予治疗。肺炎与中医学中的风温、肺热病、肺炎喘嗽颇为相似，常因寒温失常、劳倦、醉后当风等，导致人体正气不足，肺卫不固，复感风热之邪或风寒入里化热而发病，即温病学所说的“温邪上受，首先犯肺”。本病病位在肺，疾病的性质主要属于痰热，故清热解毒、清肺化痰是治疗本病的基本原则。初期邪在肺卫，应配以辛凉解表以祛邪；极期痰热壅肺，则当加强清肺化痰以祛邪；痰热消退，余邪未清，治以益气养阴、润肺为主；若见阳气欲脱者，宜急以回阳固脱。

【名医经验】

1. 赵绍琴诊治经验

赵氏认为肺炎多发于冬春二季。其病因病机多为内有

蕴热，外受温邪，内外合邪，卒然而发。故本病当属中医温病范畴，于风温中考之。

肺炎的主要临床表现有高热、形寒、咳嗽、气急、胸痛、吐铁锈色痰等，一般发病较急，在小儿容易引起昏迷、惊厥。中医治疗此病，并无特定处方，临床合参脉、舌、色、证，辨证施治，每可收到良好效果。赵氏在临床上一分为五型治疗。

肺热壅盛型：内热素盛，又感温邪，两热相合，证见高热，喘咳，气急，脉洪数弦急，舌红，苔黄质绛。此型以肺热为主，热邪郁闭，不得宣泄，是以喘咳不能平卧，治宜宣肃清化。药用：苏叶 6g，生石膏 30g，知母 10g，前胡 6g，杏仁 10g，芦根 10g。水煎服，日 3 夜 1 服。

表气闭遏型：证见高热，形寒，气急，胸闷，面色青暗，脉浮滑，舌苔白腻质红，此型热郁因于表闭，治疗必先开其郁闭，用宣肺开郁法，俟其肺气开、表气解，自当气降而喘咳即平。药用：麻黄 3g，生石膏 15g，杏仁 10g，前胡 6g，芦根 10g。水煎服，日 3 夜 1 服。

痰湿内阻型：素有痰湿内蕴，温邪外袭而发，证见寒热，喘咳痰多，胸中满闷，舌胖苔白腻，滑润多液，脉沉软缓滑，用宣肺化湿法，以利气机之开合。药用：苏叶 10g，苏梗 10g，苏子各 10g，麻黄 3g，半夏 10g，厚朴 6g，杏仁 10g，炙枇杷叶 10g，冬瓜子 10g。

痰浊壅肺型：此型痰浊壅盛，证见喘咳痰鸣，痰多且稀，周身酸楚乏力，患者常以胸闷为苦，是其特征，舌苔白滑垢腻、根部厚浊，脉象沉弦滑，按之有力。治以三子养亲汤，豁痰利气，止咳平喘。药用：苏子 6g，莱菔子 10g，白芥子 6g，冬瓜子 10g，皂角刺 4g，前胡 6g，浙贝母 10g，半夏 10g，甜葶苈 6g。

阴伤燥热型：肺阴不足，燥热较甚，身热口干，干咳胸痛，痰粘难出，舌红且干，脉细弦数，用泄热润肺法，泻白散加减：苏叶 6g，苏子 6g，桑白皮 10g，地骨皮 10g，麦冬 10g，南沙参 10g，杏仁 10g，炙枇杷叶 10g，清半夏 10g，黛蛤散（包）10g，瓜蒌仁 20g，茅根 30g，芦根 30g。

上述五型，临床多见，依法治之，多可获效。又有重者，或在小儿，可见神昏抽搐，此时宜详察其因，因于表闭者开其闭，因于热郁者泄其热，因于痰蒙者化其痰，未必皆需安宫、至宝，仍于各型证治中求之，但得肺气宣畅，热泄痰清，则自可神清抽平。^[1]

2. 曹鸣高诊治经验

肺炎属中医风温之为病，冬春居多。发热，畏风，头身疼痛，咳嗽，胸闷，口渴，苔白，脉浮数。邪从上受，肺胃内应，宜先透发，药用：淡豆豉、黑山栀、前胡、牛蒡子、杏仁、枳壳、瓜蒌皮、通草、枇杷叶、薄荷，辛凉解表，是为正治。风为阳邪，温从热化，不宜过表，汗多则易灼津耗液，反化燥火，而致动风昏陷；亦不宜早用寒凉，恐遏其邪，反不易解，导致内传生变。

若发热不退，汗出不多，烦渴多饮，面红唇焦，咳嗽频频，胸闷气急，胸胁引痛，甚则碍于呼吸，咯痰黄稠，或带血、或呈铁锈色，舌边尖红，苔黄，脉滑数。此温邪郁蒸肺胃，行将化火劫津，内陷心包，宜用鲜石斛、炙麻黄、杏仁、生石膏、黄芩、生甘草、葶苈子、射干、丹皮、黑山栀、鲜生地、白茅根、郁金、带子丝瓜络、红花、三七等，以泄热生津，宣肺和络。

如壮热，烦躁，口渴恣饮，谵语不寐，舌质绛、尖见芒刺，是邪深渐欲入营之象，须即撤气药，转用大剂犀角

(用水牛角代)、羚羊、生地、石膏、丹皮、连翘、玄参、鲜菖蒲、金银花、芦根、白茅根等，以凉血透邪，存阴泄热。必要时，可用神犀丹，以防内陷心包，昏痉厥变。

若持续高热，谵语，渴喜凉饮，腹痛拒按，矢气频频，舌绛苔黑，齿垢唇焦、脉实等种种燥实见证而元气尚可者，则非急下存阴不可，凉膈承气，量其轻重进之。如病久津枯液涸，虽实证已备，当先滋阴救阴，投鲜菖斛、鲜生地、西洋参、玄参、麦冬、水牛、大竹叶、芦根汁、鲜竹沥等，以增水行舟，绝无猛下直攻之理。

热不退忽大汗出，口渴，脉细促，神躁，气促，阴伤及气，进一步则有亡阴厥脱之虞，急用西洋参、真菖斛、麦冬、北五味、浮小麦、白芍、甘草、煅龙骨、煅牡蛎、大生地、紫贝齿等，以滋阴救逆为先；若四肢厥冷，脉细如丝，烦躁昏谵，大汗发粘，是阳将亡矣，急宜参附汤回阳救逆，俟阳气回复即须转用阴药，以调理善后。

少数危重病人，温邪热毒深入营分，发现斑疹，是热毒外出之机，须凉血透邪，泄热存阴，人参白虎汤、竹叶石膏汤，重则如玉女煎均可审证选用，总以扶正达邪为旨，神情清爽而舌体胀大，不能出口，是痰热上壅，郁极化风，可用生大黄少许，磨汁冲入药内，则舌胀常可自消。莱菔汁上可消痰，下可导滞，辛能透邪顺气，凡初病发热属实者皆宜。^[1]

3. 马莲湘诊治经验

肺炎为现代医学病名，追溯祖国医学文献，可涉及到风温、喘证、惊风、厥脱等有关病证。历代医籍中所述的“喘嗽”、“肺风痰喘”、“火热喘急”、“马脾风”、“肺胀”等均属肺炎中的一种症状，但未能包括本病的全部证候。马

氏在临床上以辨病和辨证分型相结合来立法处方。

风寒闭肺：多属支气管肺炎的早期，症状为发热，无汗，咳嗽，气粗，恶寒不渴，咯痰稀白，舌苔薄白，脉浮数，此型虽为风寒之邪侵袭肺卫引起，但寒邪迅即化热，用辛温解表已失时机，故马氏在临床上起手即用宣肺清热化痰法，药用：豆豉、金银花、连翘、大青叶、前胡、浙贝、桔梗、瓜蒌皮、冬瓜仁、鲜芦根等。一般服药3剂后微汗出，热渐退，咳嗽也好转，病情得以控制，不致进一步发展。

风温闭肺：多系支气管肺炎，症见发热微汗，咳嗽气促，痰鸣鼻煽，舌质干、苔黄，脉滑数，小儿啼哭多无泪。治拟清热解毒、宣肺化痰为主。药用：麻黄、石膏、甘草、杏仁、鱼腥草、黄芩、金银花、连翘、天竺黄、葶苈子、大青叶为主，另加万氏牛黄清心丸1粒（研吞）。此期以麻黄宣肺平喘，石膏清肺泄热为主。马氏在处方中掌握麻黄用量为石膏的十分之一，取小量麻黄（不会过汗伤津）开肺平喘之效，辛寒大于辛温，本方仍不失为辛凉之剂。万氏牛黄清心丸须及早应用，不宜待热入心包才用，早用可防止中毒性肺炎的危症。服后若见泄泻，不必急用止泻剂，此为肺移热于大肠，痰热泻下，对病有利无弊。

痰热闭肺：多系大叶性肺炎或支气管肺炎重症，起病急骤，高热烦躁。痰壅气喘不得平卧，鼻煽肩息，成人诉胸痛，大便多秘，脉滑数，舌苔黄腻。马氏用清热解毒，泻痰平喘为主，处方以麻杏石甘汤加葶苈子、天竺黄、大青叶、大黄、黄芩、莱菔子、金银花、连翘等，合牛黄清心丸、紫雪丹同用。取效较速。此外，痰闭欲绝之危证，可用桔梗白散吹鼻开闭。马氏曾治一乳儿重症肺炎，壮热面赤，目定呆视，痰鸣如锯，气喘欲绝，凌晨来诊，不能

服药，急取成药“桔梗白散”以吹粉器吹鼻孔内2次后，吐出胶粘稠痰半碗，立即啼哭出声，喘逆即平，继服清热解毒化痰剂2剂而愈。^[1]

4. 沙星垣诊治经验

沙氏治大叶性肺炎曾自拟清气汤，方以石膏为主，配伍与证情相应之品，收效甚捷。沙氏认为本病大多数病候是符合伤寒论太阳病传递或（和）合并阳明病证这一规律的，如起病之有恶寒发热，旋即恶寒自罢，而自汗大热烦渴等病情，仲景称太阳病发汗后身灼热者属温病，寒温本可转化。而后世温病学家在辨析表里范畴时更分为卫、气、营、血四个层次，对六气病因作出了确切的阐明，使临床诊疗有所发展，用药更趋于完善，由仲景原来用法麻黄汤→麻杏甘膏汤→白虎汤的以辛温解表变迁为辛凉解表，清气汤即在寒温学说融合的基础上历多年之体会所立。药用：淡豆豉 9g，连翘 9g，生石膏 30g，杏仁 9g，金荞麦 9g，甘草 3g。本方以豆豉连翘解表，而清气之用全在石膏，石膏用量至少 30g，需打碎先煎，服药应多次分进。本方使用时最宜注意药味之配伍，尤其是透表药味，如初起邪热在卫气合并之际而略偏于卫分时，可在豆豉、荆芥、薄荷、桑叶、连翘等中选用 2~3 味；若偏重在气分时，可相应加入金银花、竹叶、知母、黄芩之类。它如咳甚者加桔梗、牛蒡子；痰稠如脓者加芦根、鱼腥草、薏苡仁；痰中带血者加白茅根、藕节、桃仁等。若气分热炽者则必需加重石膏用量，沙氏的经验每剂可至 120g，并可于 24 小时进 2~3 剂。一般可在 3 天左右获效。

有人评述温病家“轻可去实”是用药太轻不能治大病，其实“轻”不是指药轻，而是说病在肺经，应用轻清透达

之意，如叶天士所指明的“在卫汗之可也，到气才可清气，入营犹可透热转气……”，此因六淫之病均能化热化火，而病邪之在卫、在气、在营又并无截然界限，最多合病、并病，邪虽入营犹可透热转气，而当尚未入营时，又最多卫气相杂，故清气之中时时辅以轻扬透表之味，此为温热病家精辟之见，后人不察，误认只用平淡轻药，实非本意。

至于用石膏的适应证和剂量问题，吴鞠通“四大”之说颇有影响，实则也并不尽然，只要具有邪在气分之“热象”，即可放胆应用。吴氏医案中治赵某一例曾用石膏达50kg之多，1剂有用至500g者，可谓罕见。此乃吴氏晚年所治，阅历既深，胆识自然过人，并可证石膏之性本甚和平。^[1]

5. 沈仲圭诊治经验

大叶性肺炎的病机为风寒外袭，内蕴郁热，症见恶寒身热，咳嗽气急，痰黄胸痛，口干喜饮，脉紧数，苔黄糙，以麻杏石甘汤加味主之。药用：麻黄4.5g，杏仁9g，生石膏15g，生甘草3g，半夏6g，前胡6g，冬瓜子9g，竹茹6g，橘红4.5g，茯苓9g，白茅根15g。本方系麻杏石甘汤合二陈汤加味，解表清热，化痰降气。如恶寒重可加麻黄之量，热盛加石膏之量，喘甚酌加葶苈子。沈氏治大叶性肺炎，除用麻杏石甘汤加味外，有时用定喘汤，药用：麻黄、杏仁、生甘草、半夏、黄芩、苏子、桑白皮、款冬花、白果。本方用麻、杏、芩、草解表清热，半夏、款冬花、桑白皮化痰降气，白果性涩敛肺，方中散敛并用，润燥相兼，立方颇有意义。另有五虎二陈汤主治哮喘喘急痰盛，药用：麻黄、杏仁、生石膏、生甘草、半夏、陈皮、茯苓、木香、沉香、人参（可改沙参）、细茶。本方系麻杏甘石汤

合二陈汤加味，治大叶性肺炎喘促痰多者，颇为对症。^[1]

6. 陆芷青诊治经验

肺炎大多由外感而起，有风寒与风热之异，但也有热毒内壅，清肃无权，如麻疹之并发肺炎者，成于此种类型。总之外寒与热二种属性。陆氏遇此症，初起恶寒高热，咳嗽痰稠，气急，舌红，苔薄黄，脉滑数，恒以麻杏甘石汤合千金苇茎汤加味：麻黄 3~5g，石膏（先煎）18~30g，杏仁 9~12g，生甘草 5g，鲜芦根 30g（先煎代水），冬瓜子 12g，桃仁 9g，薏苡仁 18g，鱼腥草 30g。痰黄稠如脓且臭者，加败酱草 15g；痰中带血或呈铁锈色者，加侧柏炭 12g，白茅根 15g；胸痛加郁金 9~12g；麻疹并发肺炎，加金银花 12g，连翘 9g；如见鼻煽，加羚羊角片 2~5g（另炖冲入）；若麻疹不透或一出即隐，以西河柳 60g 煎汤，用纱布渍热药汁擦患者全身皮肤，疹透即止。肺炎而见神昏，此温邪逆传心包，最为险候，速以安宫牛黄丸 1~2 粒（另研冲服），以神识转清为度。若化风抽搐而又神昏者，改用紫雪丹 2g 调服，6 小时 1 次，24 小时给药。当能化险为夷。

因风寒外受而致肺炎，苔必薄白，舌质不红，脉见紧象。陆氏以大青龙汤投之，见效甚速。方中麻黄分量可用至 9g，石膏 30g，桂枝 6g，小儿酌减。肺炎极期，如见汗多肢厥，面色苍白，脉微细欲绝，此亡阳也，急煎人参 3~6g，熟附子 5~10g，干姜 3g，炙甘草 5g，以救欲脱之阳，厥回脉复，立即止剂。肺炎后期，热退喘平嗽止，舌质红而干，脉细无力者，此气阴两伤之证，以生脉散投之。若余热未清，口干唇燥，咳嗽胸闷，心烦，舌红少津，脉象虚数者，用竹叶石膏汤以清余邪而复阴液。^[1]

7. 张沛虬诊治经验

张氏对大叶性肺炎一般分三期治疗。

发病期：即邪在肺卫，以辛凉解表，宣肺化痰为主，方用银翘散加减，药用：金银花 20g，荆芥 10g，炒山栀 10g，前胡 10g，象贝 10g，杏仁 10g，炒牛蒡子 10g，薄荷（后下）5g，芦根 30g。高热加大青叶 30g，板蓝根 30g。

进展期：出现气血两燔，症见高热面赤，咳嗽气促，痰黄色或如铁锈，鼻翼煽动，胸痛较明显，烦躁不安，舌红，苔黄，脉滑数，相当于大叶性肺炎实变期。治宜清热解毒，宣肺化痰，方用麻杏石甘汤加味，药用：麻黄 5g，杏仁 10g，生石膏 30g，甘草 5g，蚤休 30g，大青叶 30g，黄芩 30g，败酱草 30g，野荞麦根 30g。病情严重时可每日煎服 2 剂，分 4 次服。此方清热解毒疗效颇著。

恢复期：即气阴两伤，症见气虚邪恋，身热起伏，咳而微喘，舌红，少苔，脉细无力。治宜益气养阴，清热化痰，方用养阴清肺汤加减，药用：沙参 12g，麦冬 12g，石斛 12g，象贝 10g，知母 10g，杏仁 10g，金银花 15g，陈皮 5g，枇杷叶 15g。此外，正虚而引起的重症肺炎，除按分期分型进行治疗外，同时要重视扶正。人参白虎汤也常用。^[1]

8. 陈泽霖诊治经验

陈氏治疗肺炎开始纯用中药，总感到疗效尚不及青、链霉素，以后学习中草药，在发掘民间验方的基础上，先用鱼鸭汤（即鱼腥草、鸭跖草各 30g），约有 50% 可使发热在 3 天内退去，后又加半枝莲 30g，虎杖 15g，疗效可提高到 60%，已接近青、链霉素之水平。后再改进处方用鱼腥

草 30g, 白毛夏枯草 30g, 半枝莲 30g, 虎杖 15g, 开金锁 30g, 制成可供静脉滴注的针剂, 疗效又有提高, 约有 70% 的病人在静脉滴注后 1~3 天内热退, 咳嗽、胸痛均可减轻, 甚至有些已用过抗生素无效的病例, 再用此也可收效, 对不愿静脉滴注者, 口服也同样有效。陈氏学习西药给药每隔 4~6 小时服 1 次的方法, 令病人每日用 2 剂药, 煎 4 次, 和匀, 分 4 次温服 (即每隔 6 小时服 1 次), 以维持有效的血浓度, 这样也可提高疗效。对痰咯不爽者, 常加桔梗、枳实以助排痰; 气急者, 可加麻黄、苏子; 胸痛明显, 可加旋覆花、炙乳香、炙没药; 对肺炎阴影在 X 线下持久不消者, 可加丹参、桃仁, 以助其消散。对有些老年病人, 肺炎经中西药物治疗已经消失, 似气阴两伤, 舌苔光剥迟迟不能复原, 甚至最后如灯油燃尽而死亡。对此种病例, 陈氏用大剂益气养阴之剂, 如西洋参 4.5g, 生晒参 4.5g, 石斛 6g, 生地 30g, 黄精 30g, 天冬 9g, 麦冬 9g, 白茅根 30g, 芦根 30g 等, 煎汤频服, 可使不少濒危病人得以恢复健康。^[1]

9. 何任诊治经验

何氏认为, 肺炎之病机应是正气不足, 卫外无权, 感受风温之邪而致病。何以风温多见咳嗽? 此即所谓: “温邪上受, 首先犯肺”也。风温之邪壅遏, 痰热交阻于肺而成本病。在发病过程中, 其邪正交争颇为激烈, 正胜邪却, 则热除痰消; 正不胜邪, 热盛邪陷则可现脱证。至于病程中诸种见证, 其病机为风热之邪入肺, 郁而化热, 热灼津液而成痰, 痰盛气滞, 肺失宣降, 逆而为咳, 甚则唇口紫黯; 热郁肺络, 则胸痛痰粘, 或带铁锈色; 热毒炽盛, 内传入血, 亦可神志昏蒙; 热毒伤阴耗液, 肝风内动, 亦可

现抽搐烦躁不安。由于病机如此，故对其治法多按温病、风温论治。亦从卫、气、营、血加以辨证。此病多发于冬、春之际，始则身热，咳嗽，烦渴。其病在肺、卫，宜辛凉透邪为主。常用银翘散、麻杏石甘汤、千金苇茎汤等。本病传变迅速，每易出现神昏谵妄等逆传心包之候。其治亦宜清营透热，清心开窍，如用清营汤、安宫牛黄丸等。至于正伤而脱者，自以生脉散为主，视证情合龙、牡乃至参、附之类。何氏在临证时除按上述规律外，并视证情酌予增损。若见温邪初受，见证与风寒咳嗽类似时，常以脉象分辨之，即本证初起常见寸口脉浮大而滑。再则口渴、苔黄亦是本证多见者，均可与风寒咳嗽区别。此时肺初受风热灼烁，其治当以清上为主，可参用连翘、金银花、杏仁、贝母、山梔、瓜蒌、天花粉、沙参之类选择用之。至于胸痛咳甚，痰稠色黯者，则亦往往酌增郁金、橘红等。而热久不除，则加黄芩、滑石、山梔。至于热灼劫阴，出现烦躁者，则白芍、麦冬、生地乃至阿胶之类亦均在取用之列。何氏曾自拟一方治本病，药用：麦冬、玄参、浙贝、金银花、桔梗、百部、连翘、冬瓜子、沙参、芦根、鲜薏苡仁、蒲公英为主，随证加减，效果甚显。^[1]

10. 金厚如诊治经验

金氏诊治病毒性肺炎有独到之处。根据病毒性肺炎流行季节和证候特点，金氏认为应归入“风温”病的范畴，温病学说的卫气营血乃为辨证的指南。病因方面虽有风热痰湿四邪之分，但在治疗用药上，一直遵循清代名医叶天士之“温邪上受，首先犯肺，治宜辛凉忌温散，温邪多伤人之阴，虽有夹湿夹痰忌宜凉润”之说。况且毒热持续稽留，最易损耗津液消减抵抗力。幼儿稚阴稚阳，体力未充，

体内仅有之津液损耗严重，往往会使病情更加恶化。金氏很重视患儿之胃气，尝谓“胃中之津液不竭，其人必不即死”。所以金氏对此类患儿总以辛凉之剂开肺祛邪，另一方面又注意用甘寒养阴生津之品以扶正，一般能收到较好的效果。

对于病毒性肺炎，金氏常用的方剂有辛凉轻剂桑菊饮、平剂银翘散、重剂麻杏石甘汤等；其他如清瘟败毒饮为毒热盛，体壮不夹湿之要方；清营汤为热邪入营，阴伤偏虚不能托邪外出之主方；犀角地黄汤为热邪入血后，病势危重、烦扰不安之常用方剂；若肺炎夹湿，气机不利，喘促不安，又须用千金苇茎汤以化湿利肺驱邪；至于正气衰弱、阴伤较甚、喘乏汗多，有虚脱之变，生脉散、麦门冬汤、或喻氏清燥救肺汤等均可酌情应用。若热毒极盛，内窜心营，心神不宁，烦躁不安；或痰热内蒙，窍机失灵，嗜睡嗜语者亦可大胆分别选用局方至宝丹、安宫牛黄丸等。

如治马某，男，2岁。患儿因高热10天，伴有喘咳嗜睡，在院外曾用各种抗生素及中药治疗，发热仍起伏于39~40℃之间，气促嗜睡，甚则喘促肢凉，按病毒性肺炎收入病房。查体：精神疲惫，嗜睡，呈重病容状，呼吸急促，60次/分，眼结膜充血，鼻煽，唇红干裂出血，口周青，三凹征(+)，咽充血，扁桃体I度肿大，两肺除有少许喘鸣音外，中下方有中小水泡音散在，左侧更密，叩微浊，心(-)，腹微胀，肝剑突下2cm，肋下2cm。血常规：白细胞 $6.7 \times 10^9/L$ ，中性0.39，淋巴0.57，嗜酸0.02，单核0.02。X线胸部透视：右肺有小片阴影，左肺可见大片致密影。临床诊断：病毒性肺炎。金氏辨证：舌红、苔少而干，脉弦细数，病属发热日久，阴分耗伤，肺胃蕴热较盛，有内闭侵营之势。拟治以辛凉清解，开肺达

邪，佐以甘寒养阴，清透营分蕴热之法。药用金银花 24g，连翘 12g，薄荷 6g，牛蒡子 9g，竹叶 6g，生石膏 24g，玄参 12g，黄芩 6g，沙参 9g，贝母 12g，天花粉 9g，瓜蒌皮 9g。水煎服。局方至宝丹 2 丸，分 4 次服。服上方药后体温仍不退，发热无汗，口渴欲饮，喘憋痰粘。第 2 剂前方去薄荷、牛蒡子、瓜蒌皮，加生地 12g，广角 6g，另高丽参 3g，生梨 2 枚，煎 400ml，随时口服。第 3 日体温开始波动，最高仅 38.6℃，日轻夜重，但仍无汗，昏睡，咳喘未减，唇红干裂，舌质深红、边尖起刺、苔白而干，脉弦细数略有滑象。金氏认为，此时邪热深伏日久未得透解，以致热留阴伤，肺失肃降之权，清窍被困，呈热盛阴虚、肺脾两伤、化源欲绝之象。治以辛凉开肺，甘寒养阴，肃肺达邪之法。药用金银花 24g，连翘 16g，鲜生地 15g，玄参 9g，甘草 6g，滑石 9g，菖蒲 4.5g，天花粉 9g，竹叶 6g，黄芩 6g，瓜蒌皮 9g，枇杷叶 9g，水煎服。局方至宝丹 2 丸分 4 次服，以后基本以上方加减为治，入院第 4 天体温逐渐正常，神志转清，咳少喘瘳。共服药 11 剂，痊愈出院。出院时肺部透视复查：两肺纹理清晰，两下肺阴影均较前吸收。^[2]

11. 袁正刚诊治经验

对于阳明腑实的高热，有用通腑法一泻而热解的突出疗效。除此之外，袁氏对外感高热中有败血、痰饮瘀滞的病人（多见于术后、产后、出血后以及肺部感染者），也常以通腑消瘀法治疗。其认为：败血、痰饮皆为阴凝有形之邪。多由外感之邪乘虚而入，损伤脏腑、气血而内生，既成瘀滞，更助热势，当从腑道迅速导泄之，邪泄则脏腑气流通，大热自除。曾治一例患急性肺炎的中年男性病人，

高热，咳嗽胸痛 3 天入院，胸片报告右下肺炎伴积液。袁氏察其壮热汗出，胸痛随呼吸加剧，痰白粘量多，大便干燥，舌紫暗、苔薄黄。辨为肺肠热郁，瘀饮停络，于麻杏石甘汤中加大黄、桃仁、马鞭草导利肺肠之瘀，桑白皮、葶苈子清泻肺中伏热伏饮，通降走下，全方宣清开泄合法，连服 4 剂后，排出稀粘大便甚多，胸痛大减，体温下降，原方增损服 10 余剂，痊愈出院。袁氏认为，中医治疗外感高热要掌握辨证论治的原则，而不宜见高热就投寒凉清热，或机械孤立地将其中任何一法贯穿于治疗的始终，是难以体现中医治疗外感高热的特色的。只有在辨证审因的基础上随机活变，综合运用各法，才是取得可靠疗效的关键。^[3]

12. 张琪诊治经验

肺炎属祖国医学“温热病”、“肺热喘咳”的范畴。凡咳嗽喘促，壮热无汗或自汗，舌干，脉滑数或浮数，《伤寒论》中的麻杏石甘汤是很有效的方剂。张氏经验，本方药量比重颇为重要，石膏用量需大于麻黄 10 倍左右，服药后往往热退喘平。麻黄为宜肺定喘之要药，但性温与肺热不宜，必须与生石膏合用，方能清热透邪，如生石膏量小则达不到清热透邪之目的。近人蒲辅周谓石膏闭遏邪气，蒲氏所指是湿温之类，如温热炽盛，非石膏莫救。麻杏石甘汤重在宣肺清热，麻黄、杏仁宣开肺气，石膏清热，麻黄与石膏合用，其作用不在发汗解表，着重宣肺泄热，故《伤寒论》谓：“汗出而喘，无大热者”可用此方。^[4]

13. 谢昌仁诊治经验

急性肺炎为临床常见的热性病，以发热、咳嗽、咯痰、胸痛为主症，属于祖国医学“风温”、“咳嗽”等病的范畴。

在多年实践中体会到：按温病卫气营血不同阶段，根据致病因素和发病季节的差异，机体反应和病理变化的不同，而同病异治，采用各种不同的治疗法则与方药，才能提高中医药治疗急性肺炎的疗效。

①风温初起，邪犯肺卫，治宜疏表宣肺。风温为阳邪，风温袭于表卫则卫气阻郁，卫气通于肺，肺合皮毛，故风温病毒外受，肺卫首当其冲。出现起病急骤、发热、微恶风寒、咳嗽微喘、痰白或黄、胸闷或痛、口干微渴、舌边尖红、苔薄白，脉浮数。多见于肺炎早期。治宜辛凉疏表、宣肺化痰为原则，用银翘散化裁，取其清宣肺卫之功。

②风寒外束，肺失宣降，宜治以温散。肺炎早期以风温（热）之邪，外袭肺卫者多见，但亦有少数患者表现为恶寒重而发热不甚，无汗身楚，咳嗽痰白而稀，胸闷或痛，舌苔薄白，脉浮等主症。中医辨证则为外感风寒，内舍于肺，郁阻气道，肺气失其宣降。治宜温散之品以疏风散寒，宣降肺气。方选杏苏散、荆防败毒散等加减。忌投寒凉之剂。

③风温夹湿，病及肝胃，治当清肺疏利。江南之地，潮湿多雨，或因患者素体湿重，以致风温之疾在临床中每多夹湿，常伴有胃肠道或肝胆系症候群，出现风温夹湿证，症见发热恶寒、咳嗽胸痛，胸闷呕恶，脘痞腹胀，饮食不馨，便溏或结，舌质红、苔白腻或黄腻，脉滑数或濡数，巩膜、皮肤或见黄染等，在肺炎早、中期均可出现。治宜清热利湿并用。叶天士认为：“挟湿加芦根、滑石之流，或透风于热外，或渗湿于热下，不与热相搏，势必孤矣”。临床中对风温夹湿者，喜在银翘散或麻杏石甘汤、苇茎汤等方基础上选加藿香、鸡苏散、淡竹叶、薏苡仁、冬瓜仁、茵陈、茯苓、泽泻等药。

④热入气分，痰热伏肺，亟应清肺泄热。外邪顺传气分，热壅肺气，蒸液为痰，痰热郁阻于肺，气机不利，肺络受损则可出现高热不退、烦渴多饮、面赤咳嗽、胸痛气喘、咯痰黄稠或铁锈色痰，或带血丝，舌红质干苔黄，脉滑数或洪大等症。此证可见于各种肺炎的极期。应亟用清肺泄热、宣肺化痰法治疗。此证不解，其传变有二：一是顺传于胃，一是逆传心包。临床常用麻杏石甘汤合千金苇茎汤治疗。热盛者加金银花、连翘、炒黄芩；胸痛者加赤芍、郁金；烦躁者加栀子、豆豉；气喘者加桑皮、葶苈子；痰中带血者加白茅根、黛蛤散；便秘者去麻黄加全瓜蒌、贝母；口干舌红阴伤甚者加沙参、麦冬、石斛。

⑤肺经热盛，下迫大肠，法宜上下同治。肺与大肠相表里，肺经热盛，可下迫大肠而成湿热下利。症见高热、咳嗽气促、胸痛咯痰黄稠，兼见腹痛、泻下黄臭稀粪、小便短赤、苔黄，脉濡数等症。此则既要清肺化痰，又要清化大肠湿热。临床常以葛根芩连汤合苇茎汤加味治疗。

⑥肺热传胃，腑气不通，治用清热攻下。邪入气分热蕴肺气，最易从阳明经证传入阳明腑证而致里结。根据肺与大肠相表里的关系，肺经邪热可通过清胃通腑而得以下泻。通腑攻下方药（如大黄），不仅具有泻下作用，还能清热泻火解毒。近代药理研究也证实大黄等药对肺炎球菌有明显的抑菌作用。临证中凡见风温传人气分，高热不退，大便秘结，数日不解，舌红、苔黄燥或黄厚，脉洪数者，均应运用清热通腑法治疗。常用宣白承气汤化裁，或以麻杏石甘汤加大黄、瓜蒌等药。药后常能泻下恶臭积粪，高热随便通而得以下降，病情向愈。

⑦热盛阴伤，正不胜邪，清肺养阴并投。风温阳邪，最易伤津耗液，热邪久留，阴液必然被烁，阴伤则正难胜

邪，往往出现身热稽留不退、汗出而热不解、咳嗽胸痛、舌质红少津、苔黄、脉细数。多见于各种肺炎的末期。此时徒投苦寒泄热之剂而不滋养阴液，则热恋难退，必须清肺养阴并投，顾护阴津，防止阴津失固、热邪内陷出现逆传之症，可选用沙参麦冬汤或青蒿鳖甲汤加清肺化痰之品。

⑧气虚卫弱，御邪力薄，治宜扶正祛邪。慢性久病、产后、年老体弱的患者易患肺炎，多因体虚表卫不固，卫外力薄，御邪力差所致。对此从整体观念出发，注意扶正，根据邪正盛衰的情况，掌握扶正与祛邪的分寸，以提高机体的防卫功能，有利于病原菌的清除及炎症的吸收。可仿玉屏风散或补中益气汤、六君子汤等化裁。^[5]

14. 曹鸣高诊治经验

肺炎乃中医风温之为病，冬春居多，邪从上受，肺胃内应，宜先透发，辛凉解表，是为正治。风为阳邪，温从热化，不宜过表，汗多则易灼津耗液，反化燥火，而致动风昏陷，亦不宜早用寒凉，恐遏其邪反不易解，导致内传生变。若发热不退，汗出不多，烦渴多饮，面红唇焦，咳嗽频频，胸闷气急，胸肋引痛，甚则碍于呼吸，咯痰黄稠，或带血或呈铁锈色，舌边尖红、苔黄，脉滑数。此温邪郁蒸肺胃，行将化火劫津，内陷心包，宜用鲜石斛、炙麻黄、杏仁、生石膏、黄芩、生甘草、葶苈子、射干、丹皮、黑山栀、鲜生地、白茅根、郁金、带子丝瓜络、红藤、参三七等，以泄热生津，宣肺和络。如壮热，烦躁，口渴欲饮，谵语不寐，舌质绛、尖见芒刺，是邪深渐欲入营之象，须即撤气药，转用大剂羚羊角、生地、石膏、丹皮、连翘、玄参、鲜菖蒲、金银花、芦根、白茅根等，以凉血透邪，存阴泄热，必要时可用神犀丹，以防内陷心包，昏痉厥变。

若持续高热，谵语，渴喜凉饮，腹痛拒按，矢气频频，舌绛苔黑，齿垢唇焦，脉实等种种燥实见证而元气尚可者，则非急下存阴不可，凉膈、承气，量其轻重进之。如病久津枯液涸，虽实证已备，当先滋液救阴，投鲜石斛、鲜生地、西洋参、玄参、麦冬、竹叶、芦根汁、鲜竹沥等，以增水行舟。热不退忽大汗出，口渴，脉细促，神躁，气促，阴伤及气，进而则有亡阴厥脱之虞，急须用西洋参、石斛、麦冬、五味子、浮小麦、白芍、甘草、煅龙牡、生地、紫贝齿等，以滋阴救逆为先；若四肢厥冷，脉细如丝，烦躁昏谵，大汗发粘，是阳将亡矣，急宜参附汤回阳救逆，俟阳气回复即须转用阴药，以调理善后。少数危重病人，温邪热毒深入营分，发现斑疹，是热毒外出之机，须凉血透邪，泄热存阴，人参白虎汤、竹叶石膏汤，重则如玉女煎，均可审证选用。神情清爽而舌体胖大，不能出口，是痰热上壅，郁极化风，可用生大黄少许，磨汁冲入药内，则舌胀常可自消，莱菔汁上可消痰，下可导滞，辛能透邪顺气，凡初病发热属实者皆宜，临证可灵活变通。^[6]

15. 顾兆农诊治经验

“大气下陷”之病名，始见于张锡纯之《医学衷中参西录》，并创制“升陷汤”治之。方由黄芪、知母、柴胡、桔梗、升麻五药组成。顾氏曾用此方加减治疗一女患者，因休克性肺炎经抢救病情得以控制，体温降至 37℃，肺部体征及自觉症状均有好转。但血压持续波动在 10.7/6.7/8.0~5.3kPa，升压药一直难以撤除。后患者又再次精神不好，自觉症状加重，特请中医会诊。诊见：患者精神倦怠，面色无华，咳嗽声低少痰，气短息促，常感上下之气不相接续。手足微凉，津津汗出，脐腹胀满，大便溏下，日 3~4 次，舌苔

薄白，脉沉细而弱，两寸尤著。辨证属胸中大气下陷，急于升举之法治之。处方：黄芪 18g，知母 9g，柴胡 5g，桔梗 6g，升麻 6g，人参 9g（另煎，兑服），山茱萸 15g，桂枝 6g。服 1 剂后气短息促明显减轻，自觉心胸舒适，手足转温。血压缓慢回升，脉压差值增大，升压药随之递减，12 小时后完全撤用。又进 1 剂后，寒热感渐退，汗出锐减，无腹胀，大便自调，六脉均较前有力，但脉气仍显不足，然其下陷之气已初复胸位，宜轻其剂继予升举之药以资巩固疗效。上方药量各减半，加陈皮 10g，炒山药 18g，甘草 6g，续服 2 剂，患者精神状态明显转佳，纳谷、二便及睡眠均复常，痊愈出院。结合本案实情，顾氏仍嫌“升陷汤”收敛之力不足，补气之力稍逊，故加入参、山茱萸以加强补敛之功，更加少量桂枝，意在通调四末之阳气也。因辨证准确，药证相符，故进药 2 剂，病势大衰。为使已升之气不致复陷，已敛之气不致复散，故二诊时剂减半量，以资巩固疗效，同时又加陈皮、山药、炙甘草，意在强中气以培其本也。顾氏认为，“升陷汤”诸药剂量，应有固定的配比关系。其黄芪、知母、桔梗、柴胡 4 味之量，依次应以 6、3、2、2 的比例入方。所特殊者，在于升麻一味，其用量宜据大气下陷之程度而灵活增减，一般可用 3~6g 之间。^[7]

16. 董建华诊治经验

董氏治疗温热病，重视宣畅气机，遣方用药以轻灵活泼见长。

①宣通上焦，轻可去实：所谓实，实指上焦气机为邪热壅闭而周行壅滞，失其清虚灵动之机，为无形之气机壅实。当予轻苦微辛具流动之品，轻灵平淡之方，拨动气机，透泄无形之邪。切忌重药杂投，使无病之地反先遭克伐。

董氏拟定的辛凉Ⅰ号（桑叶、菊花、桔梗、连翘、杏仁、甘草、薄荷、芦根、金银花、荆芥、牛蒡子）用治大叶性肺炎，证属卫分或卫气合并的24例患者，均获得较好疗效，平均降温时间为2.4天。

②辛开苦降，分消走泄：温热之邪流连三焦气分，或夹湿邪、痰浊阻滞，气机升降不利则寒热起伏，胸脘痞闷。治当以辛开发于上，以苦泄热于下，以上下分消，宣通三焦，祛除温热痰湿之邪。常用小陷胸汤加枳实汤。

③行气通腑，攻积导滞：温热病热结胃腑，得攻下而解者十居六七。通腑之法，旨在承其胃降之气，通其郁闭，和洽气机，冀顽邪蕴毒因势下泄，周身之气机自然流布，故无须拘于有无结粪。但也不得以“温病下不嫌早”之说而妄用下法。温病误下，初期可使表邪内陷，后期或为伤阴，或致暴脱。因此，攻下必须适其法时，得其法，合其量。不宜失下，也不可妄下，当察病之缓急，度邪之轻重，量人之虚实，慎重而为之。温病之下，灵活多变，临床中常用的有宣肺通腑的宣白承气汤；开胸通肠的陷胸承气汤；脏腑同治的白虎承气汤、导赤承气汤；攻补兼施的增液承气汤、新加黄龙汤等。

董氏强调温热病应用寒凉不可寒遏冰伏，以防凝滞气机，郁闭邪气。主要体现在：苦寒必须适时，用之不可过早；清气不可寒滞，注意宣展气机；通腑攻下不可太过，以防徒伤胃气、胃阴；苦寒之剂稍佐温通，振奋阳气，鼓动气机，令寒药不致呆顿而奏捷效。^[8]

17. 赵尚久诊治经验

苇茎汤出自《千金方》，为专治肺痈而设。方由苇茎（芦根）、瓜瓣、薏苡仁、桃仁四药组成。具有清肺化痰、

逐瘀排脓之效，不但治肺痈有效，对于肺系因痰热蕴结所致其他病症也可用之，如吴鞠通《温病条辨》用本方治“太阴湿温喘促者”，加杏仁、滑石，谓之“轻宣肺气”、“利窍而逐热饮”。只要把握本方运用原则，灵活化裁，就能扩大运用范围，而不会拘泥于肺痈病。如用苇茎汤治肺炎，适宜于中医辨证为“痰热型”者，以发热、咳吐黄稠痰、胸痛、苔黄腻为辨证要点。若伴喘息气促、高热无汗者，合麻杏石甘汤；高热已退余热不清者，合泻白散；神疲少气、手足心热、舌红少津者，合参麦散；胃阴不足，食欲不振者，合麦门冬汤。

如治黄某，男，40岁。素有咳嗽吐痰之疾，本次因受凉触发，高热振寒，咳喘气促。西医诊断为大叶性肺炎，用抗生素治疗1周无效。诊见：高热未减（T40℃），无汗，不恶寒，咳喘气促，吐黄稠痰，痰量不多，痰中带血，时胸痛，口渴，烦躁不安，神识昏蒙。舌红、苔黄带腻，脉浮数。辨为风热犯肺，痰热凝聚所致。以芦根30g，薏苡仁15g，冬瓜仁30g，桃仁10g，麻黄6g，生石膏20g，杏仁10g。服1剂汗出热减，3剂热净，咳喘已平。后以苇茎汤合参麦散，数剂而安。^[9]

18. 沈庆法诊治经验

肺炎一病，在西医未传入中国之前，祖国医学书籍上已有记载。清·谢玉琼《麻科活人全书》谓：“加味泻白散治肺炎喘嗽”，症见“气促、鼻煽、胸高”，则以“加味泻白散去人参甘草主之。”泻白散系钱乙《小儿药证直诀》方剂。方中桑白皮能泻肺热，下气平喘，又能利水祛痰；地骨皮清虚热，生津液；甘草、粳米润肺养胃。肺热阴伤，痰咳喘嗽，最为对证。若见痰热症状明显者，则重用桑白

皮；阴伤症状明显者，则重用地骨皮。临证配伍时，肺热重用黄芩、知母、开金锁、鱼腥草、鸭跖草；痰稠厚加川贝母、沙参、杏仁、瓜蒌皮、冬瓜仁；气促胸高加葶苈子、苏子、炙枇杷叶；阴虚潮热加青蒿、鳖甲、银柴胡；胁痛咯血者加黛蛤散、郁金炭、制大黄炭、竹茹。

叶天士在《幼科要略》中也指出风温初起可用泻白散治疗；如果表解热不清则用“黄芩、连翘、桑白皮、天花粉、地骨皮、川贝、知母、山栀”。

沈氏在临床上运用泻白散治疗肺炎，认为应着眼于痰热津伤明显。此时阴液不足，卫外不固，易致外邪犯肺，肺失肃降。治疗可分两个阶段。第一阶段：由于痰热内蕴，伤津耗液，症见寒战发热，时起时伏，咳嗽气急，痰粘而稠，口干唇燥，舌红、苔薄黄腻，脉细数或细滑数。治拟清肺泻热，化痰止咳，生津增液。取泻白散为主合千金苇茎汤、增液汤加减。第二阶段：痰热渐清，肺胃阴伤，症见低热不退，咳嗽少痰，纳食减少，神疲乏力，消瘦，五心烦热，舌红苔少或绛，脉细或细数。治拟清肺养胃，取沙参麦冬汤加减。^[10]

19. 蒲辅周诊治经验

①宣透法：肺炎一证，四时皆有。文献记载的“肺气喘满，咳逆上气，气促气紧及马脾风”等，皆与现代医学所称肺炎相似。肺炎初起，多在表在上，亦即在肺在卫，其症为发热，汗出，面赤，口渴或不渴，气喘咳痰，舌苔薄白或微黄，脉浮数。治宜宣透。宣透是中医治疗四时一切温病的准绳。方剂有杏苏饮、银翘散、桑菊饮、升麻葛根汤、三拗汤、葱豉桔梗汤，或从凉解或从辛散。

②表里双解法：病毒性肺炎初起，失于宣透，则病邪

由卫而气，以致肺胃同病，表里受邪，内陷胸中。症见口渴，鼻干，舌红苔燥，气粗气紧，喘逆膈动，便秘溺赤。表里双解法是透邪外达的有效途径。方剂有麻杏石甘汤、五虎汤、栀子豉汤、凉膈散、三黄石膏汤、小陷胸汤、栝蒌薤白汤。三黄石膏汤（黄芩、黄连、黄柏、石膏、栀子、麻黄、淡豆豉，加生姜、大枣、茶叶为引）中三黄协栀子清内热，石膏协麻、豉、姜、枣透表热，诚为表里双解之剂，但药性较猛，必须证实脉实，才可施用。

③清热救阴法：病毒性肺炎在用宣透或表里双解法后，一般只须调和肺胃兼生津之品即可。若热邪尚盛，阴液受伤，或治疗不当，热邪郁闭而伤阴，则当用清热救阴之法。方剂有竹叶石膏汤、白虎汤、泻白散、千金苇茎汤、玉女煎及犀角地黄汤。竹叶石膏汤：竹叶、石膏、麦冬、半夏、人参、甘草、粳米。蒲氏认为若正虚邪实，脉细数有力，久热不退，可用此方，需加玉竹、天花粉。痰甚加天竺黄、菖蒲、川贝母、诃子；若不下利，可加竹沥、姜汁；若下利则禁用。

④生津固脱法：病毒性肺炎误用温燥，或过用寒凉，以致邪陷不解，正脱津伤。此时惟宜急扶正气，力救津液。待正气来复，邪气始有外出之可能。救逆方剂常用独参汤、参麦散、千金麦门冬汤、益胃汤。益胃汤：沙参、麦冬、生地、玉竹、冰糖。此乃甘润救津法。若气阴两虚，吴鞠通又有护阳和阴汤（人参、炙甘草、干地黄、麦冬、白芍）。吴氏云：此乃甘凉甘温法。偏于甘凉，即复脉汤法也。^[11]

20. 陶君仁诊治经验

陶氏善用釜底抽薪法治疗风湿。

如治一男性患者陈某，41岁。5天前因劳累，汗出当

风，又遭雨淋，次日恶寒、发热、身痛、咳嗽、左侧胁痛，经某医院用辛温解表之剂 2 剂，恶寒消失，身热依然（ $T39^{\circ}\text{C}$ ），且增烦渴欲饮，咳引胸痛，痰黄质粘稠，不易咯出，胸腹胀满，大便 4 日未行，小便黄赤，舌红、苔黄腻而干，脉弦数。查：白细胞 $14.5 \times 10^9/\text{L}$ ，N 0.85，L 0.15；X 线摄胸片示：左下肺大片状模糊阴影。西医诊断：左侧大叶性肺炎。中医辨证：痰热壅肺，腑中热结。治以泻热通腑，宣肺化痰。仿宣白承气汤加味。处方：生石膏（先煎）30g，生大黄（后下）10g，苦杏仁 10g，全瓜蒌 12g，黄芩 12g，桃仁泥 10g，枳壳 8g，枳实 9g，生甘草 6g。连服 2 剂，大便得通，气味恶臭，热结得泄，腑气已通，咳减热退，原方去大黄，加鱼腥草 20g，继进 4 剂，体温恢复正常。X 线复查：肺部片状阴影基本吸收。病愈。本例乃温邪入里，与阳明大肠积滞相结所致。肺与大肠相表里，肺气降，腑气通。今痰热阻肺，肺气失于肃降，则腑气不能下行，故大便不解，邪热无出路，不攻则无以削其势，急投宣白承气汤加味，祛除腑实热结。诚如唐容川说：“大黄能推陈致新，荡涤肠胃……，即速下降之势，又无遗留之邪”，使邪热随腑气下行得泄，实为“釜底抽薪”之妙用。^[12]

21. 郑惠伯诊治经验

甘露消毒丹为清·薛生白《湿热病篇》治疗湿热并重证候的有效方剂。《湿热经纬》推崇本方为“治湿热时疫之主方”。本方功效在于化浊利湿，清热解毒。《医方新解》认为本方有调整胃肠功能、利尿、利胆、保肝解毒、抗菌抗病毒等作用。郑氏常用本方治疗各种疾病，尤其夏秋暑湿季节，运用最多。凡见湿温、暑温、时疫之属于湿热并

重，邪留气分者，本方多可获得满意疗效。运用本方的辨证要点是发热缠绵，胸闷腹胀，倦怠肢酸，尿赤，苔黄白相兼或薄腻等为主的湿热并重证候。如曾治1例病毒性肺炎的患者张某，秋季突然感冒，气候尚暖，但身着棉衣，咳嗽胸闷，全身倦怠，午后尤甚，舌苔白滑。血常规正常，胸部X线透视诊断为肺炎。辨证属湿热郁滞，肺气失宣。治拟化浊利湿，清热解毒，宣通肺气。方用甘露消毒丹加麻黄、杏仁、蝉蜕、僵蚕、柴胡。服本方2剂，微似有汗，顿觉周身轻爽，恶寒消失。再投3剂，复查肺部病灶消失。肺炎属风热犯肺者多见，但郑氏在临床中观察到有一部分病毒性肺炎，确属湿温范畴，用甘露消毒丹、柴胡达原饮效果良好。本例治以甘露消毒丹，并加入麻黄、杏仁、蝉蜕、僵蚕等，以疏风清热，宣肺止咳；而柴胡一味与甘露消毒丹中黄芩配用，即取小柴胡汤柴芩相配之意，具有良好的和解退热作用。^[13]

22. 刘仕昌诊治经验

①治以宣肺为本：肺炎，中医多归温病之风温范畴辨治。风热病邪由口鼻而入侵入人体，发病较急，初起首犯肺卫，且整个病程均可表现出风热郁肺的证候特点，故宣肺之品为整个病程所必用。刘氏常用北杏仁、浙贝母、桔梗、前胡、枇杷叶、瓜蒌皮、鱼腥草等（“宣肺饮”）。初起邪在肺卫，症见发热，微恶风寒，咳嗽，胸闷不适，舌边尖红、苔薄白，脉浮数者，治宜疏风宣肺，用“宣肺饮”加薄荷、竹叶、牛蒡子、金银花、连翘、甘草等。邪在气分，症见壮热，烦渴，咳喘，胸痛，舌红、苔黄，脉数者，宜清气宣肺，用“宣肺饮”加黄芩、石膏、芦根、大青叶、板蓝根、甘草等。若邪热欲入营血，多表现为气营同病，

症见高热，烦渴，躁扰不宁，咳喘，胸痛，咳咯血痰或见皮肤红疹，舌红绛、苔黄而燥，脉数等，治宜宣肺泄热，气营两清，用“宣肺饮”加玄参、生地黄、牡丹皮、大青叶、板蓝根、知母、石膏等。若高热不退，谵语神昏者可选用安宫牛黄丸或紫雪丹以豁痰开窍。本病各阶段虽然治法不同，宣肺之法贯穿始终，乃使肺气宣畅，风热内郁之邪容易透发，邪出有路。

②寒热虚实宜分：同为肺炎一病，由于患者体质不同，兼夹之异，故有寒热虚实之别，治疗当有所区分。肺炎以风热袭肺，实热证为多，可按上述一般原则论治。但若兼有寒邪之时，表现恶寒较甚，头痛、肌肉酸疼，舌质较淡者则可在“宣肺饮”中加防风、荆芥、橘红、白芷、法半夏、白蒺藜等。虚人感受者则可用“宣肺饮”加苏叶、生姜、黄芪、防风等。

③四时季节各异：肺炎虽在秋冬、冬春气候变化较大时易见，但其他季也不少，故刘氏认为风温四时皆有，非独发于冬春两季。根据四时气候特点，用药略有所异。春季风木之令，温暖多风，易感时邪贼风，用药宜多加疏风透邪之品，可用“宣肺饮”加金银花、连翘、薄荷、牛蒡子、蝉蜕等。夏季暑气炎炎，且易兼湿，宜用“宣肺饮”选加青蒿、香薷、扁豆花、淡竹叶、鲜荷叶、生薏苡仁等清暑化湿之品。秋季燥金之令，宜用“宣肺饮”酌加冬桑叶、紫菀、百部、玄参、款冬花、玉竹、花粉等润燥透邪之品。冬季严寒，易挟寒邪，故常用“宣肺饮”加荆芥、防风、苏叶、白蒺藜、法半夏等。

④应变必须及时：肺炎经及时治疗，一般预后较好。但若感邪太重，或素体羸弱者，则容易邪闭心包，引动肝风而出现气急喘鸣、神昏痉厥之变。应变之法必须及时，

否则救治的难度增大。刘氏常在病情刚出现恶化的苗头时便及时采用急救措施，如高热不退，病者烦躁不安即可用安宫牛黄丸或紫雪丹，往往可使热退身凉，神情安定。此外刘氏认为肺炎患者，尤其是正气虚弱的小儿，最易见内闭外脱的情况，病儿见神昏谵语或昏愦不语，气息短促，手足厥冷，冷汗自出，舌绛色黯，脉细疾或沉弱。此时则宜开闭固脱合用。可用生脉散或独参汤送服安宫牛黄丸。必须注意的是当险情已过，则又当以肺炎本证常规辨治。^[14]

【按语】

赵绍琴、马湘莲、谢昌仁均采取分型辨治的方法治疗肺炎，各有千秋。曹鸣高认为肺炎属风温之为病，冬春居多，应按风温论治。沙星垣用自拟清气汤治疗大叶性肺炎、沈庆法用泻白散治疗肺炎，均有良效，可资借鉴。张沛虬分三期辨治大叶性肺炎，发病期用银翘散加减，进展期用麻杏石甘汤加味，恢复期用养阴清肺汤加减，提纲挈领，可为临床参考。金厚如诊治病毒性肺炎有独到之处，以卫气营血为辨证指南，以辛凉之剂开肺祛邪，同时用甘寒养阴之品以扶正，收到良效。蒲辅周治疗病毒性肺炎四法（宣透法、表里双解法、清热救阴法、生津固脱法），更是经验的总结与提炼，足资参考。

（吴艳华）

参 考 文 献

- [1] 赵绍琴，曹鸣高，马莲湘，等。肺炎证治。中医杂志，1985，26（10）：6~14
- [2] 陈昭定。金厚如治疗病毒性肺炎医案二则。北京中医杂志，

- 1991, (1): 6~7
- [3] 喜新. 袁正刚治疗外感高热的经验. 中国中医急症, 1992, 2 (3)
- [4] 张琪. 谈临床运用石膏治疗急性热病的经验. 黑龙江中医药, 1983, (3): 1
- [5] 谢昌仁. 急性肺炎的证治体会. 江苏中医杂志, 1983, (6): 14
- [6] 曹世宏, 曹蓓蓓. 曹鸣高教授治疗肺系疾病心法举要. 江苏中医, 1994, 15 (4): 3
- [7] 薛秦. 顾兆农治“大气下陷”验案. 山西中医, 1985, 1 (2): 18
- [8] 陈光新. 董建华老中医运用宣畅气机法则治疗温热病经验. 江苏中医杂志, 1982, (2): 13
- [9] 贺又舜. 苇茎汤加减运用的临床经验. 江苏中医杂志, 1982, (5): 14
- [10] 沈庆法. 泻白散治疗肺炎. 辽宁中医杂志, 1981, (4): 1
- [11] 马崇生. 蒲辅周医疗经验介绍. 辽宁中医杂志, 1983, 7 (4): 15
- [12] 陈启石, 吴孝华. 陶君仁临证治验拾萃. 辽宁中医杂志, 1989, 13 (6): 5
- [13] 郑邦本, 王光富. 郑惠伯巧用甘露消毒丹. 辽宁中医杂志, 1992, 19 (11): 7
- [14] 钟嘉熙. 刘仕昌教授治疗肺炎经验. 新中医, 1994, 26 (1): 21

肺 气 肿

【概述】

肺气肿是指肺脏过度充气，终末细支气管远端（呼吸细支气管、肺泡管、肺泡囊和肺泡）过度膨胀，或同时伴有气腔壁的破坏的病证。引起肺气肿的因素很多，大气污染、长期吸烟和呼吸道慢性炎症时，通气不畅，气体阻滞，使气腔内的压力增加，受损伤的气腔壁膨大，甚至破裂。肺气肿常并发肺部感染、呼吸衰竭、右心衰竭、自发性气胸等。西医治疗以祛痰、支气管解痉、吸氧和必要的控制感染为主。中医认为，肺气肿的发生与外邪侵袭、痰浊壅盛、肺肾虚弱等因素有关，临床辨别虚实最为紧要，如误犯虚虚实实之戒，病情极易恶化。

【名医经验】

1. 窦钦鸿诊治经验

窦氏于临床主要分以下七型施治，每获良效。

①肺气虚型：咳嗽气短，动则喘甚，声低语怯，自汗恶风，舌质淡胖，苔薄白，脉沉弱，治当益肺止咳定喘。方用生脉散合玉屏风散加味：党参 20g，黄芪 30g，白术 15g，五味子 12g，麦冬 12g，防风 9g，麻黄 9g，桔梗 12g，

枳壳 12g，丹参 15g。水煎服。若咳痰清稀者，为阳虚，可加桂枝 12g，干姜 9g。

②气阴两虚型：咳嗽气短，动则喘甚，声低语怯，潮热盗汗，脉细数。治当益气养阴，止咳定喘。方用生脉散合养阴清肺汤加减：太子参 30g，黄芪 30g，五味子 12g，麦冬 15g，玄参 15g，川贝母 12g，地骨皮 12g，丹皮 12g，麻黄 9g，桔梗 12g，山药 15g。水煎服。

③肺肾两虚型：为肺虚肾不纳气，治当益肺温肾，纳气定喘。方用生脉散合济生肾气丸加减：党参 30g，五味子 12g，山药 15g，熟地 15g，炮附子 10g，肉桂 10g，茯苓 15g，苏子 12g，麻黄 9g，川牛膝 12g。水煎服。若偏肾阴虚者，并见腰膝酸软，口干夜甚，五心烦热，舌红，少苔，脉细数，治当补肺养阴，止咳定喘。方用生脉散合百合固金汤加减：太子参 30g，五味子 12g，麦冬 15g，百合 15g，生地 15g，玄参 15g，川贝母 12g，麻黄 9g，桔梗 12g，川牛膝 12g，丹皮 12g，甘草 6g。水煎服。

④上实下虚型：多为感冒而致痰涎壅肺，并下元不足，肾不纳气。治当祛痰止咳，温肾纳气。方用苏子降气汤加减：苏子 12g，麻黄 9g，半夏 12g，前胡 12g，桔梗 12g，瓜蒌 15g，厚朴 12g，肉桂 10g，川牛膝 12g，沉香粉 3g（冲服），党参 15g。水煎服。

⑤热痰壅肺型：治当清肺化痰，止咳定喘。方用麻黄杏仁甘草石膏汤加味：麻黄 12g，杏仁 10g，桔梗 12g，前胡 12g，浙贝母 12g，瓜蒌 15g，生石膏 30g，金银花 30g，黄芩 12g，沙参 15g，生大黄 9g（后入），甘草 6g。水煎服。

⑥寒饮犯肺型：治当温肺化饮，止咳定喘。方用小青龙汤加减：麻黄 12g，半夏 12g，茯苓 15g，桔梗 12g，细

辛 3g, 桂枝 10g, 干姜 10g, 党参 20g, 白术 15g, 葶苈子 9g, 五味子 6g, 川芎 12g。水煎服。

⑦血府瘀阻型:咳嗽气短,胸痛心悸,面晦唇暗,舌质紫暗或有瘀斑,脉弦涩或结代。治当活血祛瘀,止咳定喘。方用血府逐瘀汤合三拗汤加减:麻黄 12g,杏仁 10g,桔梗 12g,枳实 12g,当归 12g,赤芍 15g,川牛膝 12g,柴胡 12g,郁金 12g,太子参 15g,甘草 6g。水煎服。

本病临床辨治实际还要复杂。其病变虽在肺,但关乎脾肾,而且虚多实少。急重时以治肺为主,兼顾脾肾;慢性稳定期则肺脾肾并治,而且各类证型都有不同程度的瘀血表现,故在辨治方中加入活血药,如丹参、丹皮、赤芍、川牛膝等,多能提高疗效。^[1]

2. 邵念方诊治经验

现代医学的肺气肿病,症候多属于中医的肺胀病症。病人往往以咳、喘、痰、肿并见,外感时邪诱发加重,虽经治疗,得以缓解,但其胸中胀满,气短不续则常持续存在。从辨证分析来看,气根于肾,至于肺,久病不愈,肺肾俱虚,肺不主气而气滞,肾不纳气而气逆,清气难入,浊气难出滞于胸中,壅塞于肺。加之脾肾阳虚,水停痰凝,痰随气逆久则阻肺,升降出入气机逆乱,血脉瘀阻运行不畅。病位主要在肺,兼及他脏。

发作期多为正虚邪实,虚实夹杂。治疗当分清虚实,急治其标,或标本兼治。

①肺阴不足,痰浊内阻型:症见外感时邪,发热恶寒,或不恶寒,气急胀满,咳喘烦躁,痰黄粘稠或痰白难咯,面红目如脱状,咽干口渴,舌红,无苔,脉细数。治宜养阴化痰,宣肺清热。方用沙参麦门冬汤合桑杏汤加减:沙参 30g,麦冬

18g, 桑叶 9g, 天花粉 9g, 炒杏仁 9g, 炒栀子 6g, 贝母 9g, 梨皮 9g, 厚朴 9g, 陈皮 9g, 甘草 6g。水煎服, 每日 1 剂。

②肾不纳气, 气不化津型: 症见时邪恋肺, 咳喘气急, 呼呼吸少不能平卧, 胸闷胀满, 动则加甚, 痰涎壅盛, 面色晦暗, 唇舌发绀, 颜面四肢浮肿, 脉细弱无力。治宜固肾纳气, 温阳行水。方用真武汤合生脉散加减: 熟附子 6g, 茯苓 30g, 白术 9g, 白芍 9g, 人参 9g, 麦冬 30g, 五味子 6g, 葶苈子 18g, 丹参 24g, 车前子 (包) 30g, 大枣 5 枚水煎服, 每日 1 剂。

缓解期的调治也是很重要的。肺气肿一般常因外感在冬季发作, 天暖缓解。为了控制反复发作, 要注重冬病夏治, 未病先防, 缓则治其本。这样可以减轻发作程度, 减少发作次数, 长期下去可终止发作。以此提高机体免疫力, 改善肺功能。临床一般治疗有: 一为益气固表法, 用于肺气虚弱, 卫阳不固者, 以玉屏风散加味治疗。配合及单独应用云芝肝泰冲剂, 刺五加片口服, 每收良效。二为培土生金法, 用于脾阳亏虚, 中气不足者, 以补中益气汤加减治疗, 配合及单独应用人参归脾丸或人参健脾丸治疗, 疗效亦著。三为益肾固本法, 用于肾气不固, 元气大伤者。可应用金匱肾气丸、七味都气丸及河车大造丸加减治疗。三法可据证相互应用。除此之外, 病人在缓解期应积极参加体育锻炼, 预防外感, 纠正吸烟不良嗜好, 以及避免烟尘环境。^[1]

3. 刘献琳诊治经验

肺气肿在辨证上有虚、实之分。虚者, 有肺虚、脾虚和肾虚的不同。肺虚者, 呼吸气短, 动则尤甚, 心悸汗出, 舌淡红, 苔薄白, 脉虚弱。治宜补肺益气。用生脉散合补肺汤加减。药用党参 15~30g, 麦冬 9g, 五味子 9g, 黄芪

15g, 百合 30g, 紫菀 15g, 桑白皮 9g。水煎分 2 次服。脾虚者, 呼吸少气, 倦怠乏力, 饮食减少, 咳嗽吐痰, 劳累加重, 舌淡, 苔白, 脉缓弱。治宜健脾益气, 化痰和中, 用六君子汤合生脉散化裁。

如治黄某, 男, 62 岁, 1981 年 3 月 15 日初诊。素有慢性咳嗽, 已 20 余年。近因感冒而咳嗽加重, 胸透双肺纹理增强, 透光度增高。诊为慢性支气管炎合并肺气肿。中医辨为风寒外束, 痰湿内蕴, 脾胃虚弱。治以散寒化痰, 和胃宁咳。用杏苏散加减: 苏叶 9g, 炒杏仁 9g, 半夏 9g, 茯苓 30g, 橘红 9g, 苍术 9g, 白术 9g, 厚朴 9g, 前胡 9g, 紫菀 15g, 款冬花 15g, 甘草 3g, 水煎分 2 次服。服药 9 剂, 恶寒除, 咳嗽止, 吐痰减少, 胃纳转增, 再以健脾益气, 化痰和中, 并令戒烟。用六君子汤合生脉散。服药 15 剂, 气力增加, 胃纳旺盛, 轻微活动, 亦无气喘心慌之感。遂以香砂六君丸以善后。随访 3 年, 情况良好。

肺气肿之实证, 多起病急骤, 咳喘憋气, 吐清稀白痰, 舌质淡, 苔薄白, 脉浮紧或弦。此为肺气不宣, 寒饮内停。治宜宣肺散寒, 化痰平喘, 小青龙汤为基本方。兼喉中痰鸣者, 加炒苏子、炒莱菔子、炒白芥子、葶苈子, 苔黄或口渴或烦躁者, 加生石膏。如治朱某, 男, 42 岁, 1984 年 3 月 15 日初诊。因感冒而咳嗽气喘 3 天, 不能平卧, 恶寒, 头身痛, 吐白痰质稀量多, 舌质淡, 苔薄白腻, 脉浮紧。胸透: 肺纹理增强, 透光度高。诊断为急性支气管炎、肺气肿。中医辨证为风寒外束, 寒饮内停, 肺气失宣, 肃降不行。治宜宣肺散寒, 化痰平喘, 用小青龙汤原方: 麻黄 9g, 桂枝 9g, 白芍 9g, 半夏 9g, 干姜 9g, 细辛 3g, 五味子 9g, 炙甘草 6g。水煎分 2 次服。6 剂后恶寒、头身痛止, 咳喘平。又继服 3 剂, 胸透正常, 疾病告愈。^[1]

4. 王玉生诊治经验

肺气肿多系在慢性气管炎的基础上而伴发，表现为多年反复发病，长期咳喘吐痰，轻者几年，重者十几年或几十年。王氏认为该病多现本虚标实，甚则完全处于本虚状态。本虚是发病的主要原因。对该病的治疗，主要以补益肺脾肾三脏为其大法，“固本平喘汤”即据此而设。药物组成：白术 15g，山药 10g，诃子 10g，五味子 12g，菟丝子 15g，罂粟壳 10g。此方可以改善三脏功能达到不治咳喘而咳喘自平的目的。

①痰湿型：症见咳喘，吐痰量多色白，不欲饮食，胸脘满闷，舌苔白腻，脉滑或缓。方用固本平喘汤加陈皮 12g，清半夏 10g，茯苓 15g。

②痰热型：症见咳喘，吐痰量多色黄，胸闷烦热，大便秘结，小便黄赤，舌苔黄腻，脉滑数。方用固本平喘汤加瓜蒌 30g，黄芩 12g，大黄 6g。

③虚寒型：症见咳喘，吐痰清稀色白，形寒畏冷，甚或下肢浮肿，大便稀薄，舌苔白而滑润，脉沉缓或沉迟。方用固本平喘汤加干姜 10g，肉桂 6g，补骨脂 12g。

④阴虚型：症见咳喘，无痰或吐痰量少黄稠，潮热口干咽燥，或手足心热，舌红，少苔或无苔，脉细数。方用固本平喘汤加百合 15g，麦冬 12g，沙参 12g。

肺气肿常因肺卫气虚而感冒，经常感冒亦是咳喘加剧的原因之一，故而预防治疗感冒的措施也应加强。^[1]

【按语】

众医家治疗肺气肿均从辨证分型论治。窦钦鸿分七型：

①肺气虚型，②气阴两虚型，③肺肾两虚型，④上实下虚型，⑤热痰壅肺型，⑥寒饮犯肺型，⑦血府瘀阻型。邵念方分两型：①肺阴不足，痰浊内阻型，②肾不纳气，气不化津型。王玉生分四型：①痰湿型，②痰热型，③虚寒型，④阴虚型。各具特色，基本囊括了肺气肿的临床分型，可指导临床辨治。

(郭桃美)

参 考 文 献

- [1] 奚钦鸿，周次清，邵念方，等. 肺气肿、肺心病的辨证施治. 中医药研究，1988，(2)：2~5

肺 脓 疡

【概述】

肺脓疡是由多种病原菌引起的肺部化脓性炎症，继有坏死、脓肿形成。以咳嗽、胸痛、发热和吐痰腥臭、甚则咳吐脓血为主症。自抗生素广泛应用以来，发病率已明显降低。现代医学认为本病的治疗原则是抗菌和引流。肺脓疡与中医的“肺痈”颇为相似，其发生与机体内在因素密切相关，正气内虚，或痰热素盛，或嗜酒不节、过食辛热厚味，致使湿热内蕴，上蒸于肺，在此基础上感受外邪，其中以风热病毒为多见，或风寒化热，内外合邪，热毒壅肺，蓄热内蒸，热壅血瘀，热盛则肉腐血败，化而为脓成痈。中医治疗肺脓疡，初期宜清肺散邪，成痈期宜清热解毒化瘀，溃脓期宜解毒排脓，恢复期宜益气养阴。

【名医经验】

1. 朱良春诊治经验

朱氏认为治肺脓疡，必须侧重清热解毒，化瘀排脓，庶奏佳效。历代名方如葶苈大枣泻肺汤、桔梗汤、千金苇茎汤等均为民家所常用；流传于民间的单方草药，亦常有著奇功者。江苏省南通市中医院自 60 年代采用成方龙氏家

传治肺痈之金荞麦，先后经临床验证达千余例，疗效满意。

金荞麦即蓼科植物之野荞麦，已编入 1977 年版《中国药典》，具有清热解毒，润肺补肾，活血化瘀，软坚散结，健脾止泻，收敛消食，祛风化湿之功。常用于急性咽炎、扁桃体炎、痢疾、痈疽肿毒、风湿痹痛、赤白带下、蛇犬咬伤等病。成氏原来的传统制法：金荞麦根 250g，用瓦罐密封，隔水蒸煮为棕色液体约 1 000ml，每次服 40ml，每日 3 次。剧者加黄酒一半，与水共煎煮，可增药效。后由中国医学科学院药物研究所提取其主要成分——黄烷醇，制成片剂，每次服 5 片，每日 3 次；同时还制成全成分的浸膏片，每片含生药相当于 1.5g，每次服 5 片，每日 3 次，两者效果大致相同。患者在服药后每见咯痰增多，由于脓痰大量排出，热挫纳增，空洞也随之缩小，液平消失，病灶逐步吸收而痊愈。

据中国医科院药物研究所等单位对金荞麦的分析研究表明，本品系一种新抗感染药，有抗炎、解热、抑制血小板聚集和增强巨噬细胞吞噬功能等作用。它虽然不直接杀菌，但可通过调节机体功能，提高免疫力，降低毛细血管通透性，减少炎性分泌，改善局部血液循环，加速组织再生和修复过程，从而达到痊愈的目的。

在恢复期，配合服用南通市中医院自制的补肺粉：白及 240g，浙贝母 90g，川百合 90g。偏阴虚者加麦冬 60g，北沙参 60g；偏气虚者加炙黄芪 60g，太子参 60g，共研极细末，加 100g 白糖和匀。一般每次服 9g，每日 2 次，甚有裨益。^[1]

2. 魏长春诊治经验

肺脓疡诊断往昔主要以咯吐脓性臭痰为依据，因此在

明确诊断时已属脓成之期，而塞肺之脓须从气道随痰一起排出体外，故宣肺豁痰又为基本治法之一。多年来，魏氏按仲景之旨，以自订加味桔梗苇茎汤增损运用于临床，每能应验。

加味桔梗苇茎汤系由桔梗汤、千金苇茎汤加紫菀、白前而成，如灵活化裁，可适用于肺脓疡各期。全方取桔梗为君药，以其有宣肺祛痰、排脓散结之功。桔梗之量宜大，用9~15g，若药后略有恶心亦无妨；因反可助脓痰之排出。方中桃仁活血祛瘀、消滞散结，并能止咳下气，既符合治痢以活血为法之本意，又合肺气以肃降为顺之生理特点。薏苡仁、冬瓜仁化痰浊、清湿热、散滞气；鲜芦根代苇茎能养阴清热（苇茎、桃仁、薏苡仁、冬瓜仁四味即千金苇茎汤，系治疗肺痈脓成未溃的名方）。紫菀、白前均具祛痰、止咳、下气之作用，且紫菀还有宁络止血的功效，两者合用，善治咳逆上气、胸胁痞痛、久咳唾血之证。生甘草可泻火解毒，还能调和诸药。如经X线确诊的早期肺脓疡，若其表证未罢，脉浮苔薄，形寒畏风者，可加用牛蒡子、野菊花、金银花、连翘；若热势盛，脉数苔黄，口渴喜饮者，则加黄芩、焦山栀、黛蛤散、知母、天花粉；若胸胁痞痛甚者加浙贝、瓜蒌、郁金；咯臭痰且夹血者，加仙鹤草、藕节、白及、蛤粉炒阿胶珠；若病久，脉细舌绛，形体羸瘦，指端如杵者，加麦冬、北沙参、孩儿参、鳖甲、牡蛎等。唯高热炽盛，咯血量多者，非本方所宜，以中西两法合治为妥。^[1]

3. 叶景华诊治经验

肺脓疡属中医肺痈，为内痈重症，临床主要见症为咳嗽胸痛，咯吐脓血；振寒发热。肺痈多由于肺受邪侵，邪

瘀阻滞，郁久不解，蓄结蕴蒸，酿成痈脓。叶氏认为可分2个阶段进行治疗。

①肺痈成脓破溃期：临床主要表现壮热，咳嗽，胸痛，咯大量脓痰，治疗应一方面清热解毒，使肺叶不再受邪毒燔灼而腐败，一方面须祛痰排脓，使已酿成的脓痰尽快促其排出，腐不去，新不生，且壅滞于肺叶助长邪热的鸱张。叶氏采用单方鱼桔汤并参照《景岳全书》上的如金解毒散和千金苇茎汤加减组成复方鱼桔汤：鱼腥草 30g，桔梗 15g，黄连 6g，黄芩 15g，金银花 30g，甘草 4g，桃仁 10g，生薏苡仁 30g，冬瓜仁 30g，象贝母 10g。热毒盛而高热持续不退者，重用清热解毒之剂，黄连可每日用至 15g，研末装胶囊吞服。肺与大肠相表里，邪热盛者，往往大便秘结，可加用生大黄 10g 以通腑泄热；胸痛甚者加丝瓜络、郁金；咳血者加黛蛤散、侧柏叶；如有汗多、气促、脉细、神疲等正虚现象者，加黄芪、党参。服药后部分病例咳嗽反增剧，咳出大量脓痰后，咳嗽渐减少，在这阶段服药须坚持每日 2 剂，待病势基本控制，肺部炎性病变明显消散，空洞内液平消失，才可减轻药量，否则病情易反复。

②肺痈溃久正虚期：一部分病例经治疗后邪势衰退，病情已基本控制，发热退，咳减，脓痰已无，肺部炎性病变已明显消散，空洞内无液平，以正虚为主，则宜清养补肺，叶氏用黄芪 30g，孩儿参 15g，北沙参 15g，甘草 4g，合欢皮 30g，白及 10g，生薏苡仁 30g，桔梗 6g。一部分病例低热不退，咳嗽尚有少量脓痰，肺部炎性病变尚较明显，并有正气虚弱情况，则宜扶正祛邪兼顾，上方中减去白及，加鱼腥草、黄连、黄芩、冬瓜仁、桃仁、象贝母。连续服药至症状消除，肺部炎性病变完全消散，空洞闭合仅残留纤维阴影，痊愈为止。^[1]

4. 贝叔英诊治经验

贝氏认为，肺痈（肺脓疡）之施治，应以清热解毒和消痈排脓为法，还要掌握不同阶段的特点，才能使辨证正确，取得较好效果。

病初，常见发热微恶寒，咳嗽胸痛，咳时加剧，痰较粘稠，甚则呼吸迫促，舌苔薄黄，脉浮数。此时肺卫俱热，当用银翘散加减以辛凉宣泄，清热解毒。芦根清热生津，用量宜大；淡竹叶清心除烦，必不可少；酌加浙贝母宣肺化痰；选用蒲公英、鱼腥草或败酱草，以增清热解毒之效，起轻宣消痈之功。

中期，脓疡已成，见高热寒战，烦躁自汗，咳嗽剧烈，胸痛难忍，辗转不安，吐大量脓痰，且有明显腥臭味，口干咽燥，舌红，苔黄，脉象滑数，表示病势炽盛，应及时重用千金苇茎汤以清肺泄热，除痰排脓。贝氏曾在病房治疗过 16 例肺脓疡患者，均以千金苇茎汤为主，再加鱼腥草、金荞麦、桔梗、连翘、浙贝母作为基本方。鱼腥草常用 30~60g，金荞麦亦用 30g。此外，咳嗽厉害加桑白皮、杏仁；咳痰腥臭加败酱草、金银花；胸痛明显加郁金、丝瓜络，有时加用忍冬藤或络石藤，络通则痛自减。若呼吸迫促，喘不得卧则加葶苈子、红枣以泻肺；脓痰带血则加侧柏叶、白茅根、藕节炭；在血量较多时则常加三七与白及研末冲服，效果较满意。

病的后期，身热渐退，但常心烦气短，口渴咽干，胸闷胀满，隐隐作痛，可咳吐脓痰如米粥状，舌质红，脉细数，示痈溃而正虚。因肺脓疡在发展过程中最易耗气伤阴，尤其在大量脓痰排出之后，更需选用益气养阴剂，为此贝氏采用养阴清肺汤，以扶正气，清余热。但补肺气不宜过

用甘温，以防助热伤阴，养肺阴不宜过用滋腻，以防碍胃气。益气生津以太子参为宜，养阴则以沙参、百合、麦冬为妥。必须指出的是，本病不宜补之过早，必须在热退、咳减、痰少的情况下，且有虚象时，才可适当用补，以防余热留恋，延长病期，不可不慎。^[1]

5. 韩为琨诊治经验

韩氏认为，肺脓疡（肺痈）的特点是发病急骤，寒战高热，咳嗽胸痛，痰多且臭，甚则咳脓血或咯血，一派热灼肺经，痰浊壅盛的热证、实证表现。因此，在治疗上，已非一般辛凉清解轻剂所能克功，而应采用大剂量苦寒清解之品，佐以化痰利络，以直折壅结肺经热瘀之邪。韩氏常用银翘白虎汤合小陷胸汤加减：金银花 30g，连翘 15g，知母 12g，生石膏 30~60g，黄芩 15g，瓜蒌 15g，法半夏 12g，桔梗 10g，败酱草 30g，栀子 12g，蒲公英 30g，甘草 3g。水煎服，每日 1~2 剂，分 6 次服。高热神昏谵语者，加服安宫牛黄丸。若脓痰量多且甚腥臭者，可用黄芩知母汤合桔梗汤加减：黄芩 15g，知母 12g，杏仁 12g，桑白皮 15g，栀子 12g，桔梗 10g，全瓜蒌 15g，败酱草 30g，野菊花 15g，法半夏 12g。若咳吐脓血较甚者，选用千金苇茎汤合茜草散加减：苇茎 30g，冬瓜仁 30g，桃仁 12g，薏苡仁 30g，黄芩 15g，茜草 15g，侧柏叶 15g，藕节 18g，仙鹤草 30g，败酱草 30g，浙贝母 15g，黄芪 30g。若病的恢复期出现低热口干、心烦少寐、消瘦自汗等津气两伤证候，应以益气养阴为法，佐以清解，选清燥救肺汤加减，可望收全功。^[1]

6. 陶志达诊治经验

陶氏认为，肺脓疡（肺痈）乃大热大毒之证，不能套

用一般清热解毒的常法处理。必须趁正气未衰之机，速战速决，用势专力猛之药，攻下泻热，使邪有出路，病方可速愈。故应在清热解毒方剂基础上加用大承气汤之类，或合用葶苈大枣泻肺汤、泻白散等，以攻逐痰热，起釜底抽薪、急下存阴的作用。即使大便不干硬，也可借用。攻下虽然有伤正气，但可采取衰其半即止的办法，继之以大剂清热解毒，仍可收到良好效果。至于对一些服数剂即见正气虚弱的病人，可以采取间隙应用法，与其他治法交替运用。

陶氏还认为，瘀热郁结血脉，是肺脓疡的一个重要环节。因此，在处方中加用祛瘀散结之品，可有助于恢复。除桃仁、赤芍外，可用三棱、莪术、王不留行。至于大黄，除荡涤热毒之外，亦入血分，兼具祛瘀之功，在正气尚足的情况下，用之较桃、红的功效更佳。^[1]

7. 张沛虬诊治经验

张氏除用千金苇茎汤合桔梗汤加减治肺脓疡外，多年来用采自民间的单方草药，疗效相当良好。例如：①鲜鱼腥草 100g，捣烂取汁，用热豆浆冲服，每日 2 次。在初服时可有泛恶感觉，但能促使排出大量脓痰。如连服几次，泛恶感觉消失，症状亦随之改变。②金荞麦根 60g，隔水炖汁，加少量米酒，分 2 次服。张氏常将此二药同时加于汤剂中，疗效明显提高。此外，红藤、败酱草原为治肠痈之要药，张氏移用于治肺痈，效果也较好。^[1]

8. 张发荣诊治经验

张氏以加味千金苇茎汤治肺脓疡，收效良好。处方为

苇茎 15g, 薏苡仁 30g, 冬瓜仁 30g, 桃仁 12g, 金银花 15g, 千里光 15g, 苦荞头 20g, 鱼腥草 30g (鲜者 60g)。煎药时, 金银花及鱼腥草后下, 注意保留其气味。本方薏苡仁、冬瓜仁、苦荞头相伍, 还有健脾除湿和对抗千里光、鱼腥草苦寒伤胃之妙。在肺病的成痈期和溃脓期, 均可采用本方治疗。若热势燎原, 病情重笃, 应每日用 2 剂, 日服 6 次。脓溃之后, 若热退而脓痰仍多者, 则于本方去千里光, 加黄芪 20g, 桔梗 10g, 以托里透脓。病至恢复阶段, 肺阴耗伤, 证见咳嗽吐痰不爽, 口干舌燥者, 去千里光, 另加麦冬、玄参、天花粉各 10~15g。

本病误治失治, 常可导致病程迁延, 咳嗽吐痰, 胸中隐痛, 面色苍白, 消瘦乏力, 形成慢性肺病。此时气血亏虚为本, 邪气残留为标, 若拘泥于清热解毒一方, 每多罔效。当用八珍汤以补益气血治其本, 另加黄芪、桔梗、白芷、皂角刺、金银花以托里透脓解毒治其标。若痰多者, 还可加服皂荚丸。此丸用猪牙皂 60g, 研末炼蜜而成。^[1]

9. 黄志强诊治经验

黄氏认为, 肺脓疡初起状似感冒, 往往易被忽视而延误病机。就临床所见, 来诊者大多已趋酿脓或成脓期, 故如何在此时掌握病机, 稳准狠直折病势, 截断疾病的进展, 实为本病的关键所在。本病一俟成痈, 临床表现突出, 常见寒战发热, 咳嗽, 胸痛, 吐痰腥臭, 甚则咳吐脓血, 所以诊断已属不难, 若能借助胸部 X 线诊断则更为准确。在这热毒炽盛, 热壅血瘀, 壅酿成脓之时, 治疗必须清热解毒, 化瘀排脓双管齐下。黄氏多年来用自拟消痈汤屡试不爽。药物组成: 鲜芦根 120g, 蒲公英 30g, 土茯苓 30g, 薏苡仁 30g, 鱼腥草 30g, 冬瓜仁 30g, 象贝母 12g, 黄芩

10g, 桃仁 10g, 桔梗 15g。从黄氏运用经验看, 鲜芦根对本病治疗有特殊之效, 用量宜重, 以新鲜多汁为佳, 干则少效。土茯苓善于搜剔痰瘀之蕴毒, 治疗本病亦有良效, 值得重视。如热毒较甚者, 加三叶青、黄连、生石膏, 其中三叶青对肺中热毒的清解乃在诸药之上, 宜首选; 气喘者, 加桑白皮; 口渴甚者, 加南沙参、北沙参、天花粉; 大便燥结者, 加生大黄; 咳血多者, 加鹿衔草。

本病待热退脓排, 病趋恢复, 往往气阴亏损, 余邪未清, 表现为咳少, 神疲, 纳呆, 口干, 舌红, 苔薄, 脉细数。宜益气养阴以复其元, 清热化痰以理余邪, 且不可纯用补剂, 以免助邪资寇, 死灰复燃。黄氏根据临床分两类予以调理。以阴虚为主者, 用自拟五参清肺饮善其后, 方由南沙参、北沙参、玄参、党参、丹参、芦根、百合、象贝母、玉竹、桑白皮、冬瓜仁组成, 功在养阴清热, 润肺化痰。若以气虚为主, 肺脾兼伤者, 用自拟生金九味: 即六君子汤加北沙参、黄芪、川贝母。

如治龚某, 男, 28岁, 鼻塞, 咳嗽, 发热5天。近2天来, 寒战发热渐增, 咳嗽频剧, 气急, 咳痰黄稠如脓, 有腥臭味, 伴左侧胸部疼痛, 咳则痛剧, 汗多, 大便2日未行, 纳谷不进, 口干, 面焮红。血检: 白细胞 $12.5 \times 10^9/L$, 中性 0.835, X线胸片示: 左中、上大片浸润阴影, 内有直径约 3cm 左右空洞, 并有液平线。提示: 左肺脓疡, 体温 38.7°C , 舌深红, 苔黄腻, 脉滑数。热毒已成酿脓之势。治宜清热解毒, 祛瘀排脓, 佐通腑气, 予消痈汤出入: 鲜芦根 120g, 蒲公英 30g, 鱼腥草 30g, 土茯苓 30g, 三叶青 10g, 生大黄 (后入) 10g, 黄芩 10g, 桔梗 15g, 薏苡仁 30g, 冬瓜仁 30g, 象贝母 10g。3剂后, 发热渐退, 体温 37.6°C , 便通, 余症如前。乃于原方去生大黄, 加减化裁, 共服 20余

剂，痰无腥臭，胸痛止。尚有少量咳嗽，纳欠香。乃予五参清肺饮加谷芽、麦芽，连服 10 余剂，症平，X 线摄片复查，空洞未见，炎症吸收，存留小块瘢痕状阴影。^[1]

10. 王廷富诊治经验

肺脓疡（肺痈）一般可分三期，即初期（表证期）、中期（成痈期）、后期（溃脓期）。王氏认为：肺痈溃脓期热毒瘀结于肺，日久不仅阴液耗伤，脾肺之气亦受损。根据素体和病程之差异，又可分为两型，即肺脾阴虚型和肺脾气虚型。前者症见胸痛日剧，咳嗽频繁，咳唾脓血（或脓多血少，或脓血兼夹，或纯血无脓），其脓痰秽臭甚，潮热自汗，形体消瘦，面色萎黄，两颧潮红，脉象虚数，舌质红、苔少乏津，治宜滋肺益脾，排脓止血。药用：沙参、茯苓、桔梗、甜杏仁（捣，去油）、大枣、阿胶、乌梅、桑白皮、地骨皮、鱼腥草、甘草。后者症见亦咳嗽频繁，咳时胸痛难忍，咳痰脓血兼夹，神疲力乏，面色萎黄或惨白，脉细虚数，舌质淡红，苔少微润，治宜补肺实脾，排脓止血。药用：太子参、薏苡仁、茯苓、桔梗、甜杏仁、阿胶、大枣、浮小麦、鱼腥草、甘草等。

值得提出的是桔梗一药，其味虽平，但开肺排脓之力强，因此，在用量上必须严格掌握。如脓多血少，可用 12g，脓血兼夹者，10g 为宜；脓少血多者，6g 已足；纯血无脓则禁用，可改投白及（重用）以填肺止血。

恢复期善后，可用药膳相助，如以沙参、薏苡仁、山药、芡实、莲子、大枣、白及蒸肉吃。肺阴虚者，可进百合。^[1]

11. 洪广祥诊治经验

洪氏认为，肺脓疡（肺痈）的病机主要为邪热郁肺，

热郁是形成痰热瘀阻，化腐成痛的病理基础。临床呈现以邪热盛实的证候为主，但脓疡溃后，或病势迁延，又可出现气阴耗伤，或正虚邪恋之象。因此肺脓疡的治疗，要突出清热、排脓、化瘀、扶正的治法，其中清热法贯穿治疗的全过程。从已往治疗肺痛的失败病例分析，主要原因之一，是清热不得法、不彻底，以致失去控制病势发展的主动权。

①清热：清热是肺痛的基本治法，可分为清宣和清泄两个方面。所谓清宣，即清热宣肺，主要用于肺痛初期，相当于化脓性肺炎阶段。此期用药不宜过于寒凉，以防肺气郁遏，邪热伏闭，迁延不解。洪氏常选用忍冬藤 30g，连翘 15g，鱼腥草 50g（后煎），抱石莲 30g，生麻黄 10g，桔梗 15g，生甘草 10g，作为肺痛初期的基本方。如寒热交作，加北柴胡 20g，黄芩 10g；胸痛明显，加郁金 15g，瓜蒌皮 15g；咯痰不畅者，加浙贝 10g。洪氏体会，此方优于银翘散加减的疗效，对截断病势发展有较强作用。方中麻黄是关键药之一，它不仅能宣肺解表，其与清热药配伍，还可起到防止寒凉药物郁遏肺气之弊，有利于邪热的消散。泄热，即清泄肺热，主要用于肺痛成脓期及溃脓期的热毒壅盛阶段。在择药上要选用效大力专泄热消痈之品，以有利于炎症控制和痈脓的消散。洪氏常用黄芩 15g，鱼腥草 50g（后煎），野菊花 15g，败酱草 15g，虎杖 15g，蒲公英 30g，生大黄 10g（后煎）组成基本方。如白细胞总数在 $10 \times 10^9/L$ 以上，中性粒细胞增加者，可加大败酱草的用量至 30g；寒热交作者，加北柴胡 30g；气急胸憋甚者，加葶苈子 10g，枳实 15g。本方由于量大药凉，易伤脾胃，必要时可酌减用量，并加和胃之品，如白蔻仁、陈皮等。

②排脓：临床经验证明，影响肺痛疗效的主要原因是

排脓不畅，所以“有脓必排”是肺痈的重要治则。排脓方法有三：一为透脓。用于脓毒壅盛，而排脓不畅者。常用穿山甲、皂角刺、金荞麦根、桔梗等，其中桔梗用量最大，约15~30g。溃脓期咯血量不多，不宜用透脓药。二为清脓。所谓清脓，即清除脓液之意，是肺痈排脓的常规治法。目的是加速肺痈患者脓液的清除，以缩短病程，促进愈合。常用生薏苡仁、冬瓜仁、桔梗、浙贝、瓜蒌、桃仁等。三为托脓。主要用于肺痈溃脓期，气虚而无力排脓外出者，此时可配合托脓法。常用生黄芪、党参或太子参、棉花根等。但在毒盛正不虚的情况下，不可施用托脓法。否则不但无益，反而滋长毒邪，使病势加剧，而犯“实实”之戒。

③化瘀：肺痈成脓及溃脓期，瘀血征象均较明显，故化瘀为肺痈主要辅助治法之一，常与清热、排脓法结合使用。临床经验证明，化瘀可改善肺部缺氧，促进血流通畅和脓液的排出，从而有利于炎症的吸收和脓液的消散。洪氏在临床上，喜用丹皮、赤芍、卫矛、红藤、桃仁、郁金、三七等化瘀之品。但对出血量多者，又不宜使用。可改投花蕊石、生蒲黄、三七、藕节、茜草等化瘀止血药。

④扶正：主要用于肺痈恢复期，或病情迁延，邪恋正虚者。肺痈见虚证，多以气阴两虚为主，在个别情况下，也可见气阳虚。肺痈扶正重在养阴补肺，但不可忽视补脾，因脾为肺之母，补脾能助肺益气，有利于补肺生肌，促进痈疡的愈合。洪氏常用养阴清肺合沙参麦冬汤加减：北沙参、麦冬、生黄芪、百合、淮山药、薏苡仁、冬瓜仁、白及、桔梗、生甘草。如有低热加十大功劳叶、地骨皮；咳嗽重者，加紫金牛、百部；饮食差者，加鸡内金、白蔻仁；胸闷痛者，加郁金、瓜蒌皮。对于脓毒未净、邪热未清者，仍须配合清热、排脓方药，切忌单纯补益，以致邪留不去，

而使病情缠绵反复。^[1]

12. 王玉玲诊治经验

肺痈起病之初多为实邪,《金匱》云:“若口中辟辟燥,咳即胸中隐隐痛,脉反滑数,此为肺痈。”以脉测证,滑主痰,数为热,热结痰瘀壅阻肺中,肺叶受其熏灼,致血肉腐化而逐渐成为痈脓。故初起之治,王氏强调宜攻不宜补,急当泻肺豁痰,泄其郁热,热清痰少,则肺脏清宁,复其治节之能,不至酿成痈脓。方用金匱葶苈大枣泻肺汤,用治痈之始萌而未成者。曾治钱某,年30余,春初患咳嗽,伴有寒热,医初作外寒内饮治,用小青龙汤未效,继用麻杏石甘汤宣肺清热,而咳嗽依然不能平卧。吐痰如脓,自觉有微臭,胸中隐痛,汗多口干,舌红、苔黄腻,脉滑数。王氏诊为肺痈初起,痰热蕴结,壅于肺络,急予泻肺去壅之葶苈大枣泻肺汤,遂疏葶苈子30g,大枣10枚,煎浓汤2次与服。次日复诊,喘平汗敛,胸痛已止,惟吐脓痰甚多,但已不感腥臭,继用清肺豁痰之剂,调理周余而痊。

肺痈初起治不及时,热伤肺脏,因变痈脓,表现为胸痛咳逆,吐脓如米粥,臭气外溢,此时若按金匱用桔梗汤,势必力微难及,养痈贻患。王氏主张此时应以祛邪除痰抉其痈脓为急务,运用外台桔梗白散,即使病体稍虚,亦可攻而后补,颇能达到速战速决,“邪去则正安”的目的。桔梗白散方中巴豆破积逐水,化痰排脓,贝母开胸结,桔梗宣肺气,不作汤而作散,取散者散之之义。

如秦某患肺痈症,胸痛咳逆气喘不能平卧,吐臭脓痰较多,在本地医院治疗多日未效,遂转王氏处就诊。诊见面无华,桶胸,鼓槌指,喘汗吁吁,知肺痈已成,幸尚能饮食,乃胃气未败。因肺痈为实邪,失治邪气愈盛,虽云

脓溃则正虚，然补之实锢其邪，正气亦必然自败，所谓“养痍貽患”者也，即书桔梗 1g，川贝母 1g，巴豆霜 0.6g，共研细末，分作 2 次服，用米汤送下，藉谷气以保胃气，复后呕吐大作，吐出臭脓痰约 2 盂；喘急渐平，且能安卧，继解溏便 1 次，神疲息弱，大虚之象毕露。转急投黄芪、党参、麦冬、百合、白及、山药等补益气液，佐金银花、甘草清热解毒，连进 7~8 剂，渐以向愈。

肺痈患者素禀体弱，或老年病程久延，正气虚衰，而内热较甚者，治疗应慎重考虑，不可孟浪徒攻。王氏尝用千金苇茎汤，方中薏苡仁、冬瓜仁、桃仁肃肺除痰，逐瘀排脓，特别重用鲜芦根以清热生津。本方适用于肺痈邪盛而正偏虚者。尤在泾称“此方具有下热散结通瘀之力。而重不伤峻，缓不伤懈；可以补桔梗汤、桔梗白散二方之偏。”

如治孙某，年 60 岁，素有痰湿病，咳嗽二三月不已，后复发热。咳痰如脓且有腥臭气。痰中时带血丝，胸膈隐痛，舌红、苔黄腻，脉大稍数。胸透提示左肺脓疡。此为风伤皮毛，热伤血脉，积久而蓄积痈脓之症。其为病也，热结痰瘀，胶结不解，肺脏壅阻不通，部分肺叶蒸烂，致吐出臭脓痰，而气息不平。老年久病，正气先虚，然脓痰蕴结于内，又非排除不为功，排脓非难，善后实难。千金苇茎汤能开泄肺气，清其郁热，且能破其痰瘀，决其痈脓。遂用桃仁 12g，冬瓜仁 30g，薏苡仁 30g，桔梗 10g，象贝母 10g，甘草 3g，鲜芦根 150g。煎服 3 剂，脓痰渐少，腥臭亦减，夜已能卧，再用前方续进 1 周，咳减脓痰渐消，胸痛亦止。再予养阴清肺除痰之剂善后。肺痈后期，痈脓已去，余邪未清，而肺阴耗伤者，当以补养肺阴，肃清余邪为治。王氏常用沙参、麦冬、黄芪、百合、川贝母等养

阴清热化痰。^[2]

13. 何任诊治经验

《素问》云：“肺之壅，喘而两胁满。”《金匱要略》谓：“口中辟辟燥，咳即胸中隐隐痛，脉反滑数，此为肺痈咳唾脓血。”并常有口干，鼻塞涕出，形寒毛耸，喘满，胸满胀，咳，唾浊，吐脓如米粥，喘不得卧，身面浮肿等症状。这些症状均在从各种起病原因到形成肺痈的过程中有所出现，并非每一肺痈患者都有以上症状。综观肺痈之证，多由于感受风寒未经发越，停留于肺蕴发为热。或由湿热痰浊蒸淫肺窍所成。肺痈乃邪毒蕴结，为有形之血结。所谓血结者，当排其毒，此是治法概要。如《金匱》治肺痈之专方有桔梗汤（桔梗、甘草），用于脓已溃后或较轻之症；葶苈大枣泻肺汤（葶苈、大枣）用于肺实壅塞，喘不得卧之重症。另如千金苇茎汤（苇茎、薏苡仁、桃仁、冬瓜仁），常用于肺痈初起，形寒身热，口干，咳嗽，胸痛，脉滑数者，酌加连翘、炙百部、金银花、桔梗等，清热疏风，散结逐瘀。至于高热，咳甚，气促，胸闷，痰中脓血，吐如米粥样者，则于上方中酌加清热解毒之品。病势稍缓或热退，咳减，脓痰减少，舌红、苔微黄，脉虚数者，则为邪渐退而正虚之状，常需清余邪，养阴液，可酌参用《金匱》麦门冬汤（麦冬、半夏、人参、甘草、粳米、大枣）。历来治肺痈之常用者，除有桔梗汤之升提、葶苈大枣汤之泻肺、千金苇茎汤之疏利气血、麦门冬汤之清养外，还应因症状之不同而随症施方。何氏常以千金苇茎汤为基本方制成银花大贝汤（冬瓜仁、炙甘草、沙参、薏苡仁、桃仁、芦根、麦冬、玄参、浙贝母、金银花、桔梗、百部、连翘、蒲公英），随症加减，常有明显疗效。如治陈某，女，25

岁。身热咳嗽已久，咯痰大量如米粥状、粘稠、色黯，胸闷隐痛，苔白，脉数实。某医院 X 线检查见肺部有炎症阴影，其中有圆形透亮区及液平面。予清热除痰解血结排邪毒。处方：炙百部 15g，北沙参 9g，浙贝母 9g，玄参 9g，薏苡仁 12g，金银花 12g，麦冬 12g，蒲公英 20g，鲜芦根 20g，冬瓜仁 20g，桔梗 6g，生甘草 6g。服上方 5 剂后，身热除，咯痰大减，咳嗽亦减，后在上方基础上略事加减，以清余邪，泄化痰浊，复其肺津而治愈。^[3]

14. 顾丕荣诊治经验

顾氏认为，病有难治易治之分，治有常法变法之别，故凡医者，必须知常达变。其治肺痈重症，《金匱》虽云“脓成则死”，但在临证中顾氏将徐灵胎“甘凉、滋养、滑降、芳通、解毒、填孔”六法，与曹颖甫“先用开泄，继用清养”二法，灵活地融为一炉。具体方法如：①涌泄之剂排其脓；用三物白散；②甘凉之法清其火，选苇茎汤；③滋润之品养其血，如养肺汤；④滑降之味祛其痰，如竹沥、梨汁、陈芥菜卤、姜仁、川贝等；⑤芳香之物通其气，如太乙紫金锭；⑥珠黄之类解其毒，如珍珠、犀角（以水牛角代）、人中黄等；⑦金石之药填其孔，如月石、滴乳石、尿浸石膏等；⑧清养之方善其后，如加味麦门冬汤。

如治吴某，男，56 岁。发热 5 天，咳吐脓痰夹血，右胸痛。X 线摄片提示右侧肺脓疡，连进抗菌消炎药无效，邀顾氏会诊。先予清肺熄焰，继投滋润生津，恙情渐轻。但 X 线片发现右侧第二肋间见椭圆形面积 $2\text{cm} \times 0.7\text{cm}$ 大小空洞，改用王氏圣灵丹，以合欢皮 30g，白及 9g，麦冬 9g，百合 18g，北沙参 12g，桔梗 3g，生草 3g，煎汤送服，每日 2 次，连服 1 周，X 线片阴影及透光区均已消失。续

以清养善后。^{〔4〕}

15. 王德元诊治经验

肺痈之候，一般治用桔梗汤、千金苇茎汤加减，即可获效。但重症者治疗却有不同。

如治朱某，女，28岁。1月前始则寒热（ $T38.6^{\circ}\text{C} \sim 39.5^{\circ}\text{C}$ ），咳嗽，右肋作痛，呼吸不利，当地卫生院治疗3天，病情日见加重，遂转至某医院住院治疗，诊断为肺脓疡。经用西药抗生素静脉滴注及中药宣肺排脓、清热解毒等治疗，症势有增无减，高热不退，咳嗽肋痛，吐出大量秽臭脓痰。胸透复查，提示为脓胸，进行外科手术引流，但病情日趋危重。乃邀王氏会诊。诊见：高热（ 39.5°C ）有汗不退，面赤唇干，头昏神疲，形色枯瘦，咳嗽脓痰，秽臭带血，喉中吼吼有声，鼻翼煽动，日夜端坐倚息，不能平卧，呻吟不已；右肋外侧手术创口时而流出清稀脓液，隐隐作痛；心烦不寐，夜间喃喃谵语，口干不欲饮，纳谷极少；舌绛质嫩、苔黄略腻、无津，脉细数而弱。此乃温邪搏肺，灼炼肺津，热结肉腐成脓。今热势鸱张，有阴竭营枯、化源欲绝之变，险象毕露，速予扶阴救营，解毒清热，排脓保肺。处方：犀角6g（磨冲），鲜生地30g，玄参20g，赤芍15g，丹皮10g，桔梗10g，生甘草10g，冬瓜子30g，生薏苡仁30g，鲜芦根30g。服2剂，热势已降， $T37.6^{\circ}\text{C}$ ，咳嗽明显好转，脓臭痰少，血止，已能平卧，纳谷略香，舌绛稍淡有津，脉数转缓有神。此乃津回阴复，营热渐化，痰热渐竭，肺气渐肃之佳象。前方去犀角、生甘草，玄参减为15g，加北沙参15g，麦冬15g，萎皮根15g，续服3剂，热清，咳嗽渐平，脓痰少，唯纳谷不多，乃以原方加山药、炙鸡内金、炒扁豆、炒麦芽等健脾醒胃

之品，调理月余，痊愈出院。

本例患者由于温燥之邪袭肺，病情重，来势猛，虽然输液、抗生素加中药、甚至手术引流等治疗，未能控制病情，反而病情日趋恶化，以致发展到高热不退，咳喘气急，鼻翼煽动，端坐倚息，心烦谵语，舌嫩绛、苔干黄，脉细数而弱等阴竭荣枯、化源将绝之危候，非以大剂犀角（注：现已不用，或用水牛角代之）凉血解毒，生地、玄参、丹皮、赤芍凉血散瘀，直清营血之热，佐桔梗、甘草、冬瓜仁、薏苡仁、芦根等安肺排脓之品，保肺金之化源而能奏功。据此，顽固高热顿挫，危笃重症转入坦途，续经调治而愈。^[5]

16. 赵尚久诊治经验

苇茎汤出自《千金方》，为专治肺痈而设。方由苇茎（芦根）、瓜瓣、薏苡仁、桃仁四药组成。具有清肺化痰、逐瘀排脓之效。肺脓疡（肺痈）中医辨证分初起、成痈、溃脓三个阶段，均可用苇茎汤治之。初起多兼外感风热，可用苇茎汤合银翘散；成痈热毒炽盛，苇茎汤加鱼腥草、黄连、黄芩等品，甚则合醒消丸；溃脓用苇茎汤合桔梗汤（桔梗、甘草），并视余毒多少及正气盛衰情况进行加减。

如治孙某，男，36岁。因咳嗽、吐腥臭痰伴发热半月，西医诊断为“肺脓疡”，经用青霉素、链霉素、四环素等抗生素治疗3月余，病情好转，已不发热，仅微咳、吐少量痰。停药不久，病情转剧，不规则发热，咳吐大量稠臭脓痰，咯血、气促，大便结，小便黄，苔黄腻，脉滑数。此痰热蕴肺，气血凝滞，酿成肺痈。治当清肺化痰，逐瘀排脓。以苇茎汤加水灯芯30g，鱼腥草30g，服30余剂，诸症悉退。后以麦门冬汤调理，病未再发。使用本方需注

意如下几点：①一定要有痰热互结，瘀血阻滞化脓的病理特征。②有咳吐稠痰脓血，胸中隐痛，口渴咽干，或咳吐痰涎，鼻流脓涕，面红带紫，舌赤、苔黄腻，脉滑数（或弦数）等临床表现。③本方药味分量（除桃仁外）宜重不宜轻。芦根、冬瓜仁可用至 60g，薏苡仁可用至 30g，桃仁一般 10~15g，小儿用量酌减。④病轻者，每日 1 剂，水煎分 2~3 次服；病重者，每日 2 剂，水煎分 4~6 次服。本方诸药皆清降滑利，慎用于孕妇。^[6]

17. 王少华诊治经验

秘红丹始见于《医学衷中参西录》，由大黄末、肉桂末、生赭石末组成。用以治肝郁多怒，胃郁气逆，致吐血、衄血及吐衄之证屡服他药不效者，无论因凉因热，服之皆有捷效。王氏用本方治疗肺痈，亦取得较好的疗效。

如治杨某，男，55 岁。水肿两载，作止无常。8 日前因气候炎热，汗出纳凉，风暑之气外袭，肺从内应，以致发热（ $T38.5^{\circ}\text{C}\sim39.6^{\circ}\text{C}$ ），有汗不解，不恶寒，咳嗽频作，痰厚，色黄多白少，右侧胸膈作痛，痛势渐增剧，痰中带红，渐至咯血盈口。诊见：痰吐花红，或脓多血少，或脓血参半，气味腥臭，呼吸不利，口渴，饮水不多。舌边尖偏红、苔白腻中心黄，脉沉数。证属风暑犯肺，风伤皮毛，暑热灼伤血脉所致肺痈。虽曾三投千金苇茎汤而不效，则治其常而不能治其变。其变在于此次病发 2 日余，面浮肢肿即起，五更泄泻又作，并少腹胀满小便短量少，色微黄而不赤。此乃上焦新热，触发中下焦沉寒积冷，于是太少二阴虚寒再现，气化不及州都故耳！若再专事清上，纵使有利于肺，难免有损于肾。拟清上温下，务使肺热得清，肾阳得温，膀胱气化得司，庶几各得其所。处方：大黄

6g, 金银花 30g, 野荞麦 30g, 牡丹皮 9g, 桔梗 9g, 生地 12g, 熟地黄 12g, 泽泻 9g, 茯苓 15g, 淮山药 12g, 淡附片 4.5g, 肉桂 3g。2 剂, 每日 1 剂。药后身热渐退 ($T37.9^{\circ}\text{C} \sim 38.5^{\circ}\text{C}$), 惟口反渴而欲饮, 咳嗽未已, 依然吐出花红, 气臭。浮肿已消过半, 大便仅一行, 质尚溏, 少腹胀满消, 小便量增多, 前方去淡附片加生薏苡仁 30g, 2 剂后体温降至 $37.2^{\circ}\text{C} \sim 37.8^{\circ}\text{C}$, 咳嗽吐脓血已减, 浮肿全消, 少腹无不适。方中先后还用甘草、连翘、南北沙参、白前、麦冬、太子参、白及等。共服药 22 剂, 肺痈痊愈, 水肿病亦趋稳定。

本例同患水肿、肺痈二疾, 前者为脾肾虚寒, 后者为肺脏实热, 因而用秘红丹之大黄以清在上之热, 肉桂以温在下之寒。本例始见吐纯血, 是热与血郁结, 血热妄行所致, 虽予千金苇茎汤终因病重药轻而罔效。故以大黄、金银花、野荞麦、牡丹皮、桔梗五味药组成方剂, 定名为大黄银荞汤, 治肺痈吐脓血, 投千金苇茎汤不效者, 每能奏功。本患素有水肿宿疾, 患肺痈 2 日即触发旧恙。往昔肿作, 均以金匱肾气奏功, 以药测证, 已可知为阴寒之气作祟, 于是又采用肾气丸增损, 借以温阳化气而获效。临证凡寒热错杂, 虚实互见的证候, 可用温凉补泻综合作用之方剂。

张锡纯创制秘红丹旨在“降胃平肝, 治肝郁多怒, 胃郁气逆”之吐衄, 王氏则用其泻火化瘀, 温阳祛寒, 用以治疗寒热虚实杂象纷呈之咯血症候。本方大黄与肉桂用量是 2:1, 若大黄用量大于上述比例, 则药性偏凉, 其功重在泻火化瘀, 适用于寒热错杂, 热重寒轻, 实甚于虚, 或实热真而虚寒假, 有格拒之证者。如肉桂用量大于上述比例, 则药性偏温, 重在温补命火, 引火归原, 同样适用于

寒热错杂，但寒重热轻，虚甚于实，或虚寒真而实热假之证。如肾水亏损，肾火上浮而失血时，则肉桂与大黄应用小剂量（或去大黄），以作引火归原之剂；并须配合滋水之剂，如六味地黄丸、二至丸等。本方中大黄、肉桂均具峻烈之性，使用时应严格掌握“无毒治病”，仅应“十去其九”的训诫。对于虚劳使用时更应小心。^[2]

18. 郝霭龄诊治经验

郝氏认为肺脓疡临床表现为发病急剧，突然恶寒高热，体温可达 39℃~40℃，伴有咳吐大量脓痰或脓血样痰或咯血，白细胞计数增高，葡萄球菌、链球菌、肺炎球菌常为本病的致病菌。本病相当于中医学的肺痈，历代医家早有关于肺痈的详尽描述。如张仲景《金匮要略》云：“蓄结痈脓，吐如米粥”，“时出浊唾腥臭”。明代陈实功《外科正宗》中云：“肺痈者，金受火刑之症也”。“咳吐脓痰，黄色腥秽……”。张锡纯在《医学衷中参西录》中说：“治肺中腐烂，浸成肺痈，时吐脓血，胸中隐隐作疼”。归纳起来肺痈以恶寒发热、咳吐黄痰或腥臭脓血为主证。郝氏认为本病是由于温热之邪遏于肺经不得宣化，肺经壅滞不畅，蕴毒成痈，或为外感风寒，郁久化热，蕴毒成痈。一般来说，病之初起，有一个表证阶段，即发热、恶寒、咳嗽、头痛、苔薄白、脉浮等，容易误诊为“上呼吸道感染”，经治疗病证不减者。也有病之初起，表证并不明显，而表现一派里热实证，如高热寒战、吐黄痰、口干嗜饮、大便秘结、小便短少等。这便是温热病中伏邪温病的表现，感受外邪，过时而发，热郁成毒，又兼新感，引动伏邪，因此病势较重。根据发病的不同阶段、不同症候辨证论治。如高热选用银翘散、白虎汤或清营汤，重则使用紫雪散。如咳吐黄

痰，常选用清热化痰药：瓜蒌、枳壳、射干、马兜铃、法半夏（或清半夏）、橘红、冬瓜子等。咳血可加黄芩炭、藕节、生地炭等。从病的初起至善后调理，郗氏十分强调滋阴清热的原则，不论是苦寒清热或甘寒滋阴，目的都是护阴。温热病由于发热、汗出，耗损阴液，尤其发展到后期，伤阴更重，护阴就更为重要。滋养阴液，益水制火，体温即可下降；阴虚便秘，使用增水行舟法可以润下；用滋阴制阳，益水制火而不是过用苦寒之品，损伤脾阳。常用滋阴药物：石斛、花粉、生地黄、玄参、麦冬、白芍等。在服法方面，病势较重者，一般采用每日2剂，4小时1次给药。药物剂量比常规用量大。体温在39℃以上者，生石膏用量30~60g，金银花用量25~30g，鲜芦根用量30~60g。^[8]

【按语】

朱良春治疗肺脓疡侧重清热解毒，化痰排脓，并极力推崇金荞麦，认为此药治肺脓疡有良效。魏长春治肺脓疡以宣肺豁痰为基本治法，其自订之加味桔梗苇茎汤用于肺脓疡治疗，每能应验。叶景华、贝叔英、王廷富等均分期辨治肺脓疡，各具特色。陶志达认为肺脓疡乃大热大毒之证，不能套用一般清热解毒常法处理，必须趁正气未衰之机，用势专力猛之药，速战速决，攻下泄热，使邪有出路，因此主张在清热解毒基础上加用大承气汤之类，或合用葶苈大枣泻肺汤之类，起釜底抽薪、攻下痰热作用。黄志强治疗肺脓疡主张清热解毒、化痰排脓双管齐下，据此法则自拟之消痈汤，临床屡试不爽。洪广祥治疗肺脓疡突出清热、排脓、化痰、扶正四法，其中清热贯穿治疗全过程。

（吴艳华）

参 考 文 献

- [1] 朱良春, 魏长春, 叶景华, 等. 肺结核证治. 中医杂志, 1987, 28 (7): 11~15
- [2] 姜润林, 王玉玲老中医治疗肺癰经验鳞爪. 黑龙江中医药, 1989, (2): 6
- [3] 何任. 漫话肺癰. 新中医, 1991, (11): 18
- [4] 汤淑良. 顾丕荣老中医临证经验选介. 江苏中医杂志, 1986, (10): 33
- [5] 王红华. 王德元治疗危重症经验. 江苏中医, 1989, 10 (3): 5
- [6] 贺又舜. 苇茎汤加减运用的临床经验. 江苏中医杂志, 1982, (5): 14
- [7] 王卫中. 王少华运用秘红丹临证经验. 辽宁中医杂志, 1989, 13 (4): 1
- [8] 郝云霞. 肺结核的治疗体会. 北京市老中医经验选编, 1980, 18

脓 胸

【概述】

脓胸即化脓性胸膜炎，系胸腔内有脓性渗液，多从邻近器官如肺、食管或腹部的感染蔓延而来。原发病变可能为肺炎、肺脓肿、肺结核、膈下脓肿等。急性起病者有明显毒性症状，如恶寒、高热持续不退、多汗、胸痛、咳嗽和脓痰。胸腔积脓多时，可有胸闷和气急。慢性脓胸多不发热，但贫血和消瘦明显。常伴有杵状指、趾。西医治疗原则为控制胸膜感染和消除脓腔，除全身应用抗生素外，反复胸腔穿刺抽脓，冲洗引流。中医认为脓胸由热毒引起，宜内外合治，清热解毒，祛瘀泻浊。

【名医经验】

1. 赵尚久诊治经验

赵氏曾用苇茎汤治疗外伤性脓胸 1 例，获效甚佳。

宁某，男，32 岁。患者就诊前 10 余天，因右侧胸部跌伤，感右胸剧痛，呼吸不利，当时伤处外敷草药并服止痛药片，其痛稍缓。不意 2~3 天后，突发高热（ $T41^{\circ}\text{C}$ ），咳嗽气急，吐黄稠痰，右胸刺痛胀满，X 线胸透检查发现右胸有积液，胸穿抽出脓液，诊断为“外伤性脓胸”。住院治

疗8天,高热有所减退($T39^{\circ}\text{C}$),余症基本同前。且食欲不振,口渴索饮,时时汗出,小便短黄,大便尚可,舌质红、苔黄厚,脉弦数。辨证属外伤瘀血凝胸,气滞痰阻,痰瘀互结,化火酿脓。处方:芦根60g,薏苡仁30g,桃仁10g,冬瓜仁20g,桔梗10g,浙贝母10g,金银花10g,甘草10g,田七粉3g(吞服)。服5剂热退,诸症均减,服至10剂时,病去大半。仍以上方化裁,略变动分量比例,续服5剂,诸症渐除。胸透复查:积液消失。

苇茎汤出自《千金方》,原为治肺痈而设,由苇茎(芦根)、瓜瓣、薏苡仁、桃仁四药组成。具有清肺化痰、逐瘀排脓之效,不但治肺痈有效,对于肺系因痰热蕴结所致其他病症也可用之,只要把握本方运用原则,灵活化裁,就能扩大运用范围,而不拘泥于肺痈。使用本方应注意要有痰热互结,瘀血阻滞化脓的病理特征。方中药量(除桃仁外)宜重不宜轻。芦根、冬瓜仁可用至60g,薏苡仁可用至30g,桃仁一般10~15g。病轻者,每日1剂,水煎分2~3次服;病重者,每日2剂,水煎分4~6次服。^[1]

2. 史济柱诊治经验

史氏幼承家学,擅长内外两科,学验俱丰。对骨关节结核及其他原因形成瘰管的治理颇有造诣,现将其治疗结核性脓胸形成瘰管的经验介绍如下。

①病因病机:结核性脓胸形成瘰管是全身性疾患在局部的表现。全身症状表现为羸瘦、低热、盗汗、纳呆等;局部则瘰口脓液淋漓,久不收敛。《内经》云:“邪之所凑,其气必虚”。史氏认为本病多因劳倦过度,七情内伤或禀赋不足,房事不节,肾气亏耗,正气不足,外邪乘虚内侵,留居于胸,日久化腐为脓,穿溃肌肤形成瘰管,迁延不愈

致气血耗损，正虚邪实。

②治疗方法：《素问·生气通天论》谓：“陷脉为痿，留连肉腠”。史氏认为痿管者形之于外，必根于内，治疗应以内外相辅，以内治为主，整体治疗须贯穿始终。《丹溪心法》“凡疮口不合，脓水清稀，气血俱虚也，非参芪归术之类不能补”。史氏谓：“无有气血旺盛之体，就不可能抵御邪毒之侵蚀”。并根据正虚邪实之病机，自拟扶正败毒汤随证应用。

扶正败毒汤：生黄芪 30g，全当归 15g，茯苓 10g，制黄精 30g，续断 15g，连翘 15g，生甘草 10g，葎草 30g，泽漆 30g。水煎服，每日 1 剂，若遇感冒发热则暂时停服。方中重用黄芪，因其为疡科要药，善治疮痍正气不足，久溃不敛，有较强的扶正生肌作用；当归养血活血；茯苓健脾淡渗利湿；黄精、续断滋养肝肾、补虚益精；连翘、甘草清热解毒；葎草、泽漆解毒化痰，共奏扶正败毒之功。现代医学证明，葎草、泽漆有抑制结核杆菌作用。

外治法：1) 化管条插入痿管内，表面以消毒纱布覆盖，每日更换 1 次（化管条药物组成：白降丹、红升丹等分，面糊成条，如火柴梗粗细，风干备用）。2) 若经以上方法治疗，全身情况改善，痿管脓液减少，则注入闭管膏，促使痿管闭合（闭管膏组成：乳香 10g，没药 10g，僵蚕 10g，蝉蜕 10g，白及 30g，儿茶 15g，煅龙骨 30g，象皮 10g，象牙屑 10g，蜂房 15g，血竭 30g，刺猬皮 15g，黄蜡 10g，麻油 1 000g。煎熬成稠厚液状，过滤去渣置于消毒容器内备用。具有活血化痰、解毒收敛、促使痿管分泌物吸收、加速新肉生长之功效）。使用时嘱患者平卧，用 50ml 注射器将闭管膏徐徐注入痿管内，以满溢为度，表面以消毒纱布覆盖，隔日 1 次，注前以生理盐水冲洗痿管。

③注意事项：1) 结核性脓胸形成之瘻管，较为深长。若患者全身症状尚未改善，脓水较多的情况下，切勿急于收口。此时若见瘻口缩小，或暂时闭合，乃为假象，倘若收口有反复外溃之可能应及时扩创剔除瘻口周围之腐肉，使脓毒排出畅通无阻。如患者全身症状好转，诸如低热、盗汗、纳呆等消除；血沉正常或接近正常；瘻口脓水基本消失，瘻口肉芽由苍白变为红润，并逐渐低陷成凹形，斯时乃收口之机。瘻口敛后尚须继续服扶正败毒汤 3~6 个月，以资巩固。2) 为避免瘻管内端未愈，而外端瘻管逐渐闭合，造成愈合假象，以致反复外溃，当全身情况好转、脓液逐渐减少、瘻口开始缩小时，须停用化管条，以直径为 0.2~0.3cm 之硅胶管，插入瘻管深处，直至不能向内推进为度，外端须盘曲并用胶布固定，覆盖消毒纱布。每日更换硅胶管 1 次（硅胶管须经高压消毒），直至脓液基本消除，乃注入闭管膏，促使愈合。3) 若瘻口愈合，日后复又外溃，应及时扩创使脓毒排出畅通，并作瘻管造影以探明深度，外治仍用化管条。

如治陈某某，男，59 岁，住院号 89913。患肺结核 20 余年，1980 年 7 月始低热缠绵，体温波动在 37.8℃~38.5℃之间，经治未效。至 1981 年 10 月右侧腹股沟出现鸡卵大肿块，某院予切开排脓后，脓液淋漓不尽，疮口不敛。自腹股沟疮口注入造影剂显示：向上延伸至胸腔第 11 肋间，长 25cm，宽 0.6~1cm。经利福平、雷米封等抗痨药治疗 5 月罔效。遂延史氏诊治。于 1982 年 6 月 23 日入院。体温 37.5℃，心率 86 次/分，心律齐，血压 120/80mmHg，右肺呼吸音降低，肝脾肋下未触及，右侧腹股沟有 1cm×1cm 大小瘻口。血红蛋白 89g/L；血白细胞 $5.9 \times 10^9/L$ ，N 0.72，L 0.28；ESR 115mm/1h；X 线胸

片示：右上肺萎缩，伴纤维钙化灶。形体羸瘦，面色无华，纳谷不振，神疲倦怠；脉细滑，舌质淡，苔薄腻，投扶正败毒汤加砂仁 3g（后下），水煎服，每日 1 剂。外用化管条，每日更换 1 次（化管条插入 10cm 深）。3 个月后，体温恢复正常，瘰管脓液显著减少，胃纳亦香，面色转润。上法治疗 4 个月后，瘰管脓液虽减未除，瘰口逐渐缩小，停用化管条，以直径为 0.3cm 之硅胶管插入瘰管深处，外端盘曲于瘰口旁，以胶布固定并覆盖消毒纱布，每日更换硅胶管 1 次，并用生理盐水清洗疮口。如此治疗 1 个月，局部脓液基本消除，硅胶管插入 10cm 不能再向内推进，体重较入院时增加 5kg 多，复查 ESR6mm/1h，血红蛋白 130g/L。乃注入闭管膏，隔日 1 次，约 2 个月瘰口愈合。共住院 10 个月，出院后继服扶正败毒汤 6 个月。随访 3 年，情况良好。

又如治沈某某，女，70 岁，住院号 91964。患者于 1982 年 10 月始，低热不退，1 月后右侧髂嵴上方腋前线处出现核桃大肿块，同年 12 月在某院切开排脓，疮口屡治不愈。遂求治于史氏，于 1983 年 12 月 26 日入院。体温 37.6℃，血压 120/70mmHg，右肺呼吸运动减弱，呼吸音降低，肝脾肋下未触及，右侧腋前线，髂嵴上方处可见 1.5cm×1.5cm 疮口，脓液淋漓。注入造影剂显示：右胸腔第 7 肋间至第 12 肋有 8cm×12cm 之脓腔。X 线胸片示：两上肺可见陈旧性结核钙化灶，右中下肺野可见一片密度均匀的阴影。血红蛋白 85g/L；血白细胞 $5.3 \times 10^9/L$ ，N 0.80，L 0.20；ESR 78mm/1h。形体消瘦，面容憔悴，神疲乏力；脉细，舌质偏红，苔薄腻。予扶正败毒汤加天冬 15g，麦冬 15g，水煎服，每日 1 剂；外用化管条插入疮口，每日更换 1 次（化管条插入 5cm 深）。治疗 6 个月，体温恢

复正常，纳谷渐振，精神转佳，局部脓液逐渐稀少。复注造影剂显示：右胸脓腔缩小至 $4\text{cm} \times 5\text{cm}$ 。上法继治 3 个月，脓液基本已净，复查 ESR $29\text{mm}/1\text{h}$ ，血红蛋白 115g/L 。乃注入闭管膏，隔日 1 次，连续治疗 3 个月，疮口愈合。共住院 12 个月，出院后继服扶正败毒汤半年。随访 2 年，一切良好。^[2]

【按语】

赵尚久用苇茎汤治疗脓胸，灵活化裁，取效较好。史济柱根据结核性脓胸形成瘰管的病机，自拟扶正败毒汤内服、闭管膏外用，对瘰管愈合有良效，值得临床参考。

(郭桃美)

参 考 文 献

- [1] 贺又舜. 苇茎汤加减运用的临床经验. 江苏中医杂志, 1982, (5): 14
- [2] 蔡金伟. 史济柱治疗结核性脓胸形成瘰管的经验. 中医杂志, 1987, 28 (9): 17~18

自发性气胸

【概述】

各种原因造成胸膜腔与外界相通，空气进入胸膜腔，引起胸膜腔内积气，统称气胸。自发性气胸常并发于肺或胸膜疾病，如慢性支气管炎、阻塞性肺气肿、肺心病、慢性纤维空洞型肺结核、弥漫性肺间质纤维化等。西医治疗自发性气胸取决于气胸的类型与肺受压的程度和症状，少量气胸无明显症状者，适当休息可自行吸收，多量气胸伴气急者，须抽气减压。中医认为自发性气胸与肺密切相关，治疗气胸离不开治肺，且应分清虚实，据证辨治。

【名医经验】

1. 邵长荣诊治经验

邵氏认为自发性气胸，虽然中医书籍没有这个病名，但论述有关类似的症状也不少。胸在上焦，内藏心肺，故气胸与肺有密切关系，因肺主气，以清降肃为顺，肺气上逆则为喘，无论何种因素导致喘息，均与肺有密切关系。故《内经·至真要大论》指出：“诸气贲郁，皆属于肺”。气胸的辨证首先应分清虚实。《景岳全书》指出：“实喘者有邪，邪气实也，虚喘者无邪，元气虚也”。突发性气胸起

病较急，来势较猛，而且多在剧烈的运动或其他诱因下突然发作，所以初起多属实证。而气胸反复发作，病程较长，来势缓慢，有时在无任何诱因下发病则往往因肺气虚损，以致肺泡薄弱，容易破裂，肺气不能肃降，气促而喘，反复发作后常成气阴两虚。因肺主气及皮毛，又与大肠相表里，肺气虚及肺阴不足则大肠传送无力，常出现大便秘结、自汗盗汗等症。邵氏根据“虚则补之”之理论，采用益气养阴法为主。药用大剂量黄芪及白术，可增强网状内皮系统的吞噬功能，促进细胞免疫功能。并配合黄精、太子参、玄参、五味子补肾润肺之品滋补而不腻。至于多次发作病例必要时加入丹参活血生血，莪术健脾通络，往往可以提高疗效。邵氏认为肺为上焦，比较娇嫩，易伤肺阴，所以在气胸吸收之后，还需服用生脉散、玉屏风散之类补益元气，养阴敛肺，有利于疾病的康复。人参 9g，五味子 4.5g，平地木 15g，功劳叶 15g，桑寄生 15g。每日 1 剂，水煎服。同时服用生脉饮，每次 1 支，每日 3 次。服药 1 周，胸闷气急明显好转，大便通畅，胸部透视复查左肺基本复张，左下积液吸收，继服上药，并随症加减。月后又感胸闷，胸透示左侧气胸复发，继服上方，加用养血生血之剂，加大黄芪量为 18g，莪术 12g，丹参 12g。此后在养阴基础上加入补肾纳气的狗脊、补骨脂、杜仲等药后，体重增加，全身情况良好，胸片复查恢复正常。随访数年左侧气胸未再复发。^[1]

2. 奚凤霖诊治经验

气胸的临床主要见症，颇似中医的“肺胀病”。《灵枢·胀论》指出：“肺胀者，虚满而喘咳。”其发病的原因，有外邪乘肺、咳喘损肺、创伤肺膜及用力努责等。临床治

疗，可按肺胀病的证候特点，分辨标本、虚实、寒热，遣方用药。

①单纯性气胸，治以辛开肃肺，理气降逆。

如治徐某，男，28岁，自18岁起先后突发暴喘胸痛，已5次，少则1天自愈，甚则3~5天才解，发病多在右侧，曾经X线胸透诊断为右侧自发性气胸。平时易于伤风。本次在工作时又突发右侧胸痛，气急不得卧，半天后未作处理，即渐减轻，仍有胸闷、咳嗽。体检：右胸略饱满，肋间隙无明显增宽，语震颤低弱；叩诊轻度回响增加；听诊右肺呼吸音低，两肺无干湿啰音，苔薄黄，脉浮滑，X线胸透示：右肺压缩50%左右，治以辛开肃肺，理气降逆。处方：紫苏10g，陈皮10g，大枣5个，陈酒2匙（分2次加入同煎），半夏10g，茯苓15g，桔梗5g，紫菀10g，杏仁10g，煅赭石30g。服药3剂，症状缓解，再服3剂后，X线复查右侧肺叶已张。嘱服玉屏风散（丸），每日10g，连服2月，调理巩固。

本例为单纯性气胸，平时易于伤风。肺司呼吸，皮毛为之合，肺气不足，外邪客于皮毛，则肺之窍道闭，闭则肺气壅塞损裂乃致呼吸不利，突发肺胀。此之症状尚属轻浅，故参《圣济总录》“治疗卒气喘，紫苏汤主之”，以辛开之法，配合祛痰、止咳降逆之品，药后即获缓解。本例多次发病，乃因肺脾虚，卫外不固，故以玉屏风丸益气固卫善后。随访年余，伤风减少，气胸未发。

②咳喘诱发气胸，首以补肺养阴，清肃平喘。

如治韦某，男，75岁，慢支伴肺气肿10余年，入冬感寒易发。4天前因感冒咳喘，不得卧，胸闷心悸，经治疗好转。昨夜突然剧咳胸痛，呼吸极度困难，焦躁不安。X线摄片：右侧气胸，肺压缩50%。体检：体温36.5℃，呼

吸 28 次/分，脉搏 120 次/分，BP28/17.3kPa。端坐位，呼吸急促，颈脉充盈，唇甲发绀，胸廓呈桶状，肋间隙增宽，心尖搏动向左扩展。右胸叩诊回响鼓音，语震颤消失；听诊两肺散在呼吸哮鸣音。舌红苔白，脉滑数。诊断：慢支伴肺气肿，肺部感染，右侧气胸。经胸腔闭塞引流，并抽气 2 次。1 周后症状稍有减轻，颈脖间皮下气肿明显，口舌干燥而红，中医治用补肺养阴，清肃平喘。处方：野百合 15g，生地黄 15g，玄参 15g，贝母 15g，桔梗 5g，甘草 5g，白前 10g，南沙参 10g，北沙参 10g，瓜蒌 20g，海浮石 30g，蛤壳 30g，鱼腥草 30g。服药 7 剂，咳喘渐平，颈脖皮下气肿消失。经 X 线复查：右侧气胸大部分吸收。续守原意，再加补肺纳肾。上方去桔梗、甘草、白前、瓜蒌、海浮石、蛤壳、鱼腥草，加熟地黄 15g，太子参 15g，五味子 5g，杏仁 10g，紫菀 10g，紫石英 30g，坎脐 1 条。续服 2 周，病情稳定好转，活动仍喘息短气，舌质淡红、苔薄，脉滑。脉率 88 次/分，BP17.3/9.3kPa。X 线胸片复查：右侧气胸吸收。原方略作增损，又服 2 周，气胸治愈。

本例宿疾再加外感，痰饮阻肺，肺络失和，外邪侵肺，宣肃失司，更因咳喘之甚，肺膜损伤，气入胸腔，肺气壅塞，因而加重肺胀喘咳。中西两法合并治疗 1 周，病情未见大减。口舌干燥而红，阴伤太甚，肺气亦虚，转用补肺养阴、清气平喘，百合固金汤主之，1 周后咳喘大平，活动仍喘息短气。此老年久病，肺肾气阴两虚，清肃摄纳无权，继以百合固金汤加固肺纳肾，续服 2 周病情缓解，气胸吸收。后守方以资巩固。

③ 肺心病并气胸，治用温阳化饮，益气敛肺。

如治黄某，男，57 岁。肺心病已多年，每冬发病，咳喘多痰，平时活动短气、呼吸少气。此次发病已 4 月。2 天

前右手抬高取物，突感右胸肋剧痛，气急窒息感，干咳痰少，恐惧感，急诊入院。X线胸片示：右侧气胸，右肺压缩约20%；心电图：窦性心律，肺型P波，右心室肥大。体检：体温36.4℃，呼吸28次/分，脉搏108次/分，BP18.7/13.3kPa。神清，焦虑烦躁，端坐呼吸，目胀突，颈脉动，唇甲绀，桶状胸，肋间隙增宽，气管稍向左移，心尖搏动在剑下。右胸叩诊呈过清音，听诊右肺下侧呼吸音低弱，两肺散在干湿啰音。舌质淡紫、边有齿痕、苔薄白，脉虚滑数。诊断：肺心病，右侧气胸。胸腔穿刺排气，2次共550ml，心率增快至120次/分以上，后停止抽气。中药以温阳化饮，益气敛肺。处方：茯苓30g，桂枝10g，白术15g，甘草5g，党参15g，五味子5g，麦冬10g，紫菀10g，杏仁10g，沉香3g，坎脐1条，半硫丸3g（吞服）。服药5剂，同时给抗生素、解痉剂并吸氧，症状大减，已能高枕而卧，唯仍感短气、少气。仍以原方去半硫丸、紫菀、沉香，加补骨脂15g、肉苁蓉10g，再服1周，共住院半月，好转出院。出院休息70余天，突发胸闷，左侧胸痛，气急不得卧，又急诊入院，X线胸片：左侧气胸压缩15%，血象增高。仍予中西药治疗。中药以苓桂术甘汤合皱肺丸化裁，加服黑锡丹3g，先服3剂，继又服5剂，咳嗽胸痛得除，X线摄片：左侧气胸已吸收，续以皱肺丸方出院调理。

本例肺胀，先有宿恙，肺肾久虚，肃降摄纳无权，素多痰饮，饮邪阻肺，气道涩滞，咳喘多痰，短气少气，近因过分努力，骤伤肺络，肺膜破损而致胸痛暴喘，虽然右肺压缩仅有10%~20%，由于新病旧恙交并，故发病更加急骤而重。用温阳化饮、益肺纳肾之苓桂术甘汤合皱肺丸标本同治。

④哮喘诱发气胸，治以益气养阴，固肺护膜。

如治薛某，男，44岁。哮喘史40年，间歇发作，近日感右侧胸痛胸闷，气急，咳嗽，1旬后更感咳嗽痛甚，活动作喘，胸透：右肺压缩70%。诊断为自发性气胸而收入住院。X线胸部摄片示：右肺压缩90%左右。体检：消瘦面黄，端坐呼吸，右胸廓饱满，肋间隙增宽，气管向左偏移，右侧语颤消失，呼吸音低微，叩诊呈过响清音。先后经9次胸腔穿刺抽气，右肺压缩部分仍不张，继又胸腔切开，水封并闭塞引流10天，后加用负压吸引又9天，均无效。诊见：右侧胸痛，气急，倚息而卧，胸闷，焦虑，咳嗽咯痰不利，语言气怯，呼吸少气，舌淡红、苔薄，脉虚软数。一派肺虚气阴两伤之证，治以益气养阴，固肺护膜。处方：阿胶10g，鼠粘子10g，甘草5g，杏仁10g，糯米1撮，党参15g，炙黄芪15g，熟地黄15g，天冬10g，麦冬10g，五味子5g，炙紫菀10g。并随证酌情选用下列药物：肉苁蓉10g，沙参10g，玉竹15g，山药15g，牡蛎30g，茯苓15g，陈皮5g。另服补肺护膜之白及末5g，象贝末3g。上方服20剂后，症状、体征逐步好转，精神、食欲稍振。胸透提示：右肺压缩已由90%减至60%；再服1周，复查右肺压缩减至30%，症状消失，开始下床活动。停药白及、象贝药末，汤药如上，续治2周，X线胸部摄片：右肺压缩约15%；再1周胸片示右侧肺叶已张。前方连服2月，气胸治愈出院。

本例哮喘多年，肺气已虚，平时嗜烟成癖，烟辛灼肺，气阴俱耗。当肺系受损，肺膜破裂，气溢胸腔，则发肺胀，肺胀则肺管不利而气道涩滞，故咳逆上气，肺络不和则胸痛、胸闷。治以补肺阿胶汤合《永类铃方》之补肺汤，并以白及、象贝药末，参合应用，以参、芪、草大补肺气；

地、冬、阿胶补养阴血；杏仁、紫菀、五味子、鼠粘子止咳化痰。经治疗后肺叶已张，痊愈出院。随访2年多，气胸与哮喘未再复发。^[2]

【按语】

邵长荣认为气胸与肺密切相关，其辨证首先要分清虚实，对于反复发作作者以益气养阴法为主，药用大剂量黄芪与白术，其经验可资借鉴。奚凤霖诊治气胸主张首要分辨标本、虚实、寒热，方可遣方用药，单纯性气胸治以辛开肃肺，理气降逆；哮喘诱发气胸治以补肺养阴，清肃平喘；肺心病并发气胸治以温阳化饮，益气敛肺；哮喘诱发气胸治以益气养阴，固肺护膜。对肺病治疗有提纲挈领作用。

（郭桃美）

参 考 文 献

- [1] 唐忆星. 邵长荣老师治疗呼吸系统疑难病案四则. 黑龙江中医药, 1997, (5): 21
- [2] 奚凤霖. “气胸”从“肺胀”论治的临床经验. 江苏中医杂志, 1984, (6): 22

矽肺

【概述】

矽肺是长期吸入含有较高浓度游离二氧化硅粉尘（简称矽尘）空气引起的肺弥漫胶原结节性病变，是一种严重的职业病。发病缓慢，早期无症状，随着病变进展，可有气急、胸闷、胸痛、咳嗽和咳痰。部分病人可有食欲不振、消瘦、疲乏无力、头昏、头痛、失眠、心悸等症状。常易并发肺结核。晚期并发肺心病、心力衰竭、呼吸功能不全等。矽肺目前尚缺乏理想的治疗，预防是防治矽肺的首要任务。该病中医文献尚未见有系统的论述，认为是石末伤肺所致。矽尘属金石一类，金石燥烈，耗伤肺津，肺气受损，肃降失常，呼吸不利，因而咳嗽、气短、胸闷；久咳伤气，气阴亏损可形成虚喘；此外，石末停积肺内，气血运行不畅，导致气滞血瘀，而见胸膈疼痛。肺虚之后，外邪容易侵入，痰湿逗留，常出现痰瘀凝滞的证候。临床常分肺失清肃、痰瘀凝滞、气阴两亏等型辨治，有一定疗效。

【名医经验】

1. 邵长荣诊治经验

邵氏根据观察到的矽肺患者，不仅有咳嗽、气急、痰

多或痰血、胸闷、胸痛等肺部症状，还经常有头晕神疲、心悸失眠、潮热盗汗、或腰膝酸软、畏寒肢冷等全身性虚弱症状的临床表现特点，认为当属中医肺痿、咳喘、虚劳等病证范围。矽尘属金石燥烈之邪，而肺乃喜润恶燥之脏，矽尘沉结于肺，可郁而化热，燥热炼津为痰，壅塞肺管，痰壅气滞，血行不畅，则血瘀顽痰凝结，致肺失清肃之令；若迁延日久，燥热、痰瘀必耗气伤阴，致肺的气阴俱伤，甚而可引及其他脏器。

在 50 年代末，邵氏便和其师友们以“益气养阴、软坚化痰、祛瘀通络”为原则治疗矽肺。曾对 48 例患者进行了临床治疗和观察，依据有无气阴两虚的全身症状，将患者分成两组，分别在症状、胸片和肺功能三个项目上作治疗前后对照。第一组为气阴两虚症状较明显者，治疗原则以补肺养阴，软坚散结为主，兼以止咳化痰，降气平喘。选用“矽肺一号方”（黄芪、玄参、麦冬、当归、夏枯草、海藻、昆布、丹参、山慈菇、郁金、百部、海蛤壳）或“矽肺二号方”（黄芪、南沙参、北沙参、麦冬、百合、百部、当归、牡蛎、海藻、海浮石、夏枯草、郁金、山慈菇、紫菀、玄胡、金沸草、橘皮、海蛤壳）；第二组为无明显气阴两虚症状者，治疗原则较第一组则更为精简用药偏重于软坚散结，以自拟的“矽肺煎”（南沙参、北沙参、海藻、山慈菇、夏枯草、海浮石、当归须、黄玉金、海蛤壳、蜂蜜）和用纯鸡内金制成的“鸡金片”为主，予以治疗。结果显示：两组病例症状好转显著，除全身症状消失较快外，肺的局部症状平均在 20~40 天内消失和减轻；胸片复查，两组均有 7 例矽结节周围阴影及网状阴影吸收好转现象，但是，两组均未见有矽结节消失情况；肺功能方面，第一组有效率为 85%，第二组有效率为 87.5%。从而初步得出中

医中药对矽肺患者症状和功能的改善更为有效的结论。

随着对矽肺的深入研究，邵氏逐渐发现许多矽肺患者，不仅有气阴两虚的症状，同时还兼有肾虚的症状。曾对 300 余例矽肺患者用中医辨证筛选，发现符合肾虚兼证的有 67 例，比例超过矽肺病例的 20%。于是在七八十年代，他对这类病人进行了重点研究。发现有肾阳虚、肾阴虚和阴阳两虚，而往往以肾阳虚尤为多见。治疗一般给予保肺片（补骨脂、续断、当归、胡桃肉、熟地、甘草、菟丝子、覆盆子、女贞子），偏肾阳虚的还可补肾健肺糖浆（仙灵脾、黄精、女贞子、狗脊、桑寄生、海浮石、川楝子、陈皮），偏肾阴虚的可用杞菊地黄片（生地、女贞子、淮山药、赤芍、茯苓、泽泻、桑椹子、白菊花），3 个月后，肾虚症状便有不同程度的好转。

除了补气养阴、软坚散结和补肾法外，邵氏还以活血化瘀作为治疗矽肺的基本法则之一。这是因为在矽肺的发病过程中，尚有一个重要的环节，就是一部分吞噬有矽尘的细胞可堆集在支气管、血管分叉的微小淋巴组织内，并充塞淋巴管，使淋巴管流通受阻，导致肺门淋巴管淤塞，淋巴结肿大。此外，矽肺的弥漫性纤维化、肉芽肿等病理改变均可减少肺内毛细血管床，增加肺循环的阻力，使气体交换不足，造成机体慢性缺氧，导致心血管功能的障碍，从而出现了外周微循环的变化。活血化瘀的药物，邵氏常用丹参、赤芍、当归、桃仁、红花、三棱、莪术等，以改善血液循环，疏通脉管，促进病情好转。

遗憾的是，多年的临床研究结果表明中医中药虽能很好地缓解矽肺病人的临床症状，但是对矽结节的改善却不理想，仅有少数患者有好转现象。所以近 10 年来邵氏认为中医中药治疗可以将阻止或延缓矽肺的自然发展，增强病

人体质,积极及早地控制矽肺的合并症,达到减轻患者的痛苦、延长患者的寿命为主攻目标。尤其是现在随着经济建设的高速发展,生产环境和防护措施的不断改善,再加上劳动者自我保健意识的提高,使矽肺的发病率日益减少,目前临床能接触到的也往往是已患病几十年的Ⅱ、Ⅲ期矽肺病人,患者大多存在着多脏器的损害,所以提高生命质量对他们尤为重要。根据积累的临床经验,邵氏指出矽肺乃“本虚标实”之证,随着病程的迁延,虚象会愈来愈明显,而且虚证的加重还会使标实之假象更显著。补虚,邵氏以辨证论治为主,但侧重于肺、脾、肾三脏。因为肺为气之主、脾为气之源、肾为气之根;肺与肾同主呼吸。“肺主出气,肾主纳气”;而脾与肺母子相生;所以肺病最易损及脾肾。

如洽谈某某,男,72岁,1995年9月15日初诊。曾为轧石工12年,1973年诊断为Ⅰ期矽肺,1990年诊断为Ⅲ期矽肺。患者20余年来反复咳嗽、咯痰、胸闷、气促,偶感胸部针刺样疼痛。近3年来胸闷气促逐年加重,动则更甚,生活不能自理,在职疗所诊断为Ⅲ期矽肺、肺气肿、肺大泡,呼吸困难3~4级。肺功能测定:中度混合型通气功能障碍、中—重度阻塞性肺气肿、慢性低氧血症。劳动力完全丧失,伤残分级为贰级。自诉:气促,动则益甚,咳嗽,咯吐白痰,伴胸闷乏力,心慌,失眠,口干少饮,怕冷明显,经常头晕,视物不清,耳鸣腰酸,尿频,下肢时有浮肿,纳呆,大便少,1~2天1次。检查:神清形瘦,面色苍白,口唇轻度紫绀,颈静脉轻度充盈,气管左偏,桶状胸,叩诊过轻音,听诊两肺呼吸音低,两肺底闻及少量细湿啰音。心率90次/分,律不齐,心尖区和肺动脉闻及SMⅡ级,腹平软,肝脾未及,两肾区无叩痛。舌质暗

红,舌苔薄腻,脉细。辨证为肺脾气虚,心肾阳虚,治宜温肾补肺,健脾养心。药用:淡附子 9g,白术 15g,薏苡仁 9g,茯苓 12g,茯神 12g,杜仲 12g,桑寄生 12g,海浮石 15g,姜半夏 9g,淮小麦 30g,炒枣仁 12g,谷芽 15g,麦芽 15g。服方 1 月后,咳痰减少,怕冷、心慌明显好转,胃纳有增,但气促仍甚,下肢浮肿。原方加补骨脂 12g,桂枝 9g,陈葫芦 30g,车前草 12g。2 周后浮肿消失,气促减轻。继续服用 1 月后,适逢冬至,改用膏方:黄芪 150g,炒白术 150g,防风 100g,太子参 150g,茯苓 150g,女贞子 120g,仙灵脾 120g,肉苁蓉 120g,杜仲 120g,青皮 120g,陈皮 120g,桑寄生 120g,桑椹子 120g,薏苡仁 180g,生晒参 100g,冰糖 200g,饴糖 300g,鹿角胶 200g,阿胶 200g,熬制膏药 500g,每日 2 次,每次 2 匙服用。3 个月后诉冬季气促无明显加重,精神有振,无感冒,怕冷、心慌基本缓解,腰酸、耳鸣、尿频、肢肿减轻,纳可便调。随访 1 年症状基本稳定。

综上所述,邵氏治疗矽肺的思路和方法,是他脚踏实地地长期临床探索的结晶。他以中西医结合的思维,客观地认清中医中药治疗矽肺的优势点,扬长避短,为许多矽肺患者提高了生活质量,并且延长了寿命。^[1]

2. 朱良春诊治经验

中医虽无矽肺之名,但在唐代就有“石癆”、“石工肺癆”之病名,宋代孔平仲《孔氏谈苑》更有“贾谷山采石人,末石伤肺,肺焦多死”的记载,明确指出矽肺的发生与职业和粉尘伤肺有关,并指出了它的慢性病程和严重预后。在病机方面,由于病灶在肺,而肺主气,司呼吸,倘粉尘沉积肺络,必将阻滞气机而影响肺之肃降功能,呼吸

为之不利，出现咳呛、胸闷、气短的症状。若矽尘沉积不去，肺之气阴亏虚，则化热灼津为痰，甚则损伤肺络，致痰中带血；而痰壅气滞，必将引起血瘀，痰瘀痹阻肺脉，胸部刺痛可随之出现。归纳矽肺的病机，一是正虚，一是邪实。治疗上宜攻补兼顾，扶正以固本，祛邪而攻病。从辨证与辨病相结合的角度，治宜补益气阴、调理肺脾以扶正固本、化痰散瘀、软坚消积而祛邪攻病，用自拟“止咳化矽糖浆”，配合“抗矽 14”治疗矽肺。止咳化矽糖浆是由党参、北沙参、百合、白及、夜交藤、金荞麦、白花蛇舌草、金钱草、合欢皮、石韦、甘草等 11 味药物组成，熬制为糖浆，每次服 30~50ml，每日 2 次，配合“抗矽 14”，0.5g/周，连服 4 月为 1 疗程。曾治疗 14 例矽肺病患者，服用上药后，胸闷、气急症状改善，神疲好转，食欲较香，体重略增，特别是血清血蓝蛋白有显著下降，而血蓝蛋白在矽肺病人肺内矽结节由纤维蛋白转化成胶原时起着重大作用，因此血蓝蛋白的含量可以反映出肺部纤维化的程度，随着矽肺病情增重，肺部纤维化也愈严重，血清血蓝蛋白的含量也就增高。因此，服用本方能延缓肺部纤维化，对治疗矽肺有一定的疗效。^[2]

【按语】

邵长荣治疗矽肺除了补气养阴、软坚散结和补肾法外，还以活血化痰作为治疗矽肺的基本法则，以改善血液循环，疏通脉管，促进病情好转。朱良春治疗矽肺，以补气养阴、调理肺脾、化痰散瘀、软坚消积为法，所拟“止咳化矽糖浆”能延缓矽肺患者肺部纤维化，对治疗矽肺有一定效果，值得参考。

(吴艳华)

参 考 文 献

- [1] 施红, 张颖. 邵长荣教授治疗矽肺的经验. 天津中医学院学报, 1999, 18 (6): 33
- [2] 朱良春. “止咳化痰糖浆”配合“抗矽 14”治疗矽肺的疗效观察. 江苏中医杂志, 1981, (5): 22

肺部囊状疾病

【概述】

肺部囊状疾病就其临床表现而言，多属中医学咳血、肺癰、肺积范畴。肺部囊状病灶大多呈包裹性，反复感染，周围结缔组织破坏，血供不良，使用抗生素往往效果不显，而且滥用抗生素，导致耐药菌株形成，甚至菌群紊乱、变异，治疗有一定难度。用中医药辨治有一定效果。

【名医经验】

邵长荣诊治经验

邵氏以清气化痰法治疗肺部囊状疾病，取得较好的疗效。

①清气止血：肺为娇脏，喜润恶燥，邪气外袭，首侵肺卫；痰瘀蕴于肺，肺气宣肃失司，化火化气，伤及肺络，治当清肺气而止血。如治朱某，男，60岁。因受寒而咳嗽，发热，咯出鲜血数口，X线胸部摄片提示右中下叶肺囊肿，经服用抗生素及化痰药治疗1个月后，体温正常，但仍咳嗽咳血。复查胸片：右中下叶有一直径4.5cm左右圆形阴影，伴有液平面。诊见：咳嗽，咯痰，量少色白，痰中带血，有时满口鲜血，伴有轻度气急，胃纳不佳。舌

红苔黄腻，脉弦。邵氏认为此乃外邪袭肺，肺气郁于胸中，痰湿内壅，闭塞不通，痰蕴日久，化热伤阴，肺络受损。治以清肺气，佐以化痰湿。药用鹿衔草、黄芩、鱼腥草、连翘等为主药清宣肺气；佐以石菖蒲、柴胡、前胡行气化痰；玄参、芦根养阴生津润肺；茜草根、白茅根清肺止血。恢复期佐以活血化痰之品，巩固疗效。病愈期则加重养阴活血之品。随症治疗后诸症悉除，复查X线胸片示肺囊肿明显缩小，直径3.2cm，无液平。

②化痰湿、祛邪气：本病的发作，内因痰浊壅阻于肺致肺气不宣，外因感受六淫之邪，引动内伏之痰浊，外邪与痰浊胶结而成。治当化痰湿，祛邪气。曾治一男患者瞿某，46岁，反复咳嗽、咯痰5~6年，本次加剧，甚则咳血，经X线胸片检查提示为支气管扩张、左下肺呈蜂窝状改变，伴有数个大小不等的囊状病变。因麻醉时出现过敏性休克而未行手术。诊见：咳嗽阵发，痰多色白，咳嗽剧烈时则有鲜血咯出，胸闷，乏力，口干，舌淡、苔白腻，脉滑数。邵氏认为本患者因咳嗽数年，致病邪内伏，痰饮聚肺，肺气不宣，痰郁化热化火，损伤肺阴，络损血溢脉外，痰饮邪盛，金木不和，肝气受郁，失其调达，更易受外邪侵袭，外邪与痰湿互结，以痰浊壅肺为病理基础，外邪引发是诱因，外邪与痰浊互结恋于肺，则病程缠绵。治疗上以祛痰湿为主，佐以清肺气，药用苍术、白术、猪苓、茯苓、薏苡仁、石菖蒲为主化痰祛湿；以黄芩、半边莲、鱼腥草清肺气；柴胡、前胡宣通肺气。至病情好转后，稍减化痰湿之品，加生地黄、沙参以润肺养阴生津，以防化痰之品过甚而劫阴伤津。经复查X线片示左下肺病灶明显吸收，囊状病变明显缩小。随访半年病情稳定。

由于肺囊肿病程较长，反复发作，易继发感染，大量

抗生素的使用对肺囊肿囊壁外的炎症浸润易吸收,而对肺囊肿内炎症不易消除,临床上易误诊为结核球、肿瘤等。邵氏从局部辨病着手,综合整体辨证施治。在治疗上以清肺气、化痰湿为治疗原则,并根据疾病不同阶段,佐以活血化瘀、养阴生津之品,以增强和巩固疗效。邵氏认为大多数清气化痰之品具有抗炎、抗感染作用,且不易耐药,同时还有修复炎症病灶、拮抗非特异性炎症作用,从而起到较好的止咳、化痰、止血之效。疾病稳定时给予活血化瘀、养阴生津之品,有改善病灶微循环、提高机体免疫功能之效。^[1]

【按语】

对于肺部囊状疾病的治疗,邵氏从局部辨病着手,综合整体辨证施治。治疗主张以清肺气、化痰湿为主,并根据疾病的不同阶段,佐以活血化瘀、养阴生津之品。其辨治经验值得借鉴。

(吴艳华)

参考文献

- [1] 张惠勇. 邵长荣治疗肺部囊状疾病的经验. 辽宁中医杂志, 1997, 24 (1): 9

肺性脑病

【名医经验】

王德元诊治经验

王氏治疗肺性脑病富有经验。

如治吴某，男，56岁。咳喘宿恙10余载，半月前秋行冬令，气候骤寒，宿恙暴发，始则形寒发热，咳喘气急，引胸作痛，咯痰粘稠难出。某医院诊断为慢性支气管炎、肺气肿伴感染，经吸氧、输液及抗生素，口服镇咳化痰药等治疗，症情稍缓。近2日来病情突变，高热不退，神志模糊，进而诊断为肺性脑病。会诊时，患者汗出发热不退（ $T38.7^{\circ}\text{C}$ ），咳喘气急，喉中痰鸣漉漉，张口抬肩，倚息不能平卧，口唇紫绀，两目半掩，嗜睡，喃喃呓语，呼之则两目睁开，询之则答非所问，精神委顿，舌质紫郁、苔薄黄中腻焦黑，脉细数无力。此乃肺阴素虚，痰热内蕴，感寒化火，上蒙脑窍，心灵失用所致。拟廓肺化痰，清开脑窍法。处方：石菖蒲10g，郁金10g，茯苓10g，半夏10g，炙远志6g，竹沥60g（2次冲），生姜汁6滴（2次冲），牛黄至宝丹1粒（2次化服）。1剂药后热渐退，谵语止，喘促痰鸣减轻，已能平卧，神志稍清，体温降至 37.4°C ，焦黑腻苔启化、舌质转红，脉细数转有神。此乃痰热蠲化，清窍渐开，肺肃之令渐行。药已中的，效不更方。原方竹

沥减半，加北沙参 20g，麦冬 10g。再 5 剂后，咳喘渐平，咽干，腻苔已化，舌前偏红，纳谷不馨。原方去菖蒲、郁金、竹沥、姜汁、牛黄至宝丹，加山药、玄参、炙蒺藜、炒谷芽、鱼腥草、金银花等益肺养阴，调中运脾，肃清余邪之品，调理月余，诸恙遂平出院。^[1]

【按语】

本例患者，素体阴亏，痰热蕴肺，感受骤寒，失于宣散，化火酿痰，堵闭机窍，心用失宜。王氏认为：以竹沥、半夏、茯苓可廓清肺中痰火，利气道而保肺，稍佐姜汁辛开以助竹沥豁痰之力；用菖蒲、远志、郁金可化机窍之痰浊，开心窍而醒脑；更用牛黄至宝丹芳香醒脑、驱痰清热而苏神，叶天士曾谓：至宝丹“通其神明之窍，以驱热痰之结”，故能一鼓而荡平肺家痰热，使患者高热得挫，神志回苏，咳喘平复。

(吴肇添)

参考文献

- [1] 王红华. 王德元治疗危重症经验. 江苏中医, 1989, 10 (3): 5

方剂(药)篇

流行性感冒

1. 葛根退热饮 (杨济平)

组成：生石膏 20~30g，葛根 10~15g，淡竹叶 10g，白茅根 10g，连翘 10g，钩藤 10g，甘草 3g。

用法：每日 1 剂，水煎频频冷饮服。

功效：透邪退热。

主治：流行性感冒。症见发热汗出，烦躁口渴，舌干、苔薄黄，脉洪大或滑数者。

加减：无汗加薄荷、荆芥；咳嗽加苦杏仁、枇杷叶；体痛加秦艽；头痛加龙胆草；喉咙痛加山豆根；牙痛加山梔根；便秘加番泻叶；抽搐加地龙、羚羊角；病久伤阴加沙参、麦冬；夜热加青蒿、白薇。^[1]

2. 梅翁汤 (刘瑞霖)

组成：岗梅根 30g，生石膏 30g，金银花 15g，连翘 15g，鱼腥草 12g，水翁花 9g，倒扣草 9g，贯众 9g，野菊花 9g，三桠苦 9g。

用法：每日1剂，水煎服。高热者每日服2剂。

功效：疏风清热解毒，利咽消肿散结。

主治：流行性感、急性咽喉炎、急性扁桃体炎等。

方解：刘氏治疗急性外感热病，不泥于轻宣肺卫之桑菊、银翘辈，主张清不宜迟，强调在邪气盛、正气未虚之际，重用清热解毒药直折病势，保存阴津，使邪去正安。并喜用草药，方中生石膏清阳明气分邪热，水翁花为广东草药，苦寒气香，功能清热解暑消滞，配岗梅根、金银花、连翘、野菊花、三桠苦、鱼腥草、贯众等疏风清热解毒、利咽消肿散结。全方祛邪而不伤正，热退而不伤阴，老幼适宜。

加减：咽喉红肿、咳嗽痰黄者，加玄参、桑白皮、芦根；发热多日不退者，加羚羊角尖1.5g。^[2]

3. 特效感冒宁（宋健民）

组成：苏叶10g，薄荷10g，藿香10g，防风10g，荆芥10g，金银花12g，苍术10g，黄芪10g，甘草3g。

用法：每日1剂，水煎2次，第1次用清水约200ml，浸药30分钟时，煎取100ml左右。第2次用水约120ml，煎取80ml左右，去渣。2次药汁混合后，分3次，早、午、晚温服。一般3剂即愈，重证可继服3剂。小儿用量酌减。

功效：解邪固表。

主治：感冒时邪，鼻流清涕，咽痛，咳嗽或伴见恶心、大便稀，或有发热恶寒，舌苔白薄或微黄腻，脉多浮缓。

方解：本方乃取“九味羌活汤”的方义而组成，九味羌活汤是按六经而用药，本方是依六淫（风、寒、暑、湿、燥、火）外邪而立方。感冒虽系小病，治不如法，外邪郁

而不散，常常反复发作，遗留后患。风为外邪之首。故先用防风、荆芥以祛风；再用苏叶以散风寒；薄荷以解风热；藿香以化湿邪；金银花以清暑火；甘草润燥而和诸药；黄芩以固表，使邪去不复发也。

加减：咽喉痛者，加桔梗 10g，僵蚕 6g；咳嗽痰多稠者，加浙贝母 10g；清稀者加半夏 6g，陈皮 9g；头痛者加白芷 9g，川芎 9g；夏季感冒，恶寒无汗加香薷 6g；口渴汗出，小便短赤者，加滑石 15g，石膏 20g，荷叶 10g。^[3]

(肖达民)

参 考 文 献

- [1] 杨宗仰. 名老中医杨济平学术经验简介. 新中医, 1988, 20 (1): 13
- [2] 何伟. 名老中医刘瑞霖临证经验简介. 新中医, 1988, 20 (3): 7
- [3] 李宝顺. 名医名方录. 北京: 中医古籍出版社, 1991. 358

咳 嗽

1. 桑杏汤（沈仲圭）

组成：桑叶 6g，浙贝母 6g，杏仁 9g，沙参 9g，淡豆豉 9g，栀子 4.5g，梨皮 12g。

用法：每日 1 剂，水煎服。

功效：辛凉疏邪，甘润养肺。

主治：咳嗽。证属肺经感受燥气，干咳无痰。

方解：本方以轻清疏透为主，佐以润养，符合“上焦如羽，非轻不举”的治则。药用桑叶、杏仁、浙贝母、栀子疏风清热，肃肺利膈；沙参、梨皮甘寒润燥，养肺生津；淡豆豉解表除烦。共奏辛凉疏邪，甘润养肺之功。^[1]

2. 清宣肺经汤（沈仲圭）

组成：桑叶 6g，牛蒡子 6g，川贝母 6g，杏仁 6g，马兜铃 4.5g，瓜蒌皮 9g，桔梗 3g，枇杷叶（去毛）3 片。

用法：每日 1 剂，水煎服。

功效：清宣肺经。

主治：咳嗽。证属外邪初解，肺热尚盛，咳嗽痰紧，或干咳痰少。

方解：本方以轻清疏透为主，合入宣达之品。药用桑叶、牛蒡子、桔梗、枇杷叶宣肺豁痰；杏仁、马兜铃、川贝母清热肃肺；瓜蒌皮宽畅胸膈，利气宣痹。^[1]

3. 辛润理肺汤（丁光迪）

组成：带节麻黄 4g，带皮杏仁（去尖）10g，炙甘草 6g，桔梗 5g，佛耳草（包）10g，橘红 5g，当归 10g，炮姜 4g，生姜 1 片。

用法：用适量水将药浸泡 30 分钟，然后煎煮 30 分钟，每剂煎两次，将两次煎出的药液混合。每日 1 剂，分 2 次温服。

功效：温润理肺，降逆止咳。

主治：凉燥束肺，气逆干咳。症见，干咳无痰，喉中燥痒，痒甚咳甚，晨晚为剧，甚时咳则遗尿，胸膈隐痛，咳声嘶急，或见咯血。舌净苔薄有津，脉细或弦。

方解：本病辨证关键是察其舌净苔薄，不糙不腻，有津液敷布；脉细或弦，而无数象。虽为干咳，但绝无燥热伤阴之征。若误为温燥伤肺，投以甘寒柔润之剂，反致肺气抑遏、咳更不爽，延久难愈。本方取麻黄、杏仁、桔梗、橘红、生姜，散寒宣肺利咽；甘草、炮姜，温肺益气布津；当归、佛耳草（即鼠曲草），辛温理肺，甘润下气，尤其当归，味辛性温，富含油性，最善温润，理肺止咳，乃方中要药。

加减：如喉中燥痒，频咳不止者，为凉燥郁闭清窍，宜加炒荆芥 5g，枇杷叶 10g；如咳而遗尿，为肺气失于收敛，宜加五味子 3g；如咳引胸痛，是肺气闭郁，宜加郁金 10g，桃仁泥 5g；如兼见咳血者，非火为患，乃频繁咳嗽，震伤络脉，宜加荆芥炭 5g，郁金 10g；由干咳变为咳而有痰，为病情好转之兆，是肺气畅达，驱邪外出的表现，不必加药，若痰多者，可加姜半夏 5g。病情好转，应逐渐减少辛散之品。本病治疗始终，均不宜强行镇咳，无论中药或西药，往往镇而不止，且可增加胸闷憋气，有碍正常治疗。^[2]

4. 止咳汤（王必舜）

组成：柴胡 10g，前胡 10g，杏仁泥 10g，炙百部 15g，款冬花 15g，炙桑叶 10g，炙桑白皮 10g，桔梗 6~10g，甘草 6~10g。

用法：每日 1 剂，水煎 2 次，早晚分服。

功效：理肺降气止咳。

主治：咳嗽。随证化裁，不仅可治外感之咳，而且可治内伤之咳；既可用于寒咳，又可用于热咳。

方解：纵观全方，取止嗽散之百部、桔梗、甘草理肺止咳，加性偏温的润肺降气之款冬花、杏仁配伍性偏寒凉清热宣肺之柴胡、前胡、桑叶、桑白皮，各药均较平和，寒热并用，宣中有降，使气机调畅，宣清有权，咳嗽自止，故临床应用广泛。

加减：风寒重，去桑叶、桑白皮，加荆芥、麻黄；风热重，考虑有细菌或病毒感染，加金银花、鱼腥草、大青叶、黄芩；咽痛或痒加牛蒡子、蝉蜕、山豆根、芦根、白茅根、射干；痰多色黄质粘稠或大便干燥者加莱菔子、瓜蒌、天竺黄；痰色白清稀合二陈汤或加紫菀；气喘者白前易前胡，加苏子、五味子；兼喘有热者配麻杏石甘汤；高热加石膏、荆芥、薄荷；咯血或痰中带血加白及、仙鹤草、侧柏叶；低热加沙参、玄参、知母、黄芩、青蒿、麦冬、五味子；气虚加党参或太子参、黄芪、当归、百合；气阴两虚加沙参、麦冬、五味子；易反复感冒者加党参、黄芪；气虚、阳虚加桂枝汤或黄芪桂枝五物汤；久咳或老年人需扶正，尚需加入活血化瘀之品，如黄芪、桃仁、当归、丹参，扶正一般用四君子汤补气，当归补血汤益气补血，山药健脾益肾；久病及肾还需加补肾之品，偏阳虚加仙灵脾、

肉桂、补骨脂；有喘用蛤蚧；偏阴虚加生熟地、黄精、何首乌；理肺气常用枳壳、苏梗。以上加减药物，处方时只选1~2味即可，善后主要从金水相生入手，用百合固金汤、六味地黄丸之类以固本。^[3]

5. 老咳灵（刘竹林）

组成：党参 15g，苏子 15g，茯苓 15g，法半夏 12g，白术 9g，五味子 9g，熟附子 9g，陈皮 6g，远志 6g，甘草 6g。

用法：每日1剂，水煎服。

功效：温肺化痰，敛肺止咳。

主治：老年慢性咳嗽。

方解：本方以六君子汤为主，甘温益气，燥湿化痰。用熟附子温散寒邪壮元阳，苏子下气消痰、止咳平喘，五味子敛肺止咳，远志祛痰利窍。全方共奏温肺化痰、敛肺止咳之功。

加减：若兼见痰黄、苔黄者，宜加生石膏、黄芩；痰白量多，喘甚者加细辛、款冬花；兼夜尿多，腰痛者加巴戟天、锁阳、益智仁；兼心悸者加桂枝、白芍。

注意：本方药物多为辛温或甘温药物，不宜滥用或久用，以防耗伤阴血，宜中病即止。^[4]

6. 止嗽散（何炎燊）

组成：桔梗 10g，荆芥 10g，紫菀 10g，百部 10g，白前 10g，陈皮 5g，甘草 3g。

用法：每日1剂，水煎服。

功效：宣肺解表，利气止咳。

主治：新久咳嗽，尤适用于外感咳嗽。

方解：本方乃程钟龄所制，药仅7味，服者多效。其释此方云：“肺体属金，畏火者也，过热则咳；金性刚燥，恶冷者也，过寒亦咳。且肺为娇脏，攻击之剂既不任受；而外主皮毛，最易受邪，不行表散，则邪气流连而不解。若小寇然，启门逐之则去矣。本方温润和平，不寒不燥，既无攻击过当之虞，大有启门驱贼之势，是以客邪易散，肺气安宁，宜其投之有效”。因此本方以治外感咳嗽为主，可按风、寒、暑、湿、燥六淫所伤而随症加减。

加减：外感风寒者，可合杏苏散意，即加苏叶10g，防风10g，杏仁10g，生姜3片。外感风热者，可合桑菊饮，加桑叶10g，菊花10g，连翘12g，杏仁10g。若属喘息性支气管炎者，去桔梗，加麻黄5g，杏仁10g，钩藤10g，地龙10g；兼肺气失降者，再加葶苈子15g，石韦12g。内热盛，或兼暑邪者，加黄芩10g，天花粉10g，滑石20g，芦根30g。里湿盛者，加半夏12g，茯苓15g，杏仁10g，厚朴5g。邪从燥化，呛咳无痰者，去陈皮，加川贝母10g，北沙参15g，梨皮15g，甜杏仁15g。七情郁结，郁火上冲者，加柴胡10g，香附10g，焦栀子10g，川贝母10g。饮食所伤者，加连翘10g，山楂15g，麦芽25g，莱菔子12g。^[5]

7. 解郁宣肺止咳汤（汪新象）

组成：柴胡12g，黄芩12g，半夏10g，细辛6g，五味子10g，生姜或干姜10g，杏仁10g，枳壳10g，甘草6g。

用法：将上药放入砂罐内加水盖过药面一指许，浸泡15分钟，用急火煎，煮沸后用文火煎10分钟将药汁滤出，同样再煎煮两次，煮沸15分钟后将药汁滤出，3次药汁混匀后分3次服，每日1剂。

功效：解郁散邪，宣肺止咳。

主治：外感咳嗽，症见夜间咳甚或昼夜阵咳，吐泡沫痰或清稀痰，病程1周以上。

方解：本方适应证以咳嗽夜甚，或阵咳吐清稀泡沫痰等为主，其病机乃邪郁少阳，导致三焦气机郁遏，肺气失宣，故法当疏畅三焦气机、解郁散邪、宣肺止咳为治。方中柴胡、黄芩、枳壳和解少阳，疏畅气机，解郁散火；半夏、生姜、细辛、五味子温肺散寒，降逆止咳；杏仁降肺气平喘咳；甘草和中。全方意在解郁、宣肺、止咳。气郁解则外邪散，肺气宣而咳嗽自止。肺主宣降，肝主疏泄，三焦司水火升降，而肺的宣降靠肝的疏泄和三焦升降调节，肝胆互为表里，胆与三焦同属少阳而司相火，其气机郁遏，相火不得泄越，化为邪火上逆于肺，则咳嗽作矣。故有“久咳不已，三焦受之”和“夜咳三焦火”之说，故当以清解三焦郁火、温肺散寒为法，正切中本证病机。

本方乃《伤寒论》中小柴胡汤去参枣加味而成。加枳壳助柴胡、黄芩以宣畅气机，解郁散火；加杏仁降肺气，配柴胡降浊升清。清稀泡沫痰系肺通调功能失调的表现，故加细辛，配姜、夏既能温化清稀泡沫之寒痰，又助通调水道之功；再加五味子之酸敛以防姜、辛之辛散，且姜、辛、味同用，收散并举，相反相成，发挥温肺散寒、敛肺止咳之作用，故对三焦气机阻遏所致的郁火咳嗽其效尤佳。

加减：春加荆芥、薄荷、防风；夏加香薷、厚朴、陈皮；秋加苏叶、桔梗、前胡；冬加麻黄、桂枝；咳而遗溺者加黄芪、益智仁；喉痒者加牛蒡子、蝉蜕；久咳不止者加罂粟壳、丹参、桃仁。^[6]

8. 宣肺止嗽汤（周仲瑛）

组成：炙麻黄 5g，桔梗 5g，杏仁 10g，半夏 10g，前

胡 10g，大贝母 10g，佛耳草 12g，生甘草 3g。

用法：每日 1 剂，水煎分早晚各服 1 次。

功效：宣利肺气，止咳化痰。

主治：咳嗽。症见咳嗽频频，咽痒则咳，或阵发呛咳，气急，或咳声不扬，甚至咳延数周、逾月，咯吐泡沫粘痰，色白或淡黄，量少或多，咽部可有急性或慢性充血证，舌质淡红、苔薄白，脉浮滑。

方解：方中麻黄为君辛宣散邪，邪祛则肺气自不上逆；杏仁为臣助麻黄以利肺下气止咳，复其升降之职；甘草为佐使，缓肺气之上逆。合入桔梗汤祛痰宣肺止咳，清利咽喉。配前胡、贝母清肃肺气；佛耳草止咳化痰降气。全方温中有清，温而不燥，降中寓升，升降互济，诸药相配，各显其长，互制其短。

加减：风邪在表加苏叶 10g，桑叶 10g；寒痰伏肺加细辛 3g；痰湿上扰加茯苓 10g，橘皮 6g；肺热内郁加生石膏（先煎）15g，知母 10g；痰热蕴肺加桑白皮 12g，冬瓜子 10g；阴津耗伤加南沙参 10g，天花粉 10g。^[7]

9. 健脾止咳汤（刘炳凡）

组成：党参 12g，白术 10g，茯苓 10g，炙甘草 5g，法半夏 5g，陈皮 5g，冬桑叶 10g，杏仁 10g，川杜仲 10g，补骨脂 3g，款冬花 5g，山药 12g，蝉蜕 9g，木蝴蝶 3g。

用法：上方用冷水浸泡后煎煮。文火煎煮 3 次，每次 150ml，分 3 次服用。

功效：健脾化痰，润肺止咳，补肾纳气。

主治：咳嗽经久不愈。

方解：《内经》云：“五脏六腑皆令人咳，非独肺也。”《医方类聚》云：“治嗽正当养脾，以土生金，而肺病自安

矣。”周慎斋云：“诸病不愈，宜从中治。”李念莪云：“治痰不理脾胃非其治也。”故治痰先补脾（脾为生痰之源），脾复健运之常，而痰自化。故用六君子汤健脾祛湿，以化其痰；桑叶、杏仁、冬花润肺止咳；久咳伤肾，导致肾脏虚弱出现喘促不足以息，故以杜仲、怀山药、补骨脂补肾纳气；木蝴蝶润肺舒肝，蝉蜕散风热以宣肺，又可清利咽喉。方中党参一味，《本草从新》曰：“补肾气，通下行，补气生津，治咳嗽喘逆。”既有清肺化痰之效，又有益气生津之功。诸药配合，共奏健脾、润肺、补肾之效。

加减：咳嗽吐白泡沫痰属外寒挟饮者，加干姜 3g，桑叶易苏叶以温肺散寒化饮；阳虚不达四肢而出现脉微肢冷者，加附片 3g 以温煦肾阳；湿阻脾阳导致清阳不升、浊阴不降而出现恶心欲吐、脘腹饱胀者，加砂仁 3g，白豆蔻 3g，鸡内金 3g 以芳香化湿，和胃降逆；气滞于肠胃出现脘腹饱胀者，加茱萸 3g，以行气导滞。

注意：忌油腻、生冷之物，宜吃清淡食品，勿受风凉。^[8]

（郭桃美）

参 考 文 献

- [1] 沈仲圭. 咳嗽. 辽宁中医杂志, 1981, (4): 39
- [2] 丁光迪. 辛润理肺汤. 中医杂志, 1988, 29 (5): 54
- [3] 易竞雄. 王必舜教授自拟止咳方治疗咳嗽的经验. 甘肃中医, 1999, 12 (6): 10
- [4] 刘杏琴, 刘仁宏. 老中医刘竹林治疗慢性咳嗽的经验简介. 新中医, 1995, 27 (6): 3
- [5] 马凤彬. 何炎燊临证试效方. 广州: 广东高等教育出版社, 1995, 37
- [6] 汪新象. 小柴胡汤加减治疗郁火咳嗽 50 例初探. 中医杂志,

530 方剂（药）篇

1986, (4): 43

[7] 李七一, 唐蜀华. 宣肺止咳汤. 陕西中医, 1994, 15 (12): 547

[8] 李宝顺. 名医名方录. 北京: 中医古籍出版社, 1990. 169

支 气 管 炎

一、外邪侵肺，化热入里，肃降失常（急性支气管炎）

1. 清肺止咳汤（赵冠英）

组成：黄芩 15g，金银花 15g，蜜炙麻黄 8g，杏仁 9g，百部 15g，川贝母 9g，桔梗 9g，炙甘草 8g。

用法：每日 1 剂，水煎服。

功效：清肺止咳化痰。

主治：急性气管炎。

方解：急性气管炎的病因主要是风寒邪毒内犯肺络，使肺气壅遏，肃降失常，发为咳嗽、咳痰、鼻塞、咽痛等症。本方用清热解毒的黄芩、金银花清热祛邪治其病因；麻黄、杏仁、甘草名为三拗汤，有宣肺止咳的功能；川贝母、桔梗、百部具有较好的润肺祛痰作用，痰祛则肺络通畅，肃降有常，增加了止咳之力。

加减：邪毒内盛，高热黄痰，加生石膏、知母、野荞麦根、鱼腥草等，增强清热解毒之力；痰少咳剧者，加枇杷叶、前胡、罂粟壳等，增强止咳效力；痰粘稠难咳者，加沙参、紫菀、天竺黄、竹沥汁等，增强润肺排痰之力；咳兼喘者，加地龙、穿山龙、苏子、满山红等，增强降气平喘之功。^[1]

2. 苇芩泻白汤（何炎燊）

组成：桑白皮 15g，地骨皮 15g，甘草 5g，粳米 10g，黄芩 15g，苇茎 30g，冬瓜仁 20g，薏苡仁 20g，桃仁 15g，鱼腥草 20g，蛤黛散（布包煎）10g。

用法：每日 1 剂，水煎服。病重者，每日 2 剂，水煎分 4 次服。

功效：泻肺火，祛邪热，除痰嗽。

主治：急性支气管炎、肺炎属外邪犯肺，化热入里。症见发热持续，咳嗽气促，痰粘难咯，或带血丝，或如铁锈色，胸肋隐痛，口苦心烦，舌红、苔厚，脉滑数。

方解：邪毒犯肺，最易化热入里，蕴聚肺络。叶天士治肺火痰嗽，用黄芩泻白散，是宗丹溪“黄芩治痰假其下火”之旨；苇茎汤甘寒肃肺乃治肺痈之名方；蛤黛散降火祛痰。三方相合而成复方，泻肺火，祛邪热，除痰嗽。再加入鱼腥草更增疗效。

加减：痰多加瓜蒌仁 15g，天竺黄 10g，浙贝母 15g。兼有喘鸣音者加麻黄 5~10g，葶苈子 15g。出血多者加白茅根 30g，侧柏叶 15g。内热盛，口渴汗多加石膏 30g，知母 15g。高热神烦加牛黄清心丸 1 枚或紫雪丹 3g。^[2]

二、痰热证（慢性支气管炎）

3. 清热化痰汤（张忠国）

组成：黄芩 15g，知母 15g，鱼腥草 15g（后下），桔梗 15g，紫菀 15g，枇杷叶 15g，浙贝母 15g，杏仁 10g，穿山龙 15g，地龙 15g，太子参 15g，甘草 15g。

用法：每日1剂，水煎服。

功效：清热化痰，止咳平喘。

主治：适用于慢支辨证属于痰热型，以咳嗽痰黄，量多而稠，咯吐不爽，气息粗促，舌质红，苔黄腻，脉滑数为主症者。或兼见胸胁胀满，面赤身热，口干欲冷饮等症。

方解：方中黄芩、知母、鱼腥草清泻肺热为君。桔梗、紫菀、枇杷叶、贝母、杏仁、穿山龙、地龙祛痰止咳平喘为臣。另伍太子参、甘草补脾益肺，调和药性为佐使，诸药合用，共奏清热化痰，止咳平喘之功。^[3]

三、痰湿内伏，肺肾两虚证（慢性支气管炎）

4. 燥湿化痰汤（张忠国）

组成：陈皮 15g，半夏 15g，苍术 10g，款冬花 15g，紫菀 15g，白前 15g，苏子 15g，炙百部 15g，穿山龙 15g，茯苓 15g，黄芩 15g，甘草 15g。

用法：每日1剂，水煎服。

功效：燥湿健脾，化痰止咳。

主治：适用于慢支辨证属于痰湿型，以咳嗽痰多，咯痰白粘，晨起或食后尤甚，伴胸闷脘痞，舌苔白腻，脉滑等为主症者。

方解：方中用陈皮、半夏、苍术燥湿化痰，和中降逆为君。款冬花、紫菀、白前、苏子、炙百部、穿山龙止咳祛痰以平喘，共为臣药。茯苓健脾渗湿，助陈皮以化痰；黄芩苦燥寒凉清肺，以防温燥太过，痰湿化热之弊，合为佐药。甘草和中调药，祛痰为使药。总观全方，用陈、夏、

苍燥湿化痰似嫌不足，遂增加祛痰止咳之药物。张氏认为湿痰的形成，缘于肺失清肃，脾失健运。但每因痰湿壅遏肺气，会再度导致肺失宣降，影响肺的水津输布，湿困脾阳，聚湿为痰，从而加重痰湿的病证，故伍以相应的祛痰止咳药尤为重要。^[3]

5. 喘咳定煎剂（孟澍江）

组成：麻黄 4g，杏仁 9g，甘草 3g，法半夏 9g，陈皮 6g，茯苓 10g，当归 9g，熟地黄 10g。

用法：每日 1 剂，加水 3 碗，先浸 1 小时，而后煎煮，沸后文火再煎 25 分钟，滤取药液约 250～500ml，1 日煎服 2 次。

功效：化痰除饮，止咳平喘。

主治：慢性支气管炎，肺气肿。

方解：慢性支气管炎、肺气肿，为临床常见病、多发病，每遇劳累过度或感受新邪而诱发，冬春季发作为多。发时咳逆喘促，动则喘甚，痰多色白而粘，或有咸味，咽部不利，舌苔厚腻或水滑，如有新邪则常伴形寒微热等症。方中用半夏、陈皮理气化痰，使气顺则痰降。因痰由湿生，湿去则痰消，故用茯苓利湿。益以甘草和中补土，使脾健而湿化痰消。用麻黄、杏仁宣肺止咳，且麻黄又有开肺疏表定喘之功。又用当归以和血，熟地黄补肾纳气。二陈得归、地则无过燥之弊；归地与二陈配合，则又无滋腻阻滞气机之嫌。诸药合用，共奏燥湿化痰，和中止呕，止咳平喘之效，是为肺肾合治之法。

加减：若喘咳喉中有痰似水鸡声者，加射干 6g；痰稀白而粘，加干姜、五味子各 2g；如新感之邪渐从热化，咽干不利者，加鱼腥草 15g，甚者可加生石膏 20g。^[1]

四、寒痰证（慢性支气管炎）

6. 温化寒痰汤（张忠国）

组成：干姜 12g，细辛 5g，补骨脂 15g，肉桂 5g，陈皮 15g，半夏 15g，款冬花 15g，紫菀 15g，炙百部 15g，五味子 10g，甘草 15g。

用法：每日 1 剂，水煎服。

功效：温化寒痰，止咳平喘。

主治：适用于慢支辨证属于寒痰型，以咳嗽痰多，清稀色白，胸满喘逆，舌苔白滑，脉弦为主症者。或伴见形寒肢冷、嗜睡等症。若肺气虚者，方中应加人参以补气；肺气不宣而喘者，可酌加麻黄以宣肺平喘，但须小量慎用，恐其发越阳气。

方解：张氏在温化寒痰汤中首选二姜，一则温肺散寒以化痰，一则温运脾阳以祛痰湿；另取细辛温散肺寒，协同干姜以温肺化痰，二者共为君药。补骨脂、肉桂温肾纳气，补火运脾；陈皮、半夏温化痰湿，和胃降逆；款冬花、紫菀、炙百部止咳祛痰，以上共为臣药。再以五味子温敛肺气而止咳；甘草祛痰，和中调药，为佐使药，全方既温太阴脾肺，又暖下元肾阳，温散并行，开合相济，使阳气得复，寒邪得去，痰饮得消。^[3]

五、燥痰证（慢性支气管炎）

7. 清润肺燥汤（张忠国）

组成：南沙参 15g，麦冬 15g，天冬 15g，知母 15g，瓜蒌 15g，桔梗 15g，前胡 15g，杏仁 15g，枇杷叶 15g，太

子参 15g, 山药 20g, 甘草 15g。

用法: 每日 1 剂, 水煎服。

功效: 滋润清肺, 肃肺祛痰。

主治: 适用于慢支辨证属于燥痰型, 以咳嗽痰少, 痰稠胶粘, 咯吐难出, 如粘气道, 或有咽喉干燥等为主症者。

方解: 方中以南沙参、麦冬、天冬、知母养阴润肺, 清肺止咳为君。瓜蒌甘寒清润, 化痰止咳; 桔梗、前胡、杏仁、枇杷叶宣肃肺气, 祛痰止咳; 共为臣药。太子参、山药、甘草补肺健脾, 益气养阴, 共为佐使, 全方可使肺阴得润, 燥痰可除, 肺气清肃, 咳逆自止。^[3]

六、肺脾肾亏虚证 (慢性支气管炎)

8. 紫菀二仁丸 (余瀛鳌)

组成: 紫菀 40g, 杏仁 (去皮尖) 80g, 胡桃仁 80g。

用法: 上药共研细末, 炼蜜为丸, 每丸 10g, 每次服 1 丸, 每日 2~3 次, 温开水送服。

功效: 化痰纳气, 降浊润肠。

主治: 慢性支气管炎, 症见咳喘多痰, 大便偏于燥结。

方解: 本方系宋·许叔微《本事方》中之二仁丸予以加味组成, 具有食疗与药疗相结合的特点。方中杏仁宣肺化痰; 紫菀降肺中浊气, 祛痰止咳; 胡桃仁补肾培元, 纳气定喘, 配合紫菀、杏仁兼能润肠通便。此方秋冬宜常服, 缓缓见功。^[1]

9. 补气化痰汤 (李绍南)

组成: 黄芪 45~60g, 桔梗 9g, 沙参 24g, 杏仁 9g, 紫菀 9g, 茯苓 10g, 百合 12g, 半夏 12g, 甘草 9g。

用法：每日 1 剂，水煎服。

功效：补气平喘，止咳化痰。

主治：慢性支气管炎，肺气肿，肺肾亏损，缠绵不愈者。

方解：本方名取义于丹溪谓“善治痰者不治痰而治气，气顺则一身之津液随气而顺矣。”黄芪补气而固表，得桔梗、沙参能滋补肺虚而不粘腻，并使肺气清肃而痰化。紫菀、百合养肺而降气逆，杏仁利肺止咳，半夏、甘草化痰而和中。本方是清肃滋养、补而不滞的方子。

加减：咳嗽痰稀、舌苔白滑，加白术 12g，桂枝 6g，橘红 9g；咳嗽痰稠而黄，加苏子 9g，前胡 9g，蛤粉 15g，川贝母 6g；干咳无痰加枇杷叶 12g，百部 9g；憋轻喘重加枸杞子 15g，补骨脂 10g，五味子 9g，胡桃肉 30g，或合苓桂术甘汤以化饮，或合都气丸以纳气归肾使子母均健，从而达到治肺的目的。^[1]

10. 泻肺止咳汤（陶克文）

组成：南沙参 15g，法半夏 15g，麦冬 15g，苏子 15g，苏梗 10g，杏仁 10g，厚朴 10g，桔梗 10g，紫菀 15g，款冬花 15g，甘草 6g，葶苈子 15g，浙贝母 10g，茯苓 15g。

用法：先将药物用冷水浸泡半小时，水煎 3 次，每次文火煎 30 分钟，3 次药汁混匀，共约 300ml 左右，分 3 次空腹或饭后 30 分钟温服。

功效：泻肺平喘，祛痰止咳。

主治：中老年人肺脾肾气阴两虚，痰涎壅肺之咳嗽。包括慢性支气管炎及哮喘、肺气肿、肺源性心脏病等病变过程中出现的咳嗽、喘累、气短，背部烘热，口干不欲饮，痰多泡沫，或黄稠或胶粘咳唾不利，甚则颜面、下肢水肿，

口唇紫绀，喘促不能平卧，舌质淡红或暗红，苔黄腻或灰白，脉弦数或弦滑或细小或结代。

方解：本方由《金匱》麦门冬汤、葶苈大枣泻肺汤和半夏厚朴汤三方加减组成。方中葶苈子善于泻肺平喘，苏子、杏仁、紫菀、款冬花温润降气平喘，化痰止咳；浙贝母清肺化痰止咳；厚朴、苏梗宽胸除满消痰涎；半夏、茯苓、甘草健脾燥湿，以绝生痰之源。桔梗开宣肺气，利咽祛痰，且与上述降气药相反相成，使肺气宣降正常，则气道通畅，水道通调，咳喘自平。本病病程往往较长，肺脾肾皆虚，且常出现化热伤津之势，故用南沙参、麦冬益气养阴。诸药相配，祛邪顾正，升降相因，共奏泻肺平喘、祛痰止咳之功，本方乃针对痰涎壅肺之咳喘而设，故去壅塞助湿之大枣和辛散伤阴之生姜。

本方毕竟为祛痰止咳“治标”之法，一旦痰祛喘咳平息之后，尚应进一步补肾、健脾、养肺以培养根本。六君子汤、参麦地黄汤、七味都气丸、生脉散等，均可酌情配服，以巩固疗效。

加减：若喘甚加蜜炙麻黄；热甚痰黄稠加桑白皮、黄芩、生海蛤壳；津伤口渴加芦根、石斛、川贝粉；纳差加谷麦芽；形寒肢冷、痰味咸加干姜、细辛、五味子；水肿加泽泻、生牡蛎；舌暗唇绀加丹参、郁金。^[1]

11. 脾功方（黄吉康）

组成：仙灵脾 15g，菟丝子 15g，功劳叶 15g。

用法：可制成浸膏片或用汤剂。

功效：调补肾阴肾阳。

主治：慢性支气管炎迁延期向缓解期转化阶段表现为肺脾肾亏虚者。

方解：方中仙灵脾、菟丝子助阳填精，配以功劳叶滋阴益肺补肾，于“阴中求阳，则阳得阴助而生化无穷。”三药合用，助阳益阴补肾，使肾脏精气来复，则脾运亦健，脾气旺盛，则肺气也足，使肺脾肾功能健旺，痰浊得化。

加减：胸闷纳呆苔腻者加苍术 9g，厚朴 6g，或合六君子汤加减；畏寒肢冷较甚者加附子 5 片；阴虚内热者加生地 15g，改仙灵脾为 9g。^[4]

12. 补肺定喘膏（戚景如）

组成：红参 50g（研粉冲入膏内），黄芪 300g，白术 120g，防风 90g，熟地黄 120g，山茱萸 60g，淮山药 150g，茯苓 100g，陈皮 60g，半夏 100g，川贝粉 45g（冲入），干地龙 90g，炒苏子 90g，麦冬 100g，五味子 45g（打），鹿角胶 90g，阿胶 90g，补骨脂 100g，怀牛膝 60g，核桃肉 150g，龙眼肉 150g，红枣 240g。

用法：上药浓煎 3 次，去渣，滤取清汁，再加阿胶，冰糖 1 500g，及紫河车粉 120g，蛤蚧 2 对，坎炆粉 15g 收膏，每日早晚各 1 汤匙，开水冲服。

功效：扶正固本，补肺定喘。

主治：对慢性支气管炎伴有气喘者，疗效甚佳。每年冬天服 1 剂，可预防次年不发或少发。^[5]

（吴艳华）

参 考 文 献

- [1] 李宝顺. 名医名方录. 北京：中医古籍出版社，1990. 48，9，33，238，308
- [2] 马凤彬. 何炎燊临证试效方. 广州：广东高等教育出版社，

1995, 39

- [3] 张莉, 姜颖, 张忠国治疗慢支系列验方概要. 黑龙江中医药, 1999, (1): 2
- [4] 王忆勤. 黄吉康治疗咳嗽病验方选介. 中医杂志, 1996, 37 (1): 14
- [5] 陈树森, 曹鸣高, 姜春华, 等. 慢性支气管炎证治. 中医杂志, 1985, 26 (11): 4~9

咳 喘

一、阴虛寒凝，饮聚络阻证（脾肾阳虛）

1. 温阳化痰汤（徐迪华）

组成：红参须 6g，制附片 8g，西麻黄 4g，川桂枝 6g，桃仁 10g，杏仁 10g，胆星 9g，川贝末 5g（分 2 次吞），炙苏子 12g，当归 10g，泽泻 15g，猪苓 10g，茯苓 10g，益母草 20g。

用法：每日 1 剂，水煎服。

功效：温阳蠲饮，化痰祛瘀。

主治：咳喘。症见：咳痰清稀如沫，喘促心悸，不能平卧，动则加剧，面肢浮肿，甚则一身悉肿，口干不欲饮，胸中痞结，畏寒神怯。舌淡胖质黯、苔白滑腻，脉沉细弦。^[1]

二、痰热久蕴，肺络瘀阻证（或兼肺肾阴虛）

2. 清气化痰汤（徐迪华）

组成：麻黄 4g，炒黄芩 15g，桃仁 10g，杏仁 10g，桑白皮 15g，瓜蒌皮 15g，陈胆星 10g，大贝母 15g，苏子 12g，赤芍 20g，干地龙 10g，北沙参 20g。

用法：每日1剂，水煎服。

功效：清热化痰，化瘀通络。

主治：咳喘。症见：咳嗽痰黄粘滞难咯，喘急胀满，胸闷心烦，手足心热，动则气促，面色滞暗，或面目浮肿，或时见发热不恶寒。舌红或暗红、苔黄或黄腻，脉弦滑或弦数。

加减：兼见阴伤症者，原方加南沙参30g。^[1]

三、痰浊久阻，气闭血瘀型（或兼肺脾气虚）

3. 理气泄浊汤（徐迪华）

组成：麻黄4g，川厚朴10g，桃仁10g，杏仁10g，旋覆花（包）10g，姜半夏10g，茯苓10g，陈皮10g，苏子10g，莱菔子15g，白芥子10g，川芎10g。

用法：每日1剂，水煎服。

功效：泄浊平喘，通肺逐瘀。

主治：咳喘。症见：咳嗽痰多，色白粘浊，胸闷纳呆，气短易感，或可见语声低怯，动则气喘，面肢浮肿，面唇黯淡，舌淡或暗淡、苔腻或浊腻，脉滑或细滑。

加减：肺脾气虚者，加炒党参15g，炒白术10g，或加用虫草丸内服。^[1]

四、痰瘀互阻，肾不纳气证（肺脾肾虚）

4. 温肾导痰汤（徐迪华）

组成：制附片9g，肉桂2g，仙灵脾15g，川贝末5g

(分2次吞), 淮山药 15g, 熟地 15g, 炙苏子 10g, 桃仁 10g, 川芎 10g, 五味子 10g。

用法: 每日1剂, 水煎服。

功效: 益肾纳气, 消痰化瘀, 兼补肺脾。

主治: 咳喘。症见: 咳痰量少, 声低息微, 喘急心悸, 动则尤甚, 面色滞暗, 唇甲紫绀, 或面肢浮肿, 舌嫩红或黯红, 边有瘀斑、苔少或薄腻, 脉细数或促急。^[1]

5. 加味麦味地黄汤 (董建华)

组成: 麦冬 10g, 五味子 10g, 山萸肉 10g, 紫石英 (先煎) 15g, 熟地黄 10g, 山药 10g, 牡丹皮 10g, 茯苓 10g, 泽泻 10g, 肉桂 3~6g。

用法: 每日1剂, 水煎服。

功效: 补肾纳气平喘。

主治: 老年性喘咳。

方解: 喘咳为临床常见病, 而老年性肺肾两虚的喘咳多难速效。肺主肃降司呼吸, 肾主封藏而纳气, 有升有降, 则病无所生。年高之人, 阴阳并衰, 咳喘病久, 肺肾两虚。故本方药用麦冬滋阴润肺, 清热止咳; 五味子补肾固精, 收敛肺气; 紫石英温补肾阳; 肉桂引火归元, 纳气归肾。与六味地黄丸相配, 既能收敛肺气, 又能双补肾之阴阳。^[2]

(肖达民)

参 考 文 献

- [1] 申春梯. 徐迪华老中医肺胀分型辨治述要 江苏中医, 1997 (10): 5
- [2] 李宝顺. 名医名方录. 北京: 中医古籍出版社, 1990. 36

脚 炎

1. 麻杏石甘加味方（余瀛鳌）

组成：麻黄（先煎去沫）9g，杏仁（去皮尖）12g，生石膏（先煎）45g，生甘草 6g，黄芩 12g，生地黄 24g，板蓝根 15g，忍冬藤 12g。

用法：每日 1 剂，水煎服。发热超过 39℃ 者，1 日宜服 2 剂。

功效：宣肺清热，止嗽养阴。

主治：病毒性肺炎。

加减：痰多，去生地黄，加川贝母、黛蛤散；大便燥结，加大黄、瓜蒌仁；咽痛加玄参、桔梗；胸痛加枳壳、橘络。^[1]

2. 加味麻杏石甘汤（沈仲圭）

组成：麻黄 3g，生甘草 3g，杏仁 9g，茯苓 9g，紫菀 9g，旋覆花（包）9g，生石膏 12g，冬瓜子 12g，丝瓜络 12g，马兜铃 4.5g，橘红 4.5g。

用法：每日 1 剂，水煎服。

功效：清肺平喘，清热化痰。

主治：肺炎，支气管炎，百日咳等。用于外无寒邪，内有热壅，咳逆痰黄者。

方解：麻杏石甘汤是仲景方，可治咳而喘，心烦口

渴，咳时胸痛，脉浮数之症。方中麻杏石甘汤清肺平喘，加紫菀、马兜铃、冬瓜子、旋覆花肃降肺气，清化痰热；橘红、丝瓜络化痰和络；茯苓渗湿运脾，通调水道。用治肺炎等“肺气壅塞，气喘鼻煽，胸高痰涌”之证，每奏良效。^[2]

3. 六二清肺汤（魏长春）

组成：桑白皮，地骨皮，桑叶，枇杷叶，鲜芦根，白茅根，知母，浙贝母，苦杏仁，冬瓜仁，北沙参，南沙参。

用法：每日1剂，水煎服。

功效：轻清宣泄，祛邪保津，化痰利肺。

主治：用于大叶性肺炎（正虚邪实，阴虚气弱，风热犯肺，肺气上逆）。症见发热咳喘，痰中带血，神志清楚，大小便通润，舌红燥，苔薄白，脉滑数等。

方解：本方宗吴塘“治上焦如羽，非轻不举”之意，从千金苇茎汤、泻白散、清燥救肺汤化裁而得。其中桑白皮、地骨皮清泄肺热；桑叶辛凉解表；枇杷叶下气止咳；浙贝母清化痰热；知母泻火润燥；芦根、白茅根甘寒多汁，能清热润肺，生津止渴，白茅根兼能凉血止血；苦杏仁宣肺平喘；冬瓜仁涤痰排脓；北沙参、南沙参清润养肺，止咳祛痰。

加减：本方可随证加减灵活变通，以使方证合拍，药中病所。如苔黄腻者可去二参，加黄芩、焦山栀清降肺火。痰血多者可去二叶，加二草（仙鹤草、旱莲草）。若津亏舌绛者可用玄参易南沙参，去二叶，加二冬（天冬、麦冬）、生地、石斛。若大便干结者，可去杏仁加瓜蒌仁或生大黄。此方专为阴虚而设，若体实证实或出现营血分证候者，则须另选它方。^[3]

4. 加味苇茎汤（陈亦人）

组成：桃仁 10g，杏仁 10g，炒薏苡仁 12g，芦根 20g，石韦 15g，海浮石 12g，炙枇杷叶（包）10g。

用法：每日 1 剂，水煎服。

功效：清化痰热，肃肺定喘。

主治：肺炎、慢性支气管炎、喘息性支气管炎等属痰热蕴肺、肺失清肃者。

方解：肺乃清肃之脏，其外合皮毛，内为五脏华盖。或因外感，或因内伤，皆可影响肺之宣肃，致令津气不能敷布，聚而为痰，痰气久聚不消，郁久则易于化热；痰阻则气道不畅，热甚则肺金受灼；肺气不清则逆而上冲，咳嗽作矣。其根源在“痰”与“热”，故清热与化痰为治疗的关键。苇茎汤乃《千金方》治肺病名方，为痰热瘀血壅积于肺而设。方中以苇茎（现多用干芦根）清肺泄热；冬瓜仁祛痰排脓；薏苡仁清热利湿；桃仁活血祛瘀。全方配伍严谨，然偏于消肺痈为主，其清化痰热之力稍逊，为使其清化痰热、肃降肺气之力更著，于方中伍入杏仁、枇杷叶、海浮石、石韦等。杏仁苦平泄降，专主泄降肺气，与枇杷叶相伍则相得益彰。海浮石色白入肺，性味咸寒，故能“清金降火……化老痰”（朱震亨语）；石韦乃治淋浊要药，以其配杏仁则清肺化痰、降肺气之功卓著，每每配成药对用于治疗痰热阻肺的病证。

加减：若因痰热久羁肺阴损伤者，可加入沙参、麦冬等以养其阴；方中亦可伍用大剂生芦根，以发挥其清热生津之效；痰热久伏，肺气耗伤，则宜伍入生黄芪，一则补其不足之气，一则可冀其托邪外出。^{〔1〕}

（吴肇派）

参 考 文 献

- [1] 李宝顺. 名医名方录. 北京: 中医古籍出版社, 1990. 32, 398
- [2] 沈仲圭. 咳嗽. 辽宁中医杂志, 1981, (4): 39
- [3] 赵绍琴, 曹鸣高, 马莲湘, 等. 肺炎证治. 中医杂志, 1985, 26 (10): 6~14

哮喘

一、外感风寒，痰浊内阻证（哮喘发作期）

1. 三拗二陈汤加味（李幼安）

组成：炙麻黄 4.5g，五味子 4.5g，黄荆子 4.5g，甘草 4.5g，杏仁 10g，茯苓 10g，姜半夏 10g，苏子 10g，苏梗 10g，厚朴 10g，枳壳 10g，紫菀 10g，款冬花 10g，川贝母 6g，陈皮 6g，干姜 1.5g，细辛 2g。

用法：每日 1 剂，水煎分 2 次服。

功效：祛风散寒，化痰平喘。

主治：支气管哮喘。

方解：哮喘多因风邪侵袭，肺气不利，痰湿壅盛，痰湿重则易化热而见喘急热不退。故用三拗汤（麻黄、杏仁、甘草）散风邪祛痰而平喘，二陈汤燥湿化痰，理气和中。方中麻黄、苏子、杏仁、苏梗为主药，降逆平喘，祛风散寒；陈皮、姜半夏、紫菀、款冬花、川贝母、茯苓祛痰止咳；厚朴、枳壳行气消痞；黄荆子疏风化湿，止咳平喘；《金匱要略》有云：“病痰饮者，当以温药和之”，故用干姜、细辛、五味子温肺化饮；甘草调和诸药。全方共奏祛风散寒，化痰平喘之功。

加减：发热、咳痰黄稠者，去干姜、细辛，加黄芩、

射干；咽痛、声音嘶哑者，加桔梗、马勃、牛蒡子；口渴者，加沙参、天花粉；鼻痒流涕者加辛夷花；痰壅喘咳不得卧者，加葶苈子、地龙；痰多不易咳者，加瓜蒌；心悸者，配以真武汤或济生肾气汤加减；若咳嗽病程长久，配以罂粟壳、百合。^[1]

2. 解表化痰平喘汤（邵经明）

组成：炙麻黄 9g，杏仁 9g，桂枝 9g，陈皮 9g，半夏 9g，苏子 9g，炙甘草 6g。

用法：每日 1 剂，水煎 2 次分服，以喘平为期。

功效：温散解表，理气降逆，化痰平喘。

主治：哮喘，凡外感风寒或痰饮所致者。包括支气管哮喘、喘息性支气管炎。

方解：本方所主治之哮喘，其病因多为外感风寒，侵袭于肺，内伏痰饮上逆，壅塞气道，故出现喉中痰鸣，呼吸急促，难以平卧。方中用麻黄、杏仁、桂枝为君，温散寒邪以解表，可使肺气得以宣通；内伏痰饮，故用陈皮、半夏、茯苓为臣以消痰化饮；佐甘草可增强祛痰和中健脾之力；加苏子为使，其有助陈皮、半夏理气降逆化痰之功。本方具有温散解表、理气降逆、化痰平喘之作用。

加减：内有痰火，微感外邪，症见微恶寒，身壮热，痰稠色黄，吐之不利，舌苔干燥或色黄，脉数或滑者，此乃寒束痰火之哮喘，本方去桂枝、苏子，加知母、贝母、生石膏以清热利痰平喘。如病程较长，损及于脾、健运失司、化生痰饮，上注于肺，阻塞气道，喉中痰鸣，舌苔白或腻，脉缓弱，此乃脾虚痰湿所致，治疗宜遵李士材所说：“治痰不健脾胃非其治”，本方应加党参、白术补中健脾；寒甚加干姜温化痰湿，喘可自平。年老病久，肾虚失纳，

下元不固，动则即喘，登高加剧，此乃肾不纳气之虚喘，本方慎用，以免虚虚之虞，改服都气丸或麦味地黄丸。肾阳虚者可服金匱肾气丸（病情需要也可改为汤剂），坚持长期服用，缓缓图之。^[2]

3. 黄龙疏喘汤（晁恩祥）

组成：炙麻黄、地龙、蝉蜕、苏叶、石菖蒲、白果、苏子、白芍、五味子。

用法：每日1剂，水煎服。

功效：疏风解痉。

主治：支气管哮喘。

方解：方中麻黄辛温，疏风散寒，宣肺平喘，宣中有降。《神农本草经》谓：麻黄“止咳逆上气，除寒热”。《本草备要》中认为麻黄“治痰哮喘”。药理研究表明麻黄中含有的麻黄碱、伪麻黄碱等各种生物碱及挥发油、鞣质等，对支气管平滑肌有明显的松弛作用，且具有作用持久的特点。地龙咸寒泄降，熄风解痉定喘。药理研究证实，从地龙中提取一种含氮的有效成分（次黄嘌呤），对大鼠及家兔肺灌注具有明显的舒张支气管作用，并能对抗组织胺及毛果芸香碱引起的支气管收缩；静脉注射于豚鼠可提高对组织胺的耐受性。从地龙抗组织胺作用明显的水溶性部分分离的琥珀酸，将其用于临床有宽胸祛痰作用。麻黄与地龙相伍，一温一寒，一宣一降，相得益彰，皆为治疗哮喘的要药。苏叶辛温，《本草正义》曰：“紫苏，芳香气烈。外开皮毛，泄肺气而通腠理。上则通鼻塞……。中则开胸膈，醒脾胃，宣化痰饮……。叶本轻扬，则外感风寒用之，疏散肺闭，宣通肌表，泄风化邪，最为敏捷”。苏子辛温入肺，善于下气消痰。苏叶、苏子与麻黄相伍，不仅能增强

疏风之力，而且加强升降相协，使肺之宣降得以恢复。蝉蜕甘寒体轻性浮，能入肺经，宣肺定痉，与麻黄、地龙相伍，以增强解痉之力。白果甘苦涩，有敛肺气、定喘嗽之功。石菖蒲具有开窍、豁痰、理气、活血的功能。药理研究证明其所含的 α -细辛醚有平喘作用，能对抗组织胺引起的支气管收缩，并能镇咳，与麻黄、地龙相伍，可增强化痰作用。虎杖微苦、微寒，具有祛风利湿、止咳化痰、散瘀定痛的功能。药理研究表明，虎杖具有抗病毒作用，其所含大黄素、虎杖甙能明显止咳，可助麻黄、地龙疏风化痰平喘。五味子《本经》记载其“主益气，咳逆上气”。药理研究表明，五味子醚提取物具有镇咳、祛痰作用；五味子油剂能增强细胞免疫功能。白芍能缓急解痉。酸收的五味子、白芍与辛散的麻黄、苏叶、苏子等配伍，不但不产生敛邪留邪之弊，而且可制约麻黄等的辛散之性，又可甘酸配伍，解除痉挛，同时通过一张一敛的相反相成，促进肺气的宣通。诸药合用，辛温宣肺，疏风解痉，解窍降气，豁痰平喘，使风散痰消挛解，肺气得以宣降，哮喘自平。^[3]

4. 截喘汤（姜春华）

组成：佛耳草 15g，碧桃干 15g，老鹳草 15g，旋覆花 10g，全瓜蒌 10g，姜半夏 10g，防风 10g，五味子 6g，开金锁 15g。

用法：每日 1 剂，水煎服。

功效：降逆纳气，化痰截喘。

主治：支气管哮喘、慢性支气管炎、肺气肿等所引起的咳嗽痰多、气逆喘促。

方解：本方系姜氏对支气管哮喘的截治方法进行长期研究，又结合临床实际疗效，根据中药的现代药理研究，筛选

民间单、验方而自拟的治喘专方。方中佛耳草出自《本草拾遗》，功专化痰止咳平喘；老鹳草，见于《本草纲目拾遗》，功能祛风活血，清热解毒，原列为祛风湿、强筋骨类药，但民间有用其平喘之单方，有祛痰、扩张支气管作用，其药理研究表明对金黄色葡萄球菌、肺炎球菌、链球菌及流感病毒等均有抑制作用，故能控制支气管哮喘发作期的呼吸道感染；碧桃干苦温收敛，本治盗汗、咯血。《饮片新参》有“除劳嗽”的记载，民间有用治顽喘的经验，药理研究有调节植物神经功能及微血管作用。上三味药祛痰镇咳而平喘，为方中君药。旋覆花消痰平喘，降逆下气；全瓜蒌始载于《本经》，上清肺胃之热而化痰散结，下润大肠之燥而滑肠通腑，且有广泛抗菌作用；半夏燥湿化痰，降逆下气，与前二味合而为辅；五味子气味酸涩温，《神农本草经》谓其“主益气，咳逆上气……”。仲景小青龙汤治伤寒表不解，心下有水气，就用了五味子。《类证治裁》中亦用五味子、干姜治嗽喘，谓“摄太阳而定喘”。姜氏用以虚实同治，标本兼顾，治新老虚实之咳喘，取其补肾纳气，镇咳敛肺为佐；防风主除风之害。《药法类象》谓之“治风通风，泻肺实”，是一味抗过敏的良药，能抑制哮喘发作期的变态反应，清除过敏原的刺激；开金锁（即野荞麦根），清热解毒，活血散瘀，化痰止嗽，使痰液分泌减少。全方抓住化痰降逆主要环节，痰祛喘易平，使支气管痉挛得以松弛，粘膜分泌物得以清除，而获降逆纳气，化痰截喘之功效。哮喘发作期用之，一般3~7剂即可见效，如结合辨证加减运用，则疗效尤显。如用于哮喘稳定期，能起预防及巩固作用。^[4]

5. 平喘定哮方（黄吉康）

组成：射干 15g，炙麻黄 5g，紫菀 15g，款冬花 10g，

竹沥半夏 15g, 柴胡 15g, 前胡 15g, 枳壳 10g, 桔梗 9g, 生甘草 9g。

用法：每日 1 剂，水煎分 2 次温服。儿童量减半。

功效：宣肺化痰，理气活血，平喘定哮。

主治：哮喘证、咳嗽属实证者。

方解：方中以射干苦寒降逆消痰，炙麻黄辛温宣肺平喘，寒温并用为主药；配以半夏燥湿化痰；柴胡、前胡宣肺达邪，柴胡又有抗过敏作用；紫菀、款冬花化痰止咳；枳壳、桔梗一升一降调畅肺气，“治痰先治气，气顺痰自消”；丹参、郁金活血化瘀；生甘草化痰止咳，调和诸药。综观全方，寒温并用，宣肺降气，化痰活血是组方特点。值得注意的是方中麻黄用量不宜大，特别对体弱、老人和幼儿。尤其是在“慢支”的治疗中，病人年龄偏大，且常伴有心血管疾病、高血压病或有前列腺肥大等，在许多反复发作病人中，原已服用较大剂量的 β_2 受体激动剂和茶碱类药物，用大剂量麻黄，可出现心率增快、血压增高、失眠、老年男性排尿不畅、尿频等症状，故用药前要仔细询问病史。一般常用剂量为 3~6g。多选用炙麻黄。若汗多，可配麻黄根宣敛并用。

加减：若见咳痰稀白量多之寒证，加细辛、泽漆、苏子以助麻黄温化痰饮，降气平喘；痰黄或白，粘稠难咯加黄芩、桑白皮清泄肺热，宣畅肺气；气喘发作严重，可加全蝎、蜈蚣研粉吞服以搜风、通络、化痰而解痉平喘。^[5]

6. 二麻四仁汤（陈苏生）

组成：炙麻黄 4.5g, 麻黄根 4.5g, 苦杏仁 9g, 桃仁 9g, 郁李仁 9g, 白果仁（打）9g, 百部 9g, 款冬花 9g, 车前草 24g, 生甘草 4.5g, 辛夷 9g, 苍耳子 9g。

用法：每日1剂，水煎分2次服，小儿可酌量分多次服。

功效：调整肺气，排痰止咳，散风脱敏。

主治：哮喘，咳嗽。

方解：本方中麻黄辛散，开腠理，宣肺气，透毛窍，散风寒，化痰平喘，但能收缩血管，高血压患者忌用，又因其发散力较强，体虚多汗者亦忌之。而麻黄根与麻黄作用相反，不但能止汗固表，而且还能扩张血管，使血压下降。二者合用，一开一合，开合相济调整肺气，能加强肺的活动功能，而且无升提血压、助长兴奋的流弊；杏仁降肺气之上逆，桃仁化血络之凝瘀，一气一血，能调畅肺部郁血，顺气降逆；郁李仁滑肠下气，清能去浊，白果仁敛肺而不敛痰，一滑一涩，能起上（痰）下（便）分消之功；百部、款冬花《济生方》谓百花膏，用于喘嗽不已，亦可治痰中带血；车前子、生甘草排痰止咳，调和诸药；辛夷、苍耳子散风脱敏。

加减：若服本方出现便溏者，一般可不予处理，但严重者去郁李仁，加藿香梗、厚朴；湿重纳呆，可加川厚朴、苍术；便艰加大腹皮、瓜蒌仁、火麻仁；痰稠不畅加象贝母、瓜蒌皮；中满气滞加柴胡、生牡蛎、郁金、石菖蒲；腹胀加大腹皮、瓜蒌；热重加土茯苓、金银花、连翘、白薇；若过敏现象不明显则去辛夷、苍耳子；过敏症状明显加僵蚕、蝉蜕；泛恶者加制半夏、姜竹茹；昼轻夜重加夜交藤、合欢皮；痉咳加木蝴蝶；气虚加太子参、党参；阴虚加北沙参、麦冬、知母、玄参；肾不纳气，喘息甚者加黑锡丹。^[2]

7. 麻杏射胆汤（董漱六）

组成：麻黄 5g，杏仁 10g，射干 9g，苏子 9g，蝉蜕

4.5g, 炒僵蚕 9g, 制半夏 9g, 广陈皮 4.5g, 枳实 5g, 制胆星 9g, 桔梗 4.5g, 生甘草 4.5g, 鹅管石 12g (煨、杵)。

用法: 先将上药用冷水浸过药面, 约半小时再加水少许, 煎沸后再煎 10 分钟左右, 头煎取汁一饭碗, 接着加水煎熬二煎, 取汁大半碗, 把头煎、二煎药汁一同灌入热水瓶内, 分 2 次顿服。如小儿可分 3~4 次服, 当天服完。

功效: 宣肺化痰, 降气定喘。

主治: 支气管哮喘、慢性气管炎急性发作期。症见咳嗽痰多, 咯吐不爽, 胸闷气急, 喉痒作呛有哮喘音, 夜间不得平卧, 乳蛾肿胀, 苔薄白腻, 脉浮滑数。中医辨证为风寒客肺、痰浊内阻、肺气失于宣降者。

加减: 若口渴烦躁、痰粘、舌红苔黄者, 上方可去半夏、陈皮, 加石膏 30g, 知母 12g, 贝母 12g; 如形寒肢冷无汗, 痰白呈泡沫状, 舌苔白滑者, 可去蝉蜕、僵蚕、桔梗, 加桂枝 4.5g, 细辛 3g, 干姜 2.4g; 咽红乳蛾红肿, 痰稠, 舌红脉数者, 可去半夏、陈皮, 加金银花 9g, 连翘 9g, 牛蒡子 12g, 生麻黄改用炙麻黄 5g; 如小便黄、便秘、舌红者, 可去桔梗、甘草, 加黄芩 9g, 桑白皮 12g, 生麻黄改用蜜炙麻黄 5g, 制半夏改用竹沥半夏 9g, 广陈皮改用橘络 5g; 如咳喘气逆, 腹胀胁痛者, 去桔梗、甘草, 加莱菔子 9g, 白芥子 9g; 若脘腹痞胀, 口粘纳差, 苔白腻者, 去蝉蜕、僵蚕, 加厚朴 4.5g, 焦神曲 12g; 如有头胀头痛, 鼻塞多涕者, 可去半夏、陈皮, 加辛夷 9g, 苍耳子 9g。^[2]

二、脾虚肝旺, 肺气不降证

8. 调肺汤 (刘绍武)

组成: 沙参 30g, 苏子 30g, 党参 30g, 生石膏 30g,

瓜蒌 30g，桔梗 15g，杏仁 15g，柴胡 15g，黄芩 15g，五味子 15g，罂粟壳 5g，川椒 10g，麻黄 10g，甘草 10g，大枣 10 枚。

用法：每日 1 剂，水煎服。

功效：平喘止咳。

主治：哮喘，或外感咳喘。

方解：外感喘咳久治不愈者，虽责之外邪不除，然正气不济，抗邪无力。方中用小柴胡扶正祛邪，更借麻杏甘石使邪外解，肺气得宣，则咳喘自平。至若宿疾咳喘又多与肝火及脾虚有关，脾虚则聚湿生痰，肝火则灼金成痰，痰邪犯肺，肺气不降而为咳喘。小柴胡疏肝健脾，再合麻杏甘石之宣肺平喘，内外合治，其效自彰。方中石膏制麻黄发汗，且能清肺热而减少痰的生成；瓜蒌、桔梗宽胸祛痰，以利肺气；五味子敛肺气，且与麻黄相拮抗，一收一散而有相反相成之功；肺喜润恶燥，以沙参润之；罂粟壳敛肺镇咳，以减少咳嗽之苦，然不宜多用，否则将有闭门逐贼之弊。合小柴胡共奏扶正祛邪、止咳平喘之功。至于哮喘多由外感引动宿疾而作，本方内调肝脾以制生痰之源，外解表邪以除引发之机，利肺祛痰并治发病之标。^[6]

三、寒热夹杂证（发作期）

9. 哮喘方（蔡友敬）

组成：蜜麻黄 10g，杏仁 10g，半夏 10g，苏子 10g，黄芩 10g，款冬花 10g，桑白皮 10g，蝉蜕 6g，乌梅 12g，防风 10g，甘草 3g。

用法：每日 1 剂，水煎服。

功效：宣肺气，散外邪，化痰浊。

主治：哮喘发作期寒热夹杂者。症见咳嗽气喘，喉中有哮声，呼吸紧迫，喉痒胸闷，甚则张口抬肩，不得平卧，苔黄腻，脉滑数。

方解：方中麻黄、杏仁、甘草为三拗汤，是疏散风邪，宣肺化痰，止咳平喘之要药。配合黄芩、桑白皮清泄肺热，款冬花温肺止咳，半夏、苏子降气化痰。蔡氏认为哮喘多是过敏性疾患，故加蝉蜕、乌梅、防风等解痉、脱敏之药。药理研究表明，蝉蜕具有抗组织胺、神经节阻断作用，可消除或减弱感染后的变态反应。防风、乌梅治疗多种过敏性疾患有效。诸药合用，共奏宣肺降气，化痰止咳，脱敏平喘之功。

加减：气喘不得平卧者加葶苈子 15g；发热口渴痰黄者加生石膏 30g；畏寒痰白苔白腻者去黄芩加桂枝 6g，细辛 2g；口干痰粘稠加沙参 10g，麦冬 10g；湿重纳呆者加厚朴 10g，苍术 10g。^[7]

四、虚喘兼实证

10. 补虚定喘方（蒋天佑）

组成：熟地 9~12g，炙黄芪 50g，炒山药 15~30g，补骨脂 9g，五味子 9g，代赭石 6~9g，炒地龙 6~9g，炙麻黄 6~9g，丝瓜络 6~9g，露蜂房 6~9g，葶苈子 6~9g。

用法：每日 1 剂，水煎 2 次，早晚分服。病重者，可每日服 2 剂。

功效：补肾益肺，降气定喘，化痰通络。

主治：用于急、慢性支气管炎、阻塞性肺气肿、支气管哮喘、支气管炎纤维增殖型肺结核、肺心病、风心病、冠心病等心肺病的虚喘兼实证。症见呼吸气促，吸气困难，

动则为甚，或阵咳遗尿，咳声低弱或深沉嘎涩。痰咸量多且冷，涎长难断，或痰黄粘稠，咽喉不利。易汗出感冒，形瘦神惫。或夜尿多，腰酸膝软。或外感微热，或面红口干舌燥，或心悸浮肿，面青白四肢不温，或五心烦热，便干尿黄。舌质淡胖有齿痕，或紫暗有瘀斑点，舌苔白滑润或舌质偏红少苔。脉沉细而弱，右寸及两尺脉弱尤甚，或沉细而数。

方解：方中熟地滋肾填精而实其里，黄芪补肺益气而固其表为主药。山药脾肾双补，补骨脂补肾纳气，五味子补肾敛肺，三者加强主药补肾益气之功为辅药。代赭石重镇降气，气降则痰水亦降；地龙下行利水，水行则气机和畅；麻黄宣肺行水，肺宣水行则喘定，且熟地、五味子配麻黄而有开有阖，代赭石、地龙得麻黄而有升有降，三者同属佐药。丝瓜络、露蜂房通肺窍，葶苈子利肺气而化肺痰，均为使药。

加减：若轻度外感咽痒加荆芥；喉痛加青果；咳甚加款冬花；痰黄粘稠加金银花或鱼腥草；痰血加白茅根；痰不利加瓜蒌；痰量多加白芥子；水饮喘甚加椒目；心悸失眠加炒酸枣仁；汗多麻黄易麻黄根；浮肿加茯苓皮或五加皮；口干渴加麦冬；便溏代赭石改沉香重用山药；心肾阳虚著加桂附，去阴寒药；肺肾阴虚明显，熟地改生地，加沙参、麦冬，补骨脂易胡桃肉，去阳热药；元气亏加人参；血虚加当归；精亏加紫河车或蛤蚧；血瘀加丹参或桃仁、红花；气滞加枳壳；喘脱加服或先服黑锡丹后服本方。^[8]

11. 三子汤（邵长荣）

组成：葶苈子 12g，苏子 9g，车前子 12g。

用法：每日 1 剂，水煎服。

功效：利水下气。

主治：哮喘。症见气喘痰多，下肢浮肿，但不太严重的患者。

方解：方中葶苈子具泻肺定喘、行水消肿之功，效似桑白皮而力强，适当配伍，虚实之喘皆可用之。配苏子以降气，配车前子以利水。^[9]

五、肺脾肾虚证（缓解期）

12. 纳气固本丸（杜祝岳）

组成：人参 50g，苏子 50g，山药 50g，白芥子 50g，菟丝子 50g，制附子 30g，五倍子 30g，肉桂 30g，沉香 30g，山茱萸 40g，牡丹皮 40g，葶苈子 40g，杜仲 40g，降香 35g，蛤蚧 3 对，胎盘 2 具。

用法：上药精制为丸，每丸 5g，每次 3 丸，每天 3 次。

功效：补肾益肺，降气平喘。

主治：哮喘缓解期。^[10]

13. 哮喘冬病夏治方（赵清理）

组成：制附子 9g，陈皮 9g，党参 12g，白术 12g，茯苓 12g，半夏 7.5g，炙枇杷叶 15g，炙款冬花 15g，甘草 3g。

用法：每日 1 剂，水煎服。自夏至前后开始服用，连服 15 日为 1 疗程。若制成冲剂，则用常用汤剂 7 倍之量，其中枇杷叶为常用量之 10 倍，共煎滤渣，经沉淀后，用其清液加蜂蜜适量，煎至浓稠为度，每次 1~2 汤匙，每日 2 次，开水冲服。若病重连年者，1 年内可连服 2 个疗程。

功效：补脾土，益命门。

主治：哮喘。

方解：哮喘为患，遇冬即发，慢而顽固，常以咳痰喘为主证，脾肺肾三脏功能失调为基本病机。治肺乃是治标，而根本之治，则在调理脾肾，以杜生痰之源。冬病夏治，旨在从脾肾治本着眼，以药之温热合夏时之气，补脾土、益命门。方寓四君、二陈，四君健脾补中，以杜生痰之源；二陈理气燥湿，以廓贮痰之器；倍用枇杷叶，上可清肺、肃肺以化痰止咳，中可清胃、降胃以涤痰祛浊，量大功专，又不碍补脾培肾。更陪冬花辛温润肺，下气化痰，诚有柔肺金而行治节，澄浊气而廓中州之功。制附子与天时之热相合，肾阳最易煖复。用蜂蜜乃取其滋肺于温补之中，扶正于祛邪之先。全方合之，使脾肺肾得温，正气得复，痰源得除，既防咳喘于未发，又澄本溯源以堵截，故可以获较好的疗效。^[11]

14. 补肾平喘汤（周仲瑛）

组成：太子参 30g，麦冬 10g，陈皮 10g，姜半夏 10g，炒苏子 15g，地龙 15g，五味子 10g，补骨脂 10g，灵磁石 30g，乌梅肉 15g，胎盘 6g，桃仁 10g。

用法：每日 1 剂，水煎服。

功能：补肾益肺，平喘止咳化痰。

主治：支气管哮喘，慢性喘息性支气管炎。

方解：本方以太子参、麦冬、五味子为主，意在滋补肺肾，益气养阴。方中用太子参不用人参，以避其燥，有补肺健脾，大补元气之功；麦冬养阴润肺，益胃生津，《别录》谓可“强阴益精，……保神，定肺气，安五脏，令人肥健”；五味子酸温，入肺肾二经，有敛肺滋肾，生津收汗涩精之功，孙思邈称其“在上可滋源，在下则补肾”，实为

肺肾双补之要药，用于虚喘尤为适宜；太子参、麦冬又有补脾胃之力，以滋气血之源，即叶天士云：“益肺药皆甘，补土母以生子”；陈皮、姜半夏理气止咳化痰，斡旋中焦；苏子降气定喘消痰；地龙活血通络，解痉止喘，现代药理研究其有效成分有显著舒张支气管作用；乌梅酸甘温，入肺肾二经，治久咳，可以纳肺之气，《本草经原》谓有“引气归元”之功，故能收肺气、纳肾气；胎盘大补元气，补而不燥，可阴阳双补，《本草经疏》称此药“大补而不燥，有返本归原之功”；磁石辛咸而平，入肺肾二经，可纳气平喘；补骨脂辛温，入肾助阳，使肾水不寒，蒸腾气化，肺水得荫，对于肾虚咳喘，历代医家均喜用之；桃仁活血行瘀，润肠通便，能使肺之脉通畅，补中有通之意。全方以补肾为主，兼顾脾胃，阴阳双补，有化痰理气、行血活血、止咳平喘、通畅脉络之效，且性味和平，补而不燥，滋而不膩，适于较长期服用。

加减：阴虚加生地、玄参；阳虚加制附子、肉桂；气虚加黄芪、白术、玉竹；血虚加阿胶、当归；血瘀加丹参、川芎、赤芍；心悸加酸枣仁、生龙骨、生牡蛎、柏子仁；浮肿加茯苓、薏苡仁、车前子、葶苈子；喘甚加洋金花、蛤蚧；咳甚加瓜蒌仁、川贝母；发热加柴胡、黄芩、生石膏、鱼腥草、金银花、连翘。^[2]

15. 参蛤河车丸（何炎燊）

组成：吉林人参 50g，蛤蚧 1 对，胡桃肉 60g，苏子（炒）30g，白果肉（炒微黄）50g，甜杏仁 50g，川贝母 50g，法半夏 50g，麻黄 50g，另用紫河车 1 具，连同坎炁，洗净蒸熟（隔水蒸半小时即可）晒干或文火焙干，与诸药共为细末，炼蜜为丸，瓷瓶收贮。

用法：每次服6~8g，早晚各服1次，开水下，每料可服40~50天，须连服1年以上。若哮喘发作或患有其他疾病时停服。

功效：补肺降气，补肾纳气，平喘除痰。

主治：哮喘缓解期治本之方。

方解：此方是何氏从《济生方》人参胡桃汤及《卫生宝鉴》人参蛤蚧散两方化裁而成。哮喘日久，多是虚实错杂之症。方中人参补肺气，蛤蚧、胡桃、紫河车补肾纳气，此固本培元之法。然痰饮深伏肺俞，伺机而发，又不可不防。故用麻黄之散，白果之涩，苏子之降，使肺气宣通，此未雨绸缪之计也。杏仁、半夏、贝母润燥涤痰，为之佐使，共奏其功。此方和平中正，不寒不燥，利于久服。

加减：畏寒口淡，偏虚寒者，加肉桂15g，仙灵脾50g；口干咽燥，偏阴虚者，加玄参50g，麦冬50g，天冬50g，此三药不易碾末，可用水3碗煎成1碗，去渣，微火浓缩，以代蜜糖，与诸药末为丸；呼长吸短，劳则气喘若不相接续者，加五味子50g，沉香15g，以收摄肾气；平时痰多而稠，哮喘发作时咳逆上气，胸脘痞闷欲死者，加葶苈子50g，加用石韦100g煎水一杯，置葶苈子于锅上，微火炒令热以石韦水浇之，以尽为度，微火焙干葶苈子，与诸药为丸。^[12]

16. 哮喘丸(蔡友敬)

组成：人参120g，胡桃肉120g，补骨脂120g，五味子120g，紫河车100g，茯苓100g，陈皮90g，半夏90g，甘草30g，炒白术90g，黄芪120g，杏仁90g，紫菀90g，紫石英130g。

用法：以上药研细末，以蜜泛丸如绿豆大。每次服10g，每日服3次，3个月为1疗程。

功效：补肺气，健脾气，纳肾气。

主治：哮喘缓解期。症见咳嗽痰多，食欲不振，疲乏无力，极易感冒，动则气促或气喘，舌淡，苔薄，脉细沉。

方解：方中以补气汤补益肺气，六君子汤健运脾气，人参胡桃汤和青娥丸摄纳肾气。肺气足则卫外固，邪未凑；脾气旺则运化如常，痰浊自化；肾气充则元气足，喘息必平。并加紫河车大补元气，紫石英固冲镇逆。本药丸若长期服用对哮喘根治能起一定作用。^[7]

17. 参蛤麻杏膏（董漱六）

组成：生晒参60g（如用党参，剂量加倍），蛤蚧2对，麻黄（去节）60g，杏仁100g，炙甘草50g，生姜60g，红枣（去核）120g，白果肉20枚。

用法：将生晒参另煎，收膏时冲入；蛤蚧去头足研末冲入收膏；余药加水浸泡一宿，浓煎3次，去渣，滤取3次清汁再浓缩，加入冰糖500g收膏，装瓶备用。用时每日早晚各1匙，开水冲服，不分男女老幼，常年均可服用。

功效：利痰定喘。

主治：支气管哮喘缓解期，慢性气管炎伴有肺气肿。

加减：如咳嗽低热，可加桑白皮90g，地骨皮120g；如痰多呈泡沫状，加干姜10g，细辛15g；如大便干结，加熟地120g，当归90g；如心悸盗汗，加麦冬100g，五味子45g。

注意：服药期间，切忌烟、酒、红茶、萝卜、鱼腥及一切过敏食物、辛辣食物，生冷果品。若伤风停食，可缓服数日。^[13]

六、肺气不宣，肾不纳气证

18. 三桑汤(邵长荣)

组成：桑白皮 12g，桑椹子 12g，桑寄生 12g。

用法：每日 1 剂，水煎服。

功效：清泻肺热，平补肝肾。

主治：肺气肿中气急等症不太严重，兼稍有舌紫的轻度肺气不宣和肾不纳气的哮喘缓解期患者。

方解：方中桑白皮清泻肺热为君，配以平补肝肾的桑椹子和桑寄生为辅，补中有泻，寓泻于补，具攻补兼施之效。^[9]

七、气阴两虚证(缓解期)

19. 三参汤(邵长荣)

组成：孩儿参 15g，沙参 12g，玄参 12g。

用法：每日 1 剂，水煎服。

功效：补气益阴。

主治：哮喘静止期，舌质红绛的气阴两虚者。对痰热壅肺，经久不愈而见肺之气阴两虚者，用之甚宜。

方解：方中孩儿参益气清补，功近人参而力薄，配沙参、玄参助其补益气阴之力。^[9]

(吴艳华)

参考文献

- [1] 刘萍. 三拗二陈汤加味治疗支气管哮喘. 湖北中医杂志, 1997, 19(2): 34

- [2] 李宝顺. 名医名方录. 北京: 中医古籍出版社, 1990. 174, 36, 190, 90
- [3] 张洪春, 晁恩祥. 疏风解痉法治疗过敏性支气管哮喘的临床研究. 中国中医急症, 1998, 7 (2): 54
- [4] 王佩芳, 姜光华. 辨治与专方结合. 辽宁中医杂志, 1992, 19 (9): 3
- [5] 余小平, 吴昆仑. 平喘定喘方治疗哮喘 232 例. 辽宁中医杂志, 1998, 25 (7): 314
- [6] 胡连玺. 刘绍武老师“三步六病”证治简介. 辽宁中医杂志, 1986, 10 (11): 1
- [7] 蔡光斗, 林禾禧. 蔡友敬老中医治疗哮喘病 248 例经验总结. 福建中医药, 1993, 24 (2): 4
- [8] 蒋天佑. 补虚定喘方治疗虚喘兼实证. 吉林中医药, 1991 (1): 29
- [9] 刘亚生. 邵长荣老师治喘常用的若干药与方. 福建中医药, 1986, 17 (2): 31
- [10] 杜同仿, 杜满云. 杜祝岳老中医临床经验拾遗. 新中医, 1995, 27 (2): 3
- [11] 赵清理. 理脾胃治杂病举隅. 新中医, 1991, (5): 16
- [12] 何炎巢. 参蛤河车丸治疗哮喘. 吉林中医药, 1991 (3): 34
- [13] 董漱六. 参蛤麻杏膏. 中医杂志, 1987, 28 (9): 34

肺 气 肺

1. 加味桂枝龙骨牡蛎汤（黄煌）

组成：龙骨 20g，牡蛎 30g，赭石 30g，桂枝 5g，白芍 10g，当归 10g，炙苏子 10g，五味子 5g，沉香 3g，麦冬 10g，太子参 15g。

用法：每日 1 剂，水煎服。

功效：补气益血纳气。

主治：肾不纳气、气虚喘咳之肺气肿、老年慢性支气管炎、肺心病、支气管哮喘。

方解：本方用龙、牡、赭石降逆平喘，苏子、沉香降气化痰，当归养血，五味子纳气，桂枝温肾，太子参、麦冬清润消痰，全方攻补并用，寒温相兼，补气益血纳气归根，立方针对病情，辨证用之，功效可靠。周凤梧主编《药理学》云：“代赭石苦寒体重，寒能清热、重可镇降，所以有平肝清火重镇降逆等功效”。说明此药多用于实证。若太子参改为党参，其与麦冬、五味子相合，气阴并补，对久咳肺虚，气短自汗者颇有功效。^[1]

2. 肺气肿方（李克绍）

组成：红参 9g，清半夏 9g，冬虫夏草 9g，麦冬 12g，核桃肉 12g，五味子 4.5g，厚朴 4.5g，炙甘草 3g，炒苏子 3g，杏仁 6g，桂枝 6g，生姜 2 片。

用法：每日 1 剂，水煎服。

功效：补气敛肺，降气纳气。

主治：肺气肿。

方解：人参、麦冬、五味子为生脉散，功能补肺气之不足，养肺阴之枯竭，敛肺气之耗散，为主药；桂枝通阳而降逆，《本经》谓能治“上气吐吸”，半夏合麦冬开结而不燥；厚朴、杏仁治胸满；核桃肉、冬虫夏草能纳气归肾、润肺补肺，生姜、苏子散水降气，合而用之有补气敛肺，降气纳气的作用。

加减：方中冬虫夏草价格贵而药源少，可以地龙代之。肺有瘀血，唇色紫绀者，去厚朴，加莪术 9g，黄酒 12g；挟外感加苏叶 9g，陈皮 6g。^[2]

（郭桃美）

参 考 文 献

[1] 沈仲圭. 现代名医经验方集锦. 黑龙江中医药, 1983, (4): 26

[2] 李怀生. 李克绍肺气肿方的临床验证. 浙江中医杂志, 1991, 26 (4): 154

肺源性心脏病

一、寒饮阻肺证

1. 温肺蠲饮汤（杨百荪）

组成：麻黄 10g，法半夏 10g，杏仁 10g，苏子 10g，厚朴 10g，枳壳 10g，细辛 3~6g，五味子 6g，干姜 6g，甘草 6g，茯苓 15g。

用法：每日 1 剂，水煎煮（约 15 分钟）2 次，取药汁和合，约 450ml，等量分 3 份，日服 2 次，睡前加服 1 次。

功效：宣散表邪，温肺化痰。

主治：肺源性心脏病、肺气肿，属急性发作期。症见咳嗽加重，恶风畏寒，背部寒冷，咳痰清稀，胸闷气促，甚则不能平卧，或见尿少，身肿，舌紫暗，苔白滑，脉浮紧或弦滑。

方解：本方是以《金匱要略》苓甘五味姜辛汤和小青龙汤为基础，灵活变通而成。方中麻黄、细辛、杏仁、干姜为主药，温肺散寒，宣肺平喘；辅以法半夏燥湿化痰；厚朴、枳壳理气化痰平喘；五味子敛肺且防诸药辛燥太过，甘草调和诸药。最妙是重用茯苓，健脾祛湿，以燥中土，杜绝生痰之源。全方宣降合用，散收相伍，共奏温肺化痰，止咳平喘之功。本方服法更具特点，因咳嗽发作多日轻重，故除日服 2 次外，择夜间阴寒之气较甚，阳气较弱之时，临睡前加服 1 次，以加强助阳散寒、温肺化饮之效。

本方辨证关键是要掌握寒饮阻肺，反复咳喘，痰质清稀，形寒肢冷的病症特点。若属痰热咳喘，则不可妄投。

加减：咳嗽痰多，苔厚腻者，加冬瓜仁、白术、桔梗；咳喘较甚者加紫菀、款冬花、前胡、桑白皮；痰涎壅盛，大便不通者，加葶苈子、白芥子、桃仁；胸痛气塞者，加瓜蒌皮、郁金；痰色转黄，口干渴者，去干姜，减麻黄用量，加川贝母、花粉、麦冬。^[1]

二、虚实兼杂证

2. 固本平喘汤（杨百荪）

组成：西洋参 3~6g，桂枝 3~6g，茯苓 10g，白术 10g，橘红 10g，炙枇杷叶 10g，枣皮 10g，当归 15g，阿胶（烔化）15g，山药 15g，桔梗 6g，甘草 6g。

用法：每日 1 剂，水煎煮（约 30 分钟）2 次，取药汁和合，约 300ml，等量分 2 次服。

功效：益肾固本，阴阳双调。

主治：肺心病、肺气肿，缓解康复期。症见咳嗽痰少，劳作甚则气短，偶感心慌短气，口不渴喜热饮，恶寒喜暖，极易汗出外感，舌淡苔白，脉细或弦滑。

方解：本病为本虚标实之证，而缓解康复期主要表现为虚证，治疗应以扶正为主。方中西洋参、山药、阿胶、当归等益气补血，肺脾肾兼顾；辅以桂枝、炙枇杷叶、橘红以止咳化痰；枣皮敛肺气，甘草和诸药。全方补而不膩，温而不燥，肺心病等夏季未发时服用，尤为适宜。^[1]

3. 补虚定喘方（蒋天佑）

组成：熟地 9~12g，炙黄芪 15~30g，炒山药 15~30g，

补骨脂 9g, 五味子 9g, 赭石 6~9g, 炒地龙 6~9g, 炙麻黄 6~9g, 丝瓜络 6~9g, 露蜂房 6~9g, 葶苈子 6~9g。

用法: 每日 1 剂, 水煎 2 次, 早晚分服。病急重者, 可日服 2 剂。如病已缓解, 可按上述各药比例制成蜜丸剂(每丸重 9g), 每天早晚各服 1~2 丸, 淡盐开水送服。

功效: 补肾益肺, 降气定喘, 化痰通络。

主治: 慢性肺源性心脏病、支气管哮喘、阻塞性肺气肿等心肺疾患, 见虚喘兼实证者。症见呼吸急促, 气短不续, 吸气困难, 动则为甚, 甚则端坐呼吸, 大汗淋漓。或伴有阵咳遗尿, 咳声低弱或深沉嘎涩。痰咸、量多且冷, 涎长难断, 或色黄粘稠, 咽喉不利。或心悸浮肿, 面青四肢逆冷, 或五心烦热, 便干尿黄。舌质淡胖有齿痕, 或紫暗有瘀斑瘀点, 苔白滑润, 或舌质偏红少苔, 脉沉细而弱, 右寸及两尺脉弱尤甚, 或沉细而数。

方解: 根据《素问·至真要大论》“衰者补之, ……高者抑之”的治则, 肾虚失纳, 必须补肾纳气, 肺气不足, 又当益气实表, 痰饮水气等上逆, 还要降痰定喘。方中熟地滋肾填精而实其里, 黄芪补肺益气而固其表, 同为主药。山药脾肾双补, 补骨脂补肾纳气, 五味子补肾敛肺, 三者加强主药补肾益气之功, 共为辅药。赭石重镇降气, 气降则痰水亦降; 地龙下行利水, 水行则气机和畅; 麻黄宣肺行水, 肺宣水行则喘定, 且熟地、五味子配麻黄而有开有阖, 赭石、地龙得麻黄而有升有降, 三者同属佐药。丝瓜络、露蜂房通肺络, 葶苈子利肺气而化痰, 均为使药。诸药配合, 共奏补肾益肺、降气定喘、化痰通络之功。根据现代药理研究结果表明, 熟地是滋补强壮剂, 有强心、利尿、抗过敏作用。黄芪有类性激素作用和兴奋中枢神经系统的强壮作用, 还有利尿、抗炎、降压、抗菌等作用。补

骨脂有扩张冠状动脉，提高心脏做功之效能。五味子有兴奋中枢神经系统加强大脑皮层的兴奋过程，提高皮层细胞的工作能力，有镇静、镇咳、祛痰、抗菌、降转氨酶、降血压、强心、增强肾上腺皮质功能。山药含人体生命活动所需三大要素，是平和的滋补强壮药。赭石镇静、止呕、止血、促进血细胞新生。地龙有扩张支气管、抗组织胺、解热、镇静、抗惊厥、降压作用。麻黄有解除支气管痉挛而平喘以及发汗解热、利尿、抗过敏、抑制流感病毒的作用。丝瓜络有利尿解毒清热通络作用。露蜂房有促进血液凝固，增强心脏运动，利尿降压作用。葶苈子有利尿强心平喘祛痰作用。全方有滋补强壮、兴奋调节神经、强心利尿、平喘镇咳祛痰、抗过敏、抗菌等多种作用，对人体心肺肾等有良好的治疗及调节作用。

加减：轻度外感，嗓子发痒加荆芥；喉痛加青果；咳嗽甚加炙款冬花；痰黄粘稠加金银花或鱼腥草；痰中带血加白茅根；痰粘不利加瓜蒌或贝母，痰量特多加白芥子或制南星；水饮喘甚加川椒目；心悸失眠加炒酸枣仁；汗多麻黄易麻黄根，对服麻黄有反应者改为细辛；浮肿加茯苓皮或北五加皮；口干渴加麦冬；便溏赭石改沉香，重用山药；心肾阳虚著者加桂附，阴寒药减量或不用；肺肾阴虚明显者，熟地改生地，加沙参、麦冬，补骨脂易胡桃肉，阳热药减量或不用，元气亏者加人参；血虚加当归；精亏加紫河车或蛤蚧；血瘀加丹参或桃仁；气滞加枳壳或青皮；喘脱加服或先服黑锡丹后服本方。^[2]

(郭桃美)

参 考 文 献

- [1] 郑晓瑛. 杨百菊论治肺胀摘要. 湖北中医杂志, 1994, 16 (2):

2

- [2] 蒋天佑. 补虚定喘方治疗虚喘兼实证的探讨. 黑龙江中医药, 1984, (1): 26

肺 结 核

一、阴虚肺燥证

1. 抗癆丸（李修五）

组成：黄芪 30g，地骨皮 30g，山药 60g，茯苓 40g，土贝母 40g，夏枯草 40g，百部 40g，百合 40g，当归 40g，黄精 40g，白及 40g，黄芩 40g，麦冬 40g，女贞子 40g，生地 40g，玄参 40g，猫爪草 100g，壁虎 40 条。

用法：上药共研细末，加适量蜂蜜制成大蜜丸，每丸重 9g，每次服 2 丸，每日 3 次。

功效：甘寒养阴，清金保肺。

主治：肺结核。

方解：肺结核的病理性质主要是阴虚火旺，并可导致气阴两虚，甚则阴损及阳，但以阴虚肺燥之候者居多。清金保肺实为治肺癆之纲目。抗癆丸立方统之于肺脾，选用甘寒养阴之药，甘以补脾，寒以保肺，清金保肺而无犯中州之土，培土调中，不损至高之气，扶正杀虫，标本兼顾，用治肺结核可获较好的疗效。^[1]

2. 柴胡二皮汤（田成庆）

组成：柴胡 10~24g，制半夏 6~10g，黄芩 10g，沙参 6~10g，牡丹皮 10~24g，地骨皮 15~30g，甘草 3~6g，

鲜生姜 3g，大枣 2 枚。

用法：每日 1 剂，水煎服。

功效：和解少阳枢机，解退阴虚癆热。

主治：适用于肺癆盗汗骨蒸，症见寒热往来，高热不退，胸胁苦满，舌质偏红、苔薄黄，脉弦数。辨证属少阳枢机失和、阴分偏虚癆热之证。

加减：汗多热久不退，地骨皮用大剂量；无汗者，丹皮用大剂量；往来寒热明显、体质较强，柴胡用大剂量；体虚热不退，柴胡用小剂量，另加青蒿 15g；胸中烦而不呕，去半夏加瓜蒌仁 10g；咳重者加枇杷叶（蜜炙）30～50g；痰多者沙参加量，另加海浮石 30g；痰中带血者，加生牡蛎 15～30g，竹茹 15～30g，白及、三七适量。^{〔2〕}

二、气阴两虚证

3. 参蛤散（朱良春）

组成：红参 24g，北沙参 24g，川贝母 24g，五味子 24g，白及 24g，蛤蚧 1 对，紫河车 30g，米炒麦冬 18g，化橘红 18g。

用法：上药研细末，和匀。用蜂蜜调服，每次 2g，每天 3 次。

功效：润肺止咳，滋肾填精，纳气止喘。

主治：肺结核气阴两虚者。

方解：《医学正传》提出肺癆两大治则：“一则杀其虫以绝其根本，一则补虚以复其真元。”《理虚元鉴》又说：“治虚有三本，肺脾肾是也。”朱氏常用参蛤散治疗肺结核，散中人参大补元气，健脾培本；蛤蚧擅于养肺滋肾，纳气止喘；紫河车为血肉有情之品，长于益元填精；沙参、麦

冬、川贝母、五味子、橘红润肺止咳；白及补肺生肌，促使结核灶硬结钙化；蜂蜜不但能补益脾肺，而且味甘调药易服。全方配伍精当，切中病机，对肺结核气阴两虚，咳嗽气急者有良效。^[3]

三、肝肾阴虚证

4. 肺宁丸（王荫卿）

组成：制龟板 90g，生地黄 90g，熟地黄 90g，制百部 90g，北沙参 90g，制鳖甲 60g，川贝母 60g，制乳没 60g，白及 60g，海藻 60g，紫石英 30g，生龙骨 30g，阿胶 30g，天冬 30g，麦冬 30g。

用法：上药共研细末，炼蜜为丸，每丸 9g 重，每次 1 丸，每日 2 次，白开水送服。

功效：补阴血滋肝肾，活血祛邪生新。

主治：肺结核中毒症状（低热、盗汗、五心烦热、乏力等）基本消失后，巩固治疗。

方解：方中制龟板、制鳖甲、生熟地、天麦冬、阿胶、北沙参补阴血滋肝肾以扶正气；紫石英、生龙骨降逆气收浮阳；川贝母、海藻、制乳没软坚散结，活血祛瘀生新，百部、白及润肺补肺。用于肺结核中毒症状消失后，疗效颇佳。^[4]

四、肺脾气虚证

5. 保肺散（李聪甫）

组成：北沙参 12g，茯苓 12g，百合 9g，玉竹 9g，黑芝麻 9g，炙紫菀 9g，蒸百部 9g，桔梗 6g，陈皮 5g，甘草

3g, 薄荷叶 2g。

用法: 将黑芝麻淘净炒香, 其他药味烤燥, 共研细末。每次服 6g, 每日 3 次, 米汁或白糖开水冲服。

功效: 益脾滋肺化痰。

主治: 肺结核, 症见咳嗽吐血, 或痰带血丝, 头昏身倦, 胸痛背胀, 潮热自汗, 喉燥咽干等。

方解: 本方是在“损其肺者益其气”和“劳者温之”的理论指导下组成的。方中沙参、玉竹、百合、黑芝麻、甘草、茯苓等以甘平益脾滋肺为主; 辅以紫菀、百部、陈皮、桔梗等苦辛微温, 温养肺气, 助肺化痰; 用少量薄荷辛凉以清咽喉, 相辅相成, 有“补土生金”的作用。肺结核病多属阴虚, 方中虽具滋阴润肺之品, 但对于阴虚患者, 加入山药、麦冬、天冬, 疗效尤著。^[5]

五、阴虚火旺证

6. 空洞型肺结核方(黄一峰)

组成: 南沙参 15g, 天冬 10g, 麦冬 10g, 炙百部 10g, 炙紫菀 3g, 桔梗 3g, 玉竹 15g, 茯苓 10g, 生甘草 3g, 地骨皮 10g, 生牡蛎 30g (先煎), 十大功劳叶 10g, 母鸡 1 只 (500g)。

用法: 取母鸡净肉, 不放盐、酒等佐料, 文火煮浓汁 6 杯。余药用水浸泡 30 分钟, 文火煎煮 40 分钟, 滤取药液, 加水再煎 30 分钟过滤, 将 2 次药液混合成 2 杯 (约 400ml)。用时每日 2 次服中药、鸡汁各 1 杯。

功效: 培补正气, 杀虫抗癆。

主治: 空洞型肺结核, 属阴虚火旺, 形瘦潮热, 口干舌绛少津或见痰血者。

方解：空洞型肺结核乃形精俱不足，非血肉有情之品，难以康复，故以鸡汁大补五脏为主，培元固本；百部、紫菀、桔梗、玉竹、地骨皮、甘草、生牡蛎、功劳叶等，养阴润肺，止嗽化痰，降火凉血，兼除虚热且可杀虫。现代药理研究也证明，以上药味均有不同程度的抗痨作用。本方采用补虚杀虫两大原则，一方面培补正气，增强抗病能力；一方面杀虫，是针对病因治疗，以标本兼治。长期坚持服用，可获良效。^[6]

7. 抗痨紫菀汤（何炎燊）

组成：紫菀 15g，川贝母 12g，知母 12g，人参 10g，茯苓 15g，五味子 6g，阿胶 15g，甘草 5g，桔梗 5g，黄芩 15g，丹参 15g，百部 15g，黄精 15g。方中人参可视病情需要，分别用西洋参、吉林参或太子参。

功效：补肺养阴，抗痨。

主治：浸润性肺结核。辨证属肺虚有火，干咳无痰，或痰少而粘，或有血丝，午后手足心热，盗汗，心烦，形体消瘦，舌红，脉细数。

方解：本方一向被认为是治肺痨咳血较平和之方。本方以补土生金，养阴清火为主，其中知母之寒，中虚便溏者不宜；桔梗升提，有血症者慎用。而百合固金汤（百合、生地、熟地、玄参、川贝母、甘草、桔梗、白芍、当归、麦冬）与本方大同小异，唯滋腻过之，两者可随证取舍。多年来文献不断报道许多中药有抗结核作用，其中尤以黄精、丹参、百部、黄芩等药为佳。因黄精可补养肺脾，百部杀虫止咳，黄芩清降肺火，丹参活血化瘀，用治肺结核颇切合病情。

加减：脾胃虚弱，食少便溏去知母，加山药 18g，薏苡仁

25g; 咳血加仙鹤草 15g, 侧柏叶 10g, 出血多者再加石灰散 10g 和服; 潮热加地骨皮 15g, 鳖甲 20g; 火升咳逆上气, 去桔梗, 加黛蛤散 10g; 津亏口燥加麦冬 12g, 玉竹 18g; 咽痛加玄参 15g, 咸竹蜂 5g; X 线摄片显示有空洞者加白及 15g。^[7]

六、肺胃阴虚证

8. 燕窝粥(何炎燊)

组成: 燕窝 5g, 晚造香梗米 20g, 西洋参 5g, 百合 25g。

用法: 上药加水适量熬成粥, 食时可加冰糖少许。

功效: 滋养肺胃。

主治: 用于各型肺结核之食疗。

方解: 《笔花医镜》有人参燕窝百合汤, 治火盛刑金之肺痿, 晚造香梗米得秋金之气最全, 加入方中熬粥食之, 有益气滋阴, 清金止嗽之效, 为肺结核首选之食疗方。^[7]

(吴艳华)

参考文献

- [1] 周宜强, 韩丽华. 李修五教授治疗疑难杂症的经验. 新中医, 1991, (5): 4
- [2] 李宝顺. 名医名方录. 北京: 中医古籍出版社, 1991. 102
- [3] 黄瑞彬. 朱良春治疗痼疾运用验方拾贝. 江苏中医, 1990, 11 (5): 1
- [4] 温治江. 王荫卿老中医治疗肺结核的经验. 内蒙古中医药, 1987, (1): 4.
- [5] 李聪甫. 李聪甫医论. 湖南: 湖南科学技术出版社, 1980. 243
- [6] 黄一峰. 空洞型肺结核效方. 中医杂志, 1989, 30 (6): 20
- [7] 马凤彬. 何炎燊临证试效方. 广州: 广东高等教育出版社, 1995. 32, 35

咯 血

1. 寒降止血饮（董平）

组成：酒蒸大黄 9g，代赭石 30g（先煎），焦山栀 9g，鲜生地 60g，黄芩 9g，仙鹤草 12g，旱莲草 9g，茜草炭 6g，炒蒲黄 9g，阿胶 9g（另烱），大小蓟各 9g，三七末 6g（分 2 次吞），生龙牡各 30g（先煎）。

用法：每日 1 剂，水煎分 2 次微温服。大咯血 1 日 2 剂，水煎分 4 次凉服。

功效：降气泻火，凉血止血而不留瘀。

主治：肺经实热证咯血，包括量多势急的大咯血症。凡支气管扩张、肺结核、肺脓疡等病大咯血有是证者可用是方。

方解：肺经实热证咯血，尤其量多势急的大咯血，必有气逆火升见症，徒事止血，而气逆火升、血热妄行如故，血必不止。欲凉血必先清气，欲止血必先降气，火退则血能归经，气降则血自下行。本方选用大黄伍以重镇的赭石、龙牡以降气，配苦寒的黄芩、栀子以泻火。在降气泻火的基础上，重用鲜生地佐以其他常用止血药，才能发挥各类止血药的作用。其中生地、旱莲草、大小蓟擅于凉血止血，使血不妄行；阿胶滋阴止血，使血质厚纯而不易外渗；仙鹤草收敛止血；三七、蒲黄、茜草化瘀止血，能使瘀化而不留，保持血道疏利，则血自易归经。

加减：便秘者酒蒸大黄改为生大黄（后下）；火盛者加生石膏、知母；血热甚者加犀角（现已不用，可用水牛角代之）、牡丹皮；血量过多若属气火所迫者，加紫雪丹（冲服）；合并肺部感染，高热不退者，去阿胶，加金银花、连翘、鱼腥草；若属肝火上逆，咯血反复者，去生地、黄芩、栀子，加生石决明、生白芍、山茱萸、生麦芽；实火渐清，逆气渐平，渐有转为阴虚内热者，应随症逐步减去大黄、黄芩、栀子、赭石、龙牡等，渐加沙参、百合、麦冬、地骨皮之类以扶正。

注意：凡肺经虚燥咯血、肺虚火旺咯血、肺肾阴虚虚火伤络咯血，均非本方所宜。绝对不可误投于肺经虚寒咯血和气随血脱的脱证。^[1]

2. 泻白化血汤（任达然）

组成：桑白皮 15~20g，地骨皮 10g，甘草 5g，花蕊石 15g，三七粉 3g（吞服），血余炭 10g。

用法：上药除三七粉外，加水浸泡 30 分钟，煎煮 30 分钟，每剂煎 2 次，将 2 次煎出的药液混合。症状较轻者，每日 1 剂，上下午各服 1 次；症状较重者，每日 2 剂，每 4 小时服 1 次。三七粉用药汤分冲。

功效：清肝泻肺，化瘀止血。

主治：支气管扩张咯血。

方解：本方由泻白散合张锡纯的化血丹（花蕊石、血余炭、三七粉）化裁而成，对肺热咯血不失为良方。

加减：如有风热表证，去地骨皮，加桑叶 10g，菊花 10g，牛蒡子 10g；若兼有燥火，加养阴润肺之沙参、麦冬、天花粉；痰多黄稠，发热，加鱼腥草、黄芩、大贝母；心烦易怒、胸胁引痛、脉弦数者，加黛蛤散、山栀；大便

秘结，加大黄。^[2]

(郭桃美)

参 考 文 献

- [1] 李宝顺. 名医名方录. 北京: 中医古籍出版社, 1991. 69
- [2] 任达然. 泻白化血汤. 中医杂志, 1989, 30 (12): 22

肺 脓 病

复方鱼桔汤（叶景华）

组成：鱼腥草 30g，金银花 30g，鲜芦根 30g，薏苡仁 30g，冬瓜仁 30g，桔梗 15g，黄芩 15g，黄连 10g，桃仁 10g，象贝母 10g，生甘草 5g。

用法：若邪盛时，每日 2 剂。病情好转，则改为每日 1 剂，水煎服。

功效：清热解毒，祛痰排脓。

主治：肺脓肿。

方解：复方鱼桔汤是集历代医家治疗肺痈之要药，并在原基础上，药物剂量有明显增加。方中鱼腥草、金银花、黄连、黄芩、芦根清热解毒；桔梗、薏苡仁、冬瓜仁、桃仁、象贝母祛痰排脓。全方清解肺部蕴结之热毒，使肺叶不受热毒燔灼成脓，并促使脓痰排出。肺脓肿病变虽集中表现在肺部，但其全身亦有反应，因此既要重视局部病变，又要照顾全身正气的盛衰，尤其对长期应用抗生素治疗，病情未能控制已出现正虚邪盛表现时，当扶正祛邪并进，一方面扶助正气，使机体恢复驱邪外出之力；另一方面清热解毒，化痰排脓，以助正气驱邪外出之功。治疗期间，叶氏强调重病宜用重剂，若邪盛时，宜加重药量，日服 2 剂。若有高热服药呕吐时，也可将中药煎剂保留灌肠，以通腑泄热。

加减：若邪盛时可加服黄连粉装胶囊分次吞服。若为肺脓肿后期，正气虚弱当扶正祛邪并用，可加黄芪 30g，合欢皮 30g，孩儿参 15g，北沙参 15g。^[1]

(肖达民)

参 考 文 献

- [1] 王莉珍. 叶景华治疗肺脓肿经验. 辽宁中医杂志, 1994, 21 (7): 302

矽肺

止咳化矽糖浆（朱良春）

组成：由党参、北沙参、百合、白及、夜交藤、金荞麦、白花蛇舌草、金钱草、合欢皮、石韦、甘草等组成。

用法：上药熬制为糖浆，每次服 30～50ml，每日 2 次，配合“抗矽 14”，0.5g/周，连服 4 个月为 1 疗程。

功效：补益气阴、调理肺脾、化痰散瘀、软坚消积。

主治：矽肺。

方解：矽肺是由于长期吸入含有二氧化硅的粉尘而引起以肺部弥漫性纤维化为主要特征的一种职业病。其病机乃粉尘沉积肺络，阻滞气机而影响肺之肃降功能，治疗上宜攻补兼顾，扶正以固本，祛邪而攻病。止咳化矽糖浆中党参，《本草正义》云：“能补脾养胃，润肺生津，健运中气”，《本草从新》谓其“补中益气，和脾胃，治烦渴”，所以对于气虚不足，倦怠乏力，气急喘促，脾虚食少等症有效；北沙参《本草从新》谓其“专补肺阴，清肺火，治久咳肺痿”，是治肺虚热咳的要药；百合《纲目拾遗》说它“清痰火，补虚损”，用于肺燥、肺热之虚损久咳最合。白及《滇南本草》称其“治癆伤肺气，补肺虚，止咳嗽，消肺癆咳血，收敛肺气”，《中国植物图鉴》则明确指出它善治矽肺。有人曾用其制成片剂，治疗 44 例单纯型患者，服药 3 个月至 1 年后，胸痛、气急、咳嗽、吐黑痰、咯血等

症状,均显著减轻或消失,体重增加,肺功能改善,血液浓枸橼酸钠反应有所进步,唯X线改变不大显著。本品还对结核菌有抑制作用,并有收敛止血、消肿生肌之功。因此,对矽肺、肺结核等均有效。夜交藤《本草从新》谓其“补中气,行经络,通血脉,治劳伤”,与上述诸药相合,能增强补虚强壮作用,有利于功能之恢复。白花蛇舌草《泉州本草》说它能“清热散瘀,消痈解毒,又能清肺火,泻肺热,治肺热喘促,咳逆胸闷”。据报道,它能刺激机体网状内皮系统和嗜银物质,可以提高机体免疫功能,对于矽肺肺热喘咳颇合。金荞麦的成分主要是黄酮醇类物质,有活血消肿、止咳化痰作用。通过临床观察,不仅可以改善临床症状,还能提高机体免疫功能。金钱草《植物名实图考》说它能“治吐血,下血”;《中国植物图鉴》谓其“可作强壮剂,治慢性肺炎”,具有清热解毒,镇咳止血,活血化石之功,对消除肺中矽尘有帮助。合欢皮《纲目》说它能“活血、消肿、止痛”,《动植物民间药》称其可“治咳嗽”,具有强壮、兴奋、镇痛、安神、止咳及利尿等作用。石韦《本草从新》载其“清肺气以滋化源,通膀胱而利水道”,由于本品有清肺泄热、止咳定喘、利尿排石之功,因此亦可用于排除肺中之矽尘。甘草能协和诸药而提高疗效。上述每味中药都是多功能的,而集中多种中药于一方,可以协同而产生新的效能,提高治疗效果。^[1]

(吴艳华)

参 考 文 献

- [1] 朱良春,“止咳化矽糖浆”配合“抗矽14”治疗矽肺的疗效观察. 江苏中医杂志, 1981, (5): 22